



Монографія

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ



**АКАДЕМІЯ ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
І ТУРИЗМУ**

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Монографія

За загальною редакцією
Г. А. Приба, Л. Є. Бебези

Київ
ТОВ «Типографія АМГ»
2024

УДК 159.923.35(02)
М50

*Затверджено Вченою радою Академії праці,
соціальних відносин і туризму
(протокол № 6 від 27. 12. 2023 р.)*

Рецензенти:

Бохонкова Ю. О. – доктор психологічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України, кафедра психології та соціології, завідувач кафедри

Бочелюк В. Й. – доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Хортицька національна академія, кафедра психології та соціальної роботи, завідувач кафедри

М50 **Ментальне здоров'я особистості та організації** : колективна монографія. Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред. : Г. А. Пріба, Л. Є. Бегези. – Київ : ТОВ «Типографія АМГ», 2024. – 518 с.

ISBN 978-617-520-710-9

<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29969.61284/2>

У колективній монографії наведені результати науково-дослідної роботи, проведеної науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти з спеціальності 053 «Психологія» кафедри психології та соціальної роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму у 2022–2023 роках.

Представлені в роботі теоретичні моделі та практичні розробки призначені для використання спеціалістами соціономічної сфери в якості методичного забезпечення психосоціального супроводу ментального здоров'я особистості та організації в контексті реалій і викликів сьогодення.

Наукове видання стане корисним методичним інструментарієм для практичних психологів, соціальних працівників, здобувачів вищої освіти у галузі клінічної психології, психології бізнеса та управління, також будуть цікавими для використання у навчальній підготовці кваліфікованих кадрів на етапі перед- та післядипломної освіти.

Розповсюджувати і тиражувати без офіційного дозволу Академії праці, соціальних відносин і туризму забороняється.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних даних і мовностилістичний рівень матеріалів.

ISBN 978-617-520-710-9

© Академія праці, соціальних відносин
і туризму, 2024

© Колектив авторів, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	10
-------------	----

ЧАСТИНА 1. АКМЕ-ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ФАХІВЦЯ

РОЗДІЛИ:

1.1. Професійна ідентифікація особистості.....	12
<i>Білокурський Р. Є., Кохан І. Г., Кроть А. С., Назарук В. В.</i>	
1.2. Особливості психолого-педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу	19
<i>Бузницький В. Ю., Друзюк Б. А., Калашиников О. Л., Костюченко Я. М.</i>	
1.3. Психосоціальні аспекти професійної діяльності особистості та ментальне здоров'я на робочому місці: вітчизняний та європейський досвід	28
<i>Пріб Г. А., Головченко І. А., Мошенський С. В., Сінгаєвський О. М., Степанюк В. І.</i>	
1.4. Використання математичних методів у психологічних дослідженнях.....	36
<i>Гончаренко Н. М.</i>	
1.5. Важливість психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності.....	45
<i>Дубик Т. В.</i>	
1.6. Особистісні та професійні компетентності як чинник професійної діяльності особистості	53
<i>Каленіков С. А., Менько А. В., Романчишин О. П., Шевченко Д. О.</i>	
1.7. Вплив локусу контролю на професійне самовизначення та стресостійкість випускників професійно-технічних навчальних закладів.....	61
<i>Ларченко І. В.</i>	

1.8. Моделі формування іміджу здобувача вищої освіти	70
<i>Лосієвська О. Г., Лосієвський В. І., Рачкован Є. В.</i>	
1.9. Особистісні якості та професійні компетентності персоналу девелоперських організацій	80
<i>Мамедов О. О.</i>	

ЧАСТИНА 2.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛИ:

2.1. Невротичні стани та емоційні проблеми при порушенні сімейного функціонування.....	91
<i>Бондар С. С.</i>	
2.2. Невротичні розлади у дітей та дорослих в умовах соціального стресу	102
<i>Борець О. А.</i>	
2.3. Психологічні механізми комунікації у підлітковому віці.....	115
<i>Гавучак Д. В., Кроть Р. С., Кушнір Ю. Ю., Ліщук О. В., Присяжнюк Г. В., Рачковський Е. А.</i>	
2.4. Підтримки психічного здоров'я особистості: європейські та вітчизняні практики	127
<i>Гуляєва Л. П., Драган В. В., Ваколюк Б. В., Ковальов Д. Ю., Крилов М. О., Пріб Я.А.</i>	
2.5. Агресивність в аспекті підліткового віку	134
<i>Єзерська Н. В., Рябоконь В. В.</i>	
2.6. Формування резильєнтності здобувачів вищої освіти в умовах війни	141
<i>Житинська М. О.</i>	
2.7. Теоретичний аналіз поняття «девіація» у підлітковому віці	150
<i>Канафоцька Л. М.</i>	
2.8. Особистісні особливості спортсменів в умовах стресу	156
<i>Кардаш Р. І.</i>	

2.9. Психологічні ускладнення дітей та підлітків з надмірною вагою та ожирінням.....	167
<i>Корнєва Я. І.</i>	
2.10. Сучасні дослідження проблем осіб з дисфункціональних родин.....	174
<i>Краковська А. Б.</i>	
2.11. Психологічні особливості медичних працівників в умовах емоційного виснаження.....	180
<i>Лапінська Т. В.</i>	
2.12. Теоретичний аналіз поняття адикції у науковій літературі.....	185
<i>Лузгіна В. А.</i>	
2.13. Інформаційно-психологічна безпека особистості: аналіз загроз, ризиків і перспектив в світлі сучасних реалій.....	194
<i>Марков А. Р.</i>	
2.14. Тенденції розвитку алкогольної залежності серед молоді України.....	206
<i>Фесік Ю. О.</i>	
2.15. Психоемоційні стани вагітних жінок.....	212
<i>Шинкарук Т. А.</i>	

ЧАСТИНА 3.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ У НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

РОЗДІЛИ:

3.1. Соціально-психологічні чинники емоційних станів внутрішньо переміщених осіб.....	219
<i>Абдукарімова І. А.</i>	
3.2. Групове консультування у психологічному супроводі внутрішньо переміщених осіб з відновлення працевлаштування	230
<i>Бегеза Л. Є.</i>	
3.3. Психоемоційна сфера та психічне здоров'я особистості в умовах життєвих викликів: вітчизняний та європейський досвід	239
<i>Бегеза Л. Є., Бичук М. І., Камалов В. Ш., Шиманський О. П., Янушевський А. О.</i>	

3.4. Теоретичне вивчення проявів психосоматичних розладів у молоді.....	245
<i>Воронцова І. М.</i>	
3.5. Особливості психоемоційних станів військовослужбовців у адаптаційний період	254
<i>Ковальська О. Р.</i>	
3.6. Теоретичне дослідження психічних станів особистості як наслідок кризових подій в Україні	262
<i>Лимаренко О. О.</i>	
3.7. Функціонування сімейної системи і постстресова психологічна дезадаптація учасників бойових дій: взаємодія феноменів, варіанти взаємовпливу, медико-психологічна підтримка	270
<i>Маркова М. В.</i>	
3.8. Психологічна підтримка військовослужбовця з розладами адаптації	288
<i>Мелещенко Л. В.</i>	
3.9. Психологічна підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	293
<i>Пріб Г. А.</i>	

ЧАСТИНА 4. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ

РОЗДІЛИ:

4.1. Психічне здоров'я на робочому місці, лідерство в контексті євроінтеграції	304
<i>Житинська М. О., Антипін О. С., Баранчук В. В., Ісак А. М., Міщенко Д. А., Потеруха В. В. Селіверстов В. С.</i>	
4.2. Мотиваційний вплив ідентичності та іміджу бренда на поведінку споживача.....	311
<i>Барвінко Д. О.</i>	

4.3. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності підприємців.....	318
<i>Бондарчук В. В.</i>	
4.4. Психологічні механізми формування організаційної культури підприємства	325
<i>Бондарь С. І.</i>	
4.5. Психологічні детермінанти адаптації та мотивації персоналу організації до професійної діяльності.....	337
<i>Дичук В. В., Лапінський А. В., Леонов О. П., Мовчан М. М., Сирих П.А., Форостовець Є. С., Хоролець О. В.</i>	
4.6. Психологічні особливості професійної діяльності керівника організації та підтримка психічного здоров'я на робочому місці в Україні в умовах війни: виклики та керівництво до дій.....	346
<i>Борець О. А., Закревський Ю. Ю., Мусієнко Д. В., Охрімчук Д. А., Циганок О. М.</i>	
4.7. Теоретичні аспекти психології управління та менеджменту бізнес-процесами на підприємстві	355
<i>Писаренко Н. В., Калінін А.М., Бараник З.П., Буткевич О.В., Тітов В.В.</i>	
4.8. Емоційне вигорання керівника в сфері охорони здоров'я.....	369
<i>Скида І. О.</i>	
4.9. Соціально-психологічні чинники виникнення професійного вигорання державних службовців.....	376
<i>Томашевська К. А.</i>	
4.10. Психічне здоров'я персоналу в ІТ індустрії в умовах війни.....	385
<i>Фроленко К. М.</i>	
4.11. Роль психологічних чинників у виникненні емоційного вигорання працівників ІТ-сфери.....	392
<i>Церковна О. М.</i>	
4.12. Психічне здоров'я організацій та персоналу в умовах війни.....	398
<i>Янушевська О. А.</i>	

ЧАСТИНА 5.
КОНСУЛЬТАТИВНА, ДІАГНОСТИЧНА ТА
ТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ У МЕДИКО-
ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ
СУПРОВОДІ ОСОБИСТОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

РОЗДІЛИ:

5.1. Медико-психологічна взаємодія у системі «медичний працівник-пацієнт»	405
<i>Бегеза О. С.</i>	
5.2. Психологічні особливості взаємодії у сімейному та родинному середовищі	413
<i>Гладченко В. А., Камардін О. М., Мурга С. В., Сиротін С. В., Стасюк Д. В.</i>	
5.3. Психологічні особливості тренувальної діяльності спортсменів-професіоналів у передзмагальний період	420
<i>Гречко Ю. Л.</i>	
5.4. Використання методів арт-терапії у роботі з дітьми, хворими на епілепсію	427
<i>Заицька О. П.</i>	
5.5. Формування стресостійкості особистості	433
<i>Коротков В. С.</i>	
5.6. Вплив зовнішніх факторів стресу на підвищення кількості захворювань розладами харчової поведінки	443
<i>Кабанова М. В.</i>	
5.7. Особливості та чинники розладів харчової поведінки у жінок	449
<i>Леванзова В. Я.</i>	
5.8. Передумови виникнення психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці	461
<i>Лисова В. М.</i>	
5.9. Ризики застосування методу психологічного дебрифінгу	469
<i>Меленець А. Ю.</i>	

5.10. Диференціально-діагностичні критерії та показники конструктивності життєвих стратегій подружжя	478
<i>Морозова О. В.</i>	
5.11. Посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців: теорія та діагностика	490
<i>Опанасенко С. В.</i>	
5.12. Соціально-психологічні аспекти вирішення конфліктів в територіальних громадах шляхом медіації.....	499
<i>Потапенко С. А., Потапенко І. Є.</i>	
5.13. Психологічні детермінанти комунікації у системі «лікар– пацієнт хірургічного профілю»	508
<i>Шмуліченко О. В.</i>	
ВИСНОВКИ	515

ВСТУП

Воєнна агресія проти України призвела до загибелі мирних жителів, руйнування економіки, економічних, моральних, психологічних страждань учасників ринку праці. Нині стало зрозумілим, що саме психологічні наслідки війни будуть долатися усіма верстами населення України упродовж наступних десятиліть.

Сьогодні суспільство кардинально змінює підходи до взаємодії із роботодавцями, працюючими особами, з яких велика частина є переміщеними та постраждалими особами, учасниками та інвалідами бойових дій. Адже попередні стратегії взаємодії виявилися неефективними, оскільки не враховують психологічної травми населення внаслідок війни. Для надання психологічних послуг та допомоги, фахівцю важливо знати особливості різних категорій клієнтів, їх мотивацію та ціннісні орієнтації, уміти встановлювати і підтримувати контакт, ефективно спілкуватися, застосовуючи різноманітні техніки і засоби. Саме тому напрацювання психологів-науковців та здобувачів, які безпосередньо пов'язані з дослідженням механізмів формування та розвитку ментальної здоров'я, соціальної ефективності, компетентності особистості, набувають особливого практичного значущості.

Враховуючи виклики та вимоги сьогодення, кафедра психології та соціальної роботи напрацьований потужний теоретико-практичний матеріал, який розкриває результати досліджень ментального здоров'я особистості та організації. Саме з метою реагування на запити сучасності укладено колективну монографію «Ментальне здоров'я особистості та організації», що вміщує в собі низку практичних розробок, кожна з яких є своєрідним інструментарієм, оволодіння котрим надає можливість фахівцям ефективно співпрацювати з різними категоріями клієнтів, особливо в контексті запровадження нових моделей надання психологічних та психотерапевтичних послуг.

Перша частина монографії складається з розділів, присвячених акме-психологічним стратегіям формування професійної траек-

торії фахівця. У другій частині монографії представлено розділи, в яких надано результати дослідження теоретико-методологічних та практичних підходів до забезпечення ментального здоров'я особистості. Третя частина монографії вміщує розділи, що висвітлюють результати вивчення соціально-психологічної допомоги постраждалим у наслідок військових дій. Четверта частина монографії складається з розділів, в яких знайшли відображення результати теоретико-емпіричного дослідження психічного здоров'я організацій та персоналу в умовах війни. У п'ятій частині монографії представлено розділи, що презентують авторські концептуальні моделі забезпечення консультативної, діагностичної та терапевтичної діяльності фахівця у медико-психологічному та психосоціальному супроводі особистості та організації.

Пропоновані матеріали стануть корисним методичним інструментарієм для практичних психологів, соціальних працівників, здобувачів вищої освіти у галузі клінічної психології, психології бізнесу та управління, а також будуть цікавими для фахівців, які займаються проблемами становлення і самоактуалізації особистості.

ЧАСТИНА 1.

АКМЕ-ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ФАХІВЦЯ

РОЗДІЛИ:

1.1. Професійна ідентифікація особистості

*Білокурський Р. Є., Кохан І. Г.,
Кроть А. С., Назарук В. В.*

Актуальність. Проблема професійного самовизначення довгий час не розглядалася і не вивчалася як самостійний напрям. Тривалий час питання профорієнтації ототожнювались з соціальним замовленням суспільства, щодо підготовки фахівців конкретних галузей. Відповідно цей факт обмежував сферу професійного самовизначення особистості. На сьогодні проблема професійного самовизначення учнів набуває все більшої актуальності.

Мета. Проаналізувати важливість професійної ідентифікації особистості.

Результати досліджень. Професія (від латинського *professio* – офіційне заняття, спеціальність) – вид праці, занять, що потребує певної підготовки і є джерелом існування. Професія характеризується системою знань, умінь і навичок, властивих певній людині.

Необхідно зазначити, що термін «самовизначення» вживається у психолого-педагогічній літературі в самих різних значеннях. Так говорять про самовизначення особистісне, соціальне, життєве, професійне, моральне, сімейне, релігійне тощо.

Самовизначення – це усвідомлення людиною власних особливостей, можливостей, здібностей, вибір критеріїв, норм оцінюван-

ня себе. Одночасно, це складний процес розвитку людини. Його структурними елементами є різновиди самовизначення (особистісне та професійне), що постійно взаємодіють. Особистісне самовизначення – це вибір життєвої позиції, визначення перспектив у діяльності та сімейних планах, а також перехід від однозначної ролі (учня) до соціально диференційованих ролей. Особистісне самовизначення відбувається переважно у підлітковому віці.

Професійне самовизначення – це складний динамічний процес орієнтації особистості у професійно-трудовому середовищі, розвитку та самореалізації духовних і фізичних можливостей, формування адекватних професійних намірів і планів, реалістичного образу себе, як професіонала.

Дуже точне і повне тлумачення поняття професійного самовизначення дав академік Є. О. Клімов: «Професійне самовизначення – це діяльність людини, що приймає той або інший зміст, це, насамперед, образи бажаного майбутнього, особливості усвідомлення себе й свого місця в системі ділових міжособистісних відносин».

З наведеного визначення випливають наступні дуже важливі в методологічному відношенні висновки. По-перше, професійне самовизначення не є пасивним психологічним процесом, а пов'язане з певною діяльністю людини. По-друге, для його реалізації у людини повинні бути сформовані образи бажаного майбутнього, тобто особистість повинна усвідомити своє «хочу». По-третє, людина повинна усвідомити саму себе, свої особистісні можливості й обмеження, тобто зрозуміти власне «можу». По-четверте, оскільки мова йде про пошук власного місця в системі міжособистісних відносин, виходить, людині необхідно зрозуміти, що ж у конкретному соціумі, у якому вона перебуває, необхідно тепер, тобто «треба».

Сутністю професійного самовизначення є визначення людиною себе щодо вироблених у суспільстві (і прийнятих даною людиною) критеріїв професіоналізму. Сучасне розуміння професійного самовизначення охоплює проблеми взаємозв'язку професійного самовизначення із загальним життєвим самовизначенням особистості, впливів на особистість навколишнього соціального середовища, професійного становлення і необхідність активної життєвої позиції людини.

Розвиток професійного самовизначення охоплює весь період навчання дитини в школі і складається з таких етапів: первинного вибору професії, для якого характерні диференційовані уявлення про світ професій, ситуативні уявлення про внутрішні ресурси, необхідні для певної діяльності, нестійкість професійних намірів. На цьому етапі у особистості ще не виникає запитань про зміст професії та умови роботи.

На другому етапі виникають і формуються професійні наміри і первинне орієнтування в різних сферах праці. Актуальність питання професійного самовизначення набуває особливого значення у підлітковому та юнацькому віці.

В психологічній літературі немає єдиного погляду на те, як формується вибір професії і які фактори впливають на цей процес. По цьому питанню існує

кілька точок зору, на захист кожної з яких свідчать важливі аргументи. Така неоднозначність при розкритті сутності професійного самовизначення пояснюється складністю самого процесу і його багатовимірністю. Ряд дослідників притримуються розповсюдженій точки зору на вибір професії як на вибір діяльності. В цьому випадку предметом дослідження виступають, з одного боку, характеристики людини як суб'єкта діяльності, а з іншої – характер, зміст, види діяльності і її об'єкти. Професійне самовизначення розуміється тут як процес розвитку суб'єкта праці. Отже, вибір професії зроблений правильно, якщо психофізіологічні дані особистості будуть відповідати вимогам професії, трудової діяльності. Недоліком цього напрямку є недооцінка активності самої особистості.

В контексті розуміння вибору професії як вибору діяльності розповсюджена також точка зору, що основною детермінантою правильного вибору являється професійний інтерес чи професійна спрямованість. Цей підхід виправляє помилку попереднього, оскільки стверджує на вирішальному значенні особистісної активності людини при виборі. Однак професійний інтерес може мати різноманітне походження і не співвідноситься з діяльністю. Крім того професію не можна звести до певного виду трудової діяльності. Абсолютизація професійного інтересу як основи вибору професії також не повністю правомірна.

Деякі автори притримуються погляду на вибір професії як на частковий випадок соціального самовизначення особистості (Костенко, Михайлов). Тобто вибір професії, з одного боку, вважається соціально заданим, а з іншого – визначається перш за все соціальними характеристиками професії. Не викликає сумнівів положення про вплив суспільства в цілому на процес професійного самовизначення його членів, і з професійною діяльністю пов'язане положення особистості в суспільстві.

Найбільш продуктивним являється підхід до вибору професії як до одного з найважливіших подій у цілісному життєвому визначенні людини. Вибір професії пов'язаний з минулим досвідом людини, і процес професійного самовизначення простягається далеко в майбутнє, беручи участь у формуванні загального Я-образу, визначаючи в кінцевому рахунку всю спрямованість життя. Цей підхід потребує врахування широкого кола факторів, які впливають на вибір професії, крім того, він дозволяє зробити акцент на часовому аспекті – на минулому досвіді особистості і на її уявленнях про майбутнє. В якості факторів вибору професії повинні бути враховані життєві плани особистості також і в інших областях, наприклад в особистому житті.

Погляд на вибір професії як на частину життєвого самовизначення людини не обмежує активність суб'єкта вибору професії і, враховуючи весь спектр факторів професійного самовизначення, стверджує про індивідуальну ієрархію факторів вибору професії, що характерна для кожного індивіда. Всі об'єктивно існуючі фактори впливають тією чи іншою мірою на вибір професії, однак від особливостей суб'єкта вибору насамперед залежить, які фактори стають визначальними. Об'єктивно існуючі фактори являються лише можливостями, варіантами, а те, які з них і в якій комбінації стануть визначальними при професійному самовизначенні, залежить від особливостей конкретної особистості. Велике значення має суб'єктивний образ ситуації вибору, який може суттєво відрізнитися від об'єктивної картини в силу різноманітних причин.

Беручи за основу принцип активності особистості у здійсненні професійного вибору, Пряжніков Н. С. пропонує змістовно-процесуальну модель професійного самовизначення. Вона полягає у побудові особистісного професійного плану за наступними параметрами: усвідомлення цінності чесної (суспільно-корис-

ної) праці (ціннісно-моральна сторона самовизначення); загальне орієнтування в соціально-економічній ситуації в країні і прогнозування перспектив її якісної зміни (врахування конкретної соціально-економічної ситуації і прогнозування престижності обраної професії); виділення проміжних і найближчих професійних цілей як етапів і шляхів до кінцевої мети; знання про обрані цілі: професії та спеціальності, відповідні професійні навчальні заклади і місця працевлаштування (мікроінформаційна основа самовизначення); прогнозування зовнішніх перешкод на шляху до виділених цілей; знання шляхів і способів подолання зовнішніх перешкод; прогнозування внутрішніх перешкод (недоліків, вад), які ускладнюють досягнення професійних цілей, а також знання своїх достоїнств, переваг, що сприяють реалізації намічених планів і перспектив (самопізнання як важлива сторона самовизначення); знання шляхів і способів подолання внутрішніх перешкод (і оптимального застосування переваг), що сприяють підготовці до самостійного усвідомленого вибору і майбутньої професійної діяльності; наявність системи резервних варіантів вибору у випадку невдачі по основному напрямку самовизначення; початок практичної реалізації особистої професійної перспективи і постійне коригування намічених планів за принципом «зворотного зв'язку».

Як вже було зазначено, ситуація вибору професії характеризується двозначністю: світ професій, що володіють широким спектром характеристик, і суб'єкт вибору, особистість з усіма її особливостями.

Відповідно до вказаного важливою якістю особистості є здатність опиратися впливам стресових ситуацій, розвинена стресостійкість. І якщо її рівень розвитку недостатній необхідно приділити увагу її формуванню.

На нашу думку, варто розглянути особливості професійної діяльності, що потребують високого рівня стресостійкості як умови успішного здійснення професійних завдань. Аналізом специфіки задач у галузі приватного бізнесу і питанням професійних якостей приватних підприємців у різний час займалися психологи і педагоги Ф. Брукс, Г. Вейнберг, Н. Вірт, Л. Гришко, Е. Дейкстра, С. Макконнелл, М. Смульсон, Б. Шнейдерман та ін. .

За даними І. А. Вях, підприємці здійснюють свою трудову діяльність в області, де темпи «старіння» та «оновлення» професійних

вмінь постійно пришвидшуються, а географія генерування нових знань і технологій весь час зростає. Тому основними завданнями підприємців залишаються пошук найбільш ефективних форм і методів організації та управління діяльністю шляхом вивчення досвіду світового виробництва. Отже, підприємець повинен мати такі знання, уміння і навички, які дозволять йому в подальшому працювати у багатьох ролях, а саме: менеджера, аналітика, дослідника, тестера, адміністратора, й звичайно, користувача, який може постійно самовдосконалюватись незалежно від мовного джерела нових знань, здійснювати об'єктивне оцінювання роботи підприємства чи фірми, порівнювати її з роботою аналогічних закордонних фірм, співпрацювати із закордонними приватними підприємцями.

Поняття «професіоналізм» визначається як інтегральна особистісна характеристика людини, яка: оволоділа нормами професійної діяльності і спілкування та здійснює їх на високому рівні; прагне здобути професійну майстерність; дотримується професійної ціннісної орієнтації та професійної етики; розвиває себе сучасними засобами діяльності; прагне зробити творчий внесок у професію, збагативши її досвід; прагне і вміє викликати інтерес суспільства до результатів своєї діяльності, сприяє підвищенню ваги і престижу в суспільстві, гнучко враховує нові запити суспільства до неї.

Розглядаючи професіоналізм підприємця, учені (Е. Дейкстра, М. Смульсон, Б. Шнейдерман) виділяють якості, які властиві підприємцям, що пов'язані безпосередньо із створенням бізнес продукту і психологічні й загальнолюдські риси, які повинні бути притаманні приватному підприємцю. Для підтримки професіоналізму приватний підприємець повинен постійно бути обізнаним та всіляко поповнювати свої знання і вміння.

Висновки. У рамках компетентнісного підходу акцент має бути зміщено з формування певного набору знань, умінь і навичок у галузі підприємництва на виховання таких якостей, як робота в команді, лідерські якості, відповідальність, здатність до рефлексії, здатність до самостійного навчання й освоєння нових технологій протягом життя (навіть кожні 2–3 місяці), самоосвіта, планування діяльності, логічне й алгоритмічне мислення, цілеспрямованість, наполегливість, уміння самостійно ухвалити рішення, швидко адаптуватися до нового завдання, широкий кругозір у предметній

галузі. Крім того, виникає затребуваність у специфічних знаннях психології й менеджменту.

Література.

1. Бородій Д. Професійна ідентичність як один із структурних компонентів кар'єрної компетентності майбутнього фахівця. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 135. С. 63–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2015_135_18
2. Лях Т. Л. Професійна ідентичність соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2013. № 11(270). С. 96–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_11_%282%29_16
3. Осьодлю В. І. Професійна ідентичність і професійний розвиток особистості офіцера. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2011. Вип. 28. С. 269–279. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_28_33
4. Андрушко Я. Роль психологічних захистів у структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ. Молодь і ринок. 2013. № 7. С. 147–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_7_33

1.2. Особливості психолого-педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу

*Бузницький В. Ю., Друзюк Б. А.,
Калашніков О. Л., Костюченко Я. М.*

Актуальність. Сьогодні суспільство дедалі більше усвідомлює важливість здорового розвитку та гармонії «внутрішнього всесвіту» особистості, – або ж, іншими словами, важливість психічного здоров'я людини. Проблема психічного здоров'я особистості, яка живе в сучасному нестабільному, мінливому світі, складних соціально-політичних умовах виступає на перший план.

Мета. Виявити особливості психолого-педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Результати дослідження. Система суспільних цінностей є соціально-значущим орієнтиром життєдіяльності кожного члена суспільства. Соціальна норма знаходить своє втілення (підтримку) в законах, традиціях, звичаях, тобто у всьому тому, що стало звичкою, міцно увійшло до побуту, в спосіб життя більшості населення. Вона підтримується громадською думкою, грає роль «природного регулятора» суспільних і міжособистих відносин.

Оволодіння особистістю загальнолюдськими цінностями неможливе тільки на рівні усвідомлення. У цьому процесі активну роль відіграють емоції, які виникають у процесі взаємодії з сімейним оточенням, з батьками дитини, які безпосередньо впливають на формування системи базових цінностей дитини та адекватність її поведінки.

Повага до життя, до інших людей і самого себе є умова психічного здоров'я людини. Деструктивність – негативне ставлення людини до самої себе або до інших людей і відповідна до цього ставлення поведінка. Деструктивна особистість нещаслива, навіть якщо їй вдається досягнути поставлених цілей. Деструктивна поведінка (відхилена поведінка), що розуміється як система вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві правовим чи моральним нормам, придбала останніми роками масовий характер,

що поставило проблему її вивчення в центр уваги соціологів, соціальних психологів і педагогів, медиків, працівників правоохоронних органів. Проблема відхилень вивчають кримінологія, правова статистика, соціологія, психологія, педагогіка та інші науки.

Значення вивчення цієї проблеми очевидно: поведінка, що відхиляється, є соціальним і психологічним явищем, що має деякі відхилення від визнаних норм і законів, а іноді пов'язане з певною антигромадською поведінкою людей.

Пояснити таку поведінку, розкрити її причини, знайти ефективні шляхи і засоби її попередження можливо тільки при глибокому вивченні психології поведінки, що відхиляється та факторів, які сприяють формуванню деструктивної поведінки у дитинстві. У досліджених відхиленій поведінки значне місце приділяється вивченню мотивів, причин і умов, що сприяють її розвитку, можливостей її попередження і подолання. Однією з причин, що сприяють розвитку відхиленій поведінки можливо назвати вади виховання, які призводять до формування відносно сталих психологічних властивостей, що сприяють здійсненню аморальних вчинків.

Процес формування і розвиток особистості починається з моменту народження дитини. Тому особливо велике значення має сім'я, яка є одночасно і середовищем для дитини, і першим вихователем, і виконує функції передачі духовного багатства, культурних традицій народу, сім'ї. Сім'я багато в чому передбачає те, якою стане людина в майбутньому. Саме сім'я закладає фундамент розвитку нахилів, здібностей дитини, формування її моральних якостей, здоров'я. Через сім'ю дитина опосереднює норми людських стосунків, засвоює моральні відносини.

Отже, сім'я виконує функцію соціалізації дитини, яка відбувається як у результаті об'єктивного впливу того середовища, в якому вона живе (характер і умови життя сім'ї, професійної діяльності батьків, кола їхніх інтересів; відношення між членами сім'ї, сім'ї і школи та ін.), так і виховання, яке здійснює сім'я.

Психологічне здоров'я дітей залежить від соціально-економічних, екологічних, культурних, психологічних і багатьох інших чинників.

Прояви агресивності – одна з частих проблем в середовищі дитячого колективу. Ті чи інші форми її характерні для більшості дошкільнят. Але якщо з засвоєнням правил і норм поведінки у багатьох з них ці безпосередні прояви агресивності поступаються місцем просоціальним формам, то у певної категорії дітей агресія як стійка форма поведінки не тільки зберігається, але й розвивається, трансформуючись у стійку рису особистості. У результаті знижується продуктивний потенціал, звужуються можливості повноцінного спілкування, деформується особистісний розвиток. Агресивна дитина приносить масу проблем не тільки оточуючим, але і самій собі.

В останні роки вчені, які працюють в різних напрямках, пропонують різноманітні підходи і трактування до визначення сутності агресивної поведінки, її психологічних механізмів, але у загальних рисах агресивність розуміється як цілеспрямоване нанесення фізичної або психічної шкоди іншій особі.

Дослідження та багаторічні спостереження показують – агресивність, що склалася в дитинстві, залишається стійкою рисою і зберігається протягом подальшого життя людини. Можна вважати, що вже в дошкільному віці складаються певні внутрішні передумови, сприяючі її прояву. Вивчити ці характеристики надзвичайно важливо, щоб зрозуміти природу явища і вчасно подолати небезпечні тенденції.

Говорячи про різноманітність теоретичних підходів до проблеми класифікації форм дитячої агресивності, необхідно визначити, що ця галузь науки знаходиться в безперервному розвитку і єдиної концептуальної класифікації на даний момент немає. Тим не менше, кожна з них має право на існування.

В даний час існує безліч видів класифікацій агресії. Більшість дослідників пропонує дихотомічний спосіб розподілу. В якості одного з полюсів більшість з них виділяє інструментальну агресію – поведінка, при якій агресія є тільки засобом і спрямована на досягнення якої-небудь мети, отримання результату, а не нанесення шкоди. Такий вид агресії виділяє Р. Байрон і Д. Річардсон. Агресія другого виду зазвичай визначається як ворожа – це відповідь на реальну, передбачувану або вигадану загрозу для навмисного заподіяння шкоди.

У дітей, як і у дорослих, існує дві форми прояву агресії: непродуктивна агресивність і ворожа деструктивність. Перша – механізм задоволення бажання, досягнення мети і здібності до адапта-

ції. Вона спонукає дитину до конкуренції в навколишньому світі, захисту своїх прав та інтересів і служить для розвитку пізнання і здатності покластися на себе.

Друга – не просто злісна і ворожа поведінка, але і бажання заподіяти біль, отримати задоволення від цього. Результатом такої поведінки зазвичай бувають конфлікти, становлення агресивності як риси особистості та зниження адаптивних можливостей дитини. Деструктивність агресії діти починають відчувати вже у ранньому віці і намагаються керувати нею. Однак у деяких дітей вона, ймовірно, запрограмована біологічно і проявляється з перших днів життя: її найпростішим вираженням є реакції люті і гніву. Генетично агресивність пов'язана з Y-хромосомами: вчені встановили, що вона особливо притаманна хлопчикам, які мають при деяких генетичних абераціях таку додаткову хромосому.

Дитяча агресивність є комплексне, особистісне утворення, а причинами агресивної поведінки можуть бути як психологічні (порушення в мотиваційній, емоційній, вольовій або моральній сферах), так і соціально-психологічні фактори (дезінтеграція сім'ї, порушення емоційних зв'язків у системі дитячо-батьківських відносин, особливості стилю виховання). Відносини батьків та дітей, а також соціальне оточення у якому росте дитина істотно впливає на формування поведінкових реакцій дитини, та на формування її особистості. У психологічній літературі представлений великий спектр форм дитячої агресивності. Виділяють фізичну, вербальну, пряму, інструментальну, ворожу і аутоагресію. Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, що поняття дитячої агресивності, неоднозначне і різнопланове. Існує велика кількість різноманітних точок зору з даного питання, однак, більшість авторів схильні вважати, що дитяча агресивність, є стійкою рисою особистості, для якої характерне осмислене, цілеспрямоване нанесення фізичної чи психологічної шкоди людині чи групі людей.

Психологічне здоров'я дітей залежить від соціально-економічних, екологічних, культурних, психологічних і багатьох інших чинників. На думку авторів (Л. І. Божович, А. А. Бодальов, В. С. Мухіна, Т. А. Рєпіна та інших) дитина як найвідчутніша частина соціуму схильна до різноманітних негативних дій. Останніми роками, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш поширени-

ми явищами є тривожність і страхи у дітей (І. В. Дубровіна, В. І. Гарбузов, А. І. Захаров, Е. Б. Ковальова та інші).

Страх – це психічний стан, що виникає на основі інстинкту самозбереження як реакція на дійсну або уявну небезпеку. Страх є найбільш небезпечним з усіх емоцій. Великі області досліджень, присвячених страху, створюють прекрасні підстави для подальшого розуміння цієї важливої емоції.

Страх має багато причин як суб'єктивного (мотивація, емоційно-вольова стійкість та ін.), так і об'єктивного порядку (особливості ситуації, складність завдань, перешкоди і т. д.), виявляється як у окремих індивідуумів, так і у великих мас. Ступінь і форми прояву страху різноманітні, але це область перш за все індивідуальної психології. Існують різні форми страху: переляк, боязнь, афектний страх – найсильніший. Страх, що виникає через серйозне емоційне неблагополуччя, може мати крайні форми виразу (жах, емоційний шок, потрясіння), затягну і важко переборну течію, повну відсутність контролю з боку свідомості, несприятливий вплив на формування характеру, на відносини з оточуючими і пристосування до зовнішнього світу.

У ситуації соціальної нестабільності на сучасну дитину обрушується безліч несприятливих факторів, здатних не тільки загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості, але й повернути процес її розвитку назад. Тому велику увагу проблемі страху приділяється в роботах вітчизняних психологів і психотерапевтів, які відзначають зростання числа дітей з різноманітними страхами, підвищеною збудливістю і тривожністю.

Дитячі страхи в тій або іншій мірі обумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорять про нервову слабкість малюка, неправильну поведінку батьків, конфліктних відносинах в сім'ї і в цілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин, як зазначають психологи, лежать в області сімейних відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або занадто вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в ній тривогу і потім формує ворожість до світу.

Психіка дитини відрізняється загостреним сприйняттям, нездатністю протистояти несприятливим впливам. Невротичні страхи з'являються в результаті тривалих і нерозв'язаних переживань

або гострих психічних потрясінь, часто на фоні хворобливого перенапруження нервових процесів. Тому невротичні страхи вимагають особливої уваги психологів, педагогів та батьків, тому що при наявності таких страхів дитина стає скутою, напруженою. Її поведінка характеризується пасивністю, розвивається афективна замкнутість. У зв'язку з цим гостро постає питання ранньої діагностики невротичних страхів.

Причини дитячих страхів розглядали багато психологів: А. І. Захаров, Т. А. Нємчин, В. Н. Мясищев, Дж. Алан та інші. В якості таких називалися: соматична слабкість дитини в результаті тривалих захворювань в дошкільний період; негативні взаємовідносини з батьками, конфлікти між батьками. Наявність страхів у дитячому віці в жодному разі не можна залишати без уваги, тому що це може стати фактором порушення розвитку особистості в онтогенезі (В. И. Гарбузов, В. В. Лебединський і ін.). Проблема емоційного неблагополуччя дітей, зокрема, проблема дитячих страхів, незважаючи на достатню вивченість, не тільки не втрачає своєї актуальності в наші дні, але навіть загострюється у зв'язку з масштабними змінами в суспільно-політичному й економічному житті не тільки дорослих, але й дітей.

Страх відіграє немаловажну роль у житті дитини, з одного боку, він може вберегти від необдуманих і ризикованих вчинків. З іншого боку – позитивні й стійкі страхи перешкоджають розвитку особистості дитини, сковують творчу енергію, сприяють формуванню непевності й підвищеної тривожності.

Страхи неминуче супроводжують розвиток дитини й появу різних емоційних порушень, психологічних проблем пов'язаних з рядом несприятливих подій, що відбувались у дитинстві.

Профілактика страхів складається, насамперед, з виховання таких якостей, як оптимізм, впевненість в собі, самостійність. Дитина повинна знати те, що їй належить знати за віком, про реальні небезпеки і погрози, і ставитися до цього адекватно. Існуючі способи зниження й контролю страху ґрунтуються, насамперед, на теорії навчання.

Корекція страхів здійснюється за допомогою ігротерапії, казкотерапії, арт-терапії, лялькотерапії, психоелевації, індивідуально-групових занять, поліпшення дитячо-батьківських відносин. Також використовують малювання у корекційних цілях. Малюючи, дитина дає

вихід своїм почуттям і переживанням, бажанням і мріям, перестроює свої відносини в різноманітних ситуаціях і безболісно стикається з деякими лякаючими, неприємними і травмуючими образами.

Важливість активної корекційної роботи з дитячими страхами обумовлена тим, що сам по собі страх здатний впливати на розвиток різних сфер особистості дитини. Отже, можна стверджувати, що страхи це емоційні порушення, що піддаються корекції і без наслідків можуть проходити у дітей до десяти років. Тому надзвичайно важливо вчасно звертатися до фахівця, вжити заходів для подолання фобій у дитини. В зв'язку із цим, найбільш актуальною для практичної психології і педагогіки, є задача пошуку найбільш ефективних шляхів виявлення й подолання психічного неблагополуччя дитини.

Наскільки буде виражений той або інший страх і чи буде він виражений взагалі, залежить від індивідуальних особливостей психічного розвитку й конкретних соціальних умов, у яких відбувається формування особистості дитини.

Одна з нових ідей боротьби зі страхом і агресивністю у дітей – це розвиток потенціалу дитини, а саме розвиток креативності. Розвиток креативності у дітей розв'язує суттєву задачу формування творчого потенціалу нашого суспільства, забезпечує можливості інтенсивного соціального та науково-технічного прогресу, подальшого розвитку науки й культури, всіх галузей виробництва і соціального життя. Раннє виявлення творчих здібностей у дітей дошкільного віку складає нову задачу удосконалення системи народної освіти і має важливе суспільне значення.

Торранс П. вважає, що творчість пробуджується у дітей лише після 5 років, а за даними Андрюса, пік творчості у дітей приходить на 3,5 – 4,5 роки. Інша позиція полягає в тому, що ряд психологів зовсім відмовляють дитині в будь-якій творчості. Вони вважають, що у дитини є лише пасивна фантазія.

Але виявляється, що уява у дітей з'являється набагато раніше ніж ми можемо собі уявити. Перші прояви уяви ми можемо спостерігати тоді, коли дитина починає діяти, не на основі реальності, а на основі виникаючих у неї власних уявлень, тобто в 2,5 – 3 роки, тому що саме в цьому віці дитина починає діяти в уявленій ситуації, з уявним предметом. Виникає це передусім у грі. Спостерігаючи за поведінкою дітей під час гри, деякі психологи вважають, що лише в грі проявля-

ється уяви дитини, яка з самого початку притаманна їй. Але Л. С. Виготський довів, що в грі не проявляється, а з'являється уяви дитини.

Уява молодшого дошкільника пов'язана з предметом. Малюнки дітей молодшого віку ще бідні, якщо не проводять спеціальні заняття. Але навіть, якщо і ведеться спеціальна робота, уява дітей носить ще репродуктивний характер. Дитина практично без змін відображає у своїх творах побачене чи почуте нею.

Характерною рисою уяви в усіх видах діяльності дитини є повна відсутність попереднього задуму. Основні напрямлення розвитку уяви дошкільника.

В процесі функціонування уяви дошкільника виділяють два основних етапи: зародження деякої ідеї творчого продукту; створення деякого плану-задуму реалізації цієї ідеї. Обидва ці етапи проявляються вже до кінця дошкільного дитинства. Можна виділити два види уяви : афективна та пізнавальна.

Основна задача пізнавальної уяви – це специфічне відображення об'єктивного світу, подолання протиріччя в уявленнях дитини про дійсність, побудова та уточнення цілісної картини світу. За допомогою уяви діти можуть або творчо оволодівати схемами та суттю людських дій, або, відштовхуючись від окремих уявлень дійсності, будувати цілісний образ якої-небудь події чи явища.

Афективна уява виникає в ситуаціях протиріччя, формуючого у дитини образу «я» реальності і являється в таких випадках одним з механізмів його створення. При цьому, з одного боку, уява може виконувати регулюючу функцію в процесі засвоєння норм та суті соціальної поведінки. З іншого – виступає в якості захисного механізму особистості. Захист може здійснюватися двома основними шляхами: по-перше, через багаторазову варіативну репрезентацію травмуючих впливів, в процесі якої можуть знаходитись засоби вирішення конфліктних ситуацій; по-друге, через створення уявляємої ситуації, яка знімає фрустрацію.

Висновки. Людина за сутністю свого єства перебуває у безлічі зв'язків з довколишнім світом. Вона сприймає його впливи, певною мірою протистоїть йому, і в свою чергу також впливає на нього, спричиняючи ті чи інші зміни в окремих складових особистості. Людина завжди є включеною в культурно-історичний процес, що постійно здійснюється: в ньому відбувається взаємоперебіг

надбань культури людства, відображених у певних ідеях, цінностях, ідеалах, певних предметних, речових здобутках цивілізації, у певному досвіді діяння у світі, практичного та духовного його перетворення. Природною сутністю кожної людини є стійка потреба у самопроявах. Особистість шукає такі форми активності, котрі давали б їй можливість остаточно реалізувати, розкрити свої сутнісні сили. Ця непереборне прагнення визначеності і штовхає особистість на творчий шлях. Проблема співвідношення «людина і світ» у будь-яких філософських системах, зокрема у психологічній науці, завжди визнавалась як одна з найголовніших. У її вирішенні наука безпосередньо наближається до життя, оскільки дає можливість людині пізнати сутність цього співвідношення, володіти цим знанням у повсякденному житті, а отже бути більш продуктивною, незалежною, вільною у виборі, способах взаємодії зі світом.

Отже, безперечна важливість та необхідність вирішення цих питань на сучасному рівні культурного розвитку нашої держави, пов'язаних із загальними тенденціями гуманізації освіти на всіх її ланках.

Література.

1. Moody, S. A., Neilson, K. M., Kenyon, K. L., Alfandari, D., & Pignoni, F. (2015). Using *Xenopus* to discover new genes involved in branchiootorenal spectrum disorders. *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol*. Dec; 178:16–24. doi: 10.1016/j.cbpc.2015.06.007. Epub. Jun 24. PMID: 26117063
2. Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O., Faraone, S. V., Greenhill, L. L., Howes, M. J., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T. B., Walters, E. E., & Zaslavsky, A. M. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. *Am J Psychiatry*. Apr; 163(4): 716–23. doi: 10.1176/ajp.2006.163.4.716. PMID: 16585449
3. Adamou, M., Arif, M., Asherson, P., Aw, T. C., Bolea, B., Coghill, D., & Young, S. (2013). Occupational issues of adults with ADHD. *BMC psychiatry*, 13(1), 1–7.
4. Бочелюк В. І. Психологічні особливості розвитку професійно-діяльнісного потенціалу особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2016. Вип. 4. С. 138–143.
5. Перевозна С. В. Робота з учнями із девіантною поведінкою/ С. В. Перевозна. – К. : Вих. робота. – 29 с.

1.3. Психосоціальні аспекти професійної діяльності особистості та ментальне здоров'я на робочому місці: вітчизняний та європейський досвід

*Головченко І. А., Мошенський С. В.,
Сінгаєвський О. М., Степанюк В. І.*

Актуальність. Для особистості кожної людини визначне місце посідає професійне самовизначення. У теоретичних підходах проблему самовизначення найчастіше пов'язують з проблемами розвитку особи і її самосвідомості, з проблемами соціальної зрілості і визначення життєвої, з проблемами самоздійснення і самореалізації особистості. У віковій психології і психології розвитку проблема самовизначення особистості вивчається у зв'язку із специфікою юнацького віку, процесами формування світогляду, соціалізації і вибору сфери професійної діяльності.

Мета. Проаналізувати важливість психо-соціальних аспектів професійної діяльності особистості.

Результати дослідження. Особистість – це найвища інстанція, що координує всю психічну діяльність індивіда, його поведінкову активність, соціальне обличчя людського «Я» для інших. Особистість виникає як засіб, інструмент для набуття людиною своєї сутності, вона – особистість постійно планує і спрямовує складний процес життєдіяльності, якого не має в живій природі – процес творення себе у власному життєвому світі.

Особистістю в психології позначається системне (соціальне) якість, що набувається індивідом у предметній діяльності та спілкуванні і характеризує міру представленості суспільних відносин в індивіді. Особистість кожної людини наділена тільки їй властивим поєднанням психологічних рис і особливостей, які утворюють її індивідуальність, що становлять своєрідність людини, його відмінність від інших людей. Індивідуальність проявляється в рисах темпераменту, характеру, звичках, переважаючих інтересах, в яко-

стях пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, мислення, уяви), в здібностях, індивідуальному стилі діяльності і т. ін.

Більшість поняття професійного самовизначення, які можна зустріти в психологічній літературі, мають описовий характер і стосуються, як правило, досить вузьких спеціальних аспектів. Так, наприклад, І. С. Кон зауважує, що суть феномена самовизначення молодшої людини полягає у «чіткому орієнтуванні і визначенні свого місця у світі дорослих», а також, «у виборі соціально і особистісно значущих цілей, досягнення яких забезпечується самореалізацією суб'єкта».

Поняття «самовизначення» І. С. Кон пов'язує з процесами «пошуків себе», «відкриття Я», соціального і морального дозрівання, які мають світоглядний сенс і «виразно соціальний зміст». Соціологічний підхід І. С. Кона хоча й дозволяє сформулювати загальні уявлення про головні характеристики процесу самовизначення особистості, але відображає його лише у досить вузькому аспекті соціалізації, не розкриваючи повною мірою глибинно-психологічних і інтимно-особових переживань людини, її суб'єктивне сприймання і зміст внутрішньої активності.

Професійне самовизначення – це передусім, орієнтація на певну соціальну позицію, що передбачає усвідомлення свого соціального минулого, сучасного і майбутнього. Така «соціально-професійна» орієнтація формується на основі усвідомлення особистістю свого соціального походження, усвідомлення реальних умов і обставин стосовно певної соціальної позиції і своїх можливостей у зв'язку з цими перспективами».

Ряд авторів схильні пов'язувати професійне самовизначення не стільки з соціальними процесами, скільки з особистісними аспектами розвитку. М. Р. Гінзбург вважає професійне самовизначення одним з найважливіших аспектів особистісного самовизначення випускників, оскільки воно найтісніше пов'язане з процесом планування майбутнього. Головна вимога з боку суспільства – вимога зробити професійний вибір і тому завдання вибору життєвого напрямку».

Професійне самовизначення в аспекті життєвої перспективи досліджувалось Є. І. Головахою. За його словами, вибір професії молодшою людиною пов'язаний не стільки з її життєвим досвідом, скільки з її уявленням про майбутнє. Перспектива майбутнього, що

формується у свідомості молодшої людини і суттєво впливає на процес професійного самовизначення, характеризується певним рівнем розвитку, який визначається рівнем психічного і соціального розвитку особистості.

Важливе значення має спосіб включення особистості у професію, спосіб її самовизначення в професії і характер самовираження у професійній діяльності. Ці показники окреслюють певний «тип ідентифікації особистості професії»:

- Перший тип передбачає вибір людиною такої діяльності, яка найбільшою мірою відповідає певним характеристикам особистості і передбачає постійне повторювання і відтворення трудових операцій і типових ситуацій.

- Другий тип ідентифікації зумовлений пошуком особистістю можливостей просування у професії до вищих ступенів майстерності, якісних змін у трудовій позиції, що пов'язані з розвитком самої професії.

- У третьому типі ідентифікації відкриваються можливості для розвитку особистості через професію, оскільки просування у професії відбувається на основі розгортання, розвитку і удосконалення якостей і здібностей самої людини.

- Основою для четвертого типу ідентифікації у професії стає здатність особистості до творчої активності у сфері професійної діяльності.

Професійне самовизначення це складний процес, невід'ємний від розвитку особистості у цілому. Лише у контексті розвитку особистості можливий повний аналіз психологічних основ вибору професій. Особистісні передумови вибору професії поділяють на дві групи: особливості, що забезпечують можливість успішного вибору, хоча прямо не беруть участі в його активізації (аналітичні здібності, розвинене абстрактне мислення, адекватна самооцінка) та компоненти спрямування особистості, які «динамізують» процес професійного самовизначення і обумовлюють «вибірковість реагування». Головні динамізуючі особистісні фактори – це потреба особистості у професійному самовизначенні (предметом якої є конкретна ділянка об'єктивної реальності) і потреба визначення сенсу життя (предмет якої – власна особистість, як суб'єкт діяльності). Потреба у професійному самови-

значенні, є головною особистісною потребою у юнацькому віці. Вона існує, як така, ще «до вияву свого предмету».

Зв'язок між цією потребою і її предметом здійснюється через інтереси -> «потенційні вузли» взаємодії зовнішніх профорієнтаційних факторів і особистості. Потреба визначення сенсу життя – це потреба знайти внутрішні психологічні засади для вибору, зрозуміти своє покликання, усвідомити свої властивості і можливості. Головним змістом процесу професійного самовизначення є формування професійного спрямування, рівень розвитку якого вже не стільки з потребами сенсу життя, скільки із ступенем сформованості професійних інтересів.

В процесі дослідження професійного самовизначення вагому роль треба приділяти поняттю і визначенню особистості. В психології існують різноманітні підходи до вивчення особистості, визначення її структурних рівнів. Особистістю можна назвати людину, яка досягла такого рівня соціального розвитку і самосвідомості, який дозволяє їй знаходити і обирати серед цінностей культури особистісні смисли, самостійно виконувати відповідну перетворювальну діяльність, свідомо і відповідально здійснювати саморегуляцію діяльності й поведінки.

Особистість є категорією і предметом вивчення психології особистості. Особистість з точки зору психології – це сукупність вироблених звичок і уподобань, психічний настрій і тонус, соціокультурний досвід та набуті знання, набір психофізичних рис та особливостей людини, її архетип, що визначають повсякденну поведінку і зв'язок з суспільством і природою. Також особистість спостерігається як прояв «поведінкових масок», вироблених для різних ситуацій та соціальних груп взаємодії.

Для вивчення особистості безробітного є сучасний підхід, заснований на теорії провідних тенденцій, розробленої Л. Собчик. Він передбачає аналіз 8 тенденцій (екстраверсії, спонтанності, агресивності, ригідності, інтроверсії, сензитивності, тривожності, лабільності).

В психології поняття «особистість» розглядають в сукупності понять: «людина», «індивід», «індивідуальність».

I. Людина – представник людського роду «*Homo sapiens*».

II. Індивід – це окремий представник людського роду, конкретна самість.

III. Особистість – суспільна людина, якій притаманні погляди на життя, переконання, а значить розвинутий світогляд, яка активно реалізує своє здібності.

IV. Індивідуальність – сукупність неповторних рис в людини.

Людина стає особистістю за таких умов: 1 – коли народжується психічно-здоровою (народжена людина ще не є особистістю); 2 – коли формується у суспільства (серед людей).

Поняття людини включає в себе сукупність усіх людських якостей, незалежно від того, притаманні вони чи ні даній конкретній людині. Людина – продукт та суб'єкт суспільно-історичної діяльності, єдність фізичного та психодуховного, генетично обумовленого та прижиттєвого сформованого.

Особистість має три найважливіші психологічні характеристики: стійкість, єдність та активність. Виділяють також три основні підструктури особистості: можливості, властивості та направленість. До можливостей особистості відносяться рівень розвитку її пізнавальних, емоційно-чуттєвих та вольових психічних процесів, загальні здібності, розвинена пам'ять з усіма її культурними нашаруваннями. До властивості особистості відносяться темпераментний характер та спеціальні здібності. Направленість особистості виявляє мету, яку ставить перед собою людина, прагнення, мотиви, відповідно до яких вона діє. Мотивами виступають природні та психодуховні потреби, а також переконання людини. Головну роль у процесах формування та розвитку особистості відіграють виховання, навчання та освіта. Процес розвитку особистості відноситься до психологічного періоду, а цілеспрямоване формування – до педагогічного. Процес формування ставлення та розвитку особистості відбувається протягом усього життя людини у різних соціальних інститутах, де вона грає різні соціальні ролі: у сім'ї, навчальних закладах, професійних та трудових колективах, групах стимулювання тощо.

Отже, соціально-психологічні, психологічні та індивідуально-психологічні властивості особистості доцільно розглядати цілісно як такі, що становлять єдиний ряд, який можна позначити терміном «соціально-психолого-індивідуальні» властивості особистості безробітних. У цьому ряду виділимо такі складові, як спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, ін-

телектуальні або психічні процеси, психофізіологічні якості, самоактуалізація.

Описане вище самовизначення і професійне визначення особистості стоїть на протилежних позиціях дослідження від проблеми безробіття і пов'язаних з цим психологічних викликів для особистості, але також варте уваги і дослідження.

Проблема безробіття – одна з найгостріших проблем нашого сьогодення. Людина, яка втрачає роботу, стає беззахисною як із соціально-економічної, так і з психологічної точки зору. Більшість дослідників розглядає ситуацію безробіття як кризову, оскільки під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників відбуваються значні зміни у життєвій ситуації особистості. Ці зміни потребують від неї великої внутрішньої роботи для того, щоб віднайти нові можливості та шляхи самореалізації, активно пристосуватися, тобто адаптуватися до нових умов соціального життя та професійної діяльності.

Безробітні по-різному поводитися у взаємодії, будучи то активним співрозмовником, то здатним до аналізу слухачем. Вони можуть виявляти альтруїзм, самотність, апатію, депресію тощо. Причинами цього стають як її індивідуально-психологічні властивості, так і зовнішні чинники, які спонукають до певного типу поведінки. Різноманітність індивідуально-психологічних властивостей особистості залежить від особливостей темпераменту, тобто загальної активності індивіда, динаміки психічних станів, емоційності.

Важливою властивістю безробітних, що формуються під впливом соціуму, соціальних відносин у безпосередній взаємодії з іншими, є характер. Характер – сукупність стійких індивідуальних властивостей особистості, що виявляються в типових способах діяльності та спілкування, в типових обставинах і визначаються ставленням особистості до цих обставин. Безробітні регулюють свої дії, вчинки та поведінку у групі і за допомогою волі, яка є важливим чинником у досягненні мети.

Безробітні по-різному пояснюють життєві події, ситуації та свою поведінку, неоднаково сприймають успіхи й невдачі. Залежить це від їх психічного стану, виконуваної діяльності, етнопсихологічних особливостей, соціокультурних установок тощо. Ситуація безробіття визначає якість життя, соціальні та професійні перспективи, а також обумовлює поведінку та психологічний стан

людини. Безробітні завжди належали до найбільш слабо захищених соціальних категорій. Перебування у ситуації безробіття має психотравмуючий вплив, є джерелом постійного стресу.

Висновки. Провівши ряд досліджень, соціологи та психологи прийшли до висновку, що безробіття – це життєва криза, яка супроводжується дезадаптацією, стресом, внутрішніми конфліктами, підвищеним рівнем тривожності, депресією, почуттям безперспективності. Саме в цей час у апліката посилюється ризик формування залежної (адиктивної) поведінки як засобу патологічної адаптації у суспільстві. Хибний шлях втечі від реальності взагалі і психологічного уникання психотравмуючої ситуації, якою, безперечно, є ситуація безробіття.

Вибір адиктивної стратегії поведінки для апліката обумовлюється труднощами адаптації до проблемних життєвих ситуацій, які породжує становище безробітного (складні соціально-економічні умови, багато чисельні розчарування, руйнування ідеалів, конфлікти в родині і на виробництві, утрата близьких, різка зміна звичних стереотипів, втрата роботи тощо).

Форми такої поведінки різноманітні і відокремлюються один від іншого засобами адикції, а також за наслідками для життя людини (біологічними, особистісними і соціальними). Це може бути епізодичне чи регулярне вживання будь-яких речовин (алкоголю, тютюну, наркотиків, продуктів побутової хімії, медикаментів, солодоців), комп'ютерні і азартні ігри, заняття екстремальними видами спорту, тощо.

Незалежно від обраного засобу адикції, метою адитивної поведінки є втікання від самотності, нудьги, емоційних і міжособистісних проблем, зняття напруженості і переживання інтенсивних емоцій. Психологічна сутність залежності полягає у невмінні керувати своїм психоемоційним станом, інфантилізмі, тривожності.

Без перебільшення можна сказати, що проблема адикції стоюється всіх, хоча за своєю суттю адитивна поведінка – неповноцінний адаптивний механізм, недосконалий спосіб пристосування до умов діяльності і життя, які виявилися занадто складними для пересічного індивіда.

Література.

1. Раєвська Я. М. Теорія і практика професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії : монографія. Кам'янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. 348 с.
2. Раєвська Я. М. Етапи професійного становлення сучасного фахівця соціальної сфери. Збірник наукових праць Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. XXIX. 2017. С. 139–154.
3. Ямницький В. М. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості дорослих : дис. ... д-ра психол. наук : 19. 00. 13. Київ, 2004. 410 с.
4. Кокнова Т. А. Професійні якості як найважливіший чинник професійної придатності фахівця. URL: www.rusnauka.com/10.../21608.doc.htm

1.4. Використання математичних методів у психологічних дослідженнях

Гончаренко Н. М.

Актуальність. Математичні методи обрахунку результатів психологічних досліджень є однією із компетентностей професійної діяльності психолога. Просвітницька, навчальна, корекційно-розвивальна, діагностична робота потребують від психолога ґрунтовної підготовки.

Психологічне дослідження розпочинається з формулювання гіпотези, тобто формулювання обґрунтованого припущення з метою з'ясування властивостей, причин досліджуваного проблемного питання та перевіряється дослідницьким шляхом (емпірично) із застосуванням математичних методів статистики.

Аналіз отриманих результатів діагностики передбачає аналітичний опис, виокремлення найважливіших фрагментів з масиву отриманих результатів, порівняння, узагальнення кількісних і якісних даних. Аналіз повинен ґрунтуватися на фактах, кількісних показниках, а також прикладах якісного характеру.

Кількісні показники психічних проявів та їх математико-статистичне оброблення надають висновкам статистичної значущості. Однак не можна абсолютизувати кількісні методи. Математична процедура абстрагується від «живих» даних, спрощуючи реальні психічні явища, що вивчаються. Тому всі висновки, отримані в результаті кількісного (тобто математико-статистичного) опрацювання, необхідно підкріплювати даними якісного характеру, які ґрунтуються на досвіді, спостереженнях дослідника (реєстрація поведінкових, вербальних реакцій, жестів, міміки, пантоміміки, експертна оцінка тощо) [1]. Якісні оцінки ґрунтуються на властивостях об'єкта, яким не приписані кількісні параметри ні інтервального, ні рангового характеру. Якісну оцінку виражають або в категоріях об'єктивних відношень (більше – менше, вище – нижче, сильніше – слабше тощо), або в категоріях суб'єктивних визначень (приємний, ввічливий, грубий, веселий тощо). Якісні показники широко використовують при про-

веденні експериментальних досліджень у сфері консультування, корекційної, розвивальної роботи, психопрофілактики, психологічної просвіти та в інших галузях практичної психології [1].

У практичній діяльності психологів мають справу з номінативними та порядковими емпіричними даними. Тому найбільш затребуваними є непараметричні критерії (Т-критерій Вілкоксона, U-критерій Манна-Уїтні, G-критерій знаків, ϕ^* – критерій (кутове перетворення Фішера), L-критерій тенденцій Пейджа, χ^2 -критерій Фрідмана). Зважаючи на сказане, є потреба в ознайомленні студентів з алгоритмами покрокових дій. Приклад такого алгоритму дій, який складається з чотирьох ключових кроків, запропоновано Є. Морозовим [2]. Важливим є ознайомлення студентів не лише з алгоритмами вибору того чи іншого критерію у залежності типу даних та виду вибірок, але й відповідних дій щодо їх застосування в конкретній ситуації. Оскільки при застосуванні таких критеріїв як Т-критерій Вілкоксона, U-критерій Манна-Уїтні та G-критерій знаків правило формулювання статистичного висновку відрізняється від правил для інших критеріїв [2]. Обробку емпіричних даних можна здійснювати за допомогою відповідних програмних продуктів. Зокрема, найчастіше у практиці своєї професійної діяльності психологи користуються такими доступними для широкого кола користувачів пакетами як то MS Excel і MS Access, а також професійними пакетами: SPSS, STATISTICA і MATLAB. Професійні пакети містять у собі значну кількість методів і тому потребують від студентів відповідних навичок роботи. З огляду на це, викладачам необхідно розраховувати на проведення окремих лабораторних занять, метою яких є закріплення знань з використання методів математичної статистики у психологічних дослідженнях, а також формування умінь і навичок працювати з різними програмним продуктами [2].

Існує дві точки зору щодо дослідження математики в психології. Перша сприймає математику як універсальний засіб, бачать у математизації психологічних знань єдиний шлях подолання тих складнощів, які лежать на дорозі дослідження різних проблем психології. Друга, стверджують, що дослідження математики, в силу специфіки психологічних досліджень, в принципі неможливо, бо на практиці моделювання та формалізації математичних явищ перетворюється на порожню гру математичними символами. Необґрунтованість і тієї і іншої точки зору очевидна. Від математики

не можна вимагати більшого, що вона може дати, але те, що вона дійсно може використовуватися повною мірою [3].

Використання математичних методів для діагностики психічних якості особистості на різних стадіях її розвитку є предметом численних обговорень. Таким чином, актуальність дослідження пояснюється тим, що психологічні проблеми (агресивність, депресії, нервово-психічні розлади, комп'ютерна, ігрова, наркотична та ін. залежності) дуже гостро стоять у сучасному суспільстві і вирішити їх можна за допомогою фахівців, які використовують ефективні методики, розроблені з урахуванням результатів обробки експериментальних даних математичними методами [3]. Предметом дослідження виступають математичні та психологічні методи, що володіють певними вимогами і впливають на результати психологічних досліджень.

Мета. Дослідити використання математичних методів у психологічних дослідженнях.

Результати дослідження. Психологія як самостійна наукова дисципліна не така вже давня, хоча основний об'єкт її досліджень – людина займає філософську думку відколи людство навчилося мислити. Проте знадобилися сторіччя багатьох, учених, щоб з'явилися психологічні дослідження.

З часів Вольфа психологію почали називати емпіричною, не була ж вона такою, тому що основним методом її досліджень залишався інтроспективний метод, за допомогою якого не можна було проводити жодних точних вимірів. Але якщо у 18 столітті Кант стверджував, що психологія ніколи зможе стати точною наукою, оскільки виміри у ній неможливі, то вже на початку 19 століття неможливе стає можливим. У всякому разі, саме до цього часу належать роботи німецького філософа, психолога та педагога Йоганна Герберта, який у 1822 році вперше виступив у Берліні з доповіддю «Про неможливість та необхідність застосовувати математику в психології». Найважливішою віхою у розвитку психології з'явилися роботи Вебера і Фехнера, які, вивчаючи відчуття людини, вперше застосували у своїх дослідженнях експериментальний метод [4-7]. XX століття внесло у «взаємини» людини та математики кілька несподіваних особливостей. Тож якщо на початку століття деякі аспекти цього питання широко обговорюються багатьма вченими, серед яких можна назвати А. Пуанкаре, І. П. Павлова, А. Ейнштейна та ін.,

то в 30-40 рр. вони не викликають гострого інтересу. Про це можна судити хоча б тому, що в психологічних дослідженнях даного періоду кількісним методам приділяється дуже не значна увага, формалізація кількісних явищ надає перевагу якісним описам. Проте проходить буквально кілька років, і інтерес до користування математики в психології спалахує з новою, небувалою силою. Причиною тому було зародження та бурхливий розвиток низки технічних наук, насамперед кібернетики. Вона сприяла прагненню до вдосконалення багатьох математичних методів, які у зв'язку з новими завданнями, що виникли в психології, могли бути використані в ній набагато ефективніше, ніж раніше. Але головною відмінністю взаємодії психології та математики цього періоду було звернення математики до психології [6, 7]. Це пояснюється тим, що в середині ХХ століття у зв'язку з розвитком електронно-обчислювальної техніки та досягненням у психології, неврології та фізіології з'явилася реальна можливість «поставити» проблему «удосконалення» розумових процесів. Говорячи цьому плані про взаємодію психології та математики, можна навести ще один приклад, що характеризує двосторонній зв'язок між цими предметами. «Завдяки величезній структурній та функціональній складності» зазначає автор книги «Основи математичної статистики для психологів» В. Г. Суходольський — «психічні, соціальні, педагогічні явища здавна служили для розвитку самої математичної статистики; досить згадати Ф. Гольтона, що розвинув початкові ідеї кореляції та регресії, Ч. Стерміна, який створив рангову кореляцію та однофакторний аналіз, Л. Ферстона, який розробив мультифакторний аналіз».

Отже, припущення М. Віннера, який, відзначав зв'язок між фізикою та біологією: «Я передбачаю, що не тільки біологічні науки зближуватимуться з фізикою, а й фізика асимелюватимуть деякі біологічні ідеї», певною мірою справедливо і по відношенню до взаємозв'язку між психологією та математикою. Але якщо досі ми говоримо про цей зв'язок з позиції того, що дала психологія математики, то тепер розглянемо, що ж дає математика психології? [3-7].

Зупинимося на одній проблемі, яку без будь-якого перебільшення можна назвати загальною перешкодою для більш ефективного використання математики у всіх галузях психології. Це проблема «мови». Справа в тому, що застосування математичних методів для відчуття психологічних явищ, як і застосування пси-

хологічних знань при проектуванні складних систем, вимагає для свого опису єдиної термінологічної мови. Відсутність такої мови призводить іноді до досить плачевних результатів. Проте спілкування між психологами та математиками виглядає іноді абсурдним. Так, якщо психологам і вдається сформулювати для математиків сенс поставленої проблеми, то математикам найчастіше не вдається донести до психологів сенс математичних результатів. З історії психології добре відомо, що, наприклад, психофізика почала свій розвиток зі встановлення закономірностей (знаменита формула Вебера Фехнера). В даний час математичні процедури обов'язково входять до таких розділів психології як психометрика, психодіагностика, диференціальна психологія. Сучасна психогенетика, наприклад, широко використовує такий розділ вищої математики як структурне моделювання і т. д. У той самий час головна відмінність галузей психологічних знань, використовують математичні методи, у тому, що й предмет дослідження як може бути описаний, але вимірний. Можливість вимірювання того чи іншого психологічного феномена (властивості, характеристики, риси і т. д.) відкриває доступ для застосування методів кількісного аналізу, а значить і відповідних обчислювальних процедур. У своїй роботі психолог часто стикається з проблемою вимірювання індивідуально-психологічних особливостей, таких, наприклад креативність, нейротизм, імпульсивність, властивості нервової системи та ін. І тому розробляються різні вимірювальні процедури – тести, моделі (процесів пізнання, особливості мотивації ціннісних орієнтацій особистості) тощо. Числове уявлення об'єктів чи подій дозволяє оперувати складними поняттями у більш скороченій формі. Саме це і є причиною використання вимірювань у будь-якій науці [4-7].

Зв'язок математики та психології. Тісне переплетення психології та математики пов'язано з тим, що практично всі прикладні дисципліни засновані на розрахунку конкретних показників. Використання математичних методів у наукових працях психології дозволяють вирішити такі задачі: зробити доказову базу більш структурованою та чіткою, вагомою; оцінити ситуацію на базі кількісних показників (хто, що і скільки); скласти математичну модель ситуації, що склалася, і спрогнозувати подальший сценарій розвитку подій; оцінити вплив конкретних факторів та параметрів на результативний показник.

Математичні методи необхідні обробки даних, зібраних шляхом спостереження чи експерименту. З їхньою допомогою вирішують завдання:

- встановлення подібності чи відмінності;
- на угруповання, класифікацію інформації;
- на оцінку, аналіз джерел даних;
- на складання прогнозу з урахуванням отриманої інформації.

Використання математичних методів у психології дозволяє проаналізувати систему загалом та окремі її частини. Математика дозволяє впорядкувати дослідження та грамотно побудувати психологічні теорії.

Сутність математичних методів – опис психологічних явищ за допомогою кількісних показників. Застосування алгоритмів під час розрахунку результатів знижує ризик появи помилки. Інформацію можна збирати, обробляти та класифікувати одночасно. Зараз математика займає окреме місце у психології. Її виділення у самостійну дисципліну йшло поступово. У цьому є окремі етапи, докладно розглянуті у книзі Первитської А. М. «Математичні методи у психології»:

1. кінець 19 – початок 20 століття. Результати експерименту вперше обробляють заданий алгоритм. Сформувалися перші закони та дисципліни.

2. 40-50 рр. З'явилася перша модель психічних процесів, розроблена з використанням матаналізу. Проведення практичних випробувань.

3. із 60 р. до теперішнього часу. Офіційне визнання самостійності галузі. Включення до списку обов'язкових вивчення дисциплін.

Математичну психологію часто сприймають як сукупність математичних методів, але насправді вони лише частина дисципліни, як експеримент частина дослідження.

Етапи математичної обробки даних у психологічному дослідженні.

Шкала вимірювань – зручний спосіб обробки даних. Насамперед використовують кількісну шкалу. З її допомогою дані ранжують – розподіляють за показниками. Дані розміщуються у порядку зменшення або зростання. Кожному значенню додають ранг, що визначає мінімальний та максимальний показник. Порівняння рангів необхідне розподілу даних із групам.

Кореляційний аналіз – встановлення зв'язку між явищами. Кореляцію оцінюють за силою, напрямом. Показники можуть зростати і зменшуватися, через що змінюється тип залежності даних. Він буває лінійним (показники рівновіддалені), але найчастіше виражений у формі кривої.

Факторний аналіз – прогнозування результатів. Спочатку дані розцінюються як рівні показники, для отримання результатів їх табулюють (заносять до таблиці) або використовують графічну побудову.

Стратегії обробки даних під час роботи з гіпотезами

Гіпотеза – припущення, яке вимагає перевірки. Щоб використання методів математичної обробки в психології давало достовірний результат, дослідники повинні дотримуватись правил вибору, перевірки гіпотези:

Статистичні гіпотези бувають нульовими та альтернативними. Вони несумісні та взаємовиключні.

Перевіряти гіпотезу потрібно за допомогою статистичних критеріїв – правил, за якими приймають істинну та відхиляють хибну гіпотезу.

Критерії бувають параметричними (дані розподілені за шкалою) та непараметричними (розподіл даних не враховується).

Порядок перевірки критеріїв включає вибір критерію, визначення залежності чи незалежності вибірки, кількість вибірок.

Гіпотезу оцінюють за числовими характеристиками. Точково, вибравши одне число на осі або інтервально, використовуючи вимірювання відрізка даних на осі. Вибір методу перевірки гіпотези залежить від поставленого завдання. За допомогою алгоритмів можна оперувати великим обсягом даних та отримувати достовірні результати. Недоліки:

1. Результати моделювання необхідно підтверджувати експериментом у реальних умовах.

2. Моделювання не дає заглянути далі досліджуваної області даних.

3. При виборі експерименту підвищується ризик «підгонки» реальних даних під процес, що моделюється.

Принципи застосування у дослідженнях. Принципи застосування математичних методів – положення, які використовують у психології. Вони визначають застосування та стратегії подальшого розвитку науки. До них відносяться: принцип детермінізму, який вимагає пояснення феноменів, що вивчаються, через загаль-

ноприйняті факти (під загальноприйнятими розуміються факти, офіційно визнані вченими і опубліковані у відповідній літературі); принцип єдності особистості, діяльності і свідомості [1–7]. З метою обробки даних та проведення якісного аналізу в психологічному дослідженні важливо дотримуватися певного алгоритму дій, етапів математичної обробки даних.

1. Переклад емпіричних даних на математичний вигляд. Ця стадія передбачає, що автору наукової роботи потрібно відсортувати всі зібрані відомості згідно з певними параметрами, критеріями та оформити їх за допомогою таблиць, графіків або діаграм. Наприклад, розбити піддослідних на групи за віком, статтю, освітою, темпераментом та ін.

2. Визначення результативного показника та змінних. Тут досліднику необхідно визначити, що саме він має намір дослідити (який параметр) і позначити його як результативний показник. Всі інші фактори (елементи), які впливають на шуканий коефіцієнт, прирівнюються до змінних.

3. Визначення математичного методу обробки даних. На цьому етапі слід скласти математичну модель досліджуваних явищ та процесів. Це може бути сума окремих частинок або комбінація дій. Важливо визначити, з чого складається результативний показник і як це відобразити мовою математики з урахуванням наявних даних. Найбільш поширеними математичними методами, що застосовуються у психології, є факторний аналіз, дискримінантний аналіз, множинна регресія, аналіз шляхів, дисперсійний аналіз, підступний аналіз та ін.

4. Проведення аналізу. Залежно від мети психологічного дослідження, наявних даних, дослідник може використовувати різні методи аналізу: факторний, кореляційний, моделювання та ін.

5. Формування висновків. На основі отриманих даних автору наукової роботи з психології належить відобразити отримані результати аналітичної роботи. Тут слід розшифрувати: які дії проводилися, які параметри і що означають, які результати були отримані, про що вони свідчать.

Таким чином, математичні методи у психологічному дослідженні дозволяють упорядкувати всі дані, зробити доказову базу більш вагомою та аргументованою, а результати наукової роботи точнішими.

Висновки. У психології математичні методи мають широке застосування. Це зумовлено кількома моментами: 1) математичні методи

дозволяють зробити процес дослідження явищ більш чітким, структурним і раціональним; 2) математичні методи необхідні для обробки великої кількості емпіричних даних (їх кількісних виразників), для їх узагальнення та організації в емпіричній картині дослідження залежності; 3) для функціонального призначення цих методів та потреб психологічної науки виділяють дві групи математичних методів, використання яких у психологічних дослідженнях є найчастішими: перша – методи математичного моделювання, друга – методи математичної статистики (або статистичні методи). Метод математичного моделювання застосовується: а) як засіб організації теоретичного дослідження психологічних явищ через побудовану модель-аналогів досліджуваних явищ та виявлення таким чином закономірностей функціонування та розвитку змодельованої системи; б) як засіб побудови алгоритмів дії людини в різних ситуаціях її пізнавальної та перетворюючої діяльності та побудова на їх основі що пояснюють, розвивають, навчальні, ігрові та інші комп'ютерні моделі.

Література.

1. Галян О. І. Галян І. М. Експериментальна психологія : навч. посібник. К. : Академвидав, 2012. С. 354-355.
2. Касярум С. О. Підготовка майбутніх психологів до застосування методів математичної статистики у практичній діяльності та дослідженнях. Науковий вісник Льотної академії. 2021 р., Випуск 9. С. 50-55.
3. Вальчук О. А., Матохнюк Л. О. Особливості застосування статистичного критерію * Фішера в психолого-педагогічних дослідженнях. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2014. № 38. С. 208–213.
4. Климчук В. О. Викладання курсу «Математичні методи у психології» в умовах кредитно-модульної системи // Соціальна психологія. – 2008. – №2 (28). – С. 180-189.
5. Климчук В. О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник. – К. : Освіта України, 2009. – 288 с.
6. Кричевец А. Н. Математика для психологов: Учебник / А. Н. Кричевец, Е. В. Шикин, А. Г. Дьячков / Под ред. А. Н. Кричевца. М., 2003. – 198 с.
7. Телейко, А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології: навч. посіб./ А. Б. Телейко, Р. К. Чорней . – Київ : МАУП, 2007. – 418 с.

1.5. Важливість психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності

Дубик Т. В.

Актуальність: В сучасному світі, зростаюча конкуренція та швидкий темп змін у різних сферах життя вимагають від фахівців не тільки технічної кваліфікації, але й здатності ефективно працювати в умовах стресу та невизначеності. Психологічна підготовка та розвиток ціннісних орієнтацій стають ключовими аспектами, які впливають на успіх у професійній діяльності, оскільки психологічна підготовка допомагає виробити механізми стресостійкості, що є важливим аспектом у сучасному професійному середовищі, де фахівці часто стикаються з тиском термінів, великим обсягом роботи та несподіваними ситуаціями, а розвиток ціннісних орієнтацій сприяє особистісному росту, допомагає визначити власні цілі та цінності.

Окрім того, працівники з високим рівнем психологічної підготовки та розвиненими ціннісними орієнтаціями мають більшу ймовірність досягти успіху у своїй професійній діяльності, а розуміння власних цілей та цінностей сприяє більшому задоволенню від роботи та збереженню високого рівня мотивації [1].

Мета. Теоретично проаналізувати важливість психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у контексті професійної діяльності, визначити вплив цих аспектів на працездатність та особистісний розвиток фахівців.

Результати дослідження: У сучасному професійному середовищі, де вимоги до фахівців є високими, важливість психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій. Психологічна підготовка та розвиток ціннісних орієнтацій у професійній діяльності представляють собою важливий комплексний аспект, що визначає успіх та професійне задоволення в роботі фахівця. Ціннісні орієнтації, такі як етика, відданість професії та спільні цілі, формують особистісний фундамент для високоефективної професійної діяльності [3].

Психологічна підготовка, включаючи розвиток стресостійкості, емоційного інтелекту та гнучкості управління власними емоціями, визначає здатність фахівця адаптуватися до змін і ефективно взаємодіяти в колективі. Це особливо актуально в умовах швидко-го розвитку технологій та постійних змін у ринкових умовах.

На підставі аналізу літератури та проведення практичних досліджень визначено, що психологічна підготовка дозволяє підвищити стресостійкість та адаптивність до змін, а розвиток ціннісних орієнтацій сприяє формуванню цілісної особистості та покращує міжособистісні взаємини в колективі [2; 4].

Цінності пов'язані з формуванням спрямованості особистості, визначають мотивацію її поведінки, тому суттєво впливають на всі аспекти діяльності людини. В процесі розвитку особистості, її професійного становлення, цінності зазнають певних змін залежно від їх значення та ролі в житті людини. Саме тому питання становлення людських цінностей є важливим для кожної науки, що займається дослідженням людської поведінки.

У психологічній науці питання становлення цінностей посіло одне з головних місць, неодноразово привертаючи дослідницький інтерес науковців. Проблема формування ціннісних орієнтацій у професійній діяльності представлена надзвичайно широким колом наукових робіт. Особлива увага приділяється науковцями і проблемі розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності і стала предметом теоретичних та емпіричних досліджень О. Ф. Бондаренко, І. С. Булах, Ж. П. Вірна, О. О. Грейліх, О. Д. Кайріс, Н. П. Максимчук, В. М. Мицько, А. А. Фурман, Т. М. Яблонська, С. В. Яремчук тощо. Таким чином, соціальна значущість проблеми психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності є принципово важливою, оскільки ці елементи визначають не лише особистісний розвиток індивіда, але й ефективність та стабільність його професійного виконання.

На основі аналізу наукової літератури такі дослідники як О. О. Міненко, Т. А. Садова виокремлюють кілька аспектів, які стали предметом розгляду вчених та які підкреслюють важливість цих елементів:

1. Емоційна стійкість та саморегуляція: психологічна підготовка допомагає фахівцеві розвивати емоційну стійкість та здатність

до саморегуляції в стресових ситуаціях. Це важливо в будь-якій професійній галузі, де робота з людьми або у вимогливих умовах може призвести до психологічних труднощів.

2. Комунікаційні вміння та міжособистісна ефективність: психологічна підготовка сприяє розвитку навичок ефективної комунікації та взаємодії з колегами, клієнтами чи партнерами. Це важливо для будь-якого спеціаліста, оскільки комунікаційні аспекти визначають успіх в роботі та побудову взаємин.

3. Моральні та етичні засади: розвиток ціннісних орієнтацій включає формування моральних та етичних принципів. Фахівець, який має цінності, може більш ефективно приймати етичні рішення та викликати довіру в колективі та серед клієнтів.

4. Творчість та адаптивність: психологічна готовність до творчого мислення та адаптивності умовою швидкоплинного світу. Розвинуті психологічні навички дозволяють ефективно впоратися з новими завданнями та викликами.

5. Розвиток лідерських якостей: психологічна підготовка сприяє розвитку лідерських якостей, таких як емпатія, вміння мотивувати та вести колектив [2; 4].

Усе це свідчить про те, що психологічна підготовка та розвиток ціннісних орієнтацій визначають не лише успіх професіонала у його особистій кар'єрі, але й сприяють покращенню робочих відносин, підвищенню якості послуг та формуванню сильної та етичної професійної спільноти.

Практична реалізація цих аспектів у вигляді тренінгів, консультацій та інших форм підтримки може виявитися вкрай ефективною для фахівців у будь-якій сфері. Високий рівень психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій не лише підвищує результативність роботи, але й сприяє створенню здорового та продуктивного професійного оточення. Саме тому, інтеграція психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у систему професійної підготовки є ключовою для створення конкурентоспроможних та морально налаштованих фахівців, які готові до викликів інноваційного та динамічного ринку праці.

Наукові та практичні дослідження в галузі психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльно-

сті таких науковців, як А. Маслоу, В. Вронський, Д. Гоулман тощо свідчать про низку додаткових аспектів:

1. Командна праця: розвиток ціннісних орієнтацій сприяє покращенню співпраці в команді. Фахівці, що розуміють і поділяють загальні цінності, ефективніше співпрацюють для досягнення спільних цілей.

2. Адаптація до змін: психологічна підготовка допомагає фахівцям легше адаптуватися до швидко змінюючихся умов ринку та технологій, що важливо для довгострокового успіху в кар'єрі.

3. Вплив на професійне вигорання: високий рівень психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій може допомогти у попередженні професійного вигорання, забезпечуючи фахівців ефективними стратегіями управління стресом та власними емоціями.

4. Гендерний аспект: розвиток емоційного інтелекту та ціннісних орієнтацій може впливати на подолання гендерних стереотипів у професійній сфері.

5. Креативність та інновації: фахівці з розвиненими ціннісними орієнтаціями та психологічною гнучкістю частіше проявляють креативність та готовість до інновацій, що є важливим для конкурентоспроможності у сучасному світі [5].

Ці додаткові аспекти підкреслюють значущість інтеграції психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій, як необхідних елементів для успішної та задовільної професійної діяльності.

Інтеграція цих аспектів у систему професійної підготовки та розвитку фахівців є ключовою для створення конкурентоспроможних та етичних лідерів, здатних не лише досягати власних професійних цілей, але й сприяти створенню позитивного та продуктивного робочого середовища. Відданість психологічній підготовці та розвитку ціннісних орієнтацій є необхідною умовою для впорядкування сучасного фахівця в умовах високого темпу змін та конкурентності допомагаючи їм досягати високих результатів та особистісного задоволення в професійній сфері.

Для глибшого розуміння важливості досліджуваної проблеми, розглянемо низку факторів, які виокремлюють дослідники Вакуленко В., Міненко О. та Тушева В., вивчаючи професійне становлення практичних психологів та педагогів. На думку науковців, саме ці

фактори суттєво впливають на формування психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності:

1. Емоційний інтелект: психологічна підготовка дозволяє розвивати емоційний інтелект, що є важливим для ефективного взаємодії з колегами, клієнтами та іншими учасниками професійного співтовариства. Здатність розпізнавати та керувати власними емоціями, а також емпатія до емоцій інших, покращують якість міжособистісних відносин та комунікації [2].

2. Стресостійкість: розвиток стресостійкості дозволяє ефективно впоратися з труднощами та несподіванками, що неминуче зустрічаються у професійному житті. Фахівці з високим рівнем стресостійкості здатні зберігати холонокровність та продовжувати працювати продуктивно навіть у складних ситуаціях [5].

3. Цінності як орієнтир: розвиток ціннісних орієнтацій допомагає фахівцеві чітко визначати свої цілі та принципи, які впливають на прийняття рішень у професійному житті. Ціннісні орієнтації стають важливим орієнтиром, який допомагає уникати конфліктів і приймати обґрунтовані рішення [1].

4. Міжособистісні вміння: психологічна підготовка сприяє розвитку міжособистісних вмінь, таких як ефективна комунікація, врегулювання конфліктів та співпраця в команді. Це необхідно для успішного виконання завдань та досягнення спільних цілей у професійному оточенні [3].

5. Особистісний розвиток: психологічна підготовка сприяє особистісному росту, допомагає фахівцю зрозуміти себе краще, визначити власні слабкі та сильні сторони, а також створити план для подальшого самовдосконалення. В цілому, психологічна підготовка та розвиток ціннісних орієнтацій впливають на психологічний комфорт, продуктивність та задоволення від професійної діяльності, створюючи основу для успішної та задовільної кар'єри [1].

6. Етичність і професійна інтеграція: психологічна підготовка сприяє формуванню вищих стандартів етики та професійної інтеграції. Фахівці, які розуміють моральні аспекти своєї роботи та дотримуються високих етичних стандартів, мають можливість побудувати довіру серед клієнтів, колег та інших учасників професійного співтовариства [5].

7. Адаптабельність та гнучкість: психологічна готовність дозволяє адаптуватися до змін у робочих умовах та розвивати гнучкість у вирішенні проблем. Фахівці, які легко адаптуються до нових викликів, залишаються конкурентоспроможними в швидкозмінному професійному оточенні [4].

8. Побудова позитивного робочого середовища: ціннісні орієнтації, такі як колективізм, взаємоповага та підтримка, визначають атмосферу в робочому колективі. Психологічна підготовка допомагає створити позитивне та сприятливе середовище для ефективної співпраці та досягнення спільних цілей [2].

9. Конструктивне управління конфліктами: здатність ефективно вирішувати конфлікти та шукати конструктивні рішення є важливою для підтримки гармонійних міжособистісних відносин у професійному оточенні [3].

10. Особиста задоволеність та виклик для саморозвитку: психологічна підготовка сприяє формуванню особистого задоволення від професійної діяльності та прагнення до постійного саморозвитку. Це важливо для стимулювання внутрішньої мотивації та досягнення високих результатів [4; 5].

У світлі сучасних викликів та вимог ринкових умов, важливість психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності стає настільки критичною, що можна визнати їх як визначальні фактори успіху у кар'єрі. Розуміння важливості особистісного зростання, етичних принципів та психологічної гнучкості визначає якість та стабільність професійної траєкторії.

Успішні фахівці сьогодення повинні володіти не лише технічними навичками, але й бути здатними пристосовуватися до нових умов, ефективно співпрацювати в команді та враховувати етичні стандарти. Психологічна стійкість та готовність до самовдосконалення ідуть пліч-о-пліч з особистісним зростанням та формуванням принципів.

Інтеграція цих аспектів у навчальні та професійні програми є стратегічно важливою для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та стабільності в кар'єрі. Фахівці, які розуміють себе, свої цінності та мають розвинену психологічну готовність, стають не лише професіоналами, але й керівниками позитивних змін у своїх галузях, сприяючи створенню більш стійкого, інноваційного та гуманного професійного середовища. Важливо підкрес-

лити, що психологічна підготовка та розвиток ціннісних орієнтацій є ключовими факторами, що визначають успіх та задоволення в професійній діяльності. Сучасний світ вимагає від фахівців не лише технічної експертизи, але й високого рівня самопізнання, емоційної інтелігентності та готовності адаптуватися до постійних змін. Засвоєння психологічних навичок та формування ціннісних орієнтацій стають фундаментом для створення здорового та продуктивного робочого середовища. Ці аспекти не тільки забезпечують високий рівень ефективності та адаптивності, але й покращують якість міжособистісних відносин у колективі та сприяють розвитку позитивного корпоративного клімату. Урізноманітнення підходів до психологічної підготовки, інтеграція цих аспектів у систему освіти та професійного розвитку є необхідністю сьогодення. Це допомагає створювати фахівців, які не тільки досягають власних цілей, але й вносять позитивні зміни у свої сфери, будуючи майбутнє професійної діяльності на цінностях, етиці та розумінні важливості гармонії між особистісним та професійним розвитком.

Висновки: Отже, представлені нами вище підходи підкреслюють важливість включення психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у план професійної підготовки фахівців, що сприятиме підвищенню рівня їхньої адаптивності, збільшує професійну компетентність та стабільність у професійній діяльності. Сприйняття власних цінностей та глибоке розуміння себе є ключовим для досягнення успіху особистості у кар'єрі, тому інтеграція психологічної підготовки та ціннісних орієнтацій у професійну практику та освіту стає стратегічною необхідністю для підготовки фахівців, які не лише володіють технічною експертизою, але й мають емоційну інтелігентність та готовість до постійного розвитку, а висока якість психологічної підготовки та усвідомлені цінності стають ключовими стовпами, на яких ґрунтується сталість та успішність сучасного фахівця у динамічному світі професійної діяльності. Швидка зміна умов ринку та високий темп технологічного розвитку підкреслюють необхідність глибокої саморефлексії та емоційної інтелігентності для досягнення високої результативності та особистісного зростання, а запровадження якісної психологічної підготовки, спрямованої на розвиток емоційного інтелекту та стресостійкості, а також формування ціннісних орієнтацій у си-

стему навчання та розвитку фахівців є стратегічною ініціативою, що визначає майбутнє успішної та гуманної праці. Ті, хто інвестує у свій внутрішній розвиток та розуміють важливість особистісних цінностей, стають архітекторами свого власного успіху та активними учасниками створення позитивного впливу на оточуючих. Таким чином, психологічна підготовка та розвиток ціннісних орієнтацій є визначальними складовими сучасного професійного виховання, що визначає якість та значущість професійного шляху.

Література.

1. Вакуленко В. М. Роль гендерного аспекту у формуванні ціннісних орієнтацій на ідеях народної педагогіки майбутніх педагогів. URL: <http://archive.nbuv.gov.ua>.
2. Міненко О. О. Професійне становлення практичного психолога як система парадигмальних змін. Вісник Харківського Національного Університету. Серія «Психологія». 2012. № 550. С. 209-211.
3. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. XII. Част. 4. Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2010. 492 с.
4. Садова Т. А. Аксиологічний підхід у системі педагогічної методології. Дошкільна освіта. 2010. № 1 (27). С. 63-69.
5. Тушева В. В. Цінності у структурі професійної культури майбутнього вчителя. Збірник наукових праць. № 1. Бердянськ: БДПУ, 2010. С. 151-157.

1.6. Особистісні та професійні компетентності як чинник професійної діяльності особистості

*Каленіков С. А., Менько А. В.
Романчишин О. П., Шевченко Д. О.*

Актуальність. На сьогодні існує багато різних компаній, організацій та установ, які функціонують в різних сферах економіки, але чи всі вони є процвітаючими, прибутковими та мають стабільний дохід. Одностайно відповідь: ні. Одні організації досягають успіху і інтегрують, виходячи на світовий ринок, чи розширюють сферу діяльності тим самим збільшуючи свій капітал, але ж є компанії та організації в занепаді чи ще гірше: на грані банкрутства. На мою думку, головна причина криється в ефективному та динамічному керівництві, в талановитих та вмілих робітниках та правильно обраному стилю керівництва.

Мета проаналізувати особистісні та професійні компетентності як чинник професійної діяльності особистості.

Результати досліджень. Оскільки індивідуальна діяльність керівника в організаційній системі займає центральне місце, то її вивчення і є головною проблемою теорії управління. Необхідно враховувати труднощі психологічного вивчення цієї діяльності, складності виділення діяльнісної проблематики із проблематики загально організаційної. Вони полягають у наступному. 1. Діяльність керівника перебуває в тісному зв'язку з усіма аспектами функціонування організації. Таким чином, проблема управлінської діяльності повинна вивчатися як специфічний аспект при розгляді всіх проблем керування. Існують позитивні й негативні наслідки такого широкого фронту вивчення психології управлінської діяльності, що проявляються в її розмитості по іншим розділам теорії управління. 2. Управлінська діяльність досліджувалася в цілому комплексі дисциплін, при цьому домінували її не психологічні аспекти: організаційний, соціологічний, економічний тощо. 3. Найбільше важко психологічне вивчення управлінської діяльно-

сті в науковому плані, тому що тут предметом дослідження є така невизначена сфера, як психічна реальність. Тому більше вивчені зовнішні прояви управлінської діяльності, ніж її внутрішній зміст. Основний принцип пізнання цієї діяльності – вимога комбінації аналізу її зовнішнього й внутрішнього змісту.

Основні компоненти структури діяльності: ціль, мотивація, інформаційна основа, план, ухвалення рішення, психічні процеси, механізми контролю та корекції тощо. Дія – основна одиниця будови діяльності, що представляє собою довільну й навмисну активність, спрямовану на досягнення поставленої мети. Операції – це неусвідомлені, автоматизовані дії, що є способами виконання діяльності. Стабільність структури основних компонентів діяльності позначається поняттям інваріантної структури діяльності. Зміни, іноді дуже істотні, вона може перетерплювати у зв'язку із відмінностями видів і форм самої діяльності, умов її реалізації. Тому так численні класифікації видів діяльності в психології: по предметній сфері праці; по специфіці змісту (інтелектуальна й фізична); по специфіці предмета; по загальному характеру тощо.

Проблеми лідерства являються ключовими для досягнення організаційної ефективності. З однієї сторони, лідерство розглядається як наявність певного набору якостей, які притаманні тим, хто успішно спричиняє вплив на інших, з іншої, лідерство – це процес несилового впливу у напрямку досягнення організацією своїх цілей. Для того, щоб складна організація ефективно виконувала свої задачі необхідно забезпечити виконання всіх функцій управління. Лідерство – являється тим видом діяльності, який пронизує всю систему управління. Неможливо ефективно виконувати функції планування, організації, мотивації і контролю, якщо немає ефективного керівництва і лідерів, здатних заохочувати інших працівників, позитивно впливати на них і вести за собою, тим самим досягаючи позитивних кінцевих результатів.

Не зважаючи на те, що керівництво – суттєвий компонент ефективного управління, ефективні лідери не завжди є одночасно і ефективними управлінцями. Про ефективність лідера можливо судити по тому, в якій мірі він чи вона впливають на інших. Іноді ефективне лідерство може і заважати формальній організації.

Наприклад, впливовий неформальний лідер може зробити так, що трудовий колектив почне обмежувати випуск продукції чи виробляти товари та послуги низької якості. Якщо взяти за інший приклад директора заводу, то за посадою він є менеджером. Посада відкриває йому дорогу до лідерства. Процес впливу на людей з позиції посади, яку він займає, називається формальним лідерством. Однак, в своєму впливі на людей директор не може покладатися тільки на посаду, яку він займає. Наглядно це становиться очевидним, коли виявляється, що один із заступників, який має менш формальної влади, користується більшим успіхом в управлінні стресовими й конфліктними ситуаціями, а також при вирішенні життєво важливих для підприємства проблем. Бути менеджером ще не означає автоматично вважатися лідером в організації, тому що лідерству в значній мірі притаманна неформальна основа. Можна займати першу посаду, але не бути в ній лідером. Тому можна сказати, що нове управлінське мислення потребує, щоб керівництво людьми здійснювали не формальні начальники, а лідери, які користуються в колективі неформальним авторитетом.

Діяльність – це форма активного відношення суб'єкта до дійсності, пов'язаного зі створенням суспільно значимих цінностей і освоєнням суспільного досвіду й спрямованого на досягнення свідомо поставлених цілей. Предметом психологічного вивчення діяльності є психологічні компоненти, що регулюють і спрямовують трудову активність суб'єкта й властивості особистості, через які реалізується ця активність. Основні психологічні властивості діяльності: активність, усвідомленість, цілеспрямованість, предметність, системність її будови. Мотив – це основа діяльності.

З вище зазначеного можна сказати, що феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника. Розрізняють формальний, особистий і повний авторитет керівника.

Формальний авторитет керівника впливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, давати їм завдання, вимагати виконання їх, контролювати і стимулювати їхню працю.

Особистий авторитет керівника визначається комплексом його особистих якостей як людини, таких як людяність, толерантність, етичність та ін. Повний авторитет керівника, або авторитет лідера,

виявляється при поєднанні формального і особистого авторитету особи, яка обіймає керівну посаду.

Вивчення природи лідерства в соціальних спільнотах показує, що лідери, як правило, мають ряд чітко виявлених якостей. По-перше, спосіб життя лідера передбачає тісне поєднання кар'єри і особистого життя.

По-друге, лідер ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Здібності, честолюбність, талант, знання стимулюють лідера до подальшого розвитку і удосконалення їх.

По-третє, лідер знаходить своє справжнє покликання у застосуванні успадкованих здібностей та набутих навичок, розуму, знань, таланту як способу самореалізації саме у керівництві іншими людьми.

В ході вивчення проблеми лідерства вченими було запропоновано багато різних визначень даного поняття. В своїх визначеннях лідерства багато авторів намагались чітко сформулювати той особливий компонент, який вносить сам лідер. Наприклад, Катц і Кан розглядають лідерство як елемент, який справляє вплив і проявляється незалежно від механічного виконання повсякденних доручень організації. Лідерство – це здатність підняти людське бачення на рівень більш широкого кругозору, вивести діяльність людини на рівень більш високих стандартів. Згідно з Дж. Террі, лідерство – це вплив на групи людей, який спонукає їх до досягнення спільної мети. Р. Танненбаум, І. Вешлер і Ф. Массарик визначали лідерство, як міжособову взаємодію, яке проявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікаційного процесу і направлене на досягнення цілей. Узагальнюючи різні визначення можна вивести єдине, яке на нашу думку буде відповідати самої суті цього поняття. Лідерство – це тип управлінської взаємодії (в даному випадку між лідером і послідовниками), заснований на поєднанні різних джерел влади в залежності від конкретної ситуації та спрямований на спонукання людей для досягнення спільних цілей. Іншими словами лідерство – стосунки домінування і підпорядкування, впливу і прямування в системі міжособистісних стосунків в групі, які ведуть до наміченої мети. Звідси Лідер (від англ. Leader – провідник, керівник) – це: член групи, за яким вона визнає право приймати рішення в значущих для неї ситуаціях; індивід, здатний виконува-

ти центральну роль в організації спільної діяльності і регулюванні взаємостосунків у групі.

Лідерство є процесом, за допомогою якого одна особа впливає на поведінку інших членів групи. Отже, лідерство є дещо вужчим поняттям, ніж керування, хоча діапазон його застосування є ширшим.

Керівник у своєму впливі на оточення і в побудові стосунків із ними перш за все використовує і покладається на посадову основу влади та джерела, що її живлять. Лідерство ґрунтується більше на процесі соціальної взаємодії у групі людей, що є набагато складнішим – віднайти ті важелі, за допомогою яких можна впливати на поведінку інших людей, не маючи для цього формальних (законних) підстав і стати лідером групи вдається далеко не кожному.

Лідерські стосунки відрізняє те, що послідовники визнають лідера лише тоді, коли він довів свою компетентність і цінність для групи. Отже, лідер отримує свою владу від послідовників. Для підтримання своєї позиції він повинен надавати їм можливість задовольняти їхні потреби. У відповідь послідовники задовольняють лідерську потребу у владі і надають йому необхідну підтримку у досягненні організаційних цілей.

Відносини до роботи і колег представляють собою стійкі почуття, що виражаються в переконаннях і типах поведінки, вони спрямовані на виробничу діяльність, на членів своєї робочої групи, організаційне середовище. Відносини між співробітниками в організації складаються з урахуванням як інтересів виробництва, так і психологічної сумісності членів групи, сприйняття ними один одного. Згуртованість групи залежить і від того, наскільки привабливими здаються один одному її члени. Важливою стороною діяльності менеджера є вирішення виникаючих в організації конфліктів. Конфлікт – це протиріччя, що супроводжується гострими емоційними переживаннями, зіткненням протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок. Виділяють внутрішньо-особистісні, міжособистісні і між групові конфлікти. Кожен з них несе в собі деструктивні (руйнівні) та продуктивні моменти. Завданням менеджера є не стільки уникнення конфлікту, скільки утримування під контролем його деструктивних аспектів і використання продуктивних. Причини виникнення конфліктів можна розділити на дві основні групи: чинники, пов'язані з структурою організації або

її функціонування та пов'язані з міжособистісним відносинам. Основними способами управління конфліктом є: угода (переговори), вироблення спільних цілей, уточнення і роз'яснення механізмів відповідальності і повноважень.

Вирішення конфлікту можливе на двох рівнях: на частковому, коли усувають тільки конфліктну поведінку, але не усувають глибинні психологічні, внутрішні спонукання до конфлікту; на повному, коли конфлікт вирішення і на рівні реальної поведінки, і на психологічному (емоційному) рівні.

Часткове вирішення конфлікту наявне, якщо, зважаючи на відповідні зміни реальних умов середовища, конфліктна ситуація змінюється так, що сторони вимушені припинити конфліктні дії. Хоча намагання досягнути своїх початкових цілей у них збереглося. Саме до цього приводять адміністративні вирішення конфлікту, коли запроваджують певні санкції та заборони.

Щоб успішно вирішити конфлікти, керівникові передусім необхідно вміти: реально оцінити і проаналізувати кожную конфліктну ситуацію; відрізнити безпосередній привід конфліктного зіткнення від його причин, який можуть маскувати учасники конфлікту; визначити «ділову (об'єктивну) зону» конфлікту. Важливо з'ясувати, якою мірою предмет суперечок стосується технології виробництва, системи організації та оплати праці в колективі, а якою – особливостей ділових та особистісних взаємин сторін, які конфліктують. Це дасть змогу в процесі визначити характер конфлікту і локалізувати його сферу;

- визначити мотиви «входження» людей у конфлікт. Для цього необхідно знати життєвий шлях працівників, особливо в останній період, їхні погляди і переконання, інтереси і запити;

- визначити спрямованість конкретних дій учасників конфлікту, маючи на увазі те, що саме у засобах, які використовують сторони, відображаються мотиви участі у конфлікті.

Завдяки індивідуальним психічним особливостям людей спостерігаються великі відмінності у виборі шляхів управління конфліктом. Дуже важливий при цьому і культурний чинник. У багатьох західних країнах, для яких характерна індивідуалістична культура, перевагу в основному віддається конкуренції. У багатьох африканських і азійських культурах, які за своєю природою ко-

лективістичних, переважає запобігання конфлікту і прагнення до примирення.

Види конфліктів міжособистісних конфліктів в організації. За змістом, міжособистісні конфлікти поділяються: внутрішньо особистісні, зумовлені боротьбою мотивів, коли керівники ставлять суперечні й навіть протилежні вимоги; міжособистісні, що виникають під час розподілу ресурсів, робіт, матеріальних заохочень, обов'язків тощо; зумовлені різними рисами характеру, неоднаковим рівнем знань, кваліфікаційних особливостей, рівнів інтелекту тощо; між особистістю і групою, спричинений порушеннями групових норм, своїх обов'язків, загальних «правил гри», етики поведінки, культури взаємин тощо; між груповий, що виникає між лінійним і штабним персоналом, профспілкою і адміністрацією, формальними і неформальними групами тощо. Головною причиною є зіткнення інтересів різних груп. Можна вести мову про п'ять головних міжособистісних способів вирішення конфлікту: ухилення, уникнення; згладжування, пристосування; примус (примушування), конкуренція; компроміс; вирішення, розв'язання проблеми (співпраця).

Висновки. Узагальнюючі можна зазначити, що в сучасних умовах – лідерство дасть нам змогу підняти людське бачення на рівень більш широкого світогляду, вивести ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів, а також сформувати особистість здатну досягти великих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Процес лідерства дасть змогу вдосконалити внутрішньо-управлінську структуру відносин в організації, забезпечити постійний рух вперед для досягнення найкращих результатів, корисних як для суспільства, так і країни в цілому. Дослідивши сутність лідерства на основі наявних теорій, підходів, стилів лідерства, можна робити висновок, що лідерство – це процес за допомогою якого певні індивіди ведуть за собою групу до досягнення певної мети. Лідер займає свою посаду спонтанно в умовах специфічної ситуації, важливої для життєдіяльності всієї групи. Ефективність діяльності групи буде більшою, якщо лідер є офіційним керівником групи. Отже, проблеми лідерства є ключовими у досягненні організаційної ефективності. З одного боку, лідерство розглядається як наявність певного набору якостей, які притаманні тим, хто успішно впливає на інших, з другого, лідер-

ство – це процес переважно несилового впливу в напрямі досягнення групою або організацією своїх цілей. Лідерство являє собою специфічний тип управлінської взаємодії, що ґрунтується на найефективнішому використанні різних джерел влади і спрямований на спонукання працівників до досягнення спільних цілей.

Література.

1. Балахтар В. В. Психологія особистості фахівця з соціальної роботи : монографія. Київ : Талком, 2018. 384 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: словник / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
3. Максименко С. Д. Особистість: прогноз розвитку і життєвий шлях. Генеза здійснення особистості. Київ : Вид-во ТОВ «КММ», 2006. С. 116–136.
4. Матвієнко Л. І., Загребельна Я. О. Психотехнічні прийоми профілактики агресивної поведінки менеджерів. Соціально-психологічний супровід в роботі фахівців служби зайнятості : Монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба; Є. М. Калюжної. Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. С. 283–285.
5. Гринь Є. Л. Побудова когнітивної схеми сутності опору організаційним змінам на підприємстві. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 247–252.

1.7. Вплив локусу контролю на професійне самовизначення та стресостійкість випускників професійно-технічних навчальних закладів

Ларченко І. В.

Актуальність. Професійне самовизначення та стресостійкість випускників професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) в умовах сучасного динамічного світу є незаперечною [1]. У періоди соціально-економічних змін, глобальних пандемій та військових конфліктів, особливо важливим стає розуміння того, як молоді люди сприймають свій контроль над професійними та особистісними рішеннями [2]. Це безпосередньо пов'язано з концепцією локусу контролю, яка описує, наскільки індивіди вважають, що їхні дії впливають на події у їхньому житті [3]. Локус контролю, як внутрішній (інтернальний) так і зовнішній (екстернальний), впливає на спосіб, яким випускники ПТНЗ взаємодіють із своїм соціальним та професійним середовищем, а також на їхню здатність адаптуватися до стресових ситуацій [4].

Сучасні виклики в галузі освіти та професійної підготовки вимагають глибшого розуміння факторів, що формують професійну ідентичність випускників [5]. В цьому контексті, аналіз локусу контролю набуває особливого значення, оскільки він може впливати на мотивацію, кар'єрне планування та загальне емоційне благополуччя особистості [6]. Особливо важливим це стає у випадку випускників ПТНЗ, які часто зіштовхуються з необхідністю приймати критичні рішення щодо свого майбутнього в період переходу від навчання до професійної діяльності [7]. Дане дослідження має на меті вивчити, як варіації локусу контролю впливають на професійне самовизначення та стресостійкість випускників [8]. Використання комплексного підходу, що включає методики Є. Клімова та В. Е. Мільмана, дозволяє всебічно оцінити ці аспекти [9]. Таким чином, результати даного дослідження можуть нести вагомий вклад у розуміння про-

цесів професійного самовизначення та розробку ефективних стратегій підтримки молоді у сучасних умовах [10].

Мета. Висвітлення поняття «локус контролю», його впливу на професійне самовизначення та стресостійкість, особливо серед випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Дослідження охоплює аналіз типів локусу контролю (інтернальний та екстернальний), їх ролі у формуванні особистісної мотивації та адаптивності до професійного середовища [9, 10].

Результати досліджень. Локус контролю, як психологічна конструкція, визначає сприйняття індивідом ступеню впливу власних дій на події, що відбуваються в його житті. У контексті професійного самовизначення, це виявляється в здатності особистості до самостійного планування кар'єрного шляху та адаптації до робочого середовища.

Методика Є. Клімова «Діагностика професійного самовизначення» застосована для вивчення схильності випускників до аналізу та синтезу інформації про себе у професійній сфері, їхніх цінностях та інтересах. Результати, отримані з цієї методики, дозволяють визначити, наскільки випускники готові до самостійного вибору професії та їхню здатність до самореалізації в майбутньому професійному житті. Для вивчення стресостійкості застосовано методику В. Е. Мільмана «Діагностика рівня суб'єктивної контрольованості». Ця методика дозволяє оцінити, як випускники сприймають стресові ситуації і які стратегії вони використовують для їх подолання, відображаючи рівень стресостійкості та адаптивні можливості особистості. Розподіл локусу контролю серед досліджених груп за статтю представлено на рис. 1. З представлених на рис. 1 даних щодо змін у локусі контролю у досліджуваних групах, можна відзначити наступне. У ДГ1 виявлено зростання екстернального локусу контролю, серед жінок 59,5 %, що зумовлено загальним відчуттям невизначеності та стресу, викликаних пандемією, що змушувало випускників сприймати обмеження у контролі над власним життям і професійними перспективами через зовнішні обставини.

У ДГ2 зафіксовано збільшення інтернального локусу контролю серед жінок 62,5 %, тоді як серед чоловіків цей показник знизився. Це може відображати зміну у сприйнятті особистих можливостей та активізацію пошуку власних шляхів вирішення проблем в кри-

зових умовах, зокрема серед жіночої статі. В цілому можна зазначити про значення гнучких і адаптивних підходів до професійного розвитку в умовах соціально-економічних змін, а також важливість підтримки ВПТНЗ у процесі кар'єрного самовизначення, зокрема через розвиток внутрішнього локусу контролю. Динаміку локусу контролю у досліджених групах за віком представлено на рис. 2. З представлених на рис. 2. даних щодо змін у локусі контролю у досліджуваних групах за віковими категоріями, можна відзначити наступне. У ДГ1 помітно, що найбільший відсоток екстернального локусу контролю зафіксовано серед осіб віком 17 років – 40,4 %. Це може свідчити про відчуття невизначеності та залежності від зовнішніх обставин серед молодших вікових груп у період пандемії. На відміну від цього, у ДГ2 спостерігається підвищення інтернального локусу контролю серед вікової групи 19 років – 53,1 %.

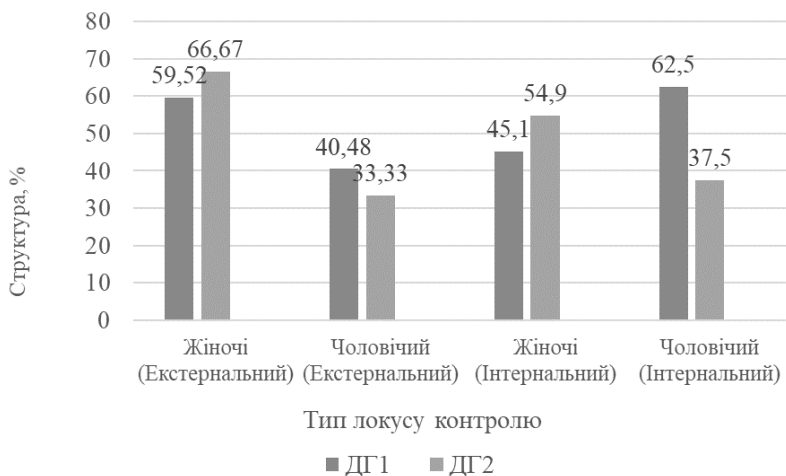


Рис. 1. Розподіл змін локусу контролю у досліджених групах за статтю

Це може вказувати на зростання відповідальності та активнішого підходу до власного професійного розвитку серед старших вікових груп у умовах військового конфлікту. Таким чином, аналіз локусу контролю у різних вікових групах показує, як змінюються

установки щодо сприйняття власного контролю над життєвими ситуаціями залежно від зовнішніх умов і віку.

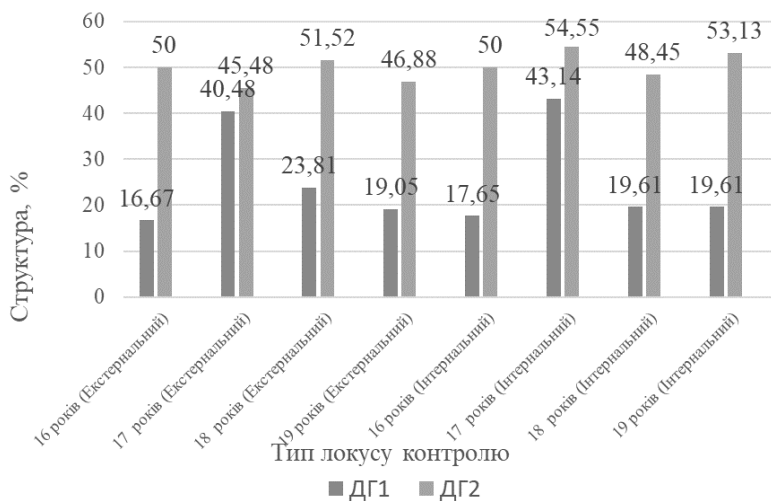


Рис. 2. Динаміка локусу контролю у досліджених групах за віком

Зміни у мотиваційній структурі особистості серед випускників ПТНЗ за статтю представлено на рис. 3. Аналізуючи представлені дані на рис. 3, можна відзначити ключові зміни у мотиваційній структурі особистості випускників ПТНЗ за методикою В. Е. Мільмана у ДГ1 та ДГ2. У ДГ1 серед жінок було виявлено 52,9 % житейської мотивації, тоді як у ДГ2 цей показник збільшився до 79,1 %. Це зростання може відображати зміну пріоритетів серед жінок в напрямку більшої уваги до особистісних цінностей та сімейних зобов'язань. Водночас, серед чоловіків у ДГ1 житейська мотивація складала 47,0 %, проте в ДГ2 вона значно знизилася до 20,8 %. Таке зменшення може свідчити про зростаючу орієнтацію чоловіків на професійний розвиток та кар'єрні амбіції. Загальний аналіз цих даних вказує на важливість врахування змін у мотиваційній структурі особистості при розробці стратегій підтримки та розвитку випускників ПТНЗ. Він підкреслює необхідність адаптації до різних соціальних та економічних умов, які можуть впливати

на професійне самовизначення та кар'єрні вибори молоді. Зміни у мотиваційній структурі особистості серед випускників ПТНЗ за віком представлено у табл. 1.

Таблиця 1.

Зміни у мотиваційній структурі особистості у досліджуваних групах за віком

Показник	Вік, у роках														Всього					
	16				17				18				19							
	ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Житей-ський	3	17,6	2	33,3	9	52,9	2	9,0	3	17,6	15	45,4	2	11,7	5	15,6	17	100,0	24	100,0
Робочий	13	17,1	4	66,6	30	39,4	20	90,9	17	22,3	18	54,5	16	21,0	27	84,3	76	100,0	69	100,0
Всього	16	17,2	6	100,0	39	41,4	22	100,0	20	21,5	33	100,0	18	19,3	32	100,0	93	100,0	93	100,0

З представлених у табл. 1. даних щодо змін у мотиваційній структурі особистості випускників ПТНЗ за віком можна відзначити наступне. У ДГ1, серед 17-річних, відзначається зростання робочої мотивації до 39,4 %, що свідчить про активне прагнення молодих людей до професійного розвитку та кар'єрного планування в умовах невизначеності, спричиненої пандемією. Це вказує на важливість зосередження на кар'єрних цілях та професійному зростанні серед молоді цього віку. У ДГ2, серед тієї ж вікової групи, спостерігається ще більше зростання робочої мотивації, яке досягає 90,9 %. Це відображає ще сильнішу орієнтацію на професійні аспекти та здатність адаптуватися до викликів, які створює військовий конфлікт. Зокрема, це може свідчити про зміну у сприйнятті особистих можливостей та необхідності швидкої адаптації до змінюваних умов.

В цілому, зміни у мотиваційній структурі особистості серед випускників ПТНЗ за віком відображають не тільки їх реакцію на зовнішні соціально-економічні зміни, але й важливість підтримки та розвитку внутрішнього потенціалу в умовах невизначеності та стресу. Це підкреслює необхідність гнучких та адаптивних підхо-

дів у підготовці випускників, зокрема у професійно-технічних навчальних закладах, для ефективного кар'єрного самовизначення. Зміни в професійних інтересах серед випускників ПТНЗ за статтю представлено у табл. 2.

Таблиця 2.

**Зміни в професійних інтересах
у досліджуваних групах за статтю**

Показник	Стать								Всього			
	Ж				Ч							
	ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Л – ЗС	9	52,9	5	50,0	8	47,0	5	50,0	17	100,0	10	100,0
Л – Л	6	42,8	22	84,6	8	57,1	4	15,3	14	100,0	26	100,0
Л – П	7	53,8	11	84,6	6	46,1	2	15,3	13	100,0	13	100,0
Л – Т	1	9,0	0	0	10	90,9	10	100,0	11	100,0	10	100,0
Л – Х	10	83,3	10	83,3	2	16,6	2	16,6	12	100,0	12	100,0
Не сформований	15	57,6	12	54,5	11	42,3	10	45,4	26	100,0	22	100,0
Всього	48	51,6	60	64,5	45	48,3	33	35,4	93	100,0	93	100,0

На основі даних, представлених у табл. 2, щодо змін у професійних інтересах серед випускників ПТНЗ за статтю, можна спостерігати важливі тенденції. В ДГ1, зокрема серед жінок, відзначається збільшення інтересів у категорії «Л – ЗС» (52,94 %) та «Не сформований» (57,69 %), що може свідчити про пошук стабільності та різноманітних професійних можливостей в умовах пандемії. Однак, в ДГ2 помітно значне зростання інтересу до категорії «Л – Л» серед жінок (84,62 %), що може вказувати на зміну професійних пріоритетів з більшою увагою до спеціалізованих сфер діяльності. Ця тенденція може бути зумовлена необхідністю адаптації до нових викликів, які створює військовий конфлікт. Також варто зазначити зниження відсотка випускників з «Не сформованим» типом інтересів (54,55 % у ДГ2 проти 57,69 % у ДГ1), що може вказувати на зростання їх професійної визначеності та адаптації до нових умов. В цілому, ці зміни у професійних інтересах випускників ПТНЗ під-

креслюють важливість гнучкої адаптації освітніх програм до мінливих соціальних та економічних умов. Вони відображають вплив зовнішніх обставин на професійне самовизначення молодих фахівців та необхідність підтримки та розвитку їх професійних інтересів з урахуванням цих викликів. Зміни в професійних інтересах серед досліджених за віком представлено у табл. 3.

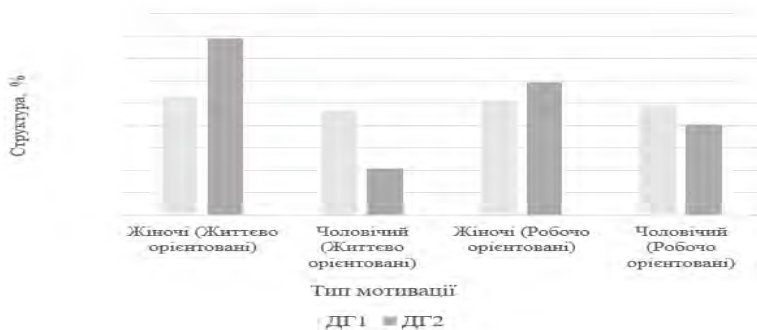


Рис. 3. Зміни мотиваційної структури у досліджених групах за статтю (методика В. Е. Мільмана)

На підставі аналізу даних, представлених у табл. 3. щодо динаміки професійних інтересів випускників ПТНЗ за віковими групами, можна виділити ключові тенденції. У дослідній групі ДГ1, серед 16-річних, інтерес до категорії «Л – ЗС» склав 29,41 %, тоді як серед 19-річних цей показник становив 17,65 %. Це свідчить про варіабельність професійних інтересів залежно від віку. Особливо помітною є зміна у віковій групі 17 років у дослідній групі ДГ2, де інтерес до категорії «Л – Л» зріс до 23,08 %. Це може свідчити про зміщення акцентів на лідерські якості та аналітичні навички у цій віковій групі, особливо в контексті пандемії COVID-19. Загалом, зміни у професійних інтересах випускників ПТНЗ відображають їх реакцію на зовнішні виклики, такі як пандемія та військовий конфлікт. Ці дані підкреслюють необхідність адаптації освітніх програм та кар'єрного планування до швидкозмінних соціальних та економічних умов,

а також важливість розвитку відповідних навичок та компетенцій серед молоді для ефективного відповіді на ці виклики.

Таблиця 3

Динаміка професійних інтересів у досліджених групах за віком

Показник	Вік																Всього			
	16				17				18				19							
	ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2		ДГ1		ДГ2	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Л – ЗС	5	29,4	1	10,0	5	29,4	3	30,0	4	23,5	1	10,0	3	17,6	5	50,0	17	100,0	10	100,0
Л – Л	2	14,2	3	11,5	8	57,1	6	23,0	2	14,2	11	42,3	2	14,2	6	23,0	14	100,0	26	100,0
Л – П	1	7,6	0	0	3	23,0	4	30,7	6	46,1	6	46,1	3	23,0	3	23,0	13	100,0	13	100,0
Л – Т	3	27,2	1	10,0	5	45,4	3	30,0	2	18,1	4	40,0	1	9,0	2	20,0	11	100,0	10	100,0
Л – Х	1	8,3	0	0	4	33,3	0	0	3	25,0	4	33,3	4	33,3	8	66,6	12	100,0	12	100,0
Не сформований	4	15,3	1	4,5	14	53,8	6	27,2	3	11,5	7	31,8	5	19,2	8	36,3	26	100,0	22	100,0
Всього	16	17,2	6	6,4	39	41,9	22	23,6	20	21,5	33	35,4	18	19,3	32	34,4	93	100,0	93	100,0

Висновок. Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що локус контролю є ключовим фактором у формуванні професійного самовизначення та стресостійкості серед випускників ПТНЗ. Зміни у соціально-економічному середовищі, такі як пандемія та військовий конфлікт, суттєво впливають на ці процеси, вимагаючи від освітніх інституцій зосередження уваги на розвитку внутрішнього локусу контролю та адаптивних стратегій виховання та навчання. Дане дослідження вносить вклад у розуміння механізмів професійного самовизначення та може бути використа-

не для розробки більш ефективних освітніх та профорієнтаційних стратегій у професійно-технічних навчальних закладах.

Ключові слова: локус контролю, професійне самовизначення, стресостійкість, професійно-технічні навчальні заклади, професійна адаптація, мотиваційна структура, гендерні відмінності, вікові характеристики.

Література.

1. Шульц Д., Шульц С. Е. Теорії особистості. – Київ: Академвидав, 2020. – 512 с.
2. Грін Дж., Палмер С. Психологія кар'єри та консультування. – Львів: Видавництво «Новий Світ», 2019. – 364 с.
3. Браун Л., Райан М. Мотивація і самореалізація: від теорії до практики. – Одеса: Астропринт, 2018. – 288 с.
4. Сміт Дж. та ін. Гендер та вікові особливості у професійному самовизначенні. – Харків: Фактор, 2021. – 232 с.
5. Вільямс Т., Деккер П. Самоефективність і особистісний розвиток. – Дніпро: Ліра, 2020. – 416 с.
6. Бандура А. Соціальне навчання та особистісний розвиток. – Київ: Академперіодика, 2022. – 576 с.
7. Роттер Ю. Б. Локус контролю в психології. – Житомир: Полісся, 2021. – 352 с.
8. Дісі Е., Раян Р. Теорія самодетермінації: сучасний погляд на мотивацію. – Вінниця: Нова Книга, 2022. – 624 с.
9. Клімов, Є. А. Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів. Київ: Український інститут практичної психології, 2020. – 198с.
10. Мільман В. Е. Стресостійкість і професійний розвиток: психологічні аспекти. – Київ: Наукова думка, 2021. – 274 с.

1.8. Моделі формування іміджу здобувача вищої освіти

Лосієвська О. Г., Лосієвський В. І.,

Рачкован Є. В.

Актуальність. Підхід вивчення іміджу як соціально-психологічного феномена ґрунтується на цілому ряді концепцій, серед яких слід особливо виділити: концепцію соціального конструктивізму К. Гергена, теорію соціальних уявлень С. Московічі, концепцію соціальної ідентичності А. Тешфела, концепцію самокатегоризації Д. Тернера, теорію когнітивного дисонансу Л. Фестингера. Важлива роль у становленні соціально-психологічної концепції іміджу належить працям вчених, виконаним у контексті аналізу реальних соціальних груп (Г. Айзенк, Г. Гарднер, Д. Гоулман, Д. Равен, Е. Трондайк, Д. Майєр, Н. Холл, К. Штайнер) [9; 10; 13; 15].

У роботах Ч. Пірса, Д. Дьюї, Ч. Кулі, Г. Блумера, Р. Мертона, Г. Лассуелла, О. Тоффлера, Я. Морено, К. Левіна, К. Роджерса, Дж. Гелбрейта, К. Шеннона, Дж. Хоманса розглядається поняття імідж – як специфічний образ предмета, коли ракурс сприйняття навмисно зміщений і акцентуються лише певні сторони об'єкта. Через це досягається ілюзорне відображення об'єкта чи явища. Між іміджом і реальним об'єктом існує розрив достовірності, оскільки імідж згущує фарби образу [8; 9; 13; 14; 15].

Поняття «імідж» і «образ» деякі автори розводять, обґрунтовуючи, що імідж – це спеціально сконструйований образ, в той час, як образ існує незалежно від спеціальних зусиль його носія чи інших його творців [7]. Також, наголошується, що імідж виникає лише в ситуації «взаємодії носія іміджу та аудиторії, на яку він розрахований, а без аудиторії він в принципі неможливий, тому що будь-який імідж її адресований і нею, в кінцевому результаті, породжується» [2].

У своєму дослідженні Д. Равен звертає увагу на тому, що саме цілеспрямованість характеризує імідж. Діяльність по створенню іміджу мотивується різницею уявлень про те, як об'єкт повинен бути сприйнятий і як він реально сприймається [14].

Мета. Дослідити моделі формування іміджу здобувача вищої освіти.

Результати досліджень. За драматургічним підходом І. Гофмана вважається, що це не простий історичний збіг, що слова «особистість», «персона» у своїх значеннях говорять про маски. Це схоже на визнання факту, що завжди та всюди, кожна людина грає роль. Саме в цих ролях люди пізнають один одного та самих себе. Ми вибираємо власну «маску» (роль) не випадково, а воліємо ту, яка найкраще зображує, ким ми насправді хочемо бути [11].

Звичайно, подібна точка зору не є в повному розумінні слова новаторською. У. Джемс, Ч. Кулі, Г. Мід розглядали самопрезентацію як засіб формування образу Я і підтримки самооцінки. Вони висловлювали ідею про те, що людині властиво демонструвати різні соціальні ролі різним партнерам, щоб представити себе найбільш вигідним чином і справити найкраще враження. За Ч. Кулі і Г. Мід знання індивіда про себе – це рефлексія знань інших про нього [9].

Постаючи перед іншими, людина повинна являти собою зразок прийнятої в даній спільноті поведінки. І лише в наодинці з собою актор може розслабитися, скинути маску і «вийти з ролі». На думку І. Гофмана даний процес можна позначити «ідеалізація» [11].

Розроблена акмеологічна концепція розвитку іміджу інтерпретує суть іміджу не лише як символічного образу, що відображає презентаційні риси особистості, але і з позицій об'єктних і суб'єктних характеристик носія іміджу – відповідального за створюваний образ і прагне до розвитку і самовдосконалення з метою досягнення високих професійних результатів, найвищих показників ефективності в діяльності [2;7].

Використання акмеологічного підходу до вивчення іміджу є своєчасним відгуком на соціальне замовлення суспільства, стурбованого підміною глибокого змісту іміджу суб'єкта його поверхневою формою, прагненням «не бути, а здаватися», перетворенням особистості в «ресурс» на відповідному ринку.

В основі цього підходу до формування іміджу лежить діяльність суб'єкта іміджу, орієнтована на його самопізнання, самовираження і самовдосконалення в особистісному і професійному аспектах [2; 7].

Таким чином, значущим досягненням останніх років у вивченні іміджу як соціально-психологічного феномена слід вважати пе-

рехід від маніпулятивної об'єктної парадигми до гуманістичної інтерсуб'єктної, початок якої було закладено роботами А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерса, Е. Фромма та ін.

Слово «імідж» походить від англійського «image» – зображення, образ. Імідж об'єкта – це образ, що виник в психіці в результаті сприйняття тих чи інших характеристик об'єкта. Часто висловлюються крайні точки зору – від визнання, що імідж можна і потрібно формувати, враховуючи специфіку реципієнта (об'єкт, який приймає інформацію), з метою досягнення найбільшої ефективності взаємодії, до цілеспрямованого формування іміджу як засобу маніпулювання знанням і поведінкою людей [9; 11].

Енциклопедичний словник дає два тлумачення терміну «імідж»:

1. Зовнішній образ, створюваний суб'єктом, з метою викликати певне враження, думка, ставлення у інших людей;
2. Сукупність властивостей, приписуваних рекламою, пропагандою, модою, забобонами, традиціями об'єкту, з метою викликати певні реакції.

Імідж – це образ об'єкту, який сприймається індивідом в емоційно забарвлених тонах. При цьому, в ньому відтворені певні значення, які об'єкт екстраполює з метою його розпізнавання та запам'ятовування. Це система уявлень індивідів про певний об'єкт та його змістовні характеристики (якісні властивості) [7].

Більш точне поняття «імідж» – є прояв внутрішніх відчуттів і власних уявлень про себе з урахуванням стереотипу сприйняття оточуючими. Залежно від того, в якому оточенні людині доводиться обертатися більшу кількість часу, створюється імідж, що підкреслює його приналежність до даного кола. Імідж, що формується під впливом соціальних ролей, дає інформацію про соціальний статус, матеріальне становище та інтереси суб'єкта. В цьому розумінні існує небезпека зрощування соціальної ролі і існуючого іміджу з особистістю, в цій ситуації людина настільки звикає до свого образу, що не уявляє себе в іншому вигляді.

Г. Берд говорить про імідж як повну картинку особистості, яка представляється іншим. Він включає те, як ви виглядаєте, говорите, одягаєтеся, дієте; ваші вміння, поставу, позу і мову тіла; ваші аксесуари, ваше оточення і компанію, яку ви підтримуєте. Імідж – деякій образ «Я», представлений світу для самопрезента-

ції. Загальна «Я-концепція» особистості проявляється одночасно, як мінімум в трьох образах:

1. «реальне Я» – якою я є людиною (з власних уявлень про себе);

2. «дзеркальне Я» – яким мене бачать інші (зі спостережень за реакцією інших людей на нашу поведінку, слова, вигляд);

3. «ідеальне Я» – якою людиною я хочу бути (бажаний образ).

Людина намагається наблизити «дзеркальне Я» до «ідеального Я» і виникає «демонстративне Я». На основі сприйняття такого складного образу «Я» у людей формується певна думка про цю людину. Таким чином, можна говорити про «імідж», який відображає рівень самооцінки особистості, про «прийнятий» імідж і «бажаний» [9].

Зовнішність людини дає сукупність сигналів, які умовно ділять на кілька складових і виділяють види наступні іміджу.

Габітарний імідж – сигнали, що виходять від зовнішності, одягу, прикрас. Його складові повинні відповідати ситуації і працювати на обрану мету [7].

Середовий імідж – штучно створене «середовище проживання», наше робоче місце, речі, які нас оточують. Навколишнє середовище «розповідає» про нас, про наші переваги, особливості, пріоритети.

Матеріалізований імідж – це судження, яке складається про людину на основі створюваних нею продуктів діяльності. Модел'єр створює одяг, викладач складає план роботи, здобувач вищої освіти пише курсову роботу і т. д.

Вербальний імідж формується на основі словесної та паравербальної інформації. Вербальні повідомлення складаються зі слів, паравербальні містять якість голосу, діапазон, тональність, паузи, сміх, плач, зітхання і т. п.

Голос і мова людини – частина його іміджу. Він може розповісти про дуже багато індикаторів життя людини.

Складовими вербального іміджу є словниковий запас і вміння ним користуватися, культура і багатство мови або їх відсутність.

Наша репрезентативна система в залежності від способу її надходження може бути:

– візуальна – сприйняття за допомогою зорових образів;

- аудіальна – сприйняття за допомогою слухових вражень;
- кінестетична – сприйняття за допомогою відчуттів;
- ольфакторна – сприйняття за допомогою запахів.

Паравербальна складова мови – це найважливіша «добавка» до неї. Якщо людям сподобається звучання голосу, вони будуть прислухатися, менше перебивати, їх легше буде переконати. Людина з красивим, добре поставленим голосом більше сприймається як приваблива.

Манера мовлення є сигналом, який дозволяє проникнути в рольову поведінку людини і розпізнати її. Добре поставлений голос – необхідна складова паравербального іміджу.

Кінетичний імідж – це думка, що складається про людину на основі його типових рухів або положень в просторі частин його тіла. Термін «кінетика» (від грец. *Kinnetikos* – належити до руху) ввів американський психолог Р. Бердвістл. «Мова рухів тіла» – це «голос» нашої підсвідомості, який зазвичай не контролюється свідомістю і видає підсвідомі установки особистості. Для створення сприятливого іміджу необхідно блокувати ту кінетику, яка здатна викликати негативні реакції і негативну думку. Однак, не завжди можна змінити особливості зовнішності, дані від природи.

Але багатьма параметрами управляти можна. Наші зовнішні риси у своєї більшості можуть коригуватися. Отже, габітарне піддається управлінню, і створити успішний габітарний імідж цілком реально. Головне – здоровий вигляд зовнішності.

Згідно гуманістичної психології Абрахама Маслоу, серед базових людських потреб є потреба у визнанні і самоактуалізації. Він вважав, що кожному необхідно схвалення. Людині необхідно відчуття власної могутності, компетентності, впевненості і свободи.

Досягнення усіх цих соціально значущих категорій неможливе без створення позитивного іміджу, відповідного очікуванням і уявленням оточуючих. Імідж є головним структурним елементом PR (Public Relations), бо виконує роль активатора емоційних проявів індивідів, а разом із цим їхньої поведінки та ставлення до суб'єкта публісیتی [3].

Проблемам соціальної ідентифікації приділив увагу і З. Фрейд. Він пов'язував це явище з протиставленням любові до власної групи і агресії стосовно інших. Умовно розподіляв людей на «своїх» і «не своїх», торкався питання прагнення мати певний статус у своєму колі [1].

Слід зазначити, що одяг є найважливішим джерелом імідж-формуючої інформації. Досить згадати відомий вислів: «По одягу зустрічають . . . ». Стан одягу, тобто доглянутість свідчить про ставлення людини як до самої себе, так і до оточуючих. Важливе значення має вибір кольору одягу, тому що вказує на психологічні особливості особистості – характер, темперамент, настрій.

Імідж можна визначити як образ, який формує думку про людину як про особистість, який визначає готовність діяти у відношенні цієї особистості певним чином [2; 7].

Імідж – це цілеспрямований сформований, цілісний, динамічний феномен, обумовлений відповідністю внутрішніх і зовнішніх, особистісних та індивідуальних якостей та чинників суб'єкта, покликаний забезпечити гармонійну та ефективну взаємодію суб'єкта з соціумом і самим собою [2; 7].

Імідж здобувача вищої освіти набуває особливого значення в сучасних умовах, коли суспільство висуває нові вимоги до майбутнього професіонала, здатного швидко вбудовуватися у процес діяльності. В основі іміджу як символічного образу суб'єкта знаходиться активна і цілеспрямована діяльність суб'єкта-прообразу іміджу, орієнтована на самопізнання, самовираження. Актуальним механізмом розвитку іміджу здобувача вищої освіти виступає узгодження структурно-змістовних особливостей іміджу на рівні індивідуальної і суспільної свідомості [1; 4].

Імідж сучасного здобувача вищої освіти визначають наступні характеристики:

- свідомість, повага до свого навчального закладу;
- громадянська активність робити внесок в розвиток суспільства;
- лідерство, організаторські здібності, вміння взяти відповідальність;
- активна життєва позиція, вміння орієнтуватися в інформації;
- креативність, творчий підхід до своєї діяльності;
- інноваційне мислення;
- професіоналізм.

Формування іміджу здобувача вищої освіти – поетапний процес. Під умовами розвитку іміджу О. Коркішко зазначає:

- усвідомлення здобувачем вищої освіти необхідності формування позитивного іміджу;

- прояв активності здобувача вищої освіти при роботі над своїм іміджем;
- знання вимог аудиторії до особистості і діяльності здобувача вищої освіти;
- дотримання принципів, форм і методів роботи з формування іміджу;
- оволодіння здобувачем вищої освіти прийомами самооцінювання, навичками проектування іміджу [5].

Всі функції іміджу здобувача вищої освіти класифікуються за трьома основними категоріями:

1. Навчальні функції (комунікативна, інформативна, когнітивна, емотивна, конативна);
2. Діяльні функції (організаційна, мотиваційна, виховна);
3. Додаткові (похідні від першої і другої груп) функції (компенсаторна, представницька, психотерапевтична, самовираження) [5].

Динамічна модель іміджу складається з трьох рівнів:

1. Конституційний – зовнішні дані, стать, вік, темперамент.
2. Особистісний, що включає:

Мотиваційний компонент: наявність значних навчально-професійних – мотивів і потреб, особистісно-значущі цінності;

Когнітивний компонент: Я-концепція здобувача вищої освіти;

Діяльнісний компонент: вміння розвивати власний імідж, а також можливість вивчати свій імідж в освітньому просторі ЗВО.

3. Соціально-психологічний – соціальна роль ЗВО і обраної ним професії [5].

Віковий період студентства найбільш плідний для формування знань, умінь, навичок, професійного розвитку. Молода людина в цей період визначається з професією, соціальною орієнтацією, обирає партнера; проявляє соціальну активність і досить гармонійне поєднання інтелектуальної і соціальної зрілості; формує цінності, що задають стійкі якості особистості, риси характеру [2].

Сформований імідж здобувача вищої освіти сприяє соціокультурній і професійній ідентифікації, побудові кар'єри в конкурентному середовищі, знаходженню свого призначення в мінливих умовах соціуму. Ефективний імідж здобувача вищої освіти – це відповідь на соціальне замовлення суспільства, що вимагає конку-

рентоспроможного фахівця, відкритого для саморозвитку, досягнення успішності в різноманітних сферах практики.

Самореалізація сучасного здобувача вищої освіти здійснюється не лише в придбанні престижної професії, в досягненні матеріально-го благополуччя. Високорозвинена особистість, позиціонуючи себе як успішна, активна, сучасна, усвідомлюючи свою самоцінність, прагне реалізувати себе на терені молодіжних студентських рухів. Саме організація ефективної і дієвої роботи студентських об'єднань у ЗВО сприяє виникненню таких якостей майбутнього фахівця, без яких неможлива успішна інноваційна діяльність в майбутньому.

Сприйняття іміджу широко зображено в афоризмах, цитатах з творів класиків. Наприклад: «Інтриги і маневри, які необхідно здійснювати для того, щоб домогтися гарної репутації, заважають нам її заслужити» (К. Гельвецій); «Людина вимірюється не з ніг до голови, а від голови до неба!» (Кун-Цзі (Конфуцій)); «Те, як ти виглядаєш, заглушає те, що ти хочеш сказати» (Р. Емерсон); «Куди б ми не йшли, наш імідж (неважливо, хороший, поганий) нас обов'язково випередить» (Ф. Честерфілд).

У широкому сенсі, імідж – це цілісний несуперечливий образ в свідомості оточуючих, відповідаючий цілям, нормам, цінностям, прийнятим в цільовій групі. Найпоширенішим є визначення іміджу як сформованого в масовій свідомості стереотипу емоційно забарвленого образу.

Імідж виникає тоді, коли його об'єкт-носії стає публічним, видимим групі, коли є продукти соціальної перцепції індивіда. Стосовно до змісту іміджу людини йдеться про сукупність його соціальних, професійних, психологічних і зовнішніх по вигляду характеристик.

Одним з основних джерел іміджу з точки зору науки є психологія соціального пізнання, де розглядається побудова образу соціуму чи конструювання соціальної реальності.

Імідж складається на основі вражень, які виробляє людина на оточуючих в результаті спілкування і взаємодії, і на основі думок, які передаються по комунікативним каналам.

Дж. Хомманс склав цікаву модель іміджу як уявлення з семіотичною, когнітивною і рольовою складовими, у якій досягається органічне поєднання індивідуального і суспільного – погляд на себе

серед інших. Імідж виражає прагнення людини утворити власний соціальний статус і зробити на оточуючих певне враження [10].

Ч. Кулі, Г. Мід розглядали самопрезентацію як засіб формування образу Я та самооцінки та висловлювали ідею про те, що людині властиво демонструвати різні соціальні ролі (патерни) різним партнерам, щоб представити себе найбільш вигідним чином і справити найкраще враження [10].

Висновок. Імідж – це емоційно забарвлений образ людини, який визиває певні зовнішні признаки, асоціації та репутації в соціальній групі, на яку він спрямований, Я-концепція, представлена суспільству. Імідж має зовнішні чинники особистості та внутрішні якості – габітарний, вербальний, кінетичний. Імідж формує думку про людину. Імідж здобувача вищої освіти має декілька рівнів у своїй структурі – когнітивний компонент, емоційну складову, соціальне вираження. Персональні характеристики особистості мають найсуттєвіший вплив на імідж здобувача вищої освіти. Самореалізація сучасного здобувача вищої освіти ЗВО здійснюється як через професійні досягнення, так і шляхом набуття особистісних соціально-емоціональних рис. Як підсумок, можна зробити висновок, що базуючись на фундаментальних персональних якостях, імідж здобувача вищої освіти формується при взаємодії особистості з зовнішніми факторами соціуму.

Література.

1. Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін / С. Гарькавець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія: – 2014. – Вип. 1. – С. 27-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknur_2014_1_9

2. Ісаченко В. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи : автореф... дис. канд. психол. Наук : спец. 13. 00. 04 «Теорія та методика професійної освіти» / В. Ісаченко. – Одеса, 2004. – 21 с.

3. Носенко Е. Емоційний інтелект: концептуалізація феномена, основні функції. Монографія / Е. Носенко, Н. Коврига. – Київ : Вища школа, 2003. – 126 с.

4. Орбан-Лембрик Л. Психологія професійної комунікації: [монографія] / Л. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги, 2009. – 528 с.

5. Коркішко А. Педагогічна модель формування професійного іміджу магістрів педагогіки вищої школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2019, (11), 120–131. <https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197215>
6. Паращук В. Основи теорії мовної комунікації / В. Паращук, О. Семенюк // Навчальний посібник. – К. : Академія, 2010. – 240 с.
7. Чебикін О. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу: монографія / О. Чебикін. – Одеса, 2009. – 223 с.
8. Baron R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory // R. Baron., J. Parker Handbook of emotional intelligence. – San Francisco, 2000. – 388 p.
9. Brown T. History of an image / T. Brown. – London : Tauris, 1988. – 150 p.
10. Eysenck H. The Structure and Measurement of Intelligence / H. Eysenck. – Berlin : Verlag 1979. – 253 p.
11. Mayer J. Hyman abilities: emotional intelligence / J. Mayer, R. Roberts, Annual Review of Psychology. – 2008. – P. 507–536.
12. Mehrabian A. Genetic Beyond IQ: Broad-based measurement of individual success potential or emotional intelligence / A. Mehrabian. – Washington. – Vol. 126. – Iss. 2. – 2000. – 239 p.
13. Oliver S. Public relations strategy. London, Philadelphia: Kogan page Ltd, 2010, 192 p.
14. Salovey J. Emotional intelligence as a standard intelligence / J. Salovey, P. Caruso, D. Sitarenios By Mayer G Emotion. – Vol 1(3), Sep 2001. – P. 232–242.
15. Shannon C. A Mathematical Theory of Communication / C. Shannon // ACM SIGMOBILE Computing and Communications Review. – Issue 1. – Vol. 5. – 2001. – P. 3–55.

1.9. Особистісні якості та професійні компетентності персоналу девелоперських організацій

Мамедов О. О.

Актуальність. Сьогодні в Україні значимості набуває діяльність у сфері «вдосконалення» або «розвитку нерухомості» (development), який, за визначенням Бусова ВІ. І., являє собою вид підприємницької діяльності, пов'язаний з будівництвом об'єктів, реконструкцією будівель або перетворенням ділянок землі для підвищення їх доданої вартості. Управління проектами – галузь менеджменту з усім властивими для менеджменту функціями, у тому числі наявністю особливих професійних компетентностей та особистісних якостей персоналу девелоперських організацій. Значний доробок у вивчення засад девелопменту зробили: Брижань І., Дегтяр О., Коваленко Ю., Ляхова О., Онікієнко С., Чевганов В., Чигасов С., Бакуліна А., Максимов С., Сидоров В., Шапіро В. та ін. [1].

Бляхарський Я. С. доводить, що девелоперів доцільно поділяти за класифікаційними ознаками, якими є характер управління проектом, специфіка управління й реалізації девелоперського проекту тощо [2]. Автор стверджує про необхідність поділу принципів девелоперської діяльності за сферою (рівнем) застосування на: загальні та спеціальні. До загальної групи належать принципи які мають значення у господарській сфері. До спеціальних належать принципи, характерні для девелоперської діяльності [3].

Щербакова І. М. дослідила внесок вітчизняних та закордонних науковців у вивчення мотивації девелоперів та відзначила значущість праць Barg Jason, Ruparathna Rajeev, Mendis Daylath, Newage Kasun, які на основі систематизації закордонних досліджень мотивації працівників будівельної галузі, дійшли висновку щодо наявності незначного обсягу знань у цій галузі, з причин дуже малої кількості наукових публікацій за цією проблематикою [4]. За І. М. Щербаковою мотивацію працівників будівельної галузі займалися такі вчені, як: Bahareh Reza, Barg Jason, Davis-Kean

P., Eccles J. S., Hancock D. J., Hewage Kasun, Janaka Y. Ruwanpura, Kasun Hewage, Kendra Cherry, Maloney W. F., Mansfield N., Muluken Yeheyis, Mendis Daylath, Odeh N., Rehan Sadiq, Ruparathna Rajeev, Roeser R. W., Schiefele U., Wigfield A. Авторка зазначає, що напруження вітчизняних й закордонних науковців дозволяють визначити девелоперів як суб'єктів діяльності та характеризувати їх потребова-мотиваційну сферу відповідно до типових у психології діяльності положень [4].

A. Lopes, R. Sbragia, E. Qualharini у праці «Психологічний контракт і управління проектами як основна компетенція організації» зазначають, що «...компанії повинні розробляти стимулююче середовище, що створює компроміси, формувати системну та орієнтовану на результат команду. Психологічний контракт є ключем до розуміння цих відносин між виконавцем та професійною командою організації, що забезпечує передбачуване виконання проекту. Центральним моментом психологічного контракту є віра в те, що роботодавець виконуватиме свої зобов'язання та забезпечить розвиваюче середовище для професійної діяльності» [5].

Батлер А. С. досліджуючи когнітивні перспективи оцінювання професійної компетентності акцентує увагу на внеску природних здібностей і навчання в досягнення компетентності, а також проблемі розробки оцінювання, коли критерії не можуть бути чітко визначені [6].

Китайські вчені Chun-Chang Lee, Wen-Chih Yeh, Zheng Yu, Ting-Hsuan Tsai у праці «Вплив підтримки керівника, сприйняття ролі та емоційного виснаження на наміри обороту брокерів з нерухомості» оцінили вплив факторів індивідуального рівня (конфлікт ролей, двозначність ролей, міжособистісний конфлікт та емоційне виснаження) та факторів організаційного рівня (підтримка керівника та групова довіра) на наміри зміни [7].

Можна зауважити, що проблема компетентностей персоналу девелоперських організацій всебічно досліджується у зарубіжній та українській науці. Проте, комплексних досліджень професійних компетентностей, особистісних якостей персоналу організацій науковим пошуком охоплено недостатньо.

Мета – дослідити професійні компетентності та особистісні якості персоналу девелоперських організацій.

Результати досліджень. Емоційне навантаження в контексті міжособистісних взаємодій є великою емоційною вимогою організації до працівників, що призводить до виснаження їх емоційних ресурсів у результаті поганого управління. Alola та ін. (2019) описав емоційне виснаження як надмірну психологічну ресурсну вимогу, яку використовують працівники під час роботи зі стресом. Lussier та ін. (2019), вивчаючи емоційне виснаження, що знижує задоволеність роботою, вказує, що емоційне виснаження – це відсутність впевненості та гідності, а також відчуття безпорадності, яке сприймають працівники, на додаток до їх негативного ставлення до своєї роботи [5].

Емоційне виснаження негативно впливає на ефективність роботи співробітників. Нго та ін. (2005) стверджували, що емоційне виснаження може опосередковано вплинути на наміри зміни кадрів через незадоволеність роботою. Під емоційним виснаженням розуміють стан індивіда, який переносить надмірне емоційне та психологічне навантаження (Maslach et al., 2001). Відповідно до Wu and Cheng (2005), емоційне виснаження – це виснаження емоційних ресурсів, коли до індивіда пред'являються занадто багато емоційних вимог. Емоційне виснаження може вплинути на задоволеність роботою та продуктивність (Karatepe & Tekinkus, 2006). Soenen та ін. (2019) також відзначили негативний вплив емоційного виснаження на ефективність роботи. Ву (2008) вказує, що емоційне виснаження призводить до суттєвих змін ефективності, таких як збільшення прогулів, зростання витрат на охорону здоров'я та зниження продуктивності. Автор припустив, що емоційне виснаження збільшує загальні операційні витрати підприємств [7].

Кім С. із співавторами розглядають розвиток кар'єри та психосоціальну підтримку в якості наставницьких (менторських) функцій. Автори дослідили їхній вплив на рольовий стрес та ставлення до роботи. Автори вказують на вплив лідерства та організаційні фактори, проте зазначають, що вони не впливають як взаємопов'язані ефекти організаційного та індивідуального рівня [8].

Chun-Chang Lee із співавторами за результатом дослідження 393 брокерів з нерухомості, які працюють у компаніях з нерухомості міста Гаосюн, зазначають, що при міжособистісному конфлікті у колективі підтримка керівника знижувала емоційне виснаження підлеглих,

забезпечуючи цілковитий позитивний ефект. Задоволеність роботою частково компенсувала ймовірність емоційного виснаження на знижувала наміри кадрів щодо виходу з проекту. Таким чином підтримка керівника щодо зниження емоційного виснаження підлеглих, відповідно на організаційному та індивідуальному рівнях, мала найбільший вплив на наміри працівників щодо залишення у проекті [7].

На особливу увагу окрім принципів діяльності девелоперів заслуговують фактори-мотиватори та демотиватори. До перших відносять професійні завдання, рівень заробітної плати, соціально-психологічний клімат, визнання заслуг та досягнень працівників, стимулювання ініціативи та активності працівників, можливості для прояву творчого потенціалу працівника. До других відповідно неясні завдання, перевантаженість, низьку оплату праці, погані стосунки в колективі, недостатню поінформованість, несправедливу критику, безпідставну відмову у визнанні заслуг, відсутність можливості для реалізації ідей тощо [9].

Dianne Weinstein у дослідженні «Психологія поведінково-орієнтованих резюме щодо відбору кандидатів: чи справді ваші менеджери з найму наймають «правильних» людей на «правильну» роботу?» зазначає, що причиною майбутніх конфліктів персоналу організацій у контексті їх професійних компетентностей та особистісних якостей є думка менеджерів, які орієнтовані на поведінку. Тобто можуть позиціонувати претендентів як «правильних» кандидатів на роботу, навіть якщо вони насправді не є «правильними» кандидатами на роботу, яку вони шукають. Таким чином, роботодавцям корисно ознайомити своїх спеціалістів з найму з поведінковими резюме та теоріями програм компетенції. Розуміння «психології резюме та орієнтованих на поведінку», допомагає фахівцям точніше оцінювати резюме і мінімізує помилки [10].

За останні кілька десятиліть управління проектами є в усіх типах організацій у багатьох галузях промисловості, у тому числі й у будівництві, й все більше проектів, програм і портфелів управляються професійно. Компетентні проектні менеджери та співробітники, здатні впоратися з проблемами, що виникають, стали конечною потребою суб'єкта господарювання. Однак компетентності в управлінні проектами як набір знань, особистої поведінки, навичок і досвіду є дуже складними і тому вимагають набуття

різноманітних елементів у трьох різних сферах: контекстуальній, поведінковій і технічній [11].

Досліджуючи професійні та особистісні якості менеджерів різних компаній S. El-Sabaa у дослідженні «Навички та кар'єрний шлях ефективного менеджера проєктів» зазначає, що ефективний адміністратор повинен виробити власну особисту точку зору на людську діяльність, щоб він міг:

1. Розпізнавати почуття та настрої, які він привносить у ситуацію;
2. Мати ставлення до власного досвіду, яке дозволить йому переоцінити його та навчитися з нього;
3. Розвивати здатність розуміти те, що інші своїми діями та словами (явно чи приховано) намагаються повідомити йому;
4. Розвивати здатність доносити свої ідеї та ставлення до інших [12].

Як зазначає S. El-Sabaa [12] «...керівники проєктів часто комунікабельні, тактовні, доброзичливі, розуміють і допомагають. Вони зосереджують свою енергію на тому, щоб керувати іншими людьми для досягнення конкретних цілей проєкту. Впевнений у собі, амбіційний, енергійний і комунікабельний – ось характеристики хорошого менеджера проєкту». Це дослідження проливає світло на питання атрибутів і навичок ефективного менеджера. Результати показали, що особистісні навички керівників мають найбільший вплив на практику управління проєктами. З іншого боку, технічні навички, умовно кажучи, мають найменший вплив [12]. Данна думка підтверджується дослідженням «Аналіз емоційного інтелекту в менеджерів проєктів: розробка шкали та перевірка» С. Camplisson, К. Cormican [13]. Автори, зазначаючи про зростання усвідомлення позитивного впливу емоційного інтелекту на управління персоналом, вказують, що керівники з високим рівнем емоційного інтелекту позитивно впливають на ефективність проєкту. Проте розуміння, вимірювання та управління емоційним інтелектом є важким завданням. Почасту організаціям важко використовувати переваги, які привносить емоційний інтелект співробітників. Узагальнюючі дослідники зазначають наявність «дефіциту» розвиненого емоційного інтелекту у деяких керівників персоналу.

У іншому дослідженні, яке присвячено особистісним якостями керівників девелоперських компаній у будівництві, а саме «Покращення ефективності будівельних проектів: підхід до емоційного інтелекту керівника проекту» автори Zhang, L., Fan, W. [14] стверджують, що емоційний інтелект має багато переваг, але він залишається значною мірою не вивченим в управлінні будівельними проектами. Анкетування охоплювало 112 керівників у будівництві, у яких досліджено емоційний інтелект та його зв'язок із ефективністю проектів. За результатами виокремлено високу кореляцію шести факторів емоційного інтелекту керівника, тоді як зв'язок із впевненості в собі та командної роботи – ні підтверджено.

У міру того, як девелоперські проекти зростають у розмірах і складності, кількість команд (організацій), необхідних для керування ними, також збільшується. Це робить більший акцент на потребі керівника розвивати навички управління людьми, які зазвичай називають м'якими навичками, важливим компонентом яких визнано емоційний інтелект. Так, Лівсі, П. у дослідженні «Модель емоційного інтелекту Гоулмана-Боятзіса для вирішення проблем управління проектами» [15] аналізуючи дослідження Delphi на вибірці менеджерів проектів, які брали участь в управлінні проектами на суму понад 500 мільйонів доларів США вказує, що компетенції, які містяться в моделі Гоулмана-Боятзіса, на 95,0 % або більше відповідають проблемам, які вирішують керівники, що підтверджує важливість емоційного інтелекту для розуміння навичок, необхідних керівнику для успішного управління великими проектами.

Sang P. із співавторами у дослідженні «Вплив компетенції керівника проекту на ефективність екологічного будівництва: китайський контекст» [16] виокремлює компетенції керівника в будівництві: знання, ефективність та особистісні компетенції. У свою чергу автори погоджуються з думкою Американського товариства цивільних інженерів (ASCE), яке виокремлює 24 базові компетенції керівника у девелоперської компанії, а саме: розпізнавання та вирішення проблем, ризик і невизначеність, управління проектами, комунікація, державна політика, бізнес і державне управління, глобалізація, лідерство, командна робота, ставлення, навчання впродовж життя та професійна та етична відповідальність [16]. Базуючись на поточній ситуації в Китаї Sang P [16]. запропонував популярну систему ком-

петенцій для керівників проектів включаючи чотири виміри та 18 показників, підкреслюючи цінність лідерських та організаційних навичок та емоційного інтелекту у виборі менеджерів. Запропоновано чотири виміри для індексу компетентності керівників проектів: лідерство та організація, базова грамотність, цільове управління та емоційний інтелект, що представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Виміри індексу компетентності керівників проектів

Компоненти	Атрибути
Лідерство та організація	Співробітництво
	Залучення до спілкування
	Командна робота
	Управління конфліктами
	Професійні знання
Елементарна грамотність	Пошук та управління інформацією
	Навчання
Цільове управління	Управління ресурсами
	Фінансовий менеджмент
	Управління ризиками
	Управління охороною праці
Емоційний інтелект	Навички міжособистісного спілкування
	Здатність емоційного контролю
	Управління

Зазначимо, що у будівельному проекті, як тимчасовій організації, здатність працювати в команді є найосновнішою та необхідною компетентністю для керівників. Участь у спілкуванні є навичкою, якою повинен володіти керівник. Комунікаційні або соціальні навички означають, що керівник володіє здатністю ефективно взаємодіяти з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами. У процесі будівництва комунікація завжди була рушійним фактором проекту, де потрібно спілкуватися з працівниками як для постановки цілей, так і для вирішення конфліктів. Менеджер повинен спілкуватися та координувати внутрішні потреби команди з іншими зацікавленими сторонами, такими як забудовники нерухомості, відділи нагляду, субпідрядники та інші зацікавлені сторони.

До професійних та особистісних якостей керівників, які позитивно впливають на успіх проекту у девелоперських організаціях, віднесемо наступні:

1. Лідерство та організованість керівника;
2. Базова грамотність проектного менеджера;
3. Цільова управлінська компетентність (навички міжособистісного спілкування, здатність контролювати емоції, управління розумінням та адаптація);
4. Емоційний інтелект керівника.

На наш погляд цільова управлінська компетентність, як головна складова, потребує пояснення за складовими.

Навички міжособистісного спілкування. Соціальна взаємодія проектних відносин при розробці девелоперських проектів є по суті емоційною, і виникаюча емоція відіграє важливу роль у проектному процесі. Співробітники девелоперських організацій почасти мають різну освіту та культурну обізнаність. Для досягнення мети проекту керівнику необхідно швидко встановити міцні стосунки з ключовими членами колективу. Тобто, ефективні міжособистісні стосунки позитивно впливають на лідерство. Навички міжособистісних стосунків керівників відображаються в здатності сприймати почуття та думки співробітників, а також здатності прислухатися до пропозицій інших людей для своєчасного прийняття відповідних рішень, щоб вони могли підтримувати міцні стосунки протягом тривалого періоду.

Здатність контролювати емоції: є найважливішим фактором, який впливає на прогрес організації. Емоції керівників є основним фактором, що впливає на те, як менеджери керують щоденною роботою. За аналізом діяльності «емоційний менеджмент» можна поділити на два аспекти: емоційний самоконтроль і регулювання емоцій співробітників таким чином, щоб вони мали позитивне ставлення до роботи. Здатність керівників розуміти та контролювати власні емоції та емоції співробітників впливає на якість їхніх стосунків із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, тим самим впливаючи на ефективність управління девелоперською організацією.

Управління розумінням та адаптація. Соціальні стосунки керівників великі та складні, наприклад, підтримка довгострокової співпраці з постачальниками. Гарні міжособистісні стосунки з оточуючими допомагають керівникам ефективніше справлятися зі своїми

завданнями. Керівник проекту є ядром соціальної мережі. Комунікація керівника передбачає управлінські та міжособистісні навички зацікавлених сторін проекту, відповідатиме за складні соціальні взаємодії. Середовищем є людське суспільство, тому міцні міжособистісні стосунки допомагають керівникам працювати ефективно.

Eddie Fisher у дослідженні «Те, що практики вважають навичками та поведінкою ефективного менеджера проекту з персоналом» [17] на підставі особистих інтерв'ю та зустрічей фокус-груп виокремив наступні навички і пов'язаних з ними форми поведінки керівників як найважливіші: ефективна комунікація, переговори та управління конфліктами, автентична (справжня) поведінка, культурна обізнаність, управління емоціями людей.

Автори зазначають, що навички роботи з людьми, які роблять менеджера ефективним, є такі: дипломатичність, відчуття такту у спілкуванні, прояви емпатії, розуміння, що мотивує людей, ефективне управління конфліктами та вміння підкріплювати повідомлення іншим людям за допомогою жестів і міміки. У контексті інтегрованого управління ефективні менеджери з персоналу створюють середовище чесності, довіри, відкритого спілкування, гордості за майстерність і відданість. Вони мотивують членів команди працювати та вдосконалюватися, розвивають позитивне ставлення типу «можу зробити» і активно слухають інших [17].

Узагальнюючі результати аналізу літератури виокремимо найбільш важливі якості менеджерів девелоперських проєктів, а саме: володіння неперевершеними технічними навичками, створення та підтримка ефективної командної динаміки, ефективне спілкування, наполеглива робота, зосередженість на потребах клієнтів, здатність робити безпеку головним пріоритетом та зберігати спокій під тиском, уміння ставити правильні запитання, відповідальність, вміння ризикувати, щоб досягти досконалості та лідерства, емоційна зрілість.

Висновки. Узагальнюючі аналіз проблеми особистісних та професійних якостей персоналу девелоперських організацій можна зазначити наступне. При досить великому вивченні проблеми професійних компетентностей та особистісних якостей персоналу девелоперських організацій у світі в Україні комплексних теоретико-практичних досліджень з даної проблеми не проводилось. Емпірично не встановлено психологічні особливості діяльності та

копінг-стратегії поведінки персоналу девелоперських організацій. Не виявлено наявності / відсутності взаємозв'язку професійних компетентностей, особистісних якостей, психологічних особливостей діяльності, копінг-стратегій поведінки та їх синергічного впливу на професійну діяльність персоналу девелоперських організацій. В умовах сьогодення, а саме стресогенності ведення бізнесу в Україні внаслідок війни, не розроблено програми психолого-організаційного супроводу персоналу девелоперських організацій.

Література.

1. Вєдерніков М. Д., Зелена М. І. Доцільність застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на українських підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 5. Т. 1. С. 18–21.
2. Бляхарський Я. С. Господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12. 00. 04. Вінниця, 2021. 22 с.
3. Бляхарський Я. Принципи девелоперської діяльності. InterConf. 2021. Вип. 80. Жовтень. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15273>, с. 137–138.
4. Щербак І. М. Девелопмент: психологія мотивації девелоперів. Перспективи та інновації науки. 2021. № 4 (4). С. 431–443. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-4\(4\)-431-443](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-4(4)-431-443). с. 438.
5. Lopes R., Sbragia R., Qualharini E. L. The Psychological Contract and Project Management as a Core Competence of the Organization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016. Vol. 226. P. 148–155. URL: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.173>.
6. Батлер А. С. Вступ до форуму: Когнітивні перспективи оцінювання професійної компетентності. Журнал прикладних досліджень пам'яті та пізнання. 2018. № 7 (2). С. 165–166. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.04.002>
7. Lee C. -C., Yeh W. -C., Yu Z., Tsai T. -H. The impacts of supervisor support, role perception, and emotional exhaustion on the turnover intentions of real estate broker. Scandinavian Journal of Management. 2022. Vol. 38, Is. 4. P. 101–227. URL: <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2022.101227>.
8. Kim C. C, Im J., Hwang J. The effects of mentoring on role stress, job attitude, and turnover intention in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management. 2015. Vol. 48. P. 68–82. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.04.006>.

9. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. посіб. К. : Мілен. 2003. 344 с.
10. Weinstein D. The psychology of behaviorally-focused résumés on applicant selection: Are your hiring managers really hiring the ‘right’ people for the ‘right’ jobs? *Business Horizons*. 2012. Vol. 55. Is. 1. P. 53–63. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.09.003>.
11. Vlahov R., Mišić S. Mladen Radujković, The Influence of Cultural Diversity on Project Management Competence Development – The Mediterranean Experience. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2016. Vol. 226. P. 463–469. URL: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.212>.
12. El-Sabaa S. The skills and career path of an effective project manager. *International Journal of Project Management*. 2001. Vol. 19. Is. 1. P. 1–7. URL: [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(99\)00034-4](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00034-4).
13. Camplisson C., Cormican K. Analysis of emotional intelligence in project managers: Scale development and validation. *Procedia Computer Science*. 2023. Vol. 219. P. 1777–1784. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.473>.
14. Zhang L., Fan W. Improving performance of construction projects: A project manager’s emotional intelligence approach. *Engineering, Construction and Architectural Management*. 2013. Vol. 20. № 2. P. 195–207. URL: <https://doi.org/10.1108/09699981311303044>.
15. Livesey, P. Goleman-Boyatzis Model of Emotional Intelligence for Dealing with Problems in Project Management. *Construction Economics and Building*. 2017. Vol. 17 (1). P. 20–45. URL: <https://doi.org/10.5130/AJCEB.v17i1.5101>.
16. Sang P, Liu J, Zhang L, Zheng L, Yao H, Wang Y. Effects of Project Manager Competency on Green Construction Performance: The Chinese Context. *Sustainability*. 2018. 10. P. 3406. URL: <https://doi.org/10.3390/su10103406>.
17. Fisher E. What practitioners consider to be the skills and behaviours of an effective people project manager. *International Journal of Project Management*. 2011. Vol. 29. Is. 8. P. 994–1002. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.09.002>.

ЧАСТИНА 2.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛИ:

2.1. Невротичні стани та емоційні проблеми при порушенні сімейного функціонування

Бондар С. С.

Актуальність. Узагальнюючи напрацювання у наукових джерелах (Eysenck, 1971, 1972, Эйдемиллер, 2008; Кратохвіл, 2008; Мешковська, 2005; Каденко, 2007, Кришталь, 1996), можна констатувати значну чисельність напрямків досліджень проблеми адюльтеру. Досліджуються загальна психологія подружніх відносин (Роджерс 2002) та психологія сучасної сім'ї (Андрєєва, 2005). Вивчаються (Prib, Bondar, 2019) психологічні та психоемоційні проблем порушення сімейного функціонування при різних стилях сімейної взаємодії. Зазначається, що одним із чинників конфліктності (Шевчишена, 2009) у сім'ї є невідповідність між установкою шлюбного партнера і його реальною поведінкою, викликана неврахуванням індивідуальних особливостей протилежної статі, її нахилів, можливостей. Клінічний досвід (Кришталь, 1996), переконливо свідчать про те, що в сексології проблема позашлюбних зв'язків має особливе значення, оскільки при цьому деформуються і сексуальні стосунки, і особистісні відмінності подружжя, і соціальні аспекти шлюбу. Подружжя дезадаптація (Мешковская 2005) й позашлюбні зв'язки жінок призводять до розвитку у подружжя невротичних розладів, у жінок – найчасті-

ше короткочасної 40,0 %, рідше пролонгованої 22,0 % депресивної реакції, у чоловіків, окрім цих реакцій 23,0 та 27,0, також виявлена неврастенія у 19,0 % та соматизований розлад 13,0 %. Структура готовності до зради (Воронина, 2015) включає когнітивний (когнітивно-мотиваційний), емоційний і особистісний компоненти, пов'язані з усвідомленням наявності її причин, умов здійснення та наслідків, наявністю особистісних якостей, які змістовно корелюють з психологічною сутністю зради, наявністю переживань, емоцій і почуттів чоловіка, що обумовлює можливість виникнення зради. Встановлено, що (Хлопоніна, 2003) взаємозв'язок між оцінками шлюбних партнерів рівня конфліктності в кожній з досліджуваних сфер сімейно-рольової взаємодії. Взаємозв'язок сфер конфліктності свідчить про наявність кругової каузальності (причинності) сімейних конфліктів. Наявність конфлікту в одній із сфер сімейно-рольової взаємодії проєктується подружжям на інші сфери та впливає на загальну оцінку рівня конфліктності в сім'ї і на задоволеність шлюбом подружжя. Дослідниками (Каденко, 2006) вказується, що позашлюбні зв'язки призводять до розвитку невротичних та особистісних розладів (неврастенії, адаптаційних розладів, депресивних реакцій), порушення міжособистісних стосунків подружжя (втрати любові) і підривають міцність шлюбу, про що свідчить той факт, що 72,0 % чоловіків і 70,0 % жінок думали про розлучення або робили спроби розлучитися. В цілому дослідниками вивчається широка палітра впливів адюльтеру на особистість та деструкцію сімейних відносин. Проте, незважаючи на досить значне поширення наукових пошуків, спрямованих на вивчення факторів благополуччя / не благополуччя сімейних взаємин, мало дослідженим залишаються психоемоційні аспекти ролі депресії, тривоги та невротичних станів у генезі порушень життєдіяльності родини при адюльтері.

Мета – виявлення емоційних проблем та невротичних стани при порушенні життєдіяльності сім'ї (сімейного функціонування).

Результати досліджень. З дотриманням принципів деонтології (Ethical principles of psychologists and code of conduct) проведено комплексне обстеження 180 подружніх пар. Проаналізовано рівень задоволеності шлюбом та проведено порівняльний аналіз між групою подружжя у «кризовому віці браку» з наявністю адюльтеру у сімейному анамнезі (кризова група з адюльтером КГА та групою

подружжя у «кризовому віці браку» без адюльтеру у сімейному анамнезі – КГ. Обидві групи дослідження були розподілені на три підгрупи: – перша – кризовий вік браку 4 роки (період 3 – 5 років) (КГА1, n = 30, КГ1 n = 30); друга – кризовий вік браку 7 років (період 6 – 8 років) (КГА2, n = 30, КГ2, n = 30); третя – кризовий вік браку 12 років (період 11 – 13 років) (КГА3, n = 30, КГ3, n = 30). Даний етап виконувався за допомогою шкали тривоги і депресії (М. Гамільтона HARS і HDRS) та клінічного опитувальника виявлення й оцінки невротичних станів (К. К. Яхін, В. Д. Менделевич) (Райгородский, 2001). Аналіз, обробка і підрахунок процентних характеристик і коефіцієнтів кореляції здійснювалися за допомогою програми SPSS 10. 0. 5 for Windows (Бююль, 2002).

Першим етапом дослідження стало оцінка тяжкості депресії за шкалою депресії Гамільтона (HDRS), яка класифікувалася як малий та тяжкий депресивний епізод (Guelfi, 1993). В цілому респонденти розрізнялися за тяжкістю депресивного синдрому за об'єктивним критерієм оцінки. Так, у КГА психопатологічні симптоми, які за вираженістю не досягали клінічно окресленої депресії виявлено у чоловіків 50,0 % КГА1, 53,3 % КГА2 та 56,7 % КГА3. Малий депресивний епізод діагностовано у 50,0 % КГА1, 46,7 % КГА2 та 43,3 % КГА3 ($p < 0,05$). Тяжкий депресивний епізод у чоловіків не виявлено ($p < 0,05$). У жінок психопатологічні симптоми, які за вираженістю не досягали клінічно окресленої депресії виявлено у 43,3 % КГА1, 46,7 % КГА2 та 53,3 % КГА3, малий депресивний епізод діагностовано у 40,0 % КГА1, 43,3 % КГА2 та 30,0 % КГА3, тяжкий депресивний епізод у 16,7 % КГА1, 10,0 % КГА2 та 16,7 % КГА3 ($p < 0,05$). Середній бал за шкалою HDRS у чоловіків КГА1 склав – відсутність депресії – 3,0 бала, малий депресивний епізод – 9,0 балів. У КГА2 відповідно – 4,0 балів та 10,0 балів. У КГА3 відповідно – 4,0 бала та 13,0 балів. Середній бал за шкалою HDRS у жінок КГА1 склав – відсутність депресії – 6,0 бала, малий депресивний епізод – 12,0 балів. У КГА2 відповідно – 6,0 бала та 14,0 балів, у КГА3 відповідно 5,0 та 15,0 балів. У КГ психопатологічні симптоми, які за вираженістю не досягали клінічно окресленої депресії виявлено у чоловіків 53,3 % КГ1, 50,0 % КГ2 та 46,7 % КГ3. Малий депресивний епізод діагностовано у 33,3 % КГ1, 40,0 % КГ2 та 33,3 % КГ3. Тяжкий депресивний епізод діагностовано

у 13,3 % КГ1, 10,0 % КГ2, 20,0 % КГ3 ($p < 0,05$). У жінок психопатологічні симптоми, які за вираженістю не досягали клінічно окресленої депресії виявлено у 60,0 % КГ1, 46,7 % КГ2 та 40,0 % КГ3, малий депресивний епізод діагностовано у 23,3 % КГ1, 36,7 % КГ2 та 30,0 % КГ3. Тяжкий депресивний епізод у жінок діагностовано у 16,7 % КГ1, 16,7 % КГ2 та 30,0 % КГ3 ($p < 0,05$). Середній бал за шкалою HDRS у чоловіків КГ1 склав – відсутність депресії – 6,0 бала, малий депресивний епізод – 15,0 балів, тяжкий депресивний епізод – 40,0 балів. У КГ2 відповідно – 6,0 балів, 14,0 балів та 41 балів. У КГ3 відповідно – 7,0 балів, 16,0 балів та 54 бала. Середній бал за шкалою HDRS у жінок КГ1 склав – відсутність депресії – 7,0 бала, малий депресивний епізод – 16,0 балів, тяжкий депресивний епізод – 46,0 балів. У КГ2 відповідно – 7,0 бала та 16,0 балів, та 48 балів. У жінок КГ3 відповідно – 7,0 бала та 15,0 балів та 50 балів.

Таким чином, можна зазначити що за об'єктивним показником визначення депресивного стану досліджені чоловіки та жінки КГ переважали над дослідженими КГА за ступенем тяжкого депресивного епізоду. У рамках дослідження структури зустрічальності симптомів нами досліджено їх міжгруповий розподіл серед жінок та чоловіків КГА та КГ.

В цілому у КГА у чоловіків усіх трьох кризових груп виявлено симптоми усього спектру депресивного реагування, а саме: почуття провини, ранкове пробудження, знижений настрій, психічна тривога, obsесивні та компульсивні розлади ($p < 0,05$). У жінок КГА також виявлено більшість симптомів депресивного реагування, а саме: знижений настрій, почуття провини, труднощі при засипанні, безсоння, збудження, психічна тривога, соматичні порушення шлунково-кишкового тракту, загально соматичні симптоми, іпохондричні розлади ($p < 0,05$).

У свою чергу у чоловіків КГ діагностовано безсоння, ранкове пробудження, загальмованість мислення, збудження, психічна та соматична тривога, розлади сексуальної сфери, іпохондричні розлади, obsесивні та компульсивні розлади ($p < 0,05$). У жінок КГ виявлено знижений настрій, почуття провини, труднощі при засипанні, безсоння, ранкове пробудження, збудження, психічна та соматична тривога, порушення шлунково-кишкового тракту, загаль-

но соматичні симптоми, розлади сексуальної сфери, іпохондричні розлади ($p<0,05$).

Другим етапом стало дослідження тривоги за Шкалою Гамильтона (HARS) для оцінки стану наявності та глибини тривожного розладу (Райгородский, 2001). Так, у КГА психопатологічні симптоми, які за вираженістю досягали клінічно окресленої субклінічної тривоги у чоловіків виявлено у 46,7 % КГА1, 50,0 % КГА2 та 50,0 % КГА3. Тривожний стан діагностовано у 53,3 % КГА1, 50,0 % КГА2 та 50,0 % КГА3. У досліджених КГА симптомів тривоги, які б відповідали тривожному розладу не виявлено. Психопатологічні симптоми, які за вираженістю досягали клінічно окресленої субклінічної тривоги у жінок виявлено у 40,0 % КГА1, 46,7 % КГА2 та 40,0 % КГА3. Тривожний стан діагностовано у 43,3 % КГА1, 43,3 % КГА2 та 43,3 % КГА3, тривожному розладу відповідно 16,7 % КГА1, 10,0 % КГА2 та 16,7 % КГА3. Середній бал за шкалою HARS у чоловіків КГА1 склав – субклінічна тривога – 4,0 бала, тривожний стан – 13,0 балів. У КГА2 відповідно – 5,0 балів та 14,0 балів. У КГА3 відповідно – 5,0 балів та 15,0 балів. Середній бал за шкалою HARS у жінок КГА1 склав – субклінічна тривога – 6,0 балів, тривожний стан – 14,0 балів. У КГА2 відповідно – 6,0 балів та 15,0 балів, у КГА3 відповідно – 7,0 балів та 12,0 балів.

Узагальнюючи можна зазначити, що у більшості чоловіків та жінок КГА тривожний розлад відповідав легкому та середньому ступеню вираженості ($p<0,05$). При об'єктивній оцінці виявлено, що близько 40,0 % чоловіків та жінок КГА приховували симптоми тривоги ($p<0,05$).

У КГ психопатологічні симптоми, які за вираженістю досягали клінічно окресленої субклінічної тривоги у чоловіків виявлено у 43,3 % КГ1, 40,0 % КГ2 та 40,0 % КГ3. Тривожний стан діагностовано у 56,7 % КГ1, 60,0 % КГ2 та 60,0 % КГ3. Тривожний розлад не виявлено ($p<0,05$). Психопатологічні симптоми, які за вираженістю досягали клінічно окресленої субклінічної тривоги у жінок виявлено у 36,7 % КГ1, 46,7 % КГ2 та 43,3 % КГ3. Тривожний стан діагностовано у 43,3 % КГ1, 40,0 % КГ2 та 40,0 % КГ3. Тривожний розлад діагностовано у 20,0 % КГ1, 13,3 % КГ2, 16,7 % КГ3. Середній бал за шкалою HARS у чоловіків КГ1 склав – субклінічна тривога – 8,0 балів, тривожний стан – 17,0 балів, тривожний роз-

лад – 42,0 бала. У КГ2 відповідно – 8,0 балів, 18,0 балів та 45 балів. У КГ3 відповідно – 8,0 балів та 19,0 балів та 46 балів. Середній бал за шкалою HARS у жінок КГ1 склав – субклінічна тривога – 8,0 балів, тривожний стан – 18,0 балів тривожний розлад – 46,0 балів. У КГ2 відповідно – 8,0 балів, 19,0 балів та 47,0 балів. У КГ3 відповідно – 8,0 балів, 19,0 балів та 50,0 балів.

Узагальнюючи оцінювання тривоги можна зазначити що за об'єктивним показником у більшості досліджених чоловіків КГ тривожний розлад відповідав середньому та тяжкому ступеню вираженості ($p < 0,05$). Встановлено, що близько 60,0 % чоловіків та жінок КГ мали схильність до «приховування» симптомів тривоги, що виявляється при проведенні об'єктивної оцінки ($p < 0,05$).

За результатами міжгрупового кореляційного аналізу респондентів КГА (Ч+Ж) та КГ (Ч+Ж) відібрані симптоми депресії та тривоги за шкалами Гамільтона (HDRS та HARS) у яких ймовірність помилки першого роду, рівень статистичної значимості між показниками – $p < 0,05$ (достовірно значущі відмінності). Відокремлені значущі показники (симптоми), як мішені психотерапевтичної роботи відібрано та покладено у обґрунтування комплексної системи сімейного консультування (психокорекції) порушень життєдіяльності родини при адюльтері.

В цілому у чоловіків та жінок кризових груп виявлено симптоми усього спектру тривожного реагування, а саме: тривожний настрій, напруга, інсомнія, серцево-судини, респіраторні, вегетативні симптоми ($p < 0,05$). За ступенем вираженості переважали симптоми «психічного» радикалу над проявами «соматичного» радикалу тривоги ($p < 0,05$). У КГ встановлено усе тривожне реагування: напруга, соматичні сенсорні симптоми, серцево-судини, респіраторні, соматичні м'язикові, гастроінтестинальні, сечостатеві, вегетативні ($p < 0,05$). За ступенем вираженості у КГ переважали симптоми «соматичного» над симптомами «психічного» радикалу тривоги ($p < 0,05$).

Третім етапом дослідження стало виявлення функціональних розладів психічної діяльності, що виникають як реакція на значущі психотравмуючі події (конфлікти) і зумовлені недосконалістю механізмів психічного захисту. За результатом дослідження за допомогою клінічного опитувальника виявлення й оцінки невротичних станів К. Яхін, В. Менделевич, 2005 (Райгородский, 2001) встанов-

лено палітра симптомів за рахунок яких порушуються пізнавальні процеси.

За шкалою тривоги виявлено: у чоловіків КГА1 – 30,0 %, КГА2 – 33,3 %, КГА3 – 36,7 %, у жінок відповідно: КГА1 – 26,7 %, КГА2 – 36,7 %, КГА3 – 36,7 % ($p<0,05$). Тривожність у КГА характеризувався, як нестабільна реакція, яка, негативно окреслює хвилювання «внутрішнього неспокою» й відчуття «необхідності якихось пошуків». Виявлено відсутність достовірно виражених ознак підвищеної стомлюваності, слабкості, зниження працездатності ($p<0,05$). Встановлена неусвідомлена тенденція до заперечення психологічного конфлікту ($p<0,05$). Тривожність у КГ виглядала наступним чином: чоловіків КГ1 – 26,7 %, КГА – 40,0 %, КГА – 33,3 %. У жінок відповідно: КГ1 – 30,0 %, КГ2 – 33,3 %, КГ3 – 36,7 % ($p<0,05$). Тривожність у КГ характеризувалася схильністю до сприйняття широкого кола ситуацій як загрозливих власної самооцінці, престижу, самоповазі. Чоловіки та жінки виявляли: чутливість до імовірних подій бо невдач, які можуть трапитися або статися, тенденцію до зниженого фону настрою, сумніви у відповідальних рішеннях, нав'язливі думки або дії спрямовані на подолання власних страхів.

Шкала невротичної депресії. Відповідно виявлено: у чоловіків КГА1 – 23,3 %, КГА2 – 36,7 %, КГА3 – 40,0 %. Серед жінок: КГА1 – 26,7 %, КГА2 – 30,0 %, КГА3 – 43,3 % ($p<0,05$). Особи КГА с невротичною тривожністю характеризувалися рисами характеру як: прямолінійність, ригідність, безкомпромісність. Дослідженням було властива емоційна насиченість переживань щодо адюльтеру з прагненням не утримання зовнішніх проявів почуттів. У чоловіків та жінок переважав сумний настрій, адинамія нерідко з явищами нав'язливості й іпонхондричності. Вербально скрізь депресивний фон проявлялася ситуація, яка травмувала чоловіків та жінок – ситуація адюльтеру. У чоловіків та жінок першому плані іноді відзначалися вегетативно-соматичні порушення. Невротична депресія у КГ виглядала наступним чином: чоловіків КГ1 – 26,7 %, КГА – 40,0 %, КГА – 33,3 %. У жінок відповідно: КГ1 – 26,7 %, КГ2 – 33,3 %, КГ3 – 40,0 % ($p<0,05$). У досліджених КГ відмічалася тужливе відношення щодо перспективного майбутнього. Вербально скрізь депресивний фон проявлялася ситуація, яка травмувала – чоловіків та жінок криза сімейних відносин. Виявлено, що депресивна симптоматика

по-часту стосувалася сімейно-сексуальних взаємин, а досліджувані частіше «рятувалися втечею в роботу». Перебіг невротичної депресії мав хвилеподібний перебіг із сльозливістю. Невротична депресія характеризувалася «легкими формами» з скаргами на: зниження активності, постійні порушення сну (утруднене засипання або раптові пробудження серед ночі з відчуттям тривоги і серцебиттям; в ранковій годині розбитість і млявість), смуток, втрату радості від життя. Придушені негативних емоцій викликало вегетативно-соматичні розлади, а саме: коливання артеріального тиску, серцебиття, запаморочення, дисфункції шлунково-кишкового тракту. Знижений настрій, по-часту супроводжувався стійкою артеріальною гіпотензією і симптомами спастичного коліту

За шкалою астенії відповідно виявлено: у чоловіків КГА1 – 23,3 %, КГА2 – 40,0 %, КГА3 – 36,7 %. Серед жінок: КГА1 – 26,7 %, КГА2 – 33,3 %, КГА3 – 40,0 % ($p < 0,05$). У КГА астенічні прояви розвивалися повільно (стомлюваність, дратівливість, «втомою, що не шукає спокою»). У тяжких випадках супроводжувалися аспонтанністю, пасивністю, адинамією, порушенням сну. Прояви астенічного кола були: емоційна нестійкість, образливість, вразливість, слабкість, підвищена стомлюваність, труднощі концентрації уваги. Поверхневий та тривожний сон характеризувався відчуттям що не відпочили, труднощами засинання й прокидання. Астенія у КГ виглядала наступним чином: чоловіків КГ1 – 30,0 %, КГА – 36,7 %, КГА – 33,3 %. У жінок відповідно: КГ1 – 26,7 %, КГ2 – 30,0 %, КГ3 – 43,3 % ($p < 0,05$). Астенічні прояви у КГ проявлялися підвищеною стомлюваністю, ослабленням або втратою здатності до тривалого фізичного і розумової напруги. У жінок спостерігаються дратівлива слабкість, що виражалася збудливістю і виснаженістю, сльозливістю, гіперестезією. У чоловіків – афективною лабільністю з переважанням зниженого настрою з рисами примхливості і невдоволення.

За шкалою істеричного типу реагування відповідно виявлено: у чоловіків КГА1 – 30,0 %, КГА2 – 30,0 %, КГА3 – 40,0 %. Серед жінок: КГА1 – 30,0 %, КГА2 – 23,0 %, КГА3 – 46,7 % ($p < 0,05$). У КГА аналіз істеричного кола реагування виявити, що конверсійні прояви спрямовані на звільнення від зовнішніх і внутрішніх обов'язків, й є заклик до навколишнього світу для звернення уваги. У глибині проявів «ховається» сімейна криза, прояви

служать метою отримати користі шляхом утворення істеричного симптому з певним задоволення від витіснених спонук (первинна користь від кризи). Завдяки зовнішній увазі у вигляді адюльтеру досягається нарцистичне задоволення (вторинна користь від кризи). Конверсійні реакції були властиві істеричним й нарцистичним типам досліджуваних, а за інтенсивністю й формою залежали від соціальних умов, навикишнього світу, тривоги та оцінки близьких. Істеричне реагування у КГ виглядало наступним чином: чоловіків КГ1 – 26,7 %, КГА – 36,7 %, КГА – 36,7 %. У жінок відповідно: КГ1 – 30,0 %, КГ2 – 26,7 %, КГ3 – 43,3 % ($p<0,05$). У досліджених КГ аналіз істеричного коло реагування дозволив виявити, що витісненого душевного конфлікту у кризовий період родини у соматичну симптоматику спрямовані на неусвідомлені від конфлікту символічних вигод. Істеричні – конверсійні розлади треба розглядати як апеляцію. Символічно вони виражають умовної «докіру»: «від мене нічого більше не можна вимагати, зі мною трапилося лихо, тепер нарешті про мене будуть піклуватися». За шкалою obsесивно-фобічних порушень відповідно виявлено: у чоловіків КГА1 – 30,0 %, КГА2 – 30,0 %, КГА3 – 40,0 % ($p<0,05$). У жінок відповідно: КГ1 – 26,7 %, КГ2 – 30,0 %, КГ3 – 43,3 % ($p<0,05$). У респондентів КГА аналіз obsесивно-фобічного кола реагування виявити, що obsесії, які виникали буди пов'язання з фактом адюльтеру (викликали небажані уявлення, думки, образи або спонування). Obsесії по-часту викликали тривогу. Obsесивно-фобічні порушення у КГ виглядало наступним чином: чоловіків КГ1 – 23,3 %, КГА – 40,0 %, КГА – 36,7 %. У жінок відповідно: КГ1 – 26,7 %, КГ2 – 33,3 %, КГ3 – 40,0 % ($p<0,05$). Obsесивно-фобічні порушення у КГ характеризувалося тим, що були іноді настільки тяжкими, що самі ставали причиною порушення сімейного функціонування. Коло obsесивно-фобічних проявів можна було трактувати як проблему «очікування» повторного адюльтеру від партнера. За шкалою вегетативних порушень відповідно виявлено: у чоловіків КГА1 – 26,7 %, КГА2 – 33,3 %, КГА3 – 40,0 %. Серед жінок: КГА1 – 30,0 %, КГА2 – 33,3 %, КГА3 – 36,7 % ($p<0,05$). Вегетативні порушення у КГ виглядали наступним чином: чоловіків КГ1 – 23,3 %, КГА – 43,7 %, КГА – 33,3 %. У жінок відповідно: КГ1 – 30,0 %, КГ2 – 30,0 %, КГ3 – 40,0 % ($p<0,05$). У досліджених

КГА та КГ прояві вегетативних порушень на тлі тривалої психофізичної напруги внаслідок сімейної кризи були подібні та виглядали наступним чином. Прояві слабкості, зниження концентрації уваги та працездатності. Дослідженим було властиво зниженням активності, боязкість, слабкість, коливання настрою, мушки перед очима, розлади сну, тремтіння пальців, пригніченість, тиск у голові, головні болі, періодичні запаморочення, відсутність апетиту, шлунково-кішкові скарги порушення потенції або лібідо.

Висновки. Встановлено, що за ступенем тяжкого депресивного епізоду переважали досліджені КГ над КГА. У КГА та КГ в усіх кризових групах виявлено симптоми депресивного реагування. Виявлено, що у КГА тривожний розлад відповідав легкому та середньому ступеню вираженості, у КГ – середньому та тяжкому ступеню вираженості ($p < 0,05$). У КГА 40,0 % чоловіків та жінок КГА, а у КГ 60,0 % приховували симптоми тривоги ($p < 0,05$). За ступенем вираженості у КГА переважали «психічні» симптоми тривоги над «соматичними» ($p < 0,05$), у КГ навпаки «соматичний» радикал тривоги над «психічним» ($p < 0,05$). Психоемоційної сфера у КГА характеризувалася неусвідомленим запереченням психологічного конфлікту ($p < 0,05$), у КГ – схильністю до сприйняття широкого кола ситуацій як загрозливих для самооцінки, самоповазі ($p < 0,05$). Досліджені КГА с невротичною тривожністю вербально скрізь депресивний фон проявляли травмуючу ситуацію адюльтеру ($p < 0,05$), у КГ – кризу сімейних відносин з «втечею в роботу». У КГ істеричне реагування проявлявся витісненням душевного конфлікту у соматичну сферу з наявністю не усвідомлених від конфлікту символічних «умовних вигод» ($p < 0,05$). Обсесивно-фобічне коле реагування у КГ характеризувалося як «очікування» повторного адюльтеру від партнеру ($p < 0,05$).

Література.

1. Мешковська, О. А. Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок (Автореф. дис. ... канд. мед. наук за спец. 19. 00. 04 – медична психологія). ХМАПО МОЗ України. 2005. Харків, 27 с.

2. Кришталь, В. В., Андрух, Г. П. Сексуальная гармония супружеской пары. Харьков: Велес, 1996. 160 с.

3. Eysenck, H. J. Personality and Sexual Adjustment The British Journal of Psychiatry, Volume 118, Issue 547 June 1971, pp. 593-608. <https://doi.org/10.1192/bjp.118.547.593>
4. Eysenck, H. J. Personality and sexual behaviour. Journal of Psychosomatic Research, Vol. 16, pp. 141 to 152. Persamon Press, 1972. Printed in Northern Ireland
5. Каденко, О. А. Подружня дезадаптація та позашлюбні сексуальні зв'язки (Автореф. дис. ... д-ра мед. наук за спец. 19. 00. 04 – медична психологія). ХМАПО МОЗ України. 2007. Харків, 28 с.
6. Роджерс, К. Психологія подружніх відносин. Можливі альтернативи / Пер. з англ. В. Гаврилова. М. : Изд-во Ексмо, 2001. 288 с. URL: <http://socio.125mb.com/psihologiya-suprujeskih-otnosheniy-vozmojnyie.html>
7. Андреева, Т. В. Психологія сучасної сім'ї. Монографія. Санкт-Петербург: Речь, 2005. 436 с. URL: <http://socio.125mb.com/psihologiya-sovremennoy-semi-monografiya-spb.html>
8. Prib, H., Bondar, S. Psychological and psychoemotional disorders of family functioning. Psychological Prospects Journal, (34), 2019. 206-218. <https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-206-218>
9. Шевчишена, О. В. Вплив соціально-психологічних установок на сімейне життя та виникнення конфліктів у молодій сім'ї / О. В. Шевчишена // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д., К. : ГНОЗІС, Т. XI., частина 2, 2009. 523-532.
10. Хлопоніна, Н. Є. Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування //Актуальні проблеми психології. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Кісарчук З. Г., К. : Міленіум, Вип. 2., 2003. 132-137.
11. Ethical principles of psychologists and code of conduct / American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). Effective January 1, 2017 Available at: <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
12. Guelfi, G. D. Devaluation clinique standardis ee en psychiatic, psycho-pathologie denerale. Depression, anxiete, et anxiodepression. 2003. Editions Medi-cales Pierre Fabre

2.2. Невротичні розлади у дітей та дорослих в умовах соціального стресу

Борець О. А.

Актуальність. Значний інтерес до формування невротичних розладів пов'язаний не лише зі серйозною поширеністю даної патології у суспільстві. Тривожні та невротичні розлади привернули велику увагу наукового співтовариства протягом останніх кількох десятиліть, але в останні роки важливість цієї теми стрімко зросла. На даний час 450 млн. осіб в світі страждають на психічні розлади. За даними МОЗ 2012 року в усьому світі, і в нашій країні зокрема, останнім часом продовжується зростання числа невротичних розладів. За статистичними даними лише 10 % населення стресостійкі, 25 % переживають стрес із втратами для здоров'я, 2/3 всіх захворювань займають невротичні, пов'язані зі стресом, та соматоформні розлади.

Через підвищений рівень стресу в суспільстві, який склався через глобальну пандемію, спричинену коронавірусом COVID-19, та значну кількість соціальних обмежень, викликаних нею, у 2020 році невротичні розлади вийшли на лідируючі позиції. Такі явища, як: вимушена довготривала ізоляція, перехід на дистанційне навчання та дистанційну роботу, соціальна ізоляція в громадських місцях, страх заразитися коронавірусом та страх захворіти стали основними чинниками формування низки страхів та невротичних безпорядків у суспільстві з 2019 року [2; 3].

Повномасштабна війна, яка триває на території України вже більше року, є невичерпним джерелом травматичних подій, під якими маються на увазі такі екстремальні, критичні та надзвичайні ситуації, які мають сильний і негативний вплив на людей і вимагають надзвичайних зусиль на межі можливостей для подолання наслідків цього впливу [15]. Вони можуть набувати форми незвичайних обставин або подій, які наражають особу на екстремальний, інтенсивний та винятковий ризик загрози життю чи здоров'ю для неї та її родини та фундаментально порушують відчуття безпеки.

Враховуючи сьогодишню ситуацію в Україні, коли вже вичерпались сподівання про швидке завершення війни, українське суспільство все більше охоплює стан розпачу та розчарування, напруження та виснаження, що значно посилює депресивні настрої та призводить до дезадаптивних станів, психопатизації особистості та зростання кількості психосоматичних та соматопсихічних та невротичних станів та захворювань.

Мета. Розглянути наукові погляди на формування невротичних розладів у дітей та дорослих в умовах соціального стресу та теоретичне дослідження чинників і механізми його виникнення.

Результати досліджень. Аналізуючи дані літератури, можна помітити, що більшість авторів [2; 5; 7; 9; 10] все частіше починає розглядати специфіку впливу мікросоціальних факторів на етіопатогенез невротичних розладів. Хоча важливість макросоціальних подій у житті українців останнім часом збільшилася, все ж роль сім'ї, друзів, товаришів, робочого мікроколективу та інших важливих людей потужно зростає і це цілком може формувати патологічний гомеостаз на рівні невротичного розладу. Нестабільність суспільства в цілому призводить до нестабільності сім'ї як окремої соціальної одиниці. Це відображається на всіх сферах сімейного життя: економічному, комунікаційному, побутовому, духовному. У 80 % психотравмуючих ситуацій, що призводять до розвитку неврозів, вони супроводжуються хронічними та деструктивними конфліктними відносинами між членами сім'ї [9]. В основі суб'єктивних невротичних конфліктів лежить прагнення одного з партнерів до нереалістичних цілей, а також однобічне домінування чи дезадаптації у ролі члена сім'ї під час і після криз, що відбуваються в сімейному житті [8].

Оскільки діти найбільше піддаються впливу стресових факторів, такі явища, як війна, постійні повітряні тривоги, дистанційне навчання, вимушене переселення, нестабільність сімейних стосунків між дорослими тощо, стали основними факторами розвитку суттєвого «помолодшання» ряду тривожних станів, симптомів та невротичних розладів також і у дітей.

Дослідниця невротичних розладів О. С. Юрценюк у своїй роботі звертає увагу на те, що майже у всіх наукових роботах, присвячених невротичним розладам, автори звертають увагу на значення соціальних факторів у патогенетичних механізмах цієї патології.

Лише в поодиноких дослідженнях намагаються визначити окремі механізми патогенезу невротичних розладів залежно від конкретного соціального чинника. Одним із потужних факторів патогенезу сучасних неврозів (залежно від ступеня важливості, усвідомленості, походження, реальності та перспективи) дослідники розглядають і безробіття. У працях багатьох авторів [6; 8; 9] цей фактор оцінюється як особливий, що визнається і сьогодні. Науковці зазначають, що безробіття одного з членів сім'ї може бути надзвичайно травмуючим фактором як для безробітного, так і для інших членів сім'ї.

Сьогодні найбільш поширеними у світовій літературі стають концепції багатофакторної етіології невротичних розладів за якими визнається єдність біологічних, психологічних і соціальних механізмів, проте, значних труднощів додає оцінка ролі етіологічних чинників. Психотравматизація є однією з основних причин невротизації, але її патогенний вплив визначається сукупністю зв'язків з багатьма іншими чинниками (генетика, епігенетика), які є ключовими у психофізіологічному формуванні особистості.

Проте, незважаючи на численність і різноплановість досліджень у цій галузі, багато аспектів залишаються недостатньо врахованими, зокрема, сучасні дослідження стресу, застосування методів подолання стресу в умовах сучасної ситуації в Україні. Тому проблема збільшення кількості та сили проявів невротичних розладів у дітей і дорослих у сучасних умовах набуває актуальності, а розуміння існуючих загроз та ризиків, механізмів їх дії та способів захисту стає не лише психологічною проблемою, а й нагальною потребою в соціальній практиці.

Соціальні катаклізми, а особливо війни, завжди виявляють вплив на появу хвилі невротичних проявів та невротичних розладів, особливо у військових та населення, що знаходяться у зоні конфлікту або задіяних навіть лише на емоційному рівні у цій катастрофі. Особливості невротичних проявів внаслідок участі у військових діях перебувають у мозаїчній синдромальній структурі захворювання з переважанням експлозивних та obsesивно-фобічних розладів, відсутністю чіткої етапності у динаміці розвитку та зв'язку з психотравмуючою ситуацією. Формування невротичного розвитку у обстежуваного контингенту через 1,5 – 2,5 роки з появою виражених дезадаптивних характерологічних рис, високого

ризик суїцидальної поведінки, інших девіантних форм реагування та поведінки [2; 3; 10].

За даними проведених досліджень [3; 7; 10], вплив травматичних подій розповсюджується не лише на безпосередні жертви, а набагато ширше, ефекти травматизації охоплюють їхні сім'ї, оточення, працівників рятувальних служб. Виділяють наступні основні фактори та умови, значимі для формування невротичних розладів, які містять сім основних груп:

1. Особливості пережитої психотравмуючої екстремальної ситуації.

2. Професійні фактори (для професій підвищеного ризику).

3. Соціально-демографічні фактори.

4. Фактори, пов'язані із станом здоров'я.

5. Соціальні фактори.

6. Соціально-психологічні фактори.

7. Індивідуально-психологічні фактори.

Типовими важкими стресорами є бойові дії, природні та транспортні катастрофи, нещасні випадки, присутність при насильницькій смерті інших, розбійний напад, тортури, зґвалтування, пожежа [7].

Психологічні наслідки психічної травми, що виникають в результаті впливу на людину екстремальних, тих що «виходять за рамки» звичайного людського досвіду, травматичних подій притягують і у теперішній час дедалі більше уваги вчених і практиків області медицини, психології, соціальної політики. До нашого часу очевидний підтверджений клінічною практикою і багатьма науковими дослідженнями, в тому числі соціологічними і психологічними, а також даними державної статистики, довготривалий характер несприятливого впливу наслідків техногенних катастроф на психічне і соматичне здоров'я потерпілих, їх соціальну адаптацію. Значну роль відіграє психічна травматизація, пов'язана з фрустрацією потреби в безпеці, обумовлений направленими в майбутнє впливом екологічних чинників, неясністю екологічної ситуації та ін. [1; 6; 8].

Виявлення посттравматичних стресових розладів у постраждалих від техногенних катастроф є соціально значимим фактором. Відомо, що особи у яких виникає цей розлад, більше ніж інші, схильні до різних форм дезадаптивної поведінки, у них частіше

виникає синдром алкогольної залежності, наркоманія, суїциди і т. ін. Ці люди потребують особливої соціальної і медико-психологічної підтримки. Про те, що серед постраждалих часто починається «хвиля» суїцидів, можна судити не тільки з публікацій в засобах масової інформації [9].

За численними дослідженнями бачимо, що, основою невротичних конфліктів в більшості випадків є особистості людини [11]. Із загальнобіологічної точки зору невроз розглядається як модель хронічного емоційного стресу. Проте неодноразово доведено, що основним проявом невротичного процесу на всіх етапах його виникнення, становлення та розвитку є порушення емоційного реагування [4; 9]. Термін «невроз» здебільшого визначається в психології як наслідок гострого або хронічного емоційного ефекту (з дуже високою особистісною значущістю), який завжди є небажаним і порушує здатність задовольняти потреби, важливі для конкретної людини, а отже, викликає явно негативні емоції, які разом з емоційними розладами призводять до вегетативного та ендокринного дисбалансу [2].

При експериментальному вивченні неврозів сучасні дослідники підтвердили, що неврози починаються з порушення системи особистих стосунків, створюючи суб'єктивно підвищені значущі цінності [1; 7]. Існує також думка [8], що в основі неврозу лежить не порушення, а неадекватність системи відносин, викликана розвитком особистості, яка страждає на невроз.

Водночас важливу роль відіграють психосоціальні стресори, які можуть призводити до значних порушень гомеостазу [8; 10]. Причини за яких формуються невротичні розлади досить складні та численні, а багатофакторна обумовленість невротичних розладів визнається більшістю дослідників [1; 4; 5]. Нерідко стимулом до появи невротизації стають різні психотравматичні ситуації, за яких порушується компенсація: надмірне збудження, негативні емоції, гострі конфлікти, шкідливі звички, виснаження. Разом з тим, чинниками, що призводять до розвитку невротичного розладу можуть бути невирішені внутрішні конфлікти, що вимагають занадто багато внутрішніх ресурсів для боротьби суперечливих почуттів особистості.

Основним чинником розвитку невротичних розладів наукова спільнота вже давно визнає психогенну природу невротичних розла-

дів та надають особливого значення факторам біологічного та соціального характеру. Дискусійним серед зарубіжних авторів залишається питання впливу стресового фактору на виникнення та перебіг невротичних розладів. При цьому, одні автори пов'язують невротичний розлад безпосередньо з кількістю стресів та зниженням адаптації до них, інші – з фактором подолання цих стресів, тобто приходять до висновку, що кожна людина створює свої власні стреси, труднощі для себе, які викликають властиві тільки даній людині психічні або соматичні порушення. Ситуація відіграє роль пускового механізму, який актуалізує наявну неадекватність системи відносин, тому при одній і тій же психотравмі неврози частіше зустрічаються у людей, які мають певні індивідуальні особливості: підвищену чутливість, нестійкість і нестійкість настрою, вразливість, схильність до депресії, істеричні реакції, які важко адаптувати до суспільних змін.

При цьому, інтенсивність стресу не завжди обумовлює важкість розладу. Стреси можуть бути поодинокими, тривалими або тимчасовими, динамічними, періодичними. Різним станам життя властива своя специфіка стресових ситуацій (початок навчання, відхід від батьків, вступ у шлюб, поява дітей та їх відхід з дому, недосягнення професійної мети, вихід на пенсію) [3; 4].

Також варто не забувати, що особливості особистості формуються під впливом спадково-конституційних рис, а також освітніх та екологічних факторів. Важливу роль у розвитку невротичних станів відіграють психотравми дитинства [9, 54]. Особливо сильно піддаються стресовому впливу люди, виховані в системі жорстких правил і установок по відношенню до себе і оточення. Усілякі відхилення від звичного сприймання можуть викликати у свідомості такої людини безліч небажаних уявлень. Людина стає психічно напруженою, шукає способи захисту або виходу з виниклих ситуацій, і одним з них є хвороба. Окрім того, патогенез невротичних розладів, останнього десятиріччя зумовлений впливом екзогенних факторів, серед яких значне місце належить синдрому алкогольної залежності [3; 5] тісно пов'язаному з емоційними проявами на всіх етапах свого зародження, формування та розвитку [1; 6].

Розвитку неврозів істотно сприяють такі чинники, як особливості фізичного стану організму при емоційному напруженні (хронічна втома, голод, тривале недосипання, соматичні захворювання,

ендокринні розлади, екзогенні отруєння). А. М. Вейн [9] вважає невроз психогенним захворюванням, яке виникає на тлі специфічних особливостей особистості і призводить до виникнення психічного конфлікту і розвитку зворотних розладів в емоційній, соматичній і вегетативній сферах, тому, на його думку, критеріями діагностики неврозів повинні бути:

- 1) наявність психотравмуючої ситуації;
- 2) наявність відповідних особливостей конституції особи;
- 3) наявність психічного конфлікту;
- 4) деякі клінічні симптоми захворювання [3].

Отже, згідно з науковими джерелами, невротичні розлади є наслідком невдач, фрустрацій і міжособистісних конфліктів і разом з тим є їх причиною, створюючи замкнутий цикл: конфлікти призводять до невротизації, яка, як наслідок, провокує нові конфлікти. Патогенними можуть бути ситуації, що порушують гідність, в тому числі моральну, викликають страх та становлять небезпеку для життя людини а також сповіщення про смерть близьких тощо [6; 3]. Постійне емоційне напруження призводить до перевантаження адаптаційних механізмів і соматовегетативної сфери та розвитку невротичних розладів [3].

При невротичних розладах спостерігаються порушення в психічній сфері людей зі специфічними схильностями, а травматичні зовнішні чинники провокують розвиток психічного захворювання.

Як свідчать дослідження вчених [2; 7; 9; 11], тривалий характер негативних соціально-економічних процесів призводить до розпаду звичних соціальних зв'язків (наприклад, на підставі різних політичних вподобань та поглядів), безлічі внутрішньо особистісних та міжособистісних конфліктів. Переосмислення життєвих цілей і крах усталених ідеалів і авторитетів сприяє зміні звичного способу життя, втраті багатьма людьми почуття власної гідності. Як наслідок – тривожна напруженість і розвиток «кризи ідентичності особистості». Така криза характеризується ригідністю (негнучкістю) особистісних установок. Людина не здатна змінити намічену раніше програму власних дій. У той час як умови життя змінилися і об'єктивно вимагають перебудови стереотипів поведінки при мінливих суспільних відносинах і нестабільній економічній ситуації [1].

Що відбувається з людиною в переломні часи? Перш за все, загострюються, стають яскраво вираженими риси характеру, які раніше людина приховувала і контролювала. Поведінка людини може характеризуватися панічними реакціями, депресивними, істеричними, тривожно-фобічними проявами. У багатьох знижується бажання спілкуватися: втрачається толерантність у спілкуванні, знижується здатність адаптуватися до нових умов. Звужується коло спілкування (тенденція до спілкування тільки з «однодумцями»). Спостерігаються песимізм, різні прояви цинізму, схильність до антисоціальних дій, поширюється зневіра в закон, алкоголізм і наркоманія.

У багатьох людей із соціально-стресовими розладами з'являється байдужість до ситуацій, які ще недавно були особистісно значущими. Нерідко людина шукає в навколишній дійсності реальні або «додумує» приклади соціальної несправедливості і недоброчисливості, які можуть супроводжуватися реакціями соціального протесту (стихійними зібраннями, бійками), правопорушеннями.

Розвиваються почуття незадоволеності, спустошеності, постійної втоми, обтяжливі відчуття переважання негативних подій та відсутності перспектив. Люди гостро відчувають посилення несправедливості, жорстокості, власну безпорадність, нездатність змінити ситуацію на краще і, водночас, «всемогутність» тих, хто впливає на ситуацію в суспільстві.

Соціально-стресові розлади не з'являються миттєво, а розвиваються як захисні реакції, які виникають при впливі на людину інших травмуючих психіку факторів. Спостерігаються три етапи їх розвитку:

- перший етап – тривожний стан, в якому людина перебуває тривалий час. Ця захисна реакція супроводжує спробу відразу пристосуватися до нових соціальних умов. Формує у багатьох людей активне протистояння новим умовам життя;

- другий етап – відносне пристосування до життя в умовах, що змінилися, етап резистентності. За неможливості адаптуватися до нових умов викликає, перш за все, стомлену байдужість;

- третій етап – напружений резистентний спокій. Є базою формування багатьох форм і варіантів невротичних і соматичних розладів. Розуміння, який етап розвитку соціально-стресового розладу

є характерним для конкретної людини, є важливим фактором при оцінці її стану і розробці комплексу відповідних рекомендацій [2].

За даними літератури, поширеність розладів психіки й поведінки серед підлітків досягає від 27-45 % до 58,4 % від числа хворих і нервово-психічними порушеннями [4]. Підвищений рівень стресу в суспільстві також став основним чинником розвитку ряду тривожних і невротичних розладів у дітей [2; 3].

Хоча ці захворювання порівняно недавно вважалися рідкісними та відносно незначними в дитинстві, сьогодні їх небезпека та вплив на якість життя дітей та їхніх рідних недооцінюють. Через зростання захворюваності в усіх країнах світу, складність диференціальної діагностики та неоднозначність тактики лікування тривожно-невротичні розлади залишаються одними з найбільш малодосліджених і найскладніших проблем сучасної дитячої неврології.

Дослідження показали, що неврози з кожним роком «молодшають» і в онтогенетичному вимірі охоплюють все молодший вік. Незважаючи на зменшення кількості дитячих захворювань, зростає кількість функціональних синдромів, причини яких, на думку швейцарських лікарів, слід шукати в соціальному середовищі дитини.

Аналізуючи тривожні розлади у дітей можемо виділити декілька окремих нозологічних форм [7]:

- тривожний розлад через тривогу розлуки – страх чи побоювання, що щось погане може статися з людиною, до якої прив'язана дитина;

- генералізований тривожний розлад – схильність до тривоги через численні страхи, стосовно того, що може трапитися щось жахливе;

- соціальна фобія – уникання соціальних контактів з метою дистанціюватися від можливої негативної оцінки оточуючих;

- специфічні фобії – боязнь тварин, комах, темряви, клоунів, гучних звуків (грози), незнайомих людей, злодіїв, крові, шприців, уколів і т. ін. ;

- панічний розлад – страх раптових панічних атак, що супроводжуються соматичними симптомами (задишка, серцебиття, пітливість) а також страх смерті або втрати свідомості;

– агорафобія – страх потрапити у місця, з яких важко швидко вибратися (натовп, громадські заклади і транспортні засоби, кіно-театри тощо).

Справжній панічний розлад та агорафобія не часто зустрічаються в дітей дошкільного й молодшого шкільного віку й характерні переважно для підлітків [1].

Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) є одним із найпоширеніших неврологічних розладів у дітей та підлітків. Поширеність цього розладу становить 1 – 4 % від усього населення [4]. Наразі 5-е видання Американської психіатричної асоціації з діагностики та статистики психічних розладів (DSM 5) визначає ОКР як стан, що характеризується компульсивними, ірраціональними думками, потягами чи ідеями (нав'язливими ідеями) у поєднанні з нав'язливою поведінкою та ритуалами (компульсіями), які дитина змушена постійно повторювати, щоб зменшити власну тривожність. Ці симптоми неминуче негативно позначаються на якості життя і часто супроводжують інші нервово-психічні розлади [8]. При цьому психологічні переживання зосереджені на очікуванні конкретної загрози або небезпеки (наприклад, зараження інфекційним захворюванням), а ритуальна поведінка дозволяє зосередитися на сенсі запобігання або відвернення цієї загрози (наприклад, миття рук, користування речами з антисептичною дією) [9].

Інші симптоми ОКР можуть включати імпульсивність, істерики, агресивну поведінку та компульсивні харчові звички, пов'язані з розладами харчування. Іноді виникають різноманітні занепокоєння, пов'язані з гігієною, забрудненням, чистотою, одноманітністю у розташуванні предметів побуту в певному порядку, ритуалами одягання та виконанням повсякденних дій [4; 8; 9].

Обсесивно-компульсивний розлад – це хронічний стан, який вражає людей з раннього дитинства до зрілого віку та має характеристики спектру розладів, починаючи від деяких обсесивно-компульсивних ознак до явного обсесивно-компульсивного розладу. Obsесивно-компульсивний розлад часто залишається нерозпізнаним протягом тривалого часу, і діти часто стикаються з нерозумінням їхньої патологічної поведінки з боку батьків, членів родини та однолітків [10].

Також тривога у дітей пов'язана з низкою рис темпераменту, включаючи поведінкову загальмованість, замкнутість, боязкість

і сором'язливість. Діти з важкою інтелектуальною недостатністю в ранньому віці мають високий ризик розвитку тривожних розладів у майбутньому [11].

Найбільш поширеними симптомами недорозвинення у віці 2–5 років є: занурення в себе в новому колі знайомств та подій; недружелюбність; труднощі сепарації; мовчазність; відсутність чи уникання зорового контакту; відсутність бажання досліджувати оточення [7]. Стиль виховання тривожних дітей найчастіше характеризується надмірною опікою, настирливістю батьків, рідше – негативізмом. За висновками дослідників дитячого невротизму, загальмовані діти можуть провокувати батьків на надмірну опіку, яка, в свою чергу, призводить до надмірної тривожності дітей. Також деякі джерела припускають, що тривожні батьки підвищують ризик тривоги у своїх дітей, моделюючи власні страхи та стратегії вирішення проблем [4]. Також одним із специфічних та разом з тим, дуже поширеним останнім часом, стресових факторів, який може відігравати важливу роль у розвитку невротичних станів, є знущання (булінг) та глузування. Тривожні діти частіше зазнають знущань і глузувань з боку своїх однолітків, вони частіше піддаються ігноруванню та витісненню з соціального кола інших дітей. Подібні розлади адаптації виникають при тривалому перебігу психогенного чинника (зміна місця проживання, дитячого садка, школи, розлучення батьків тощо).

Висновки. Отже, важливість та нагальність духовного та емоційного відродження держави в умовах значних соціально-економічних змін робить значно актуальнішими проблеми виховання і розвитку дітей, їх адаптації до нових соціальних та суспільно-політичних відносин, нових вимог до якості життя. Аналіз літературних джерел свідчить, що діти з невротичними ускладненнями є предметом дослідження як загальноосвітньої, так і спеціальної педагогіки та психології, тому в цілому відзначається, що діти з розладами емоційно-вольової сфери відносяться до категорії аномальних дітей, хоча не потребують спеціального навчання та особливого ставлення, але вони потребують спеціального, корекційного та соціально орієнтованого виховного впливу. Стрес впливає на зміну соціального функціонування людини, що може проявлятися у вигляді різних психічних порушень з переважанням тривожної

та депресивної симптоматики, посттравматичних стресових розладів [7]. У сучасних умовах з «перехідними» ритмами стрес набуває хронічного перебігу та нерідко грає важливу роль в етіології та патогенезі психічних і соматичних розладів. Так стрес призводить до зміни рівня соціального функціонування особистості, яка в свою чергу може проявлятися у вигляді різних психічних розладів, при яких переважають симптоми тривоги та депресій.

Важливо враховувати, що у структурі прикордонних нервово-психічних захворювань значне місце займають форми із затяжним протіканням хвороби. В сучасній психіатрії є низка досліджень, присвячених формуванню затяжних форм невротів та невротичного розвитку особистості. Загальновизнаним є факт, що характер і перебіг невротичних розладів більшою мірою, ніж інші психічні порушення, що знаходяться в тісному зв'язку з соціальними умовами, громадським укладом, домінуючою системою цінностей, що за останні десятиліття зазнали значних змін у нашій країні [2; 3; 5; 8]. Проте до теперішнього часу залишається невирішеною ціла низка методологічних питань щодо не лише лікування цих станів, але й їх діагностики, тому дослідження особливостей виникнення та перебігу психічних розладів в умовах соціального стресу, є очевидно перспективними і вони повинні базуватися на результатах комплексних досліджень, що включають динамічний аналіз психічного і соматичного стану особистості, її психічних особливостей та якостей, мікросоціальних умов життя.

Література.

1. Кокун О. М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти. Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. 2005;5(4):77-85.
2. Лазос Г. П. Посттравматичне зростання: теоретичні моделі, нові перспективи для практики. Актуальні проблеми психології. 2016;1(45):120-7.
3. Омельченко Я. М. Значення типу реагування на стрес значимих дорослих у процесі формування стресостійкості особистості. Психологічний часопис. 2019;5(12):169-81. doi: 10.31108/1. 2019. 5. 12. 11
4. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні. Інформаційно-аналітичний огляд за 2008-2012 рр. Київ; 2013. 202 с.

5. Чабан О. С. Неврозы: патоморфоз, концепция, пространство и территория. Тернополь: Збруч; 1997. 161 с.
6. Шелюг О. А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій. Психологія особистості. 2014;1:112-29. doi: 10.33989/2226-4078. 2014. 1. 148873
7. Юрценюк О. С. Психологічні та соціальні чинники розвитку невротичних розладів у студентів (огляд літератури). Буковинський медичний вісник. 2016;20(1):236-39. doi: <https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.1.77>. 2016. 51
8. Liu G, Weinger JG, Lu ZL, Xue F, Sadeghpour S. Efficacy and safety of MMFS-01, a synapse density enhancer, for treating cognitive impairment in older adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Alzheimers Dis. 2016;49(4):971-90. doi: 10.3233/JAD-150538
9. Lungu A, Sun M. Time for a change: college students' preference for technology-mediated versus face-to-face help for emotional distress. Telemed J E Health. 2016;22(12):991-1000. doi: 10.1089/tmj.2015.0214
10. Zhang XC, Kuchinke L, Woud ML, Velten J, Margraf J. Survey method matters: online/offline questionnaires and face-to-face or telephone interviews differ. Comput Human Behav. 2017;71:172-80. doi: 10.1016/j.chb.2017.02.006

2.3. Психологічні механізми комунікації у підлітковому віці

*Гавучак Д. В., Кротъ Р. С., Кушнір Ю. Ю.,
Ліщук О. В., Присяжнюк Г. В., Рачковський Е. А.*

Актуальність. Підлітковий вік є чутливим і перспективним для подолання наявних відхилень та адаптації в суспільстві, необхідно приділяти належну увагу контингенту підлітків, забезпечувати спеціальну психологічну допомогу в системі освіти. Щоб організувати допомогу підліткам з проблемами в розвитку, необхідно вивчити психічні особливості даного контингенту, механізми та структуру порушення. Підлітки з порушеннями відрізняються нестійкістю психічних функцій в силу наявності у них психічних порушень, пов'язаних з підвищеним рівнем збудливості і недостатнім рівнем контролю.

Проблема підліткової тривожності є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній психології. Серед негативних переживань людини тривожність займає особливе місце, часто вона призводить до зниження працездатності, продуктивності діяльності, до труднощів у спілкуванні. Людина з підвищеною тривожністю надалі може зіткнутися з різними соматичними захворюваннями. Розібратися у феномені тривоги, а також в причинах її виникнення досить складно. У стані тривоги ми, як правило, переживаємо не одну емоцію, а деяку комбінацію різних емоцій, кожна з яких впливає на наші соціальні взаємини, на наш соматичний стан, на сприйняття, мислення, поведінку. Ключовою емоцією у суб'єктивному переживанні тривоги є страх. Слід розрізняти тривогу як стан і тривожність як властивість особистості.

Мета дослідити психологічні механізми комунікації у підлітковому віці.

Результати досліджень. Тривога – реакція на небезпеку, що загрожує та реальну або уявну, тобто емоційний стан дифузного безоб'єктного страху, що характеризується невизначеним відчуттям загрози (на відміну від страху, який являє собою реакцію на

цілком певну небезпеку). Тривожність – індивідуальна психологічна особливість, яка полягає у підвищеній схильності відчувати занепокоєння в різних життєвих ситуаціях, у тому числі і тих, об'єктивні характеристики яких до цього не привертають.

Поряд зі спробами прийти до узгодженого визначення для опису стану тривоги, дослідники намагаються виявити, в чому криються справжні причини виникнення цього стану. Серед можливих причин називаються і фізіологічні особливості (особливості нервової системи підвищена чутливість), і індивідуальні особливості, і взаємини з однолітками і з батьками, і проблеми у школі та багато іншого. Багато фахівців сходяться у думці, що серед причин, що викликають дитячу тривожність, на першому місці – неправильне виховання і несприятливі відносини дитини з батьками, особливо з матір'ю.

При оцінці стану проблеми тривожності у психологічній науці відзначаються дві, на перший погляд взаємовиключні тенденції. З одного боку, посилення на не розробленість і неясність самого поняття «тривожність» як в нашій країні, так і за кордоном. Вказується, що під цей термін часто підводить досить різноманітні явища і що значні розбіжності у вивченні тривожності існують не тільки між різними школами, а й між різними авторами всередині одного напрямку, підкреслюється суб'єктивність використання даного терміну. З іншого, боку, між дослідниками існує згода по ряду основних моментів, що дозволяють окреслити деякі «загальні контури» тривожності (розгляд її у співвідношенні «стан-властивість», розуміння функцій стану тривоги) і виділити тривожний тип особистості.

За деякими джерелами, кількість публікацій з даної проблеми з кожним роком збільшується майже в геометричній прогресії. Тут необхідно зазначити, що все це більшою мірою відноситься до зарубіжної науки. І все ж, незважаючи на значну кількість робіт, вказівки на не розробленість і невизначеність проблеми, багатозначності і неясності проблеми і самого терміну «тривожність» займають значне місце при її обговоренні. Неодноразово порушувалося питання про те, чи дійсно тривожність являє собою щось єдине або цим терміном позначається сукупність зовнішніх схожих, але, по суті, абсолютно різних явищ.

На думку А. М. Прихожан, особливо гострою проблема тривожності є для дітей підліткового віку. В силу ряду вікових особливостей

підлітковість часто називають «віком тривоги». Підлітки тривожаться з приводу своєї зовнішності, з приводу проблем у школі, взаємин з батьками, вчителями, однолітками. А ще тому що у підлітковому віці тривожність може закріпитися в якості стійкого утворення.

Становлення емоційно-вольової сфери, з якою тісно пов'язане формування особистості – складний і тривалий процес, що характеризує психічний розвиток. Воно протікає під безпосереднім впливом з боку оточуючих, в першу чергу дорослих, які виховують дитину. Без знання особливостей емоційної сфери дітей, важко вірно реагувати на їхні вчинки, вибирати відповідні осуд або заохочення, цілеспрямовано керувати вихованням.

Тривожність – широко поширений психологічний феномен нашого часу. Вона є частим симптомом неврозів і функціонального психозу, а також є пусковим механізмом розладів емоційної сфери особистості. Це послужило підставою для вибору теми.

Природа людини, її індивідуальність та стиль спілкування з іншими формуються під впливом обставин життя. І природу і обставини можна змінити. Звичайно, спосіб взаємодії суб'єкта з оточуючими визначається не лише його навичками міжособистісного спілкування. Велике значення має також загальна установка індивіда щодо світу інших людей та самого себе. Однак і ці стійкі моделі поведінки, стереотипи мислення та емоційних переживань, сформовані під впливом різноманітних обставин і ситуацій міжособистісного спілкування, можуть у відповідних умовах змінюватися. Створювати такі умови здатні люди, зацікавлені у самовдосконаленні.

Можливість саморозвитку значною мірою залежить від сформованості навичок міжособистісного спілкування, від того, наскільки людина зможе зрозуміти, що саме відбувається в процесі її контактів з іншими, від того, чи вдається їй знайти з ними спільну мову і спільно розв'язувати проблеми.

Метою формування міжособистісного спілкування має бути не вдосконалення здатності маніпулювати іншими, а розвиток здатності створювати самому чи спільно з партнерами такі умови й атмосферу стосунків, які сприяли б духовному зростанню людини, розкриттю її конструктивних можливостей.

Заслугують на увагу думки, висловлені ним щодо умінь, які необхідні для забезпечення ефективності спілкування. Сюди він

відносить: вміння управляти своєю поведінкою, вміння «читати» за виразом обличчя, вміння розуміти співрозмовника, вміння «подати себе», культуру мовлення, вміння пізнавати інших і себе у процесі спілкування, аналізувати власну поведінку, бачити, розуміти, усвідомлювати зміст інформації, що надходить у процесі спілкування. На його переконання, спілкування є важливою категорією, процесом або процесами, які здійснюються всередині певної соціальної спільноти – групи, колективу, суспільства в цілому і за своєю суттю є не міжіндивідуальними, а соціальними. Тобто, вони виникають в силу суспільної необхідності і виконують певні функції, спрямовуються на створення психологічного клімату.

Близькими до ідей, сформульованих О. Леонтьєвим, є погляди В. Г. Панок, який до структури спілкування включає такі компоненти, як: програмування мети спілкування та шляхів її досягнення; мовленнєве та інше знаково-спрямоване продукування, що виконує програму; контроль за перебігом власної комунікативної поведінки, її корекція; контроль за комунікативними вчинками інших людей; порівняння результату акту комунікації з наявною програмою.

У структурі спілкування М. В. Даниленко розрізняє такі складові, як:

- уяву на етапі підготовки до спілкування, яка допомагає передбачати його контури й очікуване сприйняття інформації;
- уяву, що допомагає безпосередньо перед спілкуванням уявити його особливості, спрогнозувати очікувану реакцію слухачів;
- уяву, яка стимулює творче самопочуття;
- уяву, що допомагає у процесі спілкування здійснювати інтуїтивний пошук, мислений експеримент, орієнтуватись у мотивах реакції аудиторії з одночасною підтримкою творчого самопочуття;
- уяву, котра допомагає після спілкування передбачати його можливі результати, ефект.

Досліджуючи цю проблему з точки зору педагогіки, М. Д. Бойноправ стверджує, що виділення вільного спілкування як особливого виду діяльності може бути досить доцільним і наголошує на тому, що діяльність людини не слід зводити лише до її предметного аспекту. Тоді спілкування природно розглядається як прояв людської активності.

Проблеми, пов'язані із спілкуванням, особливостями перебігу цього процесу, знаходяться в полі зору зарубіжних учених. Наприклад, відомий американський учений Г. Томе, розглядаючи ці питання, зокрема на рівні вчителя й учнів, значну увагу надає розвитку комунікативних умінь, основними з яких виступають вербальне й невербальне спілкування та вміння слухати. Виходячи з цього, він виділяє два невід'ємні компоненти спілкування: вербальний (вимовлені слова та їх значення) і вокальний (голосові модуляції, тембр, тон, темп, висота та гнучкість голосу).

На основі викладеного вище, доходимо висновку, що спілкування – це складний вид людських відносин. Спілкування можна розглядати як взаємодію людей і як діяльність, оскільки при цьому завжди висувається якась мета (передати інформацію, досягти визнання, змінити чиюсь поведінку тощо), індивіди керуються тими чи іншими мотивами, використовують засоби і, залежно від їх адекватності, отримують результат. Спілкування як діяльність розвиває емоційну сферу, адже один з партнерів провокує виникнення в іншого певних емоцій, які, закріплюючись, стають характеристиками його особистості.

Виходячи з наукових теорій щодо сутності поняття «спілкування» та особливостей процесу його реалізації, розрізняють і функції спілкування. Перша з них полягає в регулюванні спільної діяльності людей, участь у якій вимагає від кожної з них певних знань. Діти одержують такі знання внаслідок спілкування з дорослими, опанування навчальним матеріалом, здійснення пізнавальної активності в різних видах діяльності. Звідси впливає друга функція – пізнавальна. Вже немовля, спілкуючись з дорослими, засвоює основні компоненти спілкування як діяльності, здатність зосереджувати увагу на тому, хто до нього звертається; збуджуватися при встановленні контактів. У віці трьох років дитина в загальних рисах уже знає, як треба спілкуватись. Ця здатність є виявом елементів свідомості. Звідси третя функція спілкування, що може бути визначена як первинний інструмент формування свідомості особистості. Дитина дістає відомості про довкілля в «опредмеченому» вигляді й поступово переходить до «опредмечення» себе самої, відокремлення свого «Я». Цьому сприяє четверта функція спілкування – са-

мовизначення індивіда. Таким чином, спілкування можна вважати дійовим чинником формування особистості.

М. С. Корольчук та В. М. Крайнюк виділяють такі функції процесу спілкування, як: інформаційна, інтерактивна, перцептивна. Інформаційна функція обумовлюється тим, що сам процес спілкування можливий і доцільний при виникненні необхідності передати чи одержати якусь інформацію. У процесі спілкування люди пізнають один одного, самих себе, що досягається завдяки інтерактивній функції. Вони порівнюють різні точки зору, формують власні погляди на ту чи іншу проблему, доходять певних висновків. У цьому проявляється перцептивна функція. Цю класифікацію Т. Ф. Алексєнко доповнює креативною функцією, яка проявляється у творенні змінної поведінки у процесі спілкування.

На думку І. Д. Беха, функція спілкування полягає в тому, щоб зрозуміти іншого таким, яким він є, вміти поставити себе на його місце. Особливу увагу автор надає єдності переживання й розуміння інших, що реалізується завдяки перевтіленню у стан партнера по спілкуванню. А для цього необхідно подолати свій «аутизм», тобто «вжитися» з власного світобачення.

Г. Ващенко, на додаток до наведених вище функцій спілкування, виділяє ще мотиваційну та регулятивну. Прояв першої з них він пояснює тим, що людина як соціальна істота живе серед подібних до себе, пов'язана з ними численними взаєминами, завдяки чому відбувається взаємовплив установок, мотивів поведінки. Орієнтуючись у своїх діях, люди створюють певні традиції, норми спілкування, його закони та принципи – в цьому й проявляється регулятивна функція цього процесу.

М. Д. Бойноправ розрізняє такі функції спілкування, як: комунікативна – забезпечення зв'язку між людьми; інформативна – сприяння духовному збагаченню індивіда знаннями, вміннями та навичками; психотерапевтичну – надання можливості одним, обдарованим і підготовленим індивідам, створювати на інших оздоровчий вплив; педагогічну – формування свідомості, організація діяльності та взаємин дітей і молоді; гедоністичну – введення людини у процесі спілкування у стан духовного задоволення, насолоди; морально-естетичну – умиротворення тривожного почуття совісті людини, задоволення духу гуманними вчинками, пережи-

вання відчуття краси; релігійну – забезпечення колективної та особистісної взаємодії з Богом на основі необмеженої віри у безсмертя, надії на спасіння та потреби любові до ближнього.

Таким чином, можна сказати, що спілкування має взаємний характер, коли кожний з партнерів шукає в іншому його внутрішній світ, духовні якості, почуття, думки й переживання. Водночас слід враховувати, що результативність спілкування залежить від узгодженості зовнішніх (цілі, завдання, організаційні форми діяльності тощо) та внутрішніх чинників, які полягають у взаєморозумінні, психологічній сумісності, емоційному контакті партнерів, а також від умов, рівня знань, умінь і навичок спілкування.

Таким чином, доходимо висновку, що спілкування виконує такі основні функції:

- комунікативну – встановлення контактів між людьми;
- інформаційну – передача і засвоєння певної інформації;
- перцептивну – забезпечення пізнання індивідами один одного, порівняння позицій, формулювання відповідних висновків;
- інтерактивну – організація взаємозв'язку, налагодження зворотного зв'язку між суб'єктами спілкування;
- креативну – творення змінної поведінки в процесі спілкування;
- мотиваційну – продукування взаємовпливу, що зумовлює формування певних установок, мотивів діяльності;
- регулятивну – орієнтація у власних діях, вироблення певних законів, принципів, норм поведінки;
- сугестивну – емоційно-вольовий вплив на присутніх.

Спілкування між людьми може відбуватися в різних формах: анонімній, функціонально-рольовій та неформальній.

Анонімне спілкування передбачає взаємодію між незнайомими чи не пов'язаними особистісними стосунками людьми. Це можуть бути тимчасові зв'язки між суб'єктами, в яких вони виступають як громадяни, мешканці одного району, пасажери транспорту, глядачі на культурних чи спортивних заходах тощо. Вони зустрічаються, вступають у контакти один з одним і розходяться. Тобто, партнери по спілкуванню залишаються анонімними.

Функціонально-рольове спілкування передбачає зв'язки між його учасниками, які виконують певні соціальні ролі в часових відрізках різної тривалості. Партнерів у цьому спілкуванні поєднують

взаємні обов'язки, наприклад: лікар – хворий, керівник – підлеглий, учитель – учень тощо.

Досить часто функціонально-рольове спілкування передбачає встановлення контактів поза межами офіційних стосунків: скажімо, спілкування друзів. Його особливістю є вибірковість щодо партнера. У цьому випадку воно набуває форми неформального спілкування.

Зміст спілкування реалізується за допомогою певних засобів, головним з яких є мова. Мовні (вербальні) засоби доповнюються невербальними: жести, міміка, пантоміміка та ін. Види спілкування вирізняються за різними параметрами. Залежно від контингенту учасників спілкування може бути міжособистісним, індивідуально-груповим та міжгруповим. За мірою опосередкованості вирізняють безпосереднє і опосередковане спілкування. За тривалістю – короткочасне й тривале, відповідно до завершеності – завершене та незавершене.

Підлітковий вік багатий переживаннями, труднощами і кризами. В цей період складаються, формуються стійкі форми поведінки, риси характеру, способи емоційного реагування; це пора досягнень, стрімкого нарощування знань, умінь; становлення «Я», набуття нової соціальної позиції. Разом з тим, це втрата дитячого світовідчуття, поява почуття тривожності і психологічного дискомфорту.

Підлітковий вік часто називають періодом диспропорції у розвитку. У цьому віці збільшується увага до себе, до своїх фізичних особливостей; загострюється реакція на думку оточуючих, підвищується почуття власної гідності і образливості. Фізичні недоліки часто перебільшуються. Перш за все, в порівнянні з дитячим віком, зростаючу увагу до свого тіла обумовлено не тільки фізичними змінами, а й новою соціальною роллю підлітка. Оточуючі очікують, що завдяки фізичній зрілості він вже повинен справлятися з певними проблемами розвитку.

У підлітків розвивається тривога з приводу і норми розвитку, це пов'язано, перш за все, з диспропорціями у розвитку, з передчасним розвитком, і його затримкою.

Усвідомлення соматичних змін включення у схему тіло – одне з найважливіших проблем періоду статевого дозрівання. Підлітки відзначають також соціальну реакцію на зміну їх фізичного образу (схвалення, захоплення чи відраза, глузування, презирство) і включають її в уявлення про себе. Це формує у підлітка низьку

самооцінку, невпевненість у собі, скутість у спілкуванні і зниження почуття власної значимості. До того ж сексуальний розвиток дуже тісно пов'язаний з формуванням почуття гідності і гордості, особистісної ідентичності.

Актуальним стає, як зазначає Х. Ремшидт у роботі «Підлітковий і юнацький вік», порівняння себе з однолітками, оскільки діапазон нормальної мінливості залишається невідомим, це може викликати тривожність і привести до гострих конфліктів або депресивного стану і навіть до хронічних неврозів. Сюди входять такі функціональні зміни організму, як передчасне статеве дозрівання, затримка розвитку, також до причин, які викликають тривожність у підлітків, можна віднести юнацькі вугрі, надмірна вага, затримка росту.

Наступною причиною можна виділити сексуальний розвиток підлітків. В цьому процесі вирішальну роль грає ЦНС, місце інтеграції нервових і психічних феноменів. Таким чином, розвиваються сексуальні потреби і потяги, які під впливом психосоціальних та соціальнокультурних факторів (статеве виховання, норми, індивідуальна психічна зрілість, приклади дорослих) по різному виражаються у поведінці. Але тут можуть виникати статеві порушення: з якихось причин дозрівання немає і не виникає ні сексуального потягу, не відповідних переживань. Якщо відсутні необхідні психосоціальні (соціальнокультурні) чинники або серед них переважають покарання й обмеження, сексуальні потреби можуть також зникнути бути недорозвиненими. Це може привести до неузгодженості між нормальним розвитком та психічним переживанням і поведінкою, викликаючи невпевненість в собі, зниження самооцінки і т. ін.

Потрібно зауважити, що прояв тривожності може протікати в 2 варіантах: це страх – гнів і страх – страждання, які по – різному проявляються, але однаково дезадаптують особистість. Необхідно звернути увагу на значимість сім'ї і школи в період дорослішання. Оскільки підлітковий вік це протиріччя між прагненням здаватися і невмінням «бути дорослим». Це протиріччя між прагненням до незалежності і необхідністю підкорятися вказівкам дорослих.

Труднощі підліткового віку пов'язані з підвищеною збудливістю, з іпохондричними реакціями, з афективною, з гострою реакцією на образ, з підвищеною критичністю по відношенню до старших.

Зростає роль референтної групи, що сприяє розриву з батьками, як зразком для наслідування. З боку батьків зростають обмеження і заборони; у зв'язку з новими змінами у сім'ї зростає число конфліктів. Економічні умови можуть стати причиною для неспокою: оскільки підліток постійно відчуває себе залежним, несамостійним. Молоді люди довго залежать від батьків у фінансовому відношенні. Неуспішність у школі може бути причиною конфліктів. Напружені відносини між батьками і дітьми обумовлені не стільки конфліктом між поколіннями, скільки зміненими економічними умовами і технологічним прогресом, перед обличчям яких батьки, як і діти, відчувають себе невпевненими і неспокійними, що породжує тривожність і нерішучість, а вони в свою чергу формують власний характер. Поряд з батьківським домом, школа – найважливіша інстанція соціалізації. Шкільні конфлікти пов'язані в основному з успішністю, адаптацією, авторитетом і автономією. У зв'язку з вимогами, які пред'являються до успішності, виникають конфлікти, як з учителями, так і з однолітками. По відношенню до вчителів можуть виникнути протести, відмова займатися і добиватися успіхів. Така поведінка зустрічається і у здібних і у критично налаштованих підлітків.

У відносинах з ровесниками можуть виникати конфлікти на ґрунті суперництва. Це впливає на психосоціальну адаптацію школярів та збереження класу як єдиного суспільства. Конфлікти в області автономії й авторитету обумовлені утиском свободи шкільними правилами. Підлітки вимагають обґрунтувати їх, відчувають над собою небажану опіку.

Тривога – це суб'єктивний прояв неблагополуччя особистості. Підлітки молодші і старші мають свої відмінні риси, і вони великі, але можна говорити про типові, характерні риси цього періоду, за рівнем і характером психічного розвитку. Дорослі, підкреслюючи, що підліток вже не маленька дитина і пред'являючи до нього підвищені вимоги, продовжують часом відмовляти йому в праві на самостійність, можливості на самоствердження. Звідси і виникають більшість конфліктних ситуацій, образи і різноманітні форми протесту.

Стан тривожності – наслідок підліткової кризи, який протікає, по-різному і дезорганізує особистість підлітку, впливає на всі сторони його життя. Ці кризи можуть стати причиною різних форм

поведінки, що відхиляється і особистісних порушень, в тому числі і тривожності. Через незнання дорослими періодизації вікового розвитку, особистість підлітку розвиватиметься аномально, тобто «криза підліткового віку» буде протікати з ускладненнями. Для кризи ідентичності характерно переживання підлітком почуття меншовартості, депресивний стан і сексуальні наміри. Криза ідентичності, на думку Х. Решмідта, можна розглядати як реакцію на втрату статусу дитини, на невідповідність біологічних можливостей соціальним, на невпевненість у своїй компетенції, у своєму статусі, на різкі біологічні зміни, що відбуваються в організмі підлітку.

Узагальнюючі можна зазначити що однією з важливих потреб будь – якої людини і підлітку, у тому числі, є потреба в емоційному благополуччі. Невизначеність соціального статусу підлітку, наявність сильної потреби у досягненнях, потреби в уникненні неспіху як у діяльності, так і у взаєминах з однолітками, робить підлітку особливо чутливим до невизначених і непереборних ситуацій, які ведуть до підвищеної загальної напруженості, емоційного неблагополуччя. При аналізі чинників, які впливають на успішність навчальної діяльності школярів, особливу увагу звернено на тривожність як відносно стійке особистісне утворення. Визначення тривожності в розумінні А. М. Прихожан, тобто тривожність – це стан, що виявляється в переживаннях емоційного дискомфорту внаслідок оцінки суб'єктом об'єктивно нейтральних ситуацій як містять для нього певну небезпеку, дифузну, чітко недиференційовану загрозу. Аналізуючи стан тривожності, пов'язаний з незадоволенням різних соціогенних потреб у підлітковому віці, розглянуто питання про її причини. В процесі проведення теоретичного дослідження виявлено такі джерела тривожності: реальна неспішність школярів в двох найбільш значущих областях – навчанні та спілкуванні з однолітками; особливості самооцінки; неблагополучний соціальний досвід (перш за все спілкування з батьками та іншими значущими дорослими).

Одним з важливих питань у вивченні тривожності є питання про її діагностику, тому що своєчасне виявлення тенденцій до високих рівнів тривожності, дозволяє вчасно почати проводити профілактичні заходи і корекційну роботу, тим самим, підвищуючи ефективність профілактичної та корекційно – розвиваючої роботи.

Висновки. Отримані літературні дані свідчать про те, що деякі з підлітків мають рівень тривожності, невідповідний нормі вікового розвитку, що може говорити у даному випадку і про деяке зміщення вікових меж областей проявів тривожності в значенні змісту страхів. Статеві відмінності виявляються в бік більшої тривожності у хлопчиків. Високо тривожні підлітки схильні сприймати загрозу своїй самооцінці і життєдіяльності в широкому діапазоні ситуацій та реагувати дуже вираженим станом тривожності. Деякі підлітки продемонстрували небажання повідомляти про свій стан, що в деяких випадках свідчить про наявність захисних механізмів. На підставі отриманих у дослідженні даних з'явилася необхідність у розробці рекомендацій для психолога щодо виявлення та профілактики підвищеного рівня тривожності, для класного керівника – рекомендацій по профілактиці тривожності у школярів і роботі з тривожними підлітками. А також, в складанні програми профілактичних заходів з батьками та підлітками з метою просвіти їх про психологічні особливості підліткового віку, а також про прояви тривожності (батьківські збори, класна година) і про способи подолання тривожності підлітків.

Література.

1. Калюжна Є. М., Гайдаєнко С. П. Вплив сім'ї на формування девіантної поведінки підлітка. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : матеріали V Всеукр. наук. – практ. конф. 21–22 жовтня 2021 р. м. Запоріжжя, 2021. С. 43–44
2. Мацуляк Л. А. Неблагополучні сім'ї як чинник негативної соціалізації у суспільстві неповнолітніх. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2010. Вип. 8. С. 685–687.
3. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Зверев. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 336 с
4. Маліхіна Т. Психолого – педагогічна робота з попередження аморальної поведінки підлітків/ Т. Маліхіна. – «Рідна школа» – 1999. №9. – 50 – 53 с.
5. Міщик Л. І. Соціально – психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків / Л. І. Міщик, З. Г. Білоусова. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 108 с.

2.4. Підтримки психічного здоров'я особистості: європейські та вітчизняні практики

*Гуляєва Л. П., Драган В. В., Ваколюк Б. В.,
Ковальов Д. Ю., Крилов М. О., Пріб Я.А.*

Актуальність. Особистість, як соціальна істота, постійно перебуває серед людей, під впливом соціальної діяльності й тих відносин, що склалися в суспільстві. Можна сказати, що вона перебуває під постійним тиском великого потенціалу зовнішнього психічного, яке чинить на неї і негативний, і позитивний вплив.

Незалежний збіг ідеального уявлення про себе з реальним визначає душевне благополуччя людини. Але коли з'явилася суттєва розбіжність, то виникає внутрішнє напруження, яке спонукає до змін ідеального або реального уявлення про себе, або до спроб загалом не сприймати інформацію, що призводить до дисбалансу уявлень. В останньому випадку в процес втручається інстанція, здатна до створення захисних механізмів.

Мета даного дослідження – виявлення психологічних особливостей психоемоційного реагування особистості в ситуації життєвих змін.

Результати досліджень. В останнє десятиріччя термін «психологічний захист» часто вводиться в контекст всіляких як наукових, так і науково-популярних праць по медичній, соціальній, віковій і педагогічній психології, нейропсихології, педагогіці, юридичній психології. М. Прошкіна почала спробу систематизації типології захисних механізмів у медичній психології (у клініці неврозів – по Б. Д. Карвасарському, у дослідженнях стресу – по В. А. Ташликову; у клініці алкоголізму – по В. Э. Бехтелю) і в юридичній психології (по А. Р. Ратинову й Г. Х. Єфремовій). Незважаючи на актуальність, теоретичну й практичну значимість цих досліджень, вузька спеціалізація авторів залишає відкритим питання про системну й універсальну концепцію захисту.

У науково-популярній літературі трактування цього поняття варіюються від ортодоксально психоаналітичних до вузько тематичних, самодіяльних і досить непереконливих. При відсутності системної концепції захисту й одночасної потреби в науковій інтерпретації й прогнозуванні захисного поведіння індивідів і груп, у суспільну свідомість заставляється спрощене, багато в чому утилітарне подання про складний психічний феномен. Відсутність, принаймні, у вітчизняній науковій літературі, розвиненого й структурованого поняття про захисні механізми зізнається практично всіма дослідниками. Наприклад, Ф. Е. Василюк затверджує, що надія «рано або пізно відшукати вичерпний набір захисних або компенсаторних «першоелементів» ілюзорна». Представники глибинної психології, сходячись у розумінні механізмів захисту як невід'ємної властивості індивіда, дотримувалися різних поглядів на джерела конфліктів, що приводять їх у дію. На відміну від З. Фрейда, що розглядало як джерело внутрішнього конфлікту протидія сил Воно, Его й супер-его, Д. О. Юнг зв'язував внутрішній конфлікт із невідповідністю між вимогами зовнішнього середовища й типологічною установкою індивіда; А. Адлер – з комплексом неповноцінності; К. Хорні – з несумісними невротичними потребами індивіда; Г. Саллівен – з конфліктуєчими вимогами складних міжособистісних зв'язків; Е. Еріксон – із психосоціальними кризами ідентичності.

Розглядаючи особистість як відкриту, що саморозвивається систему, представники гуманістичної психології доводять, що в основі розвитку особистості лежить її прагнення до порушення рівноваги із середовищем. Аналіз поглядів Г. Олпорта й А. Маслоу показав, що в їхньому розумінні розвиток особистості це, насамперед, особистісний ріст, що полягає в реалізації особистісного потенціалу. А. Маслоу, зв'язуючи ступінь самоактуалізації зі ступенем адекватності подання особистості про себе й про світ, бачить у захисних механізмах внутрішні перешкоди для адекватного світосприймання, а, отже, і для реалістичного оволодіння ситуацією.

Механізми психологічного захисту розуміються як похідні емоцій, оскільки кожна з основних захистів онтогенетично розвивалася для стримування однієї з базисних емоцій. Наприклад, теорія затверджує, що заміщення розвивалося спочатку й головним чином для керування з вираженням гніву, придушення – для керування

з вираженням тривоги, заперечення – з вираженням довіри, а проєкція – з вираженням недовіри або неприйняття. У кожному випадку страх є загальний елемент, що бере участь у конфлікті емоцій. Ця модель має кілька передумов для вимірів. Передбачається, що існує вісім базисних захистів, які тісно пов'язані з вісьма базисними емоціями еволюційної теорії. Ці захисти повинні мати специфічні відносини подібності-розходження один з одним. Більше того, існування захистів повинне забезпечити можливість непрямого виміру рівнів внутрішньо-особистісного конфлікту, тобто дезадаптовані індивіди (установлені за допомогою незалежних методів) повинні використовувати захисти більшою мірою, чим адаптовані випробувані. Узагальнюючі можна визначити, що категорія психологічного захисту ставиться в сучасній психології до розряду давно й міцно затвердилися. Вона давно увійшла в усі психологічні словники й довідники як загальноприйняте поняття з області психології особистості. У широкому змісті термін «Захист психологічний» уживається для позначення будь-якого поведіння, що усуває психологічний дискомфорт – одне із самих загальних визначень цього феномена. За цим і аналогічним визначеннями коштує подання про індивідуально-психологічну природу явища психологічного захисту і її механізмів, породжене ще в рамках психоаналізу З. Фрейда.

Захисні механізми психіки виникають у ранньому дитинстві та розвиваються протягом життя. Вони являють собою пристосувальні процеси, властивості, якості, яких особливість набуває у процесі соціалізації. Таким чином, механізми психологічного захисту ніби оберігають усвідомлення особистістю різного роду негативних емоційних переживань та перцепції, сприяють збереженню психологічної стабільності, вирішення внутрішньо особистісних конфліктів і протікають на несвідомому та підсвідомому рівнях. Однак у дорослому стані, при взаємодії в розширеному соціальному оточенні, захисту тільки за типом автоматизмів буває явно недостатньо. Тому якщо вона не ускладняється і не коригується, то за певних умов може призвести до дезадаптації особистості.

А. Фрейд на конкретних прикладах показала розмаїтість, складність, межі застосування захисних механізмів, підкреслюючи, що для захисту можуть використовуватися досить різні види дій, що

захист може направлятися не тільки проти потягів, але й проти всього того, що викликає тривогу.

Мета психологічного захисту – розвантаження центральної нервової системи від надмірних або застійних потреб і підкріплення збудження, підтримання психіки. Нерідко психічний захист трактується як ненадійний або болісний спосіб примирення індивіду з неприйнятною для нього інформацією. При цьому використовують терміни «витискання» або «заборона» на її усвідомлення. Здається, що способи «заборони» або «витискання» є вимушеним, досконалим, паранормальним способом психічного захисту особистості. Ось основні шляхи психічного захисту особистості: захист шляхом розумових дій; захист шляхом реакцій розрядки; захист жартами; захист від звичайної діяльності. При цьому просто безглуздо було б вважати, що свідомість «захищається» від підсвідомості або «несвідомого»: психіка – єдине ціле, і як ціле, але з різною активністю тих чи інших своїх відділів, вона захищає свій гомеостаз в умовах проблемних життєвих ситуацій від дезорганізації і розладів. Наприклад: застійне погребове збудження (психічне навантаження); патологічна фіксація якогось змісту, що веде до формування; патологічної домінанти (розладу потягів); стійкі протиріччя всередині комплексу «Я», що порушують його цілісність.

Концепція психологічного захисту була й залишається одним з найбільш важливих внесків психоаналізу в теорію особистості й у теорію психологічної адаптації. Аналіз літературних джерел, що стосується становлення проблематики психологічного захисту, дозволяє виділити кілька причин складності й суперечливості визначення статусу цього явища як об'єкта наукових досліджень. Насамперед можна відзначити наступне. Як науковий факт феномен психологічного захисту, будучи вперше зафіксований у парадигмі психоаналітичних теорій, пізніше активно вивчався в різних напрямках глибинної психології – напрямку, відношення до якого продовжує залишатися досить складним. Серед причин, що обумовили неприйняття психоаналізу, сучасні дослідники на перший план ставлять факторів ідеологічного порядку. Г. А. Ільїн відзначає: «соціальний песимізм З. Фрейда, його невір'я в кероване суспільство, у можливість формування поведінки людей, перевиховання людини. Ця позиція йшла врозріз із потребами сучас-

ного миру, де рішення завдання керування суспільством і людьми є не тільки бажаним, але й необхідним.

Відомий скепсис відносно психоаналізу виникав також у зв'язку з його певною методологічною ущербністю: редукціонізмом, щиросердечного й соціального життя індивіда, переносом клінічних, психопатологічних факторів на пояснення поведінки здорової людини, постійним підкресленням примата несвідомого, вибудовуванням аналогій між онтогенезом і антропогенезом, твердженням постійного конфлікту між свідомістю й несвідомим, проблематичністю експериментальної перевірки результатів. Така глобальна негативна оцінка психоаналізу нерідко вела до замовчування або перекрученого піднесення тих психічних явищ, заслуга відкриття яких йому належить. Сам факт того, що явище психологічного захисту було виявлено в практиці психоаналізу, приводив до його витиснення зі сфери наукових інтересів більшості дослідників. А ті з них, хто, так чи інакше, все-таки торкався проблеми захисних механізмів (і тим самим визнавав за ними статус наукового об'єкта), не мали строго обґрунтованого визначення цього феномена психічного життя.

Спостереження за результатами функціонування захисту ускладнюються тим, що реальні стимули й реакції можуть бути віддалені одне від одного в часі й просторі. Безглузде з погляду біхевіоризму розрізнення самих дій і їхньої мотивації грає тут саму істотну роль. Все це обумовлює появу в науковій літературі фрагментарних описів одиничних і особливих фактів і утрудняє виділення загального. Крім того, нагадаємо, що деякі механізми захисту дуже близько співвідносяться один з одним, так що знайти розходження між ними буває нелегко, а виразні границі можна провести досить умовно.

Перше згадування про захист утримується наприкінці другої частини «Попереднього повідомлення» В. Бройера й З. Фрейда (1893 р.), що представляє собою один з розділів «Дослідження з істерії». Уперше З. Фрейд самостійно вживає термін «захист» у своїй роботі «Захисні нейропсихози» (1894 р.). Пізніше в «Етіології істерії» (1896 р.) З. Фрейдом уперше докладно описане функціональне призначення, або ціль, захисту. Вона полягає в ослабленні інтрапсихічного конфлікту (напруги, занепокоєння), обумовленого протиріччям між інстинктивними імпульсами несвідомого

і вимогами зовнішнього середовища, що виникають у результаті соціальної взаємодії. Надалі в таких творах, як «Концепція придушення», «По ту сторону принципу задоволення», «Психологія має і аналіз «Я»», ««Я» і «Воно»» і ін., термін «захист» був замінений 3. Фрейдом на «придушення». У додатку до роботи «Придушення, симптоми й занепокоєння» (1926 р.) 3. Фрейд повернувся до старої концепції захисту, увівши, поряд із придушенням, спеціальні позначення для інших механізмів захисту, які використовуються в науковій літературі дотепер. Були визначені, таким чином, феноменологія, мета й психологічний суб'єкт захисту.

Останнє висловлення по цій проблемі зустрічається в п'ятій частині статті 3. Фрейда «Крайній і безкрайній аналіз». (1937 р.). У цій роботі захист уперше представлений «як загальне найменування всіх тих механізмів», які, будучи продуктами розвитку й навчання, послабляють діалектично єдиний внутрішньо-зовнішній конфлікт і регулюють індивідуальне поведіння. Тобто явище зв'язується з основними функціями психіки: пристосуванням, зрівноважуванням і регуляцією.

Погляди А. Фрейда принципово не відрізняються від поглядів 3. Фрейда останнього років його творчості. Її заслуга укладуться в спробі створення цілісної теоретичної системи захисних механізмів. У своїй фундаментальній монографії, що вийшла у світло в 1936 році, вона вперше докладно описала різні способи захисного поведіння (56). Механізми захисту розглядалися нею як перцептивні, інтелектуальні й рухові автоматизми різного ступеня складності, що виникли в процесі мимовільного й довільного навчання; визначальне значення в їхньому утворенні надавалося подіям, що травмують, у сфері ранніх міжособистісних відносин. Мова йде, таким чином, про генезис захисту. А. Фрейд виділено кілька критеріїв класифікації захисних механізмів, таких, як локалізація погрози «Я», час утворення в онтогенезі, ступінь конструктивності. Останній критерій знайшов подальший розвиток у сучасному розподілі механізмів захисту на первинні й вторинні, примітивні й розвинені, менш або більше усвідомлені, адаптивні й неадаптивні. Вона ж до кінця розвила ідею 3. Фрейда про зв'язок між окремими способами захисту й відповідних неврозів, визначила роль захисних механізмів у нормі й патології індивідуального розвитку.

І, нарешті, А. Фрейд дає першу розгорнуту дефініцію захисних механізмів: «Захисні механізми – це діяльність «Я», що починається, коли «Я» піддане надмірної активності спонукань або відповідних їм афектів, що представляють для нього небезпека. Вони функціонують автоматично, не домовляючись зі свідомістю».

Висновки. Таким чином, серед дослідників немає єдиної точки зору ні на загальну кількість механізмів захистів, ні на ступінь їхньої співвіднесеності один з одним, ні навіть на їхні ясні визначення в деяких випадках. Це ускладнює виявлення інваріантних характеристик захисту і її ролей у соціально-психічній адаптації індивіда. Немає необхідності докладно викладати історію питання, неодноразово описану в багатьох публікаціях. Досить виділити ключові моменти в історії розвитку й наукової ревізії поглядів на цей феномен для того, щоб на цій основі намітити основні контури для розробки системної концепції захисту.

Література.

1. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.
2. Шебанова В. І, Шебанова С. Г. Механізми психологічного захисту та копіngu (совладання) особистості: навчально-методичний посібник. Херсон : ХДУ, 2012. 224 с.
3. Шебанова В. І., Діденко Г. О. Копінг-поведінка у сучасних психологічних дослідженнях. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 39. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 368-380.

2.5. Агресивність в аспекті підліткового віку

Єзерська Н. В., Рябоконь В. В.

Актуальність. Підлітковий вік – це період пошуку ідентичності та вибору пріоритетів у подальшому житті людини. Цей життєвий період найбільше привертає увагу науковців, оскільки спостерігаються у поведінці підлітків такі поведінкові прояви, як: підвищена тривожність, нестійкість та бурхливість емоцій, агресивність, жорстокість, булінг, що все частіше набувають стійкого характеру у дитячих колективах. Агресивна поведінка підлітків є реакцією на перешкоди, загрози, виклики, проблеми. За відсутності навичок реагувати психоемоційну сферу, агресивна поведінка може стати одним із механізмів вирішення життєвих труднощів. Саме у час змін виникає потреба у аналізі наукових, практичних підходах до навчання та виховання майбутнього покоління.

Мета. Проаналізувати трактування понять «агресія», «агресивність» з методологічної точки зору.

Результати досліджень. Поняття «підлітковий вік» означає надзвичайно неоднорідну соціально-демографічну категорію. Серед науковців існує велика розбіжність у розумінні поняття «підлітковий вік». Більшість із них відзначає, що це вік від 10 до 25 років, і тому «підлітковий вік», як правило, ділиться на під-етапи. Теоретики і клініцисти історично відрізнялися в хронологічному визначенні цих під-етапів. Л. Найнштайн [5] та ін., часто консультуючись із позицією клініцистів, визначає ранній юнацький вік приблизно від 10 до 13 років, середню юність приблизно від 14 до 16 років і пізній юнацький вік приблизно від 17 до 21 року.

Л. Штайнберг [6] раніше вказував, що рання підліткова підгрупа це (від 10 до 13 років), середня (від 14 до 18 років) і пізня (від 19 до 22 років), однак у недавніх публікаціях (2014 та 2017р.) до пізньої підгрупи входить вік до 25 років.

Д. Елліотт і С. Фельдман [7] описали ранній підлітковий вік від 10 до 14 років, середній юнацький вік становить від 15 до 17 років, а пізній юнацький вік – 18 років, до середини 20-х років.

Цікавий науковий підхід представлено у роботі Ж. Арнетт [8], який запропонував вилучити вік від 18 до 25 років із визначення «підлітковий вік» на користь нової окремої фази людського розвитку – «початковий розвиток дорослого населення». Інші науковці, які досліджують людей до моменту 20-річчя, використовують поняття «юність», «twixters» і «adultescents». Молодість характеризується тим, що її громадяни належать до іншого статусу за їх віком, статтю та соціально-економічним становищем. Соціологічні проблеми «підліткового віку» стосуються засобів присвоєння цього статусу, уявлень, на які вони посилаються, поведінки, яка викликає у зацікавлених сторін та їх окремих головних дійових осіб (дорослих) або колективних (соціальних, економічних інституцій та політики). Отже, підлітковий вік – це період швидкого когнітивного розвитку.

Один із засновників психології, швейцарський психолог Ж. Піаже [12] описав підлітковий вік як період життя, в якому думка індивіда починає приймати більш абстрактну форму і той період коли егоцентричність думки зменшуються. Це дозволяє людині думати і міркувати в більш ширшій перспективі, із огляду на своє майбутнє. Протягом чотирьох-п'яти років цього етапу дитина стає все більше і більш кваліфікованою в обробці своїх розумових операцій. Як зазначають Ж. Піаже та С. Інґелдер, «логічна форма суджень і міркувань у підлітку організована вже у більш-менш нерозривному зв'язку із їх змістом, тобто розумові операції вважаються вірними, а не простими уявленнями про світ».

З настанням статевої зрілості, фізіологічні зміни, такі як статеве дозрівання, збільшення зросту, викликають когнітивні, емоційні та соціальні зміни у житті підлітка. Підлітки розвивають здатність мислити абстрактно, більше використовують свій розум, висловлюються більш ефективно та науково. Вони розвивають моральне судження, відносини із однолітками, має велике значення все, що супроводжує підвищену незалежність від батьків.

У порівнянні із дітьми, підлітки частіше ставлять під сумнів твердження інших людей, і менш схильні приймати факти як абсолютні істини. Завдяки своєму досвіду за межами сімейного кола вони дізнаються, що правила, які здавалися їм абсолютними, насправді відносні. Вони починають розрізняти норми, встановлені здоровим глуздом (наприклад, щоб уникнути смертельної небезпеки), а також ті, що базуються на культурних нормах (етикет), це та відмінність, яку не роблять маленькі діти.

Наукові дослідження часто зосереджується на підлітковому романтичному житті через їх ризики. Проте деякі дослідники зосереджують увагу на соціальному аспекті та застережені у тих явищах, що виникають у підліткових відносинах. Дійсно, для підлітків поширені романтичні стосунки: вони цілуються, тримаються за руки, відчувають себе у любові, вважають себе парами і представляють себе у спілкуванні із своїм другом по відношенню до свого соціального середовища.

Ще однією психологічною особливістю поведінки, є те, що підліток раптово хоче припинити своє дитинство порівнюючи зі своїм бажанням, своїми ідеалами, моделями ідентифікації та інтересами, що виходять із дитинства. Підліток шукає нові джерела інтересу та задоволення. Йому також важливо відійти від своїх батьків, навіть якщо це символічна відстань. Отож, основні психологічні особливості, які спостерігаються у підлітковому віці: інтелектуальний розвиток; емоційна вразливість; розвиток волі; розуміння соціального середовища; зміна об'єкта кохання; заклик до ідеалу (високі стремління); період ідентифікації себе в суспільстві; конфлікти; відчуття приналежності; автономність.

Однією з основних функцій психічної діяльності є адаптація до нових ситуації. Це форма інтелекту, що гарантує гарне навчання, накопичення, абстракцію та запам'ятовування знань.

Дійсно, керуючись формальною логікою можемо вивести декілька висновків та припущень, без звернення до фактичного спостереження. Доступ підлітка до знань, надає йому змогу транспозиціювати логічні операції переходячи від конкретних маніпулювань, до змістовних ідей.

Психічна діяльність у підлітковому віці все ще відрізняється від психічної активності дорослого, даючи зрозуміти всі аспекти його досвіду, збагачується контактами із новими групами та соціальними інституціями. Розвивається поняття про дружбу, мораль, релігію, справедливість, естетику та любов. Звичайно, не всі підлітки створюють оригінальні теорії. Багато підлітків приймає без опору встановлені вірування [3]. Ж. Еліот [7] вважає, що конфлікт є невід'ємною частиною життя. На думку психоаналітиків, підлітки зазнають афективного життя, їх адаптація вимагає мобілізації всіх психологічних захисних сил для інтеграції емоційних спалахів та імпульсів у життя.

Психологічні механізми захисту все ще є дуже рудиментарними, або архаїчними, і показують регресивну поведінку, яка проявляються від надлишкових моделей у поведінці, таких як булімія, анорексія, агресивність, поширення невротичних або психотичних станів. З моменту народження людина відчуває емоції: гнів, радість, відразу, смуток, сором і т. д. Основні фактори, що викликають емоції, виникають в ході певних ситуацій.

Однією із головних характеристик підліткового віку є конфронтація стосовно нових подій. С. Холл стверджував, що зміна соціального розвитку була пов'язана із трансформацією людського суспільства впродовж десятиліть після війни. На відміну від попередніх вчених, які визначали, що підлітковий етап починається у віці 10 років, С. Холл вважав, що підлітковий вік охоплює вік 14-24 роки [6]. Зрештою, С. Холл вважав стадію підліткового віку просто зміною людського досвіду [6].

Цей етап життя тепер загально прийнято вважати невід'ємною частиною людського стану, але, і віковий діапазон, який вписується в цю нову стадію розвитку, весь час змінюється. Розглянемо соціальні процеси та особливості підліткового віку. «Підлітковий вік по суті є часом стресу».

Протягом того часу, коли С. Холл [6] запропонував визначати вік підлітків, який збігається із сучасними поглядами на формування зрілого віку, закони про дітей забороняли дітям у віці до 16 років працювати. Закони про освіту були також сформовані із метою збереження дітей у середніх школах [7]. Деякі характеристики, які визначали підлітковий вік для С. Холла, включали підвищений рівень уваги, ризиковану поведінку та сильну залежність від дружби [6]. С. Холл запропонував, що перегляд медіа контенту та читання детективних романів сприяють небезпечній поведінці, яка включає збільшення злочинної активності та ризикованої поведінки щодо сексу та вживання алкоголю [6]. Автор також торкався різних біологічних змін, які розвивались у підлітковому віці, в основному це стосуються статевого дозрівання [6]. Фізичний ріст і розвиток відбувається протягом певного періоду часу, дівчата та хлопці відрізняються темпами зростання [8]. Поодиноким зазначався факт батьківства, що могло починатися з 13-14-річного віку [7].

Дослідники визначили інші компоненти, які також відіграють роль у формуванні ідентичності, такі як ідентифікація за статтю,

етнічною групою. Нові пізнавальні здібності, досягнуті під час підліткового віку, також можуть призвести до нових почуттів егоцентризму, в якому підлітки вважають, що можуть робити що завгодно і що вони знають краще, ніж будь-хто інший, включаючи їх батьків [3]. Підлітки, дуже самосвідомі, вони часто створюють уявну аудиторію, в якій відчують, що всі постійно стежать за ними [2]. Оскільки підлітки так багато думають про себе, вони помилково вважають, що треба думати і про них.

У підлітковому віці спостерігається великий ступінь психологічного зростання, оскільки діти роблять корективи у своїй особистості через швидкий фізичний та сексуальний розвиток, який характерний для цього періоду життя. Не лише фізіологічні зміни спостерігаються даному періоді, досить часто спостерігається перерформатування взаємин у соціальному середовищі: часто виникають конфлікти, «спалахи» емоцій. Такі неконтрольовані прояви поведінки називають «агресією», або «агресивністю».

Поняття «агресія» й «агресивність» походять від латинського слова «aggressio», що означає «напад», та не є тотожними. Терміни «агресія», «агресивність» мають різні значення. Почасту, поняття «агресія» визначається як фізична або словесна поведінка людини, яка спрямована на заподіяння шкоди суб'єктам чи об'єктам дійсності; агресивність трактується як якість особистості, яка проявляється у ставленні до соціального середовища. С. В. Шевченко вказує, що «Агресія – це індивідуальна чи колективна поведінка чи дія, направлена на нанесення фізичної або психічної шкоди чи знищення іншої людини/групи; це будь-яка форма поведінки, націленої на образу чи завдання шкоди іншій живій істоті, що не бажає подібного звернення» [12, с. 180].

У психологічній літературі дослідження поняття «агресія» представлена двома основними групами: агресія як психічна властивість людини (риса індивіда) – трактується як агресивність особистості (А. Адлер, К. Лоренц, Д. Річардсон, З. Фрейд, А. Фрейд та ін.); агресія – як форма поведінки (А. Басс, Л. Берковіц, Дж. Доллард, Н. Міллер та ін.). Представники біхевіоризму (John B. Watson, Edward L. Thorndike, Edward C. Tolman) агресію визначають, як засвоєна за певних умов поведінка людини у процесі первинної соціалізації (теорія соціального научіння). Представники поведінкового підходу висловлюють думку про те, що агресив-

ність особистості є результатом соціалізації, та є формою регулювання емоційних та поведінкових імпульсивних дій.

Р. Плутчик [10], досліджуючи емоції (вісім основних емоцій: радість, довіра, страх, здивування, смуток, очікування, гнів і відраз.), вважав, що агресія у процесі адаптації людини до соціального середовища може бути як механізм захисту та виступати у формі адаптивних реакцій: відкидання, реінтеграцію, орієнтацію, дослідження, інкорпорацію, протекцію, руйнування, відтворення. Також Р. Плутчик встановив, що механізми психологічного захисту характеризуються біполярними та полярними емоціями. У теорії соціального научіння підкреслено, що агресія розглядається як поведінка, засвоєна у процесі соціалізації. Тобто, агресивна поведінка може проявлятися за умов: 1) наявності факторів, що провокують появу агресії; 2) попередній досвід отримання агресивної поведінки; 3) умови, при яких такий вид поведінки закріплюється.

Представники біхевіорального підходу також розглядали агресивну поведінку не як еволюційний процес, а як ситуативну реакцію людини на непереборні бар'єри, які стоять на шляху до досягнення мети, та викликають розгубленість чи фрустрацію. Д. Доллард [6] став автором теорії, основним припущенням якої є: «агресія завжди є наслідком фрустрації». У свою чергу Леонард Берковіц у теорії «фрустрація-агресія» зробив припущення, що соціальне оточення впливає на прояв агресивності людини, що проявляється в діях чи поведінці [5]. Психологами-науковцями та практиками проблема агресивності та агресивної поведінки підлітків потребує вивчення та обґрунтувань. Дослідження проблеми агресивності зосереджені, здебільшого, на особистості підліткового віку, на періоді активної соціалізації людини. Індивідуально-психологічними причинами агресивності у підлітковому віці можуть бути: невміння висловлювати негативні емоції, та їх контролювати; невпевненість, низька, занижена самооцінка; відчуття тривожності та знедоленої людини; прояв внутрішнього дискомфорту; прагнення привернути увагу; недостатність особистого досвіду у вирішенні актуальних питань чи проблем.

Висновки. Таким чином, агресія у підлітковому віці характеризується психоемоційними та поведінковими проявами, що викликають як адаптаційна, захисна реакція на виникнення бар'єрів, що виникають на шляху до досягнення бажаного та реалізації потреб.

Людина може проявляти агресію за певних індивідуально-психологічних особливостей та соціальних умов, які були засвоєні у процесі навчання, або за відсутності інших способів поведінки.

Література.

1. Власова О. І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, психологічні чинники розвитку: монографія. Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2005. 308 с.
2. Єзерська Н. В. Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя підлітків в умовах спеціалізованої школи-інтернату :дис. ... к. психол. наук: 19. 00. 07 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. 247 с.
3. Єзерська Н. В. Психологічні особливості розвитку особистості підліткового віку. Молодий вчений. Серія: Психологічні науки. 2015. №7(22). Ч. 2. X. : Вид. Дім Гельветика, 2015. С. 108.
4. Шмаргун В. М. Вікові та індивідуальні психосоматичні особливості дітей як предиктори розумового розвитку (молодший шкільний і підлітковий вік): дис. ... доктора психол. наук: 19. 00. 07 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2010. 416 с.
5. Berkowitz L. Aggression: Its causes, consequences, and control. New York, McGraw-Hill, 1993. 485 p.
6. Dollard J., Miller N. E. Personality and psychotherapy. New York : McGraw-Hill, 1950. 179 p.
7. Elliott G. R. Capturing the adolescent experience / G. R. Elliott, S. S. Feldman; In S. S. Feldman & G. R. Elliot (Eds.). 1990.
8. Elliott G. R. At the threshold: The developing adolescent / G. R. Elliott, S. S. Feldman. Cambridge: Harvard University Press. 2010. P. 1–13.
9. Lahey B. B. Advances in Clinical Child Psychology [Electronic resource] / B. B. Lahey, A. E. Kazdin. 2017. Vol. 14. P. 29–30. Mode of access: <https://books.google.com.ua/books?id=dHXgBwAAQBAJ&lpq=PA30&dq=hall%201904&hl=uk&pg=PA30#v=onepage&q=hall%201904&f=false>. – Title from the screen.
10. Plutchik's Wheel of Emotions. URL : https://www.researchgate.net/publication/333489781_Summarizing_Emotions_from_Text_Using_Plutchik's_Wheel_of_Emotions
11. Steinberg L. Adolescent development / L. Steinberg, A. S. Morris // Annual Review of Psychology. 2001. No. 52. P. 83–110.
12. Shevchenko S. V. Psykholohichni osoblyvosti vynyknennia ahresii osobystosti. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. 2018. №5. s. 180-183.
13. Steinberg L. Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence / L. Steinberg. 2014.

2.6. Формування резильєнтності здобувачів вищої освіти в умовах війни

Житинська М. О.

Актуальність. Реалії сьогодення, пов'язані з війною в Україні, породжують нові виклики та диктують нові умови життя. Адаптація людини до стресової, екстремальної ситуації, вміння долати негативні наслідки, що ними провокуються, та залишатися при цьому психологічно стабільною, вимагають наявності відповідних ресурсів. Кожна людина справляється з викликами по-різному, що включає різну емоційну реакцію, сприйняття ситуації, а також поведінку, оскільки це залежить від індивідуальної психологічної стійкості або резильєнтності особистості. Резильєнтність – це сила, яка допомагає витримувати певні випробування, стресові ситуації, це вміння проходити ці випробування, що формується життєвим досвідом, тим як людина з ним взаємодіє, як вивчає досвід інших людей, переносить його, застосовує в житті. Сьогодні Україна переживає складні випробування, українці отримують важкий досвід, який сприймається як виклик, з яким складно впоратись. Молодь, зокрема студентство, наразі є особливо вразливою категорією населення, яке, попри все, має продовжувати навчатись у надскладних умовах і відповідно потребує знань та навичок щодо резильєнтності.

Мета – визначити, проаналізувати складові резильєнтності здобувачів вищої освіти та розробити модель формування резильєнтності здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки в ЗВО.

Результати досліджень. Не дивлячись на актуальність проблеми формування резильєнтності у призмі сьогодення, в цілому ця тема не є новою. Серед широкого кола наукових зацікавлень, можемо виокремити вивчення резилієнсу, як опори в умовах невизначеності, що проявляється на різних рівнях організації: особистості, групи людей, спільнот, організацій, суспільства, нації в цілому.

Надаючи концептуальну характеристику поняттю «резильєнтність» варто зазначити, що дана проблема розкривається в досліді

дженнях різних галузей наук. Серед вітчизняних дослідників цієї проблематикою займаються: Е. Грішин, Г. Лазос, Т. Мельничук, О. Хамініч, Л. П'янківська, О. Коновалова та інші.

Збільшення кількості досліджень резильєнтності супроводжується переосмисленням його концепту, появою проблеми єдиного розуміння серед українських та зарубіжних дослідників. Поява розбіжностей у трактуванні поняття «резильєнтність» призвело до існування багатьох підходів до концептуалізації та термінологічної плутанини. Так, R. Neman визначає, резильєнтність – як здатність людини адаптуватися перед обличчям трагедії, травми, різних негараздів та до постійних життєвих стресорів [5]. В свою чергу, D. Hellerstein, наголошує про виокремлення двох складових резильєнтності: *фізичну* – яка є показником стресостійкості та *психологічну*, що стосується розвитку та підтримки соціальних контактів, підвищення освітнього рівня та опанування різними психологічними техніками та прийомами, що допомагають долати негативні наслідки стресу, пошук сенсів у важких подіях та ситуаціях [2]. Зарубіжні дослідники також виокремлюють *соціальну* резильєнтність, як здатність груп відновлюватись після важких ситуацій, об'єднуватись для спільного вирішення проблем, соціальну підтримку один одного [3].

Г. Ричардсон [7] акцентує, що резильєнтність можливо підсилити чи послабити зовнішніми ресурсами. Відтак, можемо говорити, що резильєнтність не є стабільною властивістю особистості, вона може змінюватись під впливом різного виду стресової ситуації, її перебігу, часу, перебувати в латентному стані та переходити до активної фази залежно від умов. Іншими словами резильєнтність може розвиватись протягом усього життя.

Розглядаючи резильєнтність в контексті подолання негативних наслідків впливу ризиків, допінг травматичного досвіду чи уникнення негативних траєкторій, що пов'язують з ризиком, доречно наголосити на трьох базових теоретичних моделях: модель компенсації, модель захисту та інокуляції.

Нам імponує модель розроблена Davydov et al [1] Model of «Three Resilience System mechanism», в якій представлена 3-компонентна система психічного здоров'я через:

1) зменшення шкоди, обмеження негативного впливу (наприклад, реакції депресії, тривоги) негараздів або експозиції до травматичних подій;

2) захист проти негативних явищ в щоденному житті;

3) промоцію психічного здоров'я та збільшення здатності індивіда справлятися з потенційними загрозами. В цьому контексті можемо говорити про резильєнтність як певний імунітет до стресів та загроз.

Цікавим є погляд на резильєнтність з точки зору практико-орієнтованих моделей, зокрема КПТ-підхід. На думку Padesky, С. А., Mooney, К. А. [6] резильєнтність – це процес, можливість впоратись та адаптуватись в час труднощів, відновити позитивне функціонування, коли стресори стають надмірними. Автори КПТ – підходу пропонують опиратись на сильні сторони особистості, під час практичної роботи перетворюючи їх в стратегії поведінки.

Слід наголосити, що резильєнтність, це не просто здатність впоратись з кризовою ситуацією, відновитись, а й можливість стати кращим, здійснити якісний стрибок вперед. Підтвердження означеної думки знаходимо в працях науковців S. Lepore та T. Revenson, які вважають, що резильєнтність відіграє важливу роль у здатності та формуванні посттравматичного зростання особистості [3]. Нам імпонує думка Г. Лазос [10] про те, що залежно від предмету дослідження резильєнтність може розглядатись і як певна характеристика особистості, і як динамічний процес відновлення психіки після несприятливих подій.

Повертаючи увагу на студентську молодь, можемо констатувати, що формування резильєнтності здобувачів вищої освіти цілком можливе під час навчання в ЗВО. Саме навчальний заклад для молодшої людини є не лише середовищем формування професійних компетенцій, а й місцем розвитку особистісних якостей. Період навчання студента у закладі вищої освіти є важливим етапом його соціалізації, оскільки, саме в цей час, відбувається коригування життєвих цілей, поступове входження у самостійне, професійне життя.

Резильєнтність здобувачів вищої освіти при цьому визначається нами, як динамічний процес, що відображає здатність студента відновлювати адаптивне та ефективне функціонування та особистісно зростати після впливу на нього психотравмуючих факторів.

Здатність відновлювати ефективно та адаптивне функціонування студентської молоді залежить від багатьох факторів, серед яких зокрема Коновалова О. виокремлює: рівень задоволеності життям; реалістичність оцінювання навколишньої ситуації [9]. На думку багатьох науковців, що досліджують проблему резильєнтності студентської молоді (Е. Грішин, Л. П'янківська, О. Коновалова), ключовим для молоді людини є здатність самостійно вирішувати проблеми та визначати правильні шляхи розв'язку, аналізувати. Важливим є вплив формату навчання та спілкування на формування резильєнтності здобувачів вищої освіти. Переважно дистанційний формат освіти та комунікації, в якому студенти вже звикли перебувати, спровокував певні труднощі у поверненні до традиційних форм навчання, бар'єри у особистісному спілкуванні.

Для формування резильєнтності здобувачів вищої освіти важливим є когнітивна гнучкість, тобто гнучкість мислення та способів реагування на стресову ситуацію. Тут можна говорити про вміння планувати свою діяльність; ефективно вирішувати проблеми; вміння концентруватись на важливому; вміння виділяти позитивні моменти, відчувати позитивні емоції; вміння контролювати негативні емоції та боротися зі стресом. В контексті вищезазначеного, вкрай важливим є опанування комплексу навичок стресостійкості, які визначаються як «вміння благополуччя», їх тренування і свідоме використання у кризових життєвих ситуаціях. Базовими серед яких, на наше глибоке переконання, є: трекінг (відстеження та керування відчуттями), «посадка» («заземлення»), «використання ресурсів», «самопоміч». Важливим завданням перед закладом вищої освіти постає навчання студентів правильним копінг стратегіям когнітивної та поведінкової реакції на стресову подію.

При сприянні у формування резильєнтності у здобувачів вищої освіти, важливим є розуміння сутності поняття «зона резильєнтності». Ми маємо на увазі, наявну, але часто не усвідомлену сукупність навичок саморегуляції конкретної особистості, яка виступає основою і закладається ще в дитинстві. І тут важливими, на нашу думку, є лише два чинники, що впливають на розвиток резильєнтності людини з дитинства – це безумовна любов до дитини та встановлення та підтримка високих очікувань від дитини. Ми переконані в тому, що людина моделює стратегії власної поведінки,

базуючись на власних сильних сторонах та відчуваючи підтримку, яку вона має в оточенні.

Отже, базуючись на сучасних теоріях резильєнтності, аналізі поняття як концепту, виокремивши поняття «резильєнтність здобувачів вищої освіти» та дослідивши фактори, що впливають на її формування у студентської молоді, нами було виокремлено складові резильєнтності здобувачів вищої освіти:

- базова позитивна життєва позиція (емоційно-позитивний фон життя; позитивне мислення; самоставлення, оптимістична налаштованість; суб'єктивна задоволеність рівнем благополуччя);

- навички та якості, що дозволяють вирішувати проблеми (інтелект; когнітивна гнучкість; здатність знаходити варіанти; цілеспрямованість; креативність; наполегливість);

- соціальні зв'язки (почуття приналежності; замученість; соціальна компетенція; просоціальна поведінка; здатність підтримувати стосунки, кооперації; емпатійність; відчуття підтримки від оточення);

- самостійність, самоконтроль (здатність діяти незалежно; незалежність думок та поглядів; саморегуляція, самоконтроль; усвідомленість здатності контролювати результати своїх рішень; відповідальність);

- наявність прагнень та орієнтація на майбутнє, цінності та сенси (адекватні очікування; планування, спрямованість на діяльність; працездатність, успішність у навчанні; спрямованість на майбутнє) (див. рис. 1).

Заклад вищої освіти, готуючи майбутніх фахівців певної галузі, має створити умови для формування *soft skills*, тобто «м'яких навичок», які є важливим ресурсом професійної резильєнтності сучасного фахівця. Мова йде про такі уміння, які необхідні для продуктивної професійної діяльності, збереження і зміцнення професійного здоров'я, професійного зростання.

Палітра можливостей кожного навчального закладу щодо вибору форм та методів формування зазначених навичок досить широка: від включення в навчальний процес тренінгів до повної перебудови навчального процесу в бік проектного чи проблемного навчання.

Психологічний тренінг справляє конструктивний вплив на розвиток особистості за трьома напрямками: когнітивним (отримання

нової інформації); емоційним (інтерпретація отриманої інформації через особистісну значимість); поведінковим (зміна, розширення поведінкових реакцій за рахунок усвідомлення неефективності звичних способів поведінки) [11].



Рис. 1. Складові резильєнтності здобувачів вищої освіти

Результатом тренінгу є активізація інтелектуальних, комунікативних і вольових потенцій людини. Саме за допомогою тренінгу відбувається рефлексія минулого людини та моделювання майбутнього.

Можливим є використання різних методів тренінгових занять для формування резильєнтності здобувачів вищої освіти, серед яких:

1. Ігрові методи, як методи психологічного моделювання через ігрову імітацію реальних чи можливих подій;
2. Дискусійні методи для обміну думками, досвідом, обговорення проблемних питань та вироблення ефективних рішень;
3. Презентаційні методи для подання важливої інформації, посилення ефектів сприйняття;
4. Експериментальні методи для створення штучної ситуації з метою вироблення певних реакцій, формування умінь та навичок;
5. Психотехнічні методи, направлені на зміну емоційного стану особистості, формування комфортної атмосфери у роботі;
6. Методи зворотнього зв'язку та психодіагностики для виявлення адекватності тренінгового впливу [11].

Ми підтримуємо думку Коновалової О., Бикової С. [9] про необхідність впровадження в усі освітні професійні програми вивчення дисципліни «Психологія», запровадження практики фор-

мування навичок першої психологічної допомоги та самопомоги для усіх учасників освітнього процесу.

Формувати резильєнтність здобувачів вищої освіти можливо шляхом залучення їх в діяльність наукових гуртків та тренінгових центрів, що функціонують в навчальних закладах; організовуючи кураторські години з групами різних курсів; застосовуючи інтерактивні форми навчання та мотивуючи до самоосвіти через участь в проєктах відповідного спрямування. Слід звернути увагу на доведений факт, що арттерапевтичні засоби мають значний потенціал для розвитку резильєнтності, оскільки працюють з емоціями та почуттями людини, Я-концепцією (самоповагою, самооцінкою, самоцінністю).

Висновки. Отже, базуючись на проведеному аналізі існуючих моделей резильєнтності, окресливши поняття «резильєнтність здобувачів вищої освіти» та визначивши її складові, нами було розроблено модель формування резильєнтності здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки в ЗВО (рис. 2).

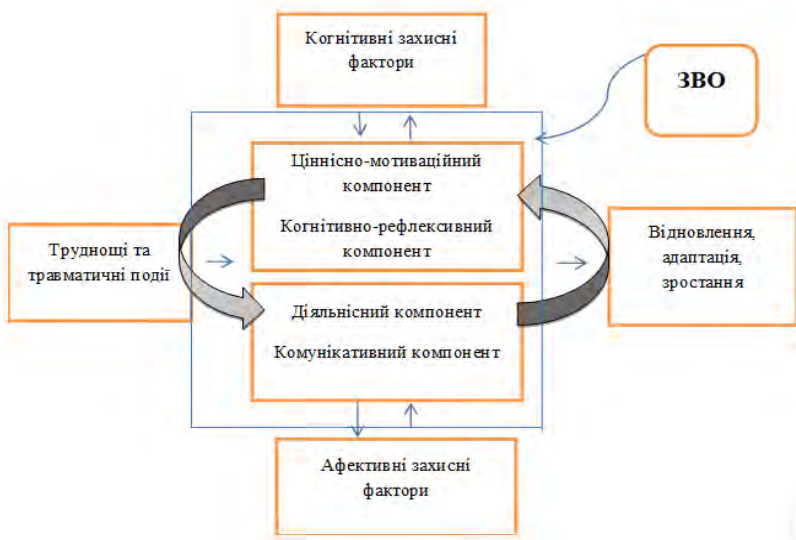


Рис. 2. Модель формування резильєнтності здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки в ЗВО

В умовах закладу вищої освіти формування резильєнтності здобувачів освіти може відбуватись за такими показниками: ціннісно-мотиваційний (ціннісне ставлення до життя, себе, до розвитку резильєнтності); когнітивно-рефлексивний (розуміння сутності резильєнтності, рефлексія власної резильєнтності); діяльнісний (формування навичок швидкого відновлення, вміння добирати оптимальні копінг-стратегії); комунікативний (саморегуляція, формування соціальної компетентності).

Ключові слова: здобувачі освіти, саморегуляція, формування резильєнтності, заклад вищої освіти, модель формування резильєнтності.

Література.

1. Davydov, D. M., Stewart, R., Ritchie, K., & Chaudieu, I. Resilience and mental health. *Clinical psychology review*. 2010, 30(5), 479-495.
2. Hellerstein D. How I can become resilient // *Heal Your Brain*. Електронний ресурс. – <http://www.psychologytoday.com/blog/heal-your-brain>
3. Kwok, A. H., Doyle, E. E. H., Becker, J., Johnston, D., & Paton, D. What is 'social resilience'? Perspectives of disaster researchers, emergency management practitioners, and policymakers in New Zealand. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. 2016, 19, 197-211. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.08.013>
4. Lepore S. J., Revenson T. A. Resilience and posttraumatic growth: Recovery, resistance, and reconfiguration // In L. G. Calhoun, & R. G. Tedeschi (Eds.), *Handbook of posttraumatic growth, research and practice*. – Mahwah, NJ: Routledge, 2006. pp. 24-46.
5. Neman R. APA's resilience initiative. // *Professional psychology : research and practice*. 2005. № 36. – p. 227.
6. Padesky, C. A., & Mooney, K. A. Strengths-based cognitive-behavioural therapy: A four-step model to build resilience. *Clinical psychology & psychotherapy*. 2012. 19(4), 283-290.
7. Richardson G. The metatheory of resilience and resiliency / Glenn E. Richardson // *Journal of clinical Psychology*. 2002. Vol. 58 (3). pp. 307-321.
8. Асонов Д., & Хаустова, О. Розвиток концепції резилієнсу в науковій літературі протягом останніх років. *Psychosomatic Medicine And General Practice*. 2019. 4(4),
9. Коновалова, О. В., Бикова, С. В. Формування резильєнтності у студентської молоді. *Науковий вісник Ужгородського національного універ-*

ситету. 2023, Серія: Психологія, (3), 13-17. <https://doi.org/10.32782/psyvisnyk/2023.3.2>

10. Лазос Г. П. Резильєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень. Актуальні проблеми психології. Том 3. : Консультативна психологія і психотерапія, 2018. Вип. 14, С. 26-64

11. Савченко Г. В. Навчально-методичний посібник з організації та проведення тренінгу: «Професійно-психологічна підготовка суддів». 2016. 104 с.

12. Хамініч О. М. Богучарова О. І. Психологічна резильєнтність у контексті переживання стресу лиха як особистісна здібність. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2015. № 2(37). С. 171–179.

2.7. Теоретичний аналіз поняття «девіація» у підлітковому віці

Канафоцька Л. М.

Актуальність. проблема девіації у підлітковому віці є актуальною в сучасному життєвому вимірі. Девіантна поведінка, як правило, закладається в підлітковому віці, адже протягом цього періоду відбувається своєрідний перехід від дитинства до дорослості, від незрілості до зрілості, який пронизує всі сторони розвитку підлітка [3, С. 52]. Вплив девіантної поведінки підлітків поширюється і на соціальне середовище, в якому вони перебувають. Діяльність і поведінка особистості детермінується, тобто обумовлюється, обмежується не лише внутрішнім механізмом мотивації, взаємодії потреб, інтересів, цінностей особистості. Зовні на поведінку людини впливають існуючі у суспільстві норми. За характером соціальна поведінка може бути різноманітною: альтруїстичною або егоїстичною, законотримною або протизаконною, серйозною або легковажною, коректною або грубою і т. д. Унаслідок дії різних факторів духовного, економічного, політичного характеру в суспільстві є люди з девіантною поведінкою. Девіантна поведінка – поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві ціннісно-нормативних стандартів. Ще наприкінці XIX і початку XX століття були поширені біологічні і психологічні трактування причин девіації. Італійський лікар Цезаре Ломброзо вважав, що існує прямий зв'язок між злочинною поведінкою і біологічними особливостями людини. Особливе значення він надавав рисам обличчя. Американський лікар і психолог Вільям Шелдон підкреслював важливість будови тіла. Прихильники психологічного трактування пов'язували девіацію з психологічними рисами (нестійкістю психіки, порушенням психологічної рівноваги і т. п.). Розгорнуте соціологічне пояснення девіації вперше дав Б. Дюркгейм. Він пропонує теорію аномії, яка розкриває значення соціальних і культурних факторів. За Б. Дюркгеймом, основною причиною девіацій є ано-

мія, буквально: «відсутність регуляції», «безнормність». По суті аномія – це стан дезорганізації суспільства, коли цінності, норми, соціальні зв'язки або відсутні, або стають хиткими і суперечливими. Тобто, усе, що порушує стабільність, призводить до неоднорідності, нестійкості соціальних зв'язків, руйнування колективної свідомості (криза, змішання соціальних груп, міграція і т. п.), породжує порушення суспільного порядку, дезорганізує людей, і в результаті з'являються різні види девіацій.

Мета. Розглянути теоретичні підходи у науковій літературі до розуміння поняття «девіація» у підлітків.

Результати дослідження. Поняття «девіації» у соціологічну систему ввів французький соціолог Еміль Дюркгейм, вивчаючи такий вид девіантної поведінки, як самогубство. Проявами цього типу поведінки є правопорушення, злочини, наркоманія, проституція, алкоголізм тощо.

Питання девіантної поведінки дітей та підлітків вивчалися багатьма вченими у галузі юридичної психології та педагогіки: В. І. Барко, О. В. Змановською, М. В. Кікалішвілі, В. І. Кривуша, Н. Ю. Максимова, Л. І. Мороз, В. М. Оржеховська, А. І. Папкін, В. М. Синьов, С. І. Яковенко, В. О. Тюріна та інші.

Автор навчального посібника з девіантології О. В. Змановська визначає девіантну поведінку «... як стійку поведінку особистості, що відхиляється від найбільш важливих соціальних норм, спричиняє реальну шкоду суспільству або самій особі, а також супроводжується її соціальною дезадаптацією».

Досліджуючи психологічні механізми виникнення і профілактики девіантної поведінки та професійної деформації працівників органів внутрішніх справ, В. І. Барко визначає девіантну поведінку як систему вчинків (або окремі вчинки), що суперечать прийнятим у суспільстві нормам і проявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді ухилення від морального і естетичного контролю над поведінкою [1, с. 122]. Слід погодитись з уточненням В. О. Тюріної, що термін «девіантна поведінка» використовується у двох основних значеннях: як у значенні вчинку, що не відповідає встановленим у суспільстві нормам, так і у значенні соціального явища, яке проявляється у відносно масових та стійких

формах людської діяльності, що не відповідають нормам та очікуванням, що склалися у суспільстві [4, с. 123-126].

Інтерес до питань вивчення девіантної поведінки українськими вченими підсилюється статистикою злочинів в Україні, вчинених неповнолітніми. Так, за статистичними даними Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України можна прослідкувати динаміку кількості злочинів, вчинених неповнолітніми, або за їх участі на території України. На рис. 1 представлено динаміку за період 2001-2019 років.

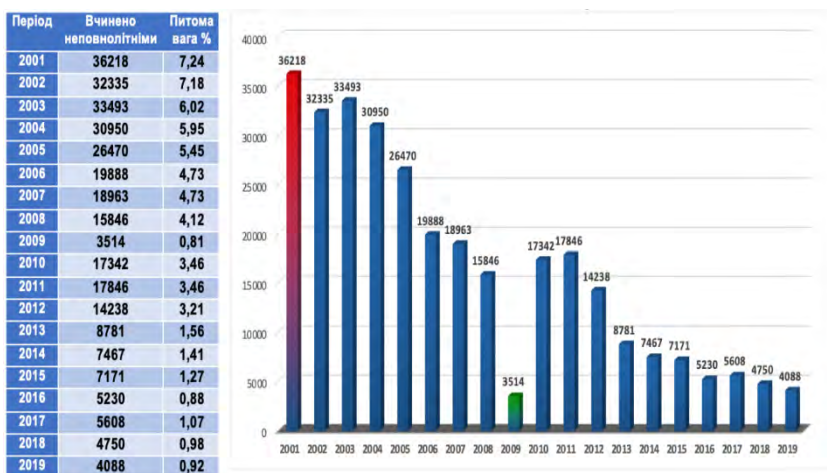


Рис. 1. Кількість злочинів, вчинених в Україні неповнолітніми, або за їх участі (2001-2019 рр.)

Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 по 2012 рік за даними листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 від 09. 08. 2019 року, а також статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 по 2019 рік за даними «Єдиного звіту про кримінальні правопорушення [8].

У нашому дослідженні також проаналізовано інформацію про кількість засуджених в Україні неповнолітніх у період з 2001 по 2019 роки наведена (рис. 2).

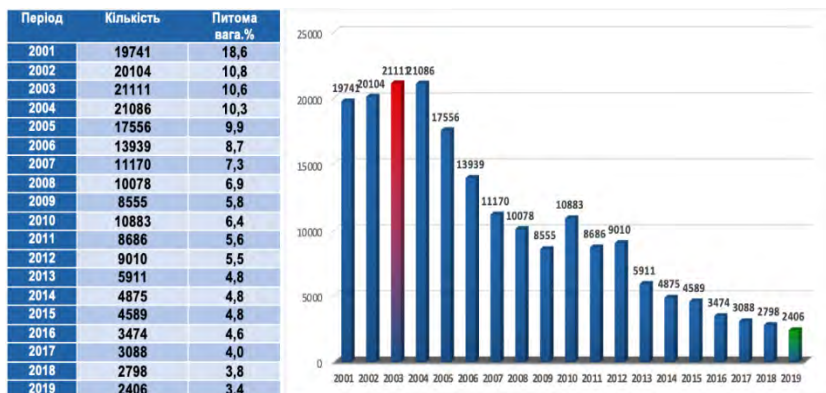


Рис. 2. Кількість засуджених в Україні неповнолітніх (2001-2019 рр.)

До рисунку 2 надамо додаткові роз'яснення. Кількість осіб вказано за судових рішень, щодо яких набрали законної сили у звітному періоді. Питома вага – від числа всіх засуджених осіб у % (відсотках). Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі форм статистичної звітності № 8 «Звіт про неповнолітніх засуджених» (річний) ДСА України. Дані наведено згідно дослідження М. В. В'юника «Інфографіка застосування Кримінального кодексу України: за даними 2001-2019 років» [6]. За звітом 2019 року Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), укладеного за результатами міжнародного опитування, яке проводять в Україні раз на чотири роки (проект «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» (ESPAD)), українські підлітки стали менше курити, проте дедалі частіше вживають алкоголь і мають більший доступ до наркотиків, ніж у попередні чотири роки. А ще збільшується їхня залежність від соцмереж. За даними вищезначеного опитування 50,0 % українських підлітків мають досвід куріння, 86 % вживали алкоголь, а 18,0 % пробували наркотики [7].

За результатами звіту Харківського інституту соціальних досліджень «Аналіз системи правосуддя щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, в Україні» Проекту Ради Європи «Захист прав дітей під час війни і в післявоєнний період в Україні» можна прослідкувати статистику злочинів, скоєних дітьми з по-

чатку 2022 року, в якій спостерігається загальна тенденція щодо помітного зменшення злочинності серед неповнолітніх. Статистика злочинів, вчинених неповнолітніми, за 10 місяців 2022 року становить менше 2000 справ, що майже вдвічі менше, ніж у попередні роки. На рекордне зниження дитячої злочинності вплинуло багато факторів: виїзд майже 25 % дитячого населення за кордон, фактичний параліч діяльності ювенальної поліції через активні бойові дії та концентрація її роботи лише на військових злочинах. Усе це засвідчує зменшення навантаження на систему органів кримінальної юстиції щодо дітей, що відкриває вікно можливостей для реформування цієї сфери та запровадження повноцінної системи правосуддя, дружнього до дитини [5, с. 5].

Висновок. Характер статистичних та теоретичних досліджень дозволяє не лише ознайомитися з наявною базою існуючих наукових досліджень та підходів до визначення характерних психологічних особливостей підлітків з девіантною поведінкою, а також з її типологією та теоріями девіації, що можна використовувати у психології, соціології, педагогіці як практичну складову по виявленню девіантної поведінки у підлітків, а й з'ясувати, чи є девіантна поведінка виключно негативним феноменом, або навпаки, може розглядатися в якості позитивного суспільного та психологічного явища. Виходячи з вищенаведених позицій, в науці превалує саме перший погляд на сутність поведінки, що відхиляється. Тобто, найчастіше під девіацією розуміється лише негативне відхилення від наявних у суспільстві норм. Особливо це проявляється у кримінологічній та інших юридичних науках, які традиційно розглядають девіантну поведінку в контексті порушення правових норм та інших правил поведінки. У той же час, слід розуміти, що девіантна поведінка як соціальне явище має певні історичні корені. Різноманітність соціальних норм, що діють в суспільстві – правових, релігійних, естетичних, політичних та інших – тягне за собою і різноманітність девіацій. Як соціальні норми і правила, так і соціальні відхилення зазнають змін: те, що раніше вважалося девіантною поведінкою, може перетворитися на норму поведінки, і навпаки. Виникнення нових законів і правил тягне за собою формування і нових видів девіацій. У зв'язку з цим, соціальна оцінка відхилень повинна здійснюватись беручи до уваги історичний аспект і носи-

ти конкретний характер [2, с. 109-122]. Більш того, відхилення від норм має не тільки негативне, але і позитивне значення. Девіація підтверджує роль норм, цінностей, дає більш повне уявлення про різноманіття норм. Реакція суспільства, соціальних груп на девіантну поведінку уточнює межі соціальних норм, зміцнює і забезпечує соціальну єдність. І, нарешті, девіація сприяє соціальній зміні, розкриває альтернативу існуючому, веде до удосконалювання соціальних норм.

Література.

1. Барко В. І., Лапчук В. С. Психологічні підходи до профілактики девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ. Юридичний бюлетень. 2015. Вип. 1. С. 120–128.
2. Бринза І. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 9. С. 43–49.
3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Київ : Центр учб. літератури, 2012. 424 с.
4. Тюріна В. О. Девіантна поведінка курсантів і студентів як наслідок їх соціальної і професійної адаптації. Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук. -практ. конф. (м. Харків, 10 квітня 2015 р.). Х. : ХНУВС, 2015. С. 123–126.
5. Аналіз системи правосуддя щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, в Україні: звіт за результатами дослідження/ за заг. ред. О. Калашник; автор. -упоряд. : Бугаєць Т., Кобзін Д., Неткова Б., Пашко Н., Черноусов А., Щербань С. Київ, 2023. 107 с.
6. Кількість вчинених злочинів на території України (з 2001 по 2019 роки). URL:<https://newcriminalcode.org.ua/statistics>
7. Скільки п'ють і курять підлітки в Україні: дослідження. 10. 10. 2019.
8. URL:<https://www.bbc.com/ukrainian/features-49999874>
9. Статистична інформація. URL:<https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>

2.8. Особистісні особливості спортсменів в умовах стресу

Кардаш Р. І.

Актуальність. На етапі стрімкого розвитку здорового способу життя серед людей, які займаються спортивною діяльністю проблеми збереження працездатності та мотивації у разі недосягнення очікуваних результатів набувають особливої актуальності. Дослідження зосереджені на низькій результативності, яка пов'язана з надмірним психологічним навантаженням у спортивній діяльності та особливостях психічних станів, що виникають під час змагальної діяльності [23, 24]. Одним із найпоширеніших явищ нашого суспільства є стрес. У сучасному житті стрес відіграє важливу роль у житті кожної людини, впливаючи на її поведінку, здоров'я, працездатність людини залежно від стресових факторів, її стосунків з оточуючими [3, 4, 10].

Мета. Надати аналіз впливу індивідуально-психологічних особливостей людини на формування результатів у спортивній діяльності. Методи дослідження. Теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація теоретичних підходів та емпіричних результатів, які містяться у науково-дослідних та науково-методичних джерелах, присвячених досліджуваній проблемі.

Результати дослідження. Вивченням антистресової проблематики та стресових станів займаються такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як В. Я. Апчел, Я. Грінберг, Л. А. Китаєв-Смик, Б. В. Овчинников, Г. Сельє, Р. А. Тігранян та ін. Березкін, В. А. Чурсинов та ін. Термін «стрес», як показує аналіз літератури був введений у побут науки у 1936 році Г. Сельє [18] для відображення реакції організму на зовнішні фактори. Відповідно твердженню Г. Сельє, стрес – це низка адаптивних захисних реакцій організму людини, які викликають фізичну чи психічну травму. Як відображає Г. Сельє [18] у своїх дослідженнях, лише невелика кількість стресу корисна для людини, оскільки допомагає їй адаптуватися до навколишньої дійсності. Якщо особа перебуває у стані сильного стресу тривалий час, то відбувається перевантаження можливостей адаптації

організму і це може призвести до різноманітних «поломок» як на психічному, так і на фізіологічному рівнях [5, 17, 17, 26].

У стадії розвитку психології стрес розглядається як стан психічної напруги, який виникає, коли людина діє у дуже важких умовах і середовищах. Стрес, як нервово-психічне перенапруження, має відгук у надмірному шоці, на який попередньо організмом передбачена відповідна реакція. Стрес проявляється як тотальна, загальна мобілізація сил організму для пошуку виходу з дуже складних життєвих обставин [6, 12, 15]. Р. Лазарус [11] стверджував, що стрес це неспецифічна психофізіологічна реакція організму, що розвивається під впливом факторів, які називають стресорами. Вони викликають довільні зміни в організмі, такі як підвищення рівня цукру в крові, збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Така реакція підготовлює організм до напружених фізичних вправ.

Г. Сельє [18] виділив такі стадії розвитку стресу: тривога, резистентність, виснаження. Стадія тривоги включає стадію шоку та стадію контршоку. Фаза шоку характеризується пригніченням центральної нервової системи, а фаза шоків реакції – відновленням порушених психічних функцій. Загалом, на цьому етапі мобілізація та активація внутрішніх захисних ресурсів організму зазнає особливих труднощів, що призводить до стану напруги. На цій стадії людина почуватимуться нормально. Друга стадія резистентності або резилентності відноситься до виникнення стійкості до стресора. Однак, оскільки вони впливають на організм з часом, його сила виснажується. Тому при виснаженні енергетичних резервів людини та пригніченні механізмів фізичного та психологічного захисту настає третя стадія – «виснаження». Саме у фазі виснаження, порівняно з початковою фазою стресу, організм індивіда не в змозі захистити себе, і це веде до процесу патологічного стану організму. Стереотипні неспецифічні реакції, які супроводжують стрес і забезпечують пристосування до мінливих умов, виживання при перебудові та ліквідації наслідків перевантаження, Г. Сельє назвав «загальним адаптаційним синдромом». Також, як у побуті, так і в науковій літературі існує поняття стресостійкості, яке характеризує не стан стресу, а схильність людини до стресу. Стрес, який триває довгий час, або короткочасний стрес, що повторюється може спричинити зміни в загальній особистості людини, з появою

чи посиленням нових рис особистості, таких як низька самооцінка, самозвинувачення, замкнутість, недовіра та агресія.

Існують також випадки, коли стрес виникає симптоматично, або є інструментом адаптаційної перебудови особистості через надмірний вплив як фізичних, так і психологічних чинників [1-3, 5]. За ствердженням Ф. Б. Березіна [2] стресостійкість є інтегративною характеристикою людини, яка включає взаємодію емоційно-вольового, інтелектуального та мотиваційного компонентів психічної діяльності людини, і вказує на те, що оптимальне та успішне досягнення цілі діяльності гарантуються в емоційній ситуації.

Стресостійкість визначає успішність соціальних взаємодій індивіда і характеризується емоційною стабільністю, високим рівнем саморегуляції, низьким рівнем тривожності та високою психологічною чутливістю до стресу.

Аналіз літературних джерел показав, що стресостійкість може розвиватись спеціально [13, 14, 20, 21].

У психології існує кілька способів захистити себе від наслідків психологічної травми в стресових ситуаціях.

1) Раціоналізація поведінки, коли відбуваються негативні події. Для цього необхідний комплексний і детальний аналіз ситуації, що допоможе зменшити наслідки психологічної травми. Рівень невизначеності, попереднє налаштування, допомагає усунути раптові ефекти.

2) Зменшити травматичні наслідки стресу з особистісним значенням шляхом знецінення та зменшення важливості конкретних подій.

3) Максимальне усвідомлене збільшення потенційного негативного впливу майбутніх подій. Розвиток ставлення до найгіршого випадку.

Стрес – це сукупність адаптивних і захисних реакцій організму людини на травматичні фізичні чи психологічні впливи.

Якщо людина протягом тривалого часу піддається інтенсивному стресу, її адаптаційні можливості перевантажуються і в організмі виникають різні порушення.

Спектр проблем розвитку особистості спортсмена надзвичайно різноманітний. Насамперед, вивчаючи особистісно-психологічні чинники спортивної діяльності спортсменів, необхідно детально розглянути сутність і структуру особистості. Становлення особи-

стості досліджували такі дослідники, як Б. Г. Ананьєв, В. С. Мерлін, А. А. Деркач, Є. А. Клімов, Н. В. Кузьміна, Б. Ф. Ломов, В. Н. М'ясищев, К. К. Платонов, Ю. П. Поваренков, В. А. Пономаренко, С. Л. Рубінштейн, В. Д. Шадріков та іншими. Незважаючи на багаторічні дослідження природи і структури особистості, до сих пір немає єдиної інтерпретації цього поняття. У той же час на кожне визначення особистості, яке зустрічається в науковій літературі та підтверджене відповідними дослідженнями, варто звернути увагу на пошук найбільш повного визначення особистості. Так С. Л. Рубінштейн [17] розуміє особистість як сукупність внутрішніх умов, на яких відображається вся зовнішня поведінка. Ці внутрішні стани є сумішшю генетичних та біологічних характеристик та соціально детермінованих характеристик, що виникли під впливом попередніх соціальних впливів. До того ж, однакові зовнішні фактори можуть по-різному впливати на різних людей, оскільки їхні внутрішні обставини поглиблюються в міру розвитку їхньої особистості. Отже людина є не тільки об'єктом і продуктом соціальних відносин, а й активним суб'єктом діяльності, спілкування, свідомості і самосвідомості. На думку автора, особистість характеризується п'ятьма можливостями.

1) Пізнавальні або епістемологічні можливості. Це визначається кількістю та якістю інформації, якою володіє людина.

2) Значення або аксіоматичні можливості. Характеризується особистістю, набутою в процесі соціалізації через систему цінностей у моральній, політичній, релігійній, естетичній та інших сферах.

3) Творчий потенціал, який визначається навичками і вміннями, які були освоєні і самостійно розвинені, здатністю працювати і масштабом реалізації в будь-якій сфері.

4) Навички спілкування. Це залежить від ступеня і форми комунікабельності, типу та інтенсивності контакту.

5) Художні можливості. Характеризується рівнем, змістом та інтенсивністю творчих потреб.

Відповідно до сучасних психологічних словників, особистість – це особлива якість людини, яка набувається в соціокультурному середовищі в процесі спільної діяльності та спілкування.

Як показує теоретичний аналіз літературних джерел, особистісні якості спортсмена визначають успішну адаптацію до зма-

гань в різних видах спорту. Індивідуальна кваліфікація залежить від деталей змісту конкретного виду спорту, деталей змагальної діяльності, які існують в кожному виді спорту. У єдиноборствах важливі характеристики темпераменту спортсмена, такі як рухові навички і сила збудження нервових процесів, комунікативні навички, які сприяють оптимальній взаємодії спортсмена з тренером або асистентом. Ці властивості нервової системи допомагають адаптуватися до швидко мінливих динамічних ситуацій. Крім того, слід відповісти, що особистість характеризується певною цілісністю, яка визначається інтегрованою функцією мотивації, емоцій та волі. Мотиви і емоції спонукають спортсмена до демонстрації конкретних характеристик характеру, тоді як воля реалізує діяльність з допомогою даних характеристик характеру.

Стресові екстремальні ситуації виявляють бажання спортсмена досягти успіху або уникнути невдачі. Спортсмени, яким властива воля до успіху, часто ризикують у критичних ситуаціях спортивних змагань. Спортсмени, які прагнуть уникнути невдач, скоріше будуть діяти обережніше, ставити вищі цілі та обминати ризиковані дії. Як вважають багато вчених [6, 8, 23-25], психологічна структура спортивної діяльності виглядає таким чином:

- 1) Характеристика психічних функцій і властивостей особистості, пов'язаних із здійсненням спортивних процесів.

- 2) Особиста мотивація, що визначає бажання людини займатися певним видом спорту та досягати результатів у спортивних змаганнях.

- 3) соціально-психологічний характер взаємовідносин спортсменів та інших людей у спортивній діяльності;

Проведений аналіз літератури показав, що спорт має особливий вплив на розвиток психологічних особливостей особистості. Цей вплив визначається наступними характеристиками [7, 20]:

- 1) Змагальний характер спортивної боротьби, спрямований на встановлення рекордів або перемогу над суперниками.

- 2) Максимальне навантаження всіх фізичних і розумових можливостей спортсмена під час змагань, необхідне для досягнення запланованого результату.

- 3) Регулярні, тривалі, інтенсивні спортивні тренування. Це призводить до серйозних змін у тому, як ми живемо та працюємо.

І. П. Волков виділяє основні завдання та зміст психологічної підготовки спортсменів [6]:

1. Виховання дисциплінованості, організованості, уміння керувати власною поведінкою в складних змагальних умовах (контролювати ситуацію, оцінювати, приймати та реалізовувати відповідні рішення).

2. Розвиток і вдосконалення пізнавальних здібностей спортсменів (пам'ять, увага, спостережливість, стійкість і гнучкість мислення, розвиток творчої уяви).

3. Підвищення психологічної стійкості в подоланні негативних факторів спортивної діяльності (концентрації та уваги, розвиток витривалості та самоконтролю, удосконалення прийомів ідеомоторної підготовки до виконання вправ, підготовка до дії) здатність оцінювати момент, коли відбуваються події на місці).

4. Навчання самоконтролю при зовнішніх проявах емоційної напруги.

5. Вивчення техніки довільного розслаблення м'язів, регуляції дихання, переключення уваги та вербальної саморегуляції.

Аналіз літературних відомостей показав, що для спортсменів різних видів спорту характерні як загальні риси особистості, так і специфічні вимоги до психологічних особливостей особистості спортсмена.

І. П. Волков [6] наголошує, що кваліфіковані спортсмени характеризуються самодисципліною, вольовим регулюванням, ініціативністю, особливою увагою до лідерства і прагненням до активності для досягнення своїх цілей, незважаючи на труднощі і перешкоди. Вивчаючи психологічні особливості особистості борця Б. Д. Кретті зазначав, що борцям властиві впевненість в собі, соціальна маскуліність, сміливість, наполегливість і відсутність схильності до невротичних реакцій, тобто емоційна стійкість [9]. Отже, спортсмени різних видів спорту характеризуються як загальними, так і специфічними рисами особистості, які мають певні вимоги до психологічних характеристик особистості спортсмена. Кваліфіковані спортсмени, незважаючи на труднощі і перешкоди, характеризуються самодисципліною, високою вольовою регуляцією, ініціативою, лідерством і активністю у досягненні своїх цілей. На думку Ю. В. Щербатих [19, 20], усі стреси, пов'язані із занят-

тями спортом, можна поділити на групи з короточасним впливом на організм і групи з тривалою дією. До короткострокової групи входять:

1. Фактори стресу, які викликають занепокоєння, наприклад ті, що пов'язані з виконанням вправи, яка призвела до попередньої травми.
2. Фактори стресу, що неприємні фізіологічно: втома, біль, втома.
3. Фактори стресу, пов'язані з темпом і швидкістю – наприклад, невинновдано надмірні налаштування для записаних результатів.
4. Фактори стресу, що призводять до невдачі – невдалий старт, невправильна техніка руху тощо.

Друга група стресорів, пов'язаних з тривалим впливом на організм, це:

1. Стресори, пов'язані з ризиком і небезпекою (акробатика, батут, альпінізм, мотоспорт, хокей).
2. Фактори стресу, пов'язані з тривалим фізичним навантаженням (тривале фізичне навантаження на фоні фізичної та розумової втоми).
3. Фактори стресу, пов'язані з боротьбою (тривале змагання).
4. Фактори стресу, пов'язані з ізоляцією (відокремлення від дому та родини під час змагань) [20].

Стресори – фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що викликають стан напруги чи тривоги. На думку Ю. В. Щербатих, тривожність, пов'язана з тренувальним процесом, може визначатися надмірними тренувальними навантаженнями, травмами, недостатніми або завищеними очікуваннями майбутніх результатів вправ, тощо. Тривожність, яка викликана змаганнями, або обумовлена невдалими виступами чи, навпаки, вдалими виступами конкурентів, конфліктами з тренером чи судьями, надмірною напругою. Когнітивно-емоційні фактори відіграють важливу роль у першій групі причин тривоги, тоді як екстремальний фізичний та емоційна напруга відіграє важливу роль у другій групі. Крім того, на думку Б. А. В'яткіна [7], існує такі три форми змагального стресу, як передстартова лихоманка, стартова апатія та бойова готовність.

Перша форма спортивного стресу проявляється у непомірному перезбудженні нервової системи, збільшеному тонусі м'язів та утрудненнях у підтримці ясності тактичного мислення. При цьому

вегетативний баланс організму зрушений у бік переважання тону-су симпатичної нервової системи.

Друга форма змагального стресу спостерігається при тривалому очікуванні змагань та у спортивному лексиконі постає як «перегорання» спортсмена. Ця форма супроводжується ваготонією – переважанням тону-су парасимпатичної нервової системи та проявляється у спортсменів у вигляді зниженої мотивації та загальної слабкості. Третя форма є найбільш оптимальною формою змагального стресу і є своєрідною бойовою готовністю, що дає можливість досягти оптимальних спортивних результатів, і виступає варіантом еустресу [7]. На думку цього вченого, стан бойової готовності спортсмена можна порівняти з початковою стадією стресу по Г. Сельє, коли організм спортсмена наповнений енергією та силою, а про негативний вплив стресу на діяльність ще не може бути мови, сама ситуація сприймається як тривожна, але ні що не загрожує благополуччю індивіду.

На думку О. М. Блеєра [14], у спортсменів можливі прояви посттравматичних стресових розладів і вони визначаються визначаються низкою факторів. Об'єктивні: наявність самої травми, можливе спостереження травми в будь-якого іншого (особливо, якщо внутрішньо ця людина ідентифікувався у спортсмена, як зразок наслідування). Крім того, для людини з дитинства характерно кілька найпоширеніших ілюзій, у тому числі і ілюзія невразливості. У тому випадку, якщо спортсмен, не маючи на своєму рахунку кількох легких травм, стикається відразу з серйозною – ілюзія руйнується різко і може спричинити кризу особистості. Вчений також відносить до цієї групи соціальні об'єктивні чинники, такі як рівень підтримки спортсмена з боку товаришів по команді, тренера чи сім'ї.

Підтримка близьких знижує негативне значення події, що травмує, і є більш значущою, ніж оцінка і підтримка з боку засобів масової інформації.

Блеєр О. М. виділяє об'єктивні і суб'єктивні фактори виникнення посттравматичного стресового розладу у спортсменів: нестача знань, вмінь, навиків, пов'язаних з тим, як справлятися з наслідками травм, мотивації до спортивної діяльності і ставлення до власного здоров'я. Якщо спортсмен має яскраво виражену орієнтацію на суперництво, перемогу за всяку ціну (навіть за рахунок власно-

го здоров'я) ризик посттравматичних стресових розладів спортсменів посилюється, оскільки будь-яка невдача веде до фрустрації. Ставлення до спорту як до єдиного способу самореалізації робить людину більш вразливою, оскільки травми створюють перешкоди на шляху до заповітних цілей. Внутрішня мотивація робить спортсменів більш цілеспрямованими і, в той же час, більш стійкими до невдач, ніж зовнішня мотивація, часто пов'язана з матеріальними стимулами. О. М. Блеєр [14] вказує на індивідуально-психологічні особливості індивіду, як на різні суб'єктивні чинники для кожного окремого спортсмена: самооцінка, акцент на характері, ієрархія цінностей, вольові якості, біографічні характеристики, рівень суб'єктивного контролю траєкторії, наявність певних особистісних характеристик. Таким чином, індивідуальні особливості особистості спортсмена включаються в структуру його діяльності, оскільки внутрішні умови або внутрішні засоби прямо або побічно впливають на характеристики стресу, появу або відсутність посттравматичного стресового розладу у спортсмена і їх вплив на результативність.

Висновки. Узагальнюючи можна зазначити, що стрес є сукупністю адаптаційно-захисних реакцій організму людини на подразники, які викликають фізичну або психічну травму. Якщо людина опиняється в сильному стресовому стані, який триває тривалий час, то відбувається перевантаження його адаптаційних можливостей, що призводить до різних порушень роботи організму. Займаючись будь-яким видом спорту, спортсмени відчують величезне нервово-емоційне навантаження. До соціально-психологічних факторів стресу можна віднести такі особистісні властивості, як спрямованість, установки та мотиви діяльності, ціннісні орієнтації та особистісний сенс, а також тривале виконання вправ на фоні фізичної та психічної втоми, усвідомлення можливості отримати травму, яка може спричинити усунення від спортивної діяльності на тривалий термін чи навіть назавжди. Для спортсменів різних видів спорту характерні як загальні риси особистості, так і наявність специфічних вимоги до психологічних особливостей особистості спортсмена. Кваліфікованих спортсменів характеризує самодисципліна, висока вольова регуляція, ініціативність, прагнення до лідерства, активність у досягненні поставлених цілей, незважаючи на труднощі та перешкоди. Індивідуальні властивості особистості

спортсмена включені в структуру його діяльності як внутрішні умови або внутрішні засоби та прямо чи опосередковано впливають на характеристики стресу і його дію на результати діяльності. Як особистісні фактори стресу можна виділити: загальні властивості особистості, спеціальні властивості особистості, індивідуальний стиль змагальної діяльності.

Література.

1. Афанасьєва І. А. Неспецифічні показники імунного захисту під час стресу у спортсменів. Вчені записки університету імені П. Ф. Лісгафт., 2007. Вип. 4. С. 7 – 13.
2. Березін Ф. Б. Психічна та психофізіологічна адаптація людини. Л. : Наука. 2010. – 270 с.
3. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.
4. Бодров У. А. Проблема подолання стресу. Псих. жур. 2006. № 2. С. 113 – 123.
5. Іванцова Н. Б. Періодизація професійного розвитку особистості / Н. Б. Іванцова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць. – 2010. – Т. 8., Вип. 7. – С. 105-114.
6. Волков І. П. Практикум по спортивній психології. 2002. – 288 с.
7. Вяткін Б. А. Роль темпераменту у спортивній діяльності. М. : Фізкультура та спорт. 2010. – 134 с.
8. Загrevський В. О. Планування траєкторії керуючих рухів спортсменів у координатах зовнішнього простору. Теорія та прак. фізич. культ. – № 10. 2010. С. 56–61.
9. Кретті Б. Дж. Психологія у сучасному спорті. М: ФіС. 2011. – 224 с.
10. Клименко В. В. Психологія спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : МАУП, 2006. – 432 с.
11. Лазарус Р. Теорія стресу та психофізіологічні дослідження. Емоційний стрес. Л. : Леніздат. 2010. С. 178 – 208.
12. Левандо В. А. Спорт, стрес, імунітет. Вісник спортивної науки. 2010 року. № 3 (8). С. 33 – 40.
13. Немов Р. С. Загальні засади психології. М: Владос, 2010. – 687 с.
14. Основи психофізіології екстремальної діяльності: курс лекцій. За ред. А. Н. Блєєра. М. : Аніта Прес, 2006. – 380 с.
15. Титаренко Т. М., Лепіхова Л. А. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: Наук. метод. посіб. – К. : Міленіум, 2006. – 204 с.

16. Мей Р. Короткий виклад та синтез теорії тривожності. Тривога та тривожність: навчальний посібник. СПб. : Пітер, 2011. – 256 с.
17. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології. : Print2print, 2018. – 720 с.
18. Сельє Г. Нариси про адаптаційний синдром. М., 2010. – 437 с.
19. Щербатих Ю. В. Психологія стресу та методи корекції. 2011. – 256 с.
20. Щербатих Ю. В. Використання методів саморегуляції та нейролінгвістичного програмування для зниження рівня стресу у студентів. Профілактика правопорушень у студентському середовищі. Вор: МО-ДЕК, 2010. – 350 с.
21. Greenberg, J. and Baron, R. A. Behaviour in Organisations (7th ed.), Prentice-Hall Inc., NJ., 2003. – 691 pages.
22. HBR's 10. On Mental Toughness. Harv. Busin. Review Press, 2018. – 224 pages.
23. Kremer J., Moran A. P. Pure Sport: Practical Sport Psychology. Routledge; 2nd edition, 2013. – 208 pages.
24. Moran A. Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction., Routledge; 2nd edition, 2012. – 464 pages.
25. Murphy J. Inner Excellence: Train Your Mind for Extraordinary Performance and the Best Possible Life. Academy of Excellence – New York – Rome – Tokyo, 2020. – 360 pages.
26. Rycroft C. Anxiety and Neurosis. Routledge. 1st Edition, 1978. – 172 pages.

2.9. Психологічні ускладнення дітей та підлітків з надмірною вагою та ожирінням

Корнєва Я. І.

Актуальність. Ожиріння – це одне з найпоширеніших захворювань ендокринної системи у дітей та підлітків. Нині в розвинених країнах світу до 15 % підлітків страждають від цієї хвороби [12]. Ця патологія має несприятливі фізичні і психологічні наслідки для дітей та підлітків, зокрема стає безпосередньою причиною захворювань шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, апное сну, передчасного розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу, підвищеного ризику розвитку раку, а також поєднання цих неінфекційних захворювань. Дитяче ожиріння може сприяти поведінковим та емоційним розладам, наприклад депресії, а також призводити до стигматизації (утискання) та поганого соціального розвитку, зниження рівня освіти та якості життя в цілому [15]. Для розвитку сучасного суспільства характерні, з одного боку, чинники, які значно підвищують якість життя дітей та підлітків за рахунок інноваційних і технічних засобів та методів; з іншого – на тлі спрощення життєво важливих завдань спостерігаємо розвиток абіологічних явищ і тенденцій, зростання гіподинамічних проявів та шкідливих звичок у способі життя молоді, нераціональне харчування і організація режиму доби та ін. Зі свого боку, ці чинники в комплексі з генетичними факторами й стресовими ситуаціями дітей сприяють розвитку проблем, які пов'язані з формуванням надлишкової маси тіла (ожиріння різних ступенів) [12]. Надлишкова маса тіла, що на 10 – 30 % перевищує показники норми, відповідає першому ступеню ожиріння, на 30 – 50 % – другому, на 50 % і більше – третьому. Уже при першому ступені ожиріння виникають деякі проблеми з фізичним станом людини, а більш значне перевищення маси тіла (1,5– 2 рази) у медицині прийнято вважати важким захворюванням, що підлягає обов'язковому комплексному лікуванню, фізичній терапії, а також

психологічний підтримці дітей та їх батьків. Отже, через специфіку цієї хвороби особи, які мають надлишкову масу тіла, не лише страждають від хвороб і обмежень рухливості, а й мають низку проблем, що зумовлені соціальною дискримінацією та ізоляцією. Особливо це характерно для покоління, що підростає. Розробка заходів для поліпшення якості життя дітей з ожирінням дасть змогу зменшити не лише наявні фізичні обмеження в повсякденному житті, а й психоемоційні страждання хворих [10, 15].

Мета. Дослідити, яким чином оцінка якості життя (QOL), взаємодія між батьками та дітьми, стилі виховання, освітній процес та соціальний вплив сприяють нездоровим звичкам в стилі життя дітей та молоді.

Слід враховувати, що перш ніж почати будь-яке втручання, додатковим фактором, що потребуватиме подолання проблеми надмірної ваги чи ожиріння, може бути нездатність батьків визнати, що дитина чи підліток мають зайву масу тіла, а особливо дитина дошкільного віку [1].

Результати дослідження. Ожиріння пов'язане з QOL (оцінка якості життя), при цьому рівні, які перевірялися у дітей та підлітків з ожирінням, еквівалентні рівням педіатричного раку або діабету [14]. Крім низької QOL, діти та підлітки з ожирінням мають також значні психосоціальні супутні захворювання, включаючи погану самооцінку, підвищений ризик депресії та тривоги, а також вище середнього ризик харчових розладів, зловживань алкоголем і наркотиками. Низька самооцінка і уявні, або дійсно вищі ІМТ (індекс маси тіла) пов'язані з підвищеною ймовірністю куріння і вживання алкоголю. Щоб усунути упередження, яке можна побачити у клінічній вибірці, Австралійське дослідження з вивчення росту та розвитку дітей (Childhood Growth and Development Study) охоплювало дітей з нормальною масою тіла ($n=158$), надмірною масою тіла ($n=77$) та ожирінням ($n=27$) зі шкіл, а також з сімей, які були включені за власним бажанням ($n=19$). Для когорти школярів у школах проводились вимірювання зросту, маси тіла та психологічне тестування [16]. Підвищення показників ІМТ було пов'язане зі зниженням самооцінки та загальної самоповаги, а також зі зниженням спортивного уміння, соціального визнання та незадоволеністю їх зовнішнім виглядом. Ці зв'язки були зареєстровані, починаючи з 8-річного віку, але зв'язок з фізичним виглядом був

більш виразним у старшій групі. Наявність психосоціального стресу в популяції дітей шкільного віку та підлітків, які не звертаються за медичною допомогою, а також тих, хто прагне такої допомоги, вказує на те, що психосоціальні проблеми присутні як у клінічно обстежуваний, так і в неклінічній популяції молоді з ожирінням [9].

В огляді літературних джерел з 34 публікацій, включених до дослідження, у всіх, окрім двох, було виявлено нижчі показники QOL щодо соціального визнання, сімейного життя, зовнішнього вигляду, щільної діяльності та фізичного функціонування [12]. Фактори, які впливають на зниження QOL, включали ступінь ожиріння, симптоми депресії, відсутність соціальної підтримки однокласників, родини та низький соціально-економічний стан [11]. Загалом, низька самооцінка не є серйозною проблемою до періоду юнацтва, оскільки самоповага однакова в дітей до підліткового віку як з ожирінням, так і з нормальною вагою тіла. Протягом юнацького віку самоповага стає все більш тісно пов'язана із зовнішнім виглядом тіла і швидко падає, з найменшою самооцінкою в тих дівчат-підлітків, які мають вищий ІМТ та загальну незадоволеність виглядом власного тіла [11].

В осіб з розладами харчування є тенденція до визначення самоповаги за образом тіла, що можливо, пояснює зв'язок між розладами харчування та молодими людьми з надмірною масою тіла та ожирінням. Опитування 135 іспанських та афро-американських дівчат з ожирінням або надмірною вагою показали, що 52 % дражнилися через їхню масу тіла зі сторони дівчат, а 60 % дражнилися зі сторони хлопців. З тих, кого дражнили, 70 % пропускали прийом їжі, сиділи на різноманітних дієтах, або влаштовували голодування; 12 % повідомляли про переїдання; і 33 % стверджували, що вони їдять «емоційно». Всі опитувані дівчата заявили, що вони були незадоволені своєю вагою і хотіли бути стрункішими. Розлади харчування, в тому числі переїдання, нервова анорексія та булімія частіше зустрічаються у тих, хто страждає на депресію, тривогу та руйнівну поведінку [11, 16].

Реагування батьків на масу тіла дитини впливає на те, як реагує сама дитина. Глузування однолітків та членів сім'ї призводить до погіршення вигляду тіла та порушує психоемоційний стан та психосоціальне функціонування загалом. Дехто може тиснути на свою дитину, транслюючи їй, наскільки непривабливим є він/вона, в результаті чого погіршуються зовнішній вигляд та самооцінка.

Ретроспективне інтернет-дослідження серед студентів коледжу з великою стурбованістю щодо їхньої ваги, зовнішності та харчової поведінки показало, що в понад 80 % випадків батьки або брати/сестри виказували негативні коментарі щодо їхньої маси тіла, зовнішнього вигляду чи харчування. Найбільше балів (вище середнього) було у психометричних тестах емоційного насилля з безпосередніми зв'язками із негативними коментарями батьків та більшою масою тіла, а також з негативними зв'язками із соціальною підтримкою та самоповагою. Деякі батьки надміру контролюючі, що може призвести до переїдання їхніх дітей та підлітків, коли вони отримують необмежений доступ до їжі. Крім того, у підлітків з екстремальним ожирінням може розвинутися нервова булімія, нервова анорексія чи поведінка з очищенням кишечника, щоб знизити масу тіла. Поперечне когортне дослідження серед підлітків з екстремальним ожирінням та їхніх батьків виявило, що симптоми булімії не співвідносяться зі ступенем ожиріння, але пов'язані з материнською психопатологією, включаючи соматизацію (один з механізмів психологічного захисту людини) і тривогу [13, 14].

Підлітки з ожирінням частіше зазнають дратувань та знущань зі сторони інших, і вони менш імовірно матимуть «найкращого друга» або вважатимуться популярними в школі, ніж їхні стрункі однокласники [16]. Батьки, вчителі та однолітки теж вказують на те, що молоді особи, які страждають на ожиріння, більш ізольовані та мають менше соціальних навичок, ніж їх стрункіші однокласники. Ті, хто має низьку самооцінку і вважають, або фактично мають вищий ІМТ, більш схильні курити і вживати алкоголь, ніж ті, в кого самооцінка вища. Крім того, вони менш спортивні і менш імовірно мають романтичні відносини, що сприяє підвищеній дратівливості, погіршенню самооцінки, самотності, депресії, тривожності та інтровертній поведінці [2].

Загалом, особи з найбільш виразним ожирінням повідомляють про більш виразний психологічний стрес [2]. Дівчата стають депресивними зі зростанням ІМТ більшою мірою, ніж хлопчики, і деякі дослідження показують, що депресія у хлопчиків-афроамериканців не пов'язана з індексом маси тіла, а швидше з дратуванням однокласниками [3]. Расовий і соціально-економічний статус впливає на те, як діти та підлітки реагують на ожиріння; однак існують супе-

речливі повідомлення про вплив ожиріння на психологічний стан у різних групах. Одне дослідження показало, що діти-афроамериканці відчувають більшу незадоволеність образом тіла та тривогу, ніж їхні білі однолітки з такою ж масою тіла, тоді як дослідження серед підлітків виявило, що афро-американці та латиноамериканці менш занепокоєні з цього приводу, ніж білі [6]. Підлітки з високим соціально-економічним станом, хворі на ожиріння з психопатологією, менш імовірно, звернуться по допомогу до програми зниження маси тіла, ніж підлітки з ожирінням з низьким соціально-економічним станом [4], можливо, через більш негативне усвідомлення щодо ожиріння у сім'ях високого соціально-економічного статусу.

Оскільки постійно повідомляється про високі показники депресії, тривожності та розладів переїдання в підлітків з ожирінням, всі пацієнти з надмірною масою тіла повинні оцінюватися щодо наявності психопатології. Часто показане обстеження та консультування психологом та/або психіатром. Клініцистам з обережністю слід призначати антидепресанти, оскільки атипіві антипсихотичні препарати викликають швидке (часто екстремальне) збільшення маси тіла [7].

Діуретики, таблетки для схуднення та мимовільне блювання нерідко використовуються для швидкого зниження маси тіла у підлітків. Одне дослідження показало, що проносні засоби, мимовільне блювання та прийом дієтичних таблеток були більш поширеними у підлітків з ожирінням, порівняно з тими, хто має нормальну масу тіла та надмірну масу тіла [7, 8]. З 6957 дітей та підлітків середньої школи в Північній Кароліні 6 % використовували дієтичні таблетки, а 7,1 % використовували проносні засоби або самостійно викликали блювання. Частота випадків вживання дієтичних таблеток у підлітків становила 3,4 в тих, хто мав нормальну масу тіла, 4,1 – надмірну масу тіла і 9,5 – ожиріння; частота використання проносних препаратів становила відповідно 1,3, 0,7 та 3,2; і поширеність випадків самоіндукції блювання становила 3,4 за нормальної маси тіла проти 7,6 у підлітків, які страждають ожирінням. Особи жіночої статі частіше зловживали речовинами для схуднення, такими як тютюн, алкоголь та марихуана, а також вони частіше були схильними до ризикованої сексуальної поведінки [8]. Важливо підкреслити помірність, а не обмеження, і радити не використовувати ризиковані заходи щодо втрати маси тіла.

Оскільки психосоціальні проблеми настільки поширені, слід проводити психологічний скринінг всіх молодих людей з ожирінням на наявність проблем психічного здоров'я, задаючи питання щодо: пропусків, відмови відвідування школи; draжніння однолітками через масу тіла, зовнішній вигляд; стійкої тривоги; депресії, завдання собі шкоди; вибухів гніву; сексуальної активності, вживання алкоголю, наркотиків; розладів харчування – виснаження, анорексії, переїдання; функціонування сім'ї, сімейного ставлення до маси тіла та, зокрема, ожиріння/психопатології у батьків.

Батькам та/або дітям та підліткам рекомендовано пройти скринінгове визначення психічного здоров'я, наприклад заповнити «Контрольний список дитячих симптомів» (Pediatric Symptom Checklist) [17]. Клініцисти можуть переглянути його під час відвідування пацієнта та у разі наявності показань направляти пацієнтів до спеціаліста з психічного здоров'я.

Висновки. В результаті аналізу досліджень ми розуміємо, що проблеми психічного здоров'я, які пов'язані з надмірною вагою та ожирінням, є широко розповсюдженими серед дітей та підлітків, і мають важливе значення для використання командного підходу, що охоплює: шкільних консультантів, психологів, медсестер, вчителів, медичних працівників, а також родини та загалом близького оточення. Підсумовуючи ще слід відмітити, що корисними є місцеві програми (наприклад, клуби для хлопчиків та дівчат), які пропонують програми фізичної активності та здорового харчування. Саме поведінкова модифікація допомагає визначити готовність дитини чи підлітка до змін, а також виявляє потенційні перешкоди для досягнення цих змін [14]. Фізичний та психологічний стан дітей та підлітків в першу чергу залежить від якості їхнього життя, відтак бачимо потребу в ініціюванні консультацій на рівні навчальних закладів із залученням до цього всієї родини для подальшого проведення досліджень.

Література.

1. Bean M. K., Mazzeo S. E., Stern M. et al. A values-based Motivational Interviewing (MI) intervention for pediatric obesity: study design and methods for MI Values // *Contemp. Clin. Trials.* – 2011. – Vol. 32 (5). – P. 667–674.
2. Dakanalis, A., Clerici, M., Di Mattei, V. E., Caslini, M. L. F., Bagliacca, E. P., Prunas, A., et al. (2014). Internalization of sociocultural standards of

beauty and eating disordered behaviours: the role of body surveillance, shame and social anxiety. *J. Psychopathology* 20, 33–37.

3. De Jong, M., Korrelboom, K., van der Meer, I., Deen, M., Hoek, H. W., & Spinhoven, P. (2016). Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) for eating disorders: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, 17(1).

4. Fairburn, C. G., Bailey-Straebl, S., Basden, S., (2015). A transdiagnostic comparison of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) and interpersonal psychotherapy in the treatment of eating disorders. *Behaviour Research and Therapy*, 70, 64–71.

5. Fluckinger C, Meyer A, Wampold BE, Gassmann D, Messerli-Burgy N, Munsch S. (2011). Predicting premature termination within a randomized controlled trial for binge-eating patients. *Behav Ther.* ;42(4):716–25.

6. Gabbard G. O. (2014). *Psychodynamic psychiatry in clinical practice*, vol. xiv. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing

7. Gorrell, S., & Murray, S. B. (2019). *Eating Disorders*. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America.

8. Levitan, R. D., and Davis, C. (2010). Emotions and eating behaviour: implications for the current obesity epidemic. *Univ. Toronto Q.* 79, 783–799

9. Thomson S, Rowe K, Underwood C, Peck R. Numeracy in the early years: Project good start. Camberwell, Victoria, Australia: Australian Council for Educational Research; 2005.

10. Tsiros M. D., Olds T., Buckley J. D. et al. Health-related quality of life in obese children and adolescents // *Int. J. Obes. (Lond.)*. – 2009. – Vol. 33 (4). – P. 387–400.

11. Skinner EA, Belmont MJ. *Journal of Educational Psychology*. 2013;85(4):571–581.

12. UNICEF, WHO, World Bank. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF-WHO-World Bank joint child malnutrition estimates. –UNICEF, New York; WHO, Geneva; World Bank, Washington DC: 2015.

13. Wisniewski L., Kelly E. (2003). The application of dialectical behavior therapy to the treatment of eating disorders. *Cogn Behav Pract.* ;10(2):131–138.

14. World Health Organization. (2022). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (ICD-11 MMS). World Health Organization. <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>

15. Zeller M. H., Modi A. C. Predictors of health-related quality of life in obese youth // *Obesity (Silver Spring)*. – 2006. – Vol. 14 (1). – P. 122

16. «Childhood Growth and Development Study», PubMed, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/24808944/>

17. https://www.brightfutures.org/mentalhealth/pdf/professionals/ped_sympton_chklst.pdf

2.10. Сучасні дослідження проблем осіб з дисфункціональних родин

Краковська А. Б.

Актуальність. Багато людей сподіваються, що як тільки вони покинуть неблагополучний сімейний дім, то залишать проблеми дитинства позаду. Проте було виявлено, що дорослі діти з дисфункціональних сімей стикаються з цілою низкою психологічних та соціальних проблем.

Дослідження впливу перебування та зростання у дисфункціональній родині на доросле життя та психологічний стан є актуальним, адже за даними, які наводять журналісти та соціальні працівники, проблема виховання дітей у неблагополучних сім'ях в Україні залишається надзвичайно нагальною. За статистикою, яку наводить Суспільне Новини, лише за перше півріччя 2020-го року працівники ювенальної превенції Івано-Франківщини виявили та задокументували 459 фактів неналежного виконання батьками або опікунами обов'язків щодо виховання дітей. В цю статистику також потрапляють випадки фізичного або психологічного насильства [14]. Також уповноважений Президента України з прав дитини М. Кулеба в інтерв'ю Укрінформ зазначає: «Майже 106 тисяч дітей, або 1,5 % всього дитячого населення країни, живуть і виховуються в інтернатах, але тільки 8 % з них сироти, а решта 92 % мають батьків». За його словами, приблизно 600 тисяч дітей проживають у неблагополучних сім'ях [10].

Підрахувати кількість сімей, що є благополучними з законодавчої точки зору, проте мають несприятливий психологічний клімат, фактично, неможливо. Здебільшого особи, що виховувались батьками з психопатіями, схильністю до психологічного насилля, не діагностованими розладами тощо, з'ясовують це лише у дорослому віці, коли можуть оцінити руйнівний вплив поведінки батьків на своє життя.

І хоча це питання вивчали такі автори як Дженет Войтіц, Ліндсі К. Гібсон, Дженет Клоско та Джефрі Янг, в їх роботах увага приді-

ляється терапевтичним технікам та діагностуванню проблем, а не самій кореляції між дисфункціональністю родини та психологічними проблемами членів таких родин, саме тому ми вирішили дослідити це питання більш уважно.

Мета. Надати аналіз дослідженням проблем осіб з дисфункціональних родин.

Результати дослідження. Перш, ніж розглядати сучасні дослідження щодо впливу дисфункції родини на осіб, що в них зростали, необхідно визначити, що мається на увазі під терміном «Дисфункціональна родина». Департамент у справах громад та місцевого самоврядування Великої Британії відносить сім'ї до «дисфункціональних» або «проблемних» за наступними критеріями:

- члени родини залучені до злочинності або демонструють антисоціальну поведінку;
- мають дітей, які регулярно прогулюють навчання, або взагалі не відвідують учбові заклади;
- дорослі члени родини не мають роботи або будь-якого сталого прибутку, окрім грошової допомоги, яку надає держава;
- виживання таких родин лягає тягарем на платників податків [4, с. 9].

З іншого боку, є визначення «дфункціональної родини», яке розглядає сім'ю як систему з чітким набором обов'язків. Соціологи Фредерік Пітерсон та Рональд Сміт виділили п'ять основних функцій, які має виконувати сім'я:

1. Господарсько-побутова – ведення бюджету, організація спільного проживання на одній території, харчування та забезпечення інших базових потреб.

2. Спілкування – здебільшого йдеться про інтелектуальний його аспект, а саме інформаційна насиченість контактів між членами сім'ї. Сюди також входить передача дітям досвіду від батьків, встановлення реалістичних меж та сталих правил поведінки.

3. Психологічна підтримка/розрядка – вміння проводити вільний час разом, прояв емпатії, інтерес до життя та емоцій членів родини.

4. Сексуальні стосунки між подружньою парою – романтична зацікавленість подружжя один в одному, здоровий тактильний контакт.

5. Соціалізація та передача соціального статусу наступному поколінню [6, с. 207-209].

Тобто сімейне середовище є результатом якості міжособистісних стосунків та системності. Функціонуючу сім'ю можна характеризувати через такі риси, як згуртованість, емпатія та здатність реагувати на щоденні виклики.

Джон та Лінда Фрієл у своїй книзі «Дорослі Діти: секрети дисфункціональних сімей» так описують проблематику: «Величезна кількість спеціалістів нашої сфери з досвідом почали відзначати, що не лише алкогольні або наркозалежні сім'ї мають глобальні проблеми. Навіть за умові відсутності хімічних залежностей в сім'ї, всі її члени можуть поводитись та реагувати на буденність за тими самими схемами, що і всередині сім'ї із проблемою залежності, адже в них співпадають регулюючі правила» [9].

Ці характеристики можуть впливати на досвід дітей, життєві траєкторії та емоційний розвиток.

Якщо родина не може підтримувати одну чи декілька функцій, це неодмінно впливає на життя всіх членів, а особливо – на зростання та психологічний стан особистості та її майбутнє.

Згідно досліджень попередніх років, більшість дітей, які виросли з батьками, у яких наявні залежності, схильні брати на себе роль дорослих, щоб піклуватись про себе, молодших сиблінгів та самих батьків [3, с. 287–298]. Цих дітей часто характеризують як «добре вихованих», «тихих» та «розумних не за віком». Проте, таке раннє дорослішання накладає відбиток на все життя і проявляється в майбутньому: нерозуміння та невміння відстоювати власні кордони, проблеми у формуванні рівноцінних партнерських стосунків, відсутність навички делегувати справи, просити про допомогу, проявляти слабкість тощо. Нестабільний клімат всередині родини, а в багатьох випадках наявність систематичного насилля, можуть бути чинниками тривожних та депресивних розладів у майбутньому. Це спостереження, на нашу думку, підкреслює важливість подальших досліджень впливу дисфункціональності сім'ї на психологічний стан осіб, які зростали в такому середовищі.

Сучасні дослідження виявляють цілу низьку проблем, з якими стикається молодь та дорослі люди, які виховувались в проблемних сім'ях. Так вчені Римського університету Сапієнца М. Ерріу, С. Чі-

міно та Л. Черніля у своїй статті «Роль сімейних стосунків у розладах харчової поведінки у підлітків: наративний огляд» зазначають важливість сімейних факторів у виникненні та підтримці розладів харчової поведінки. Зокрема, відсутність комунікації та емоційної залученості батьків у життя підлітка впливають на розвиток розладу та погіршення загального морального стану [12, с. 71].

Психічні розлади батьків також впливають на функціонування сім'ї, адже мають такі наслідки, як зменшена адаптивність, а також дезорганізована модель повсякденного планування. Плас-Крістл та колеги в своєму дослідженні зазначають, що погіршення функціонування сім'ї не залежить від типу батьківського діагнозу, більш впливовим фактором є тяжкість захворювання [5]. Проведене ними дослідження також показало, що психотерапевтичне втручання, націлене на підтримку саме функціонування родини, позитивно впливало і на стан дітей, і на стабільність батьків.

Дисфункція сімейного процесу має найгірші наслідки для дитини як вразливої групи населення. Сім'ї, головною проблемою яких є бідність та насилля, стають чинником дитячої безпритульності, адже діти або тікають від регулярних фізичних атак з боку батьків, або беруть на себе відповідальність за годування молодших сиблінгів. Згідно з даними, які отримала група вчених, що досліджувала дитячу безпритульність в місті Джакарта (Індонезія) в 2021 році, діти та підлітки, які живуть в бідних родинях та частково на вулиці, мають посилені симптоми тривожності та депресії, а також нехтують власним здоров'ям та гігієною. Діти та молодь віком 10-21 рік, які погодились прийняти участь у дослідженні, також демонстрували неадекватно занижену самооцінку [8].

Самотність, яку можна описати як комбінацію почуттів ізольованості, відірваності від близьких або неможливості приєднатись до жодної соціальної групи, може виникати у людини в будь-який віковий період, але найбільш інтенсивно емоційний її аспект зазвичай переживається у підлітковому віці. У своїй роботі «Оцінка та лікування сімей: підхід Макмастера» Крістін Райан та колеги стверджують, що якість сімейного середовища впливає на відчуття самотності, а саме дисфункціональний сімейний досвід, оскільки в такому становищі неможливо задовільнити потребу в емоційній близькості та вразливості [11, с. 43-48]. В підлітковому віці вели-

ку роль в процесі формування відчуття самотності також відіграє надмірний контроль батьків та небажання вдовольнити потребу підлітка в сепарації. Крім того, у неблагополучних сім'ях підлітки мають менше досвіду позитивних соціальних взаємодій, а отже позбавлені позитивної моделі для спостереження та віддзеркалення. Таким чином, вони гірше розвивають ефективні та тривалі стосунки з однолітками. Зважаючи на те, що стосунки з однолітками є соціальним капіталом і мають величезний вплив на життя саме в цьому віці, відірванність посилює відчуття самотності та може стати чинником депресії [7].

Відсутність спілкування та емоційної підтримки всередині родини грають важливу роль у ризику розвитку депресії та інших афективних розладів. Серед реципієнтів, які оцінили згуртованість та підтримуючу атмосферу всередині своєї родини, як низьку, також частіше виявляються симптоми депресії. Дослідження, які проводились за допомогою моделі множинного посередництва, показало, що серед підлітків віком 12-14 років (здебільшого жіночої статі), сім'ї яких є дисфункціональними, частіше діагностували депресію або виявляли легкі симптоми депресії з експоненціальною кореляцією до більшого погіршення сімейних функцій [13].

Висновки. Таким чином, ми проаналізували низку сучасних наукових досліджень, що вивчають взаємозв'язок між психологічними проблемами осіб з дисфункціями їхніх родин. Відтак бачимо потребу у подальшому дослідженні кореляції між відсутністю конкретних функцій всередині сім'ї та психологічними проблемами чи ризиками розвитку ментальних розладів членів таких сімей. Також вважаємо важливим провести дослідження саме серед української молоді, адже проблема дисфункціональності родин, особливо в період активної фази війни, на наш погляд, є актуальною.

Література.

1. Arora, A., & Prakesh, S. (2018). Dysfunctional Family – Characteristics and Effects. Firstcry Parenting . Режим доступу: <https://parenting.firstcry.com/articles/dysfunctional-family-characteristics-and-tips-to-overcome-its-effects/?amp>
2. Bowen, M. (1976). Theory in practice of psychotherapy. In P. Guerin (Ed.), Family therapy: Theory and practice. New York, NY: Gardner Press. С. 24–31.
3. Cronin S., Murphy S., Elklit A. (2016). Investigating the relationship between childhood maltreatment and alcohol misuse in a sample of Danish

young adults: Exploring gender differences. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 33(3), c. 287–298. doi:10. 1515/nsad-2016-0022

4. Department for Communities and Local Government. Annual Report and Accounts 2012-13 // LONDON: The Stationery Office. C. 9.

5. Filter, B., Wiegand-Grefe, S., Sell, M., & Plass-Christl, A. Family Functioning and Psychological Health of Children with Mentally Ill Parents. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2019, 16(7), 1278. Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/ijerph16071278>

6. Frederick W. Preston and Ronald W. Smith *Sociology: An Introduction* 1977. C. 209-207.

7. Guerrero-Muñoz, D., Salazar, D., Constain, V., Perez, A., Pineda-Cañar, C. A., & García-Perdomo, H. A. (2021). Association between Family Functionality and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Korean J Fam Med*. Режим доступу: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8010447/>

8. Irawati, K., Ningrat, F. N., & Dewi, E. U. (2021). The correlation between dysfunctional family process and self-neglect of street children at Special Region of Yogyakarta. *Bali Medical Journal (Bali MedJ)*, 10(3), 1127-1131.

9. John C. Friel, Linda D. Friel *Adult children : the secrets of dysfunctional families* Health Communications, Pompano Beach, Fla., 1988 Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=4oujAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=+the+problems+of+persons+from+dysfunctional+families&ots=hgVzXdLzqZ&sig=YplHxecjtp5BVLkQ-Wf6ngzFqvA&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20problems%20of%20persons%20from%20dysfunctional%20families&f=false

10. New Voice. Невтішна статистика. В Україні за роки незалежності кількість дітей зменшилась майже вдвічі. Режим доступу <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-ukrajini-majzhe-vdvichi-skorotilas-kilkist-ditej-za-roki-nezalezhnosti-551976.html>

11. Ryan, C., Epstein, N. B., & Keitner, G. I. (2005). *Evaluating and Treating Families: The McMaster Approach*, c. 43-48.

12. The Role of Family Relationships in Eating Disorders in Adolescents: A Narrative Review. *Behav. Sci.* 2020, 10(4), c. 71. Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/bs10040071>

13. Wang, Y., Tian, L., Guo, L., & Huebner, E. S. (2020). Family dysfunction and Adolescents' anxiety and depression: A multiple mediation model. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 66., 2020 Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0193397318302740>

14. Новини Суспільне. На Прикарпатті за пів року постраждали 19 дітей від жорстокого поводження. Режим доступу: <https://suspilne.media/47709-na-prikarpatti-za-piv-roku-postrazdali-19-ditej-vid-zorstokogo-povodzenna/>

2.11. Психологічні особливості медичних працівників в умовах емоційного виснаження

Лапінська Т. В.

Актуальність. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей середніх медичних працівників останнім часом стає однією з найважливіших проблем, особливо тих, які працюють в умовах підвищеної професійної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС). Індивідуально-психологічні особливості залежать від багатьох факторів, а саме різних інтересів, уподобань, життєвих цінностей, принципів, пріоритетів, домінуючих ознак особистості, позитивних та негативних якостей, сильних і слабких сторін характеру, виду темпераменту (емоційна стійкість/нестійкість, рухливість /інертність, активність/пасивність, ригідність/пластичність), способу життя, рівня освіти, професії, умов праці, соціального статусу, т. д. Акцентуація характеру, як крайній варіант психічного здоров'я, є складною проблемою як із соціально-психологічної, так і з медичної сторони. Зміни у характері медичних працівників порушують цілісність особистості, знижуючи адаптивні процеси і продуктивність професійної діяльності, що призводить до нервових зривів, негативної поведінки середніх медичних працівників. Акцентуації створюють ґрунт як для невротичних так і психопатичних змін, які в своїй основі порушують духовно-моральну саморегуляцію. Важливу роль відіграє своєчасна діагностика акцентуацій, які під впливом психотравмуючих факторів здатні перетворюватися в більш глибокі патологічні зміни поведінки особистості до рівня психопатії.

Мета. Вивчити індивідуально-психологічні чинники формування професійного вигорання у середніх медичних працівників, які працюють в умовах підвищеної професійної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС).

Результати досліджень. Акцентуація (лат. *accentus* – наголос), підсилення, загострення певних психічних властивостей. Виділяють окремі риси особистості (акцентуйовані), які самі по

собі ще не є патологічними, однак при певних обставинах можуть змінювати розвиток у позитивному або негативному напрямку, досягаючи особливої яскравості в психопатів і невротиків. Акцентуація характеру – надмірна виразність (загостреність) окремих рис характеру. Акцентуації характеру властива схильність особистості до впливу психотравмуючих факторів. Існують різні класифікації типів акцентуацій характеру. Так К. Леонгардом розроблено концепцію акцентуєваних особистостей в якій ним було [1] розроблено дві групи акцентуєваних особистостей: з акцентуацією характеру (демонстративний, педантичний, ригідний, збудливий); з акцентуацією темпераменту (гіпертимічний, дістимічний, тривожно-боязкий, циклотимічний, афективний). О. Є. Лічко [2] розглядає акцентуацію не тільки в особистісному плані, а й зіставляє її з характером, оскільки, на його думку, особистість є широким поняттям, що включає в себе, крім характеру та темпераменту, інтелект, здібності, світогляд тощо.

На думку П. Б. Ганнушкіна, нормальний характер – це умовність, що реально не існує, оскільки середньостатистична норма створюється суспільством. Коли виразність тієї або іншої риси характеру досягає граничних величин і виявляється біля границі норми, виникають акцентуації характеру – це крайні варіанти норми, результат посилення окремих особистісних рис [3]. За рівнем прояву характерологічних рис характери поділяються на середні (нормальні), виражені (акцентуєвані) і ті, що виходять за межі норми (психопатії). А. Є. Лічко вважає, що акцентуація пов'язана з різким, зайвим підкресленням певної риси, що призводить до хворобливої чутливості стосовно одних соціальних ситуацій при відносній стійкості до інших. Акцентуації й психопатії – це стійкі особистісні стани, які спричиняють соціально-психологічну дезадаптацію особистості [4]. Особистості, у яких основні риси мають високий ступінь вираженості, названі К. Леонгардом акцентуєваними. Акцентуєвані особистості не є патологічними. «При іншому тлумаченні, – вважає К. Леонгард, – ми б вимушені дійти висновку, що нормальним слід вважати тільки середню людину, а всяке відхилення від такої середини (середньої норми) повинне бути визнано патологією. Це вимусило б нас вивести за межі норми тих осіб, які своєю своєрідністю виразно виділяються на фоні

середнього рівня. Проте при цьому в цю рубрику потрапила б і та категорія людей, про яких говорять «особистість» в позитивному значенні, підкреслюючи, що їм властивий яскраво виражений оригінальний психічний склад». Як показують дослідження, відношення таких людей до оточуючих ґрунтуються на індивідуальних особливостях, які виникають при відповідних соціальних умовах [6].

Для формування особистості медичного працівника важливе значення має рівень загального культурного розвитку, вміння організувати своє самовиховання, умови праці та соціальне оточення. Часті психоемоційні перевантаження у процесі професійної діяльності, а також деякі особливості психічної індивідуальності призводять до того, що характер змінюється, деформується. Проявляються такі негативні риси як байдужість, грубість, дратівливість під час контакту з хворими, а іноді – пригніченість. Індивідуально-психологічні особливості середніх медичних працівників, які працюють в умовах підвищеної професійної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС) виявляли за методикою діагностики акцентуацій К. Леонгарда – Г. Шмішека та Фрайбурзьким особистісним опитувальником (FPI) [7]. Опитувальник К. Леонгарда – Г. Шмішека містить 10 шкал у відповідності до акцентованих рис характеру: демонстративний, ригідний, педантичний, збудливий, гіпертимний, дистимний, тривожно-боязливий, афективно-екзальтований, емотивний та циклотимний типи. Ознакою наявної акцентуації вважається показник вище 12 балів (максимальне значення – 24 бали).

У респондентів, які були розподілені на групи за віковою ознакою серед провідних рис акцентуацій переважали акцентуації за типами в ДГ1: гіпертимності (16,62 %), екзальтованості (15,23 %), емотивності (15,46 %), демонстративності (13,69 %). У ДГ2 проявилась емотивність (14,7 %), гіпертимність (14,05 %), екзальтованість (13,22 %), циклотимність (12,38 %). Серед осіб ДГ3 переважали такі типи, як емотивність (16,43 %), боязливість (13,14 %), педантичність (12,57 %). Загалом можна констатувати, що серед обстежених ДГ1 і ДГ2 загальна структура акцентуацій відрізнялася демонстративним типом, який проявився в ДГ1, проте для всіх обстежуваних встановлена схильність до емотивного типу акцентуації особистості.

У респондентів, які були розподілені на групи за стажем роботи провідними рисами акцентуацій стали в ДГС1: гіпертимності

(15,80 %), емотивності (15,00 %), ригідності (13,73 %), екзальтованості (13,60 %), циклотимності (13,60 %), демонстративності (13,47 %). У ДГС2 проявилась емотивність (14,78 %), гіпертимність (13,35 %), екзальтованість (13,50 %), ригідність (13,30 %). Серед осіб ДГС3 переважали такі риси акцентуацій, як гіпертимність (16,03 %), емотивність (14,74 %), екзальтованість (13,03 %), циклотимність (13,03 %), демонстративність (12,80 %). ДГС4 визначені такі типи, як емотивність (16,56 %), екзальтованість (13,44 %), боязливність (12,48 %), педантичність (12,24 %).

Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI) дозволяє діагностувати невротичні порушення та містить 12 шкал: I шкала – рівень невротичності в соматовегетативній сфері; II шкала – рівень спонтанної агресивності у поведінковій сфері; III шкала – рівень депресивності в емоційній сфері, як показник зниженого настрою; IV шкала – рівень дратівливості як показник афективного реагування на оточуючих і/або ситуацію; V шкала – рівень комунікативності у когнітивній сфері, як показник соціальної активності; VI шкала – рівень врівноваженості, як показник стресостійкості та толерантності до стресу; VII шкала – рівень реактивної агресивності як поведінки, що характеризується агресивним відношенням до соціального оточення й вираженим прагненням до домінування; VIII шкала – рівень сором'язливості як показник наявності/відсутності тривожності, скутості, невпевненості; IX шкала – рівень самокритичності, що характеризує відношення до соціального оточення; X шкала – досліджує вираженість екстраверсії-інтроверсії; XI шкала – рівень емоційної лабільності як показник частих коливань настрою; XII – шкала чоловічих-жіночих характерологічних особливостей, маскуліність – фемінінність. Результати, які були отримані з використанням цієї методики, дозволили визначити психологічну своєрідність основних підструктур темпераменту і характеру обстежених.

Висновок Узагальнюючи результати дослідження акцентуованих рис характеру, а також ураховуючи особливості роботи середніх медичних працівників, можна зазначити, що обстежувані з акцентуацією за гіпертимним типом характеризувалися енергійністю, ініціативністю, оптимізмом, але одноманітність та монотонність роботи викликали роздратування у СМП. Обстежувані з акцентуацією за екзальтованим типом характеризувалися схильністю

до авантюризму, егоцентризму із неадекватною самооцінкою власних дій, демонструванням емоційної лабільності, патетичністю. Обстежувані із діагностованою акцентуацією за емотивним типом, який проявився в усіх групах, характеризувалися слабкістю емоційного контролю, чуттєвістю, старанністю, але також виявлено підвищену імпульсивність, схильність до конфліктів, замкнутість. Таким чином можна зробити висновок, що тривала робота особливо в умовах підвищеної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС), створює умови для модифікації індивідуально – психологічних чинників з подальшим формуванням професійного/емоційного вигорання серед медичних працівників.

Література.

1. Леонгард К. Акцентуовані особи: [Текст]//К. Леонгард // Перевод з нем. : «Фенікс», 1997. – 544 с.
2. Лічко А. Є. Типи акцентуацій характеру та психопатій у підлітків /А. Є. Обличчя. – 1999. – 416 с.
3. Аверін В. А. Психологія особистості. Характер особистості / Статті з психології – Режим доступу: http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=520
4. Лічко А. Є. Психопатії та акцент. характ. у підлітків. – К. : Мед-а, 1983. – 208 с.
5. Акцентуація характеру та психопатія (класифікація Н. Я. Іванова, А. Є. Личко, 1992) – Режим доступу: http://worldleonard.h1.ru/doc/gipn/gipn_044.html
6. Максименко С. Д. Загальна психологія / Максименко С. Д. – К. : Вид-во «Центр учбової літератури», 2008.

2.12. Теоретичний аналіз поняття адикції у науковій літературі

Лузгіна В. А.

Актуальність. За останні роки спостерігається різке збільшення розповсюдження адиктивних розладів, різноманітність їх форм, поява нових різновидів [1]. Значення терміну «адикція» в науці визначене не до кінця і розуміється і як патологічний стан, і як соціальна девіація, тобто поведінка, що відхиляється від дисциплінарних, соціальних і моральних норм [2]. Якщо звернутися до історичних коренів даного поняття, то у перекладі з латинського «*addictus*» – той, хто пов'язаний боргами (засуджений до рабства за борги) [12]. На англійській мові «*addiction*» означає хибна звичка, пристрасть до чого-небудь. Інакше кажучи, це людина, яка знаходиться у глибокій рабській залежності від чогось чи когось. Це патологічна форма прихильності, яка значно обмежує життєдіяльність людини та впливає на її взаємодію з людьми, які її оточують. Питанням адикції та адиктивної поведінки присвячено чимало праць. Зокрема, Гуменюк Л. Й. [3], Железнякова Ю. В. [4], Пріб Г. А. [9] вивчали проблеми адиктивної поведінки, її соціально-психологічні чинники, основні характеристики та гендерні аспекти. Бончук Н. В. [1], Ковальова О. М. [6], Корець А. М. [7], Свідовська В. [10] у своїх працях розглядали адиктивну поведінку підлітків, неповнолітніх та осіб юнацького віку з особливими потребами. Серед зарубіжних вчених варто виокремити Додса Л. М. [3], Маєрса Д. Г. [13], Фрідсона Е. [14], які досліджували набуту безпорадність та психологію адикції.

Мета. Теоретично проаналізувати та обґрунтувати визначення категорії «адикція» у науковій літературі.

Результати дослідження. Перші наукові праці, присвячені вивченню адикції на прикладі залежності від алкоголю, було зроблено ще у 1818 р. К. Бріль-Крамером, у роботі якого описано патологічні стани запійної форми алкоголізму [12]. Системне вивчення адиктивної поведінки розпочалось у 1884 році, під час проведення

боротьби з ігроманією, наркозалежністю та алкоголізмом у Великобританії, США та Австралії. У цьому ж році почав видаватися журнал *British Journal of Addictions* [12].

Американська асоціація лікування адикції дає таке визначення цьому розладові: «це первинне хронічне захворювання мозку, розлад мотивації, пам'яті та пов'язаних з ними психологічних процесів» [12]. Спочатку термін «адикція» застосовувався лише для опису поведінки людей, залежних від будь-яких хімічних речовин, наприклад, алкоголю, нікотину, наркотиків. Термін «адиктивна поведінка» (*addictive behavior*) у дослідженнях вітчизняних учених переважно застосовувався у значенні зловживання різними хімічними психоактивними речовинами, які призводять до зміни психічного стану до того моменту, як від них сформувалася залежність. Однак із часом з'явилися ширші трактування поняття адиктивної поведінки, зокрема, як повторюваної звички, що підвищує ризик захворювання і/або пов'язана з особистими і соціальними проблемами [12-14].

Гуменюк Л. у своїх дослідженнях зазначає, що «суб'єктивно адиктивна поведінка часто виявляється як «втрата контролю», попри всі спроби людини стримуватися або контролювати себе. Спроби змінити адиктивну поведінку за допомогою лікування або вольових зусиль пов'язані з високим відсотком рецидиву. З огляду на це виділяють дві групи категорій адикції: субстанціональні (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, харчові) і процесуальні (накопичення грошей, гемблінг, секс, робота, Інтернет, релігія)» [2]. Меєрс Д. визначив, що «адикція – це наслідок збочення нормальності» [13]. Доддс Л. М. зазначає, що адикція це компульсивно-спонукувана активність, що характеризується інтенсивністю та завзятістю, відносною втратою автономії, включаючи здатність реагувати на чинники реальності та функції турботи про себе [3]. Отже, адикцію можна визначити як форму патологічної поведінки, яка не відповідає нормі.

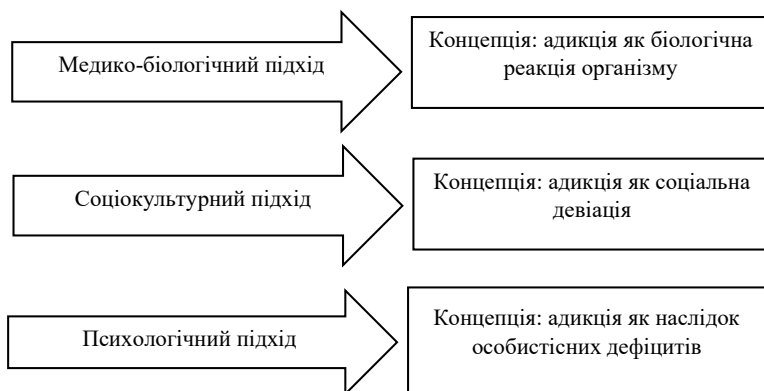
На думку Весмера Л., термін «*addictus*» означає «засудити вільну людину до рабства за борги», тобто будь-яка система чи об'єкт вимагає від людини тотальної покори [16]. Така поведінка виглядає як вимушене підпорядкування. У цьому випадку адикт – це той, хто пов'язаний боргами, отже, він визначається як невільна, залежна людина. Термін «адикт» походить від латинського *addicere* – «благоволити», «сприяти». Так, наприклад, в Америці людей, які

мають пристрасть до чогось або когось, називають «адиктами». У перекладі з англійської мови слово «адикт» означає затятий любитель, прихильник, фанат, шанувальник. У словнику «Longman Dictionary Of Contemporary English» термін «адикт» має два значення: 1) людина, яка не в змозі припинити приймати препарати (наркотики); 2) той, хто чимось дуже сильно захоплений і витрачає на це захоплення весь свій час [15].

Весмер Л. вважає, що адиктивна особистість і є залежною особою. Більшість зарубіжних дослідників за Весмером Л. вважають адикцію синонімом залежності, а адиктивну поведінку синонімом залежної поведінки [16]. Міллер В. та Ландрі М. пояснюють адикцію як порушення поведінки у відсутності фізичної та індивідуальної психологічної залежності [16]. Міллер В. запропонував визначення процесу зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини і формують залежну поведінку, як «адиктивна поведінка» [5]. Свідовська В. узагальнює, що адиктивна поведінка – це поведінка, що передує виникненню залежності, може характеризуватися наявністю компульсії, тому може вважатися стадією розвитку фізичної або психологічної залежності [10]. Поняття «адиктивна поведінка» часто ототожнюють із поняттям «залежна поведінка». Крамченкова В. стверджує, що «адиктивна поведінка займає проміжний етап в процесі формування залежності. На відміну від залежної поведінки, результатом якої є сформованість психологічної і фізіологічної залежностей, в процесі формування адиктивної поведінки формується лише психологічна залежність. Під адикцією розуміється процес формування залежності, що включає етап перших проб, адиктивну поведінку і залежну поведінку» [8].

Адикція є предметом вивчення адиктології – науки про адиктивну поведінку. Адиктивна поведінка – це одна з форм девіантної (що відхиляється) поведінки, деструктивної поведінки, з формуванням прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану завдяки вживанню різноманітних хімічних речовин чи постійній фіксації уваги на певних видах діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних емоцій. Адикції та адиктивна поведінка розглядаються з різних сторін у межах таких предметних областей, як психіатрія, наркологія, психологія.

Нами проаналізовані наукові джерела щодо визначення поняття адикції та узагальнено декілька підходів щодо цього (рис. 1). Адикція спочатку вивчалася у рамках медико-біологічного підходу та розумілася синонімічно із поняттям «залежність». Даний підхід пояснює адикцію, апелюючи до дії хімічних речовин на «систему винагороди» у лімбічному відділі мозку [8]. Таким чином, у межах медико-біологічного підходу домінуючим чинником розвитку адикції вважається індивідуальна біологічна схильність до зловживання психоактивними речовинами. Чинниками ризику для переходу адиктивної поведінки у залежність визначають патологічну спадковість, органічні ураження ЦНС, деякі морфофункціональні особливості [11].



Джерело: узагальнено автором на основі [4, 13, 14].

Рис. 1. Підходи до вивчення поняття «адикції»

Згідно з соціокультурним підходом, адикція – це соціальне відхилення, «хвороба суспільства». Адиктивна поведінка різних видів відображає порушення соціальних взаємин між людьми. Основа цієї теорії відображена у роботах відомого західного соціолога Фрідсона Е., де він наголошує, що девіантна роль – це організований набір небажаних значень, або атрибутів, що приписуються девіантній особистості [14].

Разом із тим, розвиток адиктивної поведінки залежить від певних психологічних особливостей особистості, серед них слабкість волевого контролю, високий рівень нейротизму, велика емотивність, екстернальність, неадекватне самосприйняття, неадекватна

(занижена або завищена) самооцінка, незадоволеність собою, сором'язливість, прагнення до незалежності, наявність соціальної фобії, почуття самотності та нестачі взаєморозуміння, усвідомлення нестатку соціального статусу та уваги до своєї персони, схильність до фантазій та азартних захоплень тощо. У міжособистісних відносинах такі особи зазнають труднощів у безпосередньому спілкуванні, схильні до домінування, незалежності, агресивності, схильні до підозрілості, ворожості, обману.

Також можна виокремити низку особистісних особливостей осіб з різними формами адиктивної поведінки, зокрема, низький рівень стійкості щодо повсякденних труднощів порівняно зі здатністю добре долати кризові ситуації, прихований комплекс неповноцінності, уникання відповідальності у прийнятті рішень, стереотипність поведінки, залежність, тривожність.

«Важливим чинником виникнення адиктивної поведінки є не лише особистісні особливості, а й гендерні аспекти, які можуть проявлятися фруструючими реакціями на регламентацію поведінки особистості відповідно до її статі» [9]. Основоположним у психологічному підході є уявлення про те, що вирішальний вплив на розвиток адикції на фоні біологічної і соціальної схильності впливають психологічні характеристики людини. Різні психологічні напрями підкреслюють роль тих або інших параметрів – особистісних особливостей, мотивації, поведінки, взаємодії з сімейним оточенням тощо. Найбільш поширені особистісні характеристики людей, які схильні до адикції за різними сферами життєдіяльності, представлені у табл. 1.

Для адиктів характерна певна модель поведінки. Залежно від виду адикції ця поведінка може мати специфічні риси. Якщо під час адиктивної практики людина проживає позитивний досвід, вона перебуває у хорошому настрої, відчуваючи задоволення і захищеність. Цей процес включає систему мотивації та нагородження, яка підкріплюється додатковими ритуалами («не можу почати день без чашки кави» – на початку дня обов'язково потрібно випити чашечку улюбленого напою). У компанії людей зі схожими інтересами адикт почувається комфортніше та впевненіше. Тому адиктивний досвід часто реалізується за участю групи підтримки.

Таблиця 1

Особистісні характеристики людини-адикта

№ з/п	Назва сфери життєдіяльності	Особистісні характеристики
1	Сфера поведінки	егоцентризм в спілкуванні, відсутність інтересу до інших людей; тенденція вирішувати проблеми шляхом відходу у світ фантазій; однотипний спосіб реагування на фрустрацію, невміння адекватно справлятися з труднощами; невідповідність домагань своїм можливостям; схильність звинувачувати оточення
2	Афективна і мотиваційно-потребова сфера	емоційна нестійкість; низька фрустраційна толерантність і швидке виникнення тривоги і депресії; неадекватна, частіше занижена, самооцінка; агресивність; соціофобії; порушення почуття майбутнього; слабкий самоконтроль, прагнення до негайного задоволення бажань; навіюваність; незадоволені потреби в захищеності, самоствердженні, свободі, приналежності, тимчасовій перспективі
3	Когнітивна сфера	несформованість абстрактно-логічних, рефлексивних функцій; відсутності чітких життєвих цілей, принципів, цінностей, інтересів, моральних понять; когнітивні спотворення у вигляді афективної логіки

Джерело: узагальнено автором на основі [6, 7].

Коли людина не взаємодіє з об'єктом своєї залежності, її стан погіршується. Вона відчуває психологічний та фізіологічний дискомфорт. Різкі перепади настрою; нездатність адекватно оцінювати те, що відбувається; погіршення когнітивних функцій; небажання спілкуватися; погане самопочуття, пов'язане з порушенням роботи внутрішніх органів, якщо йдеться про хімічну адикцію, всі ці симптоми свідчать про наявність у людини патологічної залежності [7]. Тобто, адикції безпосередньо пов'язані з духовно-моральною

складовою особистості, з її ціннісно-вольовою сферою. Ціннісно-мотиваційний компонент полягає у поданні об'єкта залежності як цінності, та емоційно-вольовий компонент, що виражається у поданні про непереборність потягу до об'єкта залежності [4-5]. Дюпон Р. запропонував психоаналітичне тлумачення адикції – як найсильнішу закоханість у стан, пов'язаний із вживанням наркотику [16]. У пошуках мозкової винагороди адикти нехтують ризиком. Сила мозкової винагороди така, що його втрата стає неприйнятною. Під адиктивними чинниками ми розумітимемо сукупність або прояв окремо взятих аспектів, що негативно впливають на фізіологічну, психологічну, соціальну та духовну сфери особистості і заважають їй стабільному та ефективному формуванню: негативний вплив кола значущих людей, несформовані конструкти особистості, тривалий вплив залежності.

Адикція – це процес, який має безневинний початок, розвивається та має завершення у формі залежності до адиктивного агенту. Адиктивним агентом може бути сигарета, алкоголь, наркотик, секс, які допомагатимуть змінити стан без особливих зусиль, приручаючи людину до рабства душі та тіла. Перехід адиктивної поведінки у залежну поведінку, як показує аналіз наведених вище підходів до цієї проблеми, визначається рядом чинників, що сприяють чи перешкоджають цьому переходу. Такі чинники традиційно поділяються на соціальні, психологічні та біологічні. Соціальні чинники: доступність, мода, ступінь відповідальності, вплив групи підлітків. Психологічні чинники: тип характеру, привабливість виникаючих відчуттів та їх переживання, вироблення гедонічних установок, страх завдати собі реальної шкоди, відсутність соціальних інтересів, прагнення до самоствердження, цікавість. Біологічні чинники: початкова толерантність (індивідуальна непереносимість, висока стійкість), спадковість, органічні ураження мозку, хронічні хвороби, природа речовини, що вживається [4].

Висновки. Проведений нами теоретичний аналіз окремих досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів дозволяє відзначити неоднозначне тлумачення поняття «адикція». Одні автори розглядають адикцію як синонім залежності. Інші автори виокремлюють адикцію як початкову стадію формування залежності, деякі автори відносять адикцію до однієї з форм девіантної поведінки, але без

утворення залежності. Окремі дослідники розмежовують адикцію та залежність і визначають їх як самостійні поняття, які мають власний зміст.

У вітчизняній літературі поняття «адикція», «адиктивна поведінка» розглядаються здебільшого як синоніми таких понять, як «залежність», «узалежнена поведінка». Адикція у сучасній науковій літературі визначається як пристрасть до якоїсь речовини або роду діяльності, яка включає безконтрольне прагнення приймати цю речовину або практикувати вид діяльності для досягнення бажаного психічного ефекту. Адиктивна поведінка є виявом бажання змінити свій психічний стан в напрямку виникнення інтенсивних позитивних емоцій насамперед за допомогою вживання певних речовин (тютюну, алкоголю, наркотичних, психоактивних речовин, медичних препаратів) або ж шляхом здійснення специфічної активності, яка характеризується порушенням контролю за спонуканнями, неподоланністю прагнень, ненаситністю та обов'язковістю виконання (порушення харчової поведінки, пристрасть до азартних і комп'ютерних ігор, до Інтернету, kleptomaniya тощо). Отже, адикція, у загальному розумінні – це залежність, тобто прагнення покластися на когось чи щось з метою отримання задоволення, або це залежність від деяких предметів, речовин чи видів діяльності. Залежність, що розглядається як адикція – це патологічний стан, вийти з якого самостійно неможливо. Виникає звикання на психологічному та фізіологічному рівнях, що супроводжується повторенням, втратою контролю, саморуйнуванням.

Література.

1. Бончук Н. В. Схильність до адиктивної поведінки у підлітків залежно від особливостей системи ціннісних орієнтацій. Молодий вчений. 2016. №7 (34). С. 362 – 368.

2. Гуменюк Л. Й. Соціально-психологічні фактори Інтернет-адикції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. 2013. Вип. 1. С. 11-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2013_1_4.

3. Додс Л. М. Психічна безпорадність та психологія адикції. Психологія та лікування залежної поведінки. За ред. С. Даулінга. Пер. з англ. Р. Р. Пров. Муртазіна. 2000. 240 с.

4. Железнякова Ю. В. Основні характеристики адиктивної поведінки. Теорія і практика сучасної психології. 2016. № 2. С. 4 – 8.
5. Завадська Л. А. Профілактика адиктивної поведінки. Соціальна педагогіка: [навч. -метод. посіб.] за ред. Л. К. Грицюк, В. С. Петровича. Луцьк, 1999. 111 с.
6. Ковальова О. М. Деякі психологічні особливості адитивної поведінки неповнолітніх. Правова система: теорія і практика. 2016. № 2. С. 55–59.
7. Корець А. М. Профілактика адитивної поведінки осіб юнацького віку з особливими потребами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. Випуск 5. 2017. С. 60–64.
8. Крамченкова В. О. Наукові підходи до дослідження тютюнової адиктивної поведінки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2015. Вип. 5. С. 175-180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_5_35.
9. Приб Г. А. Гендерні аспекти адиктивної поведінки. Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 4. С. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_4_22.
10. Свідовська В. Адиктивна поведінка підлітків як проблема наукового дослідження. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2020. Випуск 6. С. 108–114.
11. Сосіна І. К., Чуєва Ю. Ф. Наркологія. Х. : Колегіум, 2014. 150 с.
12. American Society of Addiction Medicine. Definition of Addiction. URL: <https://www.asam.org/resources/definition-of-addiction>
13. David G. Myers. Social Psychology, 10th Edition – Hardcover: McGraw-Hill, 2009. 768 p.
14. Freidsort E. Professionalism: The Third Logic. Chicago: The University of Chicago Press, 2001. 250 p.
15. Longman Active Study Dictionary. Pearson Education Limited 1983. 2010. 1040 p.
16. Kim K., Ryu E., Chon M. Y. et al. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 2006, 43 (2). P. 185–192.

2.13. Інформаційно-психологічна безпека особистості: аналіз загроз, ризиків і перспектив в світлі сучасних реалій

Марков А. Р.

Актуальність. Проблема інформаційно-психологічної безпеки як окремих членів суспільства, так і суспільства в цілому, на теперішній час знаходиться в стані, далекому від вирішення. Навіть у підручниках з питань інформаційного права існує різноманітність визначень цього поняття^[1]. В широкому розумінні, інформаційно-психологічна безпека особистості – це: належний рівень теоретичної та практичної підготовки особистості, при якому досягається захищеність і реалізація її життєво важливих інтересів та гармонійний розвиток незалежно від наявності інформаційних загроз; здатність держави створити умови для гармонійного розвитку й задоволення потреб особистості в інформації, незалежно від наявності інформаційних загроз; гарантування, розвиток і використання інформаційного середовища в інтересах особистості; захищеність від різного роду інформаційних небезпек.

У вузькому розумінні, інформаційно-психологічна безпека особистості – це: стан захищеності психіки людини від негативного впливу, який здійснюється шляхом упровадження деструктивної інформації у свідомість і (або) у підсвідомість людини, що приводить до неадекватного сприйняття нею дійсності; захищеність психіки й свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання свідомістю, дезінформування, спонукання до образ, самогубства тощо; стан захищеності індивідуальної, групової й суспільної свідомості та соціальних суб'єктів різних рівнів від впливу інформаційних факторів, які викликають дисфункціональні соціальні процеси; стан захищеності особистості, різноманітних соціальних груп та об'єднань людей від впливів, здатних проти їхньої волі та бажання змінювати психічні стани

і психологічні характеристики людини, модифікувати її поведінку та обмежувати свободу вибору.

Мета. Дослідити інформаційно-психологічну безпеку особистості як здатність індивіда захистити себе від негативних впливів, пов'язаних з обробкою інформації, за допомогою навичок опанування стресом, критичного мислення та збалансованого сприймання інформації.

Результати дослідження. Основним джерелом загрози інформаційній безпеці особистості є інформаційні війни, що різняться на сім видів (за командування і контроль, війна розвідок, електронна, хакерська, кібервійни, психологічна, за економічну інформацію), причому кожна ведеться зараз на трьох рівнях (особистому, корпоративному, глобальному) і в двох сферах – цивільної та військової (рис. 1).

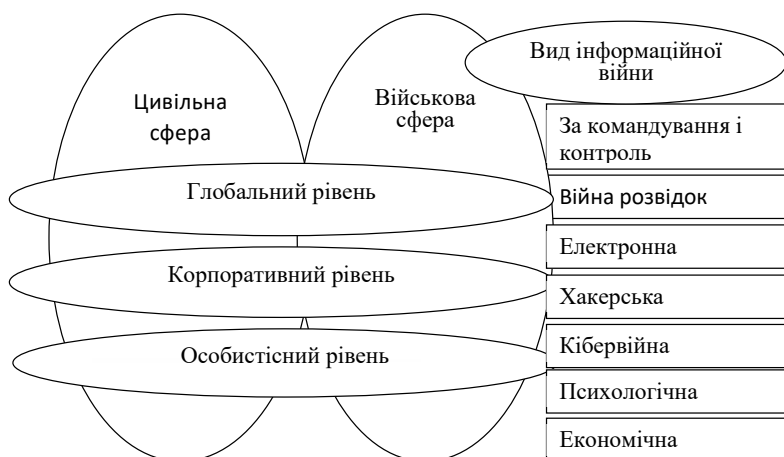


Рис. 1. Співвідношення джерел, рівнів впливу та сфер дії загроз інформаційно-психологічній безпеці особистості
(за матеріалами 3, інтерпретація автора)

За оцінкою спеціалістів, інформаційно-психологічного захисту потребує переважна кількість населення України, але на практиці більшість з них цього зовсім не бажає і всі розмови про інформаційні загрози сприймає зверхньо. Інша, незначна за чисельністю,

більш освічена частина суспільства, має запит на інформаційно-психологічну безпеку, проте, не є групою ризику внаслідок наявності так званого «інтелектуального імунітету» – здатності критично оцінювати будь-яку інформацію та відсутності схильності до індоктринації.

Взагалі, в основі будь-якого психологічного стресу лежить вплив інформації. Однак, на теперішній час окремою дефініцією виділяють інформаційний стрес, який розглядають в трьох аспектах: а) пов'язаний з інформаційним перевантаженням; б) пов'язаний зі взаємодією людини з інформаційними технологіями; в) пов'язаний з професійною діяльністю.

Перший, найбільш глобальний та розповсюджений вид інформаційного стресу, був описаний та обґрунтований А. Тoffler в рамках створеної ним концепції трьох хвиль – типів розвитку суспільства: аграрне – індустріальне – інформаційне (постіндустріальне). Атрибутом інформаційного суспільства, за А. Тoffler, є високий темп розповсюдження інформації, що потребує від людини нових адаптивних навичок, на які вона не здатна. Не маючи надійних механізмів адаптації та не опанувавши нові позитивні стратегії виходу з інформаційної кризи, людина, зокрема, і суспільство в цілому, піддаються розвитку хвороби, яку А. Тoffler назвав футурошоком (future shock), що являє собою «людську реакцію на надмірну стимуляцію», яка проявляється на трьох рівнях: а) сенсорному (зниження точності передачі образів і стирання меж між ілюзією та реальністю), б) когнітивному (зниження здатності вибору, оцінки та збереження інформації), в) поведінковому (зниження здатності до прийняття рішень [1]. До другого типу інформаційного стресу можна віднести стани втрати контролю над діяльністю, пов'язаною з не опануванням нової ситуації, та різноманітні адиктивні стани, пов'язані з новими інформаційними технологіями. Третій вид інформаційного стресу спостерігається у представників екстремальних або автоматизованих професій, пов'язаних з великою відповідальністю.

В світлі зазначеної концепції інформаційного стресу деякі автори виділяють окрему форму невротичних, пов'язаних зі стресом, розладів – інформаційний невроз, який, на їх переконання, виникає внаслідок, з одного боку, довготривалої роботи мозку в умовах несприятливого сполучення наступних факторів – необ-

хідності засвоєння та обробки великого об'єму інформації; постійного дефіциту часу; високого рівня мотивації, що визначає високу значущість інформації, а з іншого – довготривалого дефіциту високозначущої інформації. В той же час, клінічна варіативність таких станів може відповідати будь-якому невротичному розладу, тому в даному випадку мова може йти стосовно причинного зв'язку, а не специфічності клінічних проявів [1]. Враховуючи різнорівневість патологічного впливу медіатравми, ми вважаємо, що проблема деформації суспільної свідомості є сферою компетенції здебільшого соціальної або політичної психології, а наслідки ураження на індивідуальному рівні – сферою компетенції медичної/клінічної психології, бо деструктивного впливу, насамперед, зазнають емоційна, когнітивна та світоглядна сфери особистості, що призводить до високого ризику поширення і розвитку серед населення України різноманітних дезадаптивних станів психічної сфери.

На теперішній час існують досить багато зарубіжних досліджень, в яких вивчаються різні аспекти взаємозв'язків між переглядом телебачення та станом здоров'я особи [4]. Найбільшу кількість досліджень присвячено вивченню впливу телебачення на розвиток психіки і поведінки дитини. Доказові дані щодо кореляції між тривалістю перегляду телевізора і нижчим інтелектуальним коефіцієнтом (IQ) та шкільною неуспішністю з'явилися в науковому просторі ще на початку 1980-х років XX століття. Тоді ж було з'ясовано, що у дітей, яким перегляд телевізора було обмежено навіть на короткий період, зафіксовано покращення когнітивних здібностей. Подальші дослідження підтвердили шкідливі наслідки перегляду телевізійних програм у вигляді зниження когнітивних здібностей, зокрема, уваги і пам'яті, погіршення академічної успішності дітей, а також розвитку їх вербальних комунікативних компетенцій [5-9].

В подальшому були отримані дані щодо зв'язку між затримкою мовного розвитку у дітей до трьох років та надмірною кількістю часу, проведеного при перегляді телебачення. Було підтверджено, що у дітей шкільного віку, які проводять перед телевізором дві і більше години на день, достовірно частіше зустрічаються синдром дефіциту уваги і гіперактивності, емоційні й поведінкові проблеми та соціальні конфлікти з однолітками^[10].

Крім негативного впливу на розвиток формального інтелекту IQ, був доведений негативний вплив перегляду телебачення на розвиток у дитини емоційного інтелекту EQ, а саме, здатності впізнавати та керувати власними емоціями, спроможності зрозуміти емоційний стан батьків та порозумітися з ними, емпатувати наміри і бажання інших людей, а також неспроможність мати власні переконання й нездатність визнавати переконання інших. Причому негативний вплив фіксували за умови не тільки безпосереднього перегляду телевізійних програм, а й в разі присутності дитини в кімнаті з увімкненим телевізором, що працює у фоновому режимі [11]. Якщо приведені вище дослідження продемонстрували, що перегляд телебачення може бути пов'язаний з посиленням поведінкових та емоційних проблем у дітей дошкільного або шкільного віку, то японські вчені винайшли ідентичний зв'язок у дітей до 3-х років. В перспективному дослідженні, проведеному на вибірці дітей від 18 до 30 місяців, було виявлено, що гіперактивність – неухважність у віці 30 місяців була позитивно пов'язана з експозицією у телевізора у віці 18 місяців (прямий кореляційний зв'язок), тоді як просоціальна поведінка була негативно пов'язана з годинами телевізійного впливу у тому ж віці (зворотній кореляційний зв'язок) [2].

У американському дослідженні 2018 року показано зв'язок між особливостями використання телебачення в ранньому дитинстві та подальшими соціальними взаємодіями із однолітками в школі або в дитячому садку. Умови телевізійного перегляду були розділені на три категорії: надмірний перегляд, перегляд без нагляду батьків, перегляд разом з дорослими. Результати показали, що ризик виникнення соціальних труднощів з однолітками в школі у дитини підвищується, якщо члени сім'ї не брали участь у перегляді інтерактивного телебачення з ним у ранньому дитячому віці, або якщо малюки переглядали дорослі програми. Зрештою, згідно з останніми рекомендаціями Американської академії педіатрії, інтерактивний, зацікавлений спільний перегляд телебачення батьків з малюками є більш корисним підходом, ніж просто обмеження експозиції телевізора, який дивляться малюки [13].

Норвезькі вчені, дослідивши 995 4-річних дітей протягом 2-х років, довели, що надмірна залученість до перегляду телевізора обумовлює недостатню залученість дітей до проведення спіль-

ного досугу з батьками, та, в загалі, негативно впливає на якість дитяче-батьківських стосунків, а, в подальшому – на вміння будувати будь-які соціальні відносини^[14].

Інше дослідження тих же авторів продемонструвало, що одним з способів оптимізації дитяче-батьківських, зокрема, материнсько-дитячих стосунків, можуть бути спільні ігри на інтерактивних медіа-пристроях, наприклад, планшеті. На прикладі 22 пар матерів та їх 2-х річних дітей зафіксовано кращі показники соціально-емоційного розвитку дітей та позитивно-конструктивного ставлення до них матерів за умови використання для спільних ігор інтерактивних медіа, на відміну від звичайних іграшок або спільного перегляду телебачення^[15].

Найбільш широкого обговорення дістали результати дослідження японських вчених, які вперше в історії зафіксували «структурний розвиток мозку, пов'язаний з переглядом телебачення» й довели наявність структурних змін головного мозку у дітей, в залежності від часу, який вони витрачали на перегляд телевізійних передач. Дослідники з Університету Тохоку обстежили 276 дітей (133 хлопців та 143 дівчат) віком від 5 до 18 років, які щоденно переглядали телебачення від декількох хвилин до чотирьох годин в день. Дослідивши через деякий час 111 хлопців та 105 дівчат, науковці виявили, що ті, хто переглядав більшу кількість телевізійних каналів протягом більшого часу, зазнали значніших змін у структурі свого мозку, а з часом – продемонстрували нижчий рівень інтелектуального розвитку. Вчені знайшли кореляцію між тривалістю перегляду телебачення та обсягом сірої і білої речовини головного мозку – їм вдалося ідентифікувати структурні зміни (потовщення) у фронтополярній області, зоровій частині кори головного мозку, гіпоталамусі, перегородці та лівій сенсомоторній області, що розвиваються залежно від тривалості перегляду телебачення [16].

Таким чином, вперше вченим вдалося виявити наслідки перегляду телебачення на рівні нейронних систем, та розкрити механізми, за якими відбувається його негативний вплив на інтелектуальні здібності дітей. Від стану фронтальної кори залежить здатність мозку будувати логічні ланцюжки й аналізувати інформацію, а структурні зміни у гіпоталамусі, перегородці та лівій сенсомоторній області, можуть корелювати з агресією, надмірним

емоційним реагуванням, іншими поведінковими порушеннями. Крім того, було доведено зниження вербального інтелекту у дітей зі структурними змінами внаслідок надмірного перегляду телевізійних програм. Отже, дане дослідження на морфологічному рівні остаточно підтвердило, що телебачення прямо або опосередковано пов'язане з нейрокогнітивним розвитком дітей, а його надмірний перегляд обумовлює формування нейрокогнітивного дефіциту, емоційні й поведінкові порушення [17].

З огляду на появу в останні роки значного масиву досліджень з високим рівнем доказовості, що доводять шкідливість надмірного перебування біля телевізора, у США, наприклад, сформувався рух обізнаних батьків щодо жорсткого обмеження часу, проведеного з використанням телевізора або, навіть, смартфона, для їхніх дітей (показово, що ця тенденція сформувалась серед мешканців Сіліконової долини, які безпосередньо причетні до розвитку сучасних медіа-технологій). В американському суспільстві зараз спостерігається формування нового тренду: в цілому по країні діти з родин з низьким доходом проводять біля телевізора або смартфона в середньому 8 годин і 7 хвилин на день, в той час як діти із високооплачуваних сімей – 5 годин 42 хвилини [18].

Не дивлячись на то, що досліджень, в яких би вивчались проблеми, пов'язані з надмірним використанням засобів інформаційно-психологічного впливу, насамперед, переглядом телебачення, у дорослих, набагато менше, все ж-таки, існують достовірні докази його негативного впливу на стан здоров'я глядачів.

Так, в дослідженнях вчених Гарвардського університету наводяться дані щодо збільшення ризику розвитку діабету на 20 %, серцево-судинних захворювань на 15 %, а передчасної смерті на 13 % серед осіб, що щоденно проводять більше двох годин за переглядом телевізора. Результати іншого дослідження, здійсненого в Університеті в Буффало, свідчать про достовірно вищий рівень стресу, тривоги і депресії у людей, що надмірно захоплюються переглядом телевізійних матеріалів, пов'язаних з надлишковим вживанням їжі або спиртних напоїв. Результати дослідження стосовно небезпеки надмірного перегляду телебачення, опубліковані в журналі *Clinical Sleep Medicine* у 2017 році, переконливо продемонстрували, що висока частота перегляду телевізора пов'язана з низькою якістю сну,

підвищеною стомлюваністю та більшою кількістю симптомів безсоння, ніж серед осіб звичайної вибірки. Існують також дослідження, які пов'язують надмірне використання телебачення (більше години на день) з розвитком діабету 2-го типу або депресії. Американські вчені посилаються на результати вивчення ЕЕГ, які демонструють, що наднормовий перегляд телебачення змінює електрофізіологічну активність головного мозку з бета-хвиль на альфа-хвилі, які провокують виникнення мрійливого стану і блокують використання навичок критичного мислення [1]. Структурні зміни тканини головного мозку у вигляді потовщення префронтальної кори, зафіксовані внаслідок надмірного перегляду телебачення, у дорослих мають ще один парадоксальний ефект: дослідженням нейробіологічної моделі процесу переконань і сумнівів, проведеного членами Американської психологічної асоціації, встановлено, що особи з ураженням префронтальної області виявляють достовірно значнішу схильність до авторитаризму та релігійного фундаменталізму (за рахунок зламу процесу формування нормативних сумнівів щодо правильно зрозумілих когнітивних уявлень) [19].

Крім того, вченими ідентифіковано зону мозку (в тім'яній ділянці кори), що активується, якщо людина, як суб'єкт інформаційно-психологічних впливів, задовольнивши потребу бути долученою до будь-якої ідеї, спільноти або лідера, відчуває себе пов'язаною з чимось більшим, ніж є сама [20]. До того ж, за твердженням Г. Г. Почепцова, надмірний перегляд телебачення породжує не тільки втрату критичного мислення, а й хронічний стресовий стан, що супроводжується підвищеною тривожністю та фобічними включеннями [21].

Дослідження вчених Центру досліджень засобів масової інформації, технологій і здоров'я Пітсбурзького університету дозволило, навіть, запропонувати нову дефініцію – «Фейсбук-депресія», сенс якої в тому, що люди, які надмірно використовують соціальні медіа, можуть відчувати, що їх життя не відповідає ідеалізованій життєвій історії, представленій іншими у власних профілях, що може стати тригером до розвитку в них депресивного стану. В подальшому формується порочне коло: люди, які стають депресивними, звертаються до соціальних засобів масової інформації за підтримкою, але їх надмірна взаємодія з ними лише посилює депресію. Дослідження

вчених університету Сан-Дієго, здійснене на основі аналізу результатів двох національно-репрезентативних опитувань підлітків США у 8-12 класах загальної кількістю більше ніж 500 тисяч осіб, а також національних статистичних даних про смертність від суїциду у віці від 13 до 18 років, зафіксувало зростання випадків депресії і завершених суїцидів серед підлітків протягом 2010 – 2015 років, та довело, що підлітки, які витрачали більше часу на соціальні медіа, частіше повідомляли про проблеми психічного здоров'я.

Крім вищенаведеного, важливою особливістю інформаційно-психологічних впливів на індивідуальну свідомість є те, що вони, як загрози, можуть не помічатися й не усвідомлюватися самою людиною. Фахівці стверджують, що небезпечна дія інформаційно-психологічного впливу на індивідуальну свідомість можуть призвести до двох видів взаємозалежних змін [22]. По-перше, це зміни психіки, психічного здоров'я людини. Оскільки в разі інформаційних впливів важко говорити про межі норми і патології, показником змін може бути втрата адекватності відображення світу у свідомості й своєму ставленні до світу. Можна говорити про деформацію особистості зі спрощенням форми відображення дійсності, здійсненням переходу від необхідності реалізації вищих потреб (у самоактуалізації, соціальному визнанні) до нижчих (фізіологічних, побутових). По-друге, це зрушення в цінностях, життєвих позиціях, орієнтирах, світогляді особистості. Такі зміни обумовлюють прояви девіантної антисоціальної поведінки й становлять небезпеку вже для суспільства і держави. До того ж, серед негативних медико-психологічних наслідків, які спостерігаються зараз серед населення України, найбільш значущим стає високий ризик поширення і розвитку різноманітних порушень психічної сфери, серед яких превалюють як донозологічні – соціально-стресові розлади та окремі ознаки проявів або клінічно сформована психологічна дезадаптація, так і клінічно окреслені психічні розлади – гостра реакція горя, гостра реакція на стрес; розлади адаптації; посттравматичний стресовий розлад.

Однак, однією з труднощів діагностики та курації таких осіб стає відсутність наочного зв'язку між етіологічним чинником захворювання, та його клінічними проявами, які, до того ж, в багатьох випадках, соматизуються та взагалі не попадають в поле зору

фахівців з психічного здоров'я [23, 24]. Такі пацієнти звертаються до лікарів загальносоматичного профілю, які також не можуть ідентифікувати реальну причину наявного дезадаптивного стану і, таким чином, через неотримання патогенетичної терапії, відбувається погіршення стану пацієнта, що спричиняє наступний віток «порочного кола» патологічних взаємозв'язків, посилений продовженням впливу медіатравматизації. Треба зазначити, що Всеукраїнська програма підтримки ментального здоров'я «Ти як?», яка реалізується в Україні з квітня 2023 р. за ініціативи Олени Зеленської, звертає увагу на необхідність формування у українців навичок коректного споживання інформації та профілактики медіатравмування. На теперішній час важливі теоретико-методологічні напрацювання з проблеми медіатравматизації розробляються фахівцями Інституту соціальної і політичної психології НАПН України [25, 26], однак, вивчення патофизиологічних механізмів впливу інформації на психічний стан індивіда, клініко-психологічні прояви його порушень і розробка системи заходів їх нівеляції та превенції, потребує ґрунтового розкриття у теоретичному, методологічному та практичному аспектах, що свідчить про об'єктивну необхідність проведення досліджень вказаної проблеми.

Висновки. Вважаємо, що формування і розвиток дезадаптивних психічних станів в умовах масштабних соціальних криз відбувається за рахунок двовекторного впливу медіатравмування через травматичність реального контенту та деструктивного впливу інформаційно-психологічних операції ворога, тому здатність протистояння цим впливам, яка забезпечується належним рівнем інформаційно-психологічної безпеки особистості, тобто, здатністю ідентифікувати та нівелювати небезпечні для психіки інформаційні/маніпулятивні впливи, використовуючи особистісні ресурси здатності до критичного мислення, високих рівнів толерантності до невизначеності, життєстійкості/резильєнтності, які можуть бути як природними, так виробленими внаслідок психоко-рекційної роботи, є важливим напрямком збереження та зміцнення психічного здоров'я населення України. Таким чином, проблеми інформаційно-психологічної безпеки набувають в сучасному світі все більш вагоме значення, а розуміння існуючих загроз і ризиків, механізмів їх дії і можливостей захисту стає не тільки психологіч-

ною проблемою, але й нагальною потребою соціальної практики в повсякденному житті сучасної людини.

Ключові слова: інформаційно-психологічна безпека особистості, соціальна криза, медіатравмування, інформаційний стрес, психологічна дезадаптація, психокорекція, психопревенція, критичне мислення.

Література.

1. Марков А. Р., Маркова М. В. Медико-психологічні детермінанти інформаційно-психологічної безпеки цивільного населення (монографія). Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. 248 с. ISBN: 978-617-7683-61-1/
2. Покальчук О. Кому нужна информационная защита? // <https://zn.ua/SOCIUM/komu-nuzhna-informacionnaya-zaschita-299027>
3. Сопілко І. М. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації: монографія / І. М. Сопілко. – К. : МП «Лєся», 2014. – 424 с.
4. Markova M. V., Markov A. R., Savina M. V., Abdriakhimova T. B., Muharovska I. R., Gaponov K. D. Medical and psychological consequences of using on-screen technologies of informational and psychological influence: analysis of the problem. *Wiadomości Lekarskie*. 2019, tom LXXII, nr 10. P. 2040 – 2045.
5. Gadberry S. Effect of restricting first grader's TV-viewing on leisure time use, IQ change and cognitive style // *J Appl Dev Psychol*. 1981. Vol. 1. P. 45 – 57.
6. Ridley-Johnson R., Chance J. The relation of children's television viewing to school achievement and IQ // *J Educ Res*. 1983. P. 294 – 297.
7. Johnson J. G., Cohen P., Smailes E. M., Kasen S., Brook J. S. Television viewing and aggressive behavior during adolescence and adulthood // *Science*. 2002. vol. 295. P. 2468 – 2471.
8. Zimmerman F. J., Christakis D. A. Children's television viewing and cognitive outcomes: a longitudinal analysis of national data // *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2005. Vol. 159. P. 619 – 625.
9. Landhuis C. E., Poulton R., Welch D., Hancex R. L. Does childhood television viewing lead to attention problems in adolescence? Results from prospective longitudinal study // *Pediatrics*. 2007. Vol. 120. P. 532 – 537.
10. Olson S. Inside The Human Brain: How Watching TV Changes Neural Pathways Versus Reading A Book // <https://www.medicaldaily.com/neural-pathways-watching-tv-human-brain-reading-book-389744> Jun 16, 2016
11. Nathanson A. I., Aladé F., Sharp M. L., Christy K. The Relation Between Television Exposure and Executive Function Among Preschoolers // *Developmental Psychology*. January 2014. 50 (5). DOI: 10. 1037/a0035714
12. Cheng Sh., Maeda T., Yoichi S., Tomiwa K. Early Television Exposure and Children's Behavioral and Social Outcomes at Age 30 Months // *Journal of Epidemiology*. February 2010. 20 Suppl 2 (Suppl 2). S. 482-489.

13. Jackson D. B. Does TV viewing during toddlerhood predict social difficulties and conduct problems? // *Infant and Child Development*. January 2018 <https://doi.org/10.1002/icd.2086>

14. Skaug S., Englund K. T., Wichstrom L. Young children's television viewing and the quality of their interactions with parents: a prospective community study. *Scandinavian Journal of Psychology*. 2018. 59. p. 503-510.

15. Skaug S., Englund K. T., Saksvik-Lehouillier I., Lydersen S., Wichstrom L. Parent-child interactions during traditional and interactive media settings: A pilot randomized control study // *Scand J Psychol*. Apr 2018. Vol. 59 (2). P. 135-145.

16. Kawashima R., Takeuchi H., Taki Y. [et al.] The Impact of Television Viewing on Brain Structures: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses // *Cerebral Cortex*. 2016. 2013. Vol. 25(5). P. 1188-1197. doi:10.1093/cercor/bht315

17. Berns G. S., Blaine K., Preitula M. J., Pye B. E. Shortand Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain // *Brain Connectivity*. 2016.

18. Bowles N. A Dark Consensus About Screens and Kids Begins to Emerge in Silicon Valley // <https://www.nytimes.com/2018/10/26/style/phones-children-silicon-valley.html>

19. Asp E., Ramchandran K., Tranel D. Authoritarianism, religious fundamentalism, and the human prefrontal cortex // *Neuropsychology*. 2012 Jul; 26(4): 414–421.

20. Livni E. Columbia and Yale scientists found the spiritual part of our brains—religion not required // qz.com/1292368/columbia-and-yale-scientists-just-found-the-spiritual-part-of-our-brains/ May 30, 2018

21. Почешцов Г. Г. Как информационные технологии атакуют ментальное пространство человечества // https://ms.detector.media/trends/1411978127/kak_informatsionnye_tekhnologii_atakuyut_mentalnoe_prostranstvo_chelovechestva/

22. Марута Н. О., Маркова М. В. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання. *Український вісник психоневрології*. 2015. Том 23, випуск 3 (84). С. 21 – 28.

23. Марков А. Р. Клінічна варіативність дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни // *Психіатрія, неврологія та медична психологія*. 2016. Т. 3, № 2 (6). С. 98–105.

24. Марков А. Р. Клініко-феноменологічна структура дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни // *Science of Europe (Praha, Czech Republic)*. 2016. vol. 4, # 9 (9). P. 36–45.

25. Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти / *Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.)*; [укладач Чаплінська Ю. С.] // mediaosvita.org.ua. – 2017 Губеладзе І. Травмівний контент і наше психічне здоров'я // *Освіта і суспільство*. 2023. в. 3, С. 15-16.

2.14. Тенденції розвитку алкогольної залежності серед молоді України

Фесік Ю. О.

Актуальність. Споживання алкоголю у шкідливих кількостях – суттєва соціальна проблема. Проблема кожної держави, яка охоплює різні верстви населення та різні вікові групи. Алкогольна залежність вражає людей успішних, менш успішних, бідних та багатих. У випадку залежності від алкоголю людина зазвичай стикається із психічною деградацією, втратою здоров'я та гідності. Велика кількість алкоголіків вмирає раптово в молодому віці. Це підкреслює серйозні наслідки алкогольного вживання для якості життя та загального благополуччя. Економісти стверджують, що у тих, хто помірно вживає алкоголь, спостерігається зниження продуктивності праці на 4-5 %. Понад половина транспортних пригод пов'язана з впливом алкоголю. Травми на виробництві відзначаються частіше у понеділок та після свят, коли організм ще не відновився від алкогольного впливу.

Від початкової стадії до вже повної залежності може пройти і понад 15 років, але з кожним прийомом алкоголю людина поволі, але вірно погіршує генетичний фон, тим самим впливаючи на здоров'я майбутніх поколінь. Стає фізично залежною від спиртного, починає бути більш нервовою та менш стриманою, відтак з'являються проблеми у сім'ї. Дуже часто супроводжуються сімейні відносини фізичною агресією та розбещенням. Надмірне вживання алкоголю займає одну з перших позицій серед причин розірвання шлюбу. Про актуальність проблеми алкоголізму годі й говорити, так як кожна людина точно знає, що це за хвороба і кожна людина знає, які наслідки можуть бути при зловживанні алкоголю. До повномасштабного вторгнення України знаходилась на п'ятій сходинці рейтингу ВООЗ [1] споживання кількості алкоголю на душу населення за рік (споживання людей віком від 15 років). Наш показник 13,9 літрів чистого спирту.

Мета. Дослідити тенденції розвитку алкогольної залежності серед молоді України.

Результати дослідження. За даними онлайн опитування Українського інституту майбутнього проведеного в травні 2023 року, для 16 % опитуваних вживання алкоголю є основним способом розслабитись, 28 % респондентів збільшили вживання алкоголю після повномасштабного вторгнення, 23 % зізнаються, що зараз вживають алкоголь більше, ніж до початку війни [2].

Завдяки даним проєкту Global Burden of Disease («Глобальний тягар хвороби») дослідникам вдалося встановити, що приблизно 1,34 мільярда людей у світі систематично вживають алкоголь у небезпечних для здоров'я дозах. Більша частина тих, що вживають алкоголь – молоді верстви населення (51,9 %) віком від 15 до 39 років. Один з шести хлопчиків у віці 11-12 років вже має практичне уявлення про стан алкогольного сп'яніння. А 27,0 % усіх молодих людей віком від 15 до 19 вже вживають алкоголь. Маєм гіпотезу, що вік алкогольного вживання молодшає, і все більше підлітків вживають алкоголь на постійній основі, раніше починають пробувати та укорінюють думку, що алкоголь сприяє покращенню настрою та допомагає зняти стрес.

Виходячи з даної гіпотези були проведені дослідження організацією ЮНІСЕФ за сприяння ESPAD (Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин) – «куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні».

Статистичні дані ESPAD щодо дитячого алкоголізму в Україні досить невтішні і становлять [2]:

- 40,0 % молодих людей до 18 років регулярно вживають алкоголь;
- 1,0 % дітей 12-15 років мають чітку сформовану залежність;
- 90,0 % тих, хто регулярно вживали у шкільному віці стають хронічними алкоголіками;
- кожна сьома залежна дитина – дівчинка;

Останні дослідження Міжнародного проєкту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» [3] показує, що дівчата починають пробувати алкоголь дещо раніше за хлопців 79,1-86,6, така тенденція зберігається у групі підлітків, які мали великий досвід вживання, це 10 і більше разів, та групі з дуже великим досвідом 40 разів і більше – 16,8 % хлопці, 21,8 % дівчата. Про наслідки цих результатів поговоримо далі у статті.

Причини підліткового вживання. Загалом діти починають пробувати та вживати алкоголь, коли стають більш самостійні. Коли

підліток проводить більше часу поза домом, в компанії товаришів, не під контролем батьків – шанси на знайомство з алкоголем суттєво підвищуються.

Дуже важливу роль відіграє середовище в якому проживає дитина. Так в містах підлітки споживають алкоголь значно більше, ніж підлітки, котрі проживають в селах 25 %-31,9 % [4, с. 27]. Це стосується навіть різних районів великого мегаполісу. Проживаючи в центральній частині міста підлітки менше вживають, ніж ті, що проживають на його околицях.

Атмосфера в сім'ї не менш важливий фактор. В неблагополучних або багатодітних родинх ризик вживання досить високий. В таких сім'ях часто зовсім відсутній батьківський контроль. Діти належать самі собі. Не з'являються на шкільних заняттях, починають курити, а згодом і вживати алкоголь, пояснюючи тим, аби якось підняти свій настрій та покращити існування. Дуже часто такі підлітки шукають собі поплічників серед однокласників або юнаків свого віку. І так само часто їм це вдається.

На сьогодні майже у кожного підлітка є свої кишенькові гроші. На полицях магазинів, універмагах просто неймовірна вибір алкогольних виробів. Це все наразі дуже доступно. Так, як алкоголь заборонено продавати дітям до 18 років, існує значна кількість підпільних кіосків, яка цю заборону ігнорує. Часто вони знаходяться на відстані 100 метрів від території школи. На жаль, перевірка даних установ, особливо у спальних районах, проводиться не так часто і скоріше за все не так ретельно. Тому, так часто можна спостерігати школярів біля таких кіосків з сигаретами та пляшками слабоалкогольних напоїв. Це пояснює значно нижчий рівень вживання алкоголю підлітками в селах. Доступність та вибір.

Немає чим зайнятися. Позашкільне дозвілля – це важлива складова проведення часу підлітком. Часто дійсно вони не мають чим зайнятися. Приблизно 8-12 годин на тиждень підліток проводить з друзями, в гостях у компаніях. І це є нормою, що їх тягне подальше від батьків і ближче до своїх однолітків. Але часто і особливо вечірні прогулянки обмежуються фразою «підемо пройдемось» та безцільним вештанням по вулицях.

І якщо компанії одних підлітків таки обирають розмови, спільні заняття та невинні розваги, то дозвілля інших – шастання по за-

кинутих недобудовах, вживання алкоголю або інших заборонених речовин, прояв агресії до інших.

Таким чином, коли батькам немає часу визначитися, організувати та зацікавити дитину заняттями після школи, підлітки починають займатися цим самостійно, але часто не на свою користь.

Найчастіше виправдання підлітками вживання ними алкоголю [5, с. 30] наступне:

- Тому що це допомагало тобі насолодитися вечіркою – 24,9 %
- Тому що це допомагає тобі, коли ти почуваєшся депресивно або нервуєшся – 16,7 %
- Для того, щоб підбадьоритись, коли ти перебуваєш у поганому настрої – 17,1 %
- Тому що тобі подобається відчуття – 13,6 %
- Щоб «отримати кайф» – 12,0 %
- Тому що це робить заходи веселішими – 25,9 %
- Щоб «вписатися» до групи, яка тобі подобається – 7,9 %
- Тому що це покращує вечірки та святкування – 26,4 %
- Щоб забути про свої проблеми – 16,8 %
- Тому що це весело – 19,9 %
- Щоб подібатися іншим – 4,2 %
- Щоб не залишатися осторонь – 8,0 %

Тобто у підлітків є сформований зв'язок, між вживанням алкоголю та веселим настроєм. Та повна відсутність розуміння наслідків при такому вживанні. Особливо коли частота вживань збільшується.

У сучасному соціокультурному контексті виявляється розповсюдження вживання алкогольних напоїв серед підлітків, особливо в області нічних розважальних закладів та перед проведенням шкільних дискотек. Виявлено, що в цих ситуаціях значна частина присутніх долучається до вживання алкоголю, а для багатьох це стає першим досвідом взаємодії з алкогольними речовинами.

Подібні сценарії, в реальності, представляють значний ризик, що виникає у вибуховому емоційному стані всіх учасників, встановленої кореляції між вживанням алкоголю та відчуттям ейфорії. Це сприяє утвердженню у свідомості підлітків позитивного зв'язку між алкоголем та піднятим настроєм, що в результаті веде до збільшення частоти вживання алкоголю, а в подальшому – до негативних показників у статистиці. Нерідко такі вечірки закінчуються незахищеним сексом, а відтак венеричними захворюваннями та

вагітностями у підлітковому віці. Частота пологів у юних вагітних на сьогодні в Україні складає від 1,8 до 2,7 % [5] і має тенденцію до зростання з року в рік. На вік 13-18 років при народженні першої дитини припадає практично 20 % пологів у всіх вікових групах.

В рамках опитування респонденти розповіли, коли вперше зазнали випробувань із вживанням алкогольних напоїв (мінімум один келих). Виявилося, що на вік десяти років чи раніше перше знайомство з алкоголем вже мало 13,4 % від усіх опитаних [6, с. 32]. Якщо йдеться про надто раннє ознайомлення з алкоголем (вік дев'ять років чи раніше), то тут виявлено більше випадків серед хлопців, ніж серед дівчат (відповідно 10,2 % і 7,3 % серед опитаних). У групі тих, хто вперше вивів алкоголь у 10 і 11 років, частина хлопців і дівчат однакова. Проте від 12 до 15 років виявлено більшу кількість дівчат, які вперше пробували вживати алкоголь, щодо аналогічного показника серед хлопців. Отже, дівчата раніше приєднуються до практики вживання алкогольних напоїв, ніж їхні хлопці ровесники.

Тенденції підліткового пияцтва в Україні дуже невтішні. Цифри показують, що вік алкоголю невинно молодшає і переважна кількість підлітків вже мали досвід вживання алкоголю, тобто протягом життя випивали принаймні один раз.

Наразі в Україні триває війна. Ситуацій для стресу, більш, ніж достатньо. Багато дітей були вимушені переїхати у нові міста, піти до нових закладів освіти, знаходити спільну мову з ровесниками, заводити нових друзів. Велика кількість дітей мають втрати серед рідних людей. Це ті фактори, які можуть стати причиною вперше спробувати алкоголь, або перейти на його систематичне вживання.

Висновки. Виходячи з даних проведеного дослідження – підліткове вживання алкоголю це серйозна проблема та виклик для нашої країни. Нам треба приділити цьому питанню особливу увагу. З огляду на тенденцію та стан в якому перебуває держава – питання стоїть гостро на невідкладно.

Дітям потрібно організовувати та пропагувати корисні, правильні дозволя. Важливо аби вони були фінансово доступні. Донести інформацію про шкоду вживання алкоголю, навіть слабоалкогольних напоїв у невеликій кількості декілька разів на тиждень. Проводити профілактичні зустрічі, дати зрозуміти, що проблеми краще вирішувати разом з психологом, а не з пляшкою спиртного.

Також, подбати про обізнаність батьків в цьому питанні, описати ризики та ознайомити зі статистикою. За потреби допомогти в організації профілактичних заходів. Батьки мають особливо зважати на свою поведінку та звички, розмовляти про це зі своєю дитиною.

У висновку можна відзначити, що підліткове вживання алкоголю у шкідливих дозах є серйозною соціальною проблемою, яка вимагає уваги та розгляду на рівні громадськості та системи освіти. Висвітлений аналіз показує, що невірні поняття про алкоголь, як засіб розслаблення та вплив родинних традицій можуть призвести до широкого поширення цієї привілеї серед молоді. Зазначено, що підлітки, сприймаючи алкоголь як шлях до позитивних емоцій, стикаються з ризиками фізичного та психічного здоров'я, а також можуть потрапити в соціально-психологічні проблеми. Важливо акцентувати на тому, що розвиток ефективних програм профілактики та освіти є ключовим елементом вирішення цієї проблеми, спрямованим на зміну стереотипів та усвідомлення наслідків невірного вживання алкоголю серед молоді.

Література.

1. Країни, які найбільше вживають алкоголь [Електронний ресурс] / Вікіпедія // Вікіпедія. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/wiki>.

2. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні [Електронний ресурс] // ЮНІСЕФ. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: <https://news.uifuture.org/yak-zminivsy-psikhoemocyniy-stan-ukra/>.

3. Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD)» [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.uisr.org.ua/espad>

4. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні // ЮНІСЕФ. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: <https://news.uifuture.org/yak-zminivsy-psikhoemocyniy-stan-ukra/>.

5. Підліткова вагітність [Електронний ресурс] // Буковинський державний медичний університет. – 22. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.bsmu.edu.ua/blog/pidlitkova-vagitnist/>.

6. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні [Електронний ресурс] // ЮНІСЕФ. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: <https://news.uifuture.org/yak-zminivsy-psikhoemocyniy-stan-ukra/>.

2.15. Психоемоційні стани вагітних жінок

Шинкарук Т. А.

Актуальність. Материнство як соціо-культурний феномен, як система взаємодії матері та дитини у час викликів і трансформацій потребує особливої уваги фахівців та наукового вивчення. Вітчизняною та зарубіжною науковою спільнотою феномен «материнство» досліджується як самостійний психологічний феномен з позицій: психологічні особливості пренатального розвитку дитини; емоційний контакт матері та дитини; вплив відсутності матері на розвиток дитини, психологічні особливості перинатальної та неонатальної комунікації матері та дитини та ін.

Зміни психоемоційного та соматичного стану жінок на початку та протягом вагітності носять адаптивний характер. Тривоги та стреси можуть порушувати психоемоційні стани жінок, впливати на перебіг вагітності, позначитись на репродуктивній системі жінки. То ж постає необхідність у вивченні психоемоційного стану жінки у період вагітності.

Мета. Теоретичне та емпіричне вивчення психоемоційного стану вагітних жінок.

Результати дослідження. Опираючись на визначення стану як функціональності нервової системи (психіка як рівень активності-пасивності нервово-психічної діяльності організму), науковцями здійснюється дослідження поняття «стан людини» у фізіологічному, психо-фізіологічному та психологічному напрямках.

Фізіологічне трактування поняття «Психічний стан» людини «... являє собою цілісну характеристику її психічної діяльності за певний період, що відображає складну структуру взаємозв'язків з вище- і нижче розташованими рівнями системи психічної регуляції, утворену процесами самоуправління і саморегуляції» [5, с. 128].

У «Сучасному тлумачному психологічному словнику» поняття «психічний стан» «використовується для умовного виділення в психіці індивіда відносно статичного моменту – на відміну від поняття психічного процесу, що підкреслює динамічні моменти

психіки, і поняття психічної властивості, що вказує на стійкість проявів психіки, їхню закріпленість і повторюваність у структурі особистості» [4].

Автори «Словника психологічних термінів» трактують поняття «психічні стани» «...як певну психологічну характеристику особистості людини, яка показує її порівняно тривалі душевні переживання та почуття» [7].

У науковому дослідженні психічних станів людини В. М. Юрченко трактує поняття «психічні стани» – як «складне, цілісне, поліструктурне, поліфункціональне та особистісно зумовлене психофізіологічне явище, яке характеризує психосоматичну організацію людини в проміжках часу між двома значущими для неї змінами ставлення до зовнішнього або внутрішнього середовища і виконує функції відображення, регулювання та інтеграції її життєдіяльності і поведінки» [11, с. 223].

Таким чином, різні підходи до розуміння сутності психоемоційних станів у науковій літературі вказують на цілісність психіки, що характеризується передумовами попереднього стану та індивідуально-психічними особливостями і властивостями людини, а також своєрідністю перебігу.

Як характеристика психіки психічний стан людини являє собою цілісну системну реакцію (на рівні організму і часто – особистості) на зовнішні і внутрішні впливи, спрямовану на збереження цілісності організму і забезпечення його життєдіяльності в конкретних умовах існування [5]. Діалогічність наукових поглядів представляють різні підходи до класифікацій і характеристик психічних станів. Так, визначається характеристика властивостей станів за: модальністю; тривалістю (стійкість); глибиною станів (інтенсивність); якістю станів; за знаком переживань (емоцій) (позитивні і негативні); значущістю (сприятливі і несприятливі).

Наступна класифікація психічних станів за авторства М. Й. Варія містить наступні компоненти: стани бувають глибокими та поверхневими, усвідомленими й неусвідомленими, адекватними й неадекватним, можуть формуватися в залежності від причин, що їх викликають [1, с. 682] (рис. 1).

Восьмикомпонентну модель психоемоційних станів (емоцій) запропоновано Т. Кохрейн: потяг – відкидання, сила – слабкість,

свобода – примус, визначеність – невизначеність, загальні – сфокусовані, спрямовані в минуле – спрямовані в майбутнє, тривалі – раптові, соціально орієнтовані – соціально відсторонені [12].



Рис. 1. Психічні стани особистості*за М. Й. Варієм

**розроблено автором*

Психічні стани розглядають за чотирма групами:

1. «Мотиваційні (бажання, прагнення, інтереси, потяги, пристрасті).

2. Емоційні (емоційний тон відчуттів, емоційний відгук на явища дійсності, настрій, конфліктні емоційні стани – стрес, афект, фрустрація).

3. Вольові стани – ініціативності, цілеспрямованості, рішучості, наполегливості (їхня класифікація пов'язана зі структурою складної вольової дії).

4. Стани різних рівнів організованості свідомості (вони виявляються в різних рівнях уважності)» [1, с. 56].

Теоретичний аналіз медико-психологічної літератури засвідчив, що жінки у період вагітності переживають такі психоемоційні стани, як: тривожність, стійкі стреси, страхи, роздратування, фрустрацію, агресивність та ін. У той же час, психоемоційний стан вагітних жінок обумовлений функціонуванням вегетативної нервової системи, роботою залоз внутрішньої секреції, підвищенням гормо-

нальним фоном. Тому, у жінок у період вагітності спостерігається емоційна нестійкість, підвищена тривожність, дратівливість.

На психоемоційний стан вагітних жінок впливають:

- індивідуально-психологічні чинники: властивості нервової системи, особливості нервово-психічного реагування, емоційна стійкість, самооцінка, ціннісні орієнтації, психологічна готовність до вагітності;

- соціально-психологічні чинники: досвід взаємодії із соціальним середовищем (чоловік, члени родини, колеги, знайомі), задоволеність шлюбом, прийняття соціального статусу та соціальної ролі, задоволеність матеріальним забезпеченням;

- акушерський анамнез: вік, загальний стан здоров'я, кількість вагітностей та пологів, характер протікання вагітності та ін.

- вплив війни: спогади про травматичні ситуації, труднощі засинання та тривожний сон, емоційна нестабільність (сльозливість, емоційна нестриманість), постійні очікування повітряних тривог, підвищена пильність, адаптація у зв'язку з ситуацією внутрішнього переселення, економічне становище.

Нашим науковим завданням стало вивчення тривоги та тривожності вагітних, що, за практикою спостереження, вбачається нами як означення емоційної відповіді психіки на можливу фізичну чи психічну загрозу. За вивченням наукових джерел (І. Б. Венцківська, Я. М. Вітовський, О. Ф. Майданник, В. Г. Сюсюка, Т. А. Шинкарук) та практичного досвіду, вагітність у першому та початку другого триместрів характеризується змінами в емоційно-вольовій сфері та у фізичних відчуттях; тривожність спостерігається через дратівливість, швидкі зміни («перепади») настрою, зниження загальної активності.

І. Б. Венцківська, Я. М. Вітовський, О. Ф. Майданник, В. Г. Сюсюка, І. А. Шрамко [8; 9; 10; 11] у дослідженнях вказують, що за характером переживань симптоматики психоемоційного стану, який жінки суб'єктивно визначають, оцінюючи самопочуття, як:

- «оптимальний варіант (емоційний стан характеризується періодичними, нетривалими зниженнями загального фізичного та емоційного тону, підвищеною дратівливістю, які інтерпретуються як втома та стан соматичного нездужання);

- посилене переживання емоційних і соматичних станів (емоційний стан характеризується невдоволенням по відношенню до оточуючих та вимогливістю, а їхнє ставлення оцінюється, як недостатньо уважне та невідповідне до всієї важкості стану вагітної);

- тривожне переживання стану вагітності з прогнозуванням неблагоприятного результату вагітності для себе або дитини (будь-яка зміна у стані оцінюється як загрозна, жінка постійно прислухається до себе, своїх відчуттів, а тривожний фон настрою практично постійний, періоди нормального настрою короткочасні та ситуативні);

- депресивний стан періодично послаблює або загострюється, практично без «проблисків» (загальні переживання вагітності як приреченості, при цьому нерідко на словах ставлення до вагітності та майбутньої дитини як надцінності)» [8, с. 53].

Практика діяльності вказує, що психоемоційний стан вагітних жінок позначається на періоді виношуванні, психологічній готовності до пологів та процесі народження, готовності до материнства і ставленні до дитини.

Для вивчення психоемоційних станів вагітних жінок організовано емпіричне дослідження. Мета емпіричного етапу дослідження – вивчення та аналіз рівня тривожності вагітних жінок. За результатами теоретичного аналізу наукової літератури було з'ясовано, що одним із психічних станів жінок є тривожність. Для діагностування рівня тривожності було застосовано методику «Шкала ситуативної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна», що, у свою чергу, дало можливість оцінити рівень ситуативної (СТ) та особистісної (ОТ) тривожності респондентів (рис. 2). Вибірку респондентів склали три групи: 1 група – 18-30 років (39 жінок); 2 група – 31-39 років (33 жінки); 3 група – 40 – 44 роки (23 жінки).

Узагальнені результати (рис. 2) дослідження зафіксували, що у вагітних жінок переважають високий і середній рівні ситуативної та особистісної тривожності. Високий рівень ситуативної тривожності спостерігається у 53 % вагітних, а середній – у 30 %. Особистісна тривожність за високим рівнем відзначалась у 48 % респондентів, за середнім – у 32 %, низьким – у 20 % вагітних жінок.

Ситуативна та особистісна тривожність жінок у період вагітності часто супроводжується швидкою емоційною та фізичною втомленістю; підвищеним занепокоєнням, що супроводжується

або кількістю уточнюючих запитань, або їх відсутністю; бажанням присутності рідної (близької) людини. Високі показники тривожності також обумовлені ситуацією війни: постійними повітряними тривогами, хвилюванням за здоров'я рідних людей, відсутністю впевненості у завтрашньому дні.

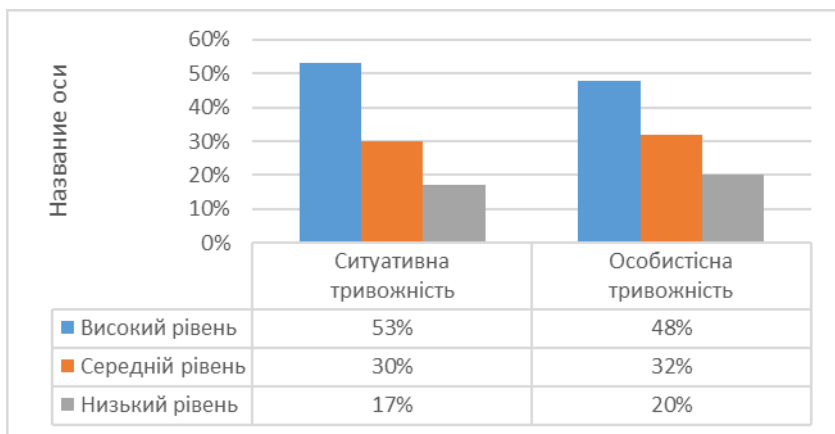


Рис. 2. Результати ситуативної та особистісної тривожності вагітних жінок

Таким чином, за результатами дослідження у більшості опитаних жінок спостерігаються такі індивідуально-особистісні реакції та стани: занепокоєність, тривожність, емоційне напруження, переживання. Підвищений рівень тривожності, підвищена емоційність, стрес можуть стати причиною негативних наслідків для здоров'я жінки: розлади харчової поведінки, головокружіння, порушення сну, підвищення артеріального тиску,

Висновки. Психоемоційний стан характеризується передумовами дією життєвої ситуації, індивідуально-психічними особливостями і властивостями людини. На психоемоційний стан вагітних жінок впливають: індивідуально-психологічні (властивості нервової системи, особливості нервово-психічного реагування, емоційна стійкість, самооцінка, ціннісні орієнтації, психологічна готовність до вагітності), соціально-психологічні (досвід взаємодії із соціальним середовищем (чоловік, члени родини, колеги, знайомі), задоволеність шлюбом, прийняття соціального статусу та

соціальної ролі, задоволеність матеріальним забезпеченням) чинники, акушерський анамнез та фактор війни. Підвищені показники середнього та високого рівнів тривожності вагітних жінок потребують допомоги як лікарів, так і психологів.

Література.

1. Варій М. Й. Загальна психологія. К. : Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.

2. Венцківська І. Б., Майданник О. Ф., Вітовський Я. М. Вплив психоемоційного навантаження на перебіг вагітності. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ : Інтермед, 2010. С. 20-24.

3. Дослідження психологічного стану вагітних з урахуванням психосоматичного компоненту: навчальний посібник / В. О. Потапов, В. В. Чугунов, В. Г. Сюсюка, Н. О. Губа, Ю. В. Котлова. Дніпро; Запоріжжя: ТОВ «Карат», 2017. 126 с.

4. Канюка С. І. Формування толерантності жінок різного віку як умови їх психологічної готовності до майбутнього материнства : дис. . . . к-та пси. наук: 19. 00. 01; Запорізький державний медичний університет Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ. 2018. 358 с.

5. Кокун О. М. Психофізіологія. Навчальний посібник. К: Центр навчальної літератури, 2006. 184 с.

6. Методика «Шкала ситуативної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна». URL: <https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/160/29.pdf>

7. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. К. : Каравела, 2020. 418 с.

8. Сюсюка В. Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція : дис. . . . д-ра мед. наук : 14. 01. 01 / Запорізьк. державн. мед. ун-т. Запоріжжя, 2018. 395 с.

9. Шинкарук Т. А. Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності. Здоров'я жінчини. 2018. № 1. С. 53-54

10. Шрамко І. А. Психологічне забезпечення соціальної підтримки жінок під час вагітності та грудного вигодовування : дис. к. психол. наук : 19. 00. 05 / Східноукраїн. національн. у-т імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2018, 220 с.

11. Юрченко В. М. Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини: дис. . . д-ра психол. наук. Рівне, 2009. 397 с.

12. Cochrane T. Eight dimensions for the emotions. Sage journals, 2009. № 48, p. 379–420.

ЧАСТИНА 3.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ У НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

РОЗДІЛИ:

3.1. Соціально-психологічні чинники емоційних станів внутрішньо переміщених осіб

Абдукарімова І. А.

Актуальність. Розуміння «емоційного стану» пов'язане з певною своєрідністю переживання та поведінки, яка виражається у психічній діяльності в цілому і впливає певний час на її динаміку та перебіг. Відомо, що емоційний стан охоплює «ключі», пов'язані з емоційною пам'яттю (минулим емоційним досвідом). Внутрішні і зовнішні подразники, діючи на людину, обумовлюють її психічний та емоційний стан, який може мати як позитивне, так і негативне забарвлення. Емоційні стани можуть позитивно впливати на виконувану діяльність, на процес спілкування, а можуть і дезорганізовувати їх, тобто здійснювати регулювальний вплив, оскільки виникнення того чи іншого стану пов'язане зі зміною діяльності, що, власне, і зумовило виділення такої категорії психічного, привернуло до неї увагу [1-3].

Проблема надання психологічної допомоги біженцям, переселенцям чи їх психологічного супроводу не нова для світу, проте є актуальною для українських фахівців. На відміну від добровільної зміни місця проживання (у пошуках, наприклад, покращення життєвих умов), у продовж 2022-2023 рр. українці переїжджають вимушено, як правило, внаслідок військових дій. Початковий конфлікт між відсутністю позитивної мотивації до переїзду і фізичною неможли-

вістю подальшого перебування на малій батьківщині, травматизація психіки, обумовлена причинами та історією міграції, а також труднощі адаптації на новому місці визначають формування вельми специфічного досвіду вимушених переселенців, який виходить за рамки звичайного і повсякденного [4, 5]. Незважаючи на гостроту проблеми і широку поширеність граничних форм невротичних розладів у вимушених переселенців, їх соціальної дезадаптації, досліджень по темі особливостей емоційних станів вимушених переселенців та порушень соціально-психологічної адаптації, недостатньо. Ключове значення у зв'язку з цим набувають дослідження псих-емоційних станів, процесів, що відбуваються з особистістю, яка вимушено змінює своє колишнє соціокультурне середовище, їх вплив на психічне здоров'я, процеси адаптації особистості до кардинальних змін у нових для неї умовах. У сучасній науковій літературі існують дослідження, присвячені вивченню мігрантів (зовнішніх та внутрішніх) та особливостей їх адаптації та взаємодії з населенням приймаючої сторони. Маловивченими залишаються їх емоційні стани. Так само маловивченою категорією залишаються вимушені переселенці у зв'язку з бойовими діями всередині країни.

Мета. Здійснити комплексне емпіричне дослідження емоційних станів внутрішньо переміщених осіб. Дослідження проводилося на базі «Українського Інституту Прикладної Психології та Психотерапії» (ТОВ «УППП»).

У дослідженні прийняло участь 86 осіб, чоловічої та жіночої статі, віком від 25 до 45 років. Дані досліджувані вимушені були переїхати із зони бойових дій в Україні. В роботі використовувався якісний та кількісний аналіз отриманих результатів а також методи математичної статистики. Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано такі методи: теоретичні (аналіз наукових розробок проблематики емоційного вигорання); емпіричні: бесіда, спостереження (для з'ясування біографічних даних досліджуваних та особливостей прояву емоційних станів). Комплекс психодіагностичних методик: 1. Методика дослідження концентрації уваги; 2. Дослідження тривожності (Спілбергер-Ханін); 3. Методика дослідження емоційного відгукування (А. Міхраб'єн); 4. Методика дослідження самопочуття, активності, настрою (САН).

Результати дослідження. Рівень концентрації уваги до психологічного впливу на внутрішньо переміщених осіб був наступним. Дуже низький рівень спостерігався у 16 осіб, низький рівень у 20, середній рівень виявився у 36 внутрішньо переміщених осіб, високий рівень у 6 досліджуваних та жодного дуже високого рівня. Концентрація – це зосередженість, тобто центральний факт, в якому висловлюється увагу. Концентрованість уваги означає, що є фокус, в якому зібрана психічна або свідомо діяльність. Увага характеризується зосередженістю на конкретному об'єкті психічної діяльності, має певну інтенсивність, а отже певний ступінь концентрації. Чим сильніше зосередження, тим більше внаслідок негативної індукції гальмується дія побічних подразників, тим цілеспрямованою й продуктивнішою стає сама діяльність [6]. В результаті психологічних впливів та проведення повторного збору емпіричних даних отримали дуже низький рівень у 3 досліджуваних, низький рівень у 10 осіб, середній рівень концентрації уваги у 24 осіб, високий рівень у 42 особи та дуже високий рівень у 4 досліджуваних. Зосередженість уваги та її стійкість у процесі діяльності порушувалися: сила і тривалість зменшувалися, увага слабшає, людина відволікається від об'єкта діяльності. Відволікання настає тоді, коли відсутні чинники, які сприяють зосередженості та стійкості уваги, у випадку внутрішньо переміщених осіб це тяжкі життєві обставини. Порівняльні показники рівня концентрації уваги до та після психологічних впливів представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Порівняльні показники рівня концентрації уваги до та після психологічних впливів

Рівень концен-трації уваги	Результати на початок дослідження (до психологічних впливів)		Результати на кінець дослідження (після психологічних впливів)	
	N	%	N	%
Дуже низький	16	19,0	6	7,0
Низький	20	23,0	10	12,0
Середній	38	44,0	24	28,0
Високий	12	14,0	42	49,0
Дуже високий	-	-	4	5,0

Концентрація уваги – це не зупинка думок на одній точці, а їх рух в єдиному напрямку. Для того щоб увага особистості до якогось-небудь предмету підтримувалася, його усвідомлення повинне бути динамічним процесом. Людина повинна на наших очах розвиватися, виявляти перед собою все новий зміст. Лише те що змінюється і оновлюється здатне підтримувати увагу. Одноманітність притупляє увагу, монотонність вгашає її [6-9]. У випадку для вимушених переселенців це є пагубним та спричиняє затяжні депресивні стани. Події, які примушують людей залишати свої домівки, настільки виходять за межі нормального життя, що переживаються як надзвичайно стресові для всіх, хто опинився в таких ситуаціях (незважаючи на те, чи від'їжджали вони через тривожні відчуття, чи через реальну загрозу життю під час розгортання військових дій). Психологи так само мають зважати на те, що переселенці опиняються у таких стресових умовах щонайменше декілька разів: до переселення, під час переселення і після свого переселення.

За результатами оцінювання досліджено рівень особистісної та реактивної тривожності вимушених переселенців за допомогою методики Спілбергера-Ханіна [10] до психологічних впливів на вимушених переселенців та після. Особистісна тривожність – підвищена схильність до переживань тривоги і занепокоєння без достатніх підстав [7, 8]. Низький рівень такої тривожності спостерігався у 36 досліджуваних до початку психологічних впливів та у 56 після. Середній рівень був притаманний 30 та 18 досліджуваним на першому та другому етапі дослідження відповідно. Високий рівень особистісної тривожності характерний для 18 вимушених переселенців до комплексної психологічної роботи та 10 після. Особистісна тривожність – це стійка індивідуальна особливість людини, що характеризує її тенденцію сприймати певний діапазон ситуацій як загрозливих, небезпечних для самооцінки і самоповаги [9]. Показники рівня особистісної тривожності до та після психологічних впливів представлено у рис. 1 та 2. Реактивна тривожність як стан характеризується суб'єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію [8]. Низький рівень реактивної тривожності спостерігається у 3 досліджуваних на початку та у 18 на кінець дослідження. Середній рівень реактивної тривож-

ності був притаманний 24 досліджуваним на першому етапі та 42 на другому етапі дослідження. До психологічних впливів високий рівень реактивної тривожності притаманний 58 досліджуваним, після – 26 вимушеним переселенцям.

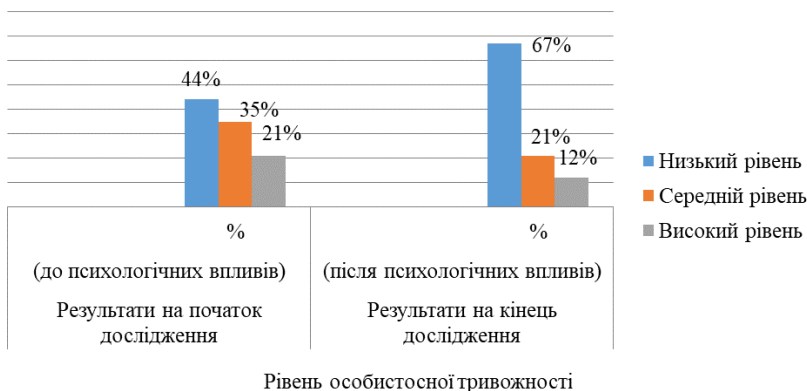


Рис. 1. Показники рівня особистісної тривожності до та після психологічних впливів

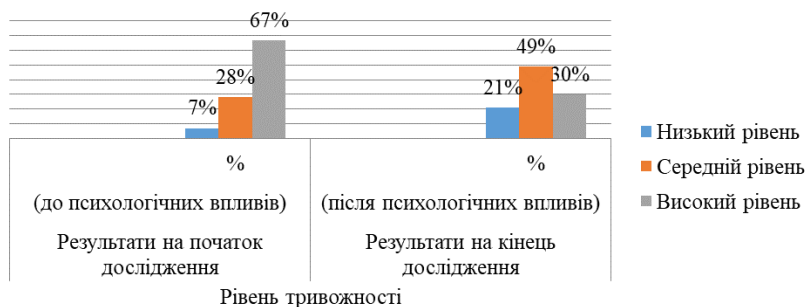


Рис. 2. Показники рівня реактивної тривожності до та після психологічних впливів

Виявлено, що особистості з високою тривожністю схильні сприймати загрозу самооцінці і життєдіяльності та реагувати вираженим станом тривоги. Високий рівень особистісної тривожності дає підставу прогнозувати виникнення станів тривожного

ряду в різноманітних ситуаціях, пов'язаних з оцінкою компетенції і престижу. Ті, хто отримує підтримку, відчують менші наслідки від шоку, тому на першому місці має стояти соціально-психологічна допомога, і саме комплексний підхід у роботі з вимушеними переселенцями у всіх закладах куди вони звертаються.

В рамках комплексного підходу до дослідження особливості емоційних психічних станів внутрішньо переміщених осіб проведено дослідження емоційного відшукування. Високі показники свідчать про особистість, якій характерна поступливість, готовність прощати інших окрім себе, готовність виконувати рутинну роботу. Такі люди емоційні, менш агресивні, схильні надавати допомогу, мають афіліативну поведінку (прагнення бути в товаристві інших людей, потреба у спілкуванні, у здійсненні емоційних контактів, у проявах дружби та любові»). Дуже високі показники на початку та кінці дослідження були у 6 досліджуваних. Високий рівень емоційного відшукування мали 18 та 14 вимушених переселенців до психологічного впливу та після відповідно. Середній, або нормальний рівень, притаманний 14 досліджуваним на першому етапі та 36 досліджуваним внаслідок психологічної роботи з вимушеними переселенцями. Такі люди зазвичай судять інших за звичками, добре контролюють власні емоції. Низький та дуже низький рівень виявився у 26 та 16 досліджуваних до початку психологічних впливів, та 18 та 6 досліджуваних в результаті комплексної соціально-психологічної роботи з досліджуваною групою. Такі досліджувані відчують дискомфорт у великій компанії, мають труднощі у встановленні контактів. Показники рівня емоційного відгук до та після психологічних впливів представлено на рис. 3.

В процесі комплексного дослідження вимушених переселенців досліджено самопочуття, активність та настрої за методикою САН. На початку дослідження низький рівень спостерігався у 62 осіб, а наприкінці цей показник зріс вдвічі, і високий рівень самопочуття відчувало 70,0 %. Порівняльні показники рівня самопочуття до та після психологічних впливів представлено на рис. 4.

Самопочуття – загальний психічний показник тілесного і духовного стану в кожний даний момент; складається з конкретних відчуттів і загальних почувань. Самопочуття тісно пов'язано з самозбереженням індивіда: воно нагадує організму його потреби і вказує йому на загрозові небезпеки [9]. Активність до психо-

логічних впливів була переважно низькою у 70 досліджуваних, в кінці дослідження переважна більшість вимушених переселенців мали високий рівень активності – 70,0 %. Активність людини є джерелом її розвитку, визначає діяльність і є її рушійною силою.

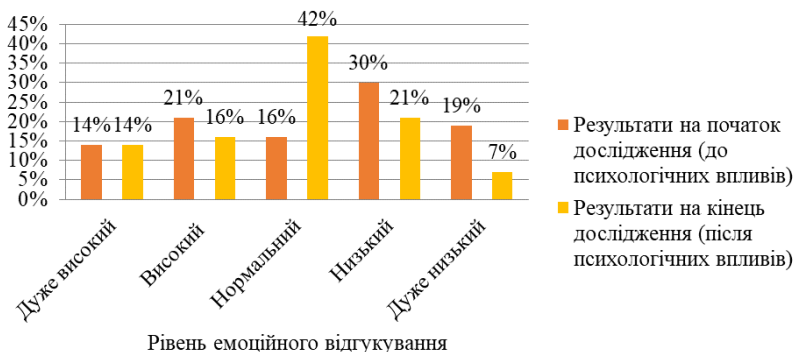


Рис. 3. Показники рівня емоційного відгук до та після психологічних впливів

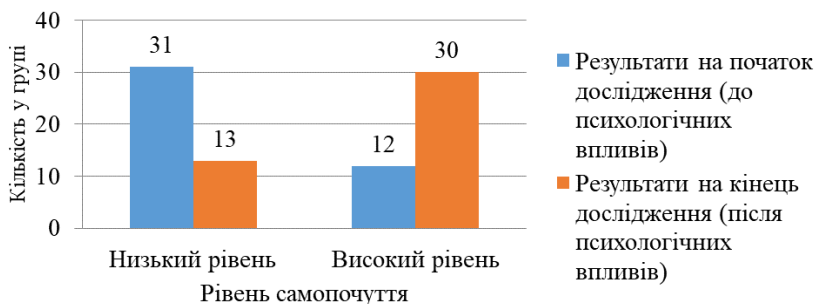


Рис. 4. Порівняльні показники рівня самопочуття до та після психологічних впливів

Принципова відмінність між цими поняттями полягає в тому, що діяльність виходить із потреби в предметі, а активність – із потреби в діяльності. До того ж, активність начебто передують діяльності в часі: до початку діяльності ми активно вибираємо, що саме бажано, вільно плануємо, думаємо, за допомогою яких засобів чогось досягти. Але активність не тільки передують діяльності,

а й «супроводжує» її протягом усього процесу. Не можна уявити оптимальну діяльність, позбавлену активності [9]. Порівняльні показники рівня активності до та після психологічних впливів представлено на рис. 5.

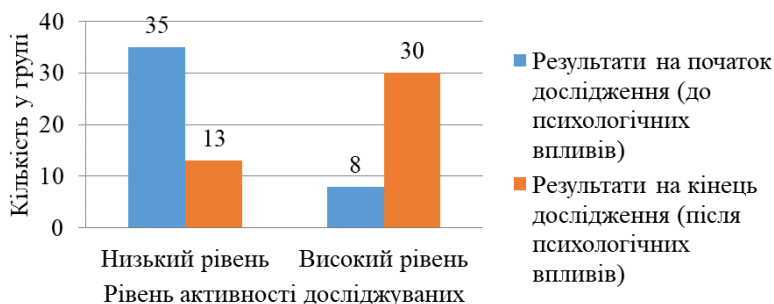


Рис. 5. Порівняльні показники рівня активності до та після психологічних впливів

Для переселенців вкрай важливо підняти рівень активності, від якого залежить швидка адаптація, пошук роботи, тощо. Рівень настрою до психологічних впливів у переважної більшості досліджуваних також був низький – 91,0 %. Внаслідок комплексної роботи та психологічних впливів у 65,0 % досліджуваних виявлено високий рівень настрою. Настрій – загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус [7]. Розрізняють позитивні настрої, які виявляються у бадьорості, та негативні, які пригнічують, демобілізують, викликають пасивність. Настрій – загальний емоційний стан, який виразно не спрямований на щось конкретне. Причини настроїв найрізноманітніші: невідповідність до діяльності, страх перед очікуваною невдачею, хворобливі стани, і приємні звістки тощо [5]. Порівняльні показники рівня настрою до та після психологічних впливів представлено у рис. 6.

Комплексний соціально-психологічний підхід до роботи з внутрішньо переміщеними особами в цілому дав позитивні зміни в особливостях психічних станів. Особи, які отримували психологічну допомогу, знайшли нові способи себе реалізовувати, проявляти інші зацікавлення, більше адаптувалися у місцевих громадах.

Виявлено зниження рівня тривоги, стабілізацію емоційного стану, покращення стосунків з близькими, підвищення рівня здатності приймати рішення і планувати майбутнє, вміння розрізняти почуття, знаходити способи їх вираження, переживати втрати. Встановлено зріст актуальності психологічної допомоги через загальну втому та психічне виснаження вимушено переміщених осіб, що виникли внаслідок тривалого (більше року) перебування у невідповідних, некомфортних умовах життя, під тиском великої кількості стресових факторів, у стані пережиття горя та втрати. Більшість соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб залишаються актуальними і сьогодні – проблеми житла та його оплати, інтеграції в місцевому суспільстві тощо.



Рис. 6. Порівняльні показники рівня настрою до та після психологічних впливів

Висновки. За результатами дослідження розглянуті особливості емоційних станів, виявлена сутність різної адаптації, у тому числі психічної, соціальної, соціально-психологічної. Встановлено, що існує взаємозв'язок у сприйнятті особистістю змін нового середовища у ситуації вимушеного переселення та особливостями психічних станів вимушених переселенців. На психологічну адаптацію вимушених мігрантів впливають такі фактори, як: соціально-економічний статус, матеріальне благополуччя, перспективи самореалізації, приналежність до нової соціальної групи і стабільність ситуації, які надають різнопланово вплив на психологічне здоров'я переселенця. З результатами емпіричного дослідження до

комплексної психологічної роботи з вимушеними переселенцями у досліджуваних спостерігався: середній рівень концентрації уваги у 44,0 % досліджуваних, 44,0 % досліджуваних мали низький рівень особистісної тривожності, у 67,0 % вимушених переселенців була висока реактивна тривожність, 30,0 % людей мали низький рівень емоційного відгукування. Після комплексної роботи можна відзначити, що високий рівень концентрації уваги прослідковувався вже у 49,0 % досліджуваних, у 67,0 % виявився низький рівень особистісної тривожності, 49,0 % вимушених переселенців проявили середній рівень реактивної тривожності, 42,0 % – нормальний рівень емоційного відгукування. Окрім того, до дослідження у вимушених переселенців виявився низькі рівні самопочуття, активності та настрою – 72,0 %, 81,0 % та 91,0 % відповідно. Після впливів було відмічено, що дані рівні зросли до високого у 70,0 %, 70,0 % та 65,0 % досліджуваних відповідно показникам САН.

Психологічна допомога тимчасово переселеним особам повинна бути своєчасною, обов'язково комплексною та індивідуальною. Власний досвід роботи з переселенцями дає змогу визначити головні функції психолога: допомога у психологічній та соціальній адаптації. Травматична ситуація переселення спричинила зміни у психічних станах людей, що змінили їх поведінку. Тому й підходи у подоланні психологічних труднощів мають бути індивідуальними у кожному конкретному випадку. Розуміння емоційних станів переселенців визначає завдання психологічної роботи з ними: опрацювання та переосмислення травми, формування нового погляду на подальше життя, що призводить до формування їх нових цілей, цінностей і сенсу, пошуку відповідних ресурсів.

Література.

1. Протокол з діагностики та терапії ПТСР Національного інституту клінічної майстерності Великобританії (NICE). – [http:// guidance. nice. org. uk/cg26](http://guidance.nice.org.uk/cg26)

2. Оверченко А. І. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. [Текст] / Оверченко А. І. – К. : Нац акад. внутр. справ., 2014. – 177 с.

3. Синопис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія

«Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). – Львів: Видавництво Українського католиц. універ., 2014. – 112 с.

4. Посттравматичні стресові розлади: діагностика, лікування, реабілітація/ П. В. Волошин, Л. Ф. Шестопалова, В. С. Підкоритов, Н. О. Марута, А. М. Бачеріков, Методичні рекомендації. – Київ – ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». 2014. – 67 с.

5. Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій: Збірник статей / Науковий редактор випуску Т. М. Титаренко. – Київ, 2015. – 150 с.

6. Техніки психотерапії при ПТСР: Практичний посібник/О. Г. Сиропятов, Н. А. Деружинська. – Київ: Українська військово-медична академія, 2014. – 144 с.

7. Блінова М. С. Сучасні соціологічні теорії міграції населення: Перевидання / М. С. Блінова; під. ред. В. І. Добренькова. – К. : КДУ, 2014. – 160 с.

8. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. – Київ, 2018. – 236 с.

9. Ложкін Г. В. Психологія: терміни, поняття, визначення: Словник-довідник / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник. – Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 188 с.

10. Райгородський Д. Я. Практична психодіагностика/Д. Я. Райгородський: Методики та тести: [навчальний посібник]. – С: Вид. Дім «БАХ-РАХ», 1998. – 672 с.

3.2. Групове консультування у психологічному супроводі внутрішньо переміщених осіб з відновлення працевлаштування

Бегеза Л. Є.

Актуальність. Сьогодні у час соціальних та економічних криз, збройних і військових катаклізмів, впливу військових дій, та пов'язаних з ними стресів, – усе це стає факторами, що викликають негативні емоцій та стани [1]. Емоції сигналізують про благополучний або неблагополучний розвиток подій, про визначеність становища особистості в системі його предметних і міжособистісних взаємин, забезпечує регулювання, корекцію поведінки людини в умовах спілкування, трудовій діяльності. Особливою категорією людей є внутрішньо переміщені особи у яких емоції по часту можуть діяти деструктивно на поведінку особистості в суспільстві порушуючи виконання соціальних ролей у тому числі працездатності. Такі особистості потребують особливого підходу при психологічному супроводі, проте групове консультування у внутрішньо переміщених осіб повинно базуватися на загальних етичних правилах консультування [2].

З такими особам *потрібно*: бути чесним і гідним довіри; поважати право людей самостійно приймати рішення; усвідомити і відкинути власні упередження та забобони; чітко дати людям зрозуміти, що, навіть, якщо вони відмовляються від допомоги зараз, вони можуть звернутися за нею в будь-який час, без обмежень; дотримуватися конфіденційності і не допускати необґрунтованого поширення отриманих від людини особистих даних; бути вимогливими, але не нав'язувати послуги, якщо людина відмовляється.

У свою чергу у спілкуванні із внутрішньо переміщеними особами *заборонено*: давати неправдиві обіцянки чи повідомляти недостовірні відомості; перебільшувати свої знання та навички; нав'язувати свою допомогу, поводитися наполегливо і безцеремонно; примушувати людей розповідати про те, що з ними сталося; поширювати отримані відомості особистого характеру; давати оцінки вчинкам і переживанням людей [2].

Треба враховувати, що психосоціальними наслідки внутрішнього переміщення може бути:

1. *Афективні прояви*: вибухова реакція, агресивність, депресія (зниження настрою, втрата здатності отримувати задоволення, байдужість), загальна тривожність, напади люті, перепади настрою, пасивність, злість та пошук «зовнішнього ворога» (хтось має за це заплатити), роздратованість, підвищена тривожність.

2. *Емоційні та волеві прояви*: притупленість емоцій (неможливість проявляти радість, горе, гнів тощо), збудливість, непрохані спогади, безсоння (труднощі із засинанням та уривчастий сон), відчуття незахищеності, стан жертви (прояв страждання, безпорадності, образи, негативне ставлення до усього почутого), сором, провини за те, що вижив.

3. *Порушення пам'яті, мислення, концентрації уваги*: неможливість запам'ятати інформацію та неможливість зосередитися, немотивована пильність, думки про самогубство, втрата автономності («Я не керую процесом. Мене кудись несе»), втрата суб'єктивності («Це не я приймаю рішення у своєму житті. Хтось це вирішує за мене»), порушення ідентичності (зв'язку особистості із соціумом, ототожнення людиною себе з певною суспільною групою), розгубленість (на рівні думок людина не може зосередитися і виконувати розумові завдання, до яких звикла), побоювання відторгнення, відсутність можливостей прогнозувати майбутнє, низька самооцінка.

4. *Порушення сприйняття*: галюцинаторні хвилювання (коли події, які травмують, спливають у пам'яті настільки яскраво, що реальні події теперішнього часу відходять на другий план),

5. *Поведінкові прояви*: зловживання алкогольними, наркотичними та лікарськими речовинами [2, 3].

Для ефективної комунікації з внутрішньо переміщеними особами треба дотримуватися наступних рекомендацій. *Доцільно* робити і говорити:

- бути поруч з людиною, але дотримуватися необхідної дистанції;
- обов'язково врахувати розташування стільця для клієнта (зручність, спиною до стіни);
- показувати своїм виглядом, що уважно слухаєте співрозмовника;
- бути терплячим і спокійним;

- надавати фактичну інформацію, якщо вона існує, чесно казати, про що знаєте, а чого не знаєте: «Я не знаю, але спробую для Вас дізнатися»;

- надавати інформацію так, щоб її легко було зрозуміти, простими словами, за потребою – повторити декілька разів спокійним тоном;

- висловлювати співчуття, коли людина говорить про свої почуття, втрату або важливі події (втрата будинку, смерть близької людини та т. ін.);

- відзначити докладені людиною зусилля, спрямовані на самотійний вихід із важкої ситуації;

- дати людині можливість помовчати у разі необхідності;

- розкажіть про успішні історії працевлаштування або започаткування власної справи інших учасників, внутрішньо переміщених осіб;

Заборонено робити і говорити:

- змушувати людину розповідати, що з нею відбулося і відбувається;

- перебивати, квапити співрозмовника (наприклад, не треба дивитися на годинник чи говорити занадто швидко);

- торкатися людини, якщо немає впевненості;

- говорити: «Ви не повинні себе так відчувати» або «Ви повинні радіти, що вижили», «Я Вас розумію»;

- починати фрази зі слів: «Ви повинні.... » – «взяти себе в руки», «знайти роботу», «забути, що відбулося»;

- вигадувати те, чого не знаєте;

- використовувати спеціальні терміни;

- давати помилкові обіцянки чи запевнення;

- передавати людині особисті розповіді, почуті від інших;

- розповідати про власні труднощі;

- думати і діяти так, немов зобов'язані розв'язати за людину всі її проблеми;

- позбавляти людину віри у власні сили і здатність самотійно дбати про себе;

- говорити про людей, використовуючи негативні епітети (наприклад, називати їх «божевільними»), не вступати у протиріччя, навіть аргументовано;

- не виправдовуватися перед людиною, якщо вона Вас звинувачує;

- не проявляти жалість – поглядом, діями, словами [2, 3].

Мета. Напрацювання навичок психологічної готовності, самомотивація до відновлення працездатності та сприяння поверненню на ринок праці внутрішньо переміщених осіб.

Результати дослідження. Розроблено програма «Групове консультування внутрішньо переміщених осіб з відновлення працевлаштування» [2]. Програма забезпечує формування наступних соціально-психологічних компетентностей: усвідомлення психо-соціальних проблем внутрішнього переміщення; вирішення власних психосоціальних проблем; соціалізація у ситуації внутрішнього переміщення. Структура консультування та групових занять за формою та методами навчання представлено у табл. 1., модульний зміст програми занять відображено у табл. 2.

Таблиця 1

Структура занять за формою та методах навчання

Форма навчання	% співвідношення	Метод викладання
Розв'язання модульного кейсу (Інтерактивні вправи)	40	Групове
Демонстрація, участь у дискусії	30	Групове
Особисті приклади	10	Індивідуальне
Навчання інших (негайне застосування знань)	10	Групове
Рефлексія	10	Інтерактивне навчання

У ході групової роботи [4] визначено наступні принципи взаємодії:

1. Емпатійне ставлення до всіх учасників групи;
2. Толерування невизначеності (в групі можуть бути присутні учасники, які тривалий час не будуть готові надати ніякої особистої інформації);
3. Конфіденційність (жодна інформація не може бути винесена за межі групи, окрім тієї, на яку дала дозвіл особа, що її ця інформація стосується);
4. Зворотній зв'язок;
5. Принцип активності (відсутність примусу як щодо комунікації, так і стосовно необхідності різко припинити комунікацію);

Таблиця 2

Модульний зміст програми занять

Модульний кейс	Σ			
Обговорення психологічних опорів, що перешкоджають поверненню на ринок праці	30	10	10	10
Практики розвитку психологічної готовності до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	30	10	10	10
Практичні навички самомотивації до пошуку роботи та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	30	10	10	10
Усього хвилин	1. 30	30	30	30
Примітки: Σ – усього;  – модульні кейси;  – робота з групами;  – зворотній зв'язок				

6. Непоспівність (оскільки різним учасникам групи потрібен різний час для знайомства, адаптації та включення у групову взаємодію);

7. Усвідомлення учасниками групи, що відповідальність за їхні зміни, в першу чергу, лежить на них.

Алгоритм групової консультації передбачав роботу консультанта та клієнта у сім етапів:

1. Знайомство, встановлення контакту;
2. Ідентифікація запиту (збір інформації та оцінка потреб);
3. Оцінка ресурсів клієнта у вирішенні проблем;
4. Визначення кроків та планування вирішення проблеми;
5. Реалізація запланованих заходів;
6. Перегляд та оцінювання результатів роботи;
7. Завершення взаємодії з консультантом

Змістовно «Групове консультування внутрішньо переміщених осіб з відновлення працевлаштування» [2]. включає наступне теоретичне та практичне наповнення.

Модульний кейс 1. Обговорення психологічних опорів, що заважають поверненню на ринок праці (табл. 3).

Таблиця 3

Психологічні опіри та поведінка у їх подоланні

Види бар'єрів	Поведінка у вирішенні бар'єрів
Фізичні	1
	2
	3
Інформаційні	4
	5
	6
Економічні	7
	8
	9
Інституційні	10
	11
	12
Психологічні	13
	14
	15

Модульний кейс 2. Практики розвитку психологічної готовності до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (табл. 4).

Таблиця 4

Розвиток психологічної готовності

Ціль/ мета/ бажан- ня	Навіщо?		Що?	Як?	
	Наві- що ця мета?	Пріори- тети	Ресурси для до- сягнення	Ваші дії, для до- сягнення мети	Допомога для досяг- нення мети
1					
2					
3					
4					
5					

Примітки.

I. Напишіть 5 цілей/бажань

II. Напишіть, що вам дасть досягнення цієї мети

III. Визначити пріоритети. Визначте, яка ціль ви будете реалізовувати в першу чергу, другу ... Навпроти кожної цілі поставте цифри від 1 до 5. Де 1 – першочергова мета...

IV. Ресурси для досягнення мети. Дайте відповідь на запитання: «Які є у вас ресурси для досягнення мети?»

V. Дії, для досягнення мети. Вкажіть конкретні дії, які ви будете робити для досягнення мети

VI. Допомога для досягнення мети

VII. Що в результаті ви отримаєте при досягненні мети.

Модульний кейс 3. Практичні навички самомотивації до пошуку роботи та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (табл. 5).

Таблиця 5

Розвиток психологічної готовності

7 кроків постановки і досягнення мети – працевлаштування:	
Кроки	Ваша відповідь
перший: чітко вирішіть для себе, ким я божу працювати	
другий: запишіть це чітко та детально	
третій: встановіть терміни. Якщо мета велика, вимагає тривалого часу або складається з багатьох етапів, встановіть проміжні терміни	
четвертий: складіть список всього, що ви вважаєте необхідним для досягнення мети – працевлаштування	
п'ятий: перетворіть свій список в план, організований за пріоритетами і по черговості дій	
шостий: негайно приступайте до дій згідно плану. Не відкладайте	
сьомий: щодня робіть хоч якусь дрібничку, що наближає вас до вашої мети	

Треба пам'ятати, що важливим аспектом самомотивації є фіксація власних результатів. Для цього вартує їх записувати. Виявляється, на кожне «так» в нашому житті ми часто чуємо 18 разів «ні»; а наш мозок в 11 разів довше і повільніше обробляє всі неприємні ситуації, які з нами трапляються. Виходить, що мозок краще запам'ятовує всі невдачі, помилки, неприємні ситуації, ніж успіх і щасливі моменти! Через це людина починає себе недооцінювати, страждає впевне-

ність у собі, сприймаємо себе невдахою. Щодня власноруч фіксуєте не менше 5 речей, які Ви зробили і при цьому Ви залишилися задоволені собою! Це може бути будь-яка ситуація чи річ, що викликала у Вас приємні емоції. Через деякий час ви помітите, що у Вас підвищитися мотивація і бажання чогось досягати. А в той день, коли настрій поганий чи опустяться руки, перелічування додасть наснаги, Ви станете більш впевненим у собі, ваша самооцінка підвищитися. Ви також відчуєте, що контролюєте досягнення власних цілей, та, зрештою, концентруєтеся на досягненнях!

Для перевірки та оцінки зміни у динаміці для внутрішньо переміщених осіб доцільно використовувати «Тест оцінки зміни внутрішньої мотивації» (С. М. Панченко) [2, 5], якій оцінює рівень внутрішньої мотивації як: високий (1-5 балів) з визначенням проблемних областей життя на сьогодні, які вимагають втручання; середній (6-9 балів) – успіхи занадто непостійні. досягнення змінюються низкою уповільнених нудних подій, які переходять у повну апатію і незадоволеність; дуже низький (10-15 балів) – те, чим ви займаєтеся, не приносить вам ні радості ні серйозних результатів. Цілі, які ви досягаєте – в основному «чужі» для Вас і не узгоджені з вашими цінностями. Треба відповісти на запитання «Чому ви все ще займаєтеся тим, чим займаєтеся? Навіщо ви все це робите?».

Висновки. Узагальнюючі результати дослідження можна зазначити, що надання психосоціальних послуг внутрішньо переміщеним особам з метою відновлення їх працездатності та сприяння поверненню на ринок праці може базуватися на розробленій програмі «Групове консультування внутрішньо переміщених осіб з відновлення працевлаштування». Зміст програми у вигляді модульних кейсів дозволяє розвинути психологічну готовність до повернення на ринок праці та відновити впевненість внутрішньо переміщених осіб у власній працездатності. Програма сприяє поверненню внутрішньо переміщених осіб на ринок праці та відбудові психосоціальних навичок самомотивації.

Ключові слова: особистість, ринок праці, психосоціальний, внутрішньо переміщені особи, мотивація, професійний розвиток, психологічна готовність, емоційний стан, комунікація, консультування, психологічні детермінанти, працевлаштування, стресогенність.

Література.

1. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov A. Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war // *Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment* – 2023. – V. 11, № 1. – P. 36–46. <https://doi.org/10.6000/2292-2598>. 2023. 11. 01. 5
2. Приб Г. А., Берега Л. Є. Психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб // Київ, АПСВТ. 2023. 21 с. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19663.87204>
3. Практичний посібник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і внутрішньо переміщеними особами: соціально-психологічний аспект / Г. А. Приб, Н. В. Ортікова. К. : ІПК ДСЗУ, 2018. 21 с.
4. Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н., Запорожець О., Климишин О., Креймейер Д., Мокроусова А., Пророк Н., Сиротич Н., Сіренко Т., Царенко Л., Шапошник Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.
5. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с.

3.3. Психоемоційна сфера та психічне здоров'я особистості в умовах життєвих викликів: вітчизняний та європейський досвід

*Бегеза Л. Є., Бичук М. І., Камалов В. Ш.,
Шиманський О. П., Янушевський А. О.*

Актуальність. В наш досить напружений час катаклізмів, політичних і економічних криз, стресів, безробіття, різких змін на тлі швидкого розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій на роботі не можливо вберегтися від негативних емоцій. Емоції – це різноманітні переживання людини, в яких відображаються її життєві відносини із зовнішнім світом та іншими людьми. Емоції є одним із головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності й поведінки, спрямованих на задоволення актуальних потреб.

Мета. Дослідити психоемоційну сферу особистості в умовах життєвих викликів.

Результати дослідження. Емоції сигналізують про благополучний або неблагополучний розвиток подій, про визначеність становища людини в системі його предметних і міжособистісних взаємин і забезпечує регулювання, корекцію її поведінки в умовах спілкування та діяльності. Деякі з емоцій можуть діяти вкрай деструктивно на поведінку людини в суспільстві, тому кожній людині необхідно навчитися керувати емоціями, не дозволяти їм руйнувати міжособистісні відносини людини в соціумі.

У ХХІ столітті, яке деякі вчені-психологи називають «віком меланхолії», адаптуватися особистості допоможе не лише розуміння ситуації та адекватне сприйняття дійсності, а насамперед вміння управляти своїми емоціями, що дозволить подолати надмірний стрес на роботі та вберегтися від багатьох хвороб.

Існує багато термінів, пов'язаних з управлінням емоціями: емоційна регуляція, афективна регуляція, управління настроєм, управління стресом, стратегії допінгу.

Вивчення феномену управління емоціями за радянських часів відбувалося традиційно у зв'язку з дослідженням проблеми емоційної стійкості (Л. М. Аболін, Л. І. Бучек, В. Л. Маришук, О. Я. Чебикін, А. І. Черкашин). В сучасній психології, залежно від методологічних позицій, поняття «управління емоціями» розглядається у наступному значенні: 1) як загальна емоційна здібність; 2) як структурний компонент емоційного інтелекту. В межах першого підходу частіше використовується поняття «емоційна регуляція», при цьому диференціюються два компоненти: внутрішня емоційна регуляція (як «саморегуляція») та зовнішня емоційна регуляція (як «контроль експресії»). При другому підході використовується власне поняття «управління емоціями», яке, переважно, інтерпретується як трьох компонентний конструкт: управління власними емоціями, їх вираженням, та управління емоціями інших людей. Управління власними емоціями визначається як здатність і потреба керувати власними емоціями, викликати і підтримувати бажані емоції і контролювати небажані емоції. Контроль експресії інтерпретується як здатність контролювати зовнішні прояви власних емоцій; як здатність адекватно та повно демонструвати власні почуття, і при цьому здатність відверто виражати себе. Управління емоціями визначається як «зараження емоціями» (Д. Гоулмен), як здатність викликати у інших людей ті, або інші емоції, знижувати інтенсивність небажаних емоцій; схильність до маніпулювання іншими (Д. В. Люсін), як вміння зовнішньо виражати власний емоційний стан з метою впливати на партнера по спілкуванню (М. О. Манойлова).

Слід відзначити, що поняття «управління емоціями інших» є мало дослідженим в сучасній психології. Недостатньо науково обґрунтованих даних щодо перебігу процесу управління емоціями інших, прийомів управління. Деякі аспекти феномену управління емоціями інших розкрито у зв'язку з лідерським впливом (Дж. Морено), маніпулятивною поведінкою (О. В. Сидоренко), застосуванням емоційних інграм (В. В. Бойко).

В останніх дослідженнях управління емоціями інших, як регулятивний компонент емоційного інтелекту, пов'язується з емоційною фасилитивністю, як схильністю до емоційної підтримки

інших людей; з реціпрокністю, як готовністю людини віддячувати «добром на добро» і «злом на зло».

Складові управління емоціями розподіляються за горизонтальною та вертикальною структурою. Варто виділити два моменти:

- по-перше, залежно від теоретичних позицій, у структурі управління емоціями дослідники виокремлюють різні складові і у різній кількості;

- по-друге, кожен з дослідників вкладає власне значення у розуміння здатності до управління емоціями.

Загалом, можна прослідкувати два підходи щодо структурування управління емоціями: інтегративний підхід, коли виокремлюється не більше двох складових (Д. В. Люсін, М. О. Манойлова, М. А. Нгуен та ін.), та парціальний підхід, при якому пропонується розгалужена система складових (Р. Бар-Он, Д. Гоулмен, Г. В. Юсупова).

Процес управління емоціями. На підставі теоретичного аналізу літературних джерел можна умовно виокремити два основні етапи в процесі управління емоціями: рефлексія та активізація. Рефлексія є закономірним етапом процесу довільного управління емоціями. Виявляється у фіксації та усвідомленості емоційних переживань. І. М. Андрєєва вважає, що усвідомлення є своєрідним засобом управління емоціями, що процесуально складається з усвідомлення себе як суб'єкта переживання емоцій та усвідомлення цього переживання як об'єкту аналізу. Вчена пов'язує усвідомлення емоцій з їх ідентифікацією, оскільки вербалізація власного емоційного стану знижує інтенсивність емоційного переживання. А. Ленгле запропонував двох позиційну концепцію усвідомлення емоційних переживань: позиція усвідомлення на зовнішньому рівні (аналіз ситуації) і позиція усвідомлення на внутрішньому рівні (аналіз емоцій).

Основний сенс рефлексивної стадії управління емоціями – емоційні переживання повинні бути осмислені. Активізація, як послідовний етап довільного або мимовільного управління емоціями, пов'язана з вибором регулятивних стратегій та прийомів. Основним засобом активізації управління емоціями за І. М. Андрєєвою є розширення, або обмеження потоку емоційної інформації: захисна стратегія, яка обмежує емоційний досвід, супроводжується думками за типом «я не реаую»; думки «дізнаюся про це більше», «Відкрий

для себе це почуття» тощо., свідчать про відкритість свідомості для емоційних переживань, а це сприяє збагаченню емоційного досвіду.

Емоційно-регулятивні стратегії класифікуються залежно від їх спрямованості:

- на життєву ситуацію (інтерспрямовані регулятивні стратегії);
- в «середину», на особистість (інтроспрямовані регулятивні стратегії);
- «на зовні», на спілкування (екстраспрямовані регулятивні стратегії).

Прийоми управління емоціями та змістовні характеристики регулятивних стратегій розкривають змістовні аспекти стратегій та прийомів управління емоціями щодо особливостей їх функціонування, можливостей розвитку та застосування. Поряд із тим, нез'ясованими залишаються наступні питання:

- віковий аспект – з якого віку відбувається цілеспрямоване навчання стратегіям, і якими є вікові особливості навчання?
- особистісний аспект – які зі регулятивних стратегій застосовуються у довільній формі, а які у мимовільній, і як вони співвідносяться з реагуванням у формі психологічного захисту?

Недостатньо науково обґрунтованих тренінгових програм, спрямованих на розвиток стратегій управління конкретними деструктивними емоціями (страх, ненависть, заздрощі). В репрезентованих тренінгових розробках не вистачає переконливих даних щодо ефективності тренінгових впливів.

Деструктивні явища управління емоціями. У зв'язку з процесом управління емоціями відомі явища: «дистресовий стереотип» (Х. Дженкінс), «теплова смерть почуттів» (К. Лоренц), «шокові емоції» (П. Жане), «холодна поза». Феномен «дистресовий стереотип» – переживання емоцій та почуттів, неадекватних ситуації, внаслідок актуалізації минулого дистресового досвіду (як правило, з глибокого дитинства). Феномен «теплова смерть почуттів» – тривале переживання нудьги, втрата інтересу до життя, внаслідок перенасичення приємними враженнями від задоволеності бажань. Феномен «шокові емоції» – примітивізація поведінки під впливом дезорганізуючих емоцій в ситуації емоційної кризи. Феномен «холодна поза» – характеризується емоційною грубістю, яка ви-

являється у навмисному демонструванні емоційної невразливості, у культивуванні проявів гніву, гордощів та недовіри.

Узагальнюючі можна зазначити, що в сучасному суспільстві не існує таких сфер діяльності людини, де б вона не підпадала під вплив – оточення, соціуму, найближчої людини, громадської думки, рекламної акції, чи заздалегідь спланованої політичної кампанії. В силу того, що людина є соціальною істотою, і вона постійно перебуває у соціумі, спілкується з іншими людьми за допомогою вербальних чи невербальних засобів комунікації, вона сама здійснює вплив на оточуючих, так само як і вони впливають на свідомість цієї особистості.

Під міжособистісним впливом розуміється процес і результат зміни одним індивідом поведінки іншої людини, її установок, намірів, уявлень, оцінок та ін. В ході аналізу особливостей психологічного впливу було з'ясовано, що серед його способів виділяються найбільш поширені – переконання, зараження, навіювання наслідування. Найвідомішими методами психологічного впливу на людину є посилення на авторитет, посилення на анонімний авторитет, навішування ярликів, технологія залякування, відволікання уваги, нейролінгвістичне програмування» тощо.

Висновки. У кожної людини є право впливати на іншу у процесі взаємодії, і не піддаватися на вплив іншої людини. Так, під час впливу людина висловлює свої почуття та стверджує свою цінність.

Крім особистого впливу на свідомість людини варто звернути увагу на те, як впливає оточення на масову свідомість, яка є одним із видів суспільної свідомості, найбільш реальною формою її практичного існування та втілення. Це особливий, специфічний вид суспільної свідомості, який характерний неструктурованій кількості людей – масам. В масовій свідомості відбиваються знання, уявлення, норми, цінності та зразки поведінки, які притаманні з тих чи інших обставин сукупності індивідів – масам. Вони з'являються в процесі спілкування людей між собою і спільного сприйняття ними соціально-політичної інформації. Масова свідомість – специфічний тип суспільної свідомості. Вона має розгалужені зв'язки з іншими сферами та рівнями суспільної свідомості. Їй властиво вбирати в себе продукти всіх цих сфер, черпати свій зміст із ідеології, науки, художньої творчості, буденних емпіричних уявлень.

Так само, як індивідуальна, так і масова свідомість підкоряється впливу оточення, і найбільшими загрозами соціального середовища в даному випадку є засоби масової інформації – телебачення, радіомовлення, Інтернет-засоби, рекламні кампанії, політичні акції та ін. Велике значення для масової свідомості має конструктивність впливу, яка полягає у вихованні підростаючого покоління на якісних зразках соціально схвалюваної поведінки, навчання дітей знанням про оточуючий світ. Але, на жаль, частіше психологічний вплив на індивідуальну та масову свідомість має деструктивний характер.

Література.

1. Зливков В. Л., Лукомська С. О., Федан О. В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях 2016р
2. Ларіна Т. О. Життєстійкість як життєве завдання особистості / Актуальні проблеми психології: Психологічна герменевтика / За ред. Н. В. Чепелевої. – К. :ДП «Інформаційно-аналітичк агентство», 2007. – Том 2, вип. 5. – с. 131-138.
3. Маннапова Е. Р Роль життєстійкості у подоланні складних життєвих ситуацій. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1, Т. 2. С. 75-78.

3.4. Теоретичне вивчення проявів психосоматичних розладів у молоді

Воронцова І. М.

Актуальність. Проблема психосоматичних розладів суттєво загострилася після початку повномасштабної війни, яка в Україні стала найтяжчим випробуванням за всю історію її незалежного існування. Війна є екстремальною ситуацією, тобто такою, що виходить за межі звичайного, нормального, людського досвіду. Для окремих людей, в тому числі представників молодого покоління, ця ситуація є гіперекстремальною: внутрішні навантаження, які вона викликає, часто перевищують можливості людського організму, руйнують звичну поведінку, можуть спричинити небезпечні наслідки для здоров'я. Такі чинники, як бойові дії на території нашої країни, систематичні ракетні та артилерійські обстріли, бомбові удари, перебування в окупації, значно підвищують уразливість молодих людей до психосоціального стресу, сприяють поширенню психосоматичних розладів тощо. Психосоматичні розлади позначаються на діяльності вегетативної нервової системи, що може викликати різну неврологічну симптоматику. Як правило, подібні порушення супроводжують тривога, симптоми депресії, іпохондрія, астенія, що позначається працездатності людини. Це створює серйозні виклики як для держави, так і суспільства в цілому.

Мета. Теоретично визначити прояви психосоматичних розладів у молоді та обґрунтувати їх специфіку.

Результати дослідження. У сучасній медичній науці, як вказують Л. Перетятко та М. Тесленко, під психосоматичними розладами розуміють групу хворобливих станів, що проявляються екзацербациєю соматичної патології, формуванням загальних, що виникають при взаємодії соматичних і психічних факторів системоконплексів соматизованих психічних порушень, психічних розладів, що відображають реакцію на соматичне захворювання [1].

У літературі поняття «екзацербация» (лат. *exacerbare* – дратувати, засмучувати, погіршувати) трактується як загострення, різке погіршення симптомів хвороби [2, с. 131].

Проблема психології соматичної хвороби завжди розглядалася удвох аспектах: по-перше, з точки зору впливу психічних факторів на соматичну сферу людини, і по-друге, впливу соматичних факторів на психіку людини.

У зв'язку з цим в сучасних медико-психологічних дослідженнях чітко оформилися два протилежних напрями. До одного з них відносять аналіз сутності патогенного впливу хвороби на особистість, змін перебігу психічних процесів та операціонально-технічних можливостей пацієнтів в умовах певної хронічної соматичної хвороби.

Зокрема, А. Франц вказував, що етіологічне значення для захворювання можуть мати такі фактори як спадкова схильність, родові травми, органічні захворювання раннього віку, що призводять до підвищеної чутливості певних органів, переживання негативного досвіду в дитинстві тілесної травми, особливості виховання в ранньому дитинстві, переживання негативного емоційно-травматичного досвіду, емоційний клімат в сім'ї і характерні особистісні особливості батьків, нещодавні тілесні ушкодження, емоційні переживання, що пов'язані з особистими і професійними взаєминами. Лише при аналізі всіх симптоматичних категорій і їх взаємодії можна отримати повну етіологічну картину [3].

І. Грицюк, М. Замелюк та Л. Магдисюк за результатами дослідження особливостей виникнення психосоматичних розладів у підлітків визначили, що основою психосоматичних розладів у підлітків є реакція на емоційне переживання, що супроводжується функціональними змінами і патологічними порушеннями в органах. Причиною психосоматичних розладів може бути алекситимія, яка є стійкою особистісною характеристикою. Психосоматичні розлади залежать від профілю особистісних рис, рівня нервово-емоційної стійкості, ступеню інтеграції особистісних властивостей [4].

Алекситимія (грец. – заперечення, *lexis* – слово, *thyme* – почуття) – нездатність особи називати емоції, пережиті нею або іншими людьми, тобто переводити їх у вербальний план (труднощі в описі свого психологічного стану). Основними характеристиками алек-

ситимії є виражена дисфункція емоційного усвідомлення, соціальної прихильності та міжособистісних стосунків [2, с. 14].

Однак термін психосоматична хвороба не має жорстких рамок. Іноді зміст цього поняття значно звужується, а іноді загальний розлад, заснований на емоційних факторах, вважають психосоматичними захворюваннями. При одних порушеннях емоційний компонент є безпосередньою причиною проблеми, в інших – це лише складова кількох різних факторів [5].

Американський психолог Л. Х'єлл за результатами досліджень визначив, що психосоматичні розлади часто є вираженням пригнічених емоцій, конфліктів, особливо гніву, страху та провини. Цікавим прикладом є психосоматичний розлад, який включає синдром подразненого кишківника. Характерні для нього симптоми відображають психоемоційний стан людини. Хоча вони посилюються такими факторами, як стрес, внутрішньо-психічні труднощі все ж є основним фактором появи проблеми [6].

Останнім часом у зв'язку із війною в Україні відмічається певна тенденція в розвитку несприятливих психоемоційних станів у людей різного віку, в тому числі й молоді. Тривале перебування в певному стані позначається на характері людини, викликаючи акцентуацію рис, спостерігається також поступовий перехід негативних станів у властивості особистості.

Акцентуація – посилення, загострення певних психічних властивостей [2, с. 13].

Як зазначає І. Мунасіпова-Мотяш [7], для більшості негативних станів характерні певні зрушення в протіканні основних психічних процесів: вони викликають порушення сенсорних процесів, уваги, пам'яті, мислення, ослаблення волі, приводять до трансформації мотивів діяльності. Накопичення негативно забарвлених психічних станів приводить до постійного психологічного дискомфорту, до виникнення і закріплення в структурі характеру рис, які знижують адаптивні можливості людини. Окрім несприятливих психологічних наслідків, ці стани визначають і не бажані медичні і соціально-економічні наслідки: підвищену психопатизацію особи, погіршення її соматичного і психічного здоров'я. Отже, дослідження психічних станів студентської молоді в сучасних умовах процесу навчання набуває особливої актуальності.

Н. Шевченко виділяє наступні показники психоемоційних станів молоді, що навчається [7]:

1) переважаючі настрої, які характеризуються за показниками рівня (гарні-погані), знаку (радісні-пригнічені), якості (спокійні-схвильовані); особливостей прояву емоцій (стримані-нестримані; адекватні-неадекватні); здатності до розуміння чужих емоцій і прояву своїх (наприклад, уміння визначити настрої);

2) ступінь психофізіологічної активності, яка характеризується загальним рівнем активності (бадьорість-млявість), прагненням до діяльності, здатністю до концентрації уваги, працездатністю; стресостійкістю (стресогенна стійкість, фрустраційна толерантність);

3) стан самопочуття, яке характеризується суб'єктивним переживанням фізичного здоров'я-нездоров'я, суб'єктивною оцінкою рівня психофізіологічної активації (загальна мобілізація організму – стомлюваність) і усвідомленою самооцінкою психологічного стану, а також динамікою емоційних станів (схильність до зміни настроїв; емоційна лабільність);

4) емоційне ставлення особи до процесу навчання і учбової ситуації в цілому (задоволеність-незадоволеність; спокій-напруженість; внутрішній дискомфорт, тривожність, страхи, апатія, небажання відвідувати навчальний заклад; агресія по відношенню до нього); емоційний фон, емоційні настрої людини по відношенню до освітнього закладу – гарні-погані, радісні-пригнічені, спокійні-напружені; відчуття, що формуються (особа або любить навчання і освітній заклад в цілому, або боїться його, або байдужа до нього).

Поняття психосоматичних захворювань увійшло в нашу свідомість назавжди. Йдеться про фізичні захворювання, у розвиток яких значний внесок сприяли психологічні, переважно емоційні та соціальні чинники.

Кожен з нас пам'ятає з дитинства, як болить живіт, коли в школі мало бути важке випробування. Ця реакція називається стресовою реакцією, і вона проходить у міру проходження важкої ситуації. Однак, коли стресові ситуації, а разом з ними і стресові реакції, виникають часто, вони можуть перерости в більш постійний функціональний або органічний розлад. Тоді ми говоримо про психосоматичний розлад.

Отже, ризик соматизації зростає у кожної людини, яка відчуває незвичайне зростання стресу, пов'язаного із зовнішньою ситуаці-

єю або внутрішнім конфліктом. У кожного з нас були соматичні реакції, коли емоційні стреси перевищували наші можливості впо- ратися з ними іншими способами, наприклад, біль у животі, про- блеми зі сном перед важливим іспитом або співбесідою. Це тому, що соматизація допомагає нам захистити себе від душевного болю, і це один із найперших способів боротьби з напругою. Певним чи- ном вони «говорять» нам піклуватися про себе.

Представники сучасної молоді часто зустрічаються з пробле- мою першого повноцінного знайомства зі своєю спеціальністю, яке відбувається, наприклад, під час проходження навчальної прак- тики. Певний рівень тривожності є звичайною та обов'язковою особливістю емоційної діяльності людини, проте, кожна людина має свій оптимальний рівень тривожності, так звану – корисну тривогу. Проте, підвищений рівень тривожності можна назвати суб'єктивним проявом неблагополуччя особистості.

Невпевнена, схильна до тривожності людина часто є помірко- ваною, а ця риса вже призводить до недовіри в адресу інших. Така людина знаходиться в постійному страху та очікуванні зовнішньої загрози, яка може виявлятися в будь чому. Це постійне напружен- ня та очікування з часом перетворюється на захисну реакцію у ви- гляді агресії, спрямованої на оточуючих. Ця реакція виражається в надмірній агресивності, упередженому ставленні до людей.

Такі особи, з розвиненою тривожністю та агресивністю часто самотні, замкнуті, неактивні. Іноді ця тривога та стан тривожно- сті впливають на результати навчальної (трудової) діяльності та на успіхи встановлення контакту з оточуючими людьми. Таким чи- ном, багаторівнева функціональна система адаптації формується за рахунок взаємодії та взаємовпливу психологічних та фізіологіч- них компонентів адаптивних реакцій.

У системі структур що реалізують адаптаційний процес, важ- ливу роль відіграє нервова система. Взаємозв'язок емоційно-мо- тиваційної сфери та механізмів адаптації зумовлює необхідність комплексного вивчення впливу психологічних та вегетативних функцій в процесі адаптації людини.

Психосоматичний аналіз особистості може бути використаний як інструмент психічної корекції. Цей аналіз повинен базуватися на основних технічних заходах, запропонованих у різних психо-

терапевтичних парадигмах. Тотальність психосоматичної проблеми дозволяє комбінувати ці інструменти, долаючи еклектичність. Прикладом такого підходу є запропонована і схвалена автором методика психосоматичного аналізу особистості ПАВА, що наведено у дослідженнях Т. Хомуленко [8].

Американський психолог Л. Лекрон [9] класифікував причини психосоматичних реакцій:

1. Конфлікт – формування психосоматичних розладів може бути наслідком внутрішніх конфліктів між різними частинами особистості. Зазвичай одна з цих частин є свідомою, а інша прихована в несвідомому. Боротьба між двома протилежними бажаннями або тенденціями може призвести до умовної перемоги однієї частини. Однак пізніше інша частина може почати «партизанську війну», і психосоматичні симптоми можуть з'явитися як ознака цього;

2. Мова тіла – в деяких випадках тіло може фізично відображати стан, описаний одним із метафоричних виразів цієї серії: «постійний головний біль», «розлад шлунку», «перебої в роботі серця», «зв'язані руки». І болять деякі органи, утруднене дихання, виникають головні болі, розлади шлунково-кишкового тракту тощо;

3. Мотивація або умовна вигода – до цієї категорії відносяться проблеми зі здоров'ям, які забезпечують певні умовні вигоди для власника. Формування симптомів відбувається на несвідомому рівні і не є обманом чи симуляцією. Симптоми реальні. Однак вони «служать» певній меті;

4. Минулий досвід – причиною хвороби може бути травматичний досвід з минулого, часто важкий досвід дитинства. Це може бути будь-яка подія, або це може бути довготривалий ефект, який стався дуже давно, але продовжує емоційно впливати на людину зараз. Цей досвід ніби відбивається в тілі. Тіло чекає способу, як його переробити;

5. Ідентифікація – фізичні симптоми можуть бути викликані ототожненням себе з кимось, хто має схожі симптоми або хвороби. Зазвичай це відбувається, коли існує сильна емоційна прив'язаність до цієї людини. Часто ця людина може бути вмираючою, близькою до смерті або вже мертвою. Іншими словами, існує страх втратити цю людину, і ця втрата фактично вже відбулася;

6. Навіювання –симптоми можуть бути викликані навіюванням. Це відбувається, коли думки про власну хворобу автоматично приймаються людиною на несвідомому рівні, тобто некритично. Свідомо чи несвідомо, симптоми можуть бути спровоковані людиною, яка має великий авторитет або знаходиться поруч у певний момент емоційного стресу;

7. Самопокарання– психосоматичні синдроми можуть відігравати роль у несвідомому самопокаранні. Це покарання пов'язане з реальним або, частіше, уявним почуттям провини, яке впливає на людину. Самопокарання полегшує переживання провини, але ускладнює життя.

Крім різних короточасних психосоматичних реакцій (блідість шкіри або її почервоніння, частий пульс, короточасне порушення сечовипускання або випорожнення, раптова м'язова слабкість та ін.), що з'являються в напружених життєвих ситуаціях, вчені Л. Перетятко та М. Тесленко [1] виділяють чотири великі групи розладів іншого ґатунку:

1. Конверсійні симптоми – символічне вираження невротичного (психологічного конфлікту). Тіло людини в даній ситуації служить, наче, сценою символічного вираження суперечливих почуттів, котрі придушені і витіснені в несвідоме. Наприклад, істеричні паралічі, психогенна сліпота або глухота, больові відчуття та ін.

2. Психосоматичні функціональні розлади – виникають частіше при неврозах. На відміну від психогенної конверсії, окремі симптоми в даній ситуації не мають специфічного символічного значення, а є неспецифічним наслідком тілесного (фізіологічного) супроводу емоцій чи психічних станів.

3. Органічні психосоматичні хвороби (психоматози) – в їхній основі лежить первинно тілесна реакція на конфліктне переживання, пов'язана з морфологічно встановленими патологічними змінами в органах. Перші прояви психосоматозів виникають у будь-якому віці, але частіше вони починають фіксуватися вже в ранній юності в осіб з вираженими і постійними особистісними характеристиками.

4. Психосоматичні розлади, пов'язані з особливостями емоційно-особистісного реагування і поведінки – схильність до травм та інших саморуйнівних видів поведінки (алкоголізм, наркоманія,

переїдання з ожирінням та ін.). Ці розлади зумовлені особливостями особистості і її переживань, що приводить до поведінки, результатом якої є порушення здоров'я.

Висновки. В процесі теоретичного аналізу наукової літератури визначено, що психосоматичні розлади – це група хворобливих станів, які виникають на основі взаємодії психічних та фізичних факторів. Емоції відіграють в житті молодшої людини велику роль. Найбільш інтенсивне переживання емоцій може викликати комплексну емоційну реакцію – стрес, яка є комплексною та містить фізіологічні та психологічні елементи. Стресовий вплив немає перевищувати адаптаційні можливості людини, бо це може привести до виникнення психосоматичних розладів. Психосоматичні прояви – це певний результат негативного впливу специфічних особливостей емоційного реагування людини на стресогенну ситуацію.

Концепція адаптаційних механізмів людської психіки є найбільш загальним підходом до роз'яснення взаємозв'язку між стресогенними чинниками професійної діяльності та психосоматичним статусом людини. Деадаптація в першу чергу стосується емоційно-когнітивних процесів, що спричиняє загальне зниження адекватності функціонування психічної сфери і виникнення психічної напруженості, а далі – до зниження ефективності діяльності та подальшої її дезінтеграції. Подальша динаміка психічної деадаптації спричиняє розлади психофізіологічної адаптації. Саме тому фізіологічні зміни потрібно вважати не первинним, а кінцевим проявом деадаптації, бо вони завжди є наслідком певних емоційних переживань та поведінкового реагування.

Література.

1. Психосоматичні розлади: сучасний стан проблеми. *Психологія і особистість*. Перетятко Л. Г., Тесленко М. М., 2017. № 2 (12), с. 137-147.
2. Словник-довідник психіатричних термінів : навч. посіб. для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г. М. Кожина та ін. Харків : ХНМУ. 2018. 161 с.
3. Психосоматичні розлади. Теорії, методи діагностики, результати досліджень : навч. посіб. Київ : Харченко Д. М., Видавничий дім «Слово», 2015. 280 с.

4. Особливості виникнення психосоматичних розладів у підлітків / Мадисюк Л. І., Грицюк І. М., Замелюк М. І. / The psychological health of the personality and society: the challenge sof today : monograph / Eds. Małgorzata Turbiarz& Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. Part 1. 5. P. 36-41.

5. Психосоматика: навч. посіб. Наказна І. М. Ніжин: вид-во НДУім. М. Гоголя, 2010. 132 с.

6. Сучасна психологія особистості : навч. посіб. Київ : Титаренко Т. М., Марич, 2009. 232 с.

7. Особливості психічних станів студентської молоді в умовах навчального процесу. Мунасіпова-Мотяш І. А., *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету*. 2012. Вип. 105, Т. 2. С. 17-20.

8. Основи психосоматики: навч. -метод. посіб. Хомуленко Т. Б., Вінниця: Нова Книга, 2009. 120 с.

9. Self Hypnotism: The Techniques and Its Use in Daily Living. Leslie M. Lecron. 1920. 224 pages.

3.5. Особливості психоемоційних станів військовослужбовців у адаптаційний період

Ковальська О. Р.

Актуальність. Важливість розуміння станів військових, що повертаються додому після участі у бойових діях зростає з кожним днем. Переважна більшість як самих військовослужбовців – майбутніх ветеранів, так і цивільного населення, не готові та не підготовлені до психологічної екологічної взаємодії, реакцій та вирішення певних життєвих ситуацій, що виникають у суспільному житті як на рівні сімейних стосунків, так і соціуму в цілому. Актуальність та обговорення тем, що стосуються роботи зі станами військових, які повертаються додому та підготовку цивільних до зустрічі з ними, стає сьогодні все більш затребуваною.

Мета. Сукупність завдань: проаналізувати теретично поняття «психоемоційні стани» військовослужбовців у науковій літературі; визначити психоемоційні стани військовослужбовців у реабілітаційний та адаптаційний періоди після бойових дій; розглянути заходи щодо впровадження комплексного підходу роботи психологів, реабілітологів та інших спеціалістів з військовослужбовцями протягом усього реабілітаційного та адаптаційного періоду, який забезпечує діагностування стану військового, поведінки, реакцій, що дає можливість допомагати військовим повертатися до звичайного життя максимально швидко та з мінімальним стресом, налагоджувати комунікацію з людьми, що не мають військового досвіду, приймати себе іншими, не такими якими вони були до військового досвіду.

Результати дослідження. Психоемоційні стани військовослужбовців досліджуються у наукових працях психологів, серед яких: Н. Агаєв, О. Блінов, О. Бойко, О. Еверт, О. Кокун, З. Комар, М. Корольчук, В. Лефтерова, Г. Ложкіна, Н. Лозінська, С. Миронець, В. Моляко, Н. Оніщенко, В. Остапчук, В. Осьодло, І. Пішко, Є. Потапчук, І. Приходько, А. Романишина, О. Сафіна, О. Тімчен-

ко, М. Томчук, С. Яковенко та ін. Детально розглянувши даний стан у літературі, ми виявили, що у психологічній науці відсутнє конкретне й однозначне трактування поняття «психоемоційний стан». Дослідниками використовуються терміни такі як: «психічний стан», «емоційний стан» та ін.

Познайомившись з вищеназваними термінами у роботах різних авторів, проаналізувавши практичні рекомендації сімейних лікарів, психіатрів, лікарів-реабітологів, психологів-практиків, психотерапевтів, було сформульовано власне визначення поняття «психоемоційний стан». На нашу думку, *психоемоційний стан* – це стан функціонування нервової системи, який відображає роботу психіки при дії на неї зовнішніх та внутрішніх факторів у різних часових інтервалах. Даний стан проявляються у вигляді різних реакцій та проживань на ті чи інші події, обставини, явища тощо. Для більш чіткого зрозуміння цих проявів, пропонуємо розглянути класифікацію психоемоційних станів за авторства М. Й. Варія [3, с. 650], представлену у рис. 1.

Для дослідження психоемоційних станів військовослужбовців, що повернулися додому, ми залучилися підтримкою психологічної служби військового шпиталю, де проходять реабілітацію після поранень діючі військові та ветерани. Було використано картку психологічного супроводу, яка заповнюється під час перебування військовими на реабілітації у військовому шпиталі та опитано близько 67 військових, що проходили реабілітацію у цей час.

За даними опитування виявлено, що найбільш розповсюдженіми станами є тривога, страх, напруження, неспокій. Часто військові відчують дратівливість, відчуття несправедливості, велике емоційне навантаження, певні власні переживання, але не завжди можуть пояснити що це. Респонденти також зазначали, що відчували роздратування, коли чули питання: «Що ти відчуваєш?» не через те, що вони не хочуть відповідати, а через те, що іноді їм важко пояснити і їх внутрішні відчуття зазвичай це спосіб звернути увагу.

Такі емоції як «безсилля і апатія», за свідченнями учасників опитування, спрацьовують як захисний механізм, як непрожита втрата. Постійна та періодична тривога – як сигнал про небезпеку. Гнів, сум, розпач, сором, провина – через те, що щось не зробив, недопрацював, повернувся живим. І як втеча від цих станів про

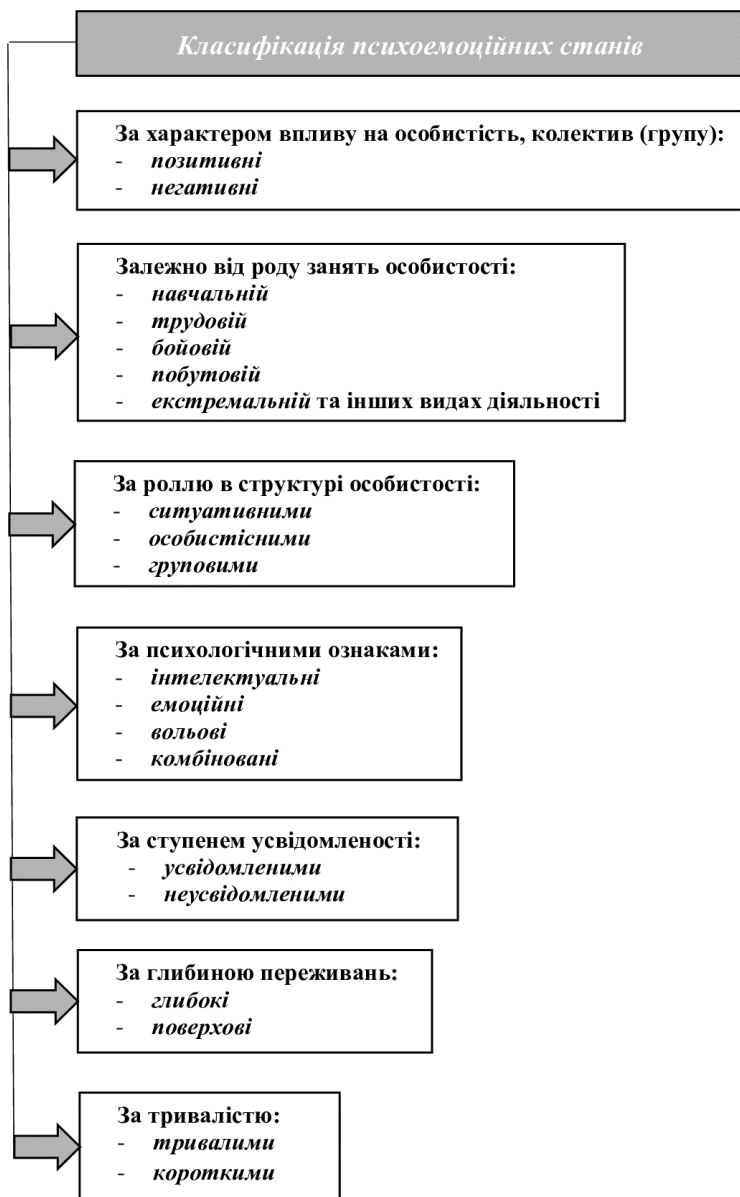


Рис. 1. Класифікація психоемоційних станів
за М. Й. Варієм [3, с. 650]

являється агресія або переходить у вживання алкоголю та інших речовин, але насамперед, викликає у військових сильний стресвпродовж довготривалого періоду та пов'язано з тим, що під час перебування на службі у зоні бойових дій, час для адаптації та проживання усіх станів обмежений або взагалі відсутній. Військова людина відразу і постійно має бути зібраною та готовою до дій. Тому у процесі служби напрацьовуються нові звички, реакції, активуються інстинкти і відповідно виникають абсолютно інші задачі, пов'язані з виконанням своїх обов'язків та постійною або періодичною небезпекою для здоров'я та життя. Також відбуваються зміни психіки людини в зв'язку із зміною умов життя та роду діяльності, особистого режиму, розпорядку дня та ночі, фізичного та психологічного навантаження, оточення тощо, що викликає короткостроковий стрес [1].

Таким чином, усі реакції, які працювали на фронті, стають неадаптаційними у цивільному житті. Для того, щоб вони змінилися потрібен час та готовність як збоку військового, так з боку його рідних, оскільки саме вони проживають процеси реабілітації та адаптації разом з ним. Адаптація до цивільного життя триває набагато довше та викликає затяжний стрес.

На зараз, розробляються та впроваджуються заходи із психологічної та фізичної реабілітації, соціальної та професійної адаптації військових, що завершують виконання своїх військових обов'язків під час війни, зокрема тих, хто має пошкодження та втрати кінцівок, як на рівні держави, так і на рівні громадських, волонтерських організацій та благодійних фондів в Україні та за кордоном. Прикладом комплексного підходу до даного питання є ізраїльська система медичної та психологічної реабілітації та адаптації військових. Даний підхід включає ефективні психореабілітаційні та психотерапевтичні методи щодо підвищення стійкості до стресу, корекції взаємовідносин, зменшення соматичних та вегетативних розладів, а також супровід ветеранів, їх родин та сімей загиблих військовослужбовців. Досвід Ізраїлю уже вивчається та впроваджується українськими спеціалістами з адаптаційними заходами під українські реалії [9].

Головним завданням військового, при поверненні додому є: перейти у стан цивільного, усвідомивши нову реальність, в якій відсутня небезпека для життя і дозволити собі розслабитись, що є далеко не легко для військового, зважаючи на пережитий ним бо-

йовий досвід, який зазвичай був і залишається для нього на все життя важливим та незабутнім, але є досить важливо для психічного та фізичного здоров'я. Також впливовим фактором, що додає важкості є великий контраст між цивільним життям та життям під час участі у бойових діях, а відповідно і станами, і реакціями, і діями. Також, за даними проведеного нами дослідження виявлено, що гостра фаза адаптації відбувається протягом 1-2 місяців, остаточна фаза триває біля 6-12 місяців. Тривалість адаптаційного процесу залежить від того, скільки людина була на фронті. Також, присутня велика ймовірність, що після служби людина змінюється назавжди. Цікавий факт, який вдалося виявити під час опитування, це те, що швидше адаптують та реабілітуються військові, які мають вищу освіту, а також ті, що займалися спортом до, під час та після служби, не зважаючи на свої нові особливості.

Також дослідження показало, що ПТСР має біля 20 % військових, навіть після травматичного досвіду. На підставі висновків, якими поділилися з нами члени психологічної служби військового шпиталю, що приймають участь у реабілітації військових, поведінка військового після повернення може бути схожа на ПТСР, в більшості випадків це є симптомами адаптації, оскільки ПТСР проявляється після завершення адаптаційного періоду. Військові зазначають, що повернутись повністю з війни неможливо, оскільки якась їх частина постійно залишається на війні, принаймні зараз, поки вона ще триває.

У процесі спостережень протягом двох тижнів та співбесід разом з членами психологічної служби шпиталю з військовими та їх рідними, виявлена та помітна переоцінка цінностей до та після участі військових у бойових діях. Це проявляється у зміні стосунків з дружинами/чоловіками, дітьми та батьками, а також друзями та знайомими, при чому, не завжди ці зміни є позитивними для усіх. Також виявлено перенесення фокусу уваги з матеріальних цінностей на більш духовні, зміну інтересів та потребу в набутті нових навичок.

Важкість адаптації полягає й у тому, що військові часто себе відчують непотрібними соціуму, рідше сім'ї (якщо є незрозуміння, несприйняття чи інші проблеми). В таких станах їм важко знайти собі місце, оскільки на військовій службі вони звикли виконувати накази – там все чітко і зрозуміло і уже про все подбали інші.

А повернувшись у цивільне життя – потрібно вчитися ніби заново жити. Часто це супроводжується відсутністю думок про майбутнє, цілей та планів. Також у деяких військових виникає бажання усамітнення, яке має багато причин. Основними з таких причин є те, що вони мають багато болю і переживань, які не хочуть показувати іншим, бояться проявити перед кимось, не бажаючи перекладати це на когось, а також часто мають переконання, що їх ніхто не розуміє і не зрозуміє, будуючи таким чином бар'єри для відкриття та близькості з рідними та проти спілкування з іншими людьми.

Практично всі опитані військові під час нашого дослідження, мають проблеми зі здоров'ям, зниження апетиту, сексуального потягу та інші стани, які можуть говорити про їх розпач, дезадаптацію, втрату інтересу до життя. Прояв цих емоцій може бути сигналом про потребу у підтримці, про допомогу, але зовсім протилежним способом. Працівники психологічної та фізичної реабілітаційної служби, розуміючи такі важкі наслідки, проводять заходи для того, щоб військові поступово самі вчилися допомагати собі, просити про допомогу екологічно, проявляти свої почуття, контролювати своїми станами та користуватися своїми новими особливостями. Змінити свої психоемоційні стани на більш позитивні та ресурсні та пришвидшити реабілітацію та адаптацію до цивільного життя, а також мінімізувати стрес, військовим пропонується за допомогою збалансованого харчування, помірних фізичних навантажень, перебування на свіжому повітрі, відвідування масажних процедур, здорового сну, емоційного і фізичного відпочинку, дотримання режиму дня, обмеження перегляду соцмереж та новин, допоможе зняти напругу та тривогу. Важливим є контролювати вживання ліків, психотропних речовин (ліки, алкоголь, наркотики, нікотин), бо часто адаптація супроводжується залежностями. При цьому важливо пропонувати допомогу, але не намагатися рятувати, проінформувати про наслідки, але залишати вибір за людиною. При бажанні повернутися у зону бойових дій, важливим буде нагадування про інші ролі людини, окрім військового, про відповідальність, яку він має у цивільному житті та про переживання рідних.

Головним для військового є знати і відчувати те, що його чекали, що він є важливим значимим, що його люблять і приймають таким, яким він є зараз. Проявляти людяність, повагу, прийняття

що він уже не такий як був до військової служби, показувати важливість, потрібність, увагу, активне слухання, не жаліти, не запитувати через цікавість та не знецінювати. Якщо людина говорить про травмуючу подію, це як спосіб переробки власного травматичного стресу, якщо він триває не занадто довго. В цілому, спогади про війну не є поганими. З часом вони зменшують свою інтенсивність якщо все проходить добре [1].

Висновки. Психоемоційні стани військовослужбовців після повернення додому є досить своєрідними, зазвичай негативними і не екологічно проявленими та глибоко переживаючими військовим. Психологічна та фізична адаптація і в багатьох випадках реабілітація є важливою частиною повернення до цивільного життя. Також дані заходи повинні проводитися протягом потрібного періоду часу та на достатньому рівні для виявлення покращень станів військових, а також включати у себе роботу із сім'ями військових, які часто проживають цей період разом зі своїм героєм. Зміни можуть відбуватися не лише завдяки самому військовому, а й велика частка покладається на його сім'ю. Також, важливе місце займає і соціум, до якого адаптується, або не адаптується військовий, в залежності від реакцій та відношення до військового. Важливо пам'ятати, що військові це люди з певним життєвим досвідом, який лишає після себе спогади, знання, навички та шрами як на тілі, так і в душі, які важливо приймати і поважати. А знаючи, про що говорить поведінка та реакції, можна уникнути багатьох проблем та бути причетним до позитивних змін психоемоційних станів військовослужбовців, що повернулися додому після участі у бойових діях, відстоюючи незалежність своєї Батьківщини.

Література.

1. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медикопсихологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. К. : НУОУ, 2016, 400 с.

2. Буряк О. О., Гіневський М. І. Соціальна адаптація армії України до нових умов існування. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2014. Випуск 4. с. 160-166.

3. Варій М. Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. К. : «Центр учбової літератури», 2007, 968 с.
4. Вдовіченко О. В., Соколова І. М., Психологічна реабілітація і супровід ветеранів війни: досвід Ізраїлю. *Zeszyty naukowe wyzszej szkoły technicznej w Katowicach issn 2082-7016; eissn 2450-5552 2023, nr 16, s. 107*
5. Вебер Т., Гридковець Л., Журавльова Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. – 236 с.
6. Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С., Остапчук В. В. Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення: Методичний посібник. К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.
7. Кокун О. М., Мороз В. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. Теорія і практика управління страхом в умовах бойових дій : метод. посібник. К : Фенікс, 2022. 88 с.
8. З. Комар Психологічна стійкість воїна, підручник для військових психологів, Київ, 2017, с. 184.
9. Як спілкуватися з військовими та як військовим спілкуватися з рідними?: матеріали онлайн зустрічі з військовим психологом Пилипом Духлієм від 13. 04. 2023р. / Українська фундація розвитку.

3.6. Теоретичне дослідження психічних станів особистості як наслідок кризових подій в Україні

Лимаренко О. О.

Актуальність. Дослідження впливу затяжної кризової ситуації на життя та психічні стани українців є актуальним, адже вже протягом 10 років суспільство живе в дуже напруженій атмосфері. Війна є серйозним стресовим чинником, який може викликати різноманітні психічні реакції в особистості. Дослідження в цьому контексті може допомогти зрозуміти, які саме аспекти воєнного конфлікту впливають на психіку громадян та як це відображається на їхньому психічному здоров'ї. Також розуміння психічних станів громадян може служити основою для розроблення та надання психологічної підтримки в умовах воєнного конфлікту. Це може бути важливим елементом стратегій збереження та відновлення психічного здоров'я населення. З настанням воєнних дій в Україні суспільство зіткнулося із соціальними, економічними та психологічними змінами. Воєнні конфлікти призводять до гуманітарних криз, таких як переселення населення, порушення прав людини, голод і бідність, та зазвичай супроводжується горем, розлукою з родиною та соціальною ізоляцією. Це має довготривалі наслідки для суспільства та громадян України. Всі ці події уособлюють собою затяжну кризову ситуацію в країні і дають вагомий негативний вплив на психічні стани кожного українця.

Мета. Дослідити психічні стани особистості, як наслідок кризових подій в Україні.

Результати дослідження. Проблематика кризових станів в Україні активно почала проявлятися починаючи з 2014 року. Революція гідності була сама по собі дуже неочікуваною та емоційно напруженою подією для населення, яка спровокувала багато різних психічних станів, що викликало цілий спектр негативних переживань. За Кокун О. М. нервово-психічна напруга розглядається як загальна реакція організму при зміні стереотипу діяльності і найбільш

різко виявляється при реальній або уявній загрозі життю або здоров'ю [4]. Спостерігаючи за перебігом подій можна було побачити, що негативні психологічні наслідки торкнулися не всіх. Доволі велика кількість громадян зазнала інтенсивного емоційного і психічного перенапруження, що призвело до травматизації та виникненню негативних психічних станів. Згодом у всьому світі сталася пандемія на covid-19, що спричинила нову хвилю переживань вже після того, як громадяни змогли відносно адаптуватися і відновити свій звичний перебіг життя. Наступним і найсерйознішим потрясінням стало повномасштабне вторгнення в Україну. Українцям довелося пережити цілий спектр негативних психічних станів, таких як стани суму, апатії, страху, невдоволеності, паніки, невизначеності, тривоги та нерішучості. Також сюди справедливо можна додати стани гніву та агресії, які стали основним мотивом, який спонукав населення стати на захист своєї землі. Треба зазначити, що кризовий стан необхідно розглядати як нормальну реакцію людини на аномальну (психотравмуючу) подію [5]. Таким чином вона намагається впоратися з неочікуваними сумними змінами, тим паче, коли це відбувається у вигляді примусового прийняття – саме в такій стресовій ситуації перебуває наше суспільство протягом тривалого часу.

Важливим моментом є те, що кожна людина реагує на стрес по-різному. За теорією стресу Г. Сель'є стрес є станом фізіологічної або психічної напруги, який зумовлений різноманітними чинниками. Вони можуть бути зовнішніми, внутрішніми, розумовими та емоційними – саме сукупність цих чинників спрямовані на порушення функцій організму, і яких сам організм намагається уникнути. Г. Сель'є вказує на те, що жоден живий організм не може залишатися в постійному стані тривоги. Якщо вплив занадто сильний, то організм може загинути ще на етапі тривоги, протягом перших годин або днів. У випадку виживання, первинна реакція обов'язково переходить у стадію «резистентності» [15].

На основі цього, науковець визначив три етапи загального адаптаційного синдрому:

1. Етап тривоги (Alarm Stage): коли організм визнає стресор і готується до боротьби або втечі. Відбувається активація нерво-гуморальної системи.

2. Етап спротиву (Resistance Stage): коли організм намагається адаптуватися до стресора, залишаючись у стані готовності (ресурси спрямовані на подолання стресора).

3. Етап виснаження (Exhaustion Stage): якщо стресор триває довго і ресурси вичерпуються, організм може зазнати виснаження. В цьому етапі можуть виникнути різноманітні проблеми зі здоров'ям, імунітет може погіршитися, і можуть виникнути різні захворювання.

Якщо проаналізувати хронологію подій з початку повномасштабного вторгнення, можна прослідкувати, що населенню України довелося проживати всі три з цих етапів. На жаль, на сьогоднішній день етап виснаження став для українців звичним. Якщо у випадку АТО та Революції Гідності люди проживали перші два етапи, а далі їм вистачало внутрішніх і зовнішніх ресурсів, щоб наступив етап відновлення від стресу (так як події були відносно короткостроковими або менш інтенсивними за напруженістю), то у випадку з війною – ситуація є надзвичайно кризовою.

Український суспільно-політичний журнал «New Voice» пише, що за даними Офісу генпрокурора станом на липень місяць 2023 року внаслідок війни в Україні було вбито близько 10,7 тис. цивільних. Серед них налічується більш ніж 500 дітей. Звісно, ці дані не враховують повний перелік загиблих і поранених у таких знищених і окупованих містах як Маріуполь і Волноваха, наразі неможливо встановити точну кількість [14]. Окрім того, в цілому було зареєстровано понад 97 тис. воєнних злочинів, вчинених росіянами за час повномасштабного вторгнення. З цих даних можна зробити висновок, що більша частина населення України є травмованою тим чи іншим чином. Якщо узагальнити, то зрозуміло, що воєнні події в країні несуть усім громадянам такі загальні негативні психічні стани як страх, втрата відчуття безпеки, гнів, паніку тощо. Але в той же час суспільство поділяється на різні сегменти людей, в залежності від свого статусу, досвіду та ролі в суспільстві. Найбільш вразливими на сьогоднішній день є два сегменти населення: вимушені переселенці та військовослужбовці.

Лише за показниками Манінтеграції станом лютий місяць 2023 року було обліковано близько 4,8 млн. внутрішньо-переміщених осіб, але їх реальна кількість становить майже 7 млн. Психічне

здоров'я вимушених переселенців на відміну від людей, що живуть в мирних містах значно гірше внаслідок того, що їм доводиться переживати втрату житла, втрату можливості повернутися додому, втрату ресурсів до існування, напруженість близьких і оточуючих людей, погані побутові умови, та мінімальні умови для існування. Пристосування особистості до іншого соціокультурного оточення, окрім загального погіршення стану здоров'я, спричинює значні негативні зміни у формуванні ідентичності.

Якщо звернутися до статистики, то за даними Global Firepower станом на 2023 рік Збройні Сили України нараховують близько 500 тисяч військовослужбовців, 200 тисяч з яких є чинного складу.

Наразі військовослужбовці переживають найбільш екстремальні психічні стани, так як мають вплив найбільш стресогенних чинників. Захисникам доводиться бачити жахливі картини на фронті, справлятися з контузіями, пораненнями та загибеллю близьких людей, жити в несприятливих і важких умовах. В дослідженнях О. Кокуна визначено, що 65,0 % військовослужбовців наявний ПТСР, порушення психічного стану мають 81,0 %, мають високий ступінь депресії 64,0 % [4].

Якщо проаналізувати всі ці показники, стає зрозуміло наскільки катастрофічною є ситуація відносно стану психологічного здоров'я населення в цілому. За словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт – до 10 мільйонів українців піддаються ризику того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до важкого стану, таких як тривожні розлади, депресії та ПТСР. Психічні травми несуть в собі серйозний вплив на життя людини особисто і на суспільство, в якому вона проживає в цілому. На сьогоднішній день вивчення проблематики психічних станів особистості в кризових ситуаціях відображена в роботах О. Кокуна, О. Алімова, Н. Афанасьєвої, Т. Титаренко, Л. Вольнової, Л. Бебези, Г. Пріба, Я. Раєвської, Л. Юрь'євої, С. Максименка, С. Томчука, Ф. Є. Василюка.

Вважається, що лише 80 % людей можуть впоратися з пост-стресовими ситуаціями, іншим же необхідна допомога. Через тяжкі кризові стани українцям доводиться стикатися з підвищеною агресією та конфліктністю в спілкуванні, відчуттям ізоляції та відчуженості через відмінність пережитого досвіду. Це можна пояснити тим, що кожна людина переживає втрату як особисте

горе, будь то втрата близької людини або навіть втрата звичного розпорядку дня. Теорія Елізабет Кюблер-Росс говорить про «п'ять етапів смерті», які переживає людина в кризових станах [7].

Розглянемо цю теорію, адаптуючи її до воєнних обставин в Україні:

1. Перший етап – це заперечення реальності ситуації. Людина може відмовлятися вірити у факт того, що почалася повномасштабна війна або надіятися на помилковість новин

2. Другий етап – це вираження гніву і обурення. Людина може звинувачувати себе, оточуючих або весь світ у тому що сталося.

3. На третьому етапі людина намагається зробити угоди чи торг з вищою силою. Вона може обіцяти щось в обмін на те щоб ворог пав, або сподіватися на те що станеться якесь диво, війна різко скінчиться і все стане так як було раніше.

4. Четвертий етап – це стадія депресії і суму. Людина розуміє реальність, розуміє, що торг не приносить результатів і також усвідомлює що війна і всі страшні речі, які вона несе за собою – є насправді, і це може призводити до глибокого почуття втрати і безпомічності.

5. Останній етап – прийняття. Незалежно від того, наскільки глибокими є страждання людини, повільно, але неухильно, вона повертається до звичного життя.

Ця теорія несе в собі більш узагальнений характер, так як відомо, що кожна людина має свої індивідуальні особливості функціонування нервової системи, життєвий досвід, рівень емпатійності та життєстійкості, що має прямий взаємозв'язок із її адаптивністю та вмінням справлятися із кризовими ситуаціями. Саме цю тему підіймає Д. Бонанно в своїх дослідженнях [12]. Проводячи дослідження життєстійкості людини він виявив, що як серйозні короткострокові проблеми, так і менш важливі, але тривалі кризи сприймаються людьми подібно. Також він говорить про те, що втрати і горе можуть спричинити не тільки стрес, але й можуть стати каталізатором для особистісного росту та психічної адаптації через переосмислення життєвих цінностей. Безперечно, всі адаптаційні механізми людини, що сприяють досягненню задовільного рівня фізичного та психологічного здоров'я, є складовими життєстійкості. Проте, головна роль життєстійкості полягає в можливості успішно взаємодіяти соціально та знаходити оптимальні шляхи

саморозвитку особистості в умовах складних життєвих обставин. В своїх роботах Г. Пріб, Л. Бегеза, Я. Раєвська говорять про два види факторів адаптації людини під час воєнного конфлікту: фактори, що сприяють успішній адаптації людини та фактори, що перешкоджають цій адаптації. На думку авторів позитивні фактори допомагають особистості пристосуватися до нової соціальної ролі, переосмислити себе в нових життєвих обставинах та успішно інтегрувати свій досвід в ресурсний стан. В той час як негативні фактори сприяють деструктивній поведінці особистості, підтримують її негативізм та перешкоджають відновленню [9].

На жаль на сьогоднішній день через довготривалу та затяжну кризову ситуацію в країні в суспільстві спостерігається тенденція до прояву негативних психічних станів та збільшенню ментальних розладів. Українці відчувають емоційну виснаженість, апатію та переживають тривожно-депресивні стани. Звісно, громадяни, які мають кращу адаптивність виступають проявляють більшу стресостійкість, але за статистикою більша частина людей в Україні витрачаючи свій психоемоційний ресурс на подолання кризи не мають можливості повноцінно його відновити. Усвідомлення цього може викликати екзистенційні страждання і як наслідок викликати супутні кризові стани. Насправді ПТСР не є частою травмою, на відміну від індивідуальної травми, яка викликає різноманітні залежності, порушення поведінки, зміни в особистості, проблеми з харчуванням, дисоціативні стани, тривогу та депресію, паніку, навіть біполярний афективний розлад.

Висновки. Таким чином аналіз робіт сучасних науковців допомагають визначити, що психічні стани в кризових випробуваннях можуть бути різноманітними та еволюціонувати від негативних емоцій до стратегій копінгу та адаптації. Відтак бачимо потребу в подальшому поглибленому дослідженні в цьому напрямку, які допоможуть більш детально розкрити процеси психічної адаптації в умовах кризи. Дослідження психічних станів українців під час воєнного конфлікту є необхідним для збереження та покращення психічного здоров'я нації в умовах важкої історичної та соціальної ситуації. Так як бойові дії в Україні продовжуються і під загрозою залишається не тільки життя людей, а і ментальне здоров'я та благополуччя нації, вважаємо, що є гостра необхідність у впровадженні підтримуючих заходів, орієнто-

ваних саме на вирішення проблематики негативних психічних станів особистості на рівні всього суспільства.

Література.

1. Вимушена міграція як фактор виникнення психосоціальної дезадаптації та невротичних розладів / А. В. Гальченко, О. В. Погорілко, В. А. Волошин, К. В. Гринь, О. В. Лук'янченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Вип. 3 (152). – С. 19–23.

2. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. О. В. Тімченка – К. : ТОВ «Август Трейд», 2007. – 502 с.

3. Кокун, О. М. (2002). Аналіз поняття адаптаційних можливостей людини. Проблеми заг. та пед. психол. : Зб. наук. Праць Ін-ту психол. ім. ГС Костюка АПНУ, 137-140.

4. Кокун О. М. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців / О. М. Кокун, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – Вип. 5 (42). – С. 262 – 267.

5. Кризова психологія: Навчальний посібник За заг. ред. проф. О. В. Тімченка. – Х. : НУЦЗУ, 2010. – 401 с.

6. Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / Під ред. проф. Л. М. Юр'євої. – К. : Вид. ТОВ «Галерея Принт», 2017. – 174 с.

7. Кюблер-Росс Е. Про смерть і вмирання, Видавництво: , Серія: Філософія – Neoclassic, Сторінок: 416, Обкладинка: Тверда, ISBN: 978-5-17-133351-5).

8. Особистість, суспільство, війна : тези доп. учас-ників міжнар. психол. форуму (м. Харків, Україна, 15 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. поліція України та ін. – Харків : ХНУВС, 2022. – 132 с.

9. Пріб. Г. А., Раєвська Я. М.,Бегеза Л. Є. Соціально-психологічні особливості адаптації особистості в умовах бойових дій. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 33 (72) № 2 2022. С. 104-109. DOI <https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/17>

10. Слюсаревський М. М. Психологія міграції: навчальний посібник / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кіровоград: 2013. С. 52-244.

11. Томчук С. В. Негативні психічні стани, їх структура, методологія та методи дослідження. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Психологічні науки. – 2023. – №12.

12. Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?. *American psychologist*, 59(1), 20. Режим доступу: <https://www.tc.columbia.edu/faculty/gab38/faculty-profile/files/americanPsychologist.pdf>.

13. Di Fiorino, M., Marunkevych, M., Madeira, L., & Figueira, M. L. (2022). An Unexpected War in Ukraine: What Should we Expect? The Consequences of War among Ukrainian Refugees. *Revista Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental*, 8(2), 28-30.

14. New Voice. 18 місяців надії і болю. Вісім цифр, що визначили півтора року великої війни з Росією. Режим доступу : <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/udari-po-moskvi-100-tisyach-zlochiv-rf-v-ukrajini-8-faktiv-pro-vynu-infografika-novini-ukrajini-50348277.html>

15. Selye, H. (2016). Stress without distress. *The Journal of Neuroscience*, 4(1), 78-89. Retrieved from <https://neuroscience.com.ua>

3.7. Функціонування сімейної системи і постстресова психологічна дезадаптація учасників бойових дій: взаємодія феноменів, варіанти взаємовпливу, медико-психологічна підтримка

Маркова М. В.

Актуальність. Однією з проблем, з якими стикаються країни, які проводять військові операції, є психологічні наслідки участі в бойових діях, що розвиваються як відповідь на потужне джерело травматичного досвіду не тільки у комбатантів, а і у членів їх родин, насамперед, дружин [–5].

Серед загальної кількості сучасних факторів макросоціального стресу, найбільший ступінь негативного впливу на учасників бойових дій і членів їх сімей мають воєнний та цивільно-військовий фактори. Вразливою групою щодо дії воєнного фактору стають бійці, що захищають країну, беручи участь у бойових діях. Найбільш впливовими стресорами при цьому стають: а) відчуття перманентної вітальної загрози; б) необхідність вбивати; в) смерть побратимів; г) побутова невлаштованість; г) військові фізіологічні стресори.

Під негативний вплив цивільно-військового фактору підпадають, в першу чергу, члени родин військовослужбовців – як ті, хто втратили своїх захисників, так і ті, хто дочекався повернення рідних. В цьому випадку найбільш значущий стресовий вплив має необхідність перебудови звичного способу життя, існування в умовах невизначеності майбутнього та перманентної тривоги за близьку людину, що бере участь в бойових діях. Але, навіть після благополучного повернення екскомбатанта додому фізично неушкодженим, він сам та його родина стикаються з новими неочікуваними викликами.

Кожен учасник бойових дій потребує певного часу для адаптації до мирного життя. З проблемами адаптації демобілізованого військовослужбовця сім'я зіштовхується вже в перший місяць після повернення бійця додому. При поверненні демобілізованого до мирного життя, у багатьох випадках сприйняття ним навколиш-

нього середовища відбувається через «військову призму дійсності», загострення відчуття біполярного сприймання світу за парадигмою «свій» – «чужий»: «Ми повернулися . . . Колишніми нам не стати. . . і не дуже хочеться. Як ви тепер будете розмовляти з нами, людьми, які не розуміють відтінків сірого? Нова чорно-біла система координат проста: є свій – є ворог» [6].

Якщо клінічно окреслені психопатологічні розлади зустрічаються, за даними літератури, у 15 – 80 % екскомбатантів, то поствоєнні донозологічні патологічні зміни у вигляді постстресової психологічної дезадаптації (ППД), що концептуалізується в рамках моделі «передхвороби», мають місце у переважній більшості учасників бойових дій [7–9]. Основними проявами ППД у екскомбатантів ми вважаємо наступні:

- а) відчуття відчуження, «покинутості» і «непотрібності»;
- б) когнітивний дисонанс через байдужість «мирного» суспільства до війни;
- в) стійке переконання, що усі цивільні не можуть зрозуміти, що пережив війн;
- г) соціальна непристосованість, безробіття;
- г) спроба застосувати в мирному житті нові набуті поведінкові стратегії, що негативно оцінюється близькими;
- д) неспроможність мирного врегулювання сімейних конфліктів, випадки фізичного, сексуального й психологічного насильства;
- є) досвід зняття психоемоційної напруги вживанням психоактивних речовин.

Все це, безперечно, накладає відбиток на сімейні відносини, бо більшість з членів родин демобілізованих військовослужбовців не готові приймати об'єктивні зміни, що відбулися з їх рідними, чекаючи допомоги від них, замість того, щоб бути готовими цю допомогу надати бійцям. Таким чином, замість потужного джерела психологічного реабілітаційного ресурсу, родина бійця перетворюється на додатковий психотравмуючий чинник, обтяжуючи і без того складний психологічний стан екскомбатанта.

Мета. Дослідити сімейні системи і постстресову психологічну дезадаптацію УБД.

Результати дослідження. За даними Науково-дослідницького центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, 80 % розлу-

чень, що зафіксовані в Україні протягом 2015 – 2016 рр., відбулися в родинях демобілізованих бійців, причому переважна більшість з них – в перші півроку після повернення з війни. За іншими даними, протягом року після демобілізації, розпадаються або опиняються на межі розлучення від 35 до 60 % родин учасників бойових дій [цит. за 10].

Американським дослідженням ще у 1992 році було доведено, що в родинях ветеранів В'єтнамської війни спостерігався підвищений рівень серйозних та дифузних проблем функціонування, зокрема, вдвічі вищий, порівняно зі звичайними сім'ями, індекс подружніх проблем, на 30 % збільшений рівень насильства та в шість разів менш виражене відчуття щастя [11]. Зарубіжні публікації останніх років описують феномен вторинної травматизації дружин бійців, що повернулися після участі в бойових діях [12, 13]. Результати хорватського дослідження констатували наявність у дружин комбатантів з ознаками посттравматичного стресового розладу (ПТСР) вдвічі вищий відсоток депресії і тривоги, порівняно з дружинами ветеранів без ПТСР (77,5 % проти 32,5 %), на 20 % збільшену поширеність соматичних захворювань, а також тиск відчуття тягаря відповідальності за родину, що відбувалось на тлі проявів емоційного, словесного і фізичного насильства, яке вони зазнавали з боку чоловіків [14]. Ізраїльськими вченими доведено, що дружини бійців з ознаками посттравматичної психологічної дезадаптації гірше, порівняно з жінками зі звичайних родин комбатантів, оцінюють подружню сумісність, а сімейні відносини сприймають як менш згуртовані та позбавлені консенсусів [15].

На думку Г. С. Росінського, сім'я є одним з найважливіших чинників формування психоемоційного стану військовослужбовця, який бере участь у бойових діях, та реадaptaції та ресоціалізації комбатантів, а стан сімейної взаємодії відіграє провідну роль як у ефективній адаптації військовослужбовців, так і, за наявності порушень нормального сімейного функціонування, може стати вагомим чинником психосоціальної дезадаптації учасників бойових дій [10].

У зробленому ним аналізі сучасних наукових джерел наведено результати дослідження 179 сімей (133 синів і 182 дочок) австралійських ветеранів В'єтнамської війни, яке показало, що фактор участі комбатантів у бойових діях збільшує ризик посттравматичного роз-

ладу у їх дітей, а також ймовірно збільшує ризик інших психіатричних проблем. Діти комбатантів-учасників В'єтнамської війни частіше, ніж в цілому в популяції, потрапляли у дорожньо-транспортні пригоди, з ними частіше ставалися нещасні випадки; сини комбатантів частіше вживали токсичні хімічні речовини, а дочки – з більшою ймовірністю ставали жертвами сексуального насильства. У дітей комбатантів (як у синів, так і у дочок) виявлено більш високі рівні депресії і тривожності, у них частіше виявлялися ознаки посттравматичного розладу, а також вищі рівні алкоголізації та наркотизації. У дітей учасників бойових дій з ознаками посттравматичного розладу були виявлені більша поширеність хімічних аддикцій, депресії та суїцидальних думок. Автори підкреслюють наявність тісного зв'язку між посттравматичними розладами у дітей комбатантів і супутніми психічними розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин, депресією і тривогою, і роблять висновок щодо того, що наслідки перенесеної учасниками бойових психотравми можуть зберігатися у наступних поколіннях [цит. за 10].

Автори іншого дослідження, проаналізованого Г. С. Росінським, Milenković T. et al., наголошують, що екскомбатанти, які брали участь у бойових діях, мають суттєві проблеми у сімейному функціонуванні, незалежно від наявності чи відсутності симптоматики посттравматичного стресового розладу; такі проблеми безпосередньо пов'язані з досвідом воєнної психотравми. При цьому наслідки перенесеної травматизації поширюються також на членів сім'ї комбатанта, що потребує цілеспрямованої психологічної допомоги у напрямку зменшення психопатологічної симптоматики і сімейної реінтеграції комбатантів [цит. за 10]. Denning L. A. et al. зазначають, що члени сімей військовослужбовців потребують особливої психологічної допомоги, оскільки піддані стресовому навантаженню; найчастіше стикаються з афективними розладами (депресія, тривога, агресивність), викривленням соціальної взаємодії, а також алкоголізацією і зловживанням іншими психоактивними речовинами [цит. за 10].

Рекомендації для членів сімей учасників Антитерористичної операції, запропоновані Управлінням по роботі з особовим складом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на основі досвіду подолання посттравматичного синдрому (2015), зазначають, що перебування чоловіка на фронті є важким

психоемоційним стресом для дружини, але не менш серйозним психологічним стресом може бути процес адаптації сім'ї після повернення бійця додому. Проблеми адаптації можуть бути пов'язані з необхідністю зміни поведінкових моделей, набутих в умовах бойових дій при переході до мирного життя, а також неадекватними очікуваннями мікросоціального оточення, насамперед, дружин, і неконструктивними поведінковими стратегіями [16].

Деякі дослідники наголошують на підвищеному емоційному навантаженні, що несуть сім'ї військових у період очікування повернення чоловіків з зони бойових дій; а після повернення стикаються з порушеннями психологічного функціонування і психопатологічними проявам, пов'язаними з перенесеним бойовим стресом. Дружини учасників бойових дій змушені нести підвищене емоційне та фізичне навантаження на всіх етапах, як у період бойової служби чоловіка, так і на етапі його ресоціалізації, вже після повернення до мирного життя. Це навантаження може суттєво ускладнювати емоційне і фізичне самопочуття дружин ветеранів, викликаючи скарги на напружені відносини, сімейний дискомфорт, конфліктність. Доволі часто дружинам комбатантів буває важко зрозуміти і прийняти зміни, які сталися з чоловіками, це викликає страх, тривогу, дратівливість, безсоння, втому і переживання за подальшу долю своїх родин [цит. за 10].

У рекомендаціях щодо соціально-психологічної адаптації демобілізованих учасників АТО та їх сімей, наголошується, що дружина військовослужбовця за час його відсутності могла стикатися з різними проблемами і навчитися самотійно вирішувати їх. Це може породжувати у неї почуття злості, що їй довелося самотійно справлятися з проблемами, а також і відчуття гордості за свої досягнення і незалежності від чоловіка; такі прояви можуть бути фактором дестабілізації сімейних відносин і потребувати перебудови існуючих моделей внутрішньосімейної взаємодії. Повернення військовослужбовця додому може супроводжуватися проблемами у стосунках, пов'язаними з появою нових знайомих та друзів, а також із почуттям підозри невірності жінки. Автори наголошують, що у цих ситуаціях члени родини обов'язково повинні розмовляти один з одним і обговорювати почуття, які при цьому виникають, а також разом шукати шляхи вирішення проблем [17]. Таким чи-

ном, сім'я учасника бойових дій представляє собою специфічне соціальне і психологічне явище, взаємовідносини і функціонування якого значною мірою зумовлені психологічними та психопатологічними трансформаціями, що відбуваються з екскомбатантом під час його участі у воєнних діях. З огляду на зазначене, нами спільно з Г. С. Росінським було здійснено дослідження, метою якого була обґрунтування й розробка програми заходів психологічної корекції й реабілітації порушення здоров'я сім'ї демобілізованих учасників бойових дій, на основі вивчення його феноменології та механізмів розвитку [1 – 4, 10]. Для цього протягом 2015–2018 рр. було комплексно обстежено 100 сімей демобілізованих військовослужбовців, що брали участь у бойових діях, та їх дружин – всього 200 осіб. За критерієм успішності подружніх стосунків, обстежені родини були розділені на дві групи. Основну групу (ОГ) склали 72 подружніх пари з порушенням здоров'я родини, групу порівняння (ГП) – 28 успішних сімейних пар (в дослідженні проводили порівняльний аналіз результатів як загальних груп ОГ і ГП, так і в залежності від їх гендерної приналежності). В дослідженні використовували соціально-демографічний, клініко-психопатологічний і психодіагностичний методи, а також системно-структурний аналіз сексуального здоров'я.

Враховуючи сучасні уявлення стосовно ролі психотравматичного досвіду у вигляді участі в бойових діях на стан психічного здоров'я і соціального функціонування комбатанта та його близьких, при аналізі і інтерпретації отриманих результатів, ми виходили з того факту, що поствоєнні патологічні зміни у вигляді ППД, що концептуалізуються в рамках моделі «передхвороби», мають місце у переважної більшості учасників бойових дій [7] (табл. 1).

Отже, в результаті дослідження встановлено, що ознаки *психічної і поведінкової дезадаптації* у вигляді викривлення психоемоційного і напруженості аддиктивного статусів виявилися притаманними більшості комбатантів та їх дружин. У 78,0 % демобілізованих учасників бойових дій та 24,0 % їх дружин спостерігалися психопатологічні клінічно окреслені зміни психоемоційної сфери. В нозологічній структурі у чоловіків превалювали невротичні, пов'язані зі стресом розлади (60,0 %), а більше половини випадків (51,0 %) складали реакція на тяжкий стрес та адаптаційні

розлади; у жінок також переважали адаптаційні розлади (17,0 %). Провідними психопатологічними феноменами були тривожно-депресивні – ізольовані або поєднані.

Таблиця 1

**Клініко-психологічний зміст і розповсюдженість
проявів складових ППД в родинх демобілізованих
військовослужбовців – учасників бойових дій**

Клас- тер МКХ- 10	Нозологія	Чоловіки		Жінки		Р
		абс.	%	абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Прояви психічної дезадаптації						
F 43	Реакція на тяжкий стрес та адаптаційні розлади					
F 43. 1	Посттравматичний стресовий розлад	20	20,0	0	0,0	0,0001
F 43. 2	Адаптаційні розлади	31	31,0	17	17,0	0,0001
F 43. 22	Адаптаційний розлад, змішана тривожно-депресивна реакція	14	14,0	13	13,0	0,0001
F 43. 21	Адаптаційний розлад, пролонгована депресивна реакція	11	11,0	0	0,0	0,0004
F 43. 23	Розлад адаптації з переважанням порушення інших емоцій	6	6,0	4	4,0	0,3738
F 45. 3	Соматоформна вегетативна дисфункція	9	9,0	7	7,0	0,3976
F 06. 6	Органічний емоційно нестійкий (астенічний) розлад	8	8,0	0	0,0	0,0034
F 34. 1	Дистимія	5	5,0	0	0,0	0,0297
F 62. 0	Стійкі зміни особистості після катастрофічного переживання	2	2,0	0	0,0	0,2487
F 07. 2	Посткомоційний синдром	3	3,0	0	0,0	0,1231

Продовження табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
Прояви поведінкової дезадаптації						
F 10. 2	Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю					
F 10. 201	Синдром залежності внаслідок вживання алкоголю, на теперішній час утримання (часткова ремісія)	8	8,0	0	0,0	0,0034
F 10. 25	Синдром залежності внаслідок вживання алкоголю, постійне вживання	5	5,0	0	0,0	0,0297
F 10. 26	Синдром залежності внаслідок вживання алкоголю, епізодичне вживання (дипсоманія)	10	10,0	0	0,0	0,0008
F 17. 25	Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання тютюну, синдром залежності (постійне вживання)	64	64,0	33	33,0	0,0001
F 15. 25	Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн, синдром залежності (постійне вживання)	11	11,0	0	0,0	0,0004
F 12. 26	Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання каннабіноїдів, синдром залежності, епізодичне вживання	5	5,0	0	0,0	0,0297
Z 72	Проблеми, пов'язані зі способом життя					
Z 72. 0	Вживання тютюну	12	12,0	16	16,0	0,5000
Z 72. 1	Вживання алкоголю	39	39,0	28	28,0	0,0669
Z 72. 6	Участь у азартних іграх	7	7,0	0	0,0	0,0070
Z 72. 8	Інші проблеми, пов'язані зі способом життя (захоплення комп'ютерними іграми, інтернет-серфінг)	10	10,0	1	1,0	0,0048

Продовження табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
Прояви особистісної дезадаптації						
Z 73	Проблеми, що мають відношення до утруднень у рішенні повсякденних життєвих питань					
Z 73. 1	Акцентуація особистісних рис	89	89,0	73	73,0	0,0032
Z 73. 2	Брак розслаблення та відпочинку	100	100,0	100	100,0	1,0000
Z 73. 3	Стрес, що не класифікований у інших рубриках	27	27,0	32	32,0	0,2677
Z 73. 4	Неадекватні соціальні навички, що не класифікуються в інших рубриках	31	31,0	0	0,0	0,0001
Прояви соціальної дезадаптації						
Z 59	Проблеми, пов'язані з житлом та економічними обставинами	58	58,0	63	63,0	0,2815
Z 56	Проблеми, пов'язані з зайнятістю та безробіттям	64	64,0	72	72,0	0,1443
Z 60	Проблеми, пов'язані з соціальним середовищем					
Z 60. 0	Проблеми адаптації при переході від одного життєвого циклу до іншого	100	100,0	100	100,0	1,0000
Прояви сексуальної дезадаптації						
F 52	Статева дисфункція, не обумовлена органічним розладом або хворобою					
F 52. 0	Відсутність або втрата статевого потягу	24	24,0	51	51,0	0,0001
F 52. 11	Відсутність сексуального задоволення	23	23,0	67	67,0	0,0001
F 52. 2	Відсутність генітальної реакції	15	15,0	0	0,0	0,0001
F 52. 3	Оргазмічна дисфункція	7	7,0	58	58,0	0,0001
F 52. 4	Передчасна еякуляція	6	6,0	0	0,0	-
Прояви сімейної дезадаптації						
Z 63	Проблеми, пов'язані з сімейними обставинами					

1	2	3	4	5	6	7
Z 63. 0	Проблеми у стосунках з дружиною / чоловіком	64	64,0	72	72,0	0,1443
Z 63. 1	Проблеми у стосунках з батьками або батьками дружини / чоловіка	25	25,0	36	36,0	0,0621
Z 63. 2	Брак сімейної підтримки	72	72,0	72	72,0	1,0000

Виразеність та клінічний зміст тривожно-депресивної симптоматики значуще різнився у осіб з різним станом задоволення подружніми стосунками ($p < 0,05$). Серед комбатантів, незадоволених подружнім життям, 75,0 % мали місце депресивні прояви на рівні легкої, а у 11,1 % – помірної депресії; клінічно значущі тривожні симптоми були характерними для 58,3 %. Серед учасників бойових дій, що відчували задоволення подружніми стосунками, у 75,0 % ознак депресивного реагування не виявлено, у 25,0 % – на рівні легкої депресії. Дружини комбатантів, незадоволені подружнім життям, потерпали від клінічно виражених проявів патологічної тривоги в 33,3 % випадків, а від симптомів депресії легкої вираженості – у 58,3 % випадків; серед жінок, задоволених подружніми стосунками, прояви депресії легкого рівню мали місце у 7,2 %. Серед обстежених переважала схильність до аддикції за об'єктами хімічного походження (напруженість аддиктивного статусу – від клінічно окреслених розладів до небезпечного або шкідливого вживання – за тютюном та/або алкоголем спостерігається у всіх комбатантів та 70,0 % їх дружин); кількість випадків схильності до вживання об'єктів нехімічного походження становила 27,7 % від загальної кількості. За нозологічною структурою клінічно окреслених розладів переважна більшість мала залежність від тютюну (64 % чоловіків та 33 % жінок).

Більша вираженість і варіативність аддиктивної поведінки зустрічалась серед подружжів, незадоволених подружнім життям: серед комбатантів у 68,1 % діагностовано тютюнову залежність, 31,9 % мали залежність від алкоголю, по 15,3 % – від вживання психостимуляторів або кави/чаю, 6,9 % – канабіноїдів; 45,8 % їх дружин мали залежність від тютюну, у 30,6 % встановлене вживання зі шкідливими наслідками алкоголю, у 19,4 % – кави/чаю,

у 12,5 % – телебачення або седативно-снотворних препаратів. У комбатантів, що втішались подружніми стосунками, аддикція на рівні залежності спостерігалась тільки за тютюном (53,6 % випадків), а серед їх дружин аддиктивна поведінка реалізовувалася на рівні вживання зі шкідливими наслідками (21,4 % – за алкоголем, 17,9 % – тютюном, 14,3 % – їжею).

У учасників бойових дій та їх дружин виявлено п'ять особистісних персоніфікаційних профілів, більшість з яких виявилась деструктивними, що свідчило про наявність ознак *особистісної дезадаптації*. Для подружжів, незадоволених власними стосунками, характерними були патологічні депресивно-інтровертивний (41,7 % комбатантів, 34,7 % дружин), невротично-депресивний (25,0 % чоловіків, 22,2 % жінок) й відносно патологічний афективно-лабільний (по 26,4 %) профілі. Серед пар, задоволених подружніми стосунками, превалювали збалансований афективно-стабільний (60,7 % чоловіків, 71,4 % жінок) або відносно патологічний афективно-лабільний (32,1 % чоловіків, 28,6 % жінок) профілі.

Між подружжями, незадоволеними спільним життям, панували неконструктивні (суперництво або уникнення) або відносно конструктивні (приспосовування та компроміс) поведінкові патерни виходу з конфліктних ситуацій; це відбувалося на тлі використання чоловіками неконструктивних стратегій копінг-поведінки усіх модальностей, а жінками – неконструктивних з відносно конструктивними. Задоволені подружжя використовували поведінкові стилі співпраці та компромісу, а також здебільшого адаптивні копінги усіх модальностей. У більшості комбатантів та питомої ваги їх дружин встановлені труднощі психосоціального функціонування в різних сферах, що продемонструвало наявність ознак у них *соціальної дезадаптації*. Проте, якщо труднощі в професійній та соціальній сферах випробовували більшість чоловіків, то з проблемами подружнього життя та взаємин з родичами стикалися 72,0 % подружжів, в той час як 28,0 % родин оцінювали сферу подружнього життя як успішну і ресурсну.

Для чоловіків, незадоволених подружніми стосунками, були характерні ознаки соціально-психологічної дезадаптації, що проявлялося накопиченням дезадаптивних форм реагування та поведінки, відчуттям психоемоційного напруження, незадоволеністю собою та іншими. Їх дружин характеризувала менша вираженість

дезадаптивних проявів. Якість життя подружжів, незадоволених сімейними стосунками, виявилась істотно нижчою, ніж у успішних родин, як за інтегральним показником, так і за окремими шкалами, особливо – за психоемоційним благополуччям, міжособистісною взаємодією та соціо-емоційною підтримкою.

Прояви *сексуальної дезадаптації* у вигляді порушення сексуального здоров'я зустрічались у подружжів, незадоволених власними стосунками: відсутність або втрата статевого потягу F 52.0 відмічалась у 33,3 % чоловіків та 70,8 % жінок; відсутність сексуального задоволення – у 32,0 % і 93,0 % жінок; еректильна дисфункція – у 20,8 % чоловіків, передчасна еякуляція – у 8,3 % чоловіків; оргазмічна дисфункція – у 80,6 % жінок даної групи. Системно-структурний аналіз сексуального здоров'я дозволив виділити два клінічних варіанта його порушення у обстежених цієї групи: виражене порушення зі стрижньовим ураженням психологічного і соціально-психологічного компонентів було діагностовано у 29 пар, відносно порушення зі стрижньовим ураженням соціально-психологічного компоненту – у 43 подружжів.

Серед родин комбатантів зустрічались три клініко-психологічних варіанти стану здоров'я сім'ї, два з яких були свідченням наявності *сімейної дезадаптації*: гармонійно-конструктивна родина (28,0 %), травматично-неузгоджений варіант порушення здоров'я сім'ї (43,0 %), який характеризувався дискретним ураженням окремих компонентів сімейної системи, та деструктивно-конгруентний варіант порушення здоров'я сім'ї (29,0 %), для якого характерним виявилось тотальне ураження усіх компонентів. Для родин комбатантів з деструктивно-конгруентним варіантом порушення здоров'я сім'ї (29,0 %) характерними були значна подружня незадоволеність, виражене порушення сексуальної реалізації, деструктивний тип сімейних відносин та патологічна конгруентність вираженого невиконання подружжями більшості сімейних функцій.

Для сімей з травматично-неузгодженим варіантом порушення здоров'я сім'ї (43,0 %) притаманними були відносні подружня незадоволеність та порушення сексуального здоров'я, а також відносно деструктивний тип сімейної взаємодії з дисконгруентною оцінкою часткового невиконання родинних функцій. Гармонійно-конструктивним родинам виявились властиві задоволення

подружніми стосунками, відсутність порушень сексуальності, конструктивний тип родинних стосунків та конгруентне успішне виконання більшості функцій сім'ї.

Узагальнення результатів підтвердило сформульовану нами гіпотезу про полімодальність феномену порушення здоров'я родин учасників бойових дій, та стало основою для розробки програми психокорекції порушення здоров'я родин комбатантів, яка враховувала як спільні закономірності його розвитку, так і змістовні відмінності його проявів, залежно від клініко-психологічного варіанту.

Треба зазначити, що розробка сучасних методів корекції порушень функціонування сім'ї є актуальною і складною задачею. Важкість вирішення задачі комплексної корекції порушень здоров'я сім'ї пов'язана з різноманіттям причин розладів сімейної адаптації, поліморфністю порушень, а також тим, що в генезі сімейної дезадаптації визначальне значення мають особистісні особливості особистості кожного з подружжя та їх поєднання.

Росінський Г. С. зазначає, що Matthews M. пропонує виділяти окремий напрямок психологічної допомоги комбатантам – військову позитивну психологію. Основні заходи цього напрямку передбачають розробку протоколів збільшення психологічної резильєнтності у період бойових дій та після них, вивчення взаємодії між позитивними не когнітивними ознаками та когнітивними здібностями для покращення процесу прийняття рішень в умовах стресу, відбір і підготовку військових, наукові дослідження і просвітницькі заходи для покращення психологічного стану комбатантів. Принциповою відмінністю від існуючої системи надання психологічної допомоги військовослужбовцям. Окремим напрямком позитивної є використання її принципів для покращення функціонування для покращення життя сімей комбатантів, насамперед, дітей. При цьому комбатанти отримують інформацію про сильні сторони свого характеру, позитивних емоціях, а також про побудову позитивних соціальних відносин. Автор вважає, що епігенетичний людино-інтерактивний інтерфейс та інші досягнення на основі нейронаук відкривають нові можливості для підвищення когнітивних, соціальних, емоційних та фізичних здібностей людини [цит. за 10].

Шпильовим Я. В. було запропоновано триетапну систему надання медико-психологічної допомоги сім'ям учасників антитерористичної

операції, що включає етап комплексної психодіагностики, на якому здійснюється діагностика і аналіз клініко-психопатологічної феноменології, особливостей патодинаміки, супутніх психопатологічних реакцій, стану соціальної адаптації, соціального функціонування та якості життя, терапевтичний етап, на якому безпосередньо реалізуються фармакотерапевтичні, психотерапевтичні та психокорекційні заходи, і етап психопрофілактики, який розпочинається після завершення основних терапевтичних заходів і досягнення стійкого лікувального ефекту. Запропонована система включає базову фармакологічну терапію, основу якої складають антидепресанти, а за необхідності додаються атипові антипсихотики, тимостабілізатори або транквілізатори і снодійні; заходи з психоосвіти, що спрямовані на інформування про причини змін у психоемоційній сфері, психологічні механізми, чинники психопатологічної симптоматики, правила психогігієни та психопрофілактики, роз'яснення вимог лікувального та реабілітаційного режиму, встановлення комплаєнтних відносин; когнітивно-поведінкову терапію, метою якої є корекція основних дисфункціональних переконань і установок, неконструктивних форм поведінки, створення конструктивних поведінкових моделей і переконань; сугестивну психотерапію, що реалізується у вигляді аутосугестивної терапії і спрямована на навчання контролю за власним психоемоційним станом, зменшенню виразності тривоги, песимізму, апатії та дратівливості; і сімейну психотерапію, що передбачає встановлення сімейного діагнозу, усунення сімейних конфліктів, забезпечення ролі сім'ї як ключового фактору мікросоціальної адаптації пацієнтів [цит. за 10].

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі запропоновано ряд психотерапевтичних та психокорекційних підходів до корекції сімейної дисфункції і пов'язаних з цим розладів у осіб, що зазнали впливу важкого стресу, включаючи бойові дії. Однак ці заходи потребують удосконалення та розвитку для забезпечення більш ефективної реабілітації і відновлення успішного сімейного функціонування в родинях військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. Психологічну підтримку здоров'я родин екскомбатантів, ми пропонуємо здійснювати через впровадження розробленої програми, яка враховує як спільні закономірності розвитку його порушення, так і змістовні відмінності його проявів, залежно від клініко-психологічного варіанту (табл. 2).

Таблиця 2

**Програма заходів психологічної корекції та підтримки
функціонування сім'ї учасників бойових дій**

Етап	Мета	Мішень	Засіб
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Мотиваційний (1 зустріч)	Формування терапевтичного альянсу і мотивації на участь у роботі	Негативні установки щодо співпраці з лікарем-психологом	Елементи мотиваційного інтерв'ю
Діагностичний (2 зустрічі)	Ідентифікація мішеней психокорекції	Психоемоційний і аддиктивний статус, особистісні й поведінкові патерни, особливості психосоціального функціонування, сексуальної реалізації і сімейної взаємодії	Психодіагностика
Інформаційної підтримки (2 зустрічі)	Підвищення інформованості щодо постстресової психологічної дезадаптації та її впливу на функціонування комбатанта та його близьких	Брак інформації стосовно впливу психотравматичного досвіду на стан психічного здоров'я, соціального і сімейного функціонування	Елементи психоосвіти
<i>Активної психокорекції (приблизно півроку) стадія стабілізації</i>	Редукція психопатологічної симптоматики, нівеляція напруженості аддиктивного статусу комбатанта	Психічна і поведінкова постстресова дезадаптація	Травмофокусована КПТ, групова ПТ, АТ, стрес-менеджмент, м'язова релаксація

1	2	3	4
партнерська стадія	Редукція психопатологічної симптоматики, профілактика вторинної травматизації дружини	Психічна і поведінкова постстресова дезадаптація	групова ПТ, АТ, стрес-менеджмент, м'язова релаксація
подружня стадія	Гармонізація дезадаптивних особистісних і поведінкових патернів, нівеляція соціально-психологічної дезадаптації подружжів	Особистісна і психосоціальна постстресова дезадаптація	КПТ, когнітивно орієнтована ПТ, реконструктивна й персоналістична ПТ, тренінги ефективної комунікації та подолання конфліктів
сімейна стадія	Нормалізація сімейної взаємодії	Сексуальна і сімейна постстресова дезадаптація	Сімейна, парна ПТ, елементи сексуально-еротичного, рольового психосексуального тренінгів
стадія визначення ефективності	Оцінка успішності психокорекції	Психоемоційний статус, особливості сімейної взаємодії	Психодіагностика
Психологічної підтримки (за запитом)	Підтримка і збереження позитивних змін	Нові навички адекватного сімейного функціонування	Групова ПТ, групи самодопомоги

Програма складається з 5-ти етапів: мотиваційного, діагностичного, інформаційної підготовки, активної психокорекції та психологічної підтримки. Етап активної психокорекції містить 5 стадій: стабілізаційну, партнерську, подружню, сімейну й оцінки ефективності.

Перші три етапи і дві стадії активної психокорекції є неспецифічними для варіанта порушення здоров'я родини, а об'єм і зміст психокорекційних заходів подружньої і сімейної стадій є диференційованими з урахуванням клініко-психологічного варіанта порушення здоров'я родини комбатанта. Оцінка ефективності, здійснена через порівняльний аналіз показників подружньої задоволеності і якості життя осіб психокорекційних і контрольних груп, довела їх дієвість відносно обраних мішеней психокорекційного впливу.

Ключові слова: сімейна адаптація, функціонування сімейної системи, постстресова психологічна дезадаптація, учасники бойових дій, психотерапія.

Література.

1. Маркова М. В., Росінський Г. С. Порушення здоров'я сім'ї демобілізованих військовослужбовців-учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми. Український вісник психоневрології. 2018. Том 26, випуск 1 (94). С. 78 – 82.
2. Маркова М. В., Росінський Г. С. Порушення здоров'я сім'ї у учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція. Медична психологія. 2019. Том 14, № 1 (53). С. 9 – 15.
3. Маркова М. В., Росінський Г. С. Порушення здоров'я родини в учасників бойових дій у світлі концепції постстресової психологічної дезадаптації: клініко-психологічні прояви, механізми формування, засади психокорекції. Проблеми безперервної медичної науки та освіти. 2019. № 3 (35). С. 5 – 9.
4. Маркова М. В., Росінський Г. С. Психологічна корекція порушень здоров'я сім'ї УБД: обґрунтування, структура, результати впровадження / Охорона ментального здоров'я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної війни: колективна монографія за редакцією академіка В. І. Цимбалюка. Київ, ВСВ «Медицина», 2020. 256 с. С. 223-245.
5. Омелянович В. Ю. Суспільні та сімейні аспекти діагнозу «посттравматичний стресовий розлад» у військовослужбовців після повернення з зони бойових дій // Psychosomatics: Science and Practice. 2019. Vol 4. №2.
6. Когут Л. Не називайте їх АТО-шниками: психологія учасників бойових дій // URL: <http://fakty.cv.ua/2018/04/ne-nazyvaite-ikh-atoshnykamypsykholohiia-uchasnykiv-boiovykh-dii/> (дата звернення: 20. 12. 2023).
7. Постстресова психологічна дезадаптація: закономірності розвитку і специфіка клінічних проявів дезадаптивних станів у окремих специфічних груп населення, вразливих до дії макросоціального стресу / За

заг. ред. проф. Маркової М. В. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 492 с. ISBN 978-617-7845-88-0

8. Марута Н. О., Заворотний В. І. Принципы реабилитации военно-служащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства // Український вісник психоневрології. 2018. Том 26, випуск 3 (96). С. 33-38.

9. Денисенко М. М., Лакінський Р. В., Шестопалова Л. Ф., Лінський І. В. Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів // Український вісник психоневрології. 2017. Том 25, випуск 2 (91). С. 40-44.

10. Росінський Г. С. Порушення здоров'я сім'ї у учасників бойових дій (феноменологія, механізми розвитку, психологічна корекція). – Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 19. 00. 04 «Медична психологія». – Харків, 2019. 184 с.

11. Jordan B. K., Marmar C. R., Fairbank J. A., Schlenger W. E., Kulka R. A., Hough R. L., Weiss D. S. Problems in families of male Vietnam veterans with posttraumatic stress disorder // J Consult Clin Psychol. 1992 Dec. V. 60(6). P. 916-26.

12. Francisković T, Stevanović A, Jelusić I, Roganović B, Klarić M, Grković J. Secondary traumatization of wives of war veterans with posttraumatic stress disorder // Croat Med J. 2007 Apr. 48 (2). P. 177-184.

13. Klarić M, Frančisković T, Obrdaj EC, Petrić D, Britvić D, Zovko N. Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder // Psychiatr Danub. 2012 Sep; 24 (3). P. 280 – 286.

14. Klaric M., Kvesic A., Mandic V., Petrov B., Franciskovic T. Secondary traumatisatation and systemic traumatic stress // Psychiatr Danub. 2013. 25 Suppl 1. P. 29–36.

15. Dekel R., Levinstein Y., Siegel A., Fridkin S., Svetlitzky V. Secondary traumatization of partners of war veterans: The role of boundary ambiguity // J Fam Psychol. 2016. 30(1). P. 63–71.

16. Рекомендації для членів сімей учасників Антитерористичної операції / упорядковано Управлінням по роботі з особовим складом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на основі досвіду подолання посттравматичного синдрому, узагальненого В. Арабинським. URL: <http://www.mil.gov.ua>

17. Методичні рекомендації щодо соціально-психологічної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції (АТО) та їх сімей // «Дорожня карта» для демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення анти терористичної операції для вирішення питань соціального забезпечення, захисту та інших соціальних гарантій URL <http://www.dszn-zoda.zp.ua/node/733>.

3.8. Психологічна підтримка військовослужбовця з розладами адаптації

Мелещенко Л. В.

Актуальність. Дана (калька з російської) тема є надзвичайно актуальною і важливою в сучасних умовах. Повномасштабна військова агресія, що розпочалася 24 лютого 2022 року може викликати серйозні розлади в адаптації особистості багатьох військових. Важливість цієї теми визначається рядом факторів. По-перше, психічна стійкість військовослужбовців має ключове значення для їх успішної служби та збереження фізичного та психічного здоров'я. Розлади адаптації можуть виникнути як у результаті військових подій, так і через стресові ситуації, пов'язані зі службовими обов'язками. По-друге, відновлення психічної стійкості важливе для успішного повернення військовослужбовців до цивільного життя після завершення служби. Надання психологічної підтримки в цьому контексті сприяє їхній соціальній реінтеграції та запобігає можливим проблемам в адаптації. По-третє, урахування психологічних аспектів військової служби є важливим етапом на шляху до створення комплексної системи підтримки військовослужбовців. Розуміння та врахування психологічних реакцій та розладів адаптації дозволяє ефективно організовувати та надавати необхідну допомогу під час і після служби. Отже, питання психологічної підтримки військовослужбовців з розладами адаптації є важливим аспектом не лише для забезпечення їхнього власного благополуччя, але й для забезпечення стабільності та ефективності військового устрою в цілому. Питання психологічної підтримки військовослужбовців з розладами адаптації у різні періоди досліджували такі науковці, як Т. Майстренко, М. Мушкевич, О. Бондаренко, С. Хоружій, Н. Лозінська, І. Пішко, В. Олійник, М. Сириця та багато інших. На їх праці ми спиратимемося при підготовці даного дослідження.

Мета. Провести теоретичний аналіз та систематизувати психологічні аспекти, що виникають у військовослужбовців під час періоду адаптації після повернення із зони бойових дій, а також розкриття проблем, які супроводжують розлади адаптації в цій ка-

тегорії осіб, і визначення ефективних методів та стратегій психологічної підтримки для полегшення цього процесу.

Результати дослідження. Психологічна підтримка військовослужбовця з розладами адаптації визначається як ключовий аспект турботи про військовослужбовців, які можуть зазнавати негативних впливів під час процесу адаптації до військового життя та після його завершення. Розлади адаптації у військовому середовищі можуть виникнути через різні фактори, включаючи стресові ситуації, непривабливі умови служби, розриви у сімейному житті та вплив бойових подій. У таких випадках важливо виявляти розуміння та надавати відповідну психологічну підтримку.

Однією з ключових особливостей прояву реакцій у демобілізованого бійця є їхнє одночасне виникнення, включаючи як позитивні, так і негативні аспекти. Це вказує на тривале перебування особи у постійному стресі під час бойових дій. Під час постмобілізаційного етапу родини військовослужбовців очікують їхнього повернення з нетерпінням, уявляючи цю зустріч як довгоочікувану подію. Однак реальність може не відповідати їхнім очікуванням, і члени родини можуть стикатися з труднощами у відновленні звичного життя.

Повернення військовослужбовця може не завжди відповідати очікуванням його родини, що може призвести до відчуття відстороненості військовослужбовця від сімейного оточення. Щоб відновити близькість, довіру та підтримку, сім'ям необхідно знову навчитися довіряти одне одному та переглянути сімейні ролі.

Військовослужбовці можуть відчувати, що їхні рідні та друзі не розуміють їхніх переживань, тому вони можуть шукати підтримку серед своїх бойових товаришів. Для надання моральної підтримки демобілізованим військовослужбовцям родинам та друзям слід проявляти розуміння до їхніх реакцій, як позитивних, так і негативних.

Зміни в потребах дітей військовослужбовця під час його відсутності можуть ускладнити їх адаптацію до повернення батька додому. Підготовка дітей до цього важливого моменту включає в себе уважне врахування їхнього віку та вислуховування їхніх почуттів. Необхідно підтримувати дітей, проявляючи розуміння до їхніх емоцій та допомагаючи їм адаптуватися до змін у сімейному оточенні.

Однією з ключових аспектів психологічної підтримки є створення відкритого та довірчого середовища для військовослужбовців, де вони можуть вільно висловлювати свої емоції, переживання та страхи. Психологи повинні ретельно слухати та розуміти індиві-

дуальний досвід кожного військовослужбовця, надаючи їм можливість висловити свої турботи без суджень.

Враховуючи вищезазначене, родинні члени можуть значно сприяти адаптації демобілізованого військовослужбовця. Головне – виявити розуміння, що військовослужбовець може бажати розмовляти чи не бажати цього, і надати йому простір. Важливо утриматися від натискання на розповідь про події в зоні бойових дій та надати підтримку, а не тиснути, оскільки це для нього критично.

Деякі демобілізовані військовослужбовці, які важко адаптуються до цивільного життя, можуть виявляти бажання повернутися до зони конфлікту, спричиняючи непорозуміння в родині («Тобі не потрібна сім'я», «Ти уникнув відповідальності»). Це може свідчити про те, що у військовослужбовця залишилося незавершене, не вирішене завдання. Такі особи були готові до перемоги, але досягти її не вдалося, і це суттєво впливає на їхні почуття.

Щоб запобігти негативним реакціям демобілізованого військовослужбовця, члени родини можуть: надавати військовослужбовцю можливість проводити час один на один з кожним членом родини або близьким другом; підтримувати його в стосунках з іншими, але дозволяти йому проводити час наодинці; забезпечувати можливість взаємодії з бойовими друзями та товаришами; спільно проводити час у різних ситуаціях, таких як прогулянки чи відвідування театрів; висловлювати впевненість у їхньому поверненні та готовності вирішувати будь-які проблеми; розподіляти домашні обов'язки та обговорювати можливі нові зобов'язання; поважати думки та дії кожного члена родини, враховуючи можливість компромісів.

Родинні члени, які зустрічають поверненого військовослужбовця, повинні утриматися від: тиску на бійця розповісти про свій бойовий досвід, оскільки він може бути не готовий до цього; оцінки дій демобілізованого військовослужбовця; вказівок щодо того, що військовослужбовець «повинен» робити; використання усталених висловів або кліше, краще висловлювати турботу та переживання за нього [1, с. 122-123].

Перед родиною стоїть завдання допомагати військовослужбовцеві усвідомлювати реальні можливості працевлаштування враховуючи соціально-економічну ситуацію, формувати правильне розуміння та адекватну реакцію на психологічні труднощі, пов'язані з переходним періодом у житті колишнього учасника військових дій [2].

Окрім того, важливо розвивати та впроваджувати програми навчання та тренінги з психологічної стійкості та стресового менеджменту. Ці програми можуть допомагати військовослужбовцям виявляти та ефективно управляти стресовими ситуаціями, а також навчати їх знаходити конструктивні шляхи розв'язання проблем.

Психологічна підтримка повинна також включати індивідуальні консультації та терапію для тих, хто потребує більш глибокого розгляду своїх проблем. Важливо визнавати унікальність кожного військовослужбовця та його особистий шлях адаптації.

Важливим аспектом є також робота з сім'ями військовослужбовців, яка може допомагати у створенні підтримуючого оточення та розуміння важливості сімейного благополуччя [3].

Напрями психологічної підтримки військовослужбовців, що повернулися із зони бойових дій, та їх родин включають наступне:

1. Індивідуальні консультації та терапія для подолання психічної травми та її наслідків учасників бойових дій, включаючи емоційні порушення та синдром посттравматичного стресового розладу.

2. Корекція та терапія нав'язливих станів та розладів сну.

3. Корекція та терапія психосоматичних розладів та сексуальних дисфункцій.

4. Проведення психологічних тренінгів та індивідуальних консультацій для сімей учасників бойових дій, включаючи батьків, шлюбних партнерів та дітей.

5. Організація психологічних тренінгів та індивідуальних консультацій для осіб, що пережили втрату близьких.

6. Проведення психологічних тренінгів та індивідуальних консультацій для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

7. Індивідуальні консультації та терапія для вирішення проблем подружніх відносин та сімейних дисгармоній.

8. Індивідуальні консультації для допомоги у подоланні труднощів у спілкуванні з особами протилежної статі.

9. Корекція для дітей, включаючи емоційні розлади, страхи, психічні травми, а також вирішення проблем у навчанні та спілкуванні [4, с. 9].

Усі ці заходи спрямовані на те, щоб надати військовослужбовцям ефективні інструменти для подолання розладів адаптації, зміцнити їх психологічну стійкість та забезпечити підтримку на різних етапах їхньої служби та після її завершення.

Висновки. У висновках можна підкреслити, що адаптація військовослужбовців після повернення з зони бойових дій представляє собою складний та чутливий процес, який вимагає уважного розуміння та підтримки з боку родини та суспільства. Зазначити, що недооцінка цього перехідного періоду може спричинити відчуття відстороненості та труднощі в емоційному зближенні військовослужбовця з його близькими. Важливим аспектом є розуміння того, що реакції демобілізованих військовослужбовців можуть бути різноманітними, і кожен з них проходить унікальний шлях адаптації. Тому важливо створювати індивідуальні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки. Доцільним є акцентування уваги на значущості створення відкритого та довірчого середовища для військовослужбовців, де вони можуть вільно висловлювати свої емоції без суджень. Психологічна підтримка повинна бути спрямована на забезпечення можливості вільного обговорення переживань, страхів та невирішених питань. Також, важливим вважається підкреслення ролі сім'ї у процесі адаптації. Члени родини можуть внести суттєвий вклад у підтримку військовослужбовця, розуміючи його потреби та надаючи необхідний простір для самовираження.

Література.

1. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. Учб. посібник для студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. О. Ф. Бондаренко. Харків. Фоліо, 2016. 237с.
2. Мушкевич М. Волинь: як допомогти військовому та його сім'ї реабілітуватися. М. Мушкевич. Режим доступу: <http://www.volynnews.com/news/vidsichagresoruukrayinayedina/volynski-atoshnyky-ne-skhylnido-suyitsydu-ale-yim-potribna-dopomoha/>
3. Методичні рекомендації щодо соціально-психологічної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції та їх сімей. Режим доступу: <http://dszn-zoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/АТО/pamjatka.pdf>
4. Повернення з зони бойових дій. Пам'ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО. Редактор-упорядник: Т. М. Майстренко. Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2015. 32 с.
5. Практикум психологічного консультування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Навчально-методичний посібник Хоружій С. М., Лозинська Н. С., Пішко І. О., Олійник В. О., Сириця М. В. Київ: «Центр учбової літератури», 2023-90 с.

3.9. Психологічна підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Пріб Г. А.

Актуальність. У напружений час соціальних та економічних криз, збройних і військових катаклізмів, впливу військових дій, та пов'язаних з ними стресів, – усе це стає факторами, що викликають негативні емоції та стани [1]. Емоції – це різноманітні переживання особистості, в яких відображаються її життєві відносини із зовнішнім світом та іншими людьми. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [2]. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника [3]. В Україні існує «Єдиний портал вакансій» де особи, зацікавлені в пошуку роботи, можуть здійснювати її самостійний пошук, послуга доступна для вимушено переміщених осіб [4]. Дане законодавче забезпечення із підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб повинно обов'язково враховувати психологічну складову відновлення [5]. Правилами надання психосоціальних послуг з відновлення працездатності внутрішньо переміщених осіб [6] є наступні: *бачити* – бути уважним (ою) до людини, щоб вона відчула, що Ви заці-

кавлені їй допомогти. Підтримуйте зоровий контакт! Спостерігаючи за людиною, Ви можете побачити, як змінюється її емоційний стан під час надання інформації, або коли отримуєте від неї інформацію. Це допоможе визначити саме ту інформацію, яка є актуальною для людини в даний момент, і в разі потреби, надати відповідну психологічну підтримку; *слухати* – під час співбесіди з людиною важливо слухати: очима, нахилом тулуба у бік співрозмовника, жестами, позою, демонструючи уважність, щоб дійсно почути, що саме турбує людину; серцем, із співчуттям, з глибокою повагою. Люди, які пережили стресову ситуацію вимушеного переміщення, можливо, захочуть розповісти, що з ними сталося. Важливо не примушувати людей розповідати про пережите; *спрямовувати* – у разі, якщо людина не проявляє ніяких емоцій у відповідь на Вашу інформацію, не відповідає на запитання, не може зрозуміти, що від неї хочуть, демонструє розгубленість, то це може свідчити про те, що вона не готова до пошуку роботи і потребує іншої допомоги. Необхідно спрямовувати людину до відповідних фахівців, центрів допомоги; *супроводжувати* – консультації є запорукою подальшого успішного працевлаштування, успішної професійної реадптації внутрішньо переміщеної особи. Ви маєте залучити, у разі потреби, необхідних фахівців й соціальних партнерів. Зв'яжіться особисто з роботодавцем, домовтеся про зустріч, з'ясуйте умови праці, інформацію про колектив тощо. Ви маєте виступити посередником.

Мета. Дослідити надання психосоціальних послуг внутрішньо переміщеним особам з метою відновлення їх працездатності та сприяння поверненню на ринок праці. **Завдання:** розвиток психологічної готовності до повернення на ринок праці та відновлення впевненості внутрішньо переміщених осіб у власній працездатності; сприяння поверненню внутрішньо переміщених осіб на ринок праці; відбудова психосоціальних навичок самомотивації.

Результати дослідження. Розроблено «Тренінг з відновлення працевлаштування внутрішньо переміщеними особам» [5]. Тренінг забезпечує придбання наступних компетенції та навичок: здатність оцінювати власну психологічну готовність до працевлаштування; розуміння особистісних ресурсів щодо впевненості у відновленні трудової діяльності; навички активного та відповідального працевлаштування; здатність умотивовано функціонувати на ринку праці;

володіння навичками саморегуляції психічного стану та інструментами для подолання психосоціальних проблем. Структура занять за формою та методах навчання представлена у табл. 1.

Таблиця 1.

Структура занять за формою та методах навчання

Форма навчання	% співвідношення	Метод викладання
Лекція	30	Лекція
Розв'язання вправ	30	Групове
Демонстрація, участь у дискусії	20	Групове
Особисті приклади	10	Індивідуальне
Рефлексія	10	Інтерактивне

Програма тренінгу включає наступне теоретичне та практичне наповнення.

Тема 1. «Виявлення бар'єрів до працевлаштування у внутрішньо переміщених осіб» (опорна лекція).

Бар'єри – це перешкоди на шляху досягнення мети, поставлених цілей з реалізації особистісного потенціалу. Бар'єри виникають через відсутність інформації, можливо, через виникнення ціннісного ставлення, упереджень, стереотипів. Виділяють наступні види бар'єрів: *фізичні* – перешкоди, що заважають руху у просторі: територіальна відстань між учасниками взаємодії, предмети, круті східинки, відсутність ліфтів та пандусів, високі пороги й тротуари тощо. Вони створюють труднощі для людей; *інформаційні* – відсутність чи брак певної інформації. Цей вид бар'єрів виникає через неправильне сприйняття інформації: стереотипи мислення, упереджені думки, невміння слухати співбесідника, неправильне тлумачення та розуміння інформації; *економічні* – брак або відсутність коштів на базові потреби (їжа, одяг та ін.) людини, що опинилась в складній життєвій (фінансовій) ситуації та не може знайти роботу чи джерело заробітку; *інституційні* – це ситуації, коли закони, нормативні документи не враховують потреби внутрішньо переміщених осіб; *психологічні* – характеризуються психічним станом, який описується як небажання щось робити, пасивність, що перешкоджає виконанню задуманих планів та дій. Емоційно людина відчуває переживання,

сором, почуття провини, страху, тривоги, низької самооцінки, які виникають через упередження та стереотипи. Психологічні бар'єри бувають і внутрішніми (характерні для літніх людей, які залишили ринок праці): відчуття пригніченості, самотності. Практичні заняття передбачають виконання справ у табл. 2.

Таблиця 2.

Види бар'єрів та їх характеристика

<i>Вправа 1. Види бар'єрів</i>	Характеристика
Фізичні	
Інформаційні	
Економічні	
Інституційні	
<i>Вправа 2. Психологічні бар'єри</i>	Характеристика
1.	
2.	
3.	

Тема 2. Напрацювання психологічної готовності до відновлення працевлаштування внутрішньо переміщеними особами (опорна лекція).

Психологічна готовність – це характеристика властивостей й психоемоційного стану особистості та є характеристикою професійної здатності. Психологічна готовність людини до діяльності включає: особистісні риси та якості (пам'ять, мислення, увага, здібності, інтереси, переконання), професійні знання, уміння і навички; професійна спрямованість, працездатність, мотивація до виконання професійних задач, етика взаємодії. Мотиваційний, емоційно-вольовий та оцінний компоненти є складовими особистісної готовності до професійної діяльності. *Мотиваційний компонент* включає в себе професійні установки, інтереси, мотиви та прагнення здійснювати професійну діяльність. Основу мотиваційного компоненту складає професійна спрямованість (особисте прагнення людини застосувати свої знання в обраній професійній сфері), у якій виражається позитивне ставлення до професії, бажання вдосконалювати свої професійні здібності. *Емоційно-вольовий компонент* психологічної готовності – сила волі, ціннісні орієнтації, процеси, що забезпечують успішний перебіг і резуль-

тативність професійної діяльності; ініціативність, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, самоконтроль, самовладання, самостійність. *Оцінний компонент* передбачає оцінку відповідності власної професійної підготовки і спроможності (професійні знання, уміння, навички, бажання навчатись нового) розв'язувати професійні задачі. Психологічна готовність включає також професійний саморозвиток та самоудосконалення. Практичні заняття передбачають виконання справ (табл. 3).

Таблиця 3.

Переваги, перешкоди та ресурсна карта працевлаштування

Вправа 1. Переваги та перешкоди працевлаштуванню				
Позитивні сторони (переваги)		Негативні сторони (перешкоди)		
1. ...		1. ...		
Вправа 2. Ресурсна карта працевлаштування [7]				
Критерії		Опис	Як я користуюсь цим благом	Чим я можу допомагати іншим
Хто мене підтримує в родині				
Хто мене підтримує з близьких				
Стороння підтримка				
Мій реальний матеріальний ресурс				
Мої ідеальні плани				
Мої реальні плани				
Позитивний погляд на себе	– Що я знаю			
	– Що я вмію			
	– Мій досвід			
Примітка. Ресурсна карта працевлаштування дає можливість проаналізувати наявні матеріальні, психологічні, соціальні та духовні ресурси й допомогти людині побачити ситуацію не лише з позиції психотравмівного досвіду, але й з позиції відповідальності за своє життя і перспектив адаптації та власного розвитку в нових умовах життєдіяльності.				

Тема 3. Формування самомотивованості до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (опора лекція).

Мотивація – це психофізіологічний процес, який під дією зовнішніх або внутрішніх факторів, стимулює у людей бажання займа-

тися тією чи іншою діяльністю. Мотивація – це спонукання до виконання певної дії. Стимулювання – свідомі дії з метою підвищення ефективності діяльності працівників і трудової організації шляхом використання розвитку їхніх матеріальних і моральних інтересів. Настанови задля особистісної мотивації: мисли позитивно; визнайте, що відволікає Вас від поставленої мети; спродуйте діяти покрово: мої бажання, перешкоди, план, дія, результат; ставте маленькі та чіткі цілі; позбудьтеся установки «я не можу», «у мене не вийде»; складіть список щоденного прогресу; надихайтесь дрібницями щодня; радійте історіям успіху; складіть список причин, які Вас мотивують; шукайте приклади натхнення (фрази, образи), коли ваші сили починають слабшати; знайдіть радника, якому Ви довіряєте; визнайте, що здорова конкуренція є чудовим джерелом мотивації.

Методи особистісної мотивації.

Метод «Якорю». Принцип роботи схожий з виробленням умовних рефлексів. Після кожного виконаного неприємного завдання нагороджувати себе чимось приємним. Припустимо, хтось любить грати на мобільному телефоні. Це заняття забирає багато продуктивного часу. Можна повністю виключити це хобі, але краще використовувати його у якості заохочення. Наприклад, кожні 2 години роботи дозволяти собі півгодини гри. Поступово це увійде в звичку і думка про не бажання працювати вже не буде такою неприємною, адже за ними піде обов'язкове заохочення.

Метод «Швейцарського сиру». Скоріше це алгоритм дій, коли доводиться виконувати величезний обсяг роботи і незрозуміло, з якого боку до нього підійти. У цьому випадку доречно наслідувати приклад мишеняти, вигризати в сирі дірки. Поступово шматок сиру зменшується, досягаючи таких розмірів, що мишеня зможе з'їсти його за один присід. Також і у вирішенні глобальних завдань. Можна потроху «вигризати» з них окремі фрагменти в довільному порядку, поступово зменшуючи обсяг завдання до психологічно комфортних масштабів.

Метод «поїдання жаби». Це прийом, як себе мотивувати на рішення неприємних завдань. Наприклад, запис до стоматолога або похід в податкову. Народна мудрість стверджує: «На сніданок треба з'їсти жабу». Що це означає? Якщо виконати вранці найнеприємніше завдання, це зарядить позитивом на цілий день, оскільки

гірше вже нічого не трапиться. Яскравий приклад – бажання більшості дітей довше простояти в черзі на щеплення. Перший, кому її зробили, забуде про неприємні відчуття, поки інші ще будуть себе «накручувати» під дверима.

Метод «візуалізації». Ефективна схема, яка допомагає швидко надихнутися. Візуалізація означає уявне формування образу результату. Припустимо, хтось хоче влаштуватися на роботу, але на даний момент він не має досвіду. Де йому взяти мотивацію? Може, спостерігати за безтурботними людьми, які щодня проживають своє життя без роботи? Теж не варіант. Єдиний спосіб надихнутися і продовжувати шукати роботу – постійно тримати перед очима образ майбутньої особистої роботи та її позитивних переваг. Практичні заняття передбачають виконання справ (табл. 4, табл. 5).

Таблиця 4.

Опрацювання навичок самоорганізації при працевлаштуванні

<i>Вправа 1. Опрацювання навичок самоорганізації при працевлаштуванні («Поглиначі» і «пастки» часу)</i>			
Нечітка постановка мети		Відсутність самодисципліни	
Відсутність пріоритетів у справах		Невміння довести справу до кінця	
Спроба занадто багато зробити за один раз		Відволікання (шум)	
Відсутність повного уявлення про майбутні завдання і шляхи їх вирішення		Затяжні наради	
Погане планування дня		Недостатня підготовка до бесід та обговорень	
Особиста неорганізованість, «завалений» письмовий стіл		Відсутність зв'язку (комунікації) або неточна зворотний зв'язок	
Надмірне читання		Балаканина на приватні теми	
Погана система досьє		Зайва комунікабельність	
Брак мотивації		Надмірність ділових записів	
Пошук записів, пам'ятних записок, адрес, телефонних номерів		Синдром «відкладання»	

Недоліки кооперації або поділу праці		Бажання знати всі факти	
Відривають від справ телефонні дзвінки		Тривалі очікування	
Незаплановані гості		Квапливість, нетерпіння	
Нездатність сказати «ні»		Занадто рідкісне делегування (передоручення) справ	
Неповна, запізнiла інформація		Недостатній контроль за перепорученими справами	
<i>Примітка:</i> Рівень: низький 20-25 виборів, середній рівень – 15-20, високий до 10 виборів			

Таблиця 5.

Діагностика стратегій досягнення цілей та самомотивації при працевлаштуванні

<i>Вправа 2. «Діагностика стратегій досягнення цілей працевлаштування»</i>		
1. Пофантазуйте, що це? а) задні вогні потягу, що відправився від нас; б) маска з отвором для очей; с) очі, які бачать у темряві.	2. Якщо би Ви могли працювати в авіації, ким би ви хотіли бути? а) стюардом на борту; б) пілотом пасажирського літака; с) диспетчером на летищі.	3. Уявіть собі, що Вам запропонували зробити проект інтер'єра офісу, де було б комфортно і добре працювати. Який колір має переважати в такому приміщенні? а) світло-голубий, блідо-зелений (салатний), рожевий; б) червоний або жовтий; с) темно-зелений, синій.
4. Що найбільше необхідно, якщо Ви вирішили підкорити гірську вершину наодинці? а) трохи божевілля;	5. Ви йдете в театр на спектакль, дуже хочете його подивитись, але з'ясовується, що квитків у касах уже немає. Що Ви будете робити? а) злитись, що не ку-	6. Дзвінок, Ви відкриваєте двері, перед Вами стоїть неохайно вдягнений чоловік, який із соромливою посмішкою просить Вас про допомогу. Він вийшов із лікарні і про-

б) відмінна фізична підготовка; с) упевненість у собі.	пили квиток раніше; б) спробуєте потрапити без квитка, для цього у Вас є можливості та способи; с) смієтесь у душі над тими людьми, які стоять розчаровані біля каси, так як Ви вже давно купили квитки під час попереднього продажу.	сить Вас позичити йому трохи грошей на квиток додому. Що Ви зробите? а) не зможете відмовити – можливо йому дійсно потрібна допомога; б) зачините двері перед носом чоловіка, висловивши думку про таких аферистів та брехунів; с) якщо б показав виписку з лікарні, може і дасте декілька гривень
Методика дозволяє визначити одну з 3-х стратегій досягнення цілей: пасивна стратегія – надмірна обережність, відмова від першості, соціальна закритість; активно-ригідна стратегія – підвищене прагнення до першості, демонстративною саме презентації, висока критичність до оточення і низька до себе; активно-пластична стратегія – поєднання «пробивної» сили з комунікативною «дипломатичністю», адекватність цілей і способів їх досягнення, компроміс і упевненість тощо. Оберіть одну з 3-х запропонованих відповідей. Підрахуйте кількість обраних вами пунктів – а (пасивна стратегія), б (активно-ригідна стратегія) і с – (активно-пластична стратегія): 5-6 балів – високий ступінь вираження; 3-4 бали – середній ступінь вираження; 1-2 бали – низький ступінь вираження.		
<i>Вправа 3. Опрацювання навичок самомотивації (наведіть 1-3 приклади за методом).</i>		
1. Метод «демотивації». Як розповідав в одному зі своїх інтерв'ю відомий камерунський боєць Френсіс Нган, секрет його грандіозних перемог – в регулярних спогадах про тяжке дитинство. Він твердо вирішив стати успішним, а ці образи послужили відмінною самомотивацією. Якщо хтось вирішив відправитися з точки «А» в пункт «В», то найефективнішим мотивом стане об'єднати мрії про переваги точки «В» з регулярними нагадуваннями про недоліки точки «А».		
2. Метод «азарту». Спосіб самомотивації – взяти самого себе на «слабо». Укласти з самим собою угоду або парі. Коли людиною опановує азарт, продуктивність його праці помітно зростає, а втома практично не відчувається. Причина того, що робота не вдається, дуже часто криється в настрої людини, небажання її виконувати. Якщо укласти під-		

свідомий суперечка, який до того ж буде підкріплений обіцянками конкретного «бонуса», то ефективність праці зросте, що підвищить шанси на успішну реалізацію задумки.
3. Метод «самонавіювання». В окремих випадках можна спробувати себе «запрограмувати» на виконання певного завдання, вселивши собі, що воно важливе. Наприклад, Ви шукаєте роботу, але Вам потрібно пройти співбесіду. Ви хвилюєтеся. Як мотивувати себе на підготовку до співбесіди? Кращий спосіб – переконати себе, що це найважливіша подія у Вас у даний час. Якщо вже не вдасться відмовитися від якоїсь роботи, то єдиний вихід – змінити своє ставлення до неї. Це і нерви збереже, і імідж сумлінного виконавця закріпить.

Висновки. Узагальнюючі результати дослідження можна зазначити, що надання психосоціальних послуг внутрішньо переміщеним особам з метою відновлення їх працездатності та сприяння поверненню на ринок праці може базуватися на розробленому «Тренінгу з відновлення працевлаштування внутрішньо переміщеними особам». Зміст тренінгу у вигляді лекційних та практичних занять дозволяє розвинути психологічну готовність до повернення на ринок праці та відновити впевненість внутрішньо переміщених осіб у власній працездатності. Тренінг сприяє поверненню внутрішньо переміщених осіб на ринок праці та відбудові психосоціальних навичок самомотивації.

Ключові слова: особистість, ринок праці, психосоціальний, внутрішньо переміщені особи, мотивація, професійний розвиток, психологічна готовність, емоційний стан, комунікація.

Література.

1. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov A. Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment – 2023. – V. 11, № 1. – P. 36–46. <https://doi.org/10.6000/2292-2598>. 2023. 11. 01. 5

2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», грудень 2015 р.

3. Закон України «Про організац. труд. віднос. в умовах воєнного стану», 2022 р.

4. Державна служба зайнятості <https://jobportal.dcz.gov.ua>

5. Пріб Г. А., Бегеза Л. Є. Психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб // Київ, АПСВТ. 2023. 21 с. [http://dx. doi. org/10. 13140/RG. 2. 2. 19663. 87204](http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19663.87204)

6. Практичний poradnik для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і внутрішньо переміщеними особами: соціально-психологічний аспект / Г. А. Пріб, Н. В. Ортікова. К. : ІПК ДСЗУ, 2018. 21 с.

7. Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.

ЧАСТИНА 4.

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ

РОЗДІЛИ:

4.1. Психічне здоров'я на робочому місці, лідерство в контексті євроінтеграції

*Житинська М. О., Антипін О. С., Баранчук В. В.,
Ісак А. М., Міценко Д. А., Потеруха В. В. Селівєрстов В. С.*

Актуальність. Життєві ролі є невід'ємною частиною нашої буденності. Ті ролі, що колись виникли не зникають безслідно, вони можуть трансформуватись, слугувати основою для інших ролей, можуть набути іншого значення, або втратити його взагалі, в будь-якому випадку ролі впливають на життєвий шлях особистості та можуть поширюватись на всі сфери життя людини.

Рольова компетентність є складовою життєвої компетентності, що тлумачиться як здатність розв'язувати життєві проблеми. Взагалі під компетентністю розуміється система умінь та здібностей людини до розв'язання певних задач. Компетентність є також складовою частиною образу «Я», критерієм самооцінки. Це один з показників гармонійного стану особистості, оскільки особистісні дисгармонії так чи інакше пов'язані з її втратою або послабленням.

Розвиток особистості є важливою складовою будь-якої теорії особистості. У рольовому розвитку особливе місце займає формування життєвих ролей особистості, а саме ролей, які пов'язані з особистісною ідентичністю, з життєвим сценарієм людини та з її характером загалом. Кожна людина має широкий та різноманітний репертуар життєвих ролей, що змінюється протягом усього життя

людини. На кожному життєвому етапі людини з'являються, розвиваються чи актуалізуються ті чи інші життєві ролі.

Розвиток життєвих ролей відбувається протягом всього життя людини, починаючи з того моменту, коли дитина вступає у взаємодію зі значимим соціальним оточенням, тобто від самого народження, оскільки роль – невід'ємний атрибут людини як соціальної істоти. Велике значення має досвід спілкування з батьками, адже саме їх вплив (настанови, оцінки, заборони, поцінювання, виховання тощо) формує життєвий сценарій дитини, а також її перші життєві ролі.

Мета. Дослідити емоційне лідерство, рольову компетентність та попорядження конфліктів в організації.

Результати дослідження. Рольова компетентність є складовою життєвої компетентності, що тлумачиться як здатність розв'язувати життєві проблеми. Взагалі під компетентністю розуміється система умінь та здібностей людини до розв'язання певних задач. Компетентність є також складовою частиною образу «Я», критерієм самооцінки. Це один з показників гармонійного стану особистості, оскільки особистісні дисгармонії так чи інакше пов'язані з її втратою або послабленням.

П. П. Горностай визначає рольову компетентність як здатність особистості розв'язувати життєві проблеми, пов'язані з рольовою поведінкою.

Безумовно, життєва компетентність, соціальна адаптація, життєвий успіх взаємопов'язані, та є причинами і наслідками один одного, які зумовлюють певний результат, що в свою чергу впливає на подальший перебіг процесів.

П. П. Горностай виділяє в структурі рольової компетентності чотири компоненти:

1. Рольова варіативність – це різноманітність репертуару психологічних ролей особистості, багатство її рольової поведінки. Крім стандартного набору соціальних та міжособових ролей у референтних групах, ролей, що визначаються становищем особи в соціумі, її статусом, рольова компетентність передбачає існування багатьох різновидів цих ролей. Наприклад, сімейна роль не обмежується однією, нехай і найважливішою функцією, а виявляється в багатьох функціях залежно від обставин. Міжособові ролі мають також значний спектр варіантів, що дає особистості змогу бути іншою в кожній новій ситуації спілкування.

2. Рольова гнучкість – це вміння легко переходити від однієї ролі до іншої. У багатьох життєвих ситуаціях буває необхідність відмовлятися від деяких ролей, які за певних умов стають неконструктивними і перетворюються на джерело психологічних проблем. Негнучка, ригідна особистість ніби «застрягає» на окремих ролях, не може відмовитися від них, або прийняти на себе нову роль. Така особливість стає причиною її низької адаптивності. Це надто помітно в період соціальної кризи, коли стрімко змінюються умови життя, перебудовується рольова структура суспільства. Багато хто не може пристосуватися до нових соціальних ролей, не здатен засвоїти нові вимоги до професійної діяльності та інших видів соціальної активності. На перший погляд, така безпорадність притаманна людям старшого віку, але насправді людей як з високим, так і з низьким показником рольової гнучкості багато в усіх вікових групах, хоча він має тенденцію знижуватись з віком.

3. Рольова глибина – це розвиненість глибинної структури ролей, опора в рольовій поведінці не лише на рольові очікування навколишніх осіб, а й на такі особистісні складові, як рольова ідентичність, рольова Я-концепція, рольове переживання. Рольове переживання – це сукупність своєрідних емоційних станів і процесів, що супроводжують рольову поведінку. Потреба в рольовому переживанні, тобто в новому чуттєвому досвіді, що набувається в процесі виконання ролей – також важлива складова рольової глибини особистості. Крім того, здатність до глибоких рольових переживань – це одна з характеристик акторського мистецтва, яке, без сумніву, має спиратись на високу рольову компетентність.

4. Здатність до рольової децентрації та прийняття ролі інших (протилежна риса має назву рольовий егоцентризм). Уміння приймати ролі інших розглядається як основна мета соціалізації особистості в концепції Дж. Г. Міда. Воно вважається за досить цінну рису людини і допомагає їй адаптуватися в соціумі, зокрема уникати рольових конфліктів.

Рольова децентрація – є складним психологічним утворення, що включає низку умінь і здатностей, таких як:

– здатність до перевтілення, тобто вміння грати ролі інших (це дуже добре видно на прикладі роботи актора, власне – це основний компонент акторських здібностей);

- рольову емпатію, тобто прийняття ролі іншої людини, здатність «приміряти» її на себе, розуміти внутрішню логіку, вміння дивитися на світ очима цієї людини, із позиції її рольової Я-концепції;
- рольову рефлексію, тобто вміння оцінити себе, свою рольову поведінку зі сторони, із погляду інших осіб, здатність визначати і прогнозувати рольові очікування щодо себе.

П. П. Горностай окрему увагу приділяє поняттю «уявні ролі», це ті ролі, які виникають не в реальній поведінці, а в ситуаціях, створених людською фантазією. Це відбувається під час сприйняття художньої творчості. Рольова децентрація передбачає можливість та вміння перевтілюватися в образи, що відповідають уявним ролям, та ідентифікуватися з героями творчості.

Проте, варто зазначити, що існує негативний статистичний взаємозв'язок між рольовою гнучкістю і глибиною, а також між глибиною і варіативністю. Це означає, що широка рольова варіативність та висока рольова гнучкість часто пов'язані з поверховим характером ролей, а значна рольова глибина характерна для обмеженого репертуару психологічних ролей. Проте за високої рольової компетентності можливим стає істотний розвиток, здавалося б, несумісних між собою параметрів. Рольова компетентність певним чином пов'язана з цілісністю особистості. Спостерігається така тенденція, що чим багатша, більша та різноманітніша система життєвих ролей людини, тим більше аспектів має її соціальне обличчя, тим багатогранніше її взаємодія з різноманітними соціальними ситуаціями, до яких людина може краще адаптуватися. У такої особистості в критичні моменти життя може спостерігатися явище атрофії ролей, яке не буде в значній мірі патологічним, оскільки втрачені ролі можуть бути заміщеними іншими, в тому числі і уявними.

Рольова компетентність також впливає на здатність людини долати життєві кризи, які можна трактувати як зміну життєвих ролей особистості. Життєву кризу можна розглядати як рольовий конфлікт у сфері життєвих ролей, що полягає у складнощах формування нових ролей, або неможливості відмови від старих. Розвинена рольова компетентність допомагає подолати життєву кризу з меншими негативними наслідками для особистості: висока рольова гнучкість сприяє легкості, а отже і гармонійності зміни життєвих ролей; рольова варіативність в свою чергу допомагає компенсувати недостат-

ньо розвинуті ролі іншими ролями з багатого рольового репертуару людини. Таким чином рольова компетентність є суттєвою складовою в структурі особистості людини, що обумовлюється здатністю розв'язувати життєві проблеми, пов'язані з рольовою поведінкою, із функціонуванням життєвих ролей. Рольова компетентність включає в себе здатність застосовувати свої життєві ролі, бути повноправним суб'єктом цих ролей, включати рольову поведінку в процес власної життєдіяльності, що сприяє гармонійній рольовій самореалізації. Рольовий розвиток особистості. Розвиток особистості є важливою складовою будь-якої теорії особистості. У рольовому розвитку особливе місце займає формування життєвих ролей особистості, а саме ролей, які пов'язані з особистісною ідентичністю, з життєвим сценарієм людини та з її характером загалом. Кожна людина має широкий та різноманітний репертуар життєвих ролей, що змінюється протягом усього життя людини. На кожному життєвому етапі людини з'являються, розвиваються чи актуалізуються ті чи інші життєві ролі. Зміна ролей при переході від однієї життєвої ситуації до іншої не завжди відбувається гармонійно. Вона може супроводжуватися життєвими кризами, що з погляду рольової теорії можна інтерпретувати як рольовий конфлікт у сфері життєвих ролей особистості.

Проблеми лідерства являються ключовими для досягнення організаційної ефективності. З однієї сторони, лідерство розглядається як наявність певного набору якостей, які притаманні тим, хто успішно спричиняє вплив на інших, з іншої, лідерство – це процес несилового впливу у напрямку досягнення організацією своїх цілей. Для того, щоб складна організація ефективно виконувала свої задачі необхідно забезпечити виконання всіх функцій управління. Лідерство – являється тим видом діяльності, який пронизує всю систему управління. Неможливо ефективно виконувати функції планування, організації, мотивації і контролю, якщо немає ефективного керівництва і лідерів, здатних заохочувати інших працівників, позитивно впливати на них і вести за собою, тим самим досягаючи позитивних кінцевих результатів.

У досягненні організаційної ефективності лідерство розглядається як наявність певного набору якостей, які притаманні тим, хто успішно впливає на інших, з другого, лідерство – це процес переважно несилового впливу в напрямі досягнення групою або

організацією своїх цілей. Лідерство являє собою специфічний тип управлінської взаємодії, що ґрунтується на найефективнішому використанні різних джерел влади і спрямований на спонукування працівників до досягнення спільних цілей.

Лідерство – це не управління. Управління концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство – на тому, щоб люди робили правильні речі. Різниця між лідером і керівником проводиться по багатьом позиціям. Ефективний керівник не обов'язково являється ефективним лідером, і навпаки. Їх основні характеристики знаходяться як би в різних вимірах. Лідер також являється керівником, але характер його дій інший, ніж у звичайного менеджера. Він не керує, не командує, а веде за собою інших. Можна бути першою особою в організації, але не являтися фактично лідером, бо той повинен бути не затверджений наказом, а психологічно визнаний оточуючими як єдиний, хто здатний забезпечити задоволення їх потреб. Тому практично виділяють такі розбіжності між лідером і керівником: керівник звичайно признається офіційно, а лідер висувається стихійно; керівникові надаються законом певні права й обов'язки, а лідер може їх не мати; керівник наділений певною системою офіційно встановлених санкцій, використовуючи які він може впливати на підлеглих, а лідеру ці санкції не надані; керівник представляє свою групу в зовнішній сфері стосунків, а лідер у сфері своєї активності обмежений в основному внутрігруповими стосунками; керівник, на відміну від лідера, несе відповідальність перед законом за стан справ у групі.

Висновки. Виходячи із функціональних і психологічних відмінностей між керівником і лідером, у групі можуть виникнути такі ситуації, які накладають свій відбиток на гармонізацію життя і діяльності групи. Феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника. Розрізняють формальний, особистий і повний авторитет. Формальний авторитет керівника впливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, цілеспрямовувати, мотивувати і контролювати їх працю та поведінку. Особистий авторитет керівника ґрунтується на його особистих якостях як людини (наприклад, толерантність, товариськість, компетентність, здоровий глузд, логічність дій та ін.). Повний авторитет керівника, або авторитет лідера, виявляється при поєднанні формального та осо-

бистого авторитету особи, яка обіймає керівну посаду. Здатність лідера здійснювати вплив визначається рівнем керівного потенціалу, реалізовувати який керівник зобов'язаний у певних ситуаціях.

Література.

1. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посібн. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 456 с.
2. Кузьмін О. Є. Керівництво організацією : навч. посібн. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, І. С. Процик. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 244 с.
3. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посібн. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : ТзОВ «Академвидав», 2003. – 568 с.
4. Яцура В. В. Основи менеджменту : навч. посібн. / В. В. Яцура, Б. І. Мицик. – Львів : Вид-во «Літопис», 2000. – 157 с.

4.2. Мотиваційний вплив ідентичності та іміджу бренда на поведінку споживача

Барвінко Д. О.

Актуальність. У сучасну житті люди постійно стикаються з різними аспектами споживання. Навколишня реклама, поїздка в метро, похід до магазину, перегляд телевізора, прослуховування музики, серфінг в інтернеті та читання книги – все це приклади того, що споживають люди. Майже вся поведінка людей прямо чи опосередковано пов'язана зі споживанням, тому науково актуальним на сьогодні стає питання мотивації споживача, а саме розуміння того які внутрішні механізми змушують нас робити той чи інший вибір. За останні кілька десятиліть наука про поведінку значно розширила наші знання про те, як люди думають і як навколишній контекст формує їхнє мислення. Доповнюючи традиційну економічну теорію поведінки ідеями з когнітивних і соціальних наук, дослідники зібрали величезну кількість доказів того, як люди відмовляються від раціонального прийняття рішень, і поглибили наше розуміння психологічних, соціальних і культурних змін, які впливають на поведінку. Після майже століття розмежування між дисциплінами економіки та психології поведінкова наука привнесла нові міждисциплінарні погляди на економічний дискурс [5].

Мета. Дослідити мотиваційний вплив ідентичності та іміджу бренда на поведінку споживача.

Результати дослідження. У кінці 20го сторіччя під час аналізу ефективності своїх зусиль підприємці та маркетологи використовували наступні основні методи.

1. Метод вивчення продажів – це те, що частіше за все купують споживачі. Суттєвий недолік цього методу в тому, що він не вказує на те які саме фактори формують і впливають на продаж.

2. Аналіз конкурентів.

3. Анкетування: Споживачам ставлять питання стосовно їхніх вподобань, смаків, попиту на певні товари чи послуги, а також причин, що впливають на їхні вибори.

4. Фокус-групи: Група учасників обговорює та ділиться своїми враженнями, уподобаннями та переживаннями стосовно конкретного продукту, бренду чи ринкової концепції.

Усі ці методи нажалі не давали вичерпного знання про мотиви які спонукають споживача до певних дій. Реальність така що 8 із 10 нових товарів на американському ринку не знаходять своїх споживачів і ідуть у забуття. Незважаючи на те що анкетування і фокус-групи пророкували позитивну динаміку або ж небачений успіх.

Сучасні дослідження поведінки споживачів не тільки розширюють межі розуміння цього процесу, а і ставлять під сумнів традиційну логіку прийняття рішень. На початку 2000х років стало зовсім зрозуміло, що традиційні методи досліджень вивчення потенціалу ринку або фокус-групи, неспроможні з'ясувати про що саме думають і чого насправді бажають споживачі. Причиною цього феномену є ірраціональне мислення людини яке наповнене соціальними та культурними упередженнями, вихованням та іншими факторами які мають скритий але значний вплив на нашу поведінку [3].

Одним із центральних принципів науки про поведінку є те, що рішення залежить не лише від раціональних факторів. Наприклад, рішення яке прийняте самостійно, може значно відрізнятися від рішення, прийнятого в компанії іншої сім'ї або групи колег. Рішення прийняте вдома, на роботі або у відпустці так само може бути різним.

Соціальні норми – цінності чи звички, які по окремих групах чи суспільствах – були визначені як система відліку для багатьох рішень, в багатьох випадках відіграють вирішальну роль. Крім того, люди, які є лідерами громадської думки, тобто займають основні позиції в соціальній групі, можуть мати вирішальний вплив на формування поведінки та норми у вашій соціальній мережі. Розуміння існування цих аспектів і прихованих мотивів та інших істотних факторів спонукало вчених на оновлення методів дослідження, спрямованих на виявлення глибинних причин споживацької поведінки [4].

Початок 21-го сторіччя ознаменувався створенням такої науки як нейромаркетинг – це галузь маркетингу, яка використовує методи і принципи нейронауки для вивчення та розуміння реакцій споживачів на маркетингові впливи. Основною метою нейромаркетингу є розкриття та використання нейрологічних механізмів, які визначають споживчу поведінку, з метою оптимізації маркетингових стратегій та підвищення ефективності рекламних кампаній [3].

Основні аспекти нейромаркетингу включають:

1. Вивчення реакцій мозку: Вимірювання активності мозку та визначення, які стимули викликають найсильніші реакції.
2. Вивчення емоційної відповіді: Аналіз емоційних реакцій споживачів на різні маркетингові впливи для покращення емоційного зв'язку з брендом чи продуктом.
3. Оцінка уваги та пам'яті: Дослідження того, як рекламні повідомлення впливають на увагу та запам'ятовуваність споживачам.
4. Тестування дизайну та пакування: Використання нейро наукових методів для аналізу того, як вигляд продукту чи упаковки впливає на споживачів.
5. Прогнозування прийняття рішень: Розуміння того, як мозок споживачів обробляє інформацію та приймає рішення про покупку.
6. Аналіз впливу бренду: Вивчення того, як бренд взаємодіє з мозком споживачів та як це впливає на їхні рішення.

Нейромаркетинг дозволяє компаніям глибше розуміти споживачів і створювати більш ефективні стратегії маркетингу, використовуючи науково обгрунтовані підходи до вивчення людської поведінки [6]. Наприклад, перше використання функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) для вивчення реакцій на рекламні стимули було зафіксоване приблизно в середині 2000-х років. Основним завданням було розуміти, як мозок реагує на візуальні та емоційні аспекти рекламних матеріалів. З часом методи нейромаркетингу ставали більш доступними і застосовувались в різних галузях, таких як вивчення ефективності брендів, аналіз поведінки споживача та розробка маркетингових стратегій. Сучасні технології дозволяють дослідникам отримувати детальну інформацію щодо реальних реакцій споживачів на маркетингові впливи. Ось кілька основних методів, які використовуються в нейромаркетингу:

1. Електроенцефалографія вимірює електричну активність мозку за допомогою електродів, розташованих на поверхні голови.
Застосування: Вивчення психофізіологічних реакцій на рекламу, бренди та інші стимули.

2. Функціональна магнітно-резонансна томографія – зображення активності різних частин мозку за допомогою магнітних полів.

Застосування: Аналіз реакцій мозку на візуальні та емоційні стимули.

3. Гальванічна шкірна реакція – вимірює зміни в електричній провідності шкіри, що відбуваються при збудженні.

Застосування: Оцінка емоційного забарвлення реакцій на стимули.

4. Емоційне вивчення за допомогою візуального відстеження – вивчення виразів обличчя та очей для визначення емоційних реакцій.

Застосування: Виявлення емоційного відгуку на візуальні подразники.

5. Функціональний магнітний резонанс при використанні VR – поєднання ФМРТ із використанням віртуальної реальності для більш точного вивчення реакцій на віртуальні середовища.

Застосування: Дослідження реакцій на віртуальні простори та продуктові концепції.

6. Електроміографія – вимірює електричну активність м'язів під час дій.

Застосування: Аналіз реакцій на фізичні стимули та взаємодію з продуктами.

Нейромаркетинг та ідентичність бренда, на перший погляд, можуть здаватися різними концепціями, але їх глибинний зв'язок стає ключовим фактором у формуванні успішних стратегій маркетингу та створенні сильних брендів. Це дозволяє створити бренд, який не лише визнаний, але й глибоко вплетений у емоційний ландшафт споживачів.

Саме тому вивчення впливу ідентичності та іміджу бренду на поведінку споживача має вирішальну роль у сучасних дослідженнях пов'язаних із маркетингом. Оскільки основною тенденцією сучасної ринкової економіки є постійне збільшення гомогенності вироблених продуктів. Іншими словами на більшості конкурентних ринків наразі існує небагато функціональних відмінностей між ключовими конкурентами і їхніми товарами. Зменшення різниці в якості товарів вважається результатом промислової революції та використання інноваційних технологій на виробництвах. Саме ці досягнення зменшили можливість пропонувати стійку конкурентну перевагу та зробили диференціацію продукції надзвичайно важкою. В рамках цього контексту, ідентичність для торгових марок стала надважливим інструментом у маркетингу та просуванні товарів, для забезпечення індивідуальності та пізнаваності.

При зміні фокусу уваги споживача з товару до бренду, який його виробляє, на перший план виходять такі поняття як ідентичність

та імідж бренда [1]: брендовий капітал (або імідж) – це, як бренд сприймається споживачами; ідентичність – це як власник хотів би, щоб цей бренд був сприйнятий споживачами.

В наш час брендинг у своїй суті – це формування унікальної особистості товару, послуги чи компанії для безпосередньої взаємодії зі споживачами. На початку процесу розвитку брендингу, компанії використовували різні способи для того, щоб виділити свої товари з маси.

З початку 1970-х р. це були яскраві упаковки, характерні форми продуктів, але головним чином це були знайомі споживачам логотипи, слогани та інші символи. Пізніше окрім звичних атрибутів, бренди починають використовувати емоційне забарвлення та соціальні цінності у своїй ідентичності. Чим і створюють унікальний досвід взаємодії зі споживачами, який асоціюється із брендом саме як системою цінностей, мотивів і місій які вони несуть у світ разом зі своїм товаром. Цінності бренду стають не лише навігаторами для внутрішнього розвитку компанії, але й ключовими елементами, що визначають його унікальність для споживача. Розкриття цих цінностей у спосіб, який стимулює емоційний відгук і дозволяє створити цей глибокий зв'язок із цільовою аудиторією. Ця зміна в розумінні призвела до корінних змін у маркетингових стратегіях брендів. Замість того, щоб продавати товари, вони почали продавати стиль життя та унікальну ідентичність своїх брендів. Це в свою чергу змінило розуміння і підходи до усвідомленого створення стратегії диференціації брендів на основі їх ідентичності.

Важливим фактором є те, що поняття ідентичності та іміджу не є статичним. Розуміння того як сприймає споживач те що ви хочете до нього донести постійно змінюється і розширюється з роками, відображаючи соціокультурні тенденції та, як слідство, зміни у споживчій поведінці.

Сучасні психологічні дослідження показують, що саме уявлення споживачів про бренд, а не певні характеристики товару, є одними із основних чинників які впливають на рішення споживача про купівлю товару чи послуги. Дослідження мотивацій, які стоять за цим вибором, дозволяють компаніям більш точно визначити потреби своїх споживачів та розробити ефективнішу маркетингову стратегію [2].

Приклади мотиваційного впливу ідентичності бренду включають [1]:

1. Лояльність до бренду: У разі створення унікальної ідентичності бренду та встановлення зв'язку з цінностями та емоціями споживачів, це може створити лояльність до бренду. Коли споживачі відчують, що бренд відображає їхні цінності та особистість, вони схильні вибирати цей бренд замість конкуруючих. Якщо споживач користується продукцією певного бренду та його досвід був позитивним, він схильний вибирати цей бренд у майбутньому. Пояснюється це тим, що ідентичність бренду допомагає формувати в споживача певні асоціації та очікування від продукту, а задоволення цих очікувань веде до підвищення лояльності до бренду.

2. Ефект соціального статусу: Споживачі можуть шукати продукти та послуги бренду, щоб підвищити свій соціальний статус або бути частиною певної культури чи спільноти. Наприклад, носіння дизайнерського одягу або аксесуарів може бути пов'язане з високим соціальним статусом, а вибір певних продуктів харчування або напоїв може бути пов'язаний з належністю до певної культури або способу життя. Купівля продукції специфічного бренду може стати частиною особи споживача, що у свою чергу підвищує його самооцінку.

3. Задоволення потреб самовираження: Ідентичність бренду може допомогти споживачам висловити свою особистість, інтереси та цінності через продукти та послуги, які вони обирають. Наприклад, споживач, який ідентифікує себе як послідовника екологічно чистих продуктів, може обрати бренд, який активно пропагує свою екологічну відповідальність.

4. Привабливість бренду: ідентичність бренду може створювати емоційну привабливість для споживачів та стимулювати їх покупки. Наприклад, бренд Apple приділяє багато уваги дизайну та зручності використання своїх продуктів, що привертає багатьох споживачів до їхньої продукції.

Вивчення мотиваційного впливу ідентичності бренду дозволяє визначити, які елементи викликають позитивну реакцію у споживача та мотивують його до покупки. Наприклад, якщо бренд асоціюється з високою якістю продукту, це може бути ключовим мотивом для тих споживачів, які цінують якість і готові заплатити більше за продукт, який відповідає їх очікуванням. Також, якщо бренд асоціюється з певними емоціями, такими як впевненість, успіх чи комфорт, то це може бути мотивом для тих споживачів, які прагнуть асоціюватися з цими емоціями.

Інший важливий аспект вивчення мотиваційного впливу ідентичності бренду – це розуміння, які споживачі схильні до купівлі конкретного бренду. Наприклад, якщо бренд асоціюється з молодіжною культурою, то швидше за все, він буде привабливішим для молодих споживачів, ніж для старшого покоління. Це дозволяє компанії більш точно визначати свою цільову аудиторію та створювати маркетингові кампанії, які будуть найефективнішими для цієї аудиторії [1]. В цілому, правильно створена ідентичність бренду є потужним мотиваційним фактором для споживачів, якщо вона враховує їхні потреби, цінності та емоції. Вивчення мотиваційного впливу ідентичності бренду також дозволяє компаніям аналізувати ефективність своїх маркетингових кампаній та коригувати їх відповідно до потреб споживачів [7].

Висновки. Можна, зазначити, що на сьогодні актуальною проблемою психології є дослідження питання створення успішного бренду, яке потребує врахування багатьох аспектів, включаючи споживчу психологію, бізнес-менеджмент та маркетинг. Одним із аспектів даної проблеми є вивчення ключових елементів побудови унікальності ідентичності бренду, що відображає його місію, цінності і дозволяє створити стійкий зв'язок між брендом та споживачами на емоційному рівні.

Література.

1. Aaker D. A., Building Strong Brands: January 1, 2002. 380 p.
2. Barden P., Decoded: The Science Behind Why We Buy: January 10, 2013. 293 p.
3. Lindstrom M., Buyology: Truth and Lies About Why We Buy: February 2, 2010. – 272 p.
4. Skorepa M., Decision-Making A Behavioral Economic Approach: December 17, 2010. 375 p.
5. Ruggeri K., Psychology and Behavioral Economics: September 21, 2021. 408 p.
6. Glover A., Neuromarketing: Understanding the Buy Buttons in Your Customer's Brain: October 14, 2007. 256 p.
7. David D. A., Managing Brand Equity: September 9, 1991. – 299 p.

4.3. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності підприємців

Бондарчук В.В.

Актуальність. Сучасний бізнес, підприємництво вже не створює лише «продукт/товар заради продукту», а вивчає потреби клієнтів, надає послуги, тим самим виборюючи конкурентноздатність. За статистикою 95% всіх створених у світі компаній закриваються в перші 5 років існування. Але ті хто вистояв, досягають успіху. В Україні мале підприємництво як самостійне соціально-економічне явище розвивається в складних умовах: війна завдає значних руйнувань інфраструктурі, викликає кризові явища в економіці. Зміна зовнішнього середовища змушує підприємства змінюватися зсередини, шукати та використовувати нові шляхи та можливості протистояти викликам часу. Ризиків уникнути неможливо, проте їх можна мінімізувати. Це зумовлює необхідність застосування на практиці більш гнучких управлінських методів, а також розроблення превентивної політики реагування на можливі несприятливі умови. Для того, щоб мінімізувати вплив ризиків, необхідно виділити основні фактори, що їх спричиняють [7].

У сьогодишніх соціально-економічних умовах (фактор війни, котрий змінив економічні і соціальні процеси, а вони в свою чергу наклали відображення на психоемоційний стан працівників та керівників компаній) психоемоційне навантаження у багатьох керівників-підприємців означається безсонням, деструктивною, агресивно, конфліктною комунікацією, збільшилась кількість розлучень і т.і. Для забезпечення робочого процесу і розвитку компанії, підприємець-керівник має враховувати індивідуально-психологічні особливості персоналу, спонукаючи колектив до спільного результату. Вплив стресорів різного характеру, соціального середовища позначається на психоемоційному стані керівника, та відображається на його діях і рішеннях.

Мета. Здійснити теоретичне вивчення та обґрунтувати соціально-психологічні чинники та особливості професійної діяльності підприємців.

Результати дослідження. Серед суб'єктів господарювання найбільш динамічним елементом ринку є малий бізнес, який формується на засадах дрібнотоварного виробництва, визначає темпи економічного розвитку, характеризується свободою ринкового вибору [2].

Все частіше у науковій літературі з економіки вживається термін «small business», що означає «малий бізнес». На законодавчому рівні (стаття 42 Господарського кодексу України [5]), у протиположності широкому вжитку, використовується термін «підприємництво» – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [4].

Проблематика підприємництва досліджувалась у напрямках: економіки: З. С. Варналій, Н.В. Голич, Ю.В. Журавель, Т. В. Лень, Н. Ю. Мариненко, О. В. Панухник, Л. В. Соколова [1; 7; 8] та ін.; психології: Я. В. Гончаренко, Г. В. Гнускіна, Г. В. Ложкін, В. В. Москаленко, О. М. Паламарчук, Н. Ю. Худякова та ін.

У наукових роботах авторами стверджується, що малий бізнес є: «...однією із форм організації економічної діяльності, пов'язана з функціонуванням малих підприємницьких структур, заснованих в різних організаційно-правових формах та різних формах власності та має на меті одержання прибутку шляхом реалізації ідеї свого заснування» [6, с.3]; «...діяльністю будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) передусім з метою одержання прибутку, яка не завжди повинна супроводжуватися ризиком і впровадженням інновацій у процесі власної діяльності» [3].

Законодавчою основою розвитку і функціонування малого й середнього бізнесу, політикою розвитку підприємництва в Україні є Конституція, Господарський Кодекс України, законодавчі акти, які регламентують, регулюють підприємницьку діяльність.

Науковцями у літературі визначено «...три основні ознаки малого бізнесу: невеликий сегмент ринку збуту, який не дозволяє значно впливати на ціни і конкурентів; управлінська незалежність (підприємство керується не через формалізовану управлінську структуру, а ініціативно власником або партнерами власниками); персоніфіковане управління, яке передбачає, що власник (партнери-власники) сам бере участь в усіх аспектах управління бізнесом

і в процесі прийняття усіх рішень не підпорядковується у своїй зовнішньому контролю, окрім законодавчого обмеження [6, с. 3].

Згідно з Господарським кодексом України, стаття 55 [5]: «*Мале підприємство* – це організація, засновником якої можуть бути «фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України» [5].

У продовження теоретичного вивчення трактування поняття «малий бізнес», Н. В. Голич визначає: «Малий бізнес – це особлива інституціональна форма реалізації підприємницької діяльності, яка розвивається на основі бізнес-ідеї, сформованої підприємцем у рамках встановлених нормативних стандартів з боку держави» [3 с. 32].

Я. М. Гринчишиним вказано, що суб'єктами малого бізнесу можуть бути: підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціативну діяльність на свій ризик і під свою економічну та юридичну відповідальність; колективи підприємців і підприємницькі асоціації; індивідуальні і колективні споживачі продукції (робіт, послуг), яких пропонують підприємці, а також спілки і асоціації споживачів; працівники, які здійснюють трудову діяльність за наймом на контрактній або іншій основі, а також їхні професійні спілки; державні структури в тих випадках, коли вони виступають безпосередніми учасниками угод та мають інтерес до діяльності бізнесу.

Господарська діяльність ведення малого бізнесу забезпечується такими видами діяльності, як: виробнича, посередницька та діяльність у сфері послуг [6, с.3].

Поняття «організація», «підприємство» дослідниками визначається як «відкрита соціально-економічна система, побудована для досягнення певних цілей, яка має чітко визначену структуру, вертикальний та горизонтальний розподіл праці, активно взаємодіє із зовнішнім середовищем, та виступає посередником між суспільством та особистістю у процесі задоволення їх потреб» [4, с. 38].

Юридичними особами визначають суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календар-

ний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України [5].

Відомо, що комерційні організації відносяться до сфери бізнесу, бо вони переважно орієнтовані на отримання прибуткового доходу. Виокремлюють такі сфери діяльності комерційних організацій: сфера надання послуг (юридичні, медичні, страхові, освітні та ін.); виробнича сфера (промисловість, харчова промисловість, металургія, хімічна промисловість та ін.), а також будівельна, транспортна і торгівельна сфери [4, с. 43].

Для вивчення психологічних особливостей професійної діяльності керівників організацій «малого бізнесу», потребують окреслення та означення соціально-психологічні та економічні чинники, котрі визначають поняття малого бізнесу із законодавчої та економічної точки зору. Це у свою чергу дозволить розуміти функціонування зовнішнього і внутрішнього середовища малого підприємства, визначити та обґрунтувати соціально-психологічні фактори, котрі обумовлюють діяльність фахівців малого підприємства, організації.

Керівники підприємств «малого бізнесу» відчують вплив як зовнішніх соціально-економічних чинників, так і внутрішніх, що позначається психологічним навантаженням на керівника та на психоемоційній сфері колективу організації вцілому. Практика розвитку малого бізнесу дозволяє виділити групи чинників, які впливають на функціонування, розвиток підприємства (рис. 1).

Охарактеризуємо визначені групи чинників: правові: законодавча баз здійснення діяльності, система оподаткування та податкові пільги; фінансово-економічні: державні гранти розвитку малого бізнесу, соціально-економічні моделі залучення капіталу, конкуренція на ринку товарів і послуг; організаційні: процедура створення малого бізнесу, умови розвитку підприємства, кадрове забезпечення; соціально-психологічні: психологічна готовність керівника здійснювати підприємницьку діяльність, систематичне професійне навчання працівників, особистісна резильєнтність колективу.

Фактори, що впливають на психоемоційний стан керівника малого підприємства, пов'язані зі чисельністю колективу, розміром фінансових потоків, юридичною відповідальністю за фінансові потоки і способи обслуговування робочих процесів. У той же час, на керівник

включений у систему сімейної та родинної взаємодії: вирішує питання соціально-економічного, побутового, психоемоційного характеру.



Рис. 1. Групи чинників, які впливають функціонування та розвиток підприємства (розроблено автором)

Можливість втрати бізнесу, «справи життя», у якій задіяні всі матеріальні ресурси підприємця і його близьких людей, може стати гострим стресом для усіх працівників організації. Таким чином, враховуючи дію та характеристики чинників, керівники можуть приймати обґрунтовані рішення щодо функціонування, розвитку підприємства.

Специфіка професійної діяльності малого підприємства відрізняється, означається ступенем відповідальності за результат, а отже і психологічним навантаженням, і, як результат, можливе виникнення психоемоційного виснаження.

Так, до прикладу, дослідження професійної діяльності підприємців з виробництва та продажу меблів, керівник враховує супутні галузі виробництва: виробництво фурнітури, творчість дизайнерів, врахування будівельних стандартів тощо. Процес виробництва меблів – є багатоступеневий і багатокомпонентний, що зумовлює багато контактів між працівниками, виникнення психологічні негаразди, конфліктів між працівниками, що можуть вплинути на інших учасників робочого процесу. Інколи психологічні чинники (психічний стан працівника) призводять до фізичних травм на виробництві.

Проте, спостерігається цікавий факт, що керівники-підприємці, члени колективу, у яких є діти, застосовують життєву стратегію

виваженості і урівноваженості своїх діях, менш провокуюча поведінка до ризиків та емоційного прийняття рішення – часто занурюються у сімейні питання, вирішують родинні проблеми – тож не зациклюються на окремих зовнішніх соціально-економічних викликах. Тобто соціально-психологічні чинники можуть бути мотиваторами у вирішенні професійних викликів, формуючи особистісну резильєнтність. Такими стимулами-мотиваторами можуть бути: близькі люди (члени сім'ї, друзів), хобі, спорт, дозвілля тощо.

Особливим фактором впливу на психоемоційний стан людей, що здійснюють підприємницьку діяльність, є релігія, вірування. Вона діє як заспокійливий чинник, як фактор відновлення фізичної та емоційної рівноваги, а також як особливі умови при необхідності прийняття рішення. У стані гострої економічної та психічної кризи люди покладаються на недоказовий, але століттями беззаперечний авторитет, – релігійні атрибути, ритуали, що, на їхню думку, нормалізує психологічне навантаження від впливу зовнішніх чинників.

У той же час, вирізняється невеликий, але значущий фактор для підприємців – це наукова праця чи розробки. Відмінна від підприємницької діяльності, наукова праця захоплює людину, займає значну кількість часу, переключає увагу підприємця від поточних проблем до питань «іншого світу». Наукові захоплення змінюють світогляд та ставлення до соціально-економічних чинників, допомагають у вирішенні професійних задач підприємницької діяльності, у формуванні фаховість колективу. Впровадження наукових розвідок та розробок у підприємницьку діяльність змінює робочий процес, покращує соціально-психологічний клімат колективу, та демонструє позитивну динаміку професійних результатів.

Висновки. Здійснено теоретичний аналіз поняття «підприємництво», яке трактується, як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Розглянуто визначення малого бізнесу: одна із форм організації економічної діяльності, пов'язана з функціонуванням малих підприємницьких структур, заснованих в різних організаційно-правових формах та різних формах власності та має на меті одержання прибутку шляхом реалізації ідеї свого заснування.

Визначено чотири групи чинників, які впливають функціонування та розвиток підприємства: правові (законодавча баз здійснення діяльності, система оподаткування та податкові пільги), фінансово-економічні (державні гранти розвитку малого бізнесу, соціально-економічні моделі залучення капіталу, конкуренція на ринку товарів і послуг), організаційні (процедура створення малого бізнесу, умови розвитку підприємства, кадрове забезпечення), соціально-психологічні (психологічна готовність керівника здійснювати підприємницьку діяльність, систематичне професійне навчання працівників, особистісна резильєнтність колективу). Окремо виокремлено фактори, що впливають на психоемоційний стан керівників-підприємців – наукова діяльність; та атрибути вірування членів колективів, що слугують символікою та процесом у ситуаціях прийняття рішення, періоду особистісної кризи, формування подальшої життєвої стратегії. Перспективою подальшого дослідження стане вивчення питань: соціально-психологічних бар'єрів керівників-підприємців, моделі та стратегії професійної резильєнтності в умовах конкуренції.

Література.

1. Варналій З.С. Мале підприємництво : основи теорії і практики : 4-те вид. К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. 302 с.
2. Гончарук Т.В. Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні. Ефективна економіка. 2017. Вип. 9. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5772>
3. Голич Н. В. Адаптивні стратегії розвитку підприємств малого бізнесу харчової промисловості в умовах децентралізації : дис... доктор філософії : 051 – Економіка / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2021. 286 с.
4. Гончаренко Я. В. Психологічні чинники орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій. Київ, 2018. 324 с.
5. Господарський кодекс України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
6. Гринчишин Я. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент в малому бізнесі». Львів. 2018. 86 с.
7. Карвацка Н.С., Бабій І.В. Управління проектними ризиками в умовах воєнного стану в Україні. С.151-152. URL : <https://economics.net.ua/wp-content/uploads/2022/06/s6.pdf>
8. Лень Т.В. Маркетингові стратегії управління персоналом підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Хмельницький, 2016. 227 с.
9. Соколова Л.В. Теорія і практика адаптації підприємств до мінливого бізнес-середовища : монографія. Харків : ХНУРЕ, 2004. 288 с.

4.4. Психологічні механізми формування організаційної культури підприємства

Бондарь С.І.

Актуальність. Питанням дослідження поняття «організаційна культура» та її складових елементів приділяється значна увага як з боку зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Важливий внесок у розроблення даної проблеми зробили ряд зарубіжних вчених, таких як С. Адамс, Л. Портер, М. Мескон, Е. Шайн, В. Сате, К. Голд, К. Шольц, А. Ф. Харріс, Е. Шейн та інші.

Серед вітчизняних вчених проблема дослідження структурних елементів на сьогодні набуває все більшої актуальності у міру того, як інтенсивно починає формуватись організаційна культура на українських підприємствах. Дана проблема широко досліджена в працях таких відомих науковців як А. Радугіна, Г. Дмитренка, А. Пригожина, А. Єгоршина, Карамушка Л., Ткалич М. Г. та багатьох інших. Узагальнення літературних джерел свідчить, що організаційна культура розглядалася з позицій різних наукових дисциплін. Можна відокремити кілька напрямків, визначивши їх, як управлінський, економічний, етнокультурний, психологічний, та критерії, за якими в контексті кожного напрямку велося вивчення організаційної культури (табл. 1).

Кожен із напрямків за визначеними критеріями висвітлює основний чинник формування та особистісний фактор організаційної культури, а також її основну функцію і, відповідно до них, досліджує це явище. Слід зазначити, що серед них управлінському напрямкові належить основоположна роль. Наука управління актуалізувала вивчення організаційної культури, що дозволило надалі всебічно розглядати цей феномен [1]. З позиції психологічної науки організаційна культура почала вивчатися порівняно недавно, що, стало усвідомленням значення людського фактору в сучасному житті організацій різних форм і напрямків діяльності. Стосовно

ж освітніх організацій зазначимо, що ця проблема не була об'єктом спеціальних досліджень.

Таблиця 1

Напрямки і критерії вивчення організаційної культури

Напрямки	Критерії		
	Функція організаційної культури	Основний чинник формування організаційної культури	Особистісний фактор організаційної культури
Управлінський	Як інноваційний і антикризовий внутрішній фактор стратегічного управління організацією, узагальнена характеристика рівня її розвитку: структури, цілей, формальних і неформальних комунікацій, способів прийняття рішень, делегування повноважень	Керівник-лідер, місія організації	Культура управління
Економічний	Як фактор підвищення продуктивності праці, конкурентоспроможності, впровадження нових технологій, адаптації до ринкових умов, організації виробництва	Ринок, прибуток	Культура праці
Етнокультурний	Як фактор взаємозв'язку культурно-національних особливостей і ефективності діяльності організації	Етнос, ідеологія, політика	Менталітет співробітників

Психологічний	Як фактор впливу на підсвідомість і свідомість співробітників, сукупність психологічних параметрів, що характеризують групову діяльність людей в межах одного колективу відповідно до мети організації	Загальнолюдські і професійні цінності, цілі, норми, правила, кодекс поведінки, почуття, переконання, установки, міжособистісні стосунки, уявлення про способи управління і спільної діяльності, мотиви трудової поведінки	Психологічна культура, соціально-психологічний клімат
---------------	--	---	---

Мета. Розкриття поняття організаційної (корпоративної) культури підприємства та дослідження психологічних механізмів її формування.

Результати дослідження. Поняттю організаційної культури, різні автори діють в рамках певної психологічної концепції щодо її вивчення і, відповідно до мети досліджень, визначають зміст, структуру та елементи організаційної культури (табл. 2).

Таблиця 2

Психологічні концепції визначення поняття організаційна культура (ОК) в контексті психологічного підходу до її вивчення

Концепції	Складові ОК	Основні тлумачення ОК
Психоаналітична концепція	• Традиції • Ритуали • Фольклор • Міфи • Мова • Символи • Артефакти	«Культура являє собою набір важливих установок (часто таких, що їх неможливо усвідомити і сформулювати), які поділяють члени того чи іншого суспільства. » (В. Сател, 1982 р.); «Культура у метафоричному розумінні – це один із способів здійснення організаційної діяльності за допомогою мови, фольклору, традицій

		та інших засобів передачі основних цінностей, переконань, ідеології, що спрямовують діяльність підприємства в потрібне русло. » (М. Морган, 1986 р); «Корпоративна культура являє собою неявну, невидиму і неформальну свідомість організації, що керує поведінкою людей і, у свою чергу, сама формується під впливом їхньої поведінки. » (К. Шольц, 1987); «Культура – це система відносин, дій і артефактів, що витримує іспит часом і формує в членів даного культурного суспільства досить унікальну загальну для них психологію. » (П. Б. Вейлл, 2001 р.).
Біхевіористична концепція	1. Тип поведінки. 2. Мотиви трудової діяльності (трудова стимуляція, правила, процедури, стиль комунікативної взаємодії, стиль вирішення конфліктів, стиль управління)	«Організаційна культура – це набір прийомів і правил вирішення проблем зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції працівників, правил, що виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність. » (Е. Шейн, 1996 р.); «Щоб зрозуміти, що таке культура організації, необхідно розглянути методи виконання роботи і те, як обходяться з людьми в цій організації.» (Д. Олдхем, 1997 р.).
Когнітивна концепція	• Місія • Норми • Цінності • Почуття • Установки • Бажання • Уявлення • Клімат	«Під культурою організації варто розуміти унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, зразків поведінки і т. п., що визначають спосіб об'єднання груп і окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених перед нею цілей. » (Д. Елдрідж і А. Кромбі, 1974 р.); «Організаційна культура – це не

		просто одна зі складових проблеми, це сама проблема в цілому. На наш погляд, культура – це не те, що організація має, а те, чим вона є. » (М. Пацановський, Н. О’Доннел – Тружиллю, 1982 р.); «Культура – це спільні для всіх і відносно стійкі переконання, відносини і цінності, що існують у середині організації. » (П. Добсон, А. Уїльямс, М. Уолтерс, 1993 р.). «Атмосфера чи клімат в організації називається її культурою. Культура відображає домінуючі звичаї, вдачі і очікування в організації. » (М. Х. Мескон, 1994р.).
--	--	---

Психоаналітична концепція акцентує увагу на вивченні несвідомого в психіці людини, яке взаємодіє з свідомим і надсвідомим, і тому в процесі визначення змісту організаційної культури психоаналіз розглядає це явище як несвідому, ірраціональну складову системи свідомо координованої діяльності людей, що виступає носієм моральних стандартів. Організаційна культура із несвідомої складової трансформується в усвідомлену через форми спільної трудової діяльності, які притаманні для працівника в організації: творчість, суспільна активність, форми поведінки, міфи, жарти, каламбури, традиції, ритуали тощо.

Людина в концепції біхевіоризму розуміється передусім як істота, що реагує, діє, навчається і запрограмована на ті чи інші реакції, дії, поведінку. Змінюючи стимули і підкріплення, можна програмувати людину на потрібну поведінку. Біхевіористична концепція основним чинником, що зумовлюють зміст організаційної культури та її функції, визначає соціальну поведінку працівника в організації. Ця поведінка формується під впливом стимулів, на які реагує людина, та шляхом копіювання поведінки колег. Домінанта поведінкових реакцій співробітників та методів їх підкрі-

плення в організаційному середовищі зумовлює певний тип організаційної культури.

Когнітивна психологічна концепція стверджує, що людина являє собою істоту, яка аналізує інформацію про реальну дійсність, приймає рішення, вирішує проблеми і, опинившись у певній ситуації, робить вибір і здійснює вчинок. Ця теорія, отже, робить висновок, що соціальну поведінку людини в певному середовищі можна пояснити переважно за допомогою аналізу ситуаційних і міжособистісних факторів цього середовища, а не тільки особистісними особливостями людини, що проявляються в різних ситуаціях. Ці ситуаційні та міжособистісні фактори створюють потенційні сили, що сприяють актуалізації та реалізації намірів, стосунків людей. Організаційна культура в контексті когнітивної теорії є тією специфічною ситуацією, яка відображає, актуалізує й реалізує діяльність працівника в організаційному середовищі, а її основні характеристики (цінності, цілі, норми, установки тощо) є тим каналом ситуаційних явищ, які керують людьми, об'єднують їх у колектив.

По суті, психологічні концепції вивчення організаційної культури розглядають її зміст і структуру, описуючи кожна один з трьох основних компонентів цього поняття, які в ієрархічній сукупності складають це явище: неусвідомлюваний (психоаналітична концепція); пізнавальний (когнітивна концепція); поведінковий (біхевіоральна концепція). Це положення підтверджено нами у подальшому емпіричному дослідженні організаційної культури на сегменті освітніх організацій [2].

Психологічні механізми формування організаційної культури. Організаційна культура формується в процесі спілкування і сумісного вирішення проблем для досягнення єдиної мети засновника та групи однодумців. В результаті цих процесів виробляються власні цінності, критерії досягнення загальних цілей, правила і норми поведінки, форми взаємодії із зовнішнім середовищем. Тобто необхідною умовою для формування і розвитку організаційної культури є сумісна діяльність людей і наявність загальної мети [3]. Формуючи організаційну культуру, потрібно усвідомлювати, що створюються лише умови, в яких відбуватиметься її розвиток, а не керувати нею безпосередньо. Формування організаційної культури залежить від керівника організації, а отже, саме він повинен чіт-

ко встановити цінності та цілі підприємства. Розуміючи місце та значення організаційної культури для успіху досягнення стратегічних цілей організації та уміння формувати бажаний профіль організаційної культури, є важливими умовами вдалих організаційних змін, в процесі яких формується організаційна культура.

Етапи формування умов організаційної культури [4]:

1) визначення місії, цілей та стратегії організації (визначення критеріїв досягнення цілей організації та цілей формування організаційної культури);

2) формування цінностей, норм та правил бажаної поведінки;

3) визначення методів та засобів впровадження сформованих цінностей, норм, правил поведінки (формування системи внутрішніх комунікацій, створення легенд, символів, обрядів);

4) розроблення програми адаптації та навчання працівників підприємства з урахуванням елементів організаційної культури (структурна побудова);

5) реалізація програми впровадження організаційної культури та здійснення її моніторингу, щодо усунення недоліків та формування нових компетенцій.

Внутрішня характеристика феномена організаційної культури передбачає опис психологічних процесів та механізмів її психічної регуляції, її структури та змісту, операційних засобів її реалізації. Предметом психологічного вивчення організаційної культури виступають психологічні компоненти, які спонукають, направляють і регулюють трудову активність співробітників і реалізують її в виконавських діях, а також особисті властивості співробітників, через які ця активність реалізується. Предмети, речі, конкретні люди або об'єднання, події та процеси, які відбуваються в суспільстві, по-різному сполучаються з наявними у них потребами.

Глибинним джерелом мотивації трудової поведінки людини є потреби, під якими розуміються бажання, потреба співробітника, колективу в чомусь. Первинні та вторинні потреби рівноцінні, однаково вагомі, в ряді випадків, матеріальне, не може замінити і компенсувати моральне, відповідно з цим прийнято виділяти дві системи мотивації зовнішню і внутрішню, між якими існують досить складні і закономірні стосунки. Вони зумовлюють особистісні уподобання співробітника, особистісну привабливість управлін-

ської діяльності, а також професійні успіхи при її здійсненні. Саме в професійному становленні та розвитку, матеріальний стимул значно переломлюється через моральну природу людини. Люди стикаються, з все більшою кількістю об'єктів, що будять їхню цікавість, інтерес і бажання. В результаті співвіднесення особистих мотивів з цілями організації, формується особливе і найважливіше психологічне утворення – особистісний сенс діяльності.

Спрямованість особистості на ті чи інші цінності, характеризують її ціннісні орієнтації і служать, свого роду вектором, особистісним сенсом діяльності. Розрізняють цінності-цілі (термінальні) і цінності-засоби (інструментальні). Перші, відображають цілі і устремління людини, то для чого і заради чого вона живе, і трудиться: здоров'я, любов, сім'я, матеріальні блага, спокій, цікава робота, служіння науці і суспільству тощо. Другі, являють собою як, і які способи людина використовує, для досягнення своїх цілей: активність, ініціативу, силу волі, наполегливість, уміння тримати слово і пр., а також можуть являти собою переконання особистості (добре-погано, морально-аморально тощо).

Серед внутрішніх збудників цінності, цілі, установки є схильністю – внутрішньою позицією співробітника стосовно до різних ситуацій і явищам в організації. Культура особистості індивіда в процесі професійної діяльності охоплює: перцептивну, пізнавальну, афективну і поведінкову сфери:

- перцептивна, пов'язана зі сприйняттям себе, інших співробітників, мікрогруп, тощо;
- пізнавальна, пов'язана з накопиченням, передачею або обміном інформацією, знаннями, самопізнання і пр. ;
- афективна, що виявляється в переживанні різних емоційних станів пов'язаних з професійною діяльністю; – поведінкова, що виявляється в способах взаємодії, формах закріпленого поведінки [5].

Сумнів у спроможності базового уявлення викликає тривогу і відчуття незахищеності. Колективні базові уявлення – як на груповому, так і на індивідуальному рівні – виконують роль «психологічних когнітивних захисних механізмів». Внутрішні переживання, які, здавалося б, ніяким чином не пов'язані з діяльністю реальною, орієнтованою на результат організації, дуже часто встають на шляху ефективної роботи персоналу та ефективного управління.

Психологічні умови формування чи оптимізації культури єдині для всіх її типів:

1. Достатній і необхідний рівень психологічної безпеки (відсутність загрози втрати індивідуальності, добровільна інтеграція).

2. Облік організаційних і перегляд власних уявлень-стереотипів, цінностей (індивідуальна і групова рефлексія).

3. Співучасть, інформованість (нейтралізація фактору невідзначеності) всіх співробітників організації.

4. Емоційна готовність до контактів («тіснота емоційних зв'язків»).

5. Організація рольових очікувань з боку менеджменту (мотивація).

6. Організація процесу права – відповідальності (критерії повноважень і професіоналізму) [5].

Будь-який організований процес, у тому числі й виробництво, здійснюються і регулюються людьми. Його ефективність значною мірою залежить від того, як працівники ставляться до виконання своїх функцій і реалізація мети, задля якої цей процес здійснюється, а отже на продуктивність праці.

Мотивація – це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації [6]. Мотивація являється частиною організаційною культури, що направлена на підвищення продуктивності праці.

Основні задачі мотивації [6]:

- формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;

- навчання персоналу і керівного складу психологічним основам спілкування;

- формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації.

Найпершим і найбільш поширеним методом мотивації був метод покарання і заохочення, так називана політика «батога і пряника». Цей метод використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи. Поступово він трансформувався в систему адміністративних і економічних санкцій і стимулів [7].

З підвищенням ролі людського чинника з'явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі в чим-небудь. Відчуття нестачі в чим-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб.

Мотивація взагалі ґрунтується на потребах людей. Оскільки людині властиві різні потреби, теоретики їх класифікують за певною ієрархією. Найбільш поширеною є класифікація потреб А. Маслоу. Сутність її зводиться до вивчення потреб людини. У основі поведінки лежать потреби людини, що можна розділити на п'ять груп: у самовиразі; в повазі; в спілкуванні з людьми; в безпеці; фізіологічні [7].

Зміст такої ієрархічної побудови полягає в тому, що пріоритетні для людини потреби більш низьких рівнів і це позначається на його мотивації.

Обов'язок керівника полягає в тому, щоб ретельно спостерігати за своїми підпорядкованими, вчасно з'ясовувати, які активні потреби рухають кожним із них, і приймати рішення по їхній реалізації з метою підвищення ефективності роботи співробітників.

У системі мотивацій вирішальна роль належить матеріальному (економічному) стимулюванню, яке здійснюється в таких формах, як грошові виплати (прямі і непрямі), передання матеріальних благ і надання певних пільг. У нормально функціонуючій ринковій економіці грошова форма матеріального стимулювання є основною. Винагорода у формі матеріальних благ чи пільг вважається винятковою і застосовується епізодично [8].

Поряд з матеріальним заохоченням широко застосовуються різні форми соціально-психологічного (неекономічного) стимулювання, яке в нас традиційно називають моральним. З підвищенням освітньо-кваліфікаційного рівня працівників та якості їх життя роль соціально-психологічних чинників мотивації зростає.

Стимулююча система винагородження покликана встановити зв'язок між винагородою і перевищенням встановленої норми продуктивності праці. Хоча в культурі організації заробітна плата також може успішно виконувати цю функцію, вона найчастіше має

свої обмеження: або тимчасові (затримка зарплати), або матеріальні (обмежена окладом, розрядом). Тому така нагорода часто не співвідноситься одержувачем із виконаною роботою. Система стимулюючого винагородження використовується як засіб мотивації, на додаток до заробітної плати. Для того, щоб система стимулюючого винагородження була ефективною, необхідно виконання двох основних вимог: проведення періодичної оцінки робіт, справедлива оцінка (службовці повинні відчувати, що їхня робота оцінюється так само справедливо, як і робота їхніх колег) [8].

Ключове питання у вимірюванні виконаної роботи – ступінь довіри до адміністрації, що проводить цю оцінку. Службовці повинні відчувати пряму залежність між виконаною роботою і винагородою. Ця вимога особливо важлива при груповій роботі. Члени групи повинні відчувати, що результат групової роботи складається з індивідуальних внесків кожного.

Перевага індивідуальних систем стимулювання полягає в тому, що службовці можуть бачити безпосередні результати своєї праці. Це вносить елемент змагання в роботу персоналу. Проте загалом цей позитивний факт може мати негативні наслідки – погіршення стосунків у колективі, замкнутість, заздрість [7]. Таким чином, питання організаційної культури та її впливу на мотивацію персоналу підприємства потребує подальшого дослідження. Важливим є виокремлення конкретних характеристик організаційної культури організації, які є привабливими та мотивуючими для персоналу і, водночас, сприяють розвиткові організації, поліпшенню її фінансових показників, зміцненню позицій на ринку. Адже сильна організаційна культура має поєднувати і турботу про інтереси всіх членів організації, і турботу про інтереси самої організації.

Висновки. Внутрішня характеристика феномена організаційної культури передбачає опис психологічних процесів та механізмів її психічної регуляції, її структури та змісту, операційних засобів її реалізації. Для реалізації мотиваційної функції організаційної культури важливим є узгоджене застосування ціннісного та цільового управління, використання традиційних засобів мотивації праці, так і специфічних засобів організаційної культури. З підвищенням ролі людського чинника з'явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріаль-

ні мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі в чим-небудь. Відчуття нестачі в чим-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб. Саме в професійному становленні та розвитку, матеріальний стимул значно переломлюється через моральну природу людини. В результаті співвіднесення особистих мотивів з цілями організації, формується особливе і найважливіше психологічне утворення – особистісний сенс діяльності. Сильна організаційна культура має поєднувати і турботу про інтереси всіх членів організації, і турботу про інтереси самої організації.

Ключові слова. психологічні механізми, особистість, організація, підприємство, персонал, професійні компетентності, особистісні якості.

Література.

1. Монастирський Г. Л. Теорія організації. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18340719/management/organizatsiyna_kultura
2. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: навч. пос. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 695 с.
3. Дяків О. П., Островерхов В. М. Особливості формування організаційної культури та її вплив на розвиток трудового потенціалу підприємства / О. П. Дяків, В. М. Островерхов // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 2. – С. 65-72.
4. Кузьмін О. Е., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник / О. Е. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
5. Карамушка Л. М. Психологія відданості персоналу організації [монографія] / Л. М. Карамушка, І. А. Андрєєвна. – К. – Львів : Галицький друкар, 2012. – 212 с.
6. Воронкова, В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади [Текст] : навч. посібник для виз / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов та ін. ; ред. В. Г. Воронкова ; ЗДІА. – К. : Професіонал, 2006. – 567 с.
7. Большакова А. Н. Социальная психология для менеджеров / А. Н. Большакова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 352 с.
8. Карамушка Л. М. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко. – Львів: Край, 2010. – 210 с.

4.5. Психологічні детермінанти адаптації та мотивації персоналу організації до професійної діяльності

*Дичук В.В., Лапінський А.В., Леонов О.П.,
Мовчан М.М., Сирих П.А., Форостовець Є.С., Хоролець О.В.*

Актуальність. Однією з центральних проблем сучасної економічної реформації в Україні є утворення високоефективного мотиваційного механізму ініціативної економічної діяльності взагалі і праці зокрема. Бо ніщо так не обумовлює якість, темпи і кінцевий успіх виходу економіки України з кризи, як ефективна система залучення людей до праці. Проблема мотивації трудової діяльності робітників підприємств різних форм власності в умовах трансформації української економіки – одна з найбільш складних. Опрацювання питань мотивації трудової діяльності сприятиме вирішенню суспільних проблем.

В сучасних умовах постає необхідність комплексного підходу в дослідженні особливостей формування мотиваційного механізму трудової діяльності робітників підприємств різних форм власності. Аналіз формування мотивації трудової діяльності необхідно здійснити з урахуванням політичних і соціально-економічних умов. В умовах ринкової економіки та багатоманітності форм господарювання формується клас підприємців, тому потрібно переосмислення динаміки мотивації трудової діяльності в свідомості та поведінці індивідів. Розкриття механізму самореалізації особистості робітників дозволить знайти місце потреб і мотивів праці в ньому. Для подолання негативних факторів в сфері трудових відносин доречно вивчення моделей та зразків мотивації трудової діяльності та їх трансформація в сучасних умовах. На сучасному етапі розвитку виробничих відносин необхідно поглиблене вивчення культурологічних аспектів суспільного життя.

В умовах економічної нестабільності зростає роль матеріального стимулювання, тому мотиви отримання винагороди за якісно виконану роботу – важливий каталізатор, здатний суттєво підвищити трудову активність.

З акцентом на психолого-управлінський прагматизм мотивація може бути визначена як «процес стимулювання самого себе та інших на діяльність, спрямовану на досягнення індивідуальних та загальних цілей організації». З цього витікає, що мотивація трудової діяльності може бути як зовнішнім по відношенню до мотивуючого суб'єкту, процесом, так і внутрішнім (самотивація), і при цьому розглядається як на макрорівні – мотивація праці взагалі, направлена на загальне підвищення трудової активності, так і на мікрорівні – мотивація праці конкретного робітника в інтересах конкретної організації та його власних.

Мета. Проаналізувати важливість психологічних детермінантів адаптації та мотивації персоналу організації до професійної діяльності

Результати дослідження. Мотивація праці являє собою усвідомлене спонукання робітника до праці шляхом впливу на притаманні йому мотиви праці. Виділяють три основних види мотивації праці: матеріальну, соціальну та адміністративну. Мотивація включає стимулювання (позитивна мотивація) та санкції (негативна мотивація). Якщо абстрагуватися від незначних відмінностей між визначеннями, суть мотивації зводиться до того, що це процес спонукання людей до діяльності певної спрямованості. І те, що мотивація праці є спонукання до праці, ніяких різночитань не викликає. Вони починаються щодо пріоритетних концепцій мотивації праці та практики мотивації.

Еволюція суспільства в своєму зрізі може бути представлена у вигляді двох еволюцій, що протікають паралельно і підкоряються одному часовому імперативу: власне людини та мотивації його ініціативної економічної діяльності. І так само, як по своїй суті з доісторичних часів, майже не змінилися основні фізіологічні потреби людини (прогресували лише способи їх задоволення), не змінилася, хоча дещо трансформувалася головна спонукаюча причина трудової діяльності – мотив задоволення основних фізіологічних потреб людини. Це означає, що з часів передпраці в основі мотиваційної парадигми розташовується така соціально-економічна функція праці, як праця в якості джерела засобів існування людини. Разом з тим, провідна роль потребової мотивації в загальній її системі сьогодні піддається сумніву західною економічною наукою та теорією управління. На думку американських фахівців, хоча припущення, закладені

в початкових концепціях мотивації, неправильні, зрозуміти їх все ж важливо. І хоча керівники минулого, часом неправильно розуміли поведінку людей, способи, якими вони користувалися (в примусу до праці), часто були ефективними. Так як ці способи працювали багато сотень років на відміну від двох-трьох десятиліть існування сучасних теорій, первинні концепції мотивації праці глибоко вкорінилися. Спокуса застосувати ці прості прагматичні підходи буде помилкою. Підлегли в сучасних організаціях значно більше освідченні і забезпечені, ніж у минулому. Тому їх мотиви трудової діяльності виявляються більш складними для впливу.

Наведені думки можуть бути по-різному оцінені з двох точок зору: економічної та управлінської. З позицій науки управління, яка оперує на стику економіки, психології, зокрема біхевіоризму, і розглядає мотивацію праці на макрорівні, автори майже праві. «Майже» тому, що важко згодитися з тезою про автоматичне задоволення в сучасних умовах первинних потреб всіх працюючих у розвинутих країнах. Такий висновок є правильним стосовно до сфер підприємництва, середнього та вищого менеджменту, а також до деяких категорій висококваліфікованих робітників, службовців. Для багатьох інших страт суспільства потребова мотивація праці залишається домінуючою. До того ж остання не зникає абсолютно і для вищого шару середнього класу, а лише відносно втрачає свою актуальність на тлі актуалізації просунутих індивідуально-психологічних мотивів. Звичайно, абсолютна потребова мотивація забезпечених людей не спостерігається в соціально-економічному стані їх стійкого соціального статусу. Але вона стає помітною, актуалізується в періоди різних форс-мажорних обставин, пов'язаних з перспективами втрати звичних прибутків, стабільного статусу. З позицій економічної теорії, висновок про архаїчність і «неправильність» потребової мотивації праці уявляється докорінно неправильним. Маючи справу з мотивацією праці не стільки на мікро-, скільки на макрорівні, економічна теорія свідчить, що потребова мотивація праці не зникає, а її стимулююче значення сьогодні таке ж актуальне, як і в минулому. Інша справа, що суттєво зросли та модифікувалися потреби, значних змін зазнав ціннісний світ особистості, а відповідно цьому змінився інструментарій пріоритетних способів реалізації потребової мотивації праці.

В своїй еволюції мотивація праці взагалі і потреба мотивація зокрема пройшли ряд етапів і приймали різні організаційно-економічні форми. При цьому мотивація праці, яка передбачала в тій чи іншій історичній обстановці певний комплекс прийомів та способів залучення (примусу) людей до праці, в процесі своєї еволюції знала два принципово різних мотиви до праці: зовнішня необхідність і внутрішня потреба. В основі першої лежить зовнішній примус у всіх його архаїчних та цивілізованих формах, в основі другої – внутрішній імпульс до праці. І якщо відволіктися від психолого-економічних тонкощів просунутої мотивації наших днів, то мотивація праці завжди є діалектика спонукання та свободи, з різним ступенем їх превалювання.

Еволюція спонукання до праці знає два його типи: позаекономічний та економічний. При цьому характерною помилкою представників різних наукових шкіл, що займаються даною проблематикою, є прагнення хронологічно строго розділити на шкалі періодизації ці два види спонукання. Спроба представити справу так, немовбито, на певному етапі еволюції історично первинне позаекономічне спонукання до праці поступилося місцем історично вторинному економічному спонуканню, – непереконлива. Звичайно, якщо надати цим типам примусу визначення «переважно», то історично першим був позаекономічний примус до праці. Але це не означає, що разом з початком превалювання економічного примусу до праці його позаекономічна предтеча сходить з історичної арени. Досить згадати комуністичний експеримент, в рамках якого поряд з економічним примусом існувало і модифіковане рабство з усіма його мотиваційними атрибутами, а також ідеологічні та інші позаекономічні методи примусу до праці. Але то була аномалія еволюційного розвитку, «випадання» з економічної цивілізації. Правило ж підтверджується тим, що позаекономічний примус до праці в сучасних формах існує і в розвинутих країнах, і в країнах третього світу поряд з економічним примусом. Ці обидва типи примусу займають свої ніші.

Як позаекономічний, так і економічний примус до праці в ході своєї еволюції приймали різні форми, зберігаючи при цьому родові ознаки. Якщо говорити про первинність двох начал мотивації праці взагалі – необхідності і свободи – то історичний пріоритет належить зовнішній економічній необхідності. При цьому праця

завжди включала в себе поєднання елементів примусу і свободи. Причому ретроспектива мотивації праці свідчить про те, що вона пройшла шлях від повного превалювання елементів примусу до суттєвого підвищення ролі свободи як детермінанти мотивації праці в умовах збереження економічною необхідністю значення універсального мотивуючого фактору.

Епоха превалювання позаекономічного примусу до праці є передісторією мотивації праці у власному розумінні слова. Так як дійсна економічна мотивація праці починається коли і тоді, там і де закінчується юридична несвобода особистості, відсутність свободи вибору праці та типу економічної поведінки. У зв'язку з цим позаекономічний примус можна розглядати в рамках загальної схеми мотивації праці лише умовно, як один з передцивілізованих способів залучення людей до праці. Історія ж власне мотивації праці починається з економічної (потребової) мотивації і при цьому нею не закінчується і не обмежується.

Саме питання мотивації праці в різні роки досліджували економісти-теоретики, фахівці з економіки праці, менеджменту, соціології, психології та інших наук. Вони зробили значний внесок у вивчення питання мотивації праці. Сьогодні існують різні теорії мотивації, налічується велика кількість визначень поняття мотивації і загалом в науці закріпився плюралістичний підхід до розуміння даної категорії. Отже, мотивація являє собою перш за все прагнення певної людини до конкретної дії, в якій вона відчуває потребу, але не здатна приступити до неї і здійснити самостійно. Поряд з тим, мотивація праці уособлює в собі прагнення працівника задовольнити свої потреби або являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, котрі спонукають людину до трудової діяльності та надають цій діяльності спрямованість, яка орієнтована на досягнення визначених цілей.

В. Герасимчук визначає термін «мотивація» у такий спосіб: «Мотивація (лат. *motivatio*) – динамічна система взаємодіючих між собою внутрішніх факторів (мотиваторів), які викликають і направляють орієнтовану на досягнення мети поведінку людини чи тварини. Під внутрішніми факторами будемо розуміти потреби, бажання, прагнення, очікування, сприйняття, ціннісні установки й інші психологічні компоненти особистості».

У вузькому розумінні цього слова мотивовану діяльність можна визначити як вільні, обумовлені внутрішніми спонуканнями дії людини, спрямовані на досягнення своїх цілей, реалізацію своїх інтересів, а мотивацію праці як прагнення працівника задовольнити свої потреби (отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. Мотивація праці є найважливішим чинником результативності роботи.

Н. М. Боднар зазначає, що мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотивація праці – це бажання працівника задовольнити свої потреби через трудову діяльність.

На переконання Б. А. Гаєвського, в структуру мотиву праці входять:

- потреби, які хоче задовольнити працівник;
- цінності, що здатні задовольнити цю потребу;
- трудові дії, які необхідні для одержання благ;
- ціна – витрати матеріального і морального характеру, що пов'язані з трудовою діяльністю.

Мотив праці формується, якщо в розпорядку суб'єкта управління є потрібний набір цінностей, що відповідає соціальне обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними і моральними витратами, ніж інші види діяльності.

Стимул – складне інтегральне психологічне явище. Це стійка особистісна властивість, що містить потреби, а також наміри щось зробити, включаючи спонукання до цього. Існує багато визначень стимулювання, однак всі вони визначають процес, що відбувається всередині людини і спонукає до дії, змушуючи її поводитися в якійсь конкретній ситуації певним чином. Поведінка ж особистості, як правило, спрямовується її найбільш сильною потребою, яку вона прагне задовольнити, активізуючи при цьому всю свою енергію і можливості.

Структуру стимулювання можна відокремити на три блоки:

- потреби;
- «внутрішній фільтр» (моральний контроль, оцінка своїх можливостей, інтереси, нахили, тощо);

– цільовий блок (образ предмета, що може задовольнити потребу, мета, процес задоволення потреб). Саме потреби виступають джерелом активності людини, завдяки ним здійснюється регулювання поведінки особистості, визначається спрямованість мислення, емоцій, почуттів і волі людини.

Стимули діяльності відіграють велику роль у житті кожної людини і суспільства в цілому. Від змісту і характеру стимулів значною мірою залежать характер та ефективність діяльності. Встановлено, що мотиваційна сфера має ієрархічний характер, тобто стимули, які стимулюють поведінку людини, неоднаково значущі для неї, неоднаково дійові, неоднаково стійкі. Одні стимули домінують, інші посідають другорядне, підпорядковане місце. Відомий американський психолог А. Маслоу (1908-1970), засновник гуманістичної психології, підкреслюючи прагнення людини до самовдосконалення, реалізації свого потенціалу, запропонував ієрархію стимулів, які стимулюють трудову активність працівників.

Стимулювання праці персоналу впливає на його продуктивність і спрямованість, підвищення професійної компетентності та кар'єрного зростання, а також досягнення організаційних цілей.

Саме професійне здоров'я є одним з основних показників «якості професійного життя», а також важливою умовою ефективності трудової діяльності, яка включає в себе не тільки високу продуктивність і якість праці, але й їх співвідношення із затраченими зусиллями працівника. В умовах праці здоров'я стає суб'єктивною самоцінністю для працюючої людини і є економічним механізмом підвищення результативності та якості праці.

Сучасна професійна діяльність може впливати на людину як позитивно, так і негативно (перевтома, професійний стрес, психотравмуючі фактори). В результаті впливу негативних факторів праці в людини може виникнути хронічна перевтома, емоційне напруження та інші прояви, які можуть позначитись на стані здоров'я середнього медичного працівника. Професійна діяльність є найбільш напруженою (у психологічному плані) серед видів соціальної діяльності і входить до групи професій з великою кількістю й інтенсивністю стрес-факторів. Особливості цієї діяльності вимагають від фахівців високої відповідальності і розвинених професійних навичок у зв'язку з великими фізичними та нервово-е-

моційними навантаженнями. Успішність її виконання залежить не тільки від загальної та спеціальної підготовки фахівців, але й від ступеня розвитку у них низки неспецифічних психологічних і психофізіологічних якостей. До них належать індивідуально-психологічні особливості, характеристики інтелектуальної та мотиваційної сфер, показники уваги, пам'яті, моторних функцій тощо.

Висновки. Психологічні та психофізіологічні якості базуються на фундаментальних закономірностях адаптації людини до діяльності в екстремальних умовах. Психічна адаптація має безпосереднє відношення до аналізу особливостей функціонального стану осіб, що здійснюють діяльність у надзвичайних ситуаціях, а також осіб, які переживають їх наслідки. Однак дослідження, проведені за останні десятиліття, довели реальність існування цього явища, що отримало назву «синдром професійного вигорання». По суті своїй прояви професійного вигорання дуже схожі на стан хронічного стресу і психічного перевантаження, і його ядром є емоційне виснаження особистості.

Професійне вигорання – це синдром, що розвивається на фоні хронічного стресу і призводить до виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини. Синдром професійного вигорання – найнебезпечніше професійна хвороба тих, хто працює з людьми: медичних працівників, вчителів, соціальних працівників, психологів, менеджерів, журналістів, бізнесменів і політиків, всіх, чия діяльність неможлива без спілкування. Невипадково, перший дослідник цього явища Кристина Масlach, назвала свою книгу: «Емоційне згорання-плата за співчуття». Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. Щоденна робота з постійним фізичним та психічним навантаженням, ускладнена напруженими емоційними контактами, призводить до життя в стані постійного стресу, накопичення його наслідків, виснаження запасів життєвої енергії, як наслідок-до серйозних фізичних захворювань і ранньої смерті. ПВ веде до виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів людини. З точки зору концепції стресу (Р. Сельє), професійне вигорання – це дистрес або третя стадія загального адаптаційного синдрому – стадія виснаження.

Література.

1. Куренкова К. М. Формирование профессиональных ценностей будущих медицинских сестер в процессе профессиональной подготовке: Автореф. дис. кан. пед. наук – М., 2009. – 20с.
2. Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С., Остапчук В. В. Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення: Методичний посібник. – К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. – 282 с.
3. Юрценюк О.С. Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури) / О. С. Юрценюк, Н. С. Карвацька, С. Д. Савка, С. С. Ротар, В. І. Курик // Буковинський медичний вісник. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 235-238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2017_21_1_52
4. Городовіченко В. М. Емоційне вигорання – плата за співчуття: стаття, журнал Медсестринство 3, 2013.
5. Коржик Б. М. Теоретичні основи Безпека життєдіяльності. -К. 1995.

4.6. Психологічні особливості професійної діяльності керівника організації та підтримка психічного здоров'я на робочому місці в Україні в умовах війни: виклики та керівництво до дій

*Борець О. А., Закревский Ю. Ю.,
Мусієнко Д. В., Охрімчук Д. А., Циганок О. М.*

Актуальність. Ефективне управління підприємствами забезпечує розвиток та підйом вітчизняного виробництва, появу нових видів товарів та підвищення їх якості, спроможність підприємств реагувати на змінні умови ринку. Процес економічної реорганізації сприяв появі потреби в підвищенні використання кадрового потенціалу керівників усіх ланок управління підприємств.

На сучасному етапі структурні економічні зміни супроводжуються реформуванням організаційно-правових форм функціонування суб'єктів господарювання та реорганізацією соціально-економічної формації. Впровадження нових стандартів системи управління якістю та обліку, зміни у функціонуванні банківської системи, перехід до проектного менеджменту на основі бізнес-планів та інші нововведення, які стосуються економіки підприємств, потребують залучення до управління нових кадрів, менеджерів нового покоління.

Управління середнім та малим бізнесом, керування державним підприємством, процес організації виробництва в сучасних умовах становлення та розвитку економіки України потребують прийняття дієвих управлінських рішень, виважених кроків у бізнес-плануванні, складанні інвестиційних проектів та інших видів управлінських робіт. Це висуває значні вимоги до якісних показників діяльності керівника, до його здатності оперативно вирішувати поставлені завдання, обирати вірні шляхи розвитку підприємства. Крім того, із зростанням малого та середнього бізнесу на діяльність керівників все більше впливають специфічні та індивідуальні, притаманні окремій фірмі умови виконання завдань з управління. Все це зумовлює необхідність розробки механізму оцінки ефективності використання керівного персоналу підприємств, а потім і його

оптимізації з врахуванням нових ринкових умов та специфіки діяльності окремого керівника як складової частини управлінського апарату підприємства.

Мета. Комплексний аналіз психологічних особливостей професійної діяльності керівника організації.

Результати дослідження. Як показав аналіз, ефективність управління у сучасному менеджменті підприємств оцінюється з різних позицій. Це, насамперед, залежить від того, які показники, що впливають на ефективність діяльності керівників, враховуються. Зокрема у роботах Андрушківа Б. М., Герасимчука В. Г., Скрипника К. Д., Ревенко Н., Рудницької О. М., Шуванова В. І., Цимбалюк С. О. та інших робиться спроба за допомогою комплексних коефіцієнтів оцінювати загальний стан діяльності управлінського персоналу, але ці дослідження носять досить узагальнений характер. Крім того, залишається невизначеним питання про оцінку індивідуального внеску кожного керівника, а саме якісної її сторони, у роботі всього управлінського апарату. Розв'язання цієї проблеми може надати змогу вирішувати концептуальні стратегічні та тактичні цілі в системі управління персоналом, що сприятиме подальшому покращенню роботи підприємства в цілому. Це вимагає нового комплексного підходу до вирішення проблеми та системності в опрацюванні конкретних завдань.

З погляду психології управління для керівника важливе знання всіх аспектів цієї дефініції: знаючи, наприклад, тип організації, він чіткіше зможе визначити свою роль у ній, джерела влади, спосіб впливу на підлеглих тощо. І чим розгалуженіша система різноманітних ланок, тим більшою є потреба в координації окремих видів діяльності з метою уникнення дублювання дій підрозділів тощо. Непорозуміння щодо обов'язків, нечіткість комунікацій знижують продуктивність праці, призводять до невиконання завдань. Чітке знання керівником, співробітниками своїх функцій, меж персональної відповідальності, координування дій, процесів, діяльності передбачає наявність структури організації.

Багатоаспектність роботи керівників передбачає вміле оперування поняттями «людина», «індивід», «індивідуальність», а також тими, що пов'язані з особистістю становлять її структуру: «темперамент», «характер», «здібності», «емоції», «вольові якості», «мотивація», «соціальні установки». Структура особистості

охоплює – загальнолюдські властивості (відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять, воля, емоції– соціально-специфічні риси (соціальні установки, ролі, ціннісні орієнтації); – індивідуально-неповторні риси (темперамент, поєднання ролей, самосвідомість).

Це дає змогу розглядати особистість як багаторівневу систему, що об'єднує в собі психофізіологічний, психологічний і соціально-психологічний рівні. В умовах управління та ділової взаємодії люди оцінюють один одного за рівнем інтелекту, який утворюється системою пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, мова, увага, уява), індивідуально-психологічними властивостями (темперамент, характер, спрямованість тощо).

Постать керівника стала об'єктом інтенсивного дослідження психологів у 70-ті роки ХХ ст. – період революції в управлінні, яка розширила його сферу за межі економіки і промислових підприємств сприяла вдосконаленню, оновленню управлінських методів і технологій тощо. Все це пред'явило нові вимоги до керівників та їх управлінської діяльності.

Психологи вважають, що ефективність управлінської діяльності залежить від таких суб'єктивних чинників, як досвід, здібності та якості керівника. Досвід вони розглядають як якість особистості, сформовану шляхом навчання, як узагальнюючі знання, навички, вміння і звички; управлінські здібності як особливості й якості особистості, що є суб'єктивними умовами успішного здійснення певного виду діяльності і які не можна звести до знань, умінь та навичок керівника; якості керівника – як результат реалізації його здібностей у процесі управлінської діяльності. Особливості темпераменту позначаються в навчальних заняттях і в трудовій діяльності природно. Але головне полягає в тому, що відмінності за темпераментами – це відмінності за рівнем можливості психіки, а по своєрідності її проявів. Встановлено відсутність залежності між рівнем досягнень, тобто кінцевим результатом дій, і особливостями темпераменту, якщо діяльність протікає в умовах, які можна визначити як нормальні. Разом з тим дослідження, що встановлюють цю закономірність, показує, що залежно від темпераменту змінюється спосіб здійснення самої діяльності.

Стиль керівника – це є індивідуально типові особливості системи способів, методів, прийомів впливу керівника на колектив з метою ефективного та якісного виконання управлінських функцій.

Поняття стилю доцільно застосовувати насамперед стосовно особистості керівника. Причому індивідуальний стиль є особливою формою поєднання виробничої функції керівника з його функцією регулювання особистих взаємовідносин між членами підпорядкованого йому колективу. До суб'єктивних якостей керівника, які визначають стиль його керівництва, відносять інтелект, загальну культуру, рівень професійної майстерності, особливості характеру і темпераменту, моральні якості та ін.

Об'єктивно стиль керівника диктується насамперед усвідомленою метою, яка визначає спосіб і характер його дій і якій він повинен підпорядковувати свою волю. Виходячи з цього, об'єктивні складові стилю такі: закономірності управління; специфіка (функціональне призначення) сфери конкретної діяльності; вимоги, які висуваються до керівників суспільством щодо їхньої компетенції, діловитості, відповідальності, особистих якостей, моралі, темпераменту, характеру тощо; соціально-психологічні риси виконавців (вік, стать, кваліфікація, професія, інтереси та потреби тощо); специфіка системи (її цілі та завдання, управлінські структури і технологія управління, функціональний зміст діяльності керівника); виробниче середовище (технологічний рівень виробництва, форми організації праці, забезпеченість виробничими ресурсами); особливості керованого колективу (структура та рівень підготовленості, характер формальних і неформальних взаємовідносин, традиції та ціннісні орієнтації); рівень ієрархії управління; способи та прийоми управління, які використовуються вищими керівниками. Зазначені складові стилю визначають особливості поєднання в діяльності керівника господарської системи виробничої функції і функції регулювання взаємовідносин у колективі, природу традицій і прийомів спілкування, що склалися в ньому, а тим самим і стиль роботи. Стиль, якого дотримується керівник, постійно перебуває в полі зору його підлеглих. Він певним чином оцінюється та сприймається ними. Багато наслідують свого керівника, намагаються його копіювати. Тому стиль роботи підлеглих атестує їхніх керівників так само переконливо, як поведінка дітей – їхніх батьків.

Всі люди різні за характером, за темпераментом, за розумовими здібностями. Керівники теж бувають зовсім різні. Класифікацію керівників можна приводити по самим різним критеріям. Всі види класифікацій обмежені і не можуть однозначно віднести керівника

до тієї чи іншої категорії. Тут розглянуті тільки деякі принципи поділу керівників на різні «типи».

Поняття «типи» висвітлює характерні властивості особистості, представника певної групи людей. Характерологічними властивостями особистості керівника є суспільна скерованість особистості, «потаємне» «Я» і стереотипи поведінки, які сукупно становлять цілісність поняття «тип керівника».

Тип керівника – особистість, яка в узагальненій формі втілює певні характерологічні властивості. На формування типу керівника впливають:

- політична система суспільства (тоталітарна, демократична тощо);
- виробничі відносини, які залежать від способу господарювання;
- загальнолюдські цінності; цінності певного суспільства, які становлять мораль (релігія, традиції, «неписані закони» тощо)
- психофізіологічна природа людини, зумовлена способом існування індивіда як частки природної системи (виявляється переважно в потребах);
- національний менталітет.

Тип поведінки керівника є суттєвим чинником впливу управлінського стилю на якість і ефективність роботи організації. Згідно з теорією К. -Г. Юнга залежно від способів сприймання інформації й процесу прийняття рішень виокремлюють чотири типи особистості:

1. Ті, що думають свідомо. Такі особистості люблять порядок, чіткість і контроль, надають перевагу короткочасним програмам і приймають стандартні рішення. На перше місце ставить логіку, кваліфікацію і ефективність. Чудовий індивідуальний виконавець. Удосконалює свої знання та навички. Логіка дій характерна для багатьох бухгалтерів, аналітиків, маркетологів, програмістів і консультантів. Зневажливо ставиться до думок інших. На керівних постах заважає абсолютна впевненість у власній праоті.

2. Ті, що думають інтуїтивно. Вони більш схильні до довгострокового планування, виявляють нахили до інновацій, сміливо йдуть на ризик, використовують можливості колективу, добре справляються з роллю керівника, орієнтовані на дії і досягнення цілей.

3. Ті, що відчують свідомо. Привабливими вважають короткочасні програми, особливу увагу приділяють людському чиннику.

4. Ті, що відчують інтуїтивно. Здебільшого покладаються на інтуїцію, уникають правил, їх приваблюють довгострокові цілі й проблеми, що вимагають нестандартних рішень.

У багатьох сучасних дослідженнях йдеться про новий тип керівника, який головним своїм завданням вважає створення власного іміджу і таким чином сприяє формуванню й утвердженню бюрократії.

Керівники бюрократичного типу. Зовні вони намагаються підкреслити свою перевагу, але дуже некомфортно почувають себе під час взаємодії із підлеглими. Виявляють активність у роботі різних комітетів. У своїх безпосередніх керівників створюють враження постійної зайнятості. Головна шкода від такого типу керівників полягає у зниженні рівня мотивації до сумлінної праці серед кваліфікованих працівників.

Велику пізнавальну і практичну цінність мають дослідження поведінки керівників у конфліктній ситуації, вияви якої зводяться до п'яти типів: конкуруючий, компромісний, той, що пристосовується, уникає і співпрацює.

Інші дослідження стверджують, що в управлінській культурі наявні чотири основних типи керівників:

1. «Майстри». Дотримуються традиційної системи цінностей, яка охоплює виробничу етику і ставлення до співробітників, що залежить від того, наскільки творчо вони виконують свої обов'язки. Такі керівники бувають поглинутими предметом своїх творчих пошуків настільки, що це заважає їм керувати складними і мінливими організаційними системами.

2. «Борці з джунглями». Пристрасно прагнуть до влади, сприймають себе та інших мешканцями «людських джунглів», де кожен прагне з'їсти іншого, їх інтелектуально-психічний потенціал сковано переважно на забезпечення власної вигоди і добробуту. Колег по роботі сприймають, як конкурентів або ворогів, а підлеглих – як засіб боротьби за владу. Серед них виокремлюють два підтипи – «леви» (переможці, які досягли успіху і будують свою імперію) і «лисиці» (влаштувавши свої гнізда в корпоративній організації, продовжують спритно і з вигодою просуватися далі. Але їхні плани можуть розвалитися, наштотхнувшись на протистояння тих, кого вони свого часу обманули або використали).

3. «Люди компанії». Ідентифікують себе з організацією, до якої належать. Усвідомивши свою психологічну слабкість, прагнуть підпорядкувати себе іншим, дбаючи більше про безпеку, ніж про успіхи. Найбільш творчі з них створюють у компанії доброзичливу атмосферу, проте в умовах жорсткої конкуренції неспроможні успішно налагоджувати справи.

4. «Гравці». Розглядають ділове життя та свою роботу як своєрідну гру, люблять ризикувати, але обґрунтовано, схильні до нововведень. Прагнуть не створення власної «імперії», а задоволення від перемоги.

Серед сучасних керівників корпорацій найширше представлений саме останній тип. Керівникам, які посідають найвищі пости, найчастіше притаманні риси «гравців» та «людей компанії».

Психолог Ю. Красовський розглядає принципи класифікації типів керівників як результат професійного емпіричного досвіду керівника. Крім стилів організаційної поведінки, він виокремлює дві групи типів керівників:

1. «Опорні» – співробітники, які становлять ділову основу організації. До них належать типи «творець» і «незамінний», які є ядром організації, забезпечують активність її функціонування.

2. «Ажурні» – «прикраса» організації, створюють фон, однак ніколи не стануть опорою підрозділу або організації. До цієї групи належать поширені стереотипи, що виявляються зі значною мірою стійкості:

- «мораліст». Схильний до розмірковування на моральні теми, любить повчати, вказувати на недоліки тощо;

- «дилетант». Береться за будь-яку справу, незважаючи на відсутність знань, досвіду для їх здійснення;

- «скептик». Його супроводжують недовіра до всього, сумніви у всьому;

- «попелюшка». Це слухняні виконавці, яким нерідко доводиться братися за чорну, невдячну роботу, не претендуючи на відповідне оцінення своїх старань;

- «себелюбець». Наділений загостреним почуттям гонору, дуже активний, намагається демонструвати свої можливості й здібності тощо;

- «діловий». Його характеризують прагматичність, відсутність відчуття перспективи;

– «гравець». Здатний швидко запалюватися у здійсненні справи, але так само швидко і охолоджуватися до неї. Його інтереси і мотиви нестійкі та вибіркові. За жорсткого контролю і відповідальності йому під силу складні завдання, він бере активну участь у життєдіяльності організації;

– «енергійний». Вирізняється надзвичайною активністю;

– «архіваріус». Надзвичайно педантичний і скрупульозний, неухильно виконує інструкції. Охайність і ретельність допомагають виконувати роботу, яка для інших є важкою і нецікавою.

«Ажурні» й «опорні» групи керівників мають спільні характеристики.

В управлінській практиці поширені й такі типи керівників:

– «штабісти». Наділені високою виконавчою дисципліною, самоорганізацією праці, вмінням діяти згідно із законом, функціональним мисленням. Проте вони не схильні до самостійних рішень в екстремальних ситуаціях, ризику, відповідальності тощо;

– «борці за справедливість». Виявляють ініціативу, добропорядність, принциповість, професіоналізм у роботі. Попри певну зовнішню схожість суттєво відрізняються від «скандалістів», у яких завищений рівень домагань за недостатності кваліфікації та здібностей;

– «орачі». Ретельно виконують свої службові обов'язки, кар'єра для них – не самоціль, а моральне заохочення часто важить більше, ніж матеріальне;

– «імітатори». Потрапивши на керівну посаду випадково або завдяки зв'язкам, вони імітують бурхливу діяльність, оточують себе «привілейованими», виявляють надмірну активність. Здебільшого їм не вистачає професійної, ділової компетентності.

Незалежно від домінування ознак, на підставі яких можна зарахувати керівників до певного психологічного типу і які визначають стиль їх роботи, кожен із них повинен бути наділений якостями, без яких неможливо вибудувати стратегію своєї поведінки й управлінську кар'єру.

Висновки. Управлінська діяльність характеризується високою емоціогеністю та стресогеністю, має велику кількість причин для виникнення негативних емоцій і станів, що пов'язано з її відповідальністю, та вимагає від керівника ефективної емоційно-вольової регуляції. Це необхідно не тільки для зменшення негативного впливу

ву на діяльність керівника, а й для унеможливлення цього впливу на підлеглих, які чітко на це реагують та можуть перейняти негативний стан начальника. Психічні стани можуть позитивно впливати на виконувану діяльність, на процес спілкування, а можуть і дезорганізовувати їх. Психічний стан – це своєрідне накопичення психічної енергії. Специфіка психічного стану передусім означає специфіку перебігу психічних процесів. Для стану неуважності часто характерні відхилення у сфері відчуття й сприйняття, пам'яті, мислення, послаблення вольової активності, нерідко специфічні емоційні переживання (сум, роздратування). З позицій функціонування психічний стан особистості виражається в тому, наскільки швидко чи повільно відбуваються в ньому реакції і процеси, як виявляються наявні психічні властивості. Психічний стан – це тимчасовий функціональний рівень психіки, який відображає взаємодію впливу внутрішнього середовища організму або зовнішніх чинників та визначає спрямованість перебігу психічних процесів у цей момент і вияв психічних властивостей людини. Отже, у психічних станах поєднуються, зливаються характеристики психічних процесів і властивостей особистості. Аналіз психічного стану дає змогу прогнозувати поведінку особистості, її розвиток та самозростання. Сучасна епоха суспільного розвитку характеризується кількома важливими особливостями. Це небачений раніше темп розвитку науки і виробництва, що має характер науково-технічної революції, все більш зростаюча роль людини в цьому процесі, як головної продуктивної сили суспільства, все більш високі вимоги, які пред'являються до працівників, до їх професійних і особистісних якостей.

Література.

1. Волошина Н. В., Терлецька Ю. М. Тренінг «фасилітація опору змінам в організації». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2017. Вип. 6 (1). С. 149–153.
2. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
3. Ходаківський Є. І. Психологія управління : підручник / Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 664 с.
4. Прищак М. Д. Психологія управління в організації : навч. посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 141 с.

4.7. Теоретичні аспекти психології управління та менеджменту бізнес-процесами на підприємстві

*Писаренко Н. В., Калінін А.М.,
Бараник З.П., Буткевич О.В., Тітов В.В.*

Актуальність. Уповільнення економічного зростання, що нині характерне для України, спонукає підприємства шукати шляхи суттєвого підвищення ефективності бізнес-процесів на підприємстві. Сучасні умови господарювання диктують нові правила поведінки на ринку, а саме, забезпечення швидкої реакції на постійні політичні виклики, військові загрози, зміни умов макросередовища, орієнтацію на потреби клієнтів, підвищення якості продукції та послуг при зниженні їх собівартості. У свою чергу, це вимагає удосконалення систем управління у менеджменті бізнес-процесами на підприємстві.

Теоретико-методологічна база сучасної психології управління базується на засадах системного та комплексного підходів. Фундаментально розроблені в психологічній науці, вони поширюються й на окремі психологічні галузі, зокрема на психологію управління, психологію особистості, соціальну психологію, а також на менеджмент. При цьому, однією з найбільш відмінних особливостей розвитку сучасної теорії і практики менеджменту є його послідовна психологізація.

Керівництво підприємством, як реалізація основних функцій менеджменту, прийняття рішень та використання методів управління, зв'язку з зовнішнім середовищем, спрямовано на досягнення однієї мети – забезпечення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта. Результати діяльності будь-якого підприємства значною мірою залежать від можливості та спроможності менеджменту приймати адекватні ситуації управлінські рішення.

Аналіз сучасного стану менеджменту з позицій психологічного забезпечення управлінської діяльності дозволяє аргументовано зазначити, що в нашій країні й досі термін «керівник» асоціюється передусім з посадою, а не з професією. При цьому, як правило,

відсутня психологічна управлінська підготовка представників економічних та технічних спеціальностей, які відносно часто стають керівниками. Нерідко з поля зору як психологів, так і керівників організацій випадають питання психологічної діяльності та адаптації менеджерів. Також, відсутні й інші прогалини.

Психологія управління у менеджменті являє собою прогресивну форму управління в нових економічних умовах. При цьому, в рамках панування вольових, переважно командних методів управління виробництвом, запропоновані психологічні знання менеджменту були мало затребувані, за виключенням дуже обмеженого кола прийомів. На сьогодні ж у практиці управління спостерігається підвищений інтерес до різних, особливо психологічних аспектів менеджменту, що видається нам цілком логічним та закономірним.

Стили управління, як соціально-психологічний феномен, активно вивчаються вітчизняними й зарубіжними дослідниками (М. Альберт, Б. Андрушків, К. Боумен, О. Виханський, І. Волков, П. Друкер, О. Кузьмін, К. Левін, М. Мескон, І. Туленков). Психологічний аспект управління бізнес-процесами для реалізації управлінської діяльності, розглядають у своїх працях А. Журавльов, Л. Карамушка, В. Лозниця, Т. Мостенська, О. Пономарьов, О. Романовський, В. Савельєва, Г. Шредер та ін. У сфері управління багато авторів наголошують на необхідності запровадження гуманістичного, людино-центрованого підходів (І. Зязюн, Ю. Конаржевський, Л. Карамушка, В. Кремень, О. Савченко, Т. Шамова, Е. Ямбург та ін.). Ми вважаємо актуальним визначення теоретичних аспектів психології управління та аналіз сучасного менеджменту бізнес-процесами на підприємстві з позицій психологічного забезпечення управлінської діяльності.

Мета. Обґрунтувати теоретичні аспекти психології управління у менеджменті бізнес-процесами на підприємстві.

Результати дослідження. Соціально-економічні та політичні зміни в житті суспільства об'єктивно вимагають від керівників якісно інших знань, навичок та умінь. Останнім часом дефініція «керівник» дедалі частіше замінюється як у побуті, так і у надрукованих результатах наукових досліджень таким поняттям як «менеджер». Вочевидь, на сьогоднішній день однією з головних задач управління є ефективна організація роботи підлеглих. Мистецтво менеджменту

проявляється все частіше у налагодженні комунікацій, координуванні та спрямуванні роботи підлеглих, у вмінні делегувати їм необхідні повноваження, надавати право висловлювати та відстоювати власну думку, зберігаючи за керівником функцію контролю.

Відомо, що до 80 % проблем, що виникають у менеджера в процесі роботи, пов'язані з людьми. Працюючи в колективі, він постійно повинен виконувати функції інформування, мотивування і виховання, що, в свою чергу, вимагає від нього досить глибоких психологічних знань [1].

В даний час психологічні аспекти менеджменту увібрали в себе практично всі сучасні напрямки психології. На етапі її зародження це був перш за все біхевіоризм, пізніше акцент перемістився на досягнення когнітивної та гештальт-психології. Черговий етап генези психології управління припадає на 1950-60-ті рр. в рамках поширення ідей гуманістичної психології [2]. Окремо слід зазначити, що й інші напрями психологічної науки також досить широко представлені в психології управління (наприклад, переважна маса сучасних методів навчання управлінського персоналу базується на необіхевіоризмі).

Менеджмент, за всієї універсальності своїх принципів, є частиною національної культури, а тому бездумне копіювання зарубіжного досвіду є непродуктивним і неефективною тактикою.

Сьогодні можна впевнено говорити про формування та розвиток психологічного етапу менеджменту та про очевидний синтез більшості відомих психологічних ідей у рамках нового наукового напрямку – психології управління. Все більшого значення в управлінській діяльності має категорія «лідер». Коли в управлінні організацією все більший акцент робиться на управління людьми з урахуванням їхньої індивідуальності, проблеми лідера і лідерства, лідера і керівника набувають вирішального значення.

Психологія управління – це галузь психології, що вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності [3].

Управлінська діяльність – вид діяльності, пов'язаної з прийняттям управлінських рішень в організації з управління людьми та з урахуванням властивостей та якостей особистості [4].

Об'єкт вивчення психології управління становлять люди, які знаходяться у фінансових і юридичних відносинах у самостійних організаціях, діяльність яких спрямована на корпоративно корисні цілі.

Характерною особливістю психології управління є те, що її об'єктом виступає організована діяльність людей. Організована діяльність – це не просто сукупна діяльність людей, об'єднаних спільними інтересами чи цілями, симпатіями та цінностями. Передусім, це діяльність людей, об'єднаних в одну організацію, які підпорядковуються правилам і нормам цієї організації та виконують задану їм спільну роботу відповідно до економічних, технологічних, правових, організаційних та корпоративних вимог.

Правила, норми і вимоги підприємства передбачають та порожують такі особливі психологічні відносини між людьми, які існують лише в організації.

Вище зазначені управлінські відносини становлять організовану спільну діяльність, сприяючи її організованості. Іншими словами, це не відносини у зв'язку з діяльністю, а відносини, що створюють спільну діяльність, за умов якої учасники пов'язані друг з одним не просто взаємною залежністю і взаємною відповідальністю, але й відповідальністю перед законом.

Можливі різні інші відносини між людьми, наприклад, соціально-психологічні відносини [4]. Останні виступають як взаємовідносини людей, опосередковані цілями, задачами та цінностями спільної діяльності, тобто її реальним змістом. Таким чином, психологія управління як окрема галузь психологічної науки, що знаходиться в процесі свого розвитку, продукує психологічні знання, що застосовуються при вирішенні проблеми управління діяльністю трудового колективу.

Підходи до розуміння предмета психології управління різноманітні, що певною мірою свідчить про його складність [1-5]. В даному світлі виділяють різні аспекти предмета психології управління: питання управління виробничими групами та колективами; психологічний аналіз виробничих та управлінських колективів та взаємовідносин людей у них; психологія особистості працівника як об'єкта управління; психологія діяльності та особистості керівника, психологічні проблеми лідерства; функціонально-структурний аналіз управлінської діяльності; психологічні особливості

прийняття індивідуальних та групових рішень; психологічні проблеми взаємовідносин між керівником та підлеглими тощо.

Резюмуючи зазначене, можна дійти висновку, що предмет психології управління – це сукупність психічних явищ і відносин, які віддзеркалюють спільну роботу людей в організації відповідно до економічних, технологічних, соціально-психологічних, правових, організаційних та корпоративних вимог.

При цьому, в рамках предмету психології управління традиційно виділяють чотири основні області [6]:

- 1) психологічні закономірності управлінської діяльності;
- 2) психологічні закономірності діяльності суб'єкта управління – керівника;
- 3) психологічні закономірності підсистеми, якою управляють, та її суб'єктів (підлеглих).
- 4) основні особливості взаємодії керівника із підлеглими.

Психологія управління тісно пов'язана з іншими науками. До них відносяться, зокрема, теорія управління, теорія систем, менеджмент, економіка та інші, а також деякі галузі психологічної науки. До останніх слід віднести психологію особистості, соціальну психологію, психологію праці, загальну психологію та деякі інші. При цьому, психологія управління має свої особливості та відмінності.

Для глибшого розуміння предмету нашого дослідження необхідно розглянути семантику змістів понять «управління», «менеджмент» та «психологія управління».

Співвідношення українського терміну «управління» і англійського «management» доцільно розглянути крізь призму англійських понять-еквівалентів, що позначають управління в системах різного класу [7].

Так, для позначення керування в технічних системах в англійській мові використовується дефініція «control» (або «drive» – при керуванні автомобілем); для позначення управління в організаціях (на підприємствах, фірмах) – термін «management»; управління державою чи регіоном – слово «government»; процесу управління людиною собою – термін «govern» [8].

Таким чином, дефініції «управління» та запозичене з англійської мови «менеджмент» є синонімами тоді, коли мова йде про

управління організацією. Саме в такому значенні ці терміни вживатимуться в нашому дослідженні.

При цьому, під організацією (підприємством, фірмою, установою тощо) розуміється об'єднання двох осіб або більшої кількості людей, які взаємодіють один з одним для досягнення певної мети.

Також, слід згадати ще одне англійське слово, *administration*, яке перекладається як «управління». Воно використовується у випадку позначення формальних, єдиних для всіх членів організації правил поведінки і взаємодії під час виконання ними своєї роботи без врахування індивідуальностей співробітників. В силу зазначеного, зміст адміністрування розкривається не через ставлення до працівника як до індивідуальності, а як до елемента трудових ресурсів (людей), необхідних для досягнення поставлених перед організацією цілей. Менеджмент же, навпаки, передбачає врахування індивідуальних особливостей працівників.

У соціальній психології окремий працівник виступає як частина, як елемент цілого, соціальної групи, поза якою його поведінка не може бути зрозумілою [9].

В психології управління і окремий працівник, і соціальна група, і колектив виступають у контексті підприємства, до якої вони входять і без якої їх аналіз у світлі управління виявляється неповним.

Вивчення особистості працівника на підприємстві, аналіз впливу організації на соціально-психологічну структуру та розвиток колективу є основними предметними проблемами досліджень у психології управління [10].

Також, в психології управління, на відміну від психології праці, актуальні не проблеми відповідності працівника його професії, професійного відбору та професійної орієнтації, а проблеми відповідності працівника вимогам підприємства, відбору людей до організації та їх орієнтації щодо особливостей цієї організації. У психології управління, на відміну соціальної психології, об'єктом вивчення стають не просто відносини людей колективі чи соціальної групі, а відносини людей організації, т. е. за умов, коли дії кожного учасника спільної діяльності задані, приписані, підпорядковані загальному порядку робіт.

Таким чином, маючи свій об'єкт і предмет вивчення, психологія управління тісно пов'язана з різними науками, насамперед

із психологічними, розділяючи з ними спільну методологію та зберігаючи особливості й відмінності.

Управління здійснюється через взаємодію людей. Тому керівнику в своїй діяльності необхідно враховувати закони динаміки психологічних процесів, міжособистісних відносин та групової поведінки [3].

До основних закономірностей відносяться:

1. *Закон невизначеності відгуку* (альтернативна назва – закон сприйняття людьми зовнішніх впливів внаслідок розходження їх психологічних структур). Даний закон встановлює, що різні люди (і навіть одна людина) в різні часи можуть по-різному реагувати на однакові впливи. Це призводить до нерозуміння потреб, очікувань, особливостей сприйняття індивіда в тій чи іншій конкретній діловій ситуації. Як результат, використовуються моделі взаємодії, неадекватні особливостям психологічних структур в цілому та психологічному стану кожного із партнерів із взаємодії у конкретний момент зокрема.

2. *Закон неадекватності відображення людини людиною* полягає в тому, що жодна людина не може досягнути іншої з таким ступенем достовірності, яка була б достатньою для прийняття серйозних рішень щодо цієї людини. Цей закон враховує безперервну мінливість природи та сутності людини відповідно до вікової асинхронності. Будь-яка людина певного календарного віку в різні моменти життя може перебувати на різних рівнях фізіологічного, інтелектуального, емоційного, соціального та мотиваційно-вольового рішення. Крім того, усвідомлено чи інтуїтивно людина намагається захиститися від спроб зрозуміти її особливості, щоб уникнути небезпеки потрапити під вплив людини, схильної до маніпулювання. В результаті, користуючись різними психологічними захисними прийомами, людина демонструє себе людям такою, якою б вона хотіла, щоб її бачили інші.

3. *Закон неадекватності самооцінки* враховує, що психіка людини є органічною єдністю двох складових – усвідомленого (логічно-мислительного) і неусвідомленого (емоційно-чуттєвого, інтуїтивного), які, виражаючись метафорично, являють собою надводну (видиму) і підводну (приховану) частини айсберга.

4. *Закон розщеплення сенсу управлінської інформації* стверджує об'єктивну тенденцію до зміни змісту директивної та іншої

інформації в процесі її руху ієрархічними сходами управління. Це пояснюється як алегоричними можливостями «канцелярської» мови інформації, що веде до виникнення відмінностей у її тлумаченні, так і відмінностями в освіті, інтелектуальному розвитку, психічному стані учасників передачі та аналізу інформації. Зміна змісту інформації прямо пропорційна протяжності (числу учасників) інформаційного каналу.

5. *Закон самозбереження* встановлює, що провідним мотивом соціальної поведінки особистості в управлінській діяльності є збереження її особистого соціального статусу, її особистої спроможності, почуття власної гідності.

6. *Закон компенсації* говорить, що при високому рівні стимуляції до праці та високих вимог організаційного оточення до людини, нестача будь-яких здібностей для успішної конкретної діяльності відшкодовується іншими здібностями чи навичками. Такий компенсаторний механізм найчастіше функціонує несвідомо, людина набуває свого особистого досвіду під час спроб і помилок. Однак, слід мати на увазі, що при досить високому рівні складності управлінської діяльності цей закон практично не застосовується.

Відомий і ряд інших закономірностей (наприклад, закон Паркінсона, принципи Пітера, закони Мерфі та деякі інші), що розширюють та доповнюють викладені закони. Наприклад, чотири головні теорії особистості, що широко використовуються в психології управління [5, 6, 7]: теорія відносин (А. Ф. Лазурський, В. М. Мясіщев), теорія діяльності (Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв), теорія спілкування (Б. Ф. Ломов, А. А. Бодальов, К. А. Абульханова-Славська), теорія установки (Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангішвілі).

Управління є невід'ємною частиною будь-якої колективної діяльності у будь-який історичний період розвитку суспільства. Так, у первісному людському стаді був ватажок, у племені – вождь, в общині – рада старійшин. З розвитком суспільства ускладнювалася й управлінська діяльність, але усвідомлення того факту, що управління є особливим видом людської діяльності, відбулося лише у XIX – на початку XX ст. [1, 3].

У науці управління основним фундаментальним поняттям є власне категорія «управління». Останнє можна розглядати у вузькому та широкому сенсах.

У вузькому значенні – це процес впливу суб'єкта управління на об'єкт, що змушує останній здійснювати певні дії, спрямовані на досягнення цілей суб'єкта. В окремих (ідеальних) випадках цілі суб'єкта та об'єкта можуть збігатися.

У широкому значенні управління включає не тільки сам вплив, а й підготовку до нього, контроль за діяльністю об'єкта управління та аналіз отриманих результатів. У цьому випадку управління є безперервним процесом, який починається зі встановлення зв'язків між суб'єктом і об'єктом та закінчується з припиненням взаємодії між ними.

При аналізі процесу управління з будь-якої точки зору слід на увазі, що він носить циклічний, спіралеподібний характер. Процес управління починається з моменту встановлення взаємозв'язків між суб'єктом і об'єктом управління і закінчується тільки зі зникненням цих взаємозв'язків.

Технологія процесу управління являє собою порядок взаємодії працівників апарату управління, інформації та технічних засобів управління при виконанні будь-якої управлінської діяльності.

Саме за допомогою технології кожен із етапів процесу управління може бути розчленований на різні операції та процедури.

Операція є первинним (чи мінімальним) елементом процесу управління. Під операцією розуміється закінчена дія, виконувана вручну чи з допомогою технічних засобів та спрямована на досягнення поставленої мети.

Останнім часом виділяють три основні види поєднання операцій:

- 1) послідовне поєднання операцій, коли кожна наступна починається тільки після завершення попередньої (наприклад, передача будь-якого розпорядження з вищого рівня управління на нижчий);
- 2) паралельне поєднання операцій, коли різні операції можуть виконуватися одночасно декількома виконавцями (наприклад, складання балансового звіту підприємства);
- 3) паралельно-послідовне поєднання операцій, що передбачає часткове їх поєднання у часі та просторі (наприклад, розробка бізнес-плану підприємства).

Сукупність (або група) логічно взаємопов'язаних та таких, що призводять до вирішення будь-якої задачі операцій є процедурою.

Процедури бувають як формальними, тобто закріпленими у будь-яких нормативних актах, так і неформальними. Прикладом формальної процедури може бути прийом на роботу нового співробітника, неформальної процедури – проведення переговорів з бізнес-партнерами.

Класифікувати операції та процедури можна за різними критеріями [10]: поділ на повторювані (постійно виконуються працівниками апарату управління та піддаються виміру, аналізу, нормуванню і проектуванню) та неповторні (характерні для творчих процесів в управлінні); за рівнем автоматизації – ручні, автоматизовані та автоматичні операції та процедури; за змістом управлінськи операції та процедури поділяються на інформаційні (пов'язані з обробкою, передачею та збереженням будь-якої інформації), логіко-мислиневі (пов'язані з виробленням та прийняттям управлінських рішень), організаційні (пов'язані з кадровою роботою, постановкою завдань перед виконавцями та адміністрацією).

Будь-яке підприємство функціонує у зовнішньому середовищі, яке можна поділити на економічне, технологічне, соціальне, політичне та етичне.

Економічне зовнішнє середовище включає: наявність потенційних покупців та їх потреб; сформований рівень ціни продукцію підприємства; можливість отримання інвестицій; наявність робочої сили необхідної кваліфікації та продуктивності у тому регіоні, де знаходиться підприємство; урядову фінансову та податкову політику; поведінка конкурентів.

Технологічне зовнішнє середовище являє собою існуючі в суспільстві знання щодо виробів, їх дизайну та технології виготовлення. При цьому, під виробами розуміються в тому числі й інформація та послуги. Значення цього середовища величезне не тільки при виготовленні виробів, а й при різних управлінських інноваціях (нововведеннях).

Політичне зовнішнє середовище включає:

- існуючу зовнішньо- та внутрішньополітичну ситуацію в тих державах, на території яких підприємство виробляє та реалізує свою продукцію;

- законодавство цих країн, що дозволяє або забороняє певні види виробництва та реалізацію певних видів товарів.

Соціальне зовнішнє середовище включає: розвиненість соціальної інфраструктури у тих регіонах, де підприємство працює та збуває свою продукцію; панівні звичаї та вірування цих регіонів; рівень освіти населення.

Етичне зовнішнє середовище включає норми особистісної та міжособистісної поведінки людей в таких регіонах.

Цілі підприємства. Основною сполучною ланкою підприємства із зовнішнім середовищем є його цілі, які об'єктивно розділяються на дві групи [10]: першу – цілі, досягнення яких дозволяє змінити зовнішнє середовище (зовнішні); другу – цілі, досягнення яких дозволяє розвиватися самому підприємству, а досягнення тих та інших цілей взаємопов'язане (неможливо намагатися досягти будь-якої внутрішньої мети без досягнення зовнішньої та навпаки).

Ілюстрацією зазначеного може служити наступний приклад. Випускаючи та продаючи якісні парфумерні вироби, підприємство не тільки отримує прибуток, що дозволяє розширювати виробництво, створювати нові робочі місця та підвищувати життєвий рівень своїх працівників, а й змінює етичне, соціальне та зрештою й економічне зовнішнє середовище. Необхідність оновлювати асортимент своєї продукції призводить до змін у технологічному середовищі, а необхідність використання у виробництві різних компонентів, що виготовляються за кордоном, змушує впливати на політичне зовнішнє середовище. І навпаки, зміна зовнішньополітичної ситуації може негативно чи позитивно вплинути на прибутки підприємства за рахунок звуження або розширення ринків збуту.

Серед різноманіття зовнішніх цілей закономірно виділяється одна, головна, яка залишається незмінною протягом усього часу існування підприємства і яку доцільно назвати його місією. Під місією підприємства розуміється загальна, глобальна мета, що визначає зміст існування підприємства.

Основною внутрішньою метою підприємства є отримання прибутку за рахунок задоволення потреб в умовах конкуренції. Вона існує в двох основних видах – ціновій та якості продукції.

Крім місії підприємства та отримання прибутку виділяють стратегічні, тактичні та оперативні цілі підприємства. Слід мати на увазі, що досягнення будь-якої тактичної мети може сприяти

досягненню кількох стратегічних цілей, що справедливо й у відношенні тактичних та оперативних цілей.

Стратегічна мета за своєю суттю є обґрунтованим уявленням про майбутнє підприємства в цілому або у будь-якому виді його діяльності. Майбутнє тут видається як п'ятирічний, іноді десятирічний період. Прикладами стратегічних цілей може бути проникнення на будь-якої ринок; розширення частки традиційного ринку; відхід з будь-якого ринку з економічних чи етичних причин; освоєння та випуск принципово нового для підприємства виробу; зростання статутного фонду підприємства на певну величину до певної дати.

При розгляді стратегічних і тактичних цілей слід враховувати їх динамічний характер. Він проявляється в тому, що з часом у підприємства формуються нові стратегічні цілі, а старі, в міру їх досягнення, переходять у розряд тактичних, а потім і оперативних. Зі стратегічної мети формується стратегія, тобто уявлення про те, що необхідно змінити для підприємства задля досягнення головної (стратегічної) мети.

У сучасному менеджменті виділяють чотири види стратегій: зростання, обмеженого зростання, скорочення, диверсифікації [7, 11].

Стратегія зростання являє собою прагнення постійного та значного збільшення значень показників, що відображають рівень розвитку підприємства. Така стратегія може застосовуватися в тому випадку коли підприємство працює в галузі, що швидко розвивається та здатне запропонувати споживачам принципово новий виріб. При виборі даної стратегії слід мати на увазі, що швидке короткострокове зростання вимагає потім постійних зусиль і вкладення коштів для підтримки завойованих позицій. Якщо підприємство не має таких коштів, то «короткострокове зростання може змінитися довгостроковим руйнуванням».

Стратегія обмеженого зростання є постійним незначним збільшенням показників діяльності підприємства, що дозволяє йому зберегти свої позиції на існуючих ринках збуту. Цієї стратегії дотримується більшість підприємств, задоволених своїм становищем та працюючих у стабільних галузях. Вона є найлегшим і зручним способом досягнення цілей та найменш ризикованим видом діяльності.

Вибір *стратегії скорочення* означає, що підприємство у своїх цілях встановлює показники свого розвитку нижчі за існуючі. У рамках цієї стратегії можливі два варіанти [7]:

- виключення всього зайвого, коли підприємство припиняє свою діяльність у будь-яких сферах, вважаючи їх малоприбутковими;
- ліквідація, що являє собою розпродаж активів підприємства через несплату заборгованості або виникнення більш прибуткових сфер діяльності.

Диверсифікація по суті є змішанням стратегій, за умов якої згортання активності у галузі супроводжується зростанням чи обмеженим зростанням у іншій.

Висновки. Основою, яка забезпечить функціонування ефективних бізнес-процесів на підприємстві є механізм господарювання, орієнтований на процесне управління, яке передбачає чітку формалізацію, структурованість бізнес-процесів, їх удосконалення й високий рівень автоматизації, та ґрунтується на застосуванні інформаційних технологій, економіко-математичних методів і моделей. Отже, питання розроблення теоретико-методичних положень і практичних засад моделювання управління бізнес-процесами актуальні для підприємств України, що зумовлено проблемністю впровадження процесного підходу до управління господарюючими суб'єктами та застосування інструментарію моделювання, аналізу й удосконалення бізнес-процесів на підприємстві. Таким чином, управління виражається у формі організації управління, яка складається з організаційної структури управління, управлінського персоналу та забезпечуючих підсистем (інформаційної, технічної, математичної). Оскільки система управління є складною, необхідно вивчати її динаміку, яка виражається в процесах управління, прийняття управлінських рішень та управлінських інноваціях.

Література.

1. Нечепуренко А. І. Роль соціально-психологічних методів у розвитку менеджменту. Економіка управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2012. № 1(17). С. 68.
2. Петюх В. М. Управління персоналом : навч. -метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. К. : КНЕУ, 2014. 330 с.
3. Кайлюк Є. М., Фесенко Г. Г. Психологія управління: навч. посіб. Х. ХНАМГ, 2012. 202 с.
4. Церковна А. В., Харламова В. В. Використання соціально-психологічних методів управління персоналом. Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління. 2019. Том 16. Вип. 3 (37). <http://rinek.onu.edu.ua/article/download/123720/118326> (дата звернення: 23. 11. 2023).

5. Ceptureanu E. G., Ceptureanu S. I. 2019. The impact of adoptive management innovations on medium-sized enterprises from a dynamic capability perspective. *Technology Analysis & Strategic Management*. 2019. Vol. 31 (10). P. 1137–1151.

6. Khosravi P., Newton C., Rezvani A. 2019. Management innovation: A systematic review and metaanalysis of past decades of research. *European Management Journal*. 2019. Vol. 37 (6). P. 694–707.

7. Zhang Y., Khan U. The influence of management innovation and technological innovation on organization performance. A mediating role of sustainability. *Sustainability*. 2019. Vol. 11 (2). P. 495.

8. Довгань Л. Є. Креативний менеджмент. К. : НТУУ «КПІ», 2014. 248 с.

9. Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту. *Наук. вісник НЛТУ України*. 2011. Вип. 21. 7. С. 360–364.

10. Васильєв О. Л. Теоретичні підходи до формування ефективних управлінських рішень як фактора розвитку підприємства. *Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту*, 2013. – Вип. 140. – С. 129–133.

11. Костюченко О. В. Творчі складові прийняття управлінських рішень у системі креативного менеджменту. *Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України*. Київ, 2018. С. 110–119.

4.8. Емоційне вигорання керівника в сфері охорони здоров'я

Скида І. О.

Актуальність За останні роки в умовах постійного реформування системи охорони здоров'я, пандемії COVID, міграції кваліфікованих спеціалістів за кордон, війни росії проти України, тощо на лікарів керівних посад було покладено значно більше задач на фоні зменшення інформаційних, кадрових та фінансових ресурсів на їх виконання. Не зважаючи на це медичні працівники продовжують виконувати свої обов'язки, що все частіше призводить до збільшення випадків емоційного вигорання серед медичних працівників зокрема керівних посад. Проблему емоційного вигорання активно вивчали різні науковців, серед них такі вчені, як Р. Лазарус, П. Бріл, Г. Сельє, М. Буриш, Н. Водоп'янова, Р. Голембієвський, К. Кондо, Р. Лазарус, К. Маслач, С. Мейєр, Н. Ноур, В. Слабінський, А. Рукавішников та інші. Проблема емоційного вигорання розглядалась тривалий час в різних галузях психології, однак на сьогодні ще залишається повністю не розкритою. Не існує єдиного погляду на причини, структуру, тривалість та динаміку синдрому емоційного вигорання. Термін «професійне вигорання» ще в 1974 році вперше використав американський вчений Дж. Фрейденберг для характеристики психологічного стану у здорових людей – фахівців, які інтенсивно і тісно спілкуються з клієнтами, пацієнтами та перебувають в емоційно насиченій атмосфері під час надання професійної допомоги [1, 5].

Згідно з визначенням ВООЗ (2001), «синдром вигорання (burnout syndrome) – це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, що характеризується порушенням продуктивності в роботі та втому, безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин з метою одержати тимчасове полегшення, що має тенденцію до розвитку фізіологічної залежності (у багатьох випад-

ках) та суїцидальної поведінки. У більш вузькому розумінні термін професійне вигорання розглядається як емоційне виснаження, виникнення і розвиток якого зумовлюється впливом професійних стрес-факторів. Виділяють такі групи чинників професійного вигорання: 1) організаційні – безпосередньо пов’язані з управлінням і умовами роботи; 2) діяльнісні – пов’язані зі змістом та характером діяльності; 3) особистісні – пов’язані з мотиваційними та індивідуально-психологічними особливостями фахівця.

Мета. Розкрити особливості синдрому емоційного вигорання людини керівної посади в сфері охорони здоров’я в сучасних умовах життя.

Результати дослідження. Сьогодні для визначення типу професійних деформацій використовують поняття «професійний стрес», «емоційне вигорання», «професійне вигорання», але вони не завжди виступають як синоніми. Дискусійним залишається питання співвідношення таких понять як «стрес» і «вигорання». Науковець Р. Лазарус розглядав стресову ситуацію як результат відмінностей між вимогами, що висуває середовище, та ресурсами, якими володіє індивід. Г. Сельє активно займався дослідженням проблеми стресу у професійній діяльності, описав три послідовні стадії адаптаційного синдрому. К. Масlach описує явище вигорання як феномен, що впливає на професійну ідентифікацію та поведінку працівників, який супроводжує втрата інтересу до роботи і прояви негуманного ставлення до клієнтів або інших осіб та складається з емоційного виснаження, деперсоналізації і редукції професійних досягнень. А. Пайнс та Е. Аронсон визначали вигорання як стан фізичного, емоційного і психічного виснаження, що спричинений тривалим перебуванням в емоційно нестабільних ситуаціях. Науковець Д. Грінберг вважає, що професійне вигорання характеризується несприятливою реакцією особистості на стрес, який отриманий у процесі здійснення професійної діяльності, що містить поведінкові та психофізіологічні компоненти. Низка науковців дотримуються думки, що прояви емоційного вигорання є невіддільним атрибутом емоційного захисту особистості.

Тривалий робочий стрес призводить до падіння адаптаційних можливостей, і врешті-решт людина стає виснаженою, нездатною виконувати будь-яке зі своїх повсякденних завдань, розчарованою

у собі та своєму робочому оточенні, що зрештою призводить до ізоляції та, можливо, звільнення з посади [4].

Професійне вигорання керівників розглядається як емоційне, розумове та фізичне виснаження через довготривале залучення до некерованої стресової ситуації в процесі емоційно насичених контактів у професійній діяльності.

На даний час не існує жодного єдиного пояснення причин та наслідків емоційного вигорання. Можна лише припустити, що виникнення даного синдрому є результатом наявності певних індивідуально-психологічних особливостей людини та впливу на неї факторів, пов'язаних із характером її діяльності.

Надзвичайна різноманітність та складність психічних станів у людей з синдромом емоційного вигорання потребує їх певної систематизації та класифікації. Вивчення даної проблеми показало відсутність єдиної системи класифікації психічних станів як проявів емоційного вигорання, недостатньо вивчена проблема емоційного вигорання у лікарів та їх керівників. На сьогоднішній день рівень навантаження на медичних працівників, зокрема керівних посад, прогресивно зростає. Вони все частіше потрапляють в стресові ситуації, страждають на депресії, це призводить до втрати здоров'я та працездатності.

Небезпека синдрому емоційного вигорання полягає в тому, що він складний в діагностиці, так як багато його симптомів, схожі з іншими психофізіологічними захворюваннями, наприклад працеголізмом, а також має властивість поширюватися серед колективу і передаватися від одного працівника до іншого. Складність вивчення емоційного вигорання у керівників полягає у запереченні та небажанні самоусвідомлення розвитку даного стану. Найбільш різко проблема стоїть серед керівників в сфері охорони здоров'я [8].

Емоційне вигорання розвивається поступово, часом непомітно для самої людини та оточуючих. Так надмірні позитивні емоції від отримання довготривало очікуваної посади можуть бути не лише проявами досягнення поставленої мети, а також свідчити про першу стадію розвитку синдрому емоційного вигорання. Згодом радість та ентузіазм зміняться постійною втомою, виснаженням та навіть втрати працездатності. Ці процеси свого часу описав Дж. Грінберга виділив п'ять стадій:

I стадія («медовий місяць») – працівник задоволений своєю роботою і завданнями, ставиться до них з ентузіазмом.

II стадія («нестача палива») – з'являється втома, апатія, можуть виникати проблеми зі сном. За умов відсутності додаткової мотивації та стимулювання у працівника втрачається інтерес до роботи і знижується продуктивність діяльності.

III стадія (хронічні симптоми) – надмірна робота без відпочинку, особливо у трудового лікаря, приводить до виснаження і схильності до захворювань, а також психологічних переживань – хронічної втоми, загостреного почуття злості чи пригніченості, відчуття загнаності в кут.

IV стадія (криза) – розвиваються хронічні захворювання, в результаті чого людина повністю або частково втрачає працездатність.

V стадія («пробивання стіни») – фізичні та психологічні проблеми переходять в гостру форму і можуть спровокувати розвиток небезпечних захворювань, які загрожують життю людини. Унаслідок цих проблем під загрозою часто знаходиться кар'єра людини [2,6].

Розвиток в часі коливає від коротких термінів до декількох років, в залежності від сфери діяльності, темпераменту людини та особистих рис характеру. К. Маслач, В. В. Бойко, Н. Є. Водоп'янова описують тривалий період формування синдрому: I стадія – 3–5 років; II стадія – 5–15 років; III стадія від 10 до 20 років [3].

Виділяють п'ять ключових груп симптомів, характерних для синдрому вигорання [7]:

1. Фізичні симптоми: фізична втома що виникає вранці після сну; зменшена або збільшена вага; слабкість; астенія; змінення гормонального фону; порушення сну; часті безпричинні головні болі; постійні розлади шлунково-кишкового тракту; задишка; надмірна пітливість, тремор; виразки шкіри, абсцеси; підвищений артеріального тиску; загострення серцево-судинних захворювань.

2. Соціально-психологічні симптоми: втрата зацікавленості, байдужість, депресія; підвищена дратівливість, спалахи невмотивованого гніву; підвищена тривожність; гіпервідповідальність на фоні втрати віри в професійний успіх, досягнення мети.

3. Поведінкові симптоми: усамотнення, відчуження від оточуючих; присвячення всього часу (робочого та навіть удома) роботі, яка не приносить результатів, так як втрачається увага, організо-

ваність та пріоритетність завдань, відбувається зосередження на неважливих дрібних деталях. Це призводить до втрати віри та ентузіазму до роботи, байдужості до результатів, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів.

4. Когнітивні симптоми: зниження інтересу до життя, хоббі, самоосвіти, тощо; в роботі та побуті превалюють рутинні справи; людина стає байдужою та цинічною.

5. Соціальні симптоми: низька соціальна активність; зниження інтересу до дозвілля, захоплень; соціальні контакти обмежуються лише роботою; почуття ізоляції від суспільства, відчуття нерозуміння та підтримки з боку сім'ї, друзів, колег.

На сьогодні досконало не систематизовано психічні стани в залежності від стадії процесу. Психічні стани – це цілісні характеристики психічної діяльності за певний період часу. Змінюючись, вони супроводжують людину протягом життя в її відносинах з людьми, суспільством, колегами тощо. В будь-якому психічному стані можна виділити три загальні виміри: мотиваційно-спонукальний, емоційно-оцінний і активаційно-енергетичний. Розрізняють позитивні, негативні та специфічні психічні стани. Також психічні стани розрізняють за глибиною і тривалістю. Виділяють стани миттєві (нестійкі), довготривалі та хронічні, або оперативні, поточні та перманентні. Кожний стан за певних умов може бути і оперативним (нестійким), і поточним (тривалим), і перманентним (хронічним). Перехід станів із поточних у перманентні може бути і позитивом, і негативом. Для емоційного вигорання притаманні негативні психічні стани такі як психічне напруження, стрес, неспокій, тривога, фрустрація, ригідність, редукція особистих досягнень, деперсоналізація, байдужість, нудьга та багато інших, які характеризують стадію емоційного вигорання. Психічні стани, що є складовими емоційного вигорання не можуть позитивно впливати на трудову діяльність та процес спілкування з колегами, підлеглими, лише дезорганізують їх. Кожний психічний стан є переживанням суб'єкта та водночас діяльністю його різних систем, він має зовнішнє вираження і виявляється у зміні ефективності діяльності, яка виконується. Тільки за сукупністю показників та симптомів можна зробити висновок про наявність у людини того чи іншого стану. Ні поведінка, ні різні психофізіологічні показни-

ки, взяті окремо, не можуть достовірно диференціювати один стан від іншого. Провідне місце в діагностиці станів належить переживанням, пов'язаним зі ставленням особистості.

В динамічній моделі Б. Перлман і Е. Хартман представлено лише основні стани що включені в чотири стадії професійного вигорання: перша стадія – напруженість, пов'язана з додатковими зусиллями по адаптації до ситуаційних робочих вимог, які створюють протиріччя між суб'єктом і робочим оточенням, що запускає процес емоційного вигорання; друга стадія супроводжується сильними відчуттями і переживаннями стресу. Багато стресогенних ситуацій можуть не викликати відповідних переживань, оскільки відбувається конструктивне оцінювання своїх можливостей і усвідомлюваних вимог робочої ситуації. Рух від першої стадії вигорання до другої залежить від ресурсів особистості і від статусно-рольових і організаційних змінних; третя стадія супроводжується реакціями основних трьох класів (фізіологічні, афективно-когнітивні, поведінкові) в індивідуальних варіаціях; четверта стадія являє собою емоційне вигорання як багатогранне переживання хронічного психологічного стресу, або дистресу [9]. Наслідками професійного вигорання керівника, як правило, є: зниження самооцінки, управлінці відчують безпорадність і апатію, які з часом можуть перейти у агресію і відчай; самотність, що не дозволяє встановити оптимальні контакти в системі «керівник – підлеглий»; переважають об'єкт – об'єктні стосунки; емоційне виснаження. Втома, апатія і депресія, які супроводжують емоційне вигорання, призводять до погіршення здоров'я, розладів травлення, підвищення артеріального тиску, загострення хронічних захворювань, синдрому хронічної втоми.

Висновки. Не зважаючи на багаторічне вивчення проблеми вигорання відмічається прогресивний ріст кількості випадків емоційного вигорання серед керівників різних галузей, зокрема в медичній галузі, що можна розглядати як результат відсутності єдиного погляду на елементи та прояви емоційного вигорання залежно від стадії перебігу процесу, недосконалої систематизація окремих його компонентів (фізичних симптомів, психічних станів), ігнорування залежності від індивідуально-психологічних особливостей людини та її соціуму, статі та віку в якому отримано керуючу посаду, не

вивчена профілактика та шляхи подолання емоційного вигорання на більш ранніх стадіях – що є суттєвою проблемою сьогодення.

Література.

1. Гнускіна Г. В. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Г. В. Гнускіна, Л. М. Карамушка // Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К., 2013. – Т. 1. – Ч. 35. – С. 107–111.
2. Колоскова О. К. Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів / О. К. Колоскова, М. І. Поліщук, Т. М. Воротняк ; Буковинський державний медичний університет // Здоров'я дитини. – 2012. – №7 (42). – С. 19–22.
3. О. Льошенко, В. Кондратьєва/Діагностика, профілактика, корекція синдрому «емоційного вигорання»// Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 10. С. 105–112.
4. Edelwich, J. and Brodsky, A. (1980) *Burn-Out: Stages of Disillusionment in the Helping Professions*. Human Services Press, New York.
5. Freudenberger H. J. Staff burn-out / H. J. Freudenberger // *Journal of Social Issues*. – 1974. – 30. – P. 159–166.
6. Holloway, F. Support systems. 1. Introduction / F. Holloway, G. Szmukler, J. Carson // *Advances in Psychiatric Treatment*. – 2000. – Vol. 6. – P. 226–235.
7. Kelley, K. Chronic self-destructiveness: Conceptualization, measurement, and initial validation of the construct / K. Kelley, D. Byrne, D. P. J. Przybyla et al. // *Motiv Emot* (1985) 9, Issue 2: P. 135–151.
8. Konstantinos G. Seretis/Occupational Diseases and Environmental Medicine/A Population-Based Study among Health Professionals Working in Hellenic Red Cross Hospital// Vol. 11 No. 4, November 2023
9. Permian B. Burnout: Summary and Future and Research / B. Perlman, E. Hartman. *Human relations*. – 1992. – V. 35 (4). – P. 16–20.

4.9. Соціально-психологічні чинники виникнення професійного вигорання державних службовців

Томашевська К. А.

Актуальність. Важливість управління персоналом у державному секторі зростає, оскільки ці установи стикаються з вимогами покращити якість послуг, що надаються в умовах дефіциту та скорочення ресурсів. Сьогодні українські державні організації страждають від відсутності ефективних інструментів управління, централізованого прийняття рішень з невеликими можливостями для місцевих управлінь, а нестабільність робочого середовища та умов праці відіграють роль передвісника професійного вигорання.

Водночас від професійної діяльності державних службовців залежить не лише формування довіри громадян до державних інституцій, а й якісно новий рівень відповідальності держави перед громадянами у реалізації їхніх прав, свобод і законних інтересів. Обставини вимагають, щоб на всіх рівнях державного апарату були високопрофесійні, креативні та енергійні люди, здатні очолити складні трансформаційні процеси та внести зміни у пріоритетні напрямки розвитку спроможності державних інституцій. Крім того, загальні вимоги до державних службовців включають необхідність підтримувати високі стандарти контакту із заявником, і обов'язково контролювати свою поведінку, виконувати свої обов'язки в ієрархічному робочому середовищі, що потенційно підвищує ризик серйозних негативних наслідків, які виникають у разі вчинення помилки.

Протягом тривалого часу дослідники державного управління стверджували, що державним службовцям для успішного управління та підвищення продуктивності урядових установ потрібно проявляти неабиякий рівень толерантності та взаєморозуміння на робочих місцях. Однак вони не помітили той факт, що саме ті державні службовці, які неухильно дотримуються цих принципів у роботі, зазнають серйозних фізичних і психологічних ушкоджень через надмірність цих якостей в обслуговуванні людей, адже дослі-

дження державного управління здебільшого зосереджені на допомозі державним службовцям ефективно виконувати свої завдання та розбудові систем боротьби з корупцією, вони часто не враховують стан працівників, які відчують емоційну втому та виснаження саме через те, що віддані своїй роботі.

Мета. Теоретичний огляд соціально-психологічних чинників виникнення емоційного вигорання державних службовців.

Результати дослідження. Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що професійне вигорання є складним багатокomпонентним феноменом і на сьогодні не існує однозначного розуміння його сутності, вчені досі не мають єдиного погляду на психологічну структуру вигорання. Розуміння сутності професійного вигорання, його структури та стадій на теоретичному рівні є досить суперечливим. Це пов'язано з різним підходом до їх опису.

Сьогодні у вітчизняній та зарубіжній літературі застосовують різні варіанти перекладу англійського терміну «вигорання», що в свою чергу спричинило розвиток найрізноманітніших теорій. Перші ґрунтовні дослідження на цю тему з'являються ще в 1970-х роках і базувалися вони на досвіді працівників, чийм завданням була турбота про людей і задоволення їхніх потреб, таких як працівники сфери навчання та охорони здоров'я (Р. Лазарус, Р. Розенман, М. Фрідман, Г. Сельє, Г. Дж. Фройденбергера, К. Маслач та інші). Ці дослідження були зосереджені на площині постачальник-одержувач. Згодом почали проводитися дослідження в організаціях з ієрархіями, функціями, ролями, ресурсами та міжособистісними стосунками (колеги, начальники, громадськість), де враховувався і контекст, у якому здійснювалася діяльність (К. Маслач, С. Джексон, М. Лейтер, Е. Іванікі, О. Сергиєнко, Р. Шваб та інші).

Починаючи з 1956 року теоретичним підґрунтям переважної більшості досліджень феномену вигорання стала теорія стресу Г. Сельє, яку розвинули його послідовники, однак дослідження професійного вигорання до сьогоднішнього дня все ще тривають і у широкому колі дослідників, і міжнародних організацій, триває дослідження синдрому вигорання і серед представників різних професійних груп та у різних сферах життєдіяльності.

Незважаючи на те, що синдром професійного вигорання визнано серйозною проблемою для здоров'я робочої сили, емпіричних

досліджень розвитку вигорання у державних службовців мало. Як і слід очікувати в науковій спільноті, одні дослідники цього явища уточнюють результати своїх попередників, інші – пропонують обґрунтування альтернатив. І те і інше може суттєво допомогти розширити уявлення про такий надзвичайно актуальний і нині феномен, як професійне вигорання та може стати неабияким досягненням у розумінні його природи.

Наукові концепти дослідження синдрому професійного вигорання свідчать, що розглядаючи феномен вигорання, основні зусилля науковців були зосереджені на визначенні низки симптомів та чинників, що мають опосередкований вплив на формування та розвиток синдрому професійного вигорання. Сьогодні психологи виділяють вже більше 100 симптомів, поява яких вказує на розвиток у індивіда синдрому професійного вигорання. У дослідження, що проводилися вже після 2000-х років, синдром професійного вигорання пов'язують із відчуттям безпорадності, тривоги, страху, провини, гніву, заціпеніння та відчуженості, а також безсонням, мігренню, хронічною втомою, м'язовою напругою, серцево-судинними проблемами [2], депресією, тривогою та підвищеним вживанням транквілізаторів і антидепресантів [1]. Це також тісно пов'язане з почуттям недооцінки працівників, прогулами, високою плинністю кадрів, негативними організаційними результатами та занадто низьким, чи занадто високим рівнем відданості роботі [7].

Виснаження негативно впливає на працівників у багатьох аспектах, включаючи їхнє психологічне здоров'я та бажання працювати. Фізичні та психологічні симптоми, викликані професійним виснаженням, подібні до симптомів посттравматичного стресового розладу (Jacobsona 2013). Люди, які переживають це, як правило, відчувають фізичний дискомфорт при повторенні, мимоволі згадуючи серйозні травматичні події, навіть якщо вони намагаються уникати їх у пам'яті (Figley and Roop 2006). Це викликає серйозні фізичні проблеми, включаючи тривогу та депресію (Cocker and Joss 2016). Крім того, виснаження змушує працівників уникати власних емоцій, щоб захистити себе. Як наслідок, люди стають байдужими та позбавляються співчуття та терпимості до інших (Figley 2002b), і втрачають бажання працювати.

Зважаючи на широкий спектр симптомів вигорання, все ж у результаті багатьох досліджень виявлено, що ризик професійного вигорання не є однаковим для всіх працівників однієї державної установи, оскільки на його прояв, крім факторів, пов'язаних із типом роботи, також впливають і індивідуальні фактори, такі як темперамент та особистість [6].

У своїх висновках вчені зосереджуються на тому, що одним із головних факторів виникнення професійного вигорання працівників є відсутність духу спільноти в організації, тобто відсутність якісних міжособистісних взаємодій, постійні конфлікти, відсутність підтримки та труднощі в роботі в команді. Це той випадок, коли професійна діяльність розглядається службовцем як стресова, в тому числі й через те, що у його колективі є особи, які справляють негативний вплив на загальну атмосферу [6].

У випадку, коли атмосфера оцінюється працівником як комфортна і він відчуває, що може брати участь у прийнятті рішень в установі – рівень відчуття виснаженості знижується, що підтверджує ряд зарубіжних досліджень. Можливість впливати на прийняття рішень посилює відчуття того, що вас цінують, і покращує залученість до роботи [1, 4].

Емпіричні дослідження китайських вчених підтвердили, що моральна відстороненість може підірвати особисте психічне здоров'я державних службовців і спричинити негативну організаційну поведінку. Робота в офісі наодинці унеможливує соціальну підтримку і, якщо працівник нездатний самотійно впоратися зі стресом, то це може перерости у виснаження, а от можливість поділитися труднощами з колегами та керівником допомагає працівнику долати напруження та є важливим захисним фактором [7, 9].

Ще одне дослідження професійного вигорання, що проводилося у Таїланді говорить про те, що державні службовці більш вразливі до політично вмотивованого втручання, іноді далекого від цілей установи, що є ще одним важливим фактором, що провокує вигорання. Окрім політичного втручання ззовні, у дослідженні також було виявлено негативний вплив на працівників таких чинників як розриви в управлінні та проектах, привілеї, що також мають місце та переважають у багатьох державних установах та створюють неабиякий тиск і стрес [8]. Чим більша невідповідність між

цінностями, очікуваннями та цілями працівників та їх роботою, тим більша ймовірність вигорання [3]. Це ускладнює для державного службовця управління ресурсами, необхідними для виконання своєї роботи, в умовах, коли відповідальність перевищує повноваження та автономію [1].

Висновки із досліджень бразильських психологів говорять про те, що деякі працівники, щоб впоратися з негативними почуттями виснаження на робочому місці, приділяють більше уваги своїм клієнтам, розвиваючи із ними стосунки, які допомагають їм подолати дискомфорт на робочому місці та неблагополучні взаємовідносини з колегами та керівництвом [8].

Численні дослідження також доводять кореляційний зв'язок між інтенсивністю стресу та ризиком професійного вигорання [2, 9]. Стрес, що пов'язаний із такими факторами як відповідальність, міжособистісні конфлікти та непередбачуваність, може призвести до відчуття невідповідності між очікуваннями працівника та реальною ситуацією на робочому місці, що, у свою чергу, теж значно підвищує ризик професійного вигорання.

Ця ситуація, які діють як фактори вигорання, сприяючи появі почуття некомпетентності, особливо в тих осіб, які відчують відповідальність за досягнення результатів, але для яких сама структура робочого місця не забезпечує їх ресурсами, необхідними для їх досягнення. Результатом може бути поява напруженості через незадоволення та розчарування особистими та професійними проектами, що піддає державним службовцям ризик синдрому вигорання.

Не можемо пройти осторонь того факту, що особистісні та психологічні фактори іноді можуть відігравати сильнішу роль у виникненні професійного вигорання, ніж організаційні та міжособистісні фактори [2]. Скажімо, риси темпераменту можуть зумовити те, як людина реагує на стрес на роботі. Тому їх теж варто розглядати як фактор схильності або фактор, що захищає від професійного вигорання [1]. Такі особистісні риси як емоційна стабільність, екстраверсія, сумлінність, привітність і відкритість знижують ризик вигорання [9]. Навпаки, нейротизм, визначений як схильність відчувати тривожні емоції такі як страх і депресія, сприяє виникненню синдрому вигорання [1].

Японські психологи, що проводили дослідження впливу темпераменту особистості на схильність до професійного вигорання, виявили отримали цікаві результати свого дослідження. Вони зазначають, що гіпертимний темперамент сприяє лідерству, надмірній залученості та стійкості до стресу, тоді як депресивний – відданості роботі, що робить ці риси бажаними в професійному середовищі. Суб'єкти з тривожним темпераментом схильні турбуватися про своє здоров'я та безпеку інших, що підходить для державних службовців, що працюють у соціальній сфері, яка полягає у професійній допомозі іншим [4, 6]. Депресивний, циклотимічний, дратівливий і тривожний темпераменти пов'язані з гіршою реакцією на стрес, що виникає в професійних ситуаціях, тоді як гіпертимний темперамент сприяє стійкості до професійного стресу [6].

Дослідження у японських державних компаніях виявило, що, циклотимічний і тривожний темпераменти пов'язані з гіршим копінгом, а рівень тривожного темпераменту пов'язаний із вищим стресом, тобто, більша інтенсивність обох темпераментів сприяє більш негативній оцінці подій, пов'язаних з роботою, що робить їх більш стресовими, що у свою чергу, підвищує ризик професійного вигорання. Таким чином, ці типи темпераменту можна розглядати як фактор, що впливає на ризик професійного вигорання.

Проаналізувавши останні дослідження професійного вигорання, які проводили зарубіжні науковці, можемо виокремити ще й такі індивідуальні фактори, які провокують або ж допомагають уникнути професійного вигорання:

1. Стать – загальноновизнано в більшості суспільств, жінки схильні до роботи у соціальній сфері, оскільки вони більш співчутливі до людей, що потребують допомоги, ніж чоловіки, що наштовхує на висновок, що жінки-постачальники послуг відчують вищий рівень втоми від співчуття, ніж чоловіки-постачальники послуг, однак, чоловіки можуть відчувати сильніший вплив розчарувань на роботі, яких жінки не відчують через причини, пов'язані з потребою в статусі. (McArthur 2017; Yeung 2017).

2. Вік – молоді люди, як правило, відчують більше виснаження (Doolittle 2010; Francis 2009) і втому, включаючи втому від роботи, ніж люди передпенсійного чи пенсійного віку (Burtson and Stichler 2010; Yeung 2017).

3. Досвід – деякі вчені стверджують, що досвід роботи має позитивний вплив на самопочуття на роботі (Randall 2004) і пов'язано це з тим, що молоді працівники не повністю розвинули необхідні навички для пом'якшення стресу (Doolittle 2010).

4. Освіта – суб'єкти з вищою освітою продемонстрували нижчу інтенсивність професійного вигорання, ніж особи з середньою освітою та більш ефективно подолання професійного вигорання, а стрес у осіб з вищою освітою, не перетворився на симптоми професійного вигорання, що підкреслює необхідність включення навчання подолання стресу та запобігання професійному вигоранню в навчальну програму чи програму підвищення кваліфікації державних службовців.

5. Ресурси – працівники використовують різні зовнішні стратегії, щоб полегшити вигорання, включаючи релігію, музику, мистецтво (Lally 2005), групові консультації, курси без відриву від роботи та семінари (Berger and Gelkopf 2011), пошук підтримки в керівників (Thoits 1995) і дистанціювання від джерела стресу (Yoder 2010). Однак, оскільки вигорання є також і психологічним станом, ефективність згаданих зовнішніх стратегій повністю залежить від того, чи успішно вони трансформуються у внутрішні стратегії подолання для людей, які їх застосовують.

6. Копінг-стратегії – Kabat-Zinn свого часу (1994) розробив методику зменшення стресу на основі усвідомленості, яка використовує уважність як особливий підхід до спостереження. Усвідомленість застосовується особливим чином – навмисне, в даний момент і без засуджень та передбачає правдиве спостереження за власними фізичними та психологічними явищами (Josefsson 2011), терпляче спостереження за безпосередніми фізичними та психологічними станами та спостереження за власними емоціями, думками та болем без осуду (Earley 2014; Brotto 2012). Було розроблено декілька методів практики усвідомленості, таких як медитація в сидячому положенні та ходьбі, сканування тіла, усвідомлена йога та усвідомленість у повсякденному житті (Kabat-Zinn 1994).

Дослідження показують, що якщо керівники колективу можуть зменшити навантаження на працівників (Keidel 2002; Yoder 2010) і збільшити організаційну і соціальну підтримку, психологічне здоров'я працівників, то професійного вигорання службовців ціл-

ком можна уникнути. Водночас, якщо співробітники можуть зміцнити власне психологічне здоров'я (Lally 2005), підвищити своє фізичне та психічне здоров'я (Figley and Roor 2006), застосовувати різні стратегії подолання негативних емоційних проявів (Josefsson 2011) то, вони теж можуть покращити своє психологічне здоров'я.

Висновки. Як правило, організації намагаються вирішити проблеми, збільшуючи фізичні ресурси та забезпечуючи співробітників професійною підготовкою, наприклад передовими медичними технологіями та комплексним аналізом управлінської політики, для ефективного та практичного вирішення проблем. Проте всі організації стикаються з моментами безпорадності, наприклад під час війни та стихійних лих. Навіть коли професійні навички співробітників всебічно розвинені, деякі ситуації, що можуть призвести до вигорання, поставлять будь-якого державного службовця під загрозу розвитку проблем зі здоров'ям, тому необхідно запроваджувати превентивні стратегії, які впливають і безпосередньо і на працівника, і на організацію та атмосферу на його робочому місці. Це стратегії, за допомогою яких державні службовці можуть фізично та психологічно дистанціюватися від джерел стресу, наприклад, беручи відпустку, зменшуючи обсяг роботи або тимчасово залишати робочі місця таким чином, відновлюючи енергію та простір, необхідні для відновлення свого фізичного та психологічного здоров'я, а керівники організацій повинні активно допомагати цим категоріям працівників у усвідомленні їхніх стратегій подолання професійного вигорання, проактивно надавати психологічне консультування працівникам, які, ймовірно, відчувають або відчували вигорання, наприклад, через курси без відриву від роботи, семінари, семінари та обговорення кейсів, розробка яких і стане темою наших подальших досліджень.

Література.

1. Колтунович Т. А. Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19. 00. 07. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2016. 352 с.
2. Масляч К. Б. Професійне вигорання особистості. Київ : Либідь, 2003. 340 с.

3. Мірошниченко О. А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у працюючих в екстремальних умовах: навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 156 с.
4. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти /За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. К. : Міленіум, 2004. 264 с.
5. Федоришин Г. М., Кицмен Н. З. Соціально-психологічні чинники професійного вигорання персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 2 (8). С. 178–185.
6. Borritz M, Rugulies R, Bjorner JB, Villadsen E, Mikkelsen OA, Kristensen TS. Burnout among employees in human service work: design and baseline findings of the PUMA study. Scand J Public Health. 2006;34(1):49-58. DOI:10. 1080/14034940510032275
7. Kokkinos CM. Job Stressors, Personality and burnout in primary school teachers. Br J Educ Psychol. 2007;77(pt 1):229-43. DOI:10. 1348/000709905X90344
8. Pavlakis A, Raftopoulos V, Theodorou M. Burnout syndrome in Cypriot physiotherapists: a National Survey. BMC Health Serv Res. 2010;10:63. DOI:10. 1186/1472-6963-10-63
9. Shirom A. Reflections on the study of burnout. Work Stress. 2005;19(3):263-70. DOI:10. 1080/02678370500376649

4.10. Психічне здоров'я персоналу в ІТ індустрії в умовах війни

Фроленко К. М.

Актуальність. Переважна більшість вітчизняної ІТ індустрії працює у глобальному контексті і конкурує з потужними зовнішніми гравцями на ринку аутсорсу і продуктової розробки. Умови військового стану спричиняють вплив на психологічне здоров'я персоналу, і як наслідок – на продуктивність і конкурентоспроможність як індивідумів так і колективів та організацій.

Мета. Дослідити вплив негативних чинників на продуктивність роботи працівників ІТ компанії, сформулювати набір рекомендацій керівникам з метою зменшення впливу умов війни на працездатність співробітників, і покращення (наскільки можливо у поточному контексті) умов праці.

Результати дослідження. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я – Психічне здоров'я по-різному визначали вчені з різних культур. Концепції психічного здоров'я включають суб'єктивне благополуччя, сприйману самоєфективність, автономію, компетентність, залежність між поколіннями та самореалізацію свого інтелектуального та емоційного потенціалу, та інше серед іншого. З міжкультурної точки зору це майже неможливо комплексно визначити психічне здоров'я. Проте загальновизнано, що психічне здоров'я є ширшим, ніж відсутність психічних розладів [1, с. 5]. У 2022 р., до звичайних факторів психологічного навантаження співробітників ІТ індустрії (remote режим роботи, ненормований робочий час, крос-культурні команди) додалися фактори стресу спричиненні війною – втрата звичного режиму і сенсу життя, втрата житла, загибель рідних, близьких, друзів, повітряні тривоги, бойові дії поряд. Д. Тупчієнко та Н. Седова, узагальнюють фактори спричинені війною наступним чином: в умовах військових дій наше тіло працює на максимальній потужності.

Гормони стресу, задача яких мобілізувати тіло в критичній ситуації, також мають свій «термін придатності». Людина може спостерігати сильні коливання настрою від тривоги, злості, приливу оптимізму до повного спустошення і виснаження. Важливо усвідомити, що це абсолютно закономірні стани, які з часом змінюють один одного. З кожним із них можна і треба працювати.

Основні ознаки перевтоми:

- відчуття знесилення, неспроможність виконувати звичайні функції;
- неувважність та погіршення концентрації;
- погіршення пам'яті;
- уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення;
- зниження цікавості до роботи;
- підвищена дратівливість;
- Нервозність;
- порушення сну;
- перманентна сонливість;
- підвищення тиску та частоти пульсу;
- головний біль;
- зниження апетиту;
- емоційна спустошеність [2 с. 55-58].

Типовий патерн зайнятості в ІТ індустрії – оперування складними конструкціями (код, алгоритми, сервіси), системами або сценаріями із залученням до роботи над спільною метою достатньо великої кількості людей, дуже часто – із різних країн. Така робота вимагає гарних когнітивних навичок, комунікативних спроможностей а також високої креативності. Окрім того, робота в ІТ вимагає постійного самовдосконалення – поточний стан справ в галузі не знаходиться на одному місці, постійно з'являються нові фреймворки, патерни програмування, інструменти та практики, які потребують вивчення і застосування. Такий комплекс вимог напругу суперечить типовим наслідкам перевтоми та стресу. Погіршення пам'яті, процесів, глибини та критичності мислення, зменшення цікавості – напругу впливають на здатність швидко створювати якісний код. Сонливість, дратівливість, нервозність – погіршують комунікацію, здатність зрозуміти один одного і працювати у команді.

Власна неспроможність працювати так само ефективно як в нормальних (довоєнних) умовах, у свою чергу, породжує незадоволення і відчуття провини, яке додатково ускладнює ситуацію, і по суті створює негативну спіраль вторинного впливу. В той самий час -наслідки військових дій є виключно локальним контекстом України. Типові замовники, або співробітники із інших країн живуть звичайним мирним життям, мають типові звичайні плани розвитку, відпочинку, горизонт планування, який вимірюються місяцями або роками. Західні компанії оперують звичайними бізнес задачами в контексті мирного часу. Цей факт, в свою чергу породжує внутрішню неготовність компаній включати військові ризики у планування типових бізнес проектів (зменшувати горизонт планування та/або цілі проектів). Також відсутнє повне розуміння наслідків потенційної емоційної нестабільності або продуктивності співробітників з України. В меншій мірі це стосуються співробітників які виїхали за кордон – але навіть у цьому випадку – відсутність звичного рівня життя, незвичне оточення, хвилювання за рідних які залишилися в Україні здійснює свій негативний вплив також і на них.

Така нездатність проявити співчуття, або хоча би зрозуміти поточну реальність з боку зарубіжних колег (це не є недоліком або браком толерантності – повне порозуміння може дати лише відповідний досвід) виступає додатковим фактором стресу для обох сторін. Що у свою чергу створює постійний негативний фон для будь якої взаємодії або комунікації. Така поточна ситуація вимагає від компаній і локального менеджменту здатності (наскільки можливо) компенсувати вплив військових факторів на продуктивність шляхом впровадження комплексу заходів психологічного характеру.

Останнім часом набули широкого поширення такі поняття як стрессостійкість, резилієнс, резильєнтність, тощо.

О. М. Кокун, Т. І. Мельничук наводять такі взаємодоповнюючі визначення термінів резилієнс і резильєнтность (базуючись на різних джерелах):

1. Резилієнс – динамічний розвивальний процес, що характеризується досягненням позитивної адаптації, незважаючи на вплив значної загрози, серйозних труднощів або травми (Cicchetti, 2013).

2. Резилієнс – процес використання біологічних, психосоціальних, структурних і культурних ресурсів для підтримки психологічного благополуччя (Folke, 2016).

3. Резилієнс – багаторівневий процес отримання кращих, ніж очікувалося, результатів перед обличчям або після негараздів (van Breda, 2018).

4. Резилієнс – це адаптивний динамічний процес повернення до початкового психосоціального функціонування після певного дезадаптивного періоду, спричиненого дезорганізуючою дією психотравмуючих факторів (Кокун та ін., 2022).

5. Резилієнс – це процес подолання негативних наслідків впливу травмівних подій, успішної боротьби з травмівними наслідками після цих подій та уникнення негативних траєкторій життя та розвитку, що пов'язані з ризиком (Fergus & Zimmerman, 2005).

6. Резильєнтність – здатність динамічної системи, такої як спільнота, передбачати виклики та успішно до них адаптуватися (Акоста та ін., 2017).

7. Резильєнтність – здатність динамічної системи успішно адаптуватися до викликів, які загрожують функціонуванню, виживанню або розвитку системи (Masten, та ін. 2021).

8. Резильєнтність – це розумова, фізична, емоційна та поведінкова здатність людини адаптуватися, відновлюватися та процвітати в ситуаціях ризику, викликів, небезпеки, складності та негараздів, а також вчитися та рости після невдач (Кокун та ін., 2022) [3, с. 5-7].

Також, автори класифікують різні чинники розвитку резильєнтності як «індивідуальні», «чинники сімейного рівня», «Чинники рівня робочого колективу/команди» і «Суспільні чинники» [3, с. 9-10].

В контексті поточного дослідження автор розглядає чинники рівня команди (як такі які знаходяться в області контролю організації) а також, хоча і в дещо меншій мірі – індивідуальні. Чинниками, які позитивно впливають на резильєнтність рівня організації або команди визнано: позитивний психологічний клімат; командна робота; згуртованість [3, с. 10].

Розглянемо можливості компанії та колективу, які можуть бути рекомендовані до використання для психологічної підтримки співробітників у відповідних категоріях:

- Позитивний психологічний клімат:

- доступна психологічна допомога –компанія може організувати курси роботи з психологом (який має доведену якість допомоги) – як такі, що включенні в поліс медичного страхування або

доступні іншим чином. Психологи, при цьому повинні розуміти контекст запиту.

- толерування вирішення психологічних проблем професійним чином. Довести до персоналу -що це нормально мати психологічні проблеми у поточній складній ситуації. Це нормально звертатися до професіоналів з метою їх вирішення.

- доступні курси підвищення психологічної самоусвідомленості для співробітників – як суто теоретичні (усвідомлення емоційного інтелекту, соціальні навички тощо) – так і у форматі «відповіді на поточні гарячі питання». Це допоможе співробітникам зрозуміти, що саме з ними відбуваються і (можливо), самостійно прийти до висновку «мені потрібна професійна допомога».

- розширення психологічних навичок менеджменту (теорія соціальної взаємодії, розвиток емоційного інтелекту, адаптаційні механізми, тощо). Це дозволяє, щонайменше контролювати поточний рівень тривожності в колективі, керувати вирішенням конфліктів і поточним робочим навантаженням.

- Командна робота:

- рекомендовано вбудувати регулярний check-in поточного стану в щоденну рутину – для визначення рівня стресу співробітників. Це дозволяє вчасно виявляти людей які вже не можуть впоратися самостійно – і пропонувати їм психологічну допомогу. Щонайменше, керівництво має можливість спробувати зменшити їх робоче навантаження.

- доступна гнучкість робочого навантаження, додаткові вихідні, дозволяють виключити перевтому з факторів стресу.

- наявність гнучкого робочого графіку – дозволяє адоптувати навантаження до повітряних тривог, проблем з електрикою, доступом до мережі.

- інформування закордонних колег про специфіку, про важливість персональної безпеки понад робочими процесами (Як приклад – це нормально пропустити on-line нараду під час повітряної тривоги).

- запровадження Agile практик, які наголошують важливість командної роботи понад результатами за будь яку ціну.

- Згуртованість:

- створення безпечного community / каналів комунікації для дискусії і публічного обговорення складних моментів. Це створює відчуття, що ти не один маєш такі проблеми, дозволяє ділитися способами подолання;

- заохочення, створення культури взаємодопомоги;

- заохочення елементів альтруїзму в поведінці (Участь у проєктах допомоги постраждалим від бойових дій, допомога військовим, діям, людям похилого віку, тощо).

Слід окремо зауважити, що у поточних умовах війни, постійних змін і небезпеки – сама наявність стабільної роботи з зрозумілими цілями, правилами і звичною робочою рутиною є потужним стабілізуючим фактором і острівцем стабільності і безпеки.

Варто окремо розглянути такий фактор як локальний менеджмент. Як персоналії – локальні Лідери знаходяться під впливом таких самих негативних факторів як і решта співробітників. Вони також відчувають стрес та небезпеку – і від їхньої здатності (як особистостей) швидко відновлюватися, зберігати здоровий глузд, проявляти емпатію великою мірою залежить здатність компанії як організації ефективно працювати і підтримувати решту співробітників.

З цього випливає, компанія має, по перше, відповідально ставитися до відбору людей на керівні позиції, по друге – інвестувати у розвиток соціальних навичок локального менеджменту. Рекомендації щодо процесу навчання та розвитку. LnD (Learning and Development). – типовий стандартний процес SOP (Standard Operational Procedure) в компаніях ІТ індустрії направлений на відтворюваність і можливість сертифікації результатів роботи а також розвиток людського капіталу. Як було вказано вище – розширення психологічних та комунікаційних навичок менеджменту – це новий важливий критерій досягнення успіху. Тому наявні психологічні тренінги варто інтегрувати в стандартні процедури розвитку і навчання менеджменту (LnD).

Висновки. Постійний стрес погіршує інтеграцію нових знань у вже існуючі структури – цей факт наразі вимагає нетрадиційних підходів. Як було сформульовано вище – постійне набуття нових знань – вимога конкурентоздатності як ІТ компаній так і окремих співробітників. Рекомендовані такі зміни до процесу навчання: об-

меження навчальних сесій по часу (повний день скоріш за все буде неефективним внаслідок накоплення втоми); наявність тривалих перерв між сесіями; використання набутих знань на практиці, бажано – багаторазове, для фіксації навичок; як варіант – повторні (але стиснуті за контекстом) сесії з повтором отриманих знань. Здатність організації підтримувати ментальне здоров'я співробітників під час війни, змінюватись і адаптуватись до поточних умов є запорукою ефективності і конкурентоспроможності. Ключовим чинником адаптації є потенціал Лідерів.

Література.

1. World health organization. The World health report: 2001: Mental health: new understanding, new hope. ISBN 92 4 156201 3 (NLM Classification: WA 540. 1)
2. Здоров'я і суспільство в умовах війни: Збірник наукових статей. Кропивницький : ЦПРОЛ, 2022. 437 с.
3. Кокун О. М., Мельничук Т. І. Резилієнс-довідник: практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2023. 25 с.

4.11. Роль психологічних чинників у виникненні емоційного вигорання працівників ІТ-сфери

Церковна О. М.

Актуальність. Сьогодні не можливо уявити розвиток суспільства без інформаційних технологій. В умовах воєнного стану ІТ-галузь стала однією із тих, хто зміг наростити обсяги надання своїх послуг, збільшити надходження до бюджету та є надійною опорою економіки України. ІТ-компанії, залучаючи кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, стрімко розвиваються та розробляють нові продукти, створюючи нові робочі місця. Львівський ІТ Кластер у 2022 році вперше дослідив соціально-демографічний профіль та кількість ІТ-фахівців, переміщення співробітників та офісів, зміни в структурі компаній та міграційні настрої ІТ-фахівців у семи регіонах Західної України. Це дослідження стало комплексним детальним дослідженням тех-індустрії України під час війни, в межах якого було зафіксовано не лише поточний стан, а й майбутні сценарії розвитку подій в технологічній індустрії після перемоги в Україні. Згідно отриманих даних дослідження було виявлено наступне: «Уже в перші місяці після вторгнення, ІТ-компаніям вдалося досить швидко адаптуватися під нові реалії та відновити роботу. Згідно з дослідженням IT Research Resilience, вже у травні 2022 року 85 % з них повністю або майже повністю відновили бізнес-активність. При цьому 63 % з них відзначили позитивний фінансовий результат, а 13 % – зростання доходу. Про високу адаптивність індустрії свідчить і дослідження проведене компанією-учасницею Кластера GlobalLogic. Згідно з їхніми даними, продуктивність українських ІТ-компаній під час воєнного стану становить 80-90 % від довоєнного. Це відобразилося і на експортних показниках: ІТ стало єдиною сферою експорту, яка виросла попри повномасштабну війну. За минулий 2022 рік експортна виручка ІТ-послуг зросла на 5,85 % і принесла економіці рекордні \$7,3 млрд» [4]. Тема емоційного вигорання в умовах сьо-

годення є дуже актуальною. Зміни в політичному, економічному та соціальному житті країни в умовах воєнного стану впливають на психологічний стан людей. Вимоги до роботи працівників стали більш складними, що призвело до емоційного напруження, втоми, та розвитку стресу. Довготривалий професійний стрес викликає синдром «емоційного вигорання».

Мета. Теоретичний розгляд ролі психологічних чинників у виникненні емоційного вигорання працівників ІТ-сфери.

Результати дослідження. Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає «чинник як умову, рушійну силу, причину будь-якого процесу, що визначає його характер або одну з основних рис» [1, с. 1601]. У психології розрізняють чинники зовнішні (об'єктивні) та внутрішні (суб'єктивні). До зовнішніх чинників можна віднести: економічну ситуацію в країні (війна), атмосферу в колективі та рівень заробітної плати, конкуренцію фахівців на ринку праці та можливість самовираження в ІТ-сфері. До внутрішніх чинників, які мають більше впливу на особистість можна віднести: внутрішній стан людини, бажання до професійного розвитку, задоволення від своєї діяльності, адекватна оцінка власних сил, адаптація у новому колективі, здатність до рефлексії, прагнення до розвитку власних задатків та здібностей та до найбільшого їх розкриття.

На думку авторів «професійне вигорання – психологічний стан працівника, який характеризується емоційною байдужістю, хронічною втомою від власної роботи та редукцією професійних досягнень. Виникненню синдрому професійного вигорання передують перебування у стані постійного психологічного напруження та значної інтелектуальної концентрації. В даний час значно розширюється кількість симптомів та збільшується перелік професій, представники яких схильні до синдрому професійного вигорання» [5, с. 136].

Публікації в науковій літературі, теоретичні та практичні дослідження показують, що тему емоційного вигорання в різних професійних сферах досліджували зарубіжні та вітчизняні науковці: М. Агапова, К. Черніс, О. Шнайдер, Т. Хенел, Т. Манн, О. Вовк, Д. Едельвич, Г. Сельє, С. Безносос, В. Бодров, М. Лейтер, Т. Зайчикова, Л. Малець, Е. Махер, В. Орел, Т. Форманюк, та ін. Дослідження проводилися на основі методів діагностики К. Маслач, В. Бойка, Н. Водоп'янової,

В. Лукьянова, Д. Трунова, О. Старченкова та ін. Але саме тема емоційного вигорання в ІТ-галузі є малодослідженою.

Сфера інформаційних технологій стрімко розвивається, і це вимагає від працівників постійного вдосконалення своїх професійних навичок. ІТ-спеціалісти вирішують складні завдання, для яких потрібні аналітичний склад розуму, уважність та витривалість, висока здатність до навчання та старанність, відповідальність та наполегливість, знання технічної англійської мови та мов програмування на досить високому рівні, досвід проектування структури сховищ даних. «Завдання, які стоять перед ІТ-спеціалістами часто виявляються занадто складними та вимагають посиленої розумової діяльності. Колектив ІТ-компанії – це працівники із різних країн, з різними світоглядами, менталітетом і звичками, тому працівники постійно адаптуються до нових умов роботи, до свого оточення та режиму праці. Працівники відчують стрес через понаднормову тривалість робочого дня, роботу у вихідні дні та роботу в нічні години. Тривала робота за ПК призводить до незадовільного фізичного стану, виникає перенапруження в тілі, що призводить до проблем із здоров'ям. Також часта проблема в ІТ-сфері, це вичерпаний ліміт задоволення від своєї роботи» [6, с. 252].

Дослідження синдрому емоційного вигорання, свідчать про складний і багаторівневий характер цього психологічного явища.

О. Шнайдер в результаті своїх досліджень вважає, що здатність керувати своїми емоціями тісно пов'язана із синдром емоційного вигорання у фахівців ІТ-сфери, а О. Вовк приходиться до висновку, «що одним із факторів впливу на імовірність розвитку синдрому професійного вигорання можна вважати нестійку самооцінку» [6, с. 253]. База дослідження О. Вовк, як і дослідження О. Шнайдера, є обмеженою, але їх результати є досить показовими для того, щоб розглянути проблему з точки зору характеристики проблеми в динаміці. Більше, ніж у половини працівників було виявлено сформований синдром професійного вигорання та майже у 40 % він знаходиться на стадії формування. Проблема професійного вигорання у ІТ-спеціалістів набула значно більших масштабів – до такого висновку приводять дослідження О. Вовк і О. Шнайдера, на базі методики В. Бойка. К. Маслач у своїх роботах звертає увагу на зміни, які відбуваються безпосередньо у професіоналів та відзна-

чає, що це синдром фізичного та емоційного виснаження, для якого характерний розвиток негативної самооцінки, негативне ставлення до роботи, втрата розуміння та співчуття по відношенню до клієнтів і в цілому до організації. М. Агапова пояснює емоційне вигорання з точки зору самоактуалізації особистості, і вважає це наслідком великих психоемоційних витрат над очікуваними результатами. В. Орел, відзначає, що неефективна адаптація суб'єкта до стресових факторів може бути результатом вигорання, і як наслідок знижується задоволеність роботою, адаптаційний потенціал спеціаліста та формує оцінку його важливості й змістовності.

Н. Гришина, «вважає, що розвиток емоційного вигорання не обмежується професійним середовищем та проявляється в різних життєвих ситуаціях людини, а робота, як засіб набуття осмисленості життя, має потужний вплив на всі життєві ситуації людини» [3, с. 197-198]. На думку Д. Трунова так проявляються захисні механізми психіки, які направлені на послаблення несприятливих професійних чинників – наслідків змін у мотиваційній сфері особистості фахівця та вбачає в стані емоційного вигорання «позитивні» сигнали для фахівця про процеси, що відбуваються в його «душі». Як свідчать дані досліджень такі результати «цілком узгоджуються з поглядами В. Бойка, який розглядає емоційне вигорання у вигляді захисного механізму та вказує на його функціональність (дозволяє більш економно витрачати «психічну», на думку автора, енергію) та деструктивні наслідки» [2]. До таких наслідків він відносить погіршення якості виконання професійних завдань та стосунків з колегами.

Синдром емоційного вигорання раніше досліджувався у сфері «людина – людина», де робота пов'язана з великим потоком людей, але зараз коло фахівців, схильних до професійного вигорання, розширилося. Вже отримані дані про наявність емоційного вигорання у сфері «людина – машина».

На думку О. Вовк «аналіз сучасних досліджень показав, що «психічне вигорання» ширше поняття, ніж «професійне вигорання», оскільки воно може бути викликане різними причинами – особовими, родинними, професійними. Психічне вигорання може виявлятися не лише в професійній сфері, а, наприклад, у сім'ї, в учбовій діяльності. Професійне вигорання становить один з ва-

ріантів психічного вигорання: перше частіше використовується в контексті трудової діяльності» [2].

Висновки. Таким чином, за результатами теоретичного аналізу проблема «емоційного вигорання» в ІТ-галузі за останні роки мала тенденцію до зростання. Спеціалісти ІТ-сфери у своїй професійній діяльності стали частіше стикатися із синдромом «професійного вигорання». Причини, які призводять до професійного вигорання зумовлені стресом, що обумовлений специфічними умовами роботи в цій галузі. До таких стресів призводять складність і унікальність професійних вимог, що висуваються до працівників будь-якого підрозділу в ІТ-сфері. До основних психологічних чинників емоційного вигорання можна віднести: рівень здатності особистості до самоконтролю, вміння адаптуватися до роботи в різних умовах (політичних, економічних, соціальних), вміння регулювати негативні емоції (у тому числі агресії), високе навантаження у сфері комунікації (комунікація з користувачами, колегами, керівництвом), незадоволеність умовами праці, високий рівень проблемності завдань, які стоять перед ІТ-спеціалістами, відповідальність за їх вирішення складних задач, розвиток власних здібностей, вміння надати перевагу тим чи іншим стратегіям подолання стресу. Важливо відмітити, що емоційне вигорання впливає не лише на стан одного працівника, а й на роботу цілого колективу. Тому досліджувати емоційне вигорання працівників ІТ-галузі важливо із врахуванням особливості діяльності людини: когнітивне та емоційне навантаження, інтенсивне спілкування, допомога. Психологічні особливості особистості також є важливими чинниками емоційного вигорання. І тут потрібно приділити увагу емоційному інтелекту, емпатії, здатності людини до регуляції негативних емоцій, адекватній оцінці власних сил, навичкам рефлексії, розвитку особистих навичок.

Література.

1. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови: книга. Київ: Перун, 2005. 1728 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989>.
2. Вовк О. В. Особливості синдрому професійного вигорання в працівників сфери інформаційних технологій: журнал Психологічне здоров'я. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2019. Випуск 1(2). 251 с.

3. Лаврова М. Г. Теоретичний аналіз сучасних поглядів на поняття «емоційне вигорання». Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. – 2014. – Т. 19, Вип. 2. – 385 с.

4. Львівський ІТ-кластер. Дослідження ІТ ринку в 2022 році. URL: <https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research/>.

5. Моначин І. Л., Кутузова Н. В. Психологічні особливості професійного вигорання ІТ-спеціалістів. Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». 2019. с. 136. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29541>.

6. Церковна О. М. Емоційне вигорання працівників ІТ-сфери. Збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції РИНОК ПРАЦІ: досягнення, виклики та перспективи у національному та європейському просторі. 2023. с. 251-254.

4.12. Психічне здоров'я організацій та персоналу в умовах війни

Янушевська О. А.

Актуальність. Однією із важливих проблем в період агресивної війни Російської Федерації проти України є проблема підтримки та збереження психічного здоров'я персоналу організацій, оскільки це має прямий вплив на ефективність професійної діяльності персоналу, задоволення його потреб, сприяє успішності діяльності організації. Це потребує осмислення цієї проблеми, здійснення аналізу основних виявів психічного здоров'я у персоналу організацій в умовах війни, проблем, які існують, вивчення особистісних та організаційних ресурсів, які використовуються персоналом [1]. Крім того, слід зазначити, що вказана агресивна війна відбувається у період становлення в Україні інформаційного суспільства. Тому додатковим напрямком уваги та дослідження має бути чинник інформаційно-психологічних даних процесів. «Адже особистість у період війни функціонує в особливому інформаційному світі. Цей світ складається з безмежної кількості негативних інформаційних потоків, які кожен секунду впливають на людину. Всебічний вплив такої інформації стає і базою розвитку значного інформаційного стресу. Остання часто має мати непередбачуваний характер, вимагати від особистості швидких дій, швидкого психічного реагування та адаптації до нових умов. Інформаційний стрес викликає стан психічної напруги, тривоги, страху та інші психофізіологічні порушення. Особливо це стосується інформації, яка за своєю сутністю не відповідає моральним нормам, є маніпулятивною та робить особистість залежною від неї» [3]. Серед вивчення психологічних наслідків війни вагоме місце займає аналіз психічних розладів населення під впливом військових конфліктів, які відбуваються в різних регіонах світу, що відображено в ряді зарубіжних досліджень [5; 6]. Вивчення психологічних наслідків широкомасштабної війни рф проти України лише розпочалось і знайшло вітчизняних авторів: Зливков В., Лукомська С. [7]; Кокун,

О. М., Мороз, В. М., Пішко, І. О., Лозінська, Н. С. [8]; Deineko O. [9]. Серед дослідження психологічних наслідків агресивної війни РФ проти України суттєве значення має проблема вивчення сутності та структури психічного здоров'я персоналу організацій у умовах війни, його негативних та позитивних виявів, класифікація основних проблем, які стосуються вираженості складових психічного здоров'я, визначення ресурсів, необхідних для його підтримки і збереження.

Мета. Дослідити основні публікації щодо виявів та ресурсів психічного здоров'я персоналу організацій, «дисконтувавши» їх відповідно умов війни. Крім того, дослідити методи підтримки зацікавлених сторін у сфері праці у виконанні ними їхніх відповідних ролей у здійсненні заходів зі збереження та зміцнення психічного здоров'я на роботі в даних умовах.

Результати дослідження. За визначенням Карамушка Л. М. «Психічне здоров'я персоналу організацій в умовах війни включає такі основні складові: 1) здатність справлятися з повсякденними стресами життя в умовах війни; 2) здатність налагоджувати стосунки з людьми в умовах війни; 3) здатність ефективно здійснювати свою професійну діяльність та працювати на користь своєї організації й суспільства, реалізувати свої здібності в умовах війни» [1].

Зазначимо, що існують різні підходи щодо вивчення структури психічного здоров'я особистості в умовах війни. У дослідженні [1] аналіз складових психічного здоров'я здійснюється через висвітлення його негативних та позитивних виявів у різних сферах життєдіяльності людей в умовах війни. Дослідження проводилось в травні 2022 р. 344 респондентів з Центрального регіону України взяли участь в дослідженні. За соціально-демографічними характеристиками респонденти були розподілені таким чином: 80,8 % опитаних були жінки та 19,2 % чоловіки. Середній вік респондентів складав $M = 39,1$, $SD = 15,8$, 58,1 % опитаних були неодруженими та 41,9 % були одруженими. 63,7 % опитаних не мали дітей, 36,3 % мали дітей. Щодо організаційно-професійних характеристик, то тут зафіксовані такі дані. 6,5 % мали середню або середню спеціальну освіту, 81,7 % мали незакінчену вищу або вищу освіту, 11,8 % навчались в аспірантурі або мали науковий ступінь (наукове звання). 25,0 % обіймали посади керівників в цих сферах, 75,0 % мали статус працівників. Респонденти працювали в таких

сферах: 29,9 % – підприємництва та бізнесу, 24,7 % – освіти і науки, 13,4 % – охорони здоров'я, 8,2 % – державної служби. 23,8 % опитаних не працювали. За характеристиками місця проживання, пов'язаного із рівнем безпеки під час війни у першій її фазі (кінець лютого-квітень) опитувані розподілились наступним чином. Щодо місця знаходження під час війни отримано такі відповіді: 62,5 % відповіли, що знаходились у своєму місті (селі), 20,9 % переїхали у більш безпечне місто (село) в межах України і 16,6 % переїхали у більш безпечне місце за кордоном. Узагальнюючі результати дослідження Карамушка, Л. М. можна зазначити наступне: психічне здоров'я персоналу організацій в умовах війни являє собою стресостійкість, збереження здатності до комунікацій в трудовому колективі та зовні нього, а також до ефективної роботи в недосконалих та небезпечних умовах; в умовах війни рівень психічного здоров'я погіршується значно вищими темпами, ніж рівень фізичного, що диктує пріоритетність перманентного контролю над першим; самозбереження та самоконтроль психічного здоров'я персоналу відбувається за рахунок його особистісних ресурсів та ресурсів соціального оточення. Ресурси організації як місця роботи персоналу залишаються незадіяними для відповідної психологічної підтримки; досліджені дані вимагають необхідності розробки та впровадження спеціальних психологічних технологій, спрямованих на збереження та підтримання психічного здоров'я персоналу організацій в умовах війни. Їх використання слід не лише спеціалізувати відповідно до рівнів впливу--індивідуальному, груповому, організаційному та суспільному, але і залучити необхідні ресурси організацій та суб'єктів відповідного рівня.

Наступним в рамках профільного дослідження [2] було запропоновано окремий аналіз факторів ризику для психічного здоров'я, які особливо актуалізуються під час війни. Мова про «психосоціальні ризики» й можуть стосуватися, серед іншого, змісту роботи чи робочого графіка, конкретних характеристик робочого місця або можливостей кар'єрного розвитку. Підвищені вимоги до роботи, низький рівень контролю над роботою і нечіткі ролі можуть загострити стрес, пов'язаний із роботою, та підвищити ризик виснаження, емоційного вигорання, тривоги та депресії. Такий самий вплив спричиняє обмеженість доступу під час воєнних

дій до основних екологічних послуг на роботі, таких як безпечна питна вода, чисте повітря й належне управління відходами. Вкрай несприятливо можуть позначатися на психічному здоров'ї типові для роботи в умовах війни неадекватна й нестабільна оплата праці та відсутність гарантій зайнятості через посилені мобілізаційні заходи, особливо для працівників комунального сектору економіки. Адже ці фактори посилюють повну невизначеність працівників щодо власної подальшої долі [2]. Хоча психосоціальні фактори ризику можна знайти в усіх галузях, робочі ситуації, типові для деяких професій в умовах війни, як правило, підвищують ризик впливу, і в цих професіях є більша ймовірність проблем із психічним здоров'ям – наприклад, якщо робота передбачає велике емоційне навантаження або частіше трапляються потенційно травматичні події, а саме робота в галузі охорони здоров'я чи в екстрених службах. Неспіввимірно сильно піддаються психосоціальним ризикам, які шкодять психічному здоров'ю, також працівники, зайняті на низькооплачуваних, невдячних або небезпечних роботах, та люди, які працюють в ізоляції. Серед працівників, які можуть зазнавати найсильнішого впливу психосоціальних ризиків через демографічний статус, – люди, які мігрували із зон окупації та воєнних дій [2].

Слід зазначити, що значне зростання кількості воєнних конфліктів та відповідні демографічні зрушення у глобальному світі прискорюють темпи змін, особливо в дистанційній роботі, електронній комерції та автоматизації. Вони також руйнують усталені ринки праці, посилюють фінансову нестабільність і спричиняють масштабну реорганізацію підприємств. Для багатьох працівників ці зміни створили нові психосоціальні ризики або загострили вже наявні, призвели до втрати заробітків та кар'єрних перспектив [2]. Узагальнюючі результати дослідження можна зазначити наступне: психосоціальні ризики для психічного здоров'я під час війни набувають особливої гостроти та значимості; мобілізаційні заходи створюють додатковий тиск на психічне здоров'я персоналу; категорії населення з підвищеним емоційним навантаженням під час війни (переселенці, працівники комунальних та екстрених служб) особливо вразливі для вищезазначених ризиків.

Важливим при аналізі психічного здоров'я персоналу є розуміння впливу інформаційних потоків. Так, ефективними способа-

ми протистояння негативному впливу інформаційних потоків є [3]: формування критичного мислення щодо отримання інформації від зовнішнього світу, набуття навичок роботи з інформацією; спільні обговорення (у складі груп, колективів) негативного впливу інформаційних потоків (приклади і слідства, обґрунтування отриманих висновків) із метою набуття навичок вміння аналізувати різні медіатексти, виділяти спрямованість інтересів авторів подібних текстів; отримання і закріплення матеріалу з інформаційної безпеки, формування уявлення про вплив інформаційних потоків на психіку людини (за допомогою, в т. ч., знань про роботу мозку та сприйняття інформації) на лекціях, семінарах; спеціальні цикли курсів із глибинної психології, основ загальної психології, психофізіології, політології, історії, літератури, філософії тощо; ширше запровадження у вищих навчальних закладах та факультетах підготовки дисциплін, спектр уваги яких буде приділено темі інформаційно-психологічного впливу. Крім того, можна запропонувати низку більш глобальних організаційних і педагогічних заходів. Перш за все необхідна розробка та реалізація цілісної концепції ідеологічної й пропагандистської дії, орієнтованої на встановлення пріоритету національних і культурних цінностей і світоглядних орієнтирів на протигагу тим, що поширюються з-за кордону. При цьому вказана концепція має стати основою для створення цивілізованого інформаційного простору країни, надання йому таких властивостей, як цілеспрямованість, системність, стійкість, безпечність. Однак тут має використовуватися не абстрактний підхід, як це було раніше, коли потужна ідеологічна система працювала сама на себе й при цьому повністю ігнорувала життєві інтереси та потреби особистості, а підхід, орієнтований на конкретних людей – громадян країни, захист їх духовного здоров'я, попередження інформаційних загроз, збереження цілісної особистості як стійкої системи, що розвивається. Через загальнодержавні ідеологічні, педагогічні, організаційні та інші заходи варто сформувати в особистості захисний інформаційний прошарок, генетичну основу якого становитимуть загальнолюдські цінності й орієнтири [3].

Висновки. Узагальнюючі результати можна зазначити наступне: інформаційне середовище як найбільш масштабний чинник впливу в умовах війни на психіку персоналу особистості актуа-

лізує проблему інформаційно-психологічної безпеки. Необхідно вживати заходів контролю над інформаційними потоками, навчати персонал організації конструктивним способам взаємодії із зовнішнім інформаційним середовищем, вчасному задіяння власних психологічних ресурсів та ресурсів свого соціального оточення. Ці фактори мають спонукати до активізації дій не тільки держави, а й суспільства, психологів, педагогів та інших фахівців. В умовах війни інформаційно-психологічна безпека суспільства загалом і особистості зокрема має стати однією з головних функцій державного управління [3]. Результати досліджень Климчук В. та Горбунової В [4] демонструють, наскільки важливо навіть в умовах воєнного часу дбати про психічне здоров'я працівників. Наведені в дослідження причини такого інвестування в цих умовах стають ще більш актуальними. Дослідження показують, що 1 долар, інвестований у психічне здоров'я працівників, може дати до 9 доларів прибутку. Варто лише забезпечити певні умови, які сприятимуть цьому процесу. Пропоновані автором умови такого сприяння повинні сприйматися з урахуванням події війни. Тому розглянуті пропоновані в якості алгоритму збереження психічного здоров'я персоналу: наукові знання та методи з доведеною ефективністю; ретельний аналіз ситуації, що склалася в організації, продумана і чітко сфокусована система впровадження заходів, оцінка та моніторинг результатів; неперервність та тривалість роботи мають бути спрощені та застосовуватися з поправкою на значний дефіцит часу в умовах швидкої зміни обставин застосування, зумовленої бойовими діями.

Література.

1. Карамушка, Л. М. Психічне здоров'я персоналу організацій в умовах війни: основні вияви та ресурси. Вчені записки Університету «КРОК» №3 (67), 2022, DOI: 10. 31732/2663-2209-2022-67-124-133.
2. World Health Organization and International Labour Organization, 2023. «Психічне здоров'я на робочому місці. Аналітична записка».
3. Панченко О. А., Кабанцева А. В. Людська психіка в інформаційній небезпеці. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. DOI <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2020.3/39>
4. Климчук В., Горбунова В. Психічне здоров'я в організаціях: чотири причини інвестувати в охорону психічного здоров'я працівників.

5. Нейпонews, <https://www.researchgate.net/publication/>
6. Murthy, R. S., Lakshminarayana, R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. *World Psychiatry*. 2006. 5(1). pp. 25-30.
7. Priebe, S., Bogic, M., Ajdukovic, D., et al. (2010). Mental disorders following war in the Balkans: a study in countries. *Archives of General Psychiatry*, 2010. 67. pp. 518-28. DOI:10. 1001/archgenpsychiatry. 2010. 37
8. Зливков, В., Лукомська, С. Діти війни: теоретико-методичні і практичні аспекти психологічної допомоги: Навч. пос. Київ-Ніжин: Вид. Лисенко М. М., 2022. 95 с.
9. Кокун О. М., Мороз, В. М., Пішко, І. О., Лозинська, Н. С. Теорія і практика управління страхом в умовах бойових дій [Theory and practice of fear management in combat conditions]. *Фенікс*, 2022. 88 p. <https://lib.iitta.gov.ua/730971> [In Ukrainian]
10. Deineko, O. War in Ukraine: a sociological study. Oslo, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Metropolitan University, 2022. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.084764>. Epub 2012 Jan 26. PMID: 22282430

ЧАСТИНА 5.

КОНСУЛЬТАТИВНА, ДІАГНОСТИЧНА ТА ТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ У МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ СУПРОВОДІ ОСОБИСТОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

РОЗДІЛИ:

5.1. Медико-психологічна взаємодія у системі «медичний працівник-пацієнт»

Бегеза О. С.

Актуальність. Медична деонтологія в Україні передбачає вивчення професійної компетентності та практичної діяльності медичних працівників, що робить її актуальною та затребуваною як в медицині, так і в психології. Професійна компетентність медичного персоналу включає виконання посадових обов'язків, дотримання принципів лікування та обстеження пацієнтів, що зазначені в міжнародних та вітчизняних медичних протоколах, та має особливий компонент – міжособистісна взаємодія у системі «медичний працівник-пацієнт». Формування професійної компетентності медичних працівників здійснюється на основі загальних компетентностей, які включають: здатність до навчання (ability to learn), екзистенційну компетентність (existential competence), здатність до відтворення знань (declarative knowledge), вміння та навички (skills and know-how) [1].

Досліджуючи формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних працівників Т. Кравцовою виділено структурні складові професійної компетентності: теоретичні знання та практичні уміння та навички, набуті під час навчання та у процесі практичної діяльності [5]. Автор вказує, що професійна компетент-

ність містить: когнітивний компонент (знання); мотиваційний компонент; аксіологічний компонент (спрямованість, ціннісні орієнтації особистості, здібності); практичний компонент (уміння, навички, досвід діяльності); емоційно-вольовий компонент (саморегуляція) [5]. Чільне місце у взаємодії має професійно-мовленнєва компетентність, яка демонструє позитивні показники у процесі обстеження та лікування пацієнта, що у свою чергу свідчить про результативність та ефективність надання медичної допомоги.

Професійно-мовленнєва компетентність медичного працівника розглядається В. Мікаєлян як комплексне явище, яке визначає мовленнєву поведінку індивіда, ґрунтуючись на сукупності його здібностей: до розуміння намірів співрозмовника; усвідомлення доцільності мети професійної комунікації; програмування комунікативних стратегій і тактик; управління процесом в рамках заданих професійних завдань [6]. Вміння комунікувати, пояснювати медичні терміни зрозумілою доступною мовою, проявляти емпатію, або вчасно розпізнавати «агресивного» пацієнтка та вміти ефективно взаємодіяти у конфліктних ситуаціях є важливим вмінням медичного працівника (молодша медична сестра, лаборант, асистент лікаря, медсестра, лікар). Тому, одним із важливих соціально-професійних завдань медичних працівників є дотримання принципів медичної деонтології отримання навичок професійно-мовленнєвої компетентності у системі взаємодії «медичний працівник-пацієнт»

Мета. Проаналізувати психологічні особливості взаємодії у системі «лікар – пацієнт», та визначити моделі та стилі їх комунікації.

Результати дослідження. Аналізуючи психологічні аспекти медичної деонтології, та вивчаючи специфіку й різновиди професійної етики медичного працівника Ю. В. Копочинська та С. Б. Лятенко [4, с. 7] визначили основні завдання медичної деонтології:

1. Вивчення принципів поведінки медичного персоналу, спрямованих на досягнення ефективності лікування хворих і профілактики захворювань.

2. Аналіз взаємодії між лікарем і хворим, та його родичами, а також між медичними працівниками в колективі.

3. Попередження і виключення несприятливих факторів у медичній діяльності та усунення наслідків медичної роботи» [4, с. 7].

Таким чином, завдання медичної деонтології є актуальними у професійній діяльності медичних працівників та потребують подальшого вивчення.

Важливим аспектом у побудові довірчих відносин між медичним працівником та пацієнтом є комунікація. Від рівня її функціонування залежить збір анамнезу лікарем, визначення подальшої тактики дослідження або лікування.

У психологічній літературі поняття «комунікація», «спілкування» розглядається у розумінні: вид людської діяльності; обмін думками, відчуттями, емоціями, враженнями, інформацією; механізм соціалізації особистості. Тобто, як процес взаємодії між людьми, спілкування регулюється такими механізмами, як: мета, зміст, засоби. У медичній психології поняття «комунікація» розуміють та тлумачать як процес, дія, а також визначають як «фундаментальна потреба», яку реалізує людина у ситуації вирішення питання особистого здоров'я.

Як зазначали І. О. Боровик, Н. І. Корильчук, В. М. Творко, важливим аспектом у формуванні довірчих відносин між медичним працівником та пацієнтом є комунікація. Від рівня її функціонування залежить збір анамнезу лікарем, визначення подальшої тактики дослідження або лікування. Комунікація – це дія, але також і фундаментальна потреба, яку реалізує кожна людина щодня. Це простий і буденний елемент нашого життя, але зі складною й розгалуженою мережею впливу [1].

Л. А. Онуфрієва, О. М. Чайковська [7] зазначають, що психологія міжособистісних взаємин та комунікації – це галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності й механізми поведінки, спілкування й діяльності людей, обумовлених їх виключністю в соціальні групи, а також психологічні особливості самих груп. У продовження авторки виділяють загальні групи міжособистісної комунікації, а саме:

- особистість у групі (системі відносин), взаємодія в системі «особистість – особистість» (батько – дитина, керівник – виконавець, лікар – хворий, психолог – клієнт і т. ін.);

- мала група (родина, шкільний клас, трудова бригада, група друзів і т. і.), взаємодія в системі «особистість – група» (лідер – ведені, керівник – трудовий колектив, новачок – шкільний клас тощо), взаємодія в системі «група – група» (змагання команд, групові переговори, міжгрупові конфлікти тощо);

– велика соціальна група (етнос, партія, суспільний рух, соціальні прошарки, територіальна, конфесіональна групи тощо) [7, с. 8].

У продовження міркування, цікавим, на нашу думку, є погляд Роберта Вітча на систему взаємодії лікаря і пацієнта (рис. 1).

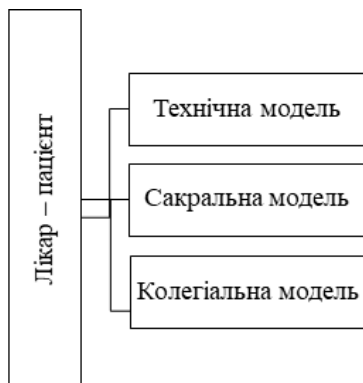


Рис. 1. Класифікація моделей спілкування між лікарем і пацієнтом за Р. Вітчем. (розроблено автором)

Автор пропонує власну класифікацію «моделей спілкування між лікарем і пацієнтом:

– технічна (лікар виконує свої обов’язки професійно, але безпристрасно, сприймаючи пацієнта, як механізм, що потрібно полатодити),

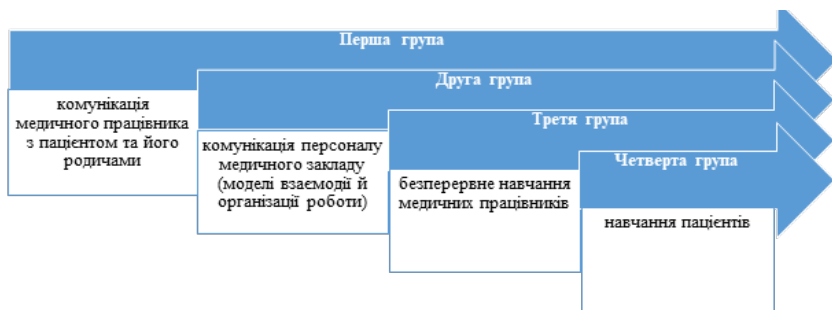
– сакральна (лікар виступає у ролі «батька», а пацієнт «дитини», котра має безапеляційно виконувати вказівки свого батька, схиляючись перед його мудрістю),

– колегіальна (в центрі стоїть пацієнт, він із лікарем стає ніби колегами в боротьбі проти хвороби і відіграє у цій боротьбі активну роль), контрактна (лікар укладає з пацієнтом негласний чи офіційний договір про лікування, але рішення приймає сам, лише обґрунтовуючи їх пацієнту) [4].

Опираючись на практику професійної діяльності у системі взаємодії «лікар – пацієнт», відбувається специфічна, вузько направлена, комунікація, яку можна охарактеризувати чотирма групами (кластерами) особливостей взаємодії (рис. 2).

Перша група – комунікація медичного працівника з пацієнтом та його родичами, методи психологічної підтримки у кризових ситуаціях (повідомлення про смерть пацієнта родичам, обговорення

методів лікування та можливих наслідків, зневажливе ставлення пацієнтів та їх родичів до медичного працівника, погрози та сталкеринг(переслідування) медичного працівника.



*Рис. 2. Кластери у системі взаємодії «лікар – пацієнт».
(розроблено автором)*

Друга група – комунікація між персоналом у медичному закладі, створення моделей організації роботи для персоналу та медичних відділень у лікарнях. Адже одним із головних факторів, який впливає на роботу медичних працівників є атмосфера в колективі, відсутність булінгу, психологічного чи фізичного насильства. Що в свою чергу позитивно впливає на розвиток спеціаліста у професійній діяльності, емоційну та психологічну лабільність медичного працівника та попереджує емоційне вигорання, конфліктні ситуації серед персоналу.

Третя група – безперервне навчання медичного персоналу, проведення лекцій, практичних занять для освоєння навиків як медичної деонтології так і психологічних факторів, які можуть допомогти у роботі із пацієнтами. Вміння діяти у конфліктних ситуація із конфліктними пацієнтами, залучення ще одного медичного працівника-партнера, який буде або свідком в даній ситуації або окремою незалежною думкою.

Четверта група – навчання пацієнтів правил поведінки у медичних закладах, правил внутрішнього розпорядку медичного закладу та окремих відділень лікарень, не перешкоджання роботі медичних працівників, навмисного пошкодження майна медичної установи і т. д. Адже дані правила допоможуть зменшити незадоволення пацієнтів, знизити ризики конфліктів між пацієнтом та

лікарем та покращити їх комунікацію, що в майбутньому матиме свої позитивні плоди – лікар зможе повноцінно працювати та виконувати свої діагностичні пошуки та лікувальні маніпуляції, а пацієнт матиме розуміння певних правил та роботи медичного закладу, бачитиме ефект від лікування та не перешкоджатиме навмисному провокуванню конфліктних ситуацій.

Таким чином, специфіка спілкування між лікарем та пацієнтом є одним із основних варіантів вивчення даної проблематики, адже більшу частину своєї роботи медичний працівник проводить із пацієнтом.

У продовження теоретичного вивчення, як зазначали Ю. В. Копчинська та С. Б. Латенко, існують моделі взаємодії між лікарем і пацієнтом (за Робертом Вічем):

1. Батьківська, патерналістська (від лат. *pater* – батько) модель характеризується тим, що медичний персонал ставиться до пацієнтів так, як батьки ставляться до своїх дітей. Тобто лікар або медична сестра самі визначають, у чому полягає благо пацієнта, в основному приймають важливі для пацієнта рішення і беруть, відповідно, велику частину відповідальності при цьому на себе. «Свята неправда» як приховування правди про діагноз від самого хворого і застосування «плацебо» (від лат. *placeo* – подобатися), тобто фармакологічно нейтрального засобу, що видається за ефективно діючі ліки – яскраві приклади батьківського ставлення до пацієнтів.

2. Інженерна модель характеризується тим, що лікар або медична сестра зводять свою роль до того, щоб виявляти і відновлювати якісь функції, усувати злами в організмі пацієнта. Міжособистий аспект взаємовідносин медичного персоналу і пацієнтів тут цілком або майже цілком ігнорується. Ця модель може домінувати в кабінетах (відділеннях) рентгенологічного обстеження, функціональної діагностики, у роботі з хворими в несвідомому стані в реанімаційних відділеннях.

3. Колегіальна модель характеризується повною взаємною довірою медичного персоналу і пацієнтів. Прямуючи до спільної мети, лікар і медична сестра стають «друзями» хворого. Сам Р. Віч вважає, що така модель суперечить соціальному реалізму» [4, с. 8-9].

Вищевказані моделі в свою чергу формують різні стилі поведінки у спілкуванні лікаря із пацієнтом, оскільки одним із завдань медичної

деонтології є ввічливе ставлення до пацієнта попри можливе відразу недовірливе та зневажливе ставлення до медичного працівника.

Одним із варіантів досліджень та впровадження психологічної підтримки для обох сторін є формування моделей поведінки та вміння поводження в кризові етапи як комунікації так і під час медичних процедур (лікування, діагностика наприклад). Оскільки пацієнти не задумуючись теж приносять «емоційну шкоду» інколи психологічне насилля по відношенню до медичних працівників, які надають медичну допомогу у зв'язку із пагубними звичками (алкогольне, наркотичне сп'яніння), негативним досвідом перебування та лікування в медичному закладі пацієнта або його близьких чи друзів, що формує поведінку пацієнта, психічні розлади, які можуть проявлятися у частій зміні емоцій, незв'язних між собою фраз, нав'язливих думок та стверджень, що медичні працівники перебувають у змові та налаштовані виключно отруювати пацієнтів і т. ін.

Розвиваючи вищевикладену думку, колективом авторів (Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Рогач І. М. Шніцер Р. І.) визначено причини поганої комунікації лікаря з пацієнтом: стереотипи, упереджене ставлення, вороже ставлення, відсутність уваги та інтересу до співрозмовника, нехтування фактами, помилки у побудові висловлювань, помилковий вибір стратегії і тактики [8].

Висновки. Професійна компетентність медичного персоналу передбачає: виконання посадових обов'язків, дотримання принципів лікування та обстеження пацієнтів міжнародними та вітчизняними медичними протоколами. Формування професійної компетентності містить структурні компоненти: когнітивний компонент (знання); мотиваційний компонент; аксіологічний компонент (спрямованість, ціннісні орієнтації особистості, здібності); практичний компонент (уміння, навички, досвід діяльності); емоційно-вольовий компонент (саморегуляція). Опираючись на практику професійної діяльності, виокремлено чотири кластери у системі взаємодії «лікар – пацієнт»: 1) комунікація між пацієнтом та його родичами, методи психологічної підтримки у кризових ситуаціях; 2) комунікація між персоналом у медичному закладі та створення моделей організації роботи для персоналу та медичних відділень у лікарнях; 3) безперервне навчання медичного персоналу, проведення лекцій, практичних занять для освоєння компетентностей як медичної деонтології, так і психологіч-

них факторів, які можуть допомогти у роботі із пацієнтами; 4) навчання пацієнтів правил поведінки у медичних закладах, правил внутрішнього розпорядку медичного закладу. Перспективою подальшого дослідження стане вивчення методів та стилів, комунікації та взаємодії в системі взаємодії «медичний працівник-пацієнт» та діагностування й аналіз психоемоційних станів пацієнтів.

Література.

1. Боровик І. О., Корильчук Н. І., Творко В. М. Комунікація в медичній галузі: проблеми та підходи. Український медичний часопис. 2023. 3 (155) – V/VI. С. 119-121. URL : <https://umj.com.ua/uk/publikatsia-243480-komunikatsiya-v-medichnij-galuzi-problemi-ta-pidhodi>
2. Галуз'як В. М. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: монографія. Вінниця, 2016. 228 с.
3. Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Герасимчук Н. М. Деонтологія в медицині: підручник. К. : ВСВ «Медицина», 2018. 240 с.
4. Копочинська Ю. В., Латенко С. Б. Основи деонтології : навч. посібн. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 87 с.
5. Кравцова Т. Формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних працівників засобами проблемно-модульного навчання. Наукові записки КДПУ ім. Винниченка: Серія: Педагогічні науки. 2013. Вип. 120. С. 208–211.
6. Мікасян В. В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичного університету як запорука успішної медичної практики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2017. Вип. 52. С. 108–112.
7. Онуфрієва Л. А., Чайковська О. М. Психологія міжособистісних взаємин та комунікації: навчально-методичний посібник: Кам'янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2021. 128 с.
8. Рогач І. М. Шніцер Р. І., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. Етика спілкування як складова частина менеджменту в системі охорони здоров'я. Навчально – методичний посібник для лікарів – інтернів та лікарів – курсантів. Ужгород. 2010. 29 с. URL : <https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2687>
9. Сучасні підходи в комунікації «лікар – пацієнт». URL: <https://zdorovi.agency/blog/suchasni-pidhodi-v-komunikaciyi-likar-paciyent/>
10. Basil Varkey. Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. 2021; 30:17–28 DOI: 10.1159/000509119
11. Karnieli-Miller O. Reflective practice in the teaching of communication skills. Patient Education and Counseling, 2020103(10): 2166–2172.

5.2. Психологічні особливості взаємодії у сімейному та родинному середовищі

*Гладченко В. А., Камардін О. М.,
Мурга С. В., Сиротін С. В., Стасюк Д. В.*

Актуальність. Сім'я є необхідним елементом соціальної структури людського суспільства, важливим інститутом соціалізації особистості. Негативні тенденції розвитку сучасної сім'ї (збільшення кількості розлучень за психологічними мотивами, зменшення народжуваності, рольове перевантаження молодого подружжя та ін.) викликають занепокоєння фахівців різних галузей науки, а також актуалізують практичні соціально-психологічні дослідження закономірностей функціонування сучасної сім'ї, ефективних форм і методів психологічної допомоги сучасному подружжю. Але поруч із проблемою психологічної корекції сімейних стосунків не менш актуальною постає проблема профілактики дисгармоній сімейного спілкування, виникнення та деструктивного розвитку сімейних конфліктів. Адже відомо, що можливих порушень легше запобігти, ніж їх усунути. Саме в контексті профілактики сімейних конфліктів спрямовано дослідження психологічних особливостей чоловіка і жінки, як важливого регулюючого компоненту міжособистісного спілкування.

Мета Комплексний аналіз психологічних особливостей взаємодії у сімейному та родинному середовищі.

Результати дослідження. Основою для формування сім'ї є шлюб, як прийнята суспільством форма стосунків між особами різної статі. З психологічного погляду під стабільністю шлюбу і сім'ї розуміються такі їх особливості, що забезпечують задоволеність людини від перебування в цих соціальних інститутах, створюючи умови для особистого щастя, особистісного зростання кожного з їх членів. Розрізняють шлюби з любові, за стереотипом, з розрахунку, залежно від особливостей шлюбно-сімейної мотивації. Мотивація взяття шлюбу включає чотири основних мотиви: інтимно-особистісний (прагнення знайти бажаного партнера для кохання); мораль-

но-психологічний (бажання знайти духовно близького супутника життя); сімейно-батьківський (орієнтація на народження і виховання дітей); господарсько-побутовий (орієнтація на налагоджений побут і ведення домашнього господарства). Ієрархія цих мотивів визначає критерії вибору шлюбних партнерів. Істотною підставою для взяття шлюбу є любов. Сучасна соціальна психологія виокремлює в любові три основних компоненти: емоційний (симпатія, часто неусвідомлена, інстинктивний потяг до людини, причини якого ще остаточно не з'ясовані); раціональний (повага, усвідомлення і визнання достоїнств людини); поведінський (уміння не тільки переживати почуття любові, а й у відповідний спосіб виявляти його в діяльності, спрямованій на отримання власної радості через радість іншої людини, у прагненні зменшити її страждання). Таким чином, здатність любити прямо залежить від уміння співпереживати, думати передусім не про себе, а про того, кого любиш.

На сучасному етапі сім'я і сімейне благополуччя знаходиться серед переліку цінностей людини і займає чільне місце. Проблема сімейних стосунків завжди привертала увагу філософів, соціологів, психологів, педагогів.

На думку багатьох дослідників (Ю. Є. Альошина, О. І. Бондарчук, А. Н. Волкова, С. В. Ковальов, Т. М. Трапезнікова, Л. Б. Шнейдер, та ін.), найбільш узагальнена класифікація сімейних ролей будується на функціональному принципі, і є такою: відповідальний за матеріальне забезпечення сім'ї. Така роль визначає комплекс обов'язків, пов'язаних із забезпеченням сім'ї необхідним рівнем добробуту; господар-господарка. Виконання цієї ролі передбачає організацію і ведення домашнього господарства; відповідальний за підтримку родинних зав'язків. Реалізація цієї ролі забезпечує організацію спілкування з родичами, участь у сімейних ритуалах і церемоніях; організація сімейної субкультури. Ця роль орієнтує на формування у членів сім'ї певних культурних цінностей, інтересів і захоплень; організатор розваг. Виконання цієї ролі припускає ініціацію й організацію життєдіяльності сім'ї у сфері дозвілля; сексуальний партнер. Ця роль пов'язана з проявом активності у сфері сексуальних стосунків; відповідальний за догляд за дитиною. Виконання цієї ролі передбачає забезпечення дитини фізичним і психічним комфортом у перші роки її життя; вихователь.

Ця роль передбачає розвиток особистості дитини; сімейний «психотерапевт». Ця роль включає дії, спрямовані на розв'язання особистісних проблем членів сім'ї.

Розподіл ролей у сім'ї може змінюватися залежно від обставин (народження дитини), особливостей професійної кар'єри тощо. Успіх сімейного життя пов'язується із спільністю орієнтацій подружжя на той чи інший тип сім'ї. Відповідно кожному типу сім'ї притаманне особливе уявлення про її функції; це уявлення зафіксовано у змісті подружніх сімейних ролей.

Розподіл моделей сім'ї на традиційні й егалітарні зумовлений функціонально-рольовим розподілом у сім'ї, а також розподілом сфер влади й відповідальності. Для традиційної моделі сім'ї характерна суворі статево-рольова диференціація сімейних ролей, тобто розподіл обов'язків шлюбних партнерів за статевою ознакою. У традиційній патріархальній сім'ї природним є верховенство чоловіка, яке виявляється в тому, що в його руках зосереджені економічні ресурси і прийняття основних рішень. На думку О. М. Здравомислової, традиційна сім'я організована так, щоб зберігати спосіб життя старшого покоління, повторити батьків у дітях.

Егалітарна модель сім'ї характеризується однаковим залученням шлюбних партнерів до реалізації сімейних ролей і обов'язків за умов, що кожен з них відповідає в основному за те, що більше відповідає його смакам і можливостям. Таким чином, рольовий розподіл у даній моделі сім'ї відбувається насамперед виходячи з особистісних уподобань і на основі взаємної домовленості подружжя, а не на основі статево-рольової диференціації. Деякі соціологічні дослідження (Е. Богардус, А. Кемпінський та ін.) свідчать про те, що сім'ї з егалітарною структурою стосунків – рівномірним і справедливим розподілом сімейної «влади» за різними сферами – є найбільш щасливими і стійкими. На думку В. І. Зацепіна, в егалітарній сім'ї розподіл домашніх обов'язків здійснюється демократично, залежно від того, у кого та чи інша робота виходить краще, а також виходячи з почуття відповідальності та обов'язку. Боротьба за владу звичайно не відбувається, тому що подружжя орієнтоване на інтереси сім'ї, має спільні цінності, а тому чоловік і дружина не прагнуть командувати один одним. Егалітарна сім'я

прагне взаєморозуміння, діалогу, на основі якого виникає новий, більш зрілий, хоча і більш складний, стиль подружніх стосунків.

Однак, саме свобода вибору егалітарної моделі дуже часто стає тим підводним каменем, на який наражається молодий «сімейний човен». На думку Т. А. Гурко, труднощі у взаєморозумінні молодого подружжя зумовлені насамперед тим, що в сучасній сім'ї зразки поведінки чоловіка і дружини стають менш жорсткими. Спостерігається відхід від регламентованих форм рольової взаємодії: стосунки в сім'ї, способи її організації дуже часто визначаються ситуацією і залежать від нахилів, можливостей і здатностей кожного з членів цієї спільноти. У минулому переважали традиційні зразки поведінки чоловіка-батька й жінки-матері, коли чоловік виконував роль голови сім'ї, її годувальника й носія соціального статусу, а жінка – берегинею домашнього вогнища. На сучасному етапі, через активне залучення в професійну і громадську діяльність, жінка нерідко має однаковий з чоловіком соціальний статус і заробіток, а тому на рівних беруть участь у прийнятті сімейних рішень. У той самий час у суспільстві існують уявлення про сімейні ролі й обов'язки подружжя, які недостатньо відповідають реальності: з одного боку, це рольові очікування, пов'язані з традиційною сім'єю, а з іншого – переконання про рівність чоловіка й жінки у виконанні більшості сімейних функцій.

Аналіз традиційної й егалітарної моделі функціонально-рольового розподілу в сім'ї нашоєхує на думку про те, що не слід вести мову про одно-значну перевагу однієї моделі над іншою, тим більше, що зміни характеру розподілу ролей у сім'ї в процесі сімейного циклу є природними і сприяють успішній адаптації сім'ї до нових життєвих ситуацій. Для успішного сімейного життя більш важливим є збіг уявлень про рольову поведінку й рольові очікування подружжя в контексті прийнятої моделі. Однією зі складових сімейно-рольової сумісності є узгодженість рольових уявлень про функції чоловіка та дружини, а також рольові очікування подружжя, їх власні рольові домагання. Рольові установки особистості виявляються в тому, які з родинних справ вона залишає під свою відповідальність, а які адресує своєму партнерові.

На сучасному етапі, за умов порушення традиційної системи сімейних ролей і відповідних їм культурних стереотипів, у біль-

шості сімей спостерігається невизначеність рольових очікувань, що викликає у шлюбних партнерів психологічний дискомфорт. На думку більшості дослідників, для оптимізації сімейного спілкування й попередження виникнення рольових конфліктів необхідно створювати умови для реалізації більш широкого діапазону сімейних ролей і зменшення їх протиріччя. Мова також іде про відповідність або невідповідність сімейних ролей можливостям особистості, що особливо виявляється при зміні сімейної структури.

На думку Г. Навайтіс, сучасна нуклеарна родина завдяки малій кількості її членів стикається з труднощами реалізації багатьох сімейних ролей, тому що кожен повинен виконувати декілька ролей, які, крім того, можуть бути досить суперечливі. Суперечливість ролей, дуже вузькі межі їх виконання не задовольняють потреб членів родини, що призводить до утискування цих потреб або до їх задоволення поза сім'єю. Крім того, сучасна нуклеарна родина створює умови для виникнення рольового конфлікту, сутність якого полягає в несумісності рольових очікувань та неможливості виконання суб'єктом, який займає певний статус, прийнятих ролей.

На думку багатьох дослідників, типовою проблемою рольової структури сучасної сім'ї, де обидва шлюбні партнери працюють, є рольова перевантаженість і дилема ідентичності працюючої жінки. Більшість сучасних досліджень зорієнтовані на соціально-економічні й соціологічні підходи до проблеми поєднання жіркою професійних і сімейних ролей. Соціально-психологічні дослідження рольового конфлікту працюючої жінки присвячені адекватним засобам виходу з конфліктних ситуацій. Причиною виникнення рольового конфлікту працюючої жінки як варіанта між рольового конфлікту є неможливість успішного виконання жіркою великої кількості ролей – сімейних і професійних – завдяки суперечливості вимог, що висуваються до жінки, і відсутністю необхідних фізичних ресурсів для повноцінного виконання цих ролей.

На сучасному етапі даний вид рольового конфлікту розглядається як психологічне явище, як комплекс негативних суб'єктивних переживань жінки, який виникає як наслідок сприйняття нею себе і власної моделі життя. Так, на думку більшості дослідників, рольовий конфлікт може бути зумовлений занадто високими вимогами й рольовими нормами, які встановлює для себе жінка, що може

бути викликане однаково високою значущістю для неї як сімейних, так і професійних ролей. Як фактори, які вносять найбільший внесок у суб'єктивне відчуття рольового конфлікту працюючої жінки, виділяють рівень суперечливості сімейних і професійних ролей.

Сімейні конфлікти є однієї з найпоширеніших форм конфліктів. По оцінках фахівців, у 80-85 % родин відбуваються конфлікти, а в інших 15-20 % виникають сварки по різних приводах. Унікальність сімейних відносин обумовлює не тільки специфіку виникнення і протікання конфліктів у родині, до й особливим образом відбивається на соціальному і психічному стані всіх її членів. У дійсній темі розглядаються особливості сімейних конфліктів, їхня класифікація, а також інші питання, що розкривають суть цього складного явища. Сімейні конфлікти — це протиборство між членами родини на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів. При аналізі причин сімейних конфліктів важливо враховувати соціальні фактори мікро- і макросередовища. До факторів мікросередовища варто віднести: погіршення матеріального становища родини; надмірну зайнятість одного чи обох з подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування чи подружжя інших членів родини; тривала відсутність житла; відсутність можливості улаштувати дітей у дитячу установу й ін. Особливості сімейних конфліктів виявляються в їхньому динаміку, а також у формах протікання. У цілому динаміка сімейних конфліктів характеризується класичними етапами (виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення конфліктної ситуації, відкрите протиборство, розвиток відкритого протиборства, дозвіл конфлікту й емоційне переживання конфлікту). Але такі конфлікти відрізняються підвищеною емоційністю, швидкістю протікання кожного з етапів, формами протиборства (докори, образа, сварка, сімейний скандал, порушення спілкування і т. п.), а також способами їхнього вирішення (примирення, досягнення згоди, притирання відносин на основі взаємних поступок, розвід і ін.). Істотною особливістю сімейних конфліктів є і те, що вони можуть мати важкі соціальні наслідки. Нерідко вони закінчуються трагічно. Дуже часто приводять до різних захворювань членів родини. Особливо важкі наслідки сімейні конфлікти мають для дітей.

Висновки. Узагальнюючі можна зазначити, що відповідність рольових очікувань одного шлюбного партнера рольовим дома-

ганням іншого визначаються як рольова адекватність подружжя. Оцінка подружжям рівня конфліктності в певній сфері сімейно-рольової взаємодії визначається в залежності від того, наскільки рольова поведінка шлюбного партнера співпадає з рольовими очікуваннями стосовно нього як виконавця певної сімейної ролі. За характером психологічної й ціннісно-орієнтаційної єдності розрізняються гармонійні і дисгармонійні сім'ї.

Література.

1. Алексеева М. І. Психологія сім'ї. В кн. : Психологія. Підручник. За ред. . Ю. І. Трофімова. – К. : Либідь. – 1999. Розд. VII. 3. – С. 544-551.
2. Максимова Н. Ю Сімейне консультування : навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 304 с
3. Психологія сім'ї : навч. посіб. / В. М. Поліщук, Н. М. Ульяна, С. А. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. М. Поліщука. – 2-ге вид., доповн. – Суми : Університет. кн., 2009. – 282 с.
4. Федоренко Р. П. Психологія молодшої сім'ї та сімейна криза : монографія / Р. П. Федоренко. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-т 2007. – 168 с.

5.3. Психологічні особливості тренувальної діяльності спортсменів-професіоналів у передзмагальний період

Гречко Ю. Л.

Актуальність. Трудова діяльність спортсменів-професіоналів пов'язана з постійними навантаженнями (як фізичного, так і психологічного характеру).

У даній статті розглядаються спортсмени з виду спорту «футбол». У регламентних документах міжнародних футбольних організацій вживається термін «player», тобто перекладається «гравець». Проте, Національним класифікатором України «Класифікатор професій» передбачена посада «Спортсмен-професіонал з певного виду спорту» (код КП 3475, випуск ДКХП 85) [1]. У свою чергу, регламентні і дисциплінарні документи Української асоціації футболу визначають термін «Футболіст-професіонал» і «Футболістка-професіоналка». У статті вживаються усі зазначені терміни [2].

Тема психологічних особливостей тренувальної діяльності футболістів-професіоналів і футболісток-професіоналок цікавить Громадську організацію «Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів (далі Асоціація), яка об'єднує понад півтори тисячі футболістів-професіоналів і футболісток-професіоналок України [3].

Асоціація, як спортивна структура, входить до Міжнародної федерації асоціацій професіональних футболістів (далі ФІФПРО), до якої входить близько шістдесяти тисяч футболістів-професіоналів і футболісток-професіоналок всього світу [3].

Одним із напрямів діяльності Асоціації є задоволення та захист законних трудових, соціально-економічних, спортивних, творчих, національно-культурних, інших спільних прав та інтересів своїх членів. Відповідно до Статуту футболісти і футболістки, які входять до Асоціації, мають право на консультації та допомогу з питань, пов'язаних з фізичним та психічним здоров'ям із залученням відповідних фахівців та спеціалістів [3].

Мета. Дослідити та проаналізувати психологічні особливості тренувальної діяльності футболістів і футболісток та представити результати емпіричного дослідження.

Результати дослідження. Психологія спорту вивчає психологічні особливості спортивної діяльності гравців-професіоналів.

Варто відмітити, що положеннями статті 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» визначено: «Професійний спорт – це комерційний напрям діяльності у спорті, пов’язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні. У професійному спорті діяльність спортсменів полягає у підготовці та участі у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів» [4].

Вивчення психологічних особливостей тренувальної діяльності професіональних футболістів і футболісток у передзмагальний період (враховуючи навантаження на тренуваннях) є важливою складовою у підготовці спортсменів спорту вищих досягнень.

До психологічних особливостей тренувальної діяльності футболіста/футболістки відноситься: формування впевненості гравця у власних силах, яка формується під впливом успішних і неуспішних результатів матчів, безпосередніх дій гравця чи грачині у матчі, сприйняття та розуміння ситуації (малюнку гри) під час матчу, логічне мислення під час футбольного матчу, раптове прийняття рішення по ситуації, що виникла по ходу гри, правильне розуміння завдання, яке поставлено перед гравцем, і шляхи та міркування вирішення, ставлення тренера до футболіста, рівень розвитку когнітивних здібностей (самоаналіз, планування, цілепокладання) [5].

Психологічні особливості проявляються при інтенсивній когнітивній і фізичній нарузі спортсмена-професіонала.

Психологічні особливості футболіста і футболістки під час підготовки до змагань (наприклад, перед кожної грою) продиктовано конкретними завданнями:

1) які ставить тренер як перед кожним футболістом, так і перед командою;

2) виконання як кожним футболістом, так і усією командою поставленого ігрового та змагального завдання.

До таких завдань відноситься: дослідження суперника з послідовним «розбором» ігор; вивчення «слабких» і «сильних» сторін ко-

манди суперника; вивчення кожного гравця, який відповідає за певну позицію на полі під час футбольного матчу; підготовка дій команди і кожного футболіста з урахуванням проаналізованих особливостей суперника; формування тренером адекватної самооцінки гравців для досягнення очікуваного та продуктивного результату гри; формування тренером разом із футболістами стану психологічної готовності до матчу(гри); аналіз і подолання негативних емоцій через певні помилки футболіста; напрацьована готовність до максимальної вольової і фізичної напруги під час змагання та використати її; вміння не сприймати негаразди і невдачі (пропущений гол) і далі виконувати завдання тренера під час матчу, тобто продовжувати гру і боротьбу [6].

Таким чином, психологічні особливості тренувальної діяльності гравця і гравчині залежить від правильності й точності виконання поставлених завдань під час тренування (у передзмагальний період) і впровадження їх (застосування, вмиле використання/застосування інструкцій/настанов тренера) безпосередньо під час футбольного матчу.

Підсумком психологічної підготовки футболіста і футболістки є стан психічної готовності, який повинен знайти свою реалізацію (вираження) в максимальному виконанні поставленого тренером завдання на гру, максимальній віддачі сил на гру, для досягнення командою найкращих (переможних) результатів у змаганнях.

Під час тренування важко виховати у гравця чи гравчині постійне прагнення напрацьовувати і вдосконалюватися, якщо у самого спортсмена не має розвитку саморозуміння і усвідомлення. У спортсменів у віці 17-20 років ще в процесі формування: психологічна, емоційна, когнітивна та поведінкові сфери, а також на фізіологічному рівні відбувається ще розвиток. Все це говорить, що спортсмени в такому віці ще не приймають відповідальних рішень (можливо навіть і під час футбольних змагань) [7]. У тренувальний період відбувається формування впевненості у собі безпосередньо спортсмена за допомогою постановки мети та способів її реалізації і досягнення під час участі у футбольному матчі. Для того, щоб гравець був упевнений у своїх силах і рівні своєї підготовки, мета повинна бути досяжною і реальною. Наприклад, метою може бути не тільки грати від оборони чи утримати нічийний результат із «сильною» командою, а й атакувати і перемогти [7].

Для аналізу психологічних особливостей професіональних спортсменів проведено анонімне анкетування «Ментальне здоров'я професіональних футболістів і футболісток під час війни». Метою дослідження було з'ясування впливу емоційного стану футболістів-професіоналів і футболісток на результати тренування під час війни.

У дослідженні взяли участь 88 футболістів із дев'яти професіональних клубів і 72 футболістки із шести професіональних клубів. Місцезнаходження клубів по всій території України:

- команди Української Прем'єр ліги – «Оболонь» Київ, «Ворскла» Полтава та «ЛНЗ» Черкаси,
- команди Професіональної футбольної ліг – перша ліга «Інгuleць» Петрове, «Вікторія» Суми та «Діназ» Вишгород;
- команди Професіональної футбольної ліги – друга ліга «Чайка» Петропавлівська Борщагівка; «Нива-В» Вінниця та «Тростянець» Тростянець;
- жіночі команди Вищої жіночої ліги: «Ворскла» Полтава, «Дніпро-1» Дніпро, «Колос» Ковалівка, «ЕМС-Поділля» Вінниця, «Житлобуд-1» Харків, «Ладомир» Володимир.

Перед футболістами/футболістками у анкеті поставлені десять запитань. Узагальнення наданих відповідей та порівняння результатів анкетування є досить цікавим. Привертає увагу те, що незважаючи на тяжкі події в країні, футболісти (71,6 %) і футболістки (88,7 %) мають перепади емоційного стану за період війни. Проте, більшість з них (71,6 % та 87,7 % відповідно) вважають, що *«трилоги не спинять бажання тренуватись і грати у футбол»*:

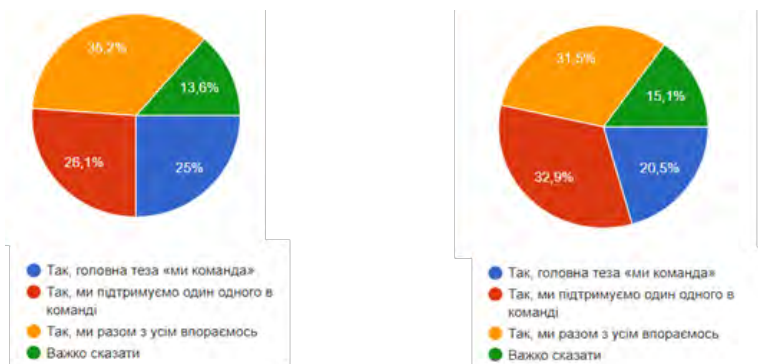


Рис. 1. Частота перепаду емоційного стану за період війни

До травматичних подій футболісти (54,5 %) і футболістки (43,8 %) відносять вибухи і повітряну тривогу, нажаль, близько 9,1 % втратили майно, близьких, роботу та 5,7 % (травми, загроза смерті). У стані неспокою як футболісти, так і футболістки намагаються відволікатись, планують повсякденні справи і покрокове їх виконання, займаються улюбленими справами, слухають музику, дихальними вправами, медитацією і навіть розвиваються як бізнесмени.

Якщо поглянути на результати відповідей, то стає очевидно, що для футболістів (42 %) і футболісток (44,4 %) «заняття футболом дає енергію» для відновлення після емоційного стану.

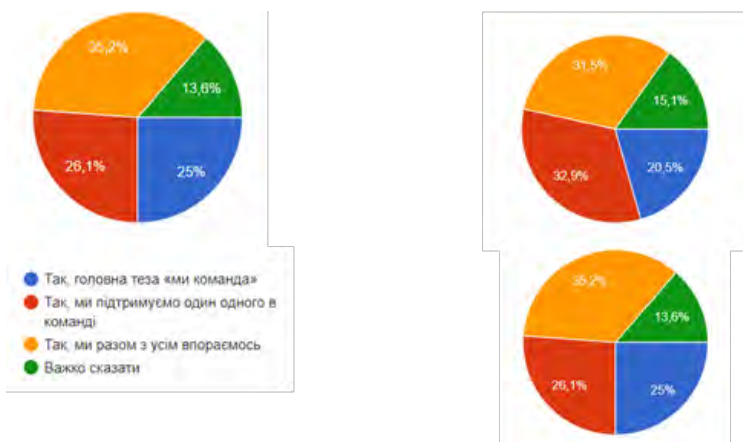


Рис. 2. Засоби відновлення після емоційного стану

Майже половина відсотків футболістів (50 %) і футболісток (49,3 %) відповіли, що «заняття футболом покращує настрій і зміцнює сон».

І також більшість футболістів (61,4 %) і футболісток (64,4 %) вважають, що страх, втома, «емоційні гойдалки» під час війни не впливають на ставлення до роботи, бо «заняття футболом знімає симптоми стресу».

Як видно із кругової діаграми, футболісти (55,7 %) і футболістки (60,3 %) підвищили свій рівень підготовки, майже 18 % не можуть відповісти, бо відчувають «емоційні гойдалки»; заняття футболом підвищує самооцінку у 26,1 % та у 23,3 % відповідно.

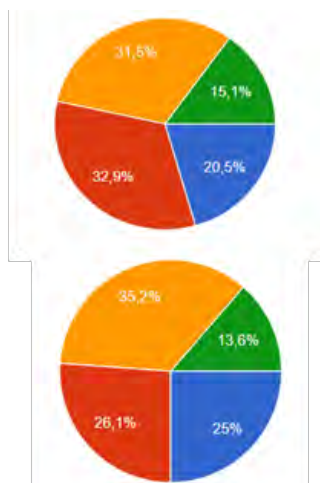


Рис. 3. Підвищення рівня підготовки, як професіонального футболіста протягом війни

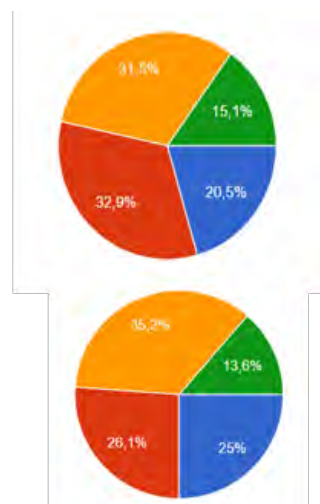


Рис. 4. Наявність під час війни атмосфери єднання та підтримки

На останнє запитання відсоток варіантів позитивних відповідей співпадають. Приємно, що «так, ми разом з усім впораємось» відповіли футболісти 35,2 % і футболістки 31,5 %; «так, ми підтримуємо один одного в команді» відповіли футболісти 26,1 %

і футболістки 32,9 %; «так, головна теза «ми команда» відповіли футболісти 25 % і футболістки 20,5 %.

Висновки. Для розуміння визначення спортивної діяльності професіональних футболістів/футболісток входять такі поняття: підготовка до змагань, тренування, індивідуальні показники (техніко-тактичні дії), наявність належної спортивна форма, тобто готовність до відповідних спортивних результатів (досягнень). Проте, суттєве місце у спортивній діяльності посідає психологія спортсменів. Тобто, психологічні властивості гравців, як характер і темперамент гравця, талант гравця, самооцінка (стійке ставлення до себе), потреби і мотиви під час заняття футболом, оточення (тренер та інші колеги по команді), входить до складової підготовки і тренувального процесу футболіста і футболістки. Психологічні особливості: мислення, міркування та розвиток, усвідомлення своєрідності спортивних завдань майбутнього футбольного матчу впливають на результат психологічної готовності і віддачі сил спортсмена для досягнення найкращих результатів у змаганнях.

Література.

1. Міністерство економіки України. /Класифікатор професій / [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. Режим доступу до ресурсу: <https://www.me.gov.ua/Profession/List?lang=uk-UA&id=d4162ef8-2771-4ac5-99ef-1d4b6f5336af&tag=KlasifikatorProfesii-Poshuk>.
2. Українська асоціація футболу. Регламент зі статусу і трансферу футболістів. Українська асоціація футболу. – 2021. – С. 14.
3. Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів. Статут [Електронний ресурс] / Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів. 2021. URL : <http://apfu.org.ua/wp-content/uploads/Statut-VAFP-2021.pdf>. С. 5–17.
4. Закон України »Про фізичну культуру і спорт» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 1993. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text>.
5. Cerin E. A processual analysis of basic emotions and sources of concerns as they are lived before and after a competition / E. Cerin, A. Barnett. // *Psychology of Sport and Exercise*. 2006. №7. С. 1–21.
6. Психологія фізичного виховання – Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павлі Тичини, 2013. 42 с.
7. Temporal patterning of competitive emotions: a critical review / E. Cerin, A. Szabo, C. Williams, N. Hunt. // *Journal of Sports Sciences*. 2000. №18. С. 605–626.

5.4. Використання методів арт-терапії у роботі з дітьми, хворими на епілепсію

Зашкольна О. П.

Актуальність. Близько 50 мільйонів людей в усьому світі живуть з епілепсією і щороку фіксується 2,4 млн нових випадків. В Україні налічується близько 100 тисяч людей з епілепсією. Епілепсія вважається одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються. Ці напади проявляються у вигляді короточасних мимовільних судом у якійсь із частин тіла або ж по всьому тілу [1]. Діти з епілепсією часто мають ознаки шкільної неуспішності та потребують спеціальної підтримки, яка враховує їхні психологічні та психофізіологічні особливості. Причинами цього можуть бути порушення психіки та поведінки, які мають високий рівень коморбідності з епілепсією – аутизм, специфічні затримки розвитку мовленнєвої функції, порушення поведінки, пізнавальних функцій, розлади з дефіцитом уваги та гіперактивністю, депресивність, тривожність тощо. Саме коморбідні психічні розлади, а не епілептичні напади, часто зумовлюють обмеження життєдіяльності. За наявності коморбідних порушень психіки та поведінки діти з епілепсією потребують фахового супроводу навіть у разі ремісії епілептичних нападів [2].

На сьогодні одним із найефективніших методів психологічної допомоги є арт-терапія. Її завдання – зануритися у глибини психіки і «дістати» звідти саме ту проблему, яка викликає неприємні спогади і негативно впливає на якість життя. Для пошуку глибинних аспектів важливим є невербальний спосіб вираження власного «Я». Арт-терапевтична робота ефективна на заняттях з дітьми, хворими на епілепсію, оскільки допомагає у пошуку ресурсів для зниження рівня тривоги і зменшення відчуття страху, сприяє зміні пригніченого настрою дитини на спокійний. Епілепсія є одним із найбільш важких захворювань нервової системи, яке відрізняється прогресивним характером перебігу, що розвивається на основі патогенетичних механізмів порушення нейромедіаторних систем, біоелектро-

генезу, синтезу та обміну макромолекулярних сполук [3]. Прояви захворювання зумовлюються незавершеністю процесів мієлінізації, підвищеною проникливістю церебральних судин, лабільністю та генералізацією збудження, нестійкістю обмінних процесів. Термін «арт-терапія» ввів у науковий обіг Адріан Хілл (1938) при описі своєї роботи в санаторіях із хворими на туберкульоз. Цей термін використовувався для позначення всіх видів занять мистецтвом, які проводилися в лікарнях і центрах психічного здоров'я. Арт-терапія – це спеціалізована форма психотерапії, заснована на мистецтві, насамперед образотворчій і творчій діяльності. Спочатку арт-терапія виникла в контексті теоретичних ідей З. Фрейда і К. Г. Юнга, а надалі набувала більш широкої концептуальної бази, включаючи гуманістичні моделі розвитку особистості К. Роджерса і А. Маслоу.

Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання. З погляду представника класичного психоаналізу, основним механізмом корекційного впливу в арт-терапії є механізм сублімації. На думку К. Г. Юнга, мистецтво (особливо легенди й міфи) й арт-терапія, яка використовує мистецтво, значно полегшують процес індивідуалізації саморозвитку особистості на основі встановлення зрілого балансу між несвідомим і свідомим Я. Найважливішою технікою арт-терапевтичної взаємодії тут є техніка активної уяви, спрямована на те, щоб зіштовхнути обличчям до обличчя свідоме й несвідоме і примирити їх за допомогою ефективної взаємодії. Не можна недооцінювати також безпосередній вплив на організм кольору, ліній і форми. У своїх працях Де Фере відкрив залежність швидкості кровообігу і сили мускульних скорочень від кольору й освітлення. Наприклад, у країнах каліграфічного письма (Китай, Японія) здавна для лікування нервових потрясінь застосовується малювання ієрогліфів. Науковці з'ясували, що при цьому людина повністю розслабляється і суттєво знижується частота її пульсу [4]. Арт-терапію як психологічний метод наразі досліджують багато вітчизняних науковців. Визначення теоретичної та практичної основи відображається у працях О. Л. Вознесенської, А. П. Чуприкова, В. В. Назаревич, В. Синиці, І. О. Борейчук, Л. Волкової, О. В. Карапетрової, О. С. Колпакчи О. В. Сороки, А. Гельбак, Т. Зінкевич-Євстігнєвої, О. Гарковець.

На думку І. С. Ільченко, арт-терапія – це динамічна система взаємодії між учасником (дитиною, дорослим), продуктом його

образотворчої творчої діяльності і арт-терапевтом (психологом) в арт-терапевтичному просторі [5]. На початкових етапах терапія мистецтвом відображала уявлення психоаналізу, відповідно до якого кінцевий продукт творчості пацієнта (щось намальоване олівцем, написане фарбами, виліплене чи сконструйоване) розцінюється як вираження неусвідомлюваних процесів, що відбуваються у його психіці [6].

Мета. Аналіз результатів ефективності методів арт-терапії у роботі із дітьми, хворими на епілепсію.

Результати дослідження. За основу покладено методи арт-терапії: пісочна терапія, ізотерапія, казкотерапія. Характеристики методів арт-терапії:

Пісочна терапія допомагає дитині на основі аналізу власного «Я» втілити різноманітні образи на піску. Це сприяє позбавленню негативних емоційних проявів, підвищенню рівня концентрації уваги, розвитку мислених процесів і покращенню пам'яті.

Ізотерапія – це робота з певними кольорами у процесі малювання. Використовуються різні інструменти: олівці, різноманітні фарби (гуаш, масляна, акрилова, акварельна), фломастери, крейда. Поверхня для малювання також може бути різноманітною: папір, скло, тканина, дерево. Завданням ізотерапії є виявлення внутрішнього стану через малювання, адже дитина може несвідоме виражати в різноманітних образах і елементах.

Казкотерапія – це використання казки як архетипічної метафори. Завданнями казкотерапії є: психодіагностика, психокорекція, психотерапія та психологічне консультування. Казкотерапія сприяє налагодженню зв'язків між дорослими і дітьми, оскільки у кожному дорослому живе «маленька дитина». Це дуже ефективний метод корекції різноманітних проблем дітей, який допомагає через казкові події показати ситуацію з іншого боку і запропонувати альтернативні моделі психологічної поведінки [7].

Обов'язковою умовою розвитку будь-якої форми епілепсії є формування патофізіологічного феномена – епілептичного вогнища і/чи епілептичної системи (група нейронів, здатних до самозбудження і поширення гіперсинхронних розрядів). До екзогенних чинників належать інфекції нервової системи, черепно-мозкові травми, інтоксикації, перинатальна патологія (особливо пологові травми, асфіксія).

Арт-терапевтична робота передбачає обов'язкову наявність анамнезу, а також інформації, чи приймає дитина медичні препарати і які саме, оскільки деякі з них (наприклад сибазон) можуть впливати на пізнавальні процеси. Важливо отримати цю інформацію до початку роботи з дитиною, щоб коригувати методи взаємодії з нею.

У дослідженні брали участь 8 дітей віком від 7 до 11 років з виявленою фокальною епілепсією. Було проведено ЄСГ. До і після завершення арт-терапевтичних вправ проводилася діагностика емоційного стану проєктивними методиками «Сходинки» і «Кактус».

При інтерпретації результатів арт-терапевтичної роботи робився акцент на образи, кольори, розміри та допоміжний матеріал.

Пісочну терапію обрали близько 80 % дітей з епілепсією. Це зумовлено тим, що тактильні подразники більш дієві у перенесенні емоцій.

При фокальних змінах, які виявляються унаслідок нейронного розряду, котрий виникає з певної обмеженої ділянки півкулі головного мозку, діти будують невеликі міста, гори, ями з водою. Були використані такі ігри на піску: «Незвичайні сліди», метою якої є розвиток тактильної чутливості; «Занурення рук у пісок», котра сприяє подоланню страхів; «Морський світ». Саме вода і пісок допомагають виявити головні деталі емоцій і думок, які проєктує дитина. Але згодом вона може руйнувати результати своєї творчості, повністю засипати їх піском чи залити водою. Зазвичай дитина з епілепсією проєктує свою хворобу у вигляді «страхітливих істот», яких украї важко перемогти. Потрібно зробити акцент на важливому моменті, який залежить від проявів нападів (денних або/і нічних): ці «страхітливі істоти» можуть нападати на жителів створеної країни. Підвищений рівень тривожності не дає дітям упевненості, що все закінчиться добре. Тому необхідно послідовно за допомогою арт-терапії знайти саме те, до чого прагне дитина. Під час пісочної терапії було запропоновано до роботи різноманітні фігурки людей, тварин, риб, рослини, паркани, камінці і навіть фігури казкових героїв. Лише 50 % дітей змогли побудувати пісочний світ, у якому вкрай обережно, але знайшли шляхи вирішення особистих проблем. Близько 65 % дітей виявили бажання обрати фігури представників тваринного та морського світу. Вони створювали африканські сафари, міські та замські зоопарки, підводний світ морів або маленьких струмочків.

Майже 100,0 % дітей повністю занурювались в обраний образ, що ставало джерелом позитивних емоцій і припливу сил.

Ізотерапія допомогла надалі інтерпретувати прояв почуттів і думок на малюнку. Дитина могла поринути в минуле, виявитися в сьогоденні або перенестися в майбутнє. Використана тематика «Моя родина», «Мій настрій», «Малюнок про мене» дала основу емоційного стану дітей хворих на епілепсію. Аналіз роботи засвідчує, що 90 % дітей виявляють високий рівень зацікавленості малюванням саме пальцями рук, на яких є фарба. Така діяльність корегує пізнавальні процеси, стимулює розвиток сприймання і сенсорних властивостей, позитивно впливає на мотиваційну сферу. Однак цей метод не підійшов близько 10 % дітей із РАС, для котрих обов'язковою умовою є наявність чистих рук.

Не можна залишити поза увагою психологію кольорів, адже вона тісно пов'язана з емоційним станом досліджуваних.

Значення кольорів: білий – чутливість, тяжіння до роздумів, замкненість; жовтий – оптимізм, багата фантазія; синій – потреба у спокої, послідовності, порядку; зелений – урівноваженість, незалежність, наполегливість; червоний – колір суперечливості: з одного боку, гнів, роздратування, з іншого – сила, лідерські якості; чорний – протест, агресія, можливий стрес.

Близько 40 % дітей молодшого шкільного віку відмовлялися від малювання яскравими кольорами. Але після кількох занять кількість цих дітей зменшилася до 7 %, що засвідчує позитивний вплив різноманітних кольорів на корекцію емоційного стану дитини. Майже 90 % дітей розташовували образ у лівій частині аркуша, що може свідчити про події, які відбувалися в минулому. Діти обирали переважно тему родини і людські фігури на протигагу пісочній терапії, де більшість обирала фігури представників тваринного та морського світу.

Казкотерапія дає можливість дітям уявити себе на місці головних героїв творів і стати лицарем, королем або королевою, щоб надалі подолати труднощі, які траплялися на шляху. Було цікаво ознайомитися з першою українською збіркою оповідань із терапевтичним ефектом для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Таємні історії маленьких і великих перемог», написаною дитячою письменницею Тетяною Стус. Майже 80 % дітей молодшого шкільного віку обрали для себе нові способи вирішення конфліктних ситуацій. Головним для 100 % було те, що кожен міг завдяки терапевтичній казці отримати те, чого саме йому бракує у повсяк-

денному житті. Для більш вираженого ефекту можна поєднувати казкотерапію й ізотерапію або пісочну терапію для побудови і перенесення сюжету казки. Майже 100 % дітей із задоволенням продовжили втілювати мотиви й образи казки на малюнку або піску.

Висновки. Результати аналізу арт-терапевтичної роботи з дітьми, хворими на епілепсію, свідчать про позитивну динаміку корекції їх психологічного стану. На початку роботи було діагностовано труднощі у спілкуванні дітей з оточуючими, наявність емоційних проблем. Початкова діагностика самооцінки (методика «Сходинки») показала низький рівень уявлення дитини про себе, тоді як після завершення арт-терапевтичних вправ рівень самооцінки дитини зріс до вищого за середній. Початкова діагностика за допомогою проєктивної методики «Кактус» виявила дещо підвищений рівень тривожності, який виявлявся у переривчастих лініях, сильному натисканні, однак після завершення арт-терапевтичної роботи методика «Кактус» засвідчила оптимістичні прояви у вигляді усмішки, додаткових деталей (капельок, бантик) та в яскравих кольорах загального малюнка. Подальший аналіз отриманих результатів допоможе виробити загальне уявлення про вплив основних методів арт-терапії на психологічний стан дитини.

Література.

1. Що треба знати про епілепсію і як надати першу допомогу. Міністерство охорони здоров'я України. URL: <https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-epilepsiju-i-jak-nadati-pershudopomogu>
2. Колупаєва А., Мартинюк В. Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні: «Особлива дитина: навчання і виховання», № 3, 2015 – с. 35.
3. Муратова Т. Н. Якість життя хворих на епілепсію в різних умовах фармакотерапії. Досягнення біології та медицини. 2014. – № 2. – С. 41–47.
4. Тертель А. Л. Психологія. Курс лекцій: навч. посіб. 2006. – 248 с.
5. Ільченко І. С. Арт-терапія: навч. посіб. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. 150 с.
6. Вознесенська О. Особливості арт-терапії як методу. Психолог. 2005. №10. С. 5–8.
7. Магдисюк Л. І., Федоренко Р. П., Замелюк М. І. Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 152 с.

5.5. Формування стресостійкості особистості

Коротков В. С.

Актуальність Стрес є неодмінною частиною життя кожної людини та представляє собою фізіологічну та психологічну реакцію на надмірне фізичне або емоційне навантаження. Відомий як важливий елемент виживання, стрес стає проблемою, коли його інтенсивність або тривалість перевищують здатність організму адаптуватися.

Фізіологічна сторона стресу включає вивільнення гормонів, таких як адреналін та кортизол, що готують організм до стану «бій або втеча». Ця реакція має еволюційні корені та була корисною для наших предків у ситуаціях небезпеки. Однак, в сучасному світі, де стресові ситуації можуть виникати не лише від фізичних загроз, але й від соціальних та робочих аспектів, довготривалий стрес може впливати на здоров'я.

Психологічна сторона стресу пов'язана із сприйняттям та реакцією на події. Один і той же події можуть впливати на різних людей по-різному, залежно від їхнього ставлення та резервів стресостійкості. Негативний стрес може викликати різні психічні та емоційні реакції, включаючи тривожність, депресію та виражений втомленість.

Вплив стресу на організм може виявитися різноманітним, включаючи проблеми зі сном, зміни в апетиті, погіршення концентрації та проблеми зі здоров'ям серця. Тривалий стрес може призвести до більш серйозних проблем, таких як хронічні захворювання, високий кров'яний тиск, та інші захворювання, які впливають на загальний стан здоров'я.

Важливо підкреслити, що стрес є невід'ємною складовою сучасного життя, і ключ до забезпечення свого здоров'я полягає в тому, як реагувати на та як керувати ним. Одним із ефективних методів управління стресом є розвиток стресостійкості – властивості особистості, яка дозволяє ефективно адаптуватися до негативних ситуацій та залишатися емоційно стійким.

Стресостійкість слід розглядати як не лише в контексті визначення її змісту та оцінки, але і в рамках її формування – розвитку

на різних етапах життєвого шляху особистості. Це дозволяє визначити фактори, які впливають на опанування людиною складнощів життя. Важливими елементами є індивідуальний досвід, суб'єктна активність, стійкі ознаки емоційності в структурі індивідуальності та інші чинники, які визначають роль стресостійкості в оптимальному функціонуванні особистості [1].

Стресостійкість не є вродженою якістю, але вона може бути розвиненою та удосконаленою через специфічні психологічні стратегії та практики. Перше, що варто врахувати, – це свідоме управління емоціями. Навчання розпізнавати та реагувати на емоції дозволяє краще контролювати стресові ситуації.

Позитивне мислення також грає важливу роль у формуванні стресостійкості. Здатність шукати позитиви в навколишньому середовищі та знаходити рішення в трудних ситуаціях допомагає знижувати рівень стресу.

Гнучкість та адаптивність – ще дві ключові складові стресостійкості. Здатність адаптуватися до змін, а не реагувати на них зі страхом, дозволяє краще справлятися з непередбачуваними обставинами.

Стрес можна розподілити на дві категорії: груповий та індивідуальний. Груповий стрес виникає у випадках, коли відбувається який-небудь негативний вплив, такий як війна, голод, терористичний акт або природний катаклізм, які впливають на значну кількість людей. При груповому стресі може виникати емоційне зараження, яке посилює вплив стресу. Індивідуальний стрес виникає, коли окрема особа переживає вплив подразника, який може не впливати на інших [1].

Важливим елементом стресостійкості є здатність до саморегуляції, яка включає в себе навички релаксації та медитації. Ці практики допомагають зберегти внутрішню рівновагу та зменшити негативні впливи стресових факторів на організм.

Розглядаючи стрес як не лише виклик, але і можливість для особистісного зростання, ми робимо перехід до стресостійкості – навички, яка стає керованою та розвивається з метою забезпечення нашого емоційного благополуччя в умовах невизначеності та напруженості.

Актуальність дослідження стресостійкості в умовах війни в Україні є невід'ємною, оскільки сучасні реалії світових конфліктів ставлять перед особистістю несприятливі умови і вимагають

високого рівня адаптації та стійкості до стресових викликів. Відповідно до інформації від Міністерства охорони здоров'я, вплив воєнних подій на наше психічне здоров'я буде відчутним щонайменше протягом 7-10 років після завершення війни [6].

Збереження психічного здоров'я в умовах воєнного конфлікту стає стратегічно важливим завданням для військовослужбовців, цивільного населення та всієї суспільності. Проведення дослідження на тему стресостійкості в контексті війни в Україні дозволить не лише краще зрозуміти психологічні аспекти подібних умов, але і розробити ефективні методики та стратегії для підтримання та підвищення рівня стресостійкості українців. Це також актуалізує питання соціокультурного впливу воєнних подій на психічне здоров'я, враховуючи унікальні особливості українського суспільства та його стійкість у непередбачуваних ситуаціях.

Вчені проводили аналіз стресостійкості як складної інтегративної характеристики особистості (Боднар А. Я.); досліджували особливості її формування на різних етапах вікового розвитку (Картенсен Л., Мозговий В. І., Полякова О. Н.); визначали копінг як сукупність когнітивних, емоційних і поведінкових стратегій, спрямованих на адаптацію до стресових ситуацій (Родіна Н. В.). Такі дослідження можуть внести важливий вклад у психологічну підготовку та розвиток стратегій психологічної допомоги для тих, хто переживає війну та конфліктні умови в Україні.

Мета. Теоретичне обґрунтування психологічних особливостей формування стресостійкості.

Результати дослідження. Стресостійкість є складною та інтегративною властивістю особистості, що визначає її здатність ефективно протистояти та адаптуватися до стресових ситуацій. Це поняття включає в себе ряд факторів, таких як психологічна стійкість, здатність до саморегуляції, адаптивні когнітивні та емоційні стратегії, які дозволяють особистості ефективно функціонувати та зберігати емоційний баланс у негативних чи викликових умовах. Стресостійкість вимірюється не лише здатністю витримувати тиск та труднощі, але й здатністю відновлюватися та пристосовуватися після стресового впливу, підтримуючи оптимальний функціональний стан особистості в довгостроковій перспективі. У структурі стресостійкості особистості, психологи виділяють емоційний, вольовий, інтелектуальний, мотива-

ційний, комунікативний, операційний та інші компоненти. Причому всі компоненти стресостійкості як психічної стійкості знаходяться в певному взаємозв'язку, можлива компенсація невиразності одних за рахунок більшої розвиненості інших [8].

Роль стресостійкості в житті особистості надзвичайно важлива, оскільки ця властивість визначає її здатність ефективно впоратися з труднощами та стресовими ситуаціями. Стресостійкість є своєрідним адаптаційним механізмом, який дозволяє особистості зберігати емоційний баланс, забезпечуючи стійкість та життєздатність в умовах викликів і невизначеності.

Одним з ключових аспектів ролі стресостійкості є здатність особистості пристосовуватися до нових умов, швидко реагувати на зміни та зберігати психічне здоров'я під час негативних впливів. Особа з високим рівнем стресостійкості може ефективно вирішувати проблеми, не втрачаючи продуктивності та емоційного благополуччя. Крім того, стресостійкість впливає на розвиток особистісних якостей, таких як саморегуляція, внутрішня міць, позитивний погляд на життя та відчуття власної компетентності.

Люди з розвинутою стресостійкістю частіше проявляють гнучкість у мисленні, легше адаптуються до нових ситуацій та зберігають внутрішню рівновагу під час труднощів. Цей процес характеризується особистісним розвитком, і, за словами Т. М. Титаренко, є «самоконституванням», вираженою потребою особистості у самопрезентації і самоосмисленні. Особистість рефлексує щодо власного життя і виявляє можливість задоволення цієї потреби в конкретних життєвих обставинах» [2].

У житті особистості стресостійкість може визначати успіх в професійній кар'єрі, стабільність в міжособистісних відносинах та здатність до самореалізації. Враховуючи виклики сучасного світу, де непередбачуваність та зміни стали нормою, розвиток стресостійкості стає актуальним завданням для кожної особистості.

Методи дослідження стресостійкості. Когнітивні тести. Включають в себе різноманітні завдання, які оцінюють когнітивні функції, такі як увага, концентрація, пам'ять та реакційна швидкість. Ці тести можуть бути проведені до та після стресового впливу для визначення змін у когнітивних функціях.

Функціональний магнітно-резонансний томограф (фМРТ). Дозволяє вивчати активність різних частин мозку під час виконання завдань. Цей метод може виявити зміни в активності мозку, пов'язані зі стресом.

Електроенцефалографія (ЕЕГ). Фіксує електричну активність мозку. Зміни в ЕЕГ можуть вказувати на зміни в когнітивних процесах, пов'язаних із стресом.

Тести на виконавчі функції. Включають в себе завдання, які оцінюють здатність до планування, прийняття рішень та інші аспекти виконавчої функції, які можуть бути важливими під час стресу.

Оцінка реакції на стрес. Проведення експериментів або спостереження, щоб визначити, як особа реагує на стресори та як це впливає на її когнітивні функції.

Завдання з вирішення проблем та творчість. Оцінюють здатність особи до вирішення проблем та генерації творчих ідей під впливом стресу.

Ці методи можуть застосовуватися окремо або в поєднанні для комплексного аналізу стресостійкості та її впливу на когнітивні процеси.

Фактори, що впливають на формування стресостійкості. Існує низка факторів, які впливають на формування стресостійкості у людей. Ось кілька ключових аспектів:

Соціальне оточення. Розвиток стресостійкості часто пов'язаний із соціальним середовищем. Сприятливі взаємини з родиною, друзями та колегами можуть створити оптимальні умови для подолання стресу.

Самооцінка та самоприйняття: Люди, які мають реалістичну самооцінку та позитивне ставлення до себе, зазвичай краще справляються із стресом. При вивченні особистісних характеристик, які можуть впливати на стресостійкість, багатьма дослідниками наголошується на значущості оцінки власної особистості. Самооцінка, що є чинником, пов'язаним із процесами соціальної адаптації та дезадаптації особистості, представляє собою особистісну рису, яка сприяє підвищенню стійкості до стресу в умовах збільшеної напруги [3].

Емоційна інтелектуальність: Здатність розпізнавати, розуміти та ефективно керувати власними емоціями, а також емоціями інших, може сприяти розвитку стресостійкості.

Адаптивні стратегії копінгу: Люди, які використовують конструктивні стратегії для подолання стресу (наприклад, проблемне вирішення, прийняття ситуації), мають більше шансів на формування стресостійкості.

Фізичне здоров'я. Здоровий спосіб життя, включаючи регулярну фізичну активність та збалансоване харчування, може підвищити опір організму до стресових факторів. Використання фізичних вправ є одним із ефективних методів для розвитку стресостійкості та негайного подолання стресу, за висновками численних вчених. Фізичні навантаження поліпшують здатність організму використовувати кисень та забезпечують належний кровообіг, стимулюють вироблення ендорфінів, сприяють удосконаленню роботи дихальної системи [4].

Досвід інтеракції зі стресом. Попередні взаємодії зі стресовими ситуаціями можуть навчити людину ефективним методам подолання та формування стресостійкості.

Підтримка оточуючих. Підтримка від родини, друзів та оточуючих важлива для побудови стресостійкого життя. Ця підтримка може включати як емоційну, так і практичну допомогу. Тому суспільство, яке включає наше сімейне оточення, друзів, колег та навіть незнайомих людей, суттєво впливає на психічне здоров'я. Невідповідність встановленим нормам, негативні умови навколишнього середовища та вихована занедбаність можуть викликати різні прояви неадекватної поведінки, що має негативний вплив на психічний стан людини [5].

Тренування в навичках управління часом. Ефективне управління часом може допомогти знизити рівень стресу та покращити загальну стресостійкість.

Практичний аспект формування стресостійкості. Формування стресостійкості включає в себе практичний аспект, який орієнтований на розвиток конкретних навичок та стратегій. Приклад практичних аспектів, які можуть допомогти в цьому процесі:

- тренування управління стресом. Розвиток навичок ефективного управління стресом включає в себе вивчення та практику таких методів, як глибоке дихання, медитація, релаксація. Успішність соціально-психологічної адаптації особистості в умовах кризи та складних обставин життя залежить від особистісних ресурсів, які визначаються здатністю до розробки інтегрованої поведінки. Чим вище ця здат-

ність, тим ефективніше може бути подолання стресогенних ситуацій. «Виходячи з того, що в основі психологічного стресу лежить пізнавальна оцінка загрози наявних можливостей, для подолання стресу необхідна опора на психічні та особистісні особливості, відтворення позитивного минулого досвіду суб'єкта» [7].

- самоаналіз стресових ситуацій. Усвідомлення та аналіз стресових ситуацій може допомогти розуміти їхній вплив та розробляти ефективні стратегії подолання.

- планування та управління часом. Навички ефективного планування можуть зменшити відчуття тиску та стресу, забезпечуючи більшу організацію та контроль над ситуацією.

- фізична активність. Регулярна фізична активність допомагає знижувати рівень стресу, сприяє виробленню ендорфінів та покращує загальний стан психічного здоров'я.

- розвиток емоційної інтелектуальності. Вміння розпізнавати та ефективно керувати власними емоціями, а також розуміти емоції інших, грає важливу роль у стресостійкості. Л. Секей надав важливість ролі емоцій у мисленнєвій діяльності, вважаючи їх ключовим елементом. За його думкою, емоції займають проміжне положення між розумінням завдання та його першим планом втілення. В раціонально-емотивній терапії Е. Елліса також розглядається взаємозв'язок між емоціями та мисленням людини. Цей підхід базується на вивченні емоцій шляхом логічного аналізу та розгляду через розумові процеси [9].

- тренування вирішення проблем. Оволодіння навичками вирішення проблем та прийняття конструктивних рішень допомагає зменшити вплив стресу на рівень функціонування.

- соціальна підтримка. Взаємодія з різними людьми, зокрема з друзями, родиною чи колегами, може служити як ефективний ресурс для подолання стресу та зміцнення стресостійкості.

Висновки. Розглянуто методи дослідження стресостійкості, такі як когнітивні тести, тести на виконавчі функції, оцінка реакції на стрес, та завдання на вирішення проблем. Розглянуто фактори, що впливають на формування стресостійкості, такі як соціальне оточення, самооцінка, емоційна інтелектуальність, стратегії копінгу, фізичне здоров'я, досвід інтеракції зі стресом, та підтримка оточуючих. У ході аналізу підтверджено важливість дослідження стресостійко-

сті в умовах воєнного конфлікту в Україні. Сучасні реалії світових конфліктів створюють несприятливі умови для особистості, вимагаючи високого рівня адаптації та стійкості до стресових викликів. Вплив воєнних подій на психічне здоров'я, як показує інформація від Міністерства охорони здоров'я, залишає відчутний слід щонайменше протягом 7-10 років після завершення конфлікту.

Зазначено, що збереження психічного здоров'я в умовах військового конфлікту стає стратегічно важливим завданням для військовослужбовців, цивільного населення та суспільства в цілому. Дослідження стресостійкості в контексті війни в Україні має на меті не лише розуміння психологічних аспектів подібних умов, але і розробку ефективних методик та стратегій для підтримання та підвищення рівня стресостійкості українців. Таке дослідження акцентує увагу на соціокультурному впливі воєнних подій на психічне здоров'я, враховуючи унікальні особливості українського суспільства та його стійкість у непередбачуваних ситуаціях.

На основі проведених досліджень визначено, що стресостійкість є складною інтегративною властивістю особистості, яка включає в себе ряд компонентів, таких як психологічна стійкість, здатність до саморегуляції, адаптивні когнітивні та емоційні стратегії. Роль стресостійкості визначається не лише здатністю витримувати тиск та труднощі, але і здатністю відновлюватися та пристосовуватися після стресового впливу.

Дослідження проведено в різних напрямках, зокрема аналіз стресостійкості як складної характеристики особистості, дослідження її формування на різних етапах вікового розвитку, а також вивчення копіngu як стратегій адаптації до стресових ситуацій. Отримані результати можуть внести вагомий вклад у психологічну підготовку та розвиток стратегій психологічної допомоги для тих, хто переживає війну та конфліктні умови в Україні.

Проблематика полягає в тому, що військовий конфлікт негативно впливає на психічне здоров'я особистості протягом тривалого періоду після його завершення. Важливість збереження та підтримання психічного здоров'я стає визначальною для військовослужбовців, цивільного населення та суспільства в цілому. Зокрема, українці перебувають під впливом непередбачуваних стресових ситуацій, які виникають через воєнні події.

Проблематика також полягає в тому, що необхідно розробити та впровадити ефективні методики та стратегії для підтримання та підвищення рівня стресостійкості українців. Акцент на соціокультурному впливі воєнних подій на психічне здоров'я дозволяє враховувати унікальні особливості українського суспільства та його стійкість у непередбачуваних обставинах.

З метою подальшого розвитку цього напрямку досліджень пропонуються кілька перспективних шляхів:

1. Глибше дослідження механізмів стресового реагування. Розкриття більш детального розуміння внутрішніх механізмів реагування на стрес дозволить ефективніше розробляти стратегії психологічної підтримки та реабілітації.

2. Адаптація методик для різних груп населення. Розробка і адаптація методик формування стресостійкості для різних груп, включаючи військовослужбовців, цивільне населення та дітей, має велике значення для широкого впровадження практичних рекомендацій.

3. Створення програм психологічної підтримки. Розробка та впровадження спеціалізованих програм психологічної підтримки для тих, хто переживає війну, може сприяти покращенню психічного здоров'я та загальної стресостійкості населення.

4. Розвиток методів психологічної реабілітації. Розробка і вдосконалення методів психологічної реабілітації для тих, хто пережив воєнні події, є важливим аспектом подальших досліджень у сфері стресостійкості.

Ці перспективи можуть сприяти розвитку практичних інструментів та програм, спрямованих на поліпшення психічного здоров'я та стресостійкості населення України в умовах воєнного конфлікту.

Література.

1. Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : монографія / В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 432 с.

2. Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування. Перша частина. Київ : Главник, 2007. –106 с.

3. Шаран Ю. В. Психофізіологічні детермінанти стресостійкості особистості / Ю. В. Шаран // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія.

4. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : ДП «Інформаційно аналітичне агенство», 2007. – Вип. 7. – С. 143–148.

5. Богданов С. Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації: методичний посібник для педагогів / С. Богданов, О. Залеська. – К. : Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всеукраїнський союз молодіжних громадських організацій, «Християнська асоціація молодих людей України» (УМСА України), 2015. – 76 с.

6. Загальна теорія здоров'я та здоров'я збереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

7. Психологія стресостійкості студентської молоді / за заг. ред. В. Шмаргуна. Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2018. 198 с.

8. Rotter J. B. Cognates of personal control: Locus of control, selfefficacy and explanatory style : Comment. *Applied and Preventive Psychology*. 1992. P. 127–129.

9. Панасюк А. М. (2005) Навчальний стрес та чинники його виникнення. Актуальні проблеми психології. Т. 1. 4–14 с.

10. Колісник Л. О. (2013). Проблема емоційного інтелекту в історії розвитку філософсько-психологічної думки. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, (42), 82-90.

5.6. Вплив зовнішніх факторів стресу на підвищення кількості захворювань розладами харчової поведінки

Кабанова М. В.

Актуальність. Дослідження французьких науковців, опубліковане в Американському журналі клінічної нутриціології (The American Journal of Clinical Nutrition), надає статистичні данні, згідно з якими з 2000 по 2018 роки кількість осіб із порушеннями харчової поведінки (ПХП) у світі зросла з 3,4 % до 7,8 % [8]. У доступній нам літературі не було знайдено новіших даних щодо поширення ПХП у глобальному масштабі. Проте, в одному з досліджень впливу COVID-19 на стан пацієнтів з нервовою анорексією показано, що захворюваність на нервову анорексію під час пандемії збільшилась на 15,2 %. Водночас зафіксовано збільшення кількості симптомів у осіб, хворих на розлади харчової поведінки [9]. У стресовій ситуації абсолютно природньою є наявність певної реакції особистості на змінені умови життя. Кожна людина реагуватиме індивідуально, відповідно до своїх особистісних особливостей, використовуючи певні моделі реагування та копінг-стратегій. Для одних це будуть конструктивні патерни, що допомагатимуть якнайшвидше знайти оптимальний тип реагування, проте існують і деструктивні моделі поведінки. Взаємозв'язок розладів харчової поведінки зі стресом полягає у схильності до певних змін у харчуванні при впливі дистресу та еустресу. Певна група людей буде переважно підвищувати рівень споживання харчових продуктів, у той час, як інша буде схильна до часткової чи повної відмови від них [1].

Враховуючи, що розлади харчової поведінки являють собою психічні порушення пов'язані зі споживанням їжі, та спричинені сукупністю соціальних, психологічних та психічних чинників, вважаємо, що проблематика їх розвитку є актуальною. З урахуванням підвищеної кількості надзвичайних ситуацій (таких як пандемія, війна), їх стресогенністю та пролонгованістю, можемо припустити, що розлади харчової поведінки можуть зустрічатись частіше.

Мета. Дослідження розладів харчової поведінки на фоні впливу зовнішніх чинників (стресу).

Результати дослідження. Наразі нами було виявлено декілька досліджень взаємозв'язку стресу та розладів харчової поведінки. Групою дослідників було залучено 45 студентів медичного університету для проходження анкетування «SCOFF» для виявлення можливої наявності розладів харчової поведінки. Відповідно до результатів, було виявлено, що 2,2 % мали високий ризик наявності розладів харчової поведінки, а 48,8 % були у групі ризику. Дослідниками було висунуте припущення, що через вплив війни та стресу, що її супроводжує, більша кількість відповідей була із вірогідністю наявності розладів харчової поведінки. Вказуючи, що їжа використовувалася для подолання наслідків впливу травматичних подій [2]. Результати іншого збору даних дослідження, проведеного на групі осіб у кількості 30 чоловік різної вікової та статевих груп, вказують на те, що 70 % опитуваних мали зміни у харчуванні від початку повномасштабного вторгнення. Із них порівну поділилась кількість респондентів, відчувших посилення, чи пригуплення апетиту (майже по 43 %). Крім того, зазначалося, що рештою опитуваних було відмічено сильні перепади у споживанні їжі. Кількість симптомів розладів харчової поведінки була виявлена майже у 93,4 % опитуваних, та проявлялася вона у вигляді obsесивної поведінки відносно харчування та самосприйняття (підрахунок калорій, обмеження у прийому їжі по часу, контролю ваги, критичне ставленні до себе), і тільки 6,6 % не відмічали жодних змін у харчуванні [4].

Згідно з результатів вільного опитування 100 осіб, було виявлено, що 68,0 % опитуваних зазначили зміни у своєму харчуванні від початку повномасштабного вторгнення. На 12,0 % збільшилась кількість переїдань. З 20 % до 60 % зросла кількість респондентів, котрі помітили відсутність апетиту та небажання приймати їжу на фоні пригніченого стану, через травматичні події війни. Кількість осіб із поміченими проявами симптомів розладів харчової поведінки до війни склала 44 % загальної кількості опитуваних. Із них 59 % відчувало посилення чи поновлення симптомів [5].

Для наведення фактів, що підтверджують нашу гіпотезу, нами було використано результати дослідження рівню стресу населення України під час війни Прядько В. В. та Сомової О. О. Науковцями було застосовано метод опитування методикою «шкала пси-

хологічного стресу PSM 25 Лемура Тесье-Філліона» (в адаптації Н. Є. Водоп'янової). В опитуванні прийняли участь 124 особи різного віку та статі. Виявлено, що 54 % респондентів, відповідно до результатів, мали середній рівень стресу, а 9,7 % – високий. При цьому, жінки були більш підвладні впливу стресу, а чоловіки відзначалися більшою стійкістю до нього. 63,7 % відчували підвищену дратівливість, та той самий відсоток проблеми зі сном. 64,5 % відчували проблеми із апетитом. Було зазначено, що відповідно до рівня стресу посилювалися симптоми його впливу [3]. Таким чином, нами виявлено, що рівень стресу українців проживаючих на території України, та за її межами, від початку повномасштабного вторгнення, значно підвищився, чим підтверджуємо наявність масовості впливу стресу на людей. Згідно із наявних фактів наведених вище, можемо припустити, що через вплив глобального стресу на людство та українців зокрема, існує вірогідність підвищення рівня розвитку розладів харчової поведінки у осіб. Особливою групою ризику становлять підлітки, адже вони ще знаходяться у залежності від батьків, та їх впливу. До того ж саме у підлітковому віці відзначаються перші прояви розладів харчової поведінки.

COVID-19 обмежив свободу людей, посилив побоювання відносно власного життя, змінив життя суспільства. Пандемія стала великим фактором травмуючого стресу, що вплинув на життя та здоров'я людей. Для надання прикладу впливу екстремальної ситуації на психічний стан людини, ми наведемо декілька досліджень впливу пандемії на психічне здоров'я людини, деякі з них показують обмежування кількості копінг стратегій для регулювання емоцій [6]. Ми схилиємося до думки, що такі ситуації можуть впливати на харчові вподобання особистості, та під тиском інших особистісних та соціальних факторів, гіпотетично, можуть провокувати підвищення кількості захворювань розладами харчової поведінки. Додатково зазначимо, що 70 % осіб із встановленим діагнозом нервова анорексія мали погіршення симптомів захворювання під час пандемії, а загальна кількість нових випадків захворювань збільшилась, у порівнянні з попередніми роками. У пацієнтів з анорексією відзначалась присутність емоційного стресу, занепокоєння, відчуття втрати контролю, підвищення кількості обмежувальної моделі харчування та інше [9]. Ми вважаємо що існує можливість схожості наслідків впливу пандемії та повномасш-

табного вторгнення, як надзвичайних ситуацій, на епідеміологію розладів харчової поведінки.

Одним із фактором розвитку розладів харчової поведінки є вплив сімейного середовища та внутрішніх взаємозв'язків. Дослідники зазначають, що одним із можливих факторів внутрішньо сімейного впливу на виникнення розладів харчової поведінки може бути підвищене споживання їжі в сім'ї. Пояснюють це впливом соціального бачення ідеалу тіла, що може спровокувати розвиток розладів харчової поведінки через спроби самоствердження підлітка. Ми погоджуємося із цим твердженням, адже стандарти індустрії краси та моди залишили великий відбиток на самосприйнятті власного тіла, особливо це стало помітним із розвитком технологій та соціальних мереж. Також було висунуте твердження, що діти, матері котрих переживали втрату близьких родичів за 6 місяців до вагітності, мали більшу вірогідність розвитку розладів харчової поведінки [7]. У свою чергу, ми вважаємо, що через підвищення рівню смертності, у наслідок воєнних дій, у довгостроковій перспективі, цей вплив може бути значно помітнішим, при дослідженні даного питання.

В статті Xie Xintong надано опис патогенезу нервової анорексії. Опрацювавши матеріал статті, ми вбачили підтвердження нашої гіпотези, що розлади харчової поведінки можуть бути пов'язані із впливом несприятливих подій у підлітковому чи ранньому дорослому віці. Додатково зазначається, що провокуючими факторами нервової анорексії дослідники назвали жорстоке поводження в дитинстві, травма, сексуальний страх. Науковцем висунуто гіпотезу, згідно якої можливо існує наявний зв'язок між проявами розладів харчової поведінки та травмуючими (стресовими) подіями, в тому числі у родині (конфлікти, розлучення), ставленням до їжі батьків [10]. На нашу думку, існує вірогідність того, що через вплив стресу надзвичайних ситуацій, кількість захворюваних на розлади харчової поведінки може зростати. Враховуючи той факт, що віком перших проявів даної групи розладів є підлітковий, ми можемо припустити, що через наслідки підвищення кількості людей із наявністю високого/середнього рівню стресу (в особливості у жінок, котрі наразі знаходяться більшу частину часу із дітьми, через військову діяльність чоловіків), вірогідно відбуватиметься вплив на взаємовідносини батьків – дітей, і опосередковано на поширення розладів харчової поведінки.

Висновки. З урахуванням наведених вище статистичних даних та результатів опитування/анкетування малих та великих груп, можемо помітити підвищену кількість проявів порушень харчової поведінки, зміни звичного харчового режиму. На нашу думку, головним чинником впливу на це є саме наявність стресового стану, що призводить до пошуку можливого вивільнення накопиченого стресу, та призводить до появи деструктивної поведінки, у вигляді вибору ідентичних назві поведінки стратегій копіngu. Зазначимо, що розлади харчової поведінки являють собою серйозну психічну проблему, що, безумовно має досліджуватися й надалі, проте з урахуванням реалій життя світової спільноти, вважаємо за необхідне посилення групи дій, для виявлення можливостей запобігати підвищенню поширення захворюваності на дану групу. На нашу думку у цій статі було доведено що вірогідність підвищення кількості захворювань на розлади харчової поведінки має взаємозв'язок із підвищенням рівню стресу, через вплив зовнішніх факторів.

Література.

1. Гіряк Г. С., Чжан Ліфан. Стрес як чинник виникнення розладів харчової поведінки особистості [Електронний ресурс] – Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2-3 червня 2022р. / під заг. ред. : О. Є. Гомотюк. Тернопіль: Універ. думка, 2022. 342с – : <http://naukskf.wunu.edu.ua/index.php/npsgf/article/view/123>

2. Євстаф'єва А. Д., Щербак О. В., Кузнецова М. О. Стрес під час війни як фактор розвитку розладів харчової поведінки у студентів медичного університету [Електронний ресурс] – Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Харків, 18 травня 2023 р. Х. : НФаУ, 2023. 335с. – Режим доступу до ресурсу: https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/32243/1/13.%20Kuznetsova_Stres%20pid%20chas%20viiny.pdf

3. Прядько В. В., Сомова О. О. Вплив війни на зміну рівня стресу та стратегій збереження життєстійкості українців [Електронний ресурс] – Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернальського. Серія: Психологія Том 33 (72) №4 2022 – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.4/16>

4. Приймак Д. В., Мокрякова М. І. Виникнення розладу харчової поведінки із початком війни – Theoretical and practical scientific achievements:

research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, October 27, 2023. Pisa, Italian Republic: International Center of Scientific Research. ISBN 979-8-88955-784-5. – : <https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/32827/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%86.%20Italy.pdf>

5. Терьошина І. Ф., Воюцька Є. В., Наумова В. Ю. Війна як стресовий чинник виникнення розладів харчової поведінки [Електронний ресурс] – Science and innovation of modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. 727 p. ISBN 978-92-9472-194-5 – Режим доступу до ресурсу: <https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiyascience-and-innovation-of-modern-world-18-20-05-2023-london-velikobritaniya-arhiv>

6. Bizzi F., Riva A., Charpentier Mora S., Tironi M., Sforza S. E., Lorenzo M. M., Nacinovich R. Investigating Functioning Profile of Adolescents with Anorexia before and during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study on Mentalizing, Alexithymia, and Impulsiveness [Електронний ресурс] – Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20(4), 3670; – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.3390/ijerph20043670>

7. Del Casale A., Adriani B., Modesti M. N., Virzi S., Parmigiani G., Vento A. E., Speranza A. M., Anorexia nervosa and familial risk factors: a systematic review of the literature [Електронний ресурс] – Current Psychology (2023) 42:25476–25484 Accepted: 24 July 2022 / Published online: 25 August 2022 – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03563-4>

8. Galmiche M., Déchelotte P., Lambert G., Pierre Tivolacci M. Prevalence of eating disorders over the 2000–2018 period: a systematic literature review [Електронний ресурс] – The American Journal of Clinical Nutrition Volume 109, Issue 5, May 2019, Pages 1402-1413. Режим доступу: <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy342>

9. Özbaran N. B., Yılcıoğlu H. Y., Tokmak S. H., Taş B. Y., Çek D., Bildik T. Changes in the psychosocial and clinical profiles of anorexia nervosa patients during the pandemic [Електронний ресурс] – Front Psychiatry. 2023; 14: 1207526. Published online 2023 Jul 19. doi:10.3389/fpsy.2023.1207526 PMID: PMC10394556 PMID: 37539323 – Режим доступу до ресурсу: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10394556/>

10. Xie X. Pathogenesis of anorexia nervosa [Електронний ресурс] – SHS Web of Conf. Volume 171, 2023 / 2023 4th International Conference on Mental Health, Education and Human Development (MHEHD 2023) 01005 – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317101005>

5.7. Особливості та чинники розладів харчової поведінки у жінок

Леванзова В. Я.

Актуальність. Проблема розладів харчової поведінки (РХП) почала привертати увагу зарубіжних спеціалістів у середині 60-х років ХХ ст. І останні десятиліття різноманітні порушення харчової поведінки стають все більш розповсюдженими, особливо серед жінок. Вони призводять до надмірної і недостатньої ваги (та ризикам пов'язаним з ними), специфічним проблемам зі здоров'ям, негативно впливають на психоемоційний стан та соціальний рівень функціонування особистості, тому потребують детального вивчення. Розглядаючи поняття РХП, слід, по-перше, визначити, що таке харчова поведінка і як вона формується. Харчова поведінка – це система специфічних взаємодій істоти з оточенням, спрямованої на задоволення потреби в їжі [3].

Найпростішою формою харчової поведінки є споживання їжі для задоволення потреби в поживних речовинах. У цьому випадку їжа виступає засобом підтримки необхідного рівня енергії та забезпечує важливі процеси в організмі. Але щоденний харчовий раціон людини частіше за все не обмежується життєво необхідною кількістю калорій чи базовим набором потрібних поживних речовин. Тим більше що обсяг спожитої їжі, час її прийому та вибір конкретних продуктів чи їх комбонування – все це має своєрідність у кожної окремої людини. Таким чином, проблема вивчення харчової поведінки набула самостійного значення, вона була відокремлена від вивчення процесу травлення чи лише біологічних потреб людини. І в залежності від безлічі параметрів, зокрема від того, яке місце займає процес харчування в ієрархії цінностей індивіда, а також від кількісних і якісних показників харчування, дослідники почали ділити харчову поведінку на адекватну (гармонійну) або неадекватну (ту, що відхиляється від норми) [1].

Мета. Дослідити особливості та чинники розладів харчової поведінки у жінок.

Результати дослідження. Вахмістров В. А. визначає адекватну харчову поведінку як ту, при якій споживання харчових речовин по складу, кількості, формі, способу вживання й приготування відповідає харчовій потребі організму в живильних речовинах і енергії залежно від стану ферментних систем, енерговитрат, біоритмів, особливостей харчової мотивації, рівня рухової активності [цит. за: 2].

Неадекватна харчова поведінка традиційно визначається як «порушення харчової поведінки» чи «розлад харчової поведінки». М. Кордуел визначає порушення харчової поведінки як ряд станів, що характеризується серйозними порушеннями в харчових звичках та апетиті [цит. за: 12].

Вознесенська Т. Г. виділяє три основні види порушень харчової поведінки [цит. за: 2]:

- екстернальна харчова поведінка – коли людина орієнтується не на внутрішні стимули до їжі (відчуття голоду, наповненість шлунку), а несвідомо починає їсти через зовнішні стимули (за компанію, коли бачить смачну їжу і т. ін.);
- емоціогенна харчова поведінка – є гіперфагічною (зі збільшенням апетиту) реакцією на стрес, коли поштовхом до їжі є не голод, а тривога, пригніченість чи інший емоційний дискомфорт (включає також «синдром нічного переїдання»);
- обмежувальна харчова поведінка, що характеризується чередуванням надмірних самообмежень, строгих дієт з депресивними станами та частими переїданнями, що супроводжуються провиною та прагненням до самопокарання.

З клінічної точки зору частіше за все розглядають окремі розлади харчової поведінки (Eating Disorders) – цілий клас психічних і поведінкових розладів, пов'язаних з прийомом їжі. «Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям» 11-го перегляду (МКХ-11, ICD-11), розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я та що вступає в силу у 2022 році, розглядає «Розлади харчування і харчової поведінки» в класі 6 – «Психічні та поведінкові розлади». Підклас розладів 6С включає неврогенну анорексію, неврогенну булімію, розлад переїдання, уникаючі та обмежувальні розлади прийому їжі (ARFID), спотворений апетит, повторне пережовування і заглотування їжі,

поверненої зі шлунку в рот, інші уточнені та не уточнені порушення харчової поведінки [24].

«Діагностичний і статистичний посібник з психічних розладів» від Американської психіатричної асоціації у редакції від 2013 року (DSM-5) визначає такі види розладів вигодовування та харчування (Feeding and Eating Disorders): спотворення смаку (pica), розлад румінації (повторна регургітація їжі протягом мінімум одного місяця), унікаючий/обмежувальний розлад харчової поведінки, нервову анорексію, нервову булімію, нападopodobне переїдання (Binge Eating Disorder) та інші специфічні розлади харчової поведінки (в тому числі синдром нічного харчування) [21].

Головною особливістю нервової анорексії є суттєве зниження ваги тіла, що не відповідає віку, статі, стадії розвитку і фізичного здоров'я, через обмеження споживання енергій порівняно з потребами. Особі, що страждає на анорексію, притаманні сильний страх набрати вагу та стійка поведінка, яка цьому перешкоджає, хвилювання через вагу або форму тіла, надмірний вплив маси та форми тіла на самооцінку, та стійке невизнання низького індексу маси тіла [25].

Для невrogenної булімії характерні наступні особливості:

- наявність епізодів переїдання (споживання надмірної кількості їжі протягом короткотривалого часу з відчуттям втрати контролю);
- повторювана компенсаторна поведінка задля уникнення збільшення ваги (самопровоковане блювання; вживання проносних, діуретиків; голодування; надмірні фізичні навантаження);
- залежність самооцінки від форми тіла та ваги [24].

У разі відсутності рекурентної компенсаторної поведінки, але за наявності повторюваних епізодів переїдання (наприклад, раз на тиждень або частіше протягом 3 місяців) доцільніше говорити про розлад з приступами/нападами переїдання – Binge Eating Disorder. Це порушення ще також називають компульсивним чи психогенним переїданням. При ньому людина відчуває втрату контролю над своєю харчовою поведінкою (не може зупинитися чи контролювати обсяг) і під час приступу їсть значно більше (об'єктивно чи суб'єктивно) або швидше, ніж зазвичай. Характерними також є споживання їжі до відчуття дискомфорту, вживання їжі без відчуття фізичного голоду та часто наодинці. Психогенні переїдання

нерідко є реакцією на стрес та емоційний дискомфорт. Вони також часто супроводжується негативними емоціями, такими як почуття провини, сорому або відрази, які зазвичай негативно впливають на самооцінку особистості [19].

Хоча в Україні немає точної статистики по поширеності РХП, за даними досліджень у розвинених країнах нервова анорексія зустрічається у 4,0 % жінок, а нервова булімія – 2 %. У ході міжнародного опитування середня поширеність розладу переїдання протягом життя становила 2,0 %. Причому психогенне переїдання та нервова булімія у чоловіків зустрічається значно рідше, ніж у жінок, а для нервової анорексії і зовсім характерне співвідношення 1:10 [26; 24].

У зв'язку з цим цікавим для дослідження є процес формування харчової поведінки та чинники, що впливають на появу РХП саме у жінок. Доведено, що природа як харчової поведінки, так і її порушень є багаточинниковою. Залежить від фізіологічних, генетичних, психологічних та соціальних причин й індивідуально-психологічних особливостей осіб, схильних до цих порушень.

В нормі, обсяг, характер і частота споживання їжі залежать в основному від наступних феноменів: почуття голоду, відчуття насичення та апетиту. Голод є фізіологічним регулятором кількості споживання їжі. Людина відчуває голод тоді, коли запасів поживних речовин в організмі недостатньо для енергетичної рівноваги. Одним з чинників голоду є скорочення спорожнілого шлунку, що за допомогою механорецепторів його стінок передається в головний мозок, де і формується відчуття голоду [11]. Буває, що сильні скорочення шлункових м'язів пов'язані зі зменшенням концентрації в крові глюкози. За результатами деяких дослідницьких робіт, відчуття голоду ще може залежати від температури навколишнього середовища [6].

Проте, для повнішого розуміння феномену слід відокремлювати відчуття голоду як фізичний стан від психологічного акту усвідомлення голоду та бажання його подолати. Останнє люди переживають при позбавленні чи відсутності їжі, що спричиняє пошук задоволення цієї потреби задля усунення внутрішнього дискомфорту. У позитивній формі це називається апетитом (лат. *appetitus* – «прагнення, бажання») – емоційне відчуття пов'язане з бажанням споживати їжу. Це один з психоемоційних аспектів регуляції харчової поведінки. При цьому апетит може бути як ком-

понентом голоду, так може існувати й сам по собі, незалежно від стану енергетичної рівноваги [11]. Звідси витікає, що на відміну від відчуття голоду, апетит не залежить від зменшення поживних запасів в організмі людини, він може зростати або зменшуватися під впливом різноманітних умовних подразників. Апетит відіграє важливу роль в отриманні задоволення від їжі та у формуванні харчових звичок, а апетитність конкретної їжі великою мірою залежить від ставлення до неї.

У той же час, протилежними по відношенню до апетиту та відчуття голоду є стани насичення і ситості, яким притаманна відсутність бажання їсти та які є важливими аспектами формування харчової поведінки. Відчуття насичення примушує людину закінчити конкретний прийом їжі, а при відчутті ситості бажання споживати їжу пригнічується на деякий час. Цим станам притаманні почуття задоволення та відчуття наповненості шлунку.

Дефіцит впевненості щодо розпізнавання голоду та насичення також може стати важливим чинником ризику виникнення РХП. Наприклад, у Шкалі оцінки харчової поведінки (EDI), розробленій у 1983 році Д. М. Гарнером, М. П. Олмстедом та Дж. П. Полевим, така інтероцептивна некомпетентність є одним з 7 параметрів у діагностуванні, що дозволяє виявити ознаки РХП [23].

У регуляції відчуття голоду, апетиту та насичення велике значення відіграє робота головного мозку (центри голоду та насичення в гіпоталамусі та відповідні їм утворення у лімбічній системі та корі великих півкуль). При цьому роль основної ланки з точки зору формування харчової мотивації належить гіпоталамусу, який не тільки забезпечує вегетативну основу емоційно-поведінкових реакцій, але й управляє всіма основними гомеостатичними процесами, у тому числі ліпостатом – системою, що контролює сталість ваги тіла [14].

Також вченими було виявлено велику кількість нейропептидів, що регулюють харчову поведінку (стимулюють та пригнічують процес споживання їжі) та досліджено і роль іншого нейротрансмітера – серотоніну. При підвищенні його в гіпоталамічних структурах (особливо яскраво виражене після вживання їжі, багатой на вуглеводи або білки) виникає відчуття ситості та харчова поведінка пригнічується, а при зменшенні – активізується [14].

Тобто на відчуття голоду, апетиту та ситості впливають різні біохімічні механізми в людському організмі, в тому числі порушення продукування чи кількості певних нейромедіаторів, амінокислот та гормонів. Тому проблеми метаболізму також розглядають серед чинників РХП (можливо, наприклад, виникнення неврогенної анорексії та неврогенної булемії у зв'язку з порушенням захоплення сератоніну) [15]. Але подібні порушення метаболізму не завжди призводять до порушень харчової поведінки. У зв'язку з цим вчені виділяють окрім фізіологічних та біологічних чинників регуляції харчової поведінки, ще й ряд соціокультурних та психологічних чинників. Зокрема харчову поведінку можуть визначати харчові звички – сформовані в процесі розвитку людини стереотипні дії високого ступеня міцності та автоматизації. Вони можуть визначатися не тільки життєвим досвідом особистості, але і традиціями її сім'ї, рівнем культурного розвитку суспільства, релігійними уявленнями, актуальною модою, конкретними економічними причинами [22]. Тому окремо виділяють соціокультурні умови формування харчової поведінки та розладів харчування, до яких відносять вплив сім'ї та соціуму на особистість.

У першу чергу сім'я може відігравати критичну роль в розвитку РХП. Ряд досліджень констатують, що не менше у 50 % родин, в яких як мінімум один з членів страждає на РХП, діти потім мають «довгу історію» надмірного занепокоєння з приводу свого зовнішнього вигляду і дотримання дієти [1]. Але наразі неможливо зробити кінцевий висновок: це виступало середовищним чинником ризику виникнення РХП чи спадковим. Оскільки у 90-і роки співпадаючі дані близнюкових і сімейних досліджень показали, що деякі РХП мають генетичний компонент. Наприклад, нащадки однієї пари родичів з нервовою анорексією можуть отримати ген сприйнятливості (вразливості) до нервової анорексії, але він може не проявитися або проявитися в несприятливих умовах, наприклад, при неправильній дієті або після емоційного стресу [16].

При чому сама родина може створити сприятливий клімат для розвитку РХП, навіть у разі відсутності відповідного гену, якщо в ній панують негармонійні стосунки. Наприклад, якщо члени родини надмірно залучені в справи один одного чи навпаки – не приділяють уваги дітям. Окрім того, родина сильно впливає на харчові звички людини, які можуть не відповідати її індивідуальним по-

требам та особливостям. Провокувати виникнення порушень харчової поведінки можуть також позитивне ставлення до дієт у родині, критичні зауваження відносно маси і форми тіла з боку членів сім'ї, сексуальне насильство, наявні в родині випадки депресивних розладів, людей з залежностями від ПАР (особливо алкоголю), а також з ожирінням [20; 11].

Що до соціального впливу на появу РХП, то багато дослідників переконано, що у збільшення кількості серйозних розладів харчування у жінок значну роль відіграють сучасні стандарти жіночої привабливості, що тяжіють до худорлявості та, в принципі, значно більше приділення уваги зовнішності жінок, ніж чоловіків [8]. Ризик розвитку РХП також зростає у осіб, що займаються специфічними видами жіночого спорту, або професія яких вимагає відповідності жорстким стандартам зовнішності (наприклад, художня гімнастика, балет, мода) [7].

Крім того, нинішнє прагнення рівноправності та рівності чоловіків і жінок означає для жінок постійне змагання з чоловіками у всіх сферах життя, що пов'язано з необхідністю придушувати фемінні якості та посилювати мускулітні. До того ж образ сучасної жінки, що насаджується рекламою зі сторінок журналів та екранів телевізорів, змушує жінок надавати першочергового значення своєму зовнішньому вигляду. Ці соціальні тенденції накладаються на потребу контролювати себе, що постійно відчувається жінкою. Деякі дослідники вважають, що жінки несвідомо зробили висновок, що найбільш доступним об'єктом контролю, який служить цілям незалежності та досягнення соціального стандарту, є образ тіла та вага, що призвело до зростання порушень харчової поведінки серед жінок [18].

Занепокоєння у психологів також викликає негативне ставлення та засудження надмірної ваги, що проявляється у сьогоденні, та яке може стимулювати прагнення до худорлявості серед дівчат-підлітків, які найбільше схильні до РХП. У той же час, слід зазначити, що в українському суспільстві через ряд історичних подій (у тому числі Голодомор 1932-1933 рр.) у минулого покоління сформувалося негативне ставлення до худорлявості, через її загрозу виживанню. Окрім того, слово «худий» в українській мові історично має значення «негарний, нехороший, поганий», тому на думку автора

цієї роботи, в багатьох українських родинах існувала тенденція до «загодовування», що сприяла формуванню дефіциту впевненості щодо розпізнавання голоду й насичення та закріплювала відповідні поведінкові патерни у харчуванні. Окрім того, у майбутньому це могло спричинити виникнення РХП через внутрішній конфлікт між прагненням до зовнішніх «стандартів краси» та внутрішнім переконанням, що «бути худим – це погано».

Але окрім біологічних, фізіологічних та соціокультурних чинників харчової поведінки важливого значення набувають індивідуальні психологічні чинники, оскільки харчова поведінка, в тому числі, задовольняє психоемоційні потреби особистості. Це обумовлено роллю харчування у дитинстві – з перших днів життя відчуття насичення еквівалентне почуттю «мене люблять» та відчуттю захищеності.

За думкою Савенкова Ю. І. харчова поведінка також є засобом: розрядки психоемоційної напруги; нагороди та чуттєвої насолоди, що виступає як самоціль; підтримання певних ритуалів чи звичок (релігійні, національні, сімейні традиції); компенсації незадоволених потреб (потреба у спілкуванні, батьківській турботі тощо); задоволення естетичної потреби; спілкування, коли їжа пов'язана із перебуванням у колективі; самоствердження, коли першорядну роль відіграють уявлення про престижність їжі та про відповідну зовнішність [3].

Психологічні механізми розвитку порушень харчової поведінки описуються дослідниками по-різному. Частина дослідників розглядають РХП як форму адиктивної поведінки та описують такий ряд причин, що сприяють виникненню харчової залежності: відсутність сенсу життя, ситуації втрати, кризові стани, дефіцит любові [5; 13].

У цьому контексті слід звернути увагу на зазначену у роботах Малкіної-Пих І. Г. чотирьох компонентну модель, що описує мотивацію харчової поведінки [12]. Вона заснована на аналогічній моделі мотивації вживання алкоголю і включає такі компоненти мотивації, як: отримання задоволення; подолання негативних емоцій; соціалізація; відповідність очікуванням інших людей.

Згідно Краснощорової Н. Ю., РХП втілюють в собі несвідому боротьбу внутрішньої індивідуальності людини, її уявлення про саму себе в соціумі та проблем, які витікають із травмуючого життєвого досвіду, моделей соціалізації. Концентрація на харчуванні або на «не харчуванні» (у випадку обмежувального типу харчової

поведінки), дає можливість людині обмежувати, таким чином, тяжкі переживання своїх проблем, стає для неї єдиною по-справжньому контрольованим аспектом життя [6]. Причиною нервової анорексії часто вважають дисморфобічні переживання – коли людина надмірно переживає через свою зовнішність чи зайву вагу. Недоліки чи незначні дефекти фігури, з точки зору людини, настільки помітні оточенню, що воно нібито дає зрозуміти, наскільки ця людина неприваблива [9]. Деякі науковці розглядають різні можливі моделі коморбідності РХП з тривожністю та розладами настрою.

Також психологи часто розглядають РХП як дезадаптивний спосіб вирішення конфліктів: коли їжа виступає засобом символічної комунікації, а людина страждає на почуття неспроможності відповідати вимогами життя [10]. Це почуття розвивається як за відсутності важливих життєвих навичок, так і на фоні синдрому навченої безпорадності, в результаті невдалих спроб налагодити ефективні стосунки з іншими людьми. У цьому разі РХП виступає непродуктивною копінг-стратегією, в якій їжа, вага тіла і образ тіла стають головними життєвими цінностями, а специфічна харчова поведінка – засобом подолати стрес, емоційний дискомфорт чи негативні уявлення про себе. Загалом, дослідники відмічають, що індивідуальними психологічними чинниками які сприяють виникненню РХП є: низька самооцінка; перфекціонізм (невиправдано високі стандарти або страх приниження); тривожність; надмірне переймання своєю масою тіла, зовнішнім виглядом та залежність самооцінки від цих параметрів [11, с. 23].

Висновки. Харчова потреба, виступаючи у тварини чисто біологічною за своєю природою, у людини постає у складнішому вигляді, на конкретну харчову поведінку людини впливає комплекс фізіологічних, соціокультурних та психологічних чинників. І в залежності від безлічі параметрів, зокрема від того, яке місце займає процес харчування в ієрархії цінностей індивіда, а також від кількісних і якісних показників харчування, харчова поведінка людини може знаходитися в рамках нормальних харчових патернів, епізодичних порушень харчової поведінки та патологічної харчової поведінки. РХП є цілою групою психічних і поведінкових розладів зі схожими механізмами розвитку, об'єднаних переживаннями з приводу маси та форми тіла і порушеннями стереотипу харчуван-

ня, що зустрічаються переважно серед жінок. Порушення харчової поведінки призводять зазвичай до виражених проблем з соматичним здоров'ям і рівнем психосоціального функціонування, тому заслуговують детального вивчення чинники, що можуть призвести до їх виникнення. До чинників РХП в людини відносять біохімічні порушення, генетичний компонент, сімейний вплив, соціальний тиск та індивідуальні психологічні особливості. У ряді наукових праць термін «розлади харчової поведінки» фігурує поруч з поняттям «самооцінка», що є емоційно-ціннісною складовою «Я-концепції» та характеризує характер ставлення людини до себе. Але їх взаємозв'язок недостатньо вивчений. На розвиток самооцінки, як і на появу РХП, також впливає ряд соціокультурних чинників (характер виховання, досвід спілкування з однолітками та вплив соціуму), що робить необхідність емпіричного дослідження зв'язку рівня самооцінки та проявів РХП ще більш аргументованим.

Література.

1. Абсаямова Л. М. Психологія харчової поведінки людини. Навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2017. 181 с.
2. Абсаямова Л. М. Розлади та порушення харчової поведінки особистості // Проблеми сучасної психології. 2014. № 25. С. 19-33.
3. Абсаямова Л. М. Харчова поведінка жінок: розлади та психокорекція : дис. ... д-ра псих. наук. : 19. 00. 01. Київ, 2019. 398 с.
4. Вадзюк С. Н. та ін. Фізіологічні терміни. Тлумачний словник / За ред. П. О. Неруша. Тернопіль: ТМДУ, 2005. 193 с.
5. Крат Л. Сутність і зміст нервової булімії як різновиду харчової адикції / Л. Крат, Я. Гошовський // Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології : матеріали VI Міжнар. наук. -практ. інтернет-конф., 13 трав. 2019 р. / За заг. ред. Я. О. Гошовського, О. В. Лазорко, А. В. Кульчицької, Т. В. Федотової. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С. 140-143.
6. Кудла Т. В., Антонова З. О., Ханецька Н. В. Психологічні чинники ризику виникнення порушень харчової поведінки в жінок // Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». Випуск 27. 2021. С. 125-130. URL: <http://habitus.od.ua/journals/2021/27-2021/23.pdf>
7. Кульчицька А. В., Федотова Т. В. Соціально-психологічні аспекти формування харчової поведінки в підлітковому віці. Психологічні перспективи. 2019. № 33. С. 178–191.

8. Лапіна Ю. Тіло, їжа, секс і тривога. Що турбує сучасну жінку. Дослідження клінічної психологині : пер. з рос. Альпіна Паблішер Україна, 2021. 221 с.

9. Лапушенко М. В. Дисморфобія: проблема визначення, діагностики та надання психологічної допомоги // «Young Scientist», № 12 (15). 2014. С. 255-259.

10. Левченко Д. О. Проблема розладів харчової поведінки в сучасному світі // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 18 лист. 2020 р. / за заг. ред. проф. О. В. Бацилевої. Київ, 2020. С. 81-84.

11. Лінет Вайтгед. Подолати розлад харчової поведінки / пер. з англ. І. Грицюк; наук. ред. К. Явна. Львів: Видавництво Українського католицького університету: Свічадо, 2014. 112 с.

12. Малкина-Пых И. Г. Терапия пищевого поведения: справочник практического психолога. Москва: Эксмо, 2007. 1037 с.

13. Мойзріст О. М. До проблеми порушень харчової поведінки: ПХП як варіант нехімічної адикції // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія (зб. наук. праць) / за ред. С. Д. Максименка. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. Т. X. Випуск 17. С. 289-299.

14. Нікіфорова Я. В. Взаємозв'язок харчової поведінки з метаболічними чинниками ризику // Сучасна гастроентерологія. 2015. №23. С. 113–121.

15. Сак Л. В., Хаустова О. О. Порушення емоційної регуляції у пацієнтів з нервовою анорексією // Психосоматична медицина та загальна практика, 2019. URL: <https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/247>

16. Смоляр В. І. Генетичні та середовищні аспекти харчової поведінки // Проблеми харчування. № 3-4 (23). 2010. С. 16–25.

17. Фізіологія людини / Гжегоцький М. Р., Філімонов В. І., Петришин Ю. С., Мисаковець О. Г. Київ: Книга плюс, 2005. 316 с.

18. Шебанова В. І. Діагностичні критерії та систематика основних форм порушень харчової поведінки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Гол. ред. М. О. Носко. Т. 2. Вип. 94. Чернігів: ЧДПУ, 2011. С. 251– 255.

19. Abraham S. F., Beumont P. J. How patients describe bulimia or binge eating // Psychol Med. 1982, № 12(3). P. 625-635.

20. Cerniglia L., Cimino S., Tafà M., Marzilli E., Ballarotto G., Bracaglia F. Family profiles in eating disorders: family functioning and psychopathology. Psychol Res Behav Manag. 2017. doi: <https://doi.org/10.2147/prbm.s145463>

21. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, D. C: American Psychiatric Association. 2013. 947 p.
22. Frances J. Raphael, J. Hubert Lacey. Sociocultural Aspects of Eating Disorders // *Annals of Medicine*, 24:4. 1992. P. 293-296. doi: 10.3109/07853899209149957
23. Garner D. M., Olmstead M. P. and Polivy J. Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. *International Journal of Eating Disorders*. 1983, 2.P.15-34.doi:10.1002/1098-108X(198321)2:2<15::AID-EAT2260020203>3.0.CO;2-6
24. International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information. Version: 02/2022. Retrieved from: <https://icd.who.int/>
25. Schmidt U., Adan R., Boehm I., Campbell I. Eating disorders: The big issue // *The Lancet Psychiatry*. 2016. №3. P. 313-315.
26. Smink, F. R. ; van Hoeken, D; Hoek, HW. Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. *Current Opinion in Psychiatry*. 26 (6). 2013. P. 543–548. doi:10. 1097/yco. 0b013e328365a24f.

5.8. Передумови виникнення психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці

Лисова В. М.

Актуальність. На сьогоднішній день гаджети посідають важливе місце у житті сучасних підлітків, адже більшу частину свого дня підлітки проводять, користуючись різними гаджетами: смартфонами, комп'ютерами, телевізорами тощо. Окрім цього, значну роль у житті підлітків відіграють не лише гаджети, але й можливості, які користування гаджетами надає підліткам. Так, на сьогодні провідне місце у житті підлітків посідає мережа Інтернет, що дозволяє їм користуватись соціальними мережами, шукати інформацію, переглядати різні відео- та фото-матеріали, а також навчатись. Також користування гаджетами передбачає, що підлітки чимало часу проводять, граючи у відео-ігри, як за допомогою комп'ютера, спеціальних ігрових приставок, так і за допомогою смартфона. Підлітки значний час проводять у соціальних мережах, спілкуючись із друзями, долучаючись до спільнот за інтересами та використовуючи можливості для розваг і інших способів проведення вільного часу.

Разом з тим, використання гаджетів у житті підлітків є важливим не лише завдяки функціям сучасних технологій, які є різноманітними, але й внаслідок виникнення психологічної залежності. Користуючись гаджетами постійно, підлітки формують особливу психологічну залежність, що негативно впливає на їх життя, так само, як і використання гаджетів в цілому. Психологічна залежність у такому випадку погіршує взаємодію підлітків з оточуючими, стає причиною появи певних психологічних проблем, зокрема – тривожність, стрес, агресивність тощо. Окрім цього, користуючись гаджетами, підлітки стають жертвами негативного зовнішнього психічного впливу, що провокує виникнення особливо негативних психічних станів. Усе це характеризує психологічну залежність від гаджетів, як таку, що негативно впливає на підлітків. З огляду на це, сучасним педагогам та психологам важливо розуміти передумови

виникнення психологічної залежності від гаджетів серед підлітків, знання яких дозволить у подальшому уникнути її формування, тим самим покращивши психічний стан молодого покоління.

Мета. Комплексний аналіз передумов виникнення психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці.

Результати дослідження. Питання психологічної залежності підлітків від гаджетів розглядається низкою вітчизняних дослідників. Так, О. В. Літвінова та Н. С. Венгер з'ясували, що використання гаджетів негативно впливає на психічний стан підлітків, а саме – їх самопочуття та настроїв [6]. Окрім цього, Ю. І. Керебка визначила негативний вплив використання гаджетів на особистість підлітків [4]. О. В. Гурова, у свою чергу, розглянула такий прояв психологічної залежності від гаджетів, як фабінг – патологічну залежність від смартфона [2]. Дані дослідження дають змогу зазначити, що використання гаджетів у підлітковому віці нерідко призводить до формування психологічної залежності, що негативно впливає на психічний стан підлітків.

Отже, перш ніж перейти до з'ясування передумов виникнення психологічної залежності від гаджетів, звернемо увагу на особливості психологічної залежності, а також характер прояву психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці. Загалом, зазначимо, що у наукових колах не існує уніфікованого визначення поняття залежної поведінки, а також поняття психологічної залежності. Залежність характеризується втечею людини від реальності, що може мати патологічний характер. У такому випадку життя людини залежить від різних чинників, що і впливають на виникнення залежної поведінки. Залежність може бути спричинена психоактивними речовинами, їжею, азартними іграми, а також певними предметами, використання яких формує психічний стан людини, який вона не прагне змінювати і який викликає почуття ейфорії. При цьому людина ігнорує негативний вплив такого стану на її життя, постійно прагнучи повернутись до нього та відчутти його вплив на психоемоційний стан людини [5].

Таким чином, важливо підкреслити, що психологічна залежність від гаджетів є проявом адиктивної поведінки. Досліджуючи природу залежної поведінки людини, А. Мудрик надає наступне визначення адиктивної поведінки, згідно з яким адиктивна поведінка є однією

з форм девіантної поведінки, що є відхиленням від норм, а також проявом деструктивної поведінки, що характеризується прагненням відходу від реальності завдяки штучній зміні психічного стану за допомогою вживання психоактивних речовин та, у даному випадку, постійній фіксації уваги на певних видах діяльності, що дозволяє розвинути та підтримувати інтенсивні емоції. Таким чином, психологічна залежність підлітків від гаджетів проявляється у вигляді постійної фіксації уваги на користуванні гаджетами та здійсненні різних маніпуляцій з їх допомогою, завдяки чому підлітки мають можливість отримувати певні емоції та підтримувати свій емоційний стан на сталому рівні. Користуючись гаджетами, вони можуть отримувати як позитивні, так і негативні емоції, однак, незалежно від характеру емоцій, підлітки прагнуть підтримувати даний тип емоційного стану на сталому рівні, що приносить їм задоволення [7; с. 9].

Разом з тим, характерним проявом психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці є інтернет-залежність або інтернет-адикція. Такий різновид психологічної залежності проявляється у вигляді нав'язливого бажання постійно перебувати у мережі Інтернет. Дане бажання проявляється у постійному використанні підлітками різних можливостей даної мережі, у тому числі і використання соціальних мереж. Разом з тим, подібні способи використання гаджетів дають можливість підліткам спілкуватись з іншими, і при цьому не лише знайомими, але й незнайомими людьми. Таким чином підлітки намагаються компенсувати недостатню кількість спілкування у реальному житті шляхом штучної заміни такого спілкування віртуальним спілкуванням. На жаль, подібні дії негативно впливають на психічний стан підлітків, оскільки спілкування з невідомими людьми у мережі Інтернет, у якій не дотримуються етичні та моральні норми, може мати особливо негативний характер. У такому випадку характерним є булінг у мережі Інтернет, який може стати причиною пригніченого стану підлітків та появи таких проблем, як тривожно-депресивні розлади [4].

Також, розглядаючи питання залежності від гаджетів, підкреслимо, що дана залежність є психічним розладом, який проявляється у вигляді нав'язливого бажання брати до рук певний пристрій та нездатністю вчасно від нього відмовитись. Таким чином, підліток, користуючись постійно гаджетами, може фокусуватись не на ре-

альному світі, а на віртуальному. Окрім цього, він ігнорує потребу у їжі, живому спілкуванні, фізичній активності [8].

Важливо окреслити критерії психологічної залежності підлітків від гаджетів [3]: наявність споглядальних та пасивних стосунків з дійсністю, поверхнєве сприйняття подій, що відбуваються у житті людини, на основі зовнішніх ознак; зовнішня соціабельність підлітка, яка поєднується зі страхом перед стійкими емоційними контактами; прагнення підлітка надавати перевагу штучній реальності, яка замінює цінності і події реального життя; використання втечі від реальності у вигляді використання гаджетів як способу розв'язання проблем; високий рівень тривожності та агресивності; безуспішність спроб скорочення часу, який підліток витрачає на використання гаджетів; стереотипність та повторювальність поведінки; наявність ускладнених відносин з близькими людьми, наявність ускладнених соціальних контактів з оточуючими.

Таким чином, зазначимо, що психологічна залежність підлітків відповідає усім критеріям психологічної залежності, оскільки підлітки проводять велику кількість часу, користуючись різноманітними гаджетами, при цьому не маючи бажання або можливості відмовитись від гаджетів частково або остаточно. Окрім цього, використання гаджетів стає причиною певних психічних проблем, а також причиною погіршення відносин з оточуючими.

З огляду на це, визначимо наступні симптоми психологічної залежності підлітків від гаджетів [8]: наявність гарного самопочуття, відчуття ейфорії та покращення настрою у процесі використання гаджетів, і, навпаки, погіршення настрою після припинення використання; неможливість припинити використовувати гаджети; стабільне зростання часу, витраченого на використання гаджетів; зневажання рідних та друзів внаслідок надання переваги гаджетам замість живого спілкування та взаємодії з близькими; негативне психічне самопочуття під час тимчасового припинення використання гаджетів, зростання рівня тривоги, поява відчуття роздратованості та спустошення; брехня про використання гаджетів близьким, а також брехня про кількість часу, проведеного у процесі використання гаджетів; наявність проблем із навчанням: гаджети відволікають підлітків від навчального процесу, відволікають від виконання домашнього завдання тощо. Отже, досліджую-

чи характер прояву психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці, варто зазначити, що дана залежність формується під сукупним впливом як особистісних (психологічних) особливостей підлітків, так і зовнішніх факторів, які загалом провокують виникнення даної психологічної залежності.

Таким чином, на основі аналізу досліджень А. Войскунського та Ю. Керебко зазначимо, що основними причинами виникнення психологічної залежності підлітків від гаджетів є [1; 4]: недостатня кількість або відсутність спілкування із близькими, а також теплих емоційних відносин у родині; відсутність у підлітка захоплень, інтересів, хобі, уподобань, які б не були пов'язані з використанням гаджетів; відсутність вміння налагоджувати соціальний контакт із оточенням, а також відсутність друзів; неуспішність дитини у соціумі, у навчанні тощо; наявність фізичних та психічних проблем – важкої інвалідності або тяжкого захворювання.

Разом з тим, першою передумовою виникнення психологічної залежності від гаджетів, на нашу думку, є недостатній контроль з боку батьків. Гаджети відіграють важливу роль у житті сучасних підлітків, оскільки з їх допомогою вони мають можливість отримувати невід'ємну інформацію для навчання та саморозвитку. Окрім цього, гаджети дають можливість підліткам підтримувати зв'язок з тими, з ким вони не мають можливості спілкуватись у реальному житті внаслідок тих або інших причин. Також зазначимо, що гаджети дають можливість підліткам відпочити та розважитись. Їх використання може бути корисним, однак за умов серйозного контролю з боку батьків. Батьки мають контролювати кількість часу, який підлітки витрачають на гаджети, контролювати те, як саме вони їх використовують тощо. Однак, важливою проблемою є недостатній контроль з боку батьків, внаслідок чого підлітки, відчуваючи надмірну свободу, починають використовувати гаджети неконтрольовно. У результаті чого під сукупним впливом інших факторів формується психологічна залежність, яка з кожним разом лише загострюється [9].

Окрім цього, у такому випадку виникнення психологічної залежності від гаджетів також зумовлює недостатня кількість спілкування підлітків із близькими людьми, а також відсутність позитивних та щирих емоційних стосунків всередині родини. Підлітки, не відчуваючи уваги з боку батьків, використовують гаджети для

того, аби компенсувати недостатню кількість часу, проведеного з рідними. За допомогою гаджетів, окрім цього, підлітки прагнуть отримати любов та увагу, якої їм не вистачає у реальному житті. Батьки більшу частину доби проводять на роботі, а після не приділяють підліткам достатньо часу, що може стати важливою передумовою виникнення психологічної залежності.

Також на виникнення психологічної залежності від гаджетів впливає і факт відсутності у підлітків захоплень і хобі поза використанням гаджетів. Підлітки, що займаються спортом, відвідують різні гуртки, а також мають хобі, не мають достатньо вільного часу для того, аби використовувати гаджети у такій кількості, що свідчила б про наявність психологічної залежності. Однак підлітки, які мають велику кількість вільного часу, за наявності гаджетів будуть звертатись саме до них, як до способу організації свого дозвілля. За допомогою гаджетів вони грають в комп'ютерні ігри, користуються соціальними мережами, переглядають відео, що може мати також і негативний зміст. Таким чином, внаслідок відсутності інших способів організації дозвілля, підлітки звертаються саме до гаджетів, що і стає передумовою формування психологічної залежності [1].

Разом з тим, якщо підлітки не мають достатньої кількості живого спілкування, що зумовлено відсутністю друзів, вони також можуть бути схильні до виникнення психологічної залежності від гаджетів. У такому випадку підлітки матимуть бажання знайти друзів за допомогою гаджетів – у відео-іграх або у соціальних мережах. Таким чином, спілкуючись з незнайомцями за допомогою гаджетів, підлітки будуть задовольняти потребу у спілкуванні, а відчуття задоволення та радості від спілкування з такими особами буде відігравати роль передумови формування психологічної залежності від гаджетів.

Окрім цього, зазначимо, що ще однією передумовою формування психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці виступає загальний психічний стан підлітків та їх психологічні особливості. На думку дослідників, підлітки, що мають знижену самооцінку, більше схильні до виникнення залежності від гаджетів, ніж підлітки з адекватним рівнем самооцінки. Також на формування психологічної залежності від гаджетів впливає відчуття самотності, що зумовлено впливом інших факторів, які були окреслені попередньо.

Таким чином, на основі окреслених передумов виникнення психологічної залежності підлітків від гаджетів, існує необхідність застосування спеціальних методів профілактики даної залежності, які будуть спрямовані на налагодження відносин всередині родини, покращення соціальної взаємодії підлітків з оточуючими, а також вдосконалення психічного стану підлітків. Однак, за умов таких причин, як наявність фізичних та психічних відхилень у розвитку, дані передумови подолати ускладнено, тому важливо долати інші причини виникнення даної залежності, що дозволить компенсувати вплив інших негативних факторів.

Висновки. Отже, психологічна залежність підлітків від гаджетів є негативним психічним станом, який характеризується постійним прагненням користуватись гаджетами за відсутності можливостей уникнути дане бажання. Психологічна залежність у такому випадку є проявом адиктивної поведінки, що негативно впливає на підлітків, має особливі симптоми та стає причиною погіршення їх соціально-психологічного благополуччя. Основними передумовами виникнення психологічної залежності від гаджетів є негативні відносини всередині родини та відсутність або недостатня кількість спілкування з близькими, погіршені відносини з оточуючими, відсутність друзів, відсутність хобі та інтересів окрім гаджетів, психологічні особливості у вигляді заниженої самооцінки тощо. Існує велика ймовірність подолати або зменшити негативний вплив психологічної залежності від гаджетів за умов використання спеціальних методів, що передбачають спільну взаємодію педагогів, психологів та батьків з метою профілактики та подолання даної залежності.

Література.

1. Войскунский А. Актуальні проблеми психології залежності від Інтернету. Психологічний журнал. Випуск №1. 2004. С. 91-102
2. Гурова О. В. Фабінг: психологічні причини та наслідки. URL: [http://Mediaosvita.Org.Ua/Wp-Content/Uploads/2019/06/Gurova-O. V. -Fabing_-Psychologichni-Prychyny-Ta-Naslidky. pdf](http://Mediaosvita.Org.Ua/Wp-Content/Uploads/2019/06/Gurova-O.V.-Fabing_-Psychologichni-Prychyny-Ta-Naslidky.pdf)
3. Залежність як соціально-психологічне явище. URL: [https://www.dkpp.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/zalezhna_pov_1-. pdf](https://www.dkpp.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/zalezhna_pov_1-.pdf)
4. Керебко Ю. І. Вплив інтернет-залежності на особистість підлітків. Теорія і практика сучасної психології. Випуск №3. 2018. С. 190 – 193

5. Коваленко О. І., Самара О. Є. Емоційна залежність особистості як проблема сучасної психології. Габітус. Випуск № 42. 2022. С. 178-181
6. Літвінова О. В., Венгер Н. С. Емпіричне дослідження впливу гаджетів на психічний стан підлітків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск №4. 2021. С. 155-161
7. Мудрик А. Б. Психологія залежної поведінки: навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2022. 236 с.
8. Полянська Я. В. Психологічні особливості гаджетозалежності у дітей шкільного віку. URL: <http://ekhsuir.kspu.edu>
9. Gadgets and Their Impact on Child Development [Електронний ресурс]. URL: <https://www.mdpi.com/2504-3900/82/1/6>

5.9. Ризики застосування методу психологічного дебрифінгу

Меленець А. Ю.

Актуальність. Проблеми пошуку ефективних методів психологічної інтервенції для постраждалих від надзвичайних подій важко переоцінити. Війна, розв'язана російською федерацією проти України, окупація, терористичні акти і атаки на цивільну інфраструктуру призвели до того, що не тільки військові але й цивільні у найвіддаленіших від фронту регіонах потерпають від хронічного стресу, спричинених війною ризиків для життя і здоров'я і, як наслідок, ризиків розладів адаптації і посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Відтак, перед психологічною спільнотою України постає важлива задача у формуванні правильного підходу до перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з ментального здоров'я і впровадженні ефективних, науково обгрунтованих і визнаних світом методів психологічного втручання для профілактики і терапії ПТСР. Міністерство охорони здоров'я України (далі МОЗ) визначає доказові підходи до терапії ПТСР [3], однак впровадження світових стандартів потребує періоду адаптації, що на практиці створює ситуацію, коли методична база навчальних закладів не встигає за нововведеннями і подає інформацію що втратила свою актуальність. Відтак, дискусія що роками розвивається в науковій спільноті Європи і США щодо ефективності і ризиків використання методу психологічного дебрифінгу не відлунюється у психологічній спільноті України. Це призводить до того, що молоді спеціалісти стикаються з наслідками використання ризикових методів і вимушені вчитися на помилках у власному досвіді, ціною здоров'я постраждалих, що отримують некваліфіковану та неефективну допомогу. В умовах сьогодення така помилка є дуже дорога.

Мета. Ознайомлення з критикою методу психологічного дебрифінгу і обгрунтування ризиків, згідно яких цей метод було ви-

ключено з рекомендованих [3, 14, 7], та огляд альтернатив з визначеною доказовістю.

Результати дослідження. При підготовці матеріалів ми ознайомилися з працями як критиків методу (Wessely, Rosse, Bison) так і його прихильників (Adler, Castro, McGurk) а також приводимо актуальні станом на зараз рекомендації таких інституцій як NICE (Велика Британія), AHRQ (США), National Center for PTSD (США) та МОЗ України.

Почнемо з визначення поняття психологічного дебрифінгу, історії його виникнення і впровадження як методу терапії і профілактики ПТСР.

Першочергове походження терміну – англійське слово «debriefing», що може бути перекладене як «звітування». Воно означало процес звітування виконавцями після проведеної операції з метою надання важливої інформації. В словнику Merriam Webster приводиться приклад використання слова «to debrief» в військовому контексті: «допитувати (когось, наприклад пілота), зазвичай після повернення (наприклад з місії), задля отримання корисної інформації» [8].

В психологічному контексті термін психологічний дебрифінг (далі – ПД) концептуалізувався у 1970-х роках [15] і вперше був описаний Мітчеллом у 1983 році, що стимулювало розробку декількох схожих видів інтервенцій з узагальненою назвою психологічний дебрифінг. Метод представляв собою інтерв'ю, що слугувало експозицією до травмуючої ситуації і мало надати постраждалому можливість усвідомити пережитий досвід і поділитися своїми почуттями з консультантом, з метою структуризації спогадів про подію.

Така інтервенція надавалася одразу після або впродовж кількох днів після надзвичайної події, і в більшості своїх форм виглядала як разова індивідуальна або групова консультація тривалістю від однієї до трьох годин. Рівень підготовки спеціалістів, що їх надавали, як і види ПД, відрізнялися. Деякі з популярних варіантів це – кризові інтервенції (Crisis intervention approaches), груповий психологічний дебрифінг (Group psychological debriefing), стрес-дебрифінг критичного інциденту (Critical incident stress debriefing), процесуальний дебрифінг (Process debriefing) та інші [6].

Вважалося, що така інтервенція має перешкоджати подальшому розвитку і виникненню ПТСР і має використовуватися як його профілактика [9].

ПД швидко набув розголосу і широко використовувався як інтервенція до постраждалих від надзвичайних подій впродовж 80-90-х років, що супроводжувалося майже казковими відгуками щодо його ефективності. Під доказами в користь ефективності методу, його розробники посилялися на зворотні відгуки респондентів, на яких цей метод випробовували в умовах польового експерименту. Звісно, що самозвіт респондента про те, що інтервенція йому допомогла, не може вважатися об'єктивним науковим доказом ефективності.

Відтак, в середині 90-х науковці стали замислюватися над надійністю доказів ефективності ПД, що призвело до організації кількох рандомізованих контрольованих досліджень [5]. Слава методу випереджала розвиток доказової бази, поклавши, таким чином, початок дискусії між прихильниками і критиками методу.

Оскільки ПД позиціонувався як метод профілактики ПТСР, а його аргументація базувалася на позитивних зворотних відгуках респондентів одразу після процедури, справжня перевірка його ефективності потребувала оцінки ефекту середньої і пролонгованої тривалості. Так, мета-аналіз досліджень ефективності ПД не показав переваг у процесах відновлення у респондентів, що отримали таку інтервенцію разово і тими, хто не піддавався жодному лікуванню. Більше того, деякі з досліджень звітували про збільшення симптомів ПТСР у тих респондентів, що отримували таку інтервенцію в порівнянні з тими респондентами, що не отримували [19].

Прихильники методу спробували реабілітувати ПД, розмежовуючи його ефект на цивільних і військових. Адже, оригінальна аргументація походила саме від експериментів з військовими. Проте, й самими авторами експериментів було визнано, що так званий позитивний ефект (нагадаємо, що під позитивним ефектом малися на увазі позитивні відгуки самих військових одразу після інтервенції), був лише у тих групах, що на момент інтервенції вже були сформовані і мали взаємини. Тому невідомо, чи позитивним відгукам слугувала саме процедура психологічного дебрифінгу, чи це зумовлено терапевтичністю групової підтримки. Самі ж авто-

ри чесно зазначали, що цей метод потребує подальшого вивчення і наразі не має достовірних доказів ефективності [4].

Розглянемо кілька присвячених вивченню користі ПД робіт. Оpubліковане у Кокранівській бібліотеці – авторитетній організації, що займається вивченням ефективності медичних засобів та методик шляхом проведення рандомізованих контрольованих досліджень, дослідження «Психологічний дебрифінг для превенції посттравматичного стресового розладу (ПТСР)» («Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD)» за авторства Rose SC, Bisson J, Churchill R, Wessely S) зазначає наступне [16]: «Немає доказів, що разова сесія індивідуального психологічного дебрифінгу є корисним засобом превенції ПТСР після травматичної події. Примусовий дебрифінг постраждалих від травмуючої події має припинитися. Більш прийнятним може бути застосування моделі “Screen and treat” (підхід, який орієнтується на проведення скринінгу з метою підбору індивідуальних адекватних методів терапії)».

У дослідженні вивчався метод стрес-дебрифінгу критичного інциденту (Critical incident stress debriefing, далі – CISD). Дослідження проводилося за участі постраждалих від опіків осіб, що проходили лікування у лікарні. Групи були поділені на експериментальну, учасникам якої було надано один сеанс ПД тривалістю 30-120 хвилин впродовж 3-х тижнів від травмуючої події, і контрольну, якій дебрифінг не надавався. І хоч на початку експерименту між групами не було суттєвих відмінностей у рівнях депресії, тривоги і ПТСР, під час 90-денного спостереження і оцінки за структурованим клінічним інтерв'ю, частота ПТСР була 21 % у експериментальній і 15 % у контрольній, що не показує значної різниці між двома групами. Через 13 місяців, частота ПТСР була вища у групі, що отримувала сесію дебрифінгу (26 %) в порівнянні з групою, що не отримувала (9 %) [12, 16].

Автори наводять наступні висновки: «Одна сесія індивідуального дебрифінгу ані попередила розвиток ПТСР, ані знизила психологічний дистрес, в порівнянні з контрольованою групою. Через рік, одне дослідження показало значимо підвищений ризик виникнення ПТСР у тих, хто отримував дебрифінг.

Ті, хто отримували дебрифінг, не повідомили про зниження тяжкості протікання ПТСР ні через 1-4 місяці, ні через 6-13 мі-

сяців, ні через 3 роки. Також не виявлено доказів того, що дебрифінг загалом знизив загальну уразливість психіки, уразливість до депресії і тривоги, або що ефект дебрифінгу на ці показники перевищував би показники від психоедукаційної інтервенції [16]. Однак, попри те, що дослідники погоджуються з висновками щодо неефективності застосування ПД, автори зазначають, що аргумент щодо можливої шкоди цього методу (підвищення ризику виникнення ПТСР внаслідок ПД) потребує подальшого вивчення [20].

Метааналіз авторів Emmerik, Kamphuis та ін. [19] також супроводжується висновками про те, що відсутність інтервенцій сприяла покращенню стану і зменшенню симптомів ПТСР, в той час як сесія стрес-дебрифінгу критичного інциденту призводила до того, що ці симптоми не покращувалися. Автори інтерпретують результати досліджень висновком, що ні CISD ні інші такого роду інтервенції не сприяють природному одужанню від психічної травми [12].

Стаття в журналі *The British Journal of Psychiatry*, що випускається Кембріджським університетом – «Psychological debriefing is a waste of time» [20] описує природу дебатів навколо цього методу, спроби очистити репутацію методу шляхом виділення різних типів дебрифінгу, приводить дослідження щодо його неефективності (також згадуючи, що й немає надійних доказів того, що дебрифінг обов'язково веде до підвищення ризиків розвитку ПТСР), та все ж наполягає на тому, що від цього методу варто відмовитися на користь більш сучасних і таких, що доказали свою ефективність:

«Боюся, що я не можу точно побачити відмінності між різними формами дебрифінгу, і я не можу знайти серйозних аргументів щодо того, чому одна форма має бути неефективною, тоді як те, що здається варіацією, має бути ефективним, навіть якщо немає доказів в підтримку цієї ідеї. »

«Тепер ясно, що настав час терміново переоцінити, як ми реагуємо на травму. Немає сумніву, що ті, хто намагається допомогти людям, які постраждали від катастроф і травм, мають благородні мотиви, але цього, на жаль, недостатньо. Натомість настав час, щоб тих, кого запросили взяти участь у дебрифінгу, що відбувається в той момент, коли людина найбільш вразлива, принаймні попереджали, що ця процедура може бути не стільки корисною, скільки й нашкодити» [20].

Таким чином, автор підкреслює, що метод визнано щонайменше неефективним, а різні його варіації, що пропонуються його прихильниками задля покращення його репутації – все ще мають ту ж проблему у вигляді відсутності досліджень і доказової бази ефективності. Подальше Оксфордське дослідження впливу дебрифінгу на постраждалих в результаті автомобільних пригод, опубліковане у 2018 році [13] показало наступне:

«Група, що отримала інтервенцію, через 3 роки показала значно гірші наслідки стосовно психіатричних симптомів. Тривога перед подорожуванням в якості пасажира, біль, фізичні проблеми, загальний рівень функціонування, і фінансові проблеми. Пацієнти, які мали високі ступені інтрузій та симптомів уникнення, залишались з цими симптомами, якщо отримували інтервенцію, і навпаки, одужували, якщо не отримували інтервенцію. »

Таким чином, висновки цього дослідження знову ставлять під сумнів ідею про те, що дебрифінг є ефективним засобом запобігання ПТСР.

Такою є критика методу. Цікаво, що прихильники ПД не приховують ризиків і застережень щодо використання цього методу, а також мають чіткі рекомендації і протипоказання щодо його використання.

Так, Єммі Адлер у своїй презентації дебрифінгу WRAIR (Інституту досліджень армії Волтер Рід) [1], наводить перелічені вище дослідження Кокрейнівської бібліотеки [16] і Ланцет [19], а також критикує дослідження, проведені на цивільних [1, 13] і вважає що вони мають обмежену цінність щодо застосування на військових.

Серед потенційних застережень Адлер наводить: повторне переживання травми людиною; споглядання людьми травми інших учасників; втручання у природний процес зцілення; припущення про негативні меседжі щодо відновлення; забезпечення одноразової інтервенції без продовження супроводу; нестача всебічних ґрунтовних досліджень, що демонструють ефективність.

Також Адлер застерігає від використання методу на окремих постраждалих і зазначає, що його може бути застосовано тільки до учасників сформованих команд, з якими проведено попередню підготовку і які мають пряме відношення до події (військові, рятувальники, професіонали що надають першу допомогу і т. п.). Для всіх

інших випадків Адлер рекомендує використовувати першу психологічну допомогу (PFA – Psychological First Aid) [1].

Таким чином, ми розглянули історію виникнення, поширення і популяризації методу психологічного дебрифінгу. На основі задокументованих джерел можна прийти до висновку, що слава цього методу випереджала розробку доказів і обґрунтування його ефективності, а подальші дослідження показали [16, 19], що користь ПД переоцінена. Прихильники методу і його варіацій, в свою чергу, не приховують потреби у дослідженнях і розробці доказової бази [1, 4] і попереджають про можливі ризики що супроводжуються його застосування: ретравматизацію, вікарну травму, втручання в природний процес зцілення, нестачу доказів ефективності, а також застерігають від використання методу на цивільних і у групах, що не мали попередньої підготовки [1]. Перечислена проблематика а також наукова дискусія, що продовжується між прихильниками і критиками методу, триває, і призвела до виключення методу ПД з рекомендованих професійними спільнотами світу.

Так, Національний інститут здоров'я і досконалості допомоги (National Institute for Health and Care Excellence – NICE) – виконавчий позавідомчий державний орган Департаменту охорони здоров'я Об'єднаного Королівства рекомендує відмовитися від методу дебрифінгу у своїх рекомендаціях по лікуванню ПТСР [14]. А Національний центр ПТСР при департаменті у справах ветеранів США, посилаючись на організацію ISTSS (Інтернаціональна спільнота досліджень травматичного стресу), також відмічають, що метод дебрифінгу не має доказової бази і не може використовуватися для профілактики ПТСР. Проте, вони відзначають його корисні сторони, що стосується скринінгу, психоедукації і підвищення моралі у військових. Для попередження і терапії ПТСР радять використовувати когнітивно-поведінкову терапію та першу психологічну допомогу (PFA) [11, 6, 14, 17]. В Україні до рекомендацій МОЗ, заснованих на показаннях уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД), психологічний дебрифінг не увійшов. Натомість, для терапії ПТСР рекомендується використовувати такі методи як травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія (ТФ-КПТ) та EMDR, при ускладнених випадках

пропонується використання цих методів в поєднанні з психофармакологією [2].

Висновки. На основі вищезазначеного наголошуємо на важливості продовження дискусії щодо ПД в професійній спільноті України, оновленні теоретико-методологічної бази з підготовки психологів згідно з актуальними тенденціями і рекомендаціями, а також на інформуванні майбутніх спеціалістів щодо ризиків і застережень у використанні методів з обмеженою доказовою базою, таких, як психологічний дебрифінг.

Література.

1. Адлер Е. Психологічний дебрифінг: міркування стосовно застосування представниками професій високого ризику. Вебінар: «Психологічна допомога військовослужбовцям: досвід фахівців США» 1 березня 2023. WRAIR.

2. Державний експертний центр МОЗ України. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад : веб-сайт. URL: https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/images/dodatki/2016_121_PTSR/2016_121_YKPMPTSR.pdf?fbclid=IwAR067yDcA17RTxg67qO3m5jk6gnQmaS5HAe49cy0WzBggEciVhmdD_hTg7k (дата звернення: 10. 11. 2023).

3. Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад. Міністерство охорони здоров'я України : веб-сайт. URL: <https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad> (дата звернення: 10. 11. 2023).

4. Adler A. B., Castro C. A., McGurk D. Time-driven battlemind psychological debriefing: a group-level early intervention in combat. *Mil Med.* 2009.

5. Bisson, J. I., McFarlane, A. C., Rose, S., Ruzek, J. I., & Watson, P. J. Psychological debriefing for adults. Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. The Guilford Press. 2009. Pp. 83 – 105.

6. Brief summary: Psychological debriefing for post-traumatic stress disorder. Society of clinical psychology: website. URL: <https://div12.org/treatment/psychological-debriefing-for-post-traumatic-stress-disorder/> (Last assessed: 15. 11. 23)

7. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults. American Psychological Association : website. URL: <https://www.apa.org/ptsd-guideline/ptsd.pdf> (Last accessed: 10. 11. 2023).

8. Debrief. Merriam-Webster dictionary: website. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/debrief> (Last assessed: 10. 11. 2023).

9. Gartlehner G., Forneris C. A., Brownley K. A., Gaynes B. N., Sonis J., Coker-Schwimmer E., Jonas D. E., Greenblatt A., Wilkins T. M., Woodell C. L., Lohr K. N. Interventions for the Prevention of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults After Exposure to Psychological Trauma. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). 2013. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK133344/> (Last assessed 15. 11. 23).

10. Hawker D. M., Durkin J. To debrief or not to debrief our heroes: That is the question. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 18, (6). 2010. Pp. 453-463. URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.730/abstract> (Last assessed: 15. 11. 2023).

11. Interventions for the Prevention of Post-traumatic Stress Disorder in Adults After Exposure to Psychological Trauma. Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ) : website. URL: <https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/ptsd-adults-trauma-interventions/research-protocol> (Last accessed: 10. 11. 2023).

12. Matthew J. Friedman, Paula P. Schnurr, Terence M. Keane. *Handbook of PTSD: science and practice*. 3d ed. N. -Y., The Guilford Press. 2021. p. 318-319.

13. Mayou R. A., Ehlers A., Hobbs M. Psychological debriefing for road accident victims. Three-year follow-up of a randomized controlled trial. *British Journal of Psychiatry*. 2000. Pp. 589 -593.

14. Post-traumatic stress disorder. NICE guideline. NICE The National Institute for Health and Care Excellence : website. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/resources/posttraumatic-stress-disorder-pdf-66141601777861> (Last accessed: 10. 11. 2023).

15. Raphael B., Wilson J. *Psychological Debriefing: Theory, Practice and Evidence*. 2000. – 388 p.

16. Rose S. C., Bisson J., Churchill R., Wessely S. Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). *Cochrane Database Syst Rev*. 2002.

17. Treatment – Post-traumatic stress disorder. National Health Service (NHS): website. URL: <https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/treatment> (Last assessed: 10. 04. 2023).

18. Treatment Essentials. PTSD: National Center for PTSD: website. URL: <https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/txessentials/index.asp> (Last assessed: 10. 11. 2023).

19. Van Emmerik A. A., Kamphuis J. H., Hulsbosch A. M., Emmelkamp P. M. Single session debriefing after psychological trauma: a meta-analysis. *Lancet*. 2002.

20. Wessely S., Deahl M. Psychological debriefing is a waste of time. *The British Journal of Psychiatry*, 183(1). 2003. Pp. 12-14.

5.10. Диференціально-діагностичні критерії та показники конструктивності життєвих стратегій подружжя

Морозова О. В.

Актуальність. У сучасній соціально-психологічній літературі можна виокремити два основні підходи до дослідження життєвих стратегій, які розрізняються по тому, що розуміється в якості підстави для їх типологізації.

Перший підхід характеризується тим, що за основу типу життєвих стратегій береться тип соціальної адаптації подружжя. Дослідники виокремлюють три типи стратегій в залежності від соціальних і особистісних функцій, які виконуються подружжям [3; 7]: успішна зовнішня адаптація; ефективна внутрішня адаптація; стратегія виживання. Стратегія успішної зовнішньої адаптації орієнтована на сьогодення і найближче майбутнє, ідентифікація спрямована на первинні (сім'я та ін.) і професійні групи. Стратегія ефективної внутрішньої адаптації орієнтована на минуле і віддалене майбутнє, ідентифікація спрямована на великі групи – країна, народ. І, нарешті, третя стратегія – стратегія виживання – характеризується невисоким статусом і погіршується матеріальним становищем подружжя, які ідентифікують себе з групами людей зі схожою долею [7].

Другий підхід в якості основи типологізації життєвих стратегій виділяє позицію, яку займає людина по відношенню до свого власного життя і пов'язану з цим активність [2]. Вважається, що людина може займати три різні, хоча і взаємозалежні позиції: «мати» (рецептивна активність); «досягати» (мотиваційна активність); «бути» (творча або «екзистенціальна» активність).

Перший тип активності подружжя (рецептивна або «споживацька») є основою стратегії благополуччя, другий тип активності є передумовою стратегії життєвого успіху і третя (творча, «екзистенціальна») активність характерна для стратегії самореалізації особистості.

Наведемо систематизацію різних підстав, за якими зроблено класифікацію життєвих стратегій:

- за ступенем усвідомлення індивідом – свідомі і несвідомі;
- за спрямованістю змін, що відбуваються в особистості – прогресивні, регресивні (конструктивні, деструктивні);
- за характером активності індивіда – активні, реактивно-адаптивні, пасивні;
- за локусом контролю – екстернальні, інтернальні (екзогенні, ендогенні);
- за способом сприйняття умов життя – гедоністичні і засновані на почутті обов'язку, відповідальності;
- за ступенем збігу з цілями і завданнями суспільства – просоціальні, асоціальні та антисоціальні;
- за ступенем реалізації – ефективні, малоефективні і неефективні; – за характером і способом самореалізації – стратегії самоактуалізації і маніпуляції; за характером співвідношення емоційності і раціональності – афективні, когнітивні;
- за пріоритетністю в соціальному обміні – стратегії привласнення або збалансовані (гармонійні);
- за наявністю елемента творчості – креативні і звичайні;
- за типом активності – успіху, благополуччя та самореалізації;
- за базисними тенденціями – стратегії задоволення потреб, адаптивного самообмеження, творчої експансії і встановлення внутрішньої гармонії;
- за програмними цілями і засобами – підпорядкування, інновації, традиції;
- за типом особистісної організації часу і ставлення до нього – буденні, функціонально-дієві, спостережно-рефлексивні і перетворюючі стратегії;
- за типом пристосування до мінливого зовнішнього соціального середовища – пасивні і активні;
- за ступенем аффіліації – індивідуальні і колективістські [2; 4; 5; 8].

Мета. Надати аналіз диференціально-діагностичним критеріям та показникам конструктивності життєвих стратегій подружжя.

Результати дослідження. При визначенні критеріїв і показників конструктивності життєвих стратегій подружжя та розкриття

особливостей неконструктивних життєвих стратегій подружжя констатовано, що їх формування реалізується за допомогою механізму ідентифікації, що забезпечується, з одного боку, дією механізму типізації (віднесення до усталених або референтних типів життєвих стратегій, наявних у даному культурному просторі), з іншого, – механізму індивідуалізації (додання стратегії життя власного індивідуального, неповторного і унікального змісту, що, в цілому, виражає своєрідність і визначеність). Різниця між ними полягає також в спрямованості і послідовності переходу від одних структурних орієнтацій до інших. При цьому типізація означає перехід від культурних і соціальних орієнтацій до індивідуальних, суб'єктивних, а індивідуалізація характеризує зворотний перехід в процесі вибору життєвих стратегій [3].

Аналізуючи ступінь узгодженості чоловіка і дружини, увага акцентувалася на тих сімейних цінностях, які характеризуються найменшим збігом, оскільки їх неузгодженість є однією з причин рольової невідповідності у подружній парі. Неузгодженість очікувань і домагань шлюбних партнерів є конфліктогенним чинником, що дестабілізує міжособистісні відносини в сім'ї.

Аналізуючи специфіку уявлень подружньої пари про значимість сімейних цінностей, ми виходили з того, що установки чоловіка і дружини щодо найважливіших сфер життєдіяльності сім'ї можуть мати ідеальний характер, але не відповідати реальній рольовій поведінці подружжя. Адекватність рольової поведінки чоловіка і дружини залежить від очікувань рольовим домаганням подружжя. Середні значення показників рольових очікувань і домагань у шлюбі по вибірці жінок і чоловіків наведено у табл. 1.

За допомогою результатів тесту «Рольові очікування і домагання у шлюбі» ми побачили, що жінки та чоловіки мають різні очікування. Шкали, де є очікування (господарсько-побутові, батьківсько-виховні, соціальної активності, емоційно-психотерапевтичні, зовнішньої привабливості) та домагання (у цих же сферах) відображають рівень очікувань від партнера в кожній із цих сфер та терапії. Для забезпечення зворотного зв'язку використовувалися такі психотехніки, як «соціограма в дії», «сімейна скульптура», «сімейна хореографія» (подібне «живим картинкам», коли подружжя, обираючи пози і розташування у просторі, намагалися зобра-

зити свої взаємини в статичі або динаміці) та настанови на власну активність у тій чи іншій сфері.

Таблиця 1

Середні значення показників рольових очікувань і домагань у шлюбі (76 подружніх пар)

Група	Інтимно-сексуальна сфера	Особистісна ідентифікація з шлюбним партнером	Господарсько-побутові очікування (від партнера)	Батьківсько-виховна очікування (від партнера)	Соціальна активність очікування (від партнера)	Емоційно-психотерапевтична очікування (від партнера)	Зовнішня привабливість очікування (від партнера)	Господарсько-побутові домагання (від себе)	Батьківсько-виховна домагання (від себе)	Соціальна активність домагання (від себе)	Емоційно-психотерапевтична домагання (від себе)	Зовнішня привабливість домагання (від себе)
жінки	5,1	6,4	5,7	5,8	6,8	7,3	6,6	5,9	6,1	6,9	5,7	5,9
чоловіки	5,8	6,3	4,2	6,9	5,4	6,9	7,1	5,3	7,3	7,8	5,2	5,1

Слід зазначити, що конфліктні відносини у подружніх відносинах виникають, як правило, через те, що погано розуміються та враховуються потреби один одного.

Тест-опитувальник В. Століна, Т. Романової, Г. Бутенко, застосований у дослідженні для оцінки задоволеності шлюбом як критерію благополуччя подружжя, надав можливість диференціювати оцінки шлюбу на такі категорії: абсолютно благополучні; благополучні; скоріше благополучні; перехідні; швидше неблагополучні; неблагополучні; абсолютно неблагополучні [8].

Використовуючи ці критерії, за допомогою частотного аналізу досліджувані були розподілені на групи відповідно до критеріїв та показників конструктивності їх життєвих стратегій.

Слід зазначити, що конструктивним життєвим стратегіям відповідали уявлення подружжя про себе як про впевнених, сильних людей, які можуть вплинути на життєву ситуацію, стати головною дійовою особою, здатною нести відповідальність за себе і своїх

близьких; неконструктивним – уявлення подружжя про себе як про слабких людей, що не можуть вплинути на свою життєву ситуацію, з почуттями невпевненості в своїх силах і здібностях, безсиллям і безпорадністю (позиція жертви). Конструктивним життєвим стратегіям відповідали також уявлення про позитивну природу подружжя, ставлення до інших людей як до рівних собі, здатність звернутися до них з проханням про допомогу в скрутній ситуації; неконструктивним – уявлення про інших людей, як про небезпечних і ворожих, заперечення можливості звернутися до них за допомогою у важкій ситуації, або як про більш сильних (прагнення сховатися за їх спиною, нездатність спертися на себе).

При конструктивних життєвих стратегіях активність спрямована на вирішення виниклого протиріччя, її характер відповідає особливості ситуації; при неконструктивних – активність носить захисний характер і являє собою форми відчуження: відчуження від людей і агресивну активність, спрямовану на подолання перешкоди за будь-якою ціною; відчуження від себе і своїх ресурсів, пошук того, хто вирішить ситуацію, або пасивна поведінка (споглядання). Конструктивним життєвим стратегіям відповідає гнучкість і різноманітність обраних відповідних способів; неконструктивним – стереотипне, фіксоване, негнучке реагування. Проаналізувавши досліджувані показники, ми виокремили ті з них, що мають відмінності на рівні статистичної тенденції (при $p \leq 0,1$), статистично достовірні (значущі) відмінності, що вказують на те, що рішення значимо і приймається (при $p \leq 0,05$) і відмінності на високому рівні статистичної значущості (при $p \leq 0,01$), що вказують на високу значимість. За підсумками статистики парних вибірок складена табл. 2, що відображає кореляції і критерії міжгрупових факторів щодо конструктивності життєвих стратегій подружжя. До групи з конструктивними проявами життєвих стратегій подружжя, які стабілізують їх стосунки, увійшли 47 (61,8 %) подружніх пар. Їх відрізняє усталене прагнення до збереження сім'ї; бажання і здатність до узгоджених дій на її благо; ініціативність та реальний внесок кожного з подружжя у вирішенні сімейних проблем (на рівні 4-5 балів важливості та на рівні 4 балів достатньої міри реалізованості кожним із подружжя); оптимальне поєднання особистих цілей і потреб зі справами і потребами подружжя; орієнтація на можливості саморозвитку, са-

мовдосконалення та особистісні досягнення у поєднанні з домінуванням сімейних цінностей; високі показники загальної усвідомленості життя та його керованості; прагнення до емоційного єднання і згуртованості подружжя, створення атмосфери довіри, взаєморозуміння; конструктивність установок на шлюб (на рівні 32 ± 4 бала), реальний погляд на суперечності, застосування, при необхідності, протективних і дефензивних захисних механізмів; терпимість; вміння попереджати бажання і потреби партнера; узгодженість сімейних цінностей і ролевих очікувань у шлюбі, усвідомлення причин і наслідків подружньої невірності; прагнення до єдиних підходів у вихованні дітей; високий ступінь задоволеності шлюбом на рівні благополучної сім'ї (38 ± 5 балів).

Таблиця 2

Описова статистика міжгрупових факторів щодо конструктивності життєвих стратегій подружжя (76 подружніх пар)

Групи	Кількість подружніх пар	Середні показники за ОЗШ по вибірці чоловіків	Середні показники за ОЗШ по вибірці жінок	t
I група (з конструктивними проявами життєвих стратегій)	47 (61,8 %	34,82	30,46	4,263**
II група (з неконструктивними проявами життєвих стратегій)	29 (38,2 %)	24,39	19,25	3,011*
Середні показники за вибіркою	76	29,60	24,86	
		27,23±0,31		

Примітка: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$.

До II групи з неконструктивними проявами життєвих стратегій подружжя, що руйнують стабільність відносин між ним, увійшли 29 (38,2 %) подружніх пар.

Їх характеризує нездатність повною мірою оцінити і зрозуміти почуття партнера, його характерологічні особливості і звички; незадоволеність самореалізацією; неузгодженість в системі цінностей (на рівні низьких (2 ± 1) балів їх важливості для сім'ї взагалі та на рівні низької міри реалізованості у 2-3 бали кожним із подружжя); невизначеність і суперечливість рольових очікувань й рольових домагань, розбіжність уявлень про рольову поведінку; нездатність контролювати і регулювати свої власні емоції і почуття; зневіра у можливість сталості подружньої любові і спотворені уявлення про фактори сімейного благополуччя; прояви споживацько-егоїстичного ставлення до подружнього життя в цілому; неконструктивність установок на шлюб (на рівні 60 ± 10 балів), фрустрованість, агресія, фіксація на психотравмуючому досвіді; ігнорування взаємоповаги, довіри і взаєморозуміння; відсутність єдиних підходів до вирішення побутових проблем та виховання дітей; низький ступінь задоволеності шлюбом на рівні неблагополучної сім'ї (19 ± 2 бала).

На формування життєвої стратегії подружжя впливає життєва позиція, сукупність життєвих цілей, завдань подружжя. Якщо позиція суперечлива, нестійка, – стратегію побудувати важко. Перш ніж почати обмірковувати стратегічний план життя, потрібно розібратися в цих протиріччях, намагатися визначити їх сутність, почати вирішувати. Потреба у визначенні, формуванні та реалізації подружжям своєї життєвої стратегії тісно пов'язана з потребою зробити своє життя більш насиченим внутрішніми подіями, більш інтенсивним духовно.

Встановлено, що відповідність життєвих орієнтацій і засобів їх забезпечення досягається як власними ресурсами подружжя (здібності, знання, вміння), так і за допомогою залучених ресурсів, що надаються іншими людьми, організаціями, інститутами. Формування нових поведінкових установок і ціннісних орієнтацій, які відображають нові реалії, без підтримки відповідних соціальних інститутів не захищають від подальшої дезадаптації сім'ї.

Дослідження показало, що зміна життєвої стратегії подружжя характеризується нуклерізацією (зменшенням кількості членів сім'ї), послабленням внутрішніх зв'язків, зниженням рівня взаємозалежності її членів один від одного, зміною характеру подружніх відносин, переходом до нових ролей, великою увагою до особистих

потреб і інтересів особистості, падінням народжуваності, зростанням числа розлучень, розвитком альтернативних форм сім'ї.

Вплив на вибір даних стратегій має, з одного боку, специфіка соціально-економічних трансформацій, зміна рівня добробуту, з іншого, – бажання успіху, підвищення свого статусу. Розвиток нової репродуктивної поведінки подружжя констатує відрив сучасних орієнтацій від традицій шлюбності і сімейного способу життя, обмежує процес народження дітей в сучасному суспільстві. При побудові подружжям стратегії життя відбувається послідовна операціоналізація етапів стратегій з єдиною взаємною узгодженістю. На цьому створюється загальна програма реалізації життєвої стратегії подружжям.

Психологічна наука виокремлює декілька форм надання допомоги, серед яких найпоширенішими є консультування, індивідуальна психотерапія, соціально-психологічний тренінг та групи підтримки. Психологічне консультування використовують для вирішення конкретних життєвих проблем, з якими стикається клієнт. Індивідуальна психотерапія є тривалим процесом, спрямованим на вирішення глибоких проблем особистості. Соціально-психологічний тренінг використовують у випадку необхідності розвитку поведінкових навиків без опрацювання життєвого досвіду клієнта. Група підтримки – проміжна форма роботи, застосування якої дозволяє опрацювати особистісний досвід клієнта з використанням психотерапевтичних технік для покращення якості функціонування особистості, використати переваги групової форми роботи [1]. Група підтримки характеризується як мала терапевтична група, склад учасників якої є досить однорідним, зі схожими проблемами, для подолання яких вони звертаються у групи. Кількість учасників обмежена [1].

Психологічне консультування в межах соціально-психологічної програми корекції неконструктивних життєвих стратегій подружжя має виражену специфіку та залежить від професіоналізму консультанта та освідомлення досвіду подружжя. Так, стиль консультування в русі особистісно-орієнтованого підходу відрізнявся повною центрацією на подружжі, особлива увага була приділена переживанням кожного та їх досвіду. Когнітивно-поведінковий підхід передбачав короткострокове консультування, схоже з процесом соціального навчання або перенавчання.

Консультування являє собою професійну взаємодію між консультантом і клієнтом, яка спрямована на вирішення проблеми останнього. Консультування відрізняється від психотерапії і центроване на більш поверхневій роботі (наприклад, на міжособистісних стосунках подружжя), основне його завдання – допомогти подружжю подивитися на свої проблеми і життєві складнощі з боку, обговорити ті моменти взаємовідносин, які, будучи джерелами труднощів, не усвідомлюються і не контролюються [5]. Також консультація – одна з форм здійснення психотерапії, центральна задача якої в тому, щоб допомогти подружжю знайти своє справжнє Я і знайти в собі мужність стати цим Я [1; 5].

В ході дослідження за основу було визначено розширене використання терміну «психологічне консультування» (В. Бінас, Б. Мастеров та ін) як психологічного супроводу подружжя, зокрема в складні періоди життя. Залежно від життєвої стратегії подружжя цілями консультування є ті чи інші зміни самосвідомості (формування продуктивного ставлення до життя; знаходження віри в свої сили, відновлення стосунків подружжя, формування відповідальності один за одного та ін.), поведінкові зміни (формування продуктивної взаємодії подружжя один з одним і з зовнішнім світом). Психологічне консультування подружжя в межах соціально-психологічної програми корекції їх неконструктивних життєвих стратегій було спрямоване на відновлення або перетворення зв'язків подружжя один з одним і світом, на розвиток вміння розуміти один одного і формувати конструктивні життєві стратегії, гнучко регулюючи відносини як самого подружжя, так і з різними соціальними групами.

Соціально-психологічна програма корекції неконструктивних життєвих стратегій подружжя складалася з наступних основних блоків:

1. Інформаційна частина, знайомство учасників між собою, вправи на підвищення рівня довіри та створення позитивної атмосфери в групі, аналіз ускладнень у подружніх парах; діагностичний етап – відстеження, в тому числі у динаміці, розвитку подружжя, які звернулися за допомогою; збір інформації, діагностичні процедури. На основі спільного дослідження психолог і подружжя визначали орієнтири спільної роботи (цілі та завдання), розподіляли відповідальність, виявляли межі необхідної підтримки.

Ми намагалися здійснити необхідну психологічну підтримку подружжя, гнучко змінюючи її форму і міру, відповідно до їх стану та перспективи найближчого розвитку; створити умови для змін і стимулювання цього процесу: організувати, спрямувати, забезпечити сприятливі для умови, прагнучи до того, щоб сконструювати конструктивні життєві стратегії.

2. Налагодження конструктивного спілкування, підвищення рівня емпатійного та активного слухання, розвиток вміння слухати.

Проведено відбір і застосування засобів, для створення умов, що стимулюють позитивні зміни у відносинах подружжя і сприяють оволодінню продуктивною взаємодією. Узагальнювалися результати діагностики і на їх основі визначалися умови, необхідні для сприятливого розвитку конструктивних життєвих стратегій подружжя, набуття позитивних відносин всередині подружжя та зі світом в цілому, а також гнучкості і комунікативної адаптивності. Розроблялися і реалізовувалися індивідуальні та групові програми соціально-психологічної підтримки сім'ї, її розвитку, орієнтовані на конкретне подружжя з врахуванням їх особливостей та потреб. Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги подружжям II групи, які мають особливо складні проблеми.

3. Аналіз сімейних цінностей та цілей подружнього життя, підвищення ступеня сімейної адаптованості та згуртованості подружніх пар. У цьому блоці передбачався аналіз проміжних і кінцевих результатів спільної роботи і внесення на їх основі змін у психокорекційний процес.

Підвищення ступеня сімейної адаптованості та згуртованості подружніх пар в межах формування їх життєвих стратегій розглядався нами як пролонгований, багатостадійний процес. Його аналіз передбачав виокремлення динаміки, яка складалася зі стадій, ступенів та кроків.

Для осмислення динаміки ми скористалися метафорою спільної подорожі від наявної ситуації до бажаного майбутнього. Допомога подружжю передбачала вирішення трьох основних задач: визначити «місце, на якому в момент звернення перебуває подружжя» (У чому полягає проблема? У чому сутність неблагополуччя подружжя та його причини?); виявити «Місце, куди хоче прийти подружжя», тобто стан, якого вони хочуть досягти (сформувати

образ бажаного майбутнього, визначити його реальність) і вибір напрямку змін (Що робити? У якому напрямі рухатися?); допомогти подружжю туди перебратися (Як це зробити?).

Процес вирішення першого завдання відповідав діагностичному компоненту психологічного супроводу; другого – формування рішення або вибору шляху; третього – перетворенню або реабілітації [2; 4; 7 та ін.].

4. Вироблення навичок подолання конфліктних ситуацій, підвищення рівня рефлексії подружжя.

Основними методами цього блоку програми виступили як інтерв'ю, спрямоване на соціально-психологічну підтримку подружжя, так і діалог, а також поведінкові методи, психодрама і рольове моделювання, аналіз історії сім'ї, методи групової терапії. Для забезпечення зворотного зв'язку використовувалися такі психотехніки, як «соціограма в дії», «сімейна скульптура», «сімейна хореографія» (вони представляли собою щось подібне «живим картинкам», коли подружжя, обираючи пози і розташування у просторі, намагалися зобразити свої взаємини в статичній або динамічній).

Висновки. Соціально-психологічна програма показала позитивну динаміку щодо підвищення ступеня самореалізації в шлюбі на операціональному рівні, рівні цінностей та рольових установок, розвитку рефлексії та узгодженості сімейних цінностей та рольових очікувань, розширення досвіду безконфліктного спілкування в системі міжособистісної сімейно-рольової взаємодії подружжя, збільшення ступеня конструктивності установок на шлюб, зростання загального інтегрального показника задоволеності шлюбом, поряд зі зниженням рівня агресивності, фрустрованості, відчуження, фіксації на психотравмуючому досвіді тощо.

Література.

1. Донець О. І. Програма роботи з розлученими жінками у групах підтримки / О. І. Донець // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Т. 11. – Вип. 6. – Кн. 1. – С. 279–287.

2. Кісарчук З. Г., Єрмусевич О. І. Психологічна допомога сім'ї: навч. посіб. – К. : Главник, 2006. – 127 с.

3. Корольчук М. С. Психологія сімейних взаємин. – К. : Ніка-центр, 2011. – 296 с.
4. Мурадян О. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз. // Соціологічні студії. – 2013. – № 1(2). – С. 49 – 54.
5. Орбан-Лембрик Л. Е., Лембрик С. П. Шлюбно-сімейні взаємини і стабільність родинного життя // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 120-136.
6. Психологія сім'ї: навчальний посібник / За заг. ред. : В. М. Поліщука. – Суми: Університетська книга, 2008. – 238 с.
7. Ткаченко В. Є. Благополуччя подружніх відносин і його психологічні детермінанти: теоретичний аналіз // Наука і освіта. – 2010. – № 3. – С. 113– 131.
8. Федоренко Р. П. Психологія молодшої сім'ї і сімейна криза: монографія. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 168 с.
9. May R. Psychology and the human dilemma. – N. -Y. :W. W. Norton, 1991. – 356 p.

5.11. Посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців: теорія та діагностика

Опанасенко С. В.

Актуальність. Психічне здоров'я у поєднанні з фізіологічним початком виступає однією з основних складових загального ментального здоров'я людини. Тому аксіома: індивідуум не може бути абсолютно здоровим без одного з основних елементів – психічного здоров'я, сьогодні в умовах воєнного стану набуває надактуальності та надважливості. Перебуваючи в умовах негативного впливу сучасного напруженого ритму життя, подвійних моральних стандартів, війни сучасна людина змушена діяти в умовах, наближених до екстремальних. Наразі, стрес є нормальною реакцією організму людини на складні життєві ситуації. Військовослужбовці є особливою категорією громадян, які піддаються великому стресовому навантаженню під час виконання своїх посадових обов'язків. Тому, не дивно, що багато з них переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Серед низки стресових станів ПТСР посідає одне з чільних місць та потребує обов'язкового діагностування й лікування. У військовослужбовців ПТСР може розвиватися через досвід бойових дій, побачених картин жорстокості та насильства, страх за власне життя та життя товаришів, розділення від родини та друзів та інші подібні фактори. Відмова від лікування або заперечення наявності ПТСР негативно впливає на ментальне здоров'я особистості.

До проблематики, що пов'язана із вивченням ПТСР зверталися як зарубіжні так і українські вчені, зокрема, Р. Волошин, Л. Китаєв-Смик, Р. Лазарус (вивчення механізмів розвитку ПТСР, його симптоматика, фази та причин розвитку); І. Котєнєв, В. Лисенко, О. Морозов, В. Омелянкович, Н. Тарабіна, О. Тімченко, С. Яковенко (технології діагностики подолання стресових розладів та ПТСР); І. Малкіна-Пих (психологічна допомога в кризових ситуаціях); В. Доморацький, Н. Крилов, А. Пушкарьов (особливості корекції посттравматичного стресового розладу в учасників військових дій); Г. Сельє (теоретичні основи по-

няття про ПТСР і загальний адаптаційний синдром); Ф. Шапіро (психотерапія емоційних травм).

Мета. Теоретично проаналізувати основні особливості ПТСР у військовослужбовців та обґрунтувати методики його діагностики.

Результати дослідження. Психічне здоров'я має взаємозв'язок не лише із наявністю чи відсутністю захворювання у людини, воно інтегрується в інші аспекти її життя, соціального середовища, впливає на переживання останньою всього спектру позитивних чи негативних емоцій, її внутрішнього благополуччя та фізичного здоров'я. Стрес – це фізіологічна та психологічна реакція організму на подразники, які спричиняють тривогу або небезпеку. Це може бути щоденні стресові ситуації, такі як довгий період роботи в напруженому графіку, фінансові труднощі, конфлікти з рідними або колегами, або більш серйозні стресові ситуації, такі як аварії, природні катастрофи або насильство.

Аналіз наукових джерел дозволив дійти висновку, що досліджуючи протягом останніх 80-ти років феномен стресу, науковці не змогли дійти одностайної думки щодо єдиного визначення цього поняття. З одного боку, стрес розглядається як суто негативне явище, з іншого, як таке, що має як позитивні, так і негативні площини [7]. Представники психосоматичної медицини так тлумачать дефініцію «стрес»: Ф. Александер розглядав стрес у дихотомії: стрес-чинник, стрес – реакція людини на нього; Д. Меканік досліджував природу стресу відповідно до біхевіористичної концепції та вважав, що це відповідна дискомфортна реакція організму особистості на подразники; Б. Доренвенд вивчав стрес у межах соціально-психологічної теорії як поведінкову реакцію людини на низку соціально-психологічних чинників; Г. Вольф досліджував психосоматичні реакції людей у стресових ситуаціях, тобто зміщував акцент на поведінкові характеристики особистості, визначаючи стрес як фізіологічну реакцію на зовнішні подразники [6, с. 13]. Таким чином, закордонні психологи по-різному тлумачили поняття стресу, розглядаючи окрему характеристику цього явища. Хоча їх визначення і різнились, але не суперечили одне одному (рис. 1)

Отже, у фізіології людини формування та протікання стресових реакцій відбувається так само як і у тваринному світі, основною метою чого є пристосування організму людини до нових викликів навколишнього середовища та зовнішніх подразників.

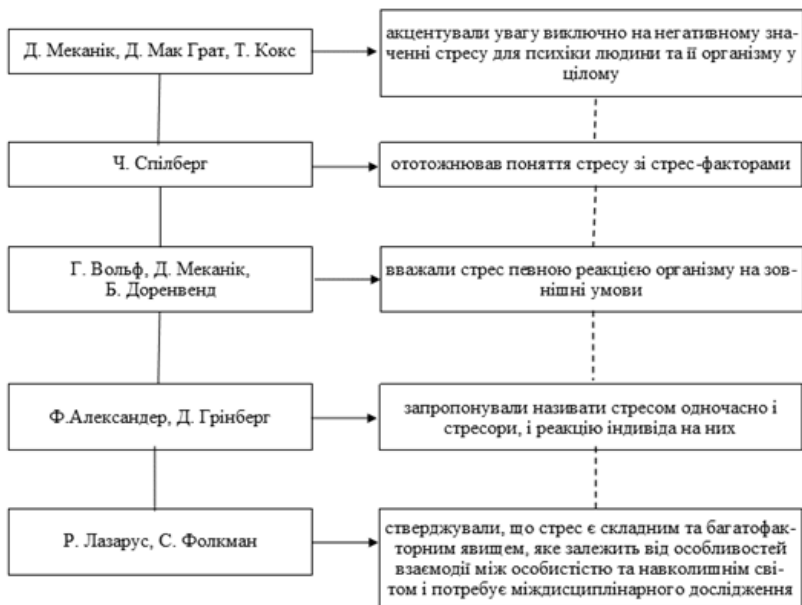


Рис. 1. Генеза тлумачення дефініції «стрес»

ПТСР є психологічним станом, який може виникнути після досвіду травматичних подій, таких як бойові дії або інші ситуації, пов'язані зі смертю, тяжкими тілесними ушкодженнями, сексуальним насиллям та ін.

«ПТСР є, мабуть, найбільш суперечливим з усіх психіатричних діагнозів. Так, існують розбіжності щодо кваліфікованих подій, які вважають достатньо травматичними, щоб спровокувати посттравматичний стресовий розлад; щодо характеру типових симптомів, які виникають після впливу травми; щодо заходів запобігання ПТСР та його лікування; а також розбіжності щодо того, яку компенсацію мають люди з ПТСР» [1, С. 23].

Стрес може спричинити багато різних фізичних та психічних проблем, в той час як ПТСР є однією з форм психічного розладу, що може виникнути після травматичної події. Тому, хоча ці два терміни пов'язані, вони мають різні концептуальні та клінічні значення.

Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, ПТСР – це психічний розлад, який може розвинути у людей,

що пережили або були свідками травматичної події, яка спричинила пошкодження або загрозу життю.

«Окрім того, військовослужбовці, які мали досвід перебування у бойових подіях, часто проявляють нестійкість психіки, за якої як великі, так і незначні труднощі штовхають людину до різноманітних видів агресії та аутоагресії, серед яких є і самогубство. У Збройних силах України та арміях інших країн існує тенденція до збільшення кількості самогубств серед військовослужбовців» [5, с. 164].

Симптоми ПТСР можуть включати:

- повторні спогади або нав'язливі думки про травматичну подію;
- нічні кошмари про травматичну подію;
- уникнення та ухилення від ситуацій, що нагадують травматичну подію;
- підвищена тривожність та підозрілість;
- зниження настрою та інтересів;
- відчуття відокремлення від інших людей;
- проблеми зі сном та концентрацією;
- підвищена роздратованість та легка збудливість.

Ці симптоми можуть розгорнутися у відмінній послідовності та різних комбінаціях, залежно від того, як травматична подія вплинула на особу. Якщо військовослужбовець переживає ці симптоми після травматичної події, важливо звернутися за допомогою до професійного психотерапевта або лікаря.

З метою створення цілісної картини розвитку ПТСР у військовослужбовців можна використати різні психодіагностичні методи. Зокрема, PCL – шкала самооцінки наявності ПТСР – базується на критеріях DSM-IV. Між версіями для військових (М) і для цивільних (С) існують незначні відмінності, так само як і для осіб, що побували в «особливо травмуючих обставинах» (S). Відмінності є в уточненні ситуації, версія для військових розглядається як базова. PCL – шкала самооцінки базується на критеріях DSM-IV та містить сімнадцять пунктів – ознак ПТСР. Респонденти оцінюють кожний пункт від одного (зовсім ні) до п'яти (дуже виражено), щоб вказати ступінь прояву конкретного симптому впродовж минулого місяця. Існують три версії PCL – шкали, хоча відмінності досить несуттєві. PCL-M – це військова версія, і питання стосуються «травматичного

(стресового) військового досвіду». PCL-C – версія для цивільного населення, і питання стосуються «травматичного (стресового) досвіду у минулому». PCL-S – версія стосується певного конкретного виду травми у минулому. Підрахунок балів ідентичний для всіх трьох версій тесту. Респонденти оцінюють кожний пункт від одного (зовсім ні) до п'яти (дуже виражено), щоб вказати ступінь прояву конкретного симптому впродовж минулого місяця. Таким чином, діапазон оцінки може перебувати в межах від 17 до 85 балів.

Не дивлячись на те, що самооцінювальні шкали не слід використовувати для постановки формального діагнозу, PCL є результативним діагностичним інструментом, Weathers та інші (1993) рекомендують межу від 50 балів і вище – як оптимальний показник для того, щоб вказати на можливе встановлення діагнозу ПТСР військовослужбовців (тобто якщо підрахунок балів дорівнює 50 і більше, то можна вже говорити про ПТСР, якщо менше – ні). Альтернативна стратегія підрахунку полягає в тому, щоб використовувати окремі пункти у відповідності до критеріїв DSM-IV. Наприклад, для підозри щодо наявності ПТСР необхідно, щоб було відмічено не менш як на рівні «3» (помірно) або вищому рівні одне із питань з діапазону №№1-5, не менш як 3 питання серед питань діапазону №№6-12, і мінімум 2 серед питань №№13-17. Пропонується граничний бал 3 (помірно) або більше для кожного пункту – як найбільш відповідний для цього підходу.

Міссісіпська шкала для оцінки ПТСР (військовий варіант) була розроблена для оцінки ступеня вираженості ПТСР у ветеранів бойових дій (Keane T. M., et al., 1987, 1988). В даний час вона є однією з широко використовуваних методик для вимірювання ознак ПТСР. Міссісіпська шкала (МШ) отримала поширення в нашій країні на початку 1990-х рр. . в ряді досліджень, присвячених вивченню психологічних наслідків аварії на ЧАЕС, а також для вивчення ПТСР серед ветеранів війни в Афганістані. МШ використовується для діагностики ПТСР в учасників та ветеранів війни. Також за допомогою даної методики можна виявити схильність особистості до почуття провини та суїцидальності. Призначена методика лише для дорослих. Шкала складається з 35 тверджень, кожне з яких оцінюється за п'ятибальною шкалою Ліккерта. Оцінка результатів проводить-

ся підсумовуванням балів, підсумковий показник дозволяє виявити ступінь впливу перенесеного індивідом травмуючого досвіду.

Шкала тривоги. Тест на тривожність Спілбергера-Ханіна допомагає визначити виразність тривожності у структурі особи. Тривожність як особистісна риса означає мотив або набуту поведінкову позицію, яка змушує людину сприймати широке коло об'єктивно безпечних обставин, як що містять загрозу, спонукаючи реагувати на них станами тривоги, інтенсивність яких відповідає величині реальної небезпеки.

Особистісна тривожність є конституційною межею, що обумовлює схильність сприймати досить широке «віяло» ситуацій як загрозливі, відповідаючи на кожную з них певною реакцією. Як схильність, особиста тривожність активізується при сприйнятті певних стимулів, що оцінюються людиною як небезпечні для самооцінки, самоповаги. При високій особистісній тривожності кожна з цих ситуацій матиме стресовий вплив на суб'єкта і викликатиме у нього виражену тривогу. Дуже висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними та невротичними зривами та психосоматичними захворюваннями.

Ситуативна тривожність характеризує стан людини в даний момент часу, що характеризується суб'єктивно переживаними емоціями: напругою, занепокоєнням, стурбованістю, нервозністю у цій конкретній обстановці. Цей стан виникає як емоційна реакція на екстремальну чи стресову ситуацію, може бути різним за інтенсивністю та динамічним у часі.

Психологічний портрет високотривожних осіб: для них характерна схильність у діапазоні ситуацій сприймати будь-який прояв якостей їх особистості, будь-яку зацікавленість у них як можливу загрозу їхньому престижу, самооцінці. Ускладнені ситуації вони схильні сприймати як загрозливі, катастрофічні. Відповідно до сприйняття проявляється і сила емоційної реакції. Такі люди запальні, дратівливі і перебувають у постійній готовності до конфлікту та готовності до захисту, навіть якщо в цьому немає потреби. Для них, як правило, характерна неадекватна реакція на зауваження, поради та прохання. Особливо велика ймовірність нервових зривів, афективних реакцій у ситуаціях, де йдеться про їхню компетенцію в тих чи інших питаннях, їхньому престижі, самооцінці, їхньому відно-

шенні. Зайве підкреслення результатів своєї діяльності чи способів поведінки, як у кращий, і у гірший бік, категоричний стосовно них тон чи тон, який висловлює сумнів, – усе це неминуче веде до зривів, конфліктам, створенню різноманітних психологічних бар'єрів, які перешкоджають ефективному взаємодії із такими людьми. До високо тривожним людям небезпечно пред'являти категорично високі вимоги, навіть у ситуаціях, коли вони здійсненні для них. Неадекватна реакція на такі вимоги може затримати, а то й загалом відсунути на довгий час виконання необхідного результату.

Шкала депресії А. Т. Бека дозволяє виявити наявність депресії та ступінь тяжкості депресивних розладів. Наразі, опитувальник складається з 21 пункту, кожен з яких містить кілька варіантів тверджень.

Узагальнені результати показали, що пацієнти які мають по тестам більше 50 балів із 85, в них прослідковуються симптоми ПТСР. Серед усієї вибірки 30 чоловік (20 %) мають сформовані та стійкі симптоми ПТСР. У ще 35 респондентів (23 %) спостерігаються симптоми розладу пристосувальних реакцій та інтрузії. У пацієнтів з ПТСР високий рівень тривожності. Усі учасники дослідження мають поганий сон, почуття тривоги, відстороненість, емоційну дисрегуляцію у вигляді спалахів гніву, зниження концентрації уваги, негативних нав'язливих думок, що асоціюються із травмою.

Для лікування ПТСР у військовослужбовців можуть використовуватися різні методи, включаючи терапію, ліки та інші підходи.

Психотерапія: різні види психотерапії можуть бути корисні для лікування ПТСР. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія може допомогти особі з ПТСР навчитися управляти своїми думками та емоціями, а емоційно орієнтована терапія може допомогти особі з ПТСР відновити зв'язок між тілом та емоціями.

Ліки: деякі ліки, такі як антидепресанти та препарати для заспокоєння, можуть допомогти зменшити симптоми ПТСР.

Експозиційна терапія: цей вид психотерапії полягає у поступовому викладанні особі з ПТСР тим ситуаціям, що викликають тривогу, з метою зменшення тривожності та покращення здатності до адаптації.

Рухові терапії: це включає фізичні вправи, які можуть допомогти розслабитися та зменшити тривогу, такі як йога, танець та інші.

Медитація та міндфулнес: ці практики можуть допомогти особі з ПТСР зосередитися на моменті та зменшити тривогу та напругу.

Ці методи лікування можуть бути використані окремо або в комбінації, залежно від потреб та індивідуальних особливостей особи з ПТСР. Важливо, щоб лікування було індивідуалізованим та проводилося під керівництвом кваліфікованого фахівця. Важливо надати підтримку та допомогу військовослужбовцям, які стикаються з цим станом, та підтримувати їх у процесі одужання.

Висновки. Збереження ментального здоров'я населення є ключовим завданням в умовах воєнного часу. Воєнні конфлікти, терористичні акти та інші форми насильства можуть призвести до травми та стресу у населення. Це може призвести до зниження якості життя, збільшення ризику розвитку психічних та фізичних захворювань, зниження працездатності та інших проблем. Усвідомлення та прийняття факту наявності ПТСР є важливим кроком на шляху до одужання. ПТСР є серйозним психічним розладом, який може виникнути в результаті переживання травматичної події, такої як війна, терористичний акт, насильство або катастрофа. У багатьох випадках військові, які пережили травматичну подію, можуть бути неусвідомлені щодо свого стану. Вони можуть ігнорувати симптоми ПТСР або спробувати знайти інші способи заспокоїтися, наприклад, за допомогою алкоголю або наркотиків. Проте, визнання наявності ПТСР та початок лікування можуть допомогти зменшити тяжкість симптомів та поліпшити якість життя. Лікування ПТСР може включати психотерапію, фармакотерапію та інші методи. Проте, перший крок у лікуванні полягає у тому, щоб визнати наявність проблеми та звернутися до кваліфікованого фахівця для отримання допомоги.

Література.

1. Агаєв Н. А., Кокур О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С., Остапчук В. В., Ткаченко В. В. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

2. Галич М. Ю., Литвин В. В. Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного часу: діагностика та профілактика. Юридична психологія. 2022. № 1 (30). С. 22–28.

3. Методика «PCL – шкала самооцінки наявності ПТСР», Національний Центр PTSD, Бостон, США. URL: <http://www.ncptsd.va.gov>.

4. Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. URL: <https://www.who.int>.
5. Синишина В. Вплив бойового досвіду на посттравматичний стресовий розлад у учасників антитерористичної операції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2021. Вип. 4. С. 162–170.
6. Тептюк Ю. О. Психологічні умови розвитку стресостійкості у соціальних працівників різних вікових категорій: дис. ... канд. психол. наук. 19. 00. 07. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К., 2021. 272 с.
7. Wise M. G. Posttraumatic stress disorder, human reaction to catastrophe. Drug Ter. 1983. P. 121–123.

5.12. Соціально-психологічні аспекти вирішення конфліктів в територіальних громадах шляхом медіації

Потапенко С. А., Потапенко І. Є.

Актуальність. Суспільство є соціальним середовищем існування людини, яке територіально обумовлює утворення місцевих спільнот (територіальних громад), наділених субкультурою, які мають власну історію виникнення та розвитку, відповідну систему символів та цінностей що віддзеркалюють їх ідентичність. Кожна територіальна громада безпосередньо та/або через органи місцевого самоврядування вирішує всі питання місцевого значення та покладені на неї державою завдання, шляхом здійснення місцевого самоврядування у межах закріпленої за ними законом компетенції. Практика свідчить, що соціально-психологічна взаємодія між державою та місцевою владою може бути досягнута шляхом чіткого визначення та розподілу їхніх повноважень та відповідальності. У цьому зв'язку у 2014 році в Україні розпочата реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, які передбачають об'єднання територіальних громад та зміну адміністративно-територіального устрою нашої країни. Основоположний вектор децентралізації влади в Україні та країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) закріплений Європейською хартією місцевого самоврядування 1985 року (ст. 5), якою встановлено, що проведення зміни просторових кордонів органів місцевого самоврядування не повинно здійснюватися без з'ясування думки жителів місцевих спільнот [1]. Це положення закарбувало основоположну засаду про те, що територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування на своїй території. При цьому, при проведенні реформи місцевого самоврядування в Україні та країнах ЄС врахування думки місцевих спільнот мало різні форми, зміст та юридичне значення.

Мета. Дослідити соціально-психологічні аспекти вирішення конфліктів в територіальних громадах шляхом медіації.

Результати дослідження. Основною концептуальною ідеєю реформи місцевого самоврядування в Україні та країнах ЄС є укрупнення гмін, комун, муніципалітетів, волостей, громад тощо для досягнення більш якісного рівня їх життєдіяльності, наслідком цього є відповідне збільшення їх територій. У цьому контексті слушно наголосити на тому, що на початку цієї реформи система зв'язків між членами місцевих спільнот є децентралізованою, оскільки їх просторові межі об'єктивно дозволяють їм доволі часту безпосередню взаємодію, спостереження один за одним, спілкування, солідарність у вирішенні питань місцевого значення та громадську свідомість. В подальшому, укрупнення та збільшення просторових меж проживання об'єднаних територіальних громад обумовлює перехід до централізованої системи зв'язків, при якій її члени, яких стало значно більше, вже не можуть безпосередньо сприймати всіх інших членів та взаємодіяти як раніше, а в основному обмінюються інформацією через центральний ланцюг, яким є адміністративний центр територіальної громади, де розташований її орган місцевого самоврядування.

На відміну від країн ЄС в Україні при утворенні об'єднаних територіальних громад законодавчо визначена умова врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інші чинників, що можуть вплинути на її соціально-економічний розвиток. Тож, при проходженні процедур від ініціювання до добровільного утворення об'єднаної територіальної громади обов'язковим є проведення громадських обговорень.

Місцева спільнота являє собою об'єднання людей, яке сформоване на основі спільних умов життя, інтересів, традицій, історичних, культурних та інших чинників, які визначають її соціальну ідентичність. Поняття «соціальна ідентичність» означає самоототожнення індивіда з тими спільнотами, які він сприймає за «свої» і стосовно яких він може сказати «ми» [2]. Відношення «спільність – індивід» є неминучою ланкою зв'язку індивіда з суспільством, в якому він, слідуючи груповим нормам, формується як особистість. Наразі до змісту поняття «соціальна ідентичність місцевої спільноти» входить спільна територія проживання, історія виникнення та розвитку, соціальна взаємодія, моральні норми, цінності, традиції, інтереси, звички та потреби [3]. Т. Семігіна,

О. Майданник, Ю. Оніщик, Я. Журавлев зазначають, що структура соціальної ідентичності місцевої спільноти складається з ідеологічного, індивідуально-психологічного, соціально-економічного та правового рівнів (Semigina) [4].

На думку С. Крамера, Т. Амоса, С. Лазаруса та М. Сідата ідеологічний рівень включає традиції, інтереси, переконання, світогляд, певний спосіб життя [5]. Оскільки жителі територіальної громади пов'язані між собою певним історично складеним способом життя, то їх традиції є історично обумовленими на локально-територіальному рівні. Це притаманні лише їм способи мислення та дій, світоглядні установки, оцінка дійсності, визначення потреб та інтересів, сприйняття та відношення до навколишнього середовища. Місцеві спільноти є носіями житлових, освітніх, культурних, релігійних, політичних інтересів, які визначаються обсягом інтересів її членів. Як правило, ці особливості територіальної громади частково знаходять своє відображення у статутах, положеннях, які проходять процедуру громадського обговорення та затверджуються їх органами місцевого самоврядування. Кожна територіальна громада охороняє свої традиції від можливої руйнації при вирішенні питання об'єднання з іншими суміжними громадами і це є однією із причин для відмови їх добровільного об'єднання.

Наступний, індивідуально-психологічний рівень, описаний Е. Остромом та Д. Пате, на їхню думку цей рівень охоплює звички, спільність цінностей, взаємовідносини в середині спільноти та з іншими спільнотами, психологічну ідентифікація із спільнотою, відповідальність перед нею, довіру один до одного, солідарність та наявність громадської свідомості [6]. Складовими відчуття спільності є враження злитості з місцевою спільнотою, дотримання її цінностей, традицій та інтересів, поділений емоційний зв'язок, який полягає у відчутті спільності долі її членів, міру і характер їх взаємодії. Саме ці фактори забезпечують позитивний психологічний клімат між жителями територіальної громади. Саме тому, при проведенні реформи місцевого самоврядування принциповим є врахування індивідуально-психологічних особливостей жителів територіальних громад з метою утворення нових соціальних інституцій з позитивним психологічним кліматом.

Соціально-економічний рівень утворюють: територія, місцевий бюджет, нерухоме та рухоме майно, земля, природні ресурси, розташовані в межах території територіальної громади, які є матеріальною і фінансовою основою та гарантією надання членам місцевої спільноти якісних публічних послуг і вирішення питань місцевого значення. Одним із важливих моментів у забезпеченні сталого місцевого розвитку є усвідомлення членами місцевих спільнот необхідності своєчасної сплати податків. Правовий рівень охоплює здатність жителів територіальної громади, як первинного суб'єкта місцевого самоврядування, впливати на місцеве життя шляхом вирішення питань місцевого значення, а також наділяти їх певними повноваженнями, шляхом проведення виборів, що визначає її суб'єктом здійснення місцевого самоврядування.

Наведені рівні соціальної ідентичності місцевих спільнот співіснують і є важливими для формування державної політики утворення територіальних громад та визначення їх повноважень. Територіальні громади можуть вплинути на реформування місцевого самоврядування та зберегти соціальну ідентичність тоді, коли її врахування чітко встановлено та гарантовано на законодавчому рівні. Підтвердженням цьому може слугувати досвід Естонії та України.

Проведений Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація сприяння самоорганізації населення» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у 2018 році аналіз конфліктів в об'єднаних територіальних громадах з метою виявлення конфліктогенного потенціалу дав змогу виокремити наступні їх причини: 1) протиріччя, успадковані з часу об'єднання; 2) невдоволення практикою розподілу ресурсів між внутрішніми громадами; 3) оптимізація соціальної інфраструктури; 4) протиріччя навколо земельних питань; 5) протистояння в середовищі місцевої управлінської еліти; 6) боротьба за повноваження та бюджетні ресурси між рівнями влади громад і районів [7].

Досвід першого етапу реформи децентралізації влади в Україні (2015-2020 рр.) показує, що в утворених добровільно об'єднаних територіальних громадах, кожна місцева спільнота зберегла свою соціальну ідентичність, а традиції, світогляд, громадська свідомість у самій об'єднаній територіальній громаді ще перебуває на стадії становлення і для цього потрібен тривалий проміжок часу [8].

Особливе загострення спостерігалось у 2020 році, коли принцип «добровільності» в утворенні об'єднаних територіальних громад в Україні був замінений урядом утворенням в імперативному порядку сформованих територіальних громад з визначеними в адміністративними центрами та розформованих територіальних громад з повним ігноруванням думки жителів місцевих спільнот та в супереч властивих їм соціальних ідентичностей.

І. Терещенко, А. Гусев, О. Овчаренко, О. Левченко, О. Сас, Г. Єлісєєва, розробники методичного посібника «Робота з конфліктами в громадах у процесі децентралізації» розглядали конфлікти, пов'язані з децентралізацією і об'єднанням у нові громади на прикладі Вінницької, Черкаської та Львівської областей [9, с. 44]. Вони включилися у дослідження на останньому етапі ухвалення рішень в рамках реформи територіально-адміністративного устрою і примусового об'єднання територіальних громад, та безпосередньо під час виборчого процесу до сформованих (за рішенням уряду) територіальних громад. Конфліктогенні питання в процесі реформи децентралізації ними вивчалися на рівні областей, районів та громад, що давало можливість мати різне бачення ситуації для аналізу: 1) ситуація, що склалася; 2) тенденції та контексти, які визначають цю ситуацію; а також окреслити групи людей, щодо яких варто планувати заходи трансформації конфлікту (інтервенції або втручання) – діалоги, медіація, фасилітаційні сесії бачення майбутнього тощо [9, с. 44].

І. Терещенко, А. Гусев, О. Овчаренко, О. Левченко, О. Сас, Г. Єлісєєва виявили, що на обласному рівні формується розуміння ситуації. На районному рівні виднішою є політична взаємодія, можна побачити тих людей, які не залучені в конфлікт напряму, але які є дуже впливовими, та можуть в певний момент зіграти помітну роль у розвитку конфлікту. Фактично, вони значимі і їх потрібно намагатись залучити до роботи з конфліктом в громаді, оскільки вони здатні організувати інших, аби їх слухали. Саме за рахунок таких потенційних учасників можна здійснювати символічне вирівнювання сторін конфлікту. На рівні територіальної громади складніше вийти на опозицію, для цього треба кілька контактних людей та відповідних знайомств [9, с. 45-46].

Критично психологічний клімат на рівні територіальних громад змінився у зв'язку із широкомасштабною збройною агресією

Росії проти суверенної та незалежної України в лютому 2022 року, що призвело до масових вбивств і поранення цивільного населення та військових, руйнування житла, населених пунктів, критичної інфраструктури, виникнення прифронтових територіальних громад тощо. Війна, з-поміж інших конфліктів, також стала причиною виникнення конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та приймаючими територіальними громадами, які можуть перерости у рівень глибоких та затяжних.

Конфлікт є одним із тих чинників, який несе загрозу у життєдіяльності територіальної громади, а одним із шляхів його вирішення є медіація. О. Аллахвердова характеризує медіацію як соціально-психологічний феномен, зазначаючи, що це форма вирішення конфліктів, суть якої полягає у створенні психологічних умов, які призводять до зниження емоційного напруження, прийняття конструктивного рішення та врегулювання конфлікту між сторонами [10]. А. Альошина та В. Косовська характеризують медіацію як спосіб вирішення конфліктів за участю незалежного посередника, який заснований на добровільній згоді сторін з метою прийняття прийняттого для обох сторін рішення. При цьому автори наголошують, що професійними якостями медіатора, які позитивно можуть вплинути на ефективність процедури, володіють конфліктологи та юристи [10].

В конфліктній ситуації медіатор допомагає вести діалог у конструктивному руслі, але остаточне рішення приймають самі сторони конфлікту (спору). Ключовими факторами є те, що під час медіації сторони добровільно беруть участь у переговорах, а не за повісткою чи наказом тощо, і розмова між ними від початку спрямована на порозуміння, а не на перемогу однієї сторони над іншою. Медіація, як процес, має свою структуру та принципи, що відрізняє її від процесу переговорів та інших форм посередництва.

Перевагами медіаційного процесу у розв'язанні конфліктів у територіальних громадах є, перш за все, його конфіденційність: вся інформація, яку медіатор отримує в процесі проведення переговорів від обох сторін та від кожної сторони окремо, є конфіденційною та не підлягає розголошенню. Крім того, сторони за власним узгодженням можуть вирішити питання яка саме інформація може підлягати розголосу, та яка має залишатися за дверима кімнати переговорів.

Для вирішення конфліктів у територіальних громадах для медіаторів слухними можуть бути поради, сформульовані розробниками методичного посібника «Робота з конфліктами в громадах у процесі децентралізації» стосовно конфліктологічної компетентності працівників органів місцевого самоврядування і органів влади, а саме: вони мають навчитися виявляти конфлікти в громадах на ранніх стадіях його розвитку; спрямовувати зусилля не на боротьбу з «винними», а на покращення якості життя громадян; вміти проводити аналіз щодо того, як ухвалені рішення вплинуть на конфліктний потенціал громади; розробляти зміни до регуляторних актів та ухвалювати відповідні рішення на системному рівні одразу після гострої фази конфлікту; вивчати та розуміти особливості ідентичності жителів громади, їх уявлення про справедливість, стабільність, зміни, майбутнє; розуміти та спиратися в роботі з конфліктом на принцип інклюзивності; при аналізі ситуації враховувати гендерні особливості в конфлікті; спільно з жителями громади будувати бачення майбутнього через заходи зі згуртування, залучення їх до ухвалення рішень; сформувати базу нейтральних фахівців-посередників, яких можливо залучити для проведення трансформаційних заходів (медіацій, фасилітації, діалогів, переговорів, супроводу тощо) [9, с. 48].

В гострій фазі конфлікту важливо зупинити активні дії або акції, які загрожують небезпекою жителям громади та іншим громадянам. В цьому випадку яскраво проступає проблема не співпадиння критеріїв визначення початку конфлікту у конфліктологів та представників влади. Юридично повноваження на їх зупинення закріплені за представниками влади, які на жаль часто, починають працювати з конфліктом лише в «гарячій» фазі протистояння. Конфліктологи ж мають іншу позицію щодо вирішення конфлікту: чим раніше – тим краще. Тобто, чим раніше до конфлікту будуть залучені нейтральні посередники (медіатори), тим швидше і якісніше можна буде досягти порозуміння між конфліктуєчими сторонами [9, с. 49].

Медіацію також можна використовувати для згуртування громади та попередження виникнення конфліктів, в тому числі на стадії розробки концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного

пункту, іншої містобудівної та землепорядної документації, бюджету територіальної громади, громадського бюджету та інших регуляторних актів. Можна робити картування конфліктів, інтересів та напруги у громадах.

Висновки. Практика свідчить про те, що територіальні громади є досить чутливими до ігнорування їхньої соціальної ідентичності при вирішенні питання їх об'єднання з іншими громадами. Утім, обрана Кабінетом Міністрів України процедура формування (примусового утворення) територіальних громад без врахування їх соціальної ідентичності робить їх лише формально однорідними, але за змістом вони є конфліктними та мають негативний психологічний клімат, що в подальшому впливає на їхню життєдіяльність. У цьому зв'язку багатоманітність соціальних ідентичностей територіальних громад обумовлює необхідність розроблення дієвого механізму їх об'єднання з врахуванням соціальних, психологічних та інших чинників та можливістю вирішення конфліктів між територіальними громадами шляхом медіації. Важливою складовою процесу медіації є те, що медіатор виступає нейтральною стороною, яка не має власної компетенції приймати рішення або генерувати варіанти різних рішень. Медіатор, як посередник, не висловлює своїх уподобань, не є арбітром та суддею, а тому під час процесу вирішення конфліктів, які виникають в територіальних громадах, він не виказує будь-яких оцінювальних суджень щодо жодної зі сторін та їх позицій, його завдання – рухатись між сторонами конфлікту, бути перекладачем, передавачем та каталізатором, що сприяє ефективному пошуку найкращих рішень, враховуючи та виявляючи справжні інтереси кожного жителя територіальної громади. Таким чином, медіація є однією із моделей вирішення конфліктів у територіальних громадах та упередження їх виникнення в майбутньому, в тому числі конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та приймаючими територіальними громадами.

Література.

1. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15. 10. 1985 р. О URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 15. 11. 2023).

2. Brown, R., Capozza, D. (Eds.). Social Identities: Motivational, Emotional, Cultural Influences. Abingdon: Routledge, 2016. p. 304.

3. Etzioni, A. *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*. New York: Basic Books, 1996. p. 314.
4. Semigina T., Maidannyk O., Onischuk Y., Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. *Juridikal tribune – tribune juridikal*, 2020. (10) 2. June. 209.
5. Kramer, S., Amos, T., Lazarus, S., & Seedat, M. (2012). The philosophical assumptions, utility and challenges of asset mapping approaches to community engagement. *Journal of Psychology in Africa*, 2012. 22(4). p. 537–544.
6. Ostrom, E. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. New York: Cambridge University Press, 1990. 295 p.
7. Конфлікти в об'єднаних територіальних громадах: типи, причини, форми, наслідки. Асоціація сприяння самоорганізації населення. 2018. 36 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/10Q5dMSiQVurL02OvBHMawfzQksu7FLLg/view> (дата звернення: 15. 11. 2023).
8. Потапенко С. А. Характерні риси об'єднаної територіальної громади. *Вісник академії праці, соціальних відносин і туризму*. 2019. № 2. С. 47–55.
9. Терещенко І., Гусев А., Овчаренко О., Левченко О., Сас О., Єлісеєва Г. Робота з конфліктами в громадах у процесі децентралізації: методичний посібник. К. : 2020. 65 с. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/479278.pdf> (дата звернення: 15. 11. 2023).
10. Цит. за: Токарева К. С. Адміністративно-правове регулювання медіації: сучасний стан та тенденції розвитку: дис. ... докт. юрид. наук: 12. 00. 07. Київ: 2021. С. 37-38.

5.13. Психологічні детермінанти комунікації у системі «лікар–пацієнт хірургічного профілю»

Шмуліченко О.В.

Актуальність. В умовах війни, коли люди зазнають психічних і фізичних травмувань, виникає затребуваність у отриманні медичної допомоги хірургічного профілю, що у свою чергу потребує від медичних працівників відповідної професійно-фахової та соціально-психологічної компетентності. Сьогодення потребує від лікарів-хірургів нових навичок, що діють та є ефективними у стресових умовах, вмінь швидко реагувати на стан пацієнта та приймати миттєві рішення. Робота лікарів передбачає велику емоційну насиченість, подекуди амбівалентність: задоволення отриманим результатом з приводу успішно проведеного лікування, схвалення і повага колег; з іншого боку – часто зустрічається емоційне та фізичне виснаження, напруженість діяльності, що призводить до професійного вигорання.

У медико-психологічній літературі дослідниками вивчено низку наукових робіт з професійної діяльності медичного персоналу, зокрема: Є. С. Готько, Л. В. Животовська, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, А. М. Скрипніков та ін. Існує доробок наукових праць, присвячених проблемам медичної освіти та професійного розвитку лікаря (В. М. Ждан, Л. О. М. О. Денеко, Качала, Р. Ю. Погоріляк, І. М. Рогач, Г. Т. Сонник, К. І. Чопей та ін.). Однак, професійна діяльність лікаря-хірурга та її психологічна комунікативна специфіка вивчена недостатньо.

Мета. Теоретичний аналіз феномену «комунікація», визначення психологічних особливостей комунікативного процесу та взаємодії у системі «лікар – пацієнт хірургічного профілю».

Хірургія (грец. *cherurgia*, від *cheir* – рука + *ergon* – дія, робота) – галузь медицини, яка вивчає хвороби, основний метод лікування яких [4] – оперативне вирішення наявного гострого/хронічного захворювання, застосовуючи прийоми, методи, техніки виконання операцій.

Діяльність лікаря-хірурга полягає у виявленні причин захворювань, заповненні історії хвороби, проведенні дослідницьких робіт для встановлення або підтвердження діагнозу, проведенні пе-

редопераційної підготовки, планових і позапланових (екстрених) операцій, веденні пацієнта після операції, розробці і впровадженні нових методів діагностики і лікування різних захворювань. [1].

Прийняття професійних рішень вимагає від хірурга мобілізації знань і досвіду, затрати фізичних та емоційних зусиль (відповідальність перед пацієнтом); ускладнює становище хірурга те, що він, не може передбачити результати, у той же час повинен знайти можливості зниження ступеню операційного ризику, тому, за ситуаційної потреби, лікар-хірург завжди консультується з колегами, як вітчизняними, так й іноземними.

Перед операцією лікар у загальних рисах пояснює пацієнту, у чому полягає суть втручання, його необхідність, які функціональні зміни відбудуться в організмі після оперативного втручання. Робота лікаря-хірурга це ще і психологічна робота з тривожністю пацієнта, його страхом перед операцією, страхом смерті, страхом майбутнього, намагаючись налаштувати пацієнта на позитивний результат і вселити в нього надію на одужання. Це не тільки діагностика, але й визначення ступеня ризику операції, доцільності тих чи інших додаткових діагностичних і лікувальних маніпуляцій, одержання згоди хворого і його родичів на термінове хірургічне втручання і т. д. [3, с.24-25].

Професійна діяльність лікарів суттєво відрізняється від діяльності інших фахівців. Ця відмінність полягає у тому, що лікар має справу з людиною у хворобі: особливості поведінки пацієнта визначаються не лише порушеннями біологічних систем організму, а й позначаються на психоемоційному стані пацієнта, що обумовлює зміни у міжособистісній комунікації.

Професійно-психологічними чинниками діяльності лікарів-хірургів є:

1. Вербальна та невербальна взаємодія з пацієнтами та членами родини: повідомлення про стан хвороби пацієнту (рецидиви, виникнення ускладнень; або перехід захворювання до термінальної стадії – про що повідомляється лише родичам пацієнта); спілкування з пацієнтами, що мають неспецифічний психоемоційний стан.

2. Вплив соматичної нозології захворювання, що призводить до незворотніх змін органів та систем у пацієнтів хірургічного профілю: «емоційна включеність» медичного персоналу на фізич-

ний та психоемоційний стан пацієнта; емоційна криза та розуміння пацієнтом неможливості одужання.

3. Організація професійної діяльності та вимоги до фахово-практичних навичок лікарів-хірургів: постійне підвищення рівня професійної кваліфікації (курси, конференції, майстер-класи, навички роботи із сучасною медичною апаратурою, іноземне стажування, ознайомлення із сучасними іноземними публікаціями); професійне перевантаження, що призводить виникнення синдрому хронічної втоми.

Швидкість видужування є партнерською взаємодією лікаря і пацієнта. Лікарем забезпечується стратегія процесу лікування недуги, пацієнтом – з однієї сторони – виконання призначень лікаря, а з іншої – бажання і психологічна готовність бути здоровим. Тобто, формується модель і стратегія комунікативної взаємодії лікаря і пацієнта, яка ґрунтується на взаємодопомозі, відкритому комунікативному діалозі лікаря і пацієнта (родичів пацієнта) з метою долання хвороби. Така міжособистісна взаємодія та конгруентність слугують формуванням соціального та емоційного інтелекту, розвитком комунікативної компетентності.

Аналіз наукової літератури вказує, що поняття «комунікативна компетентність фахівця» психологами розуміється як сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування, здатність встановлювати контакт та взаємодіяти з іншими людьми. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої соціально-психологічної взаємодії між людьми.

У медицині комунікація – це процес двостороннього обміну інформацією між пацієнтом і лікарем. Щоб переконатися в перцептивній взаємодії, слід отримувати інформацію про те, як пацієнт зрозумів лікаря, як сприймає його, як ставиться до своєї хвороби та запропонованих лікарем методів лікування. Для ефективної комунікації характерні: досягнення взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації та предмету спілкування (досягнення більшої визначеності в розумінні сприяє розв'язанню проблем пацієнта, забезпечує досягнення мети – одужання пацієнта – з оптимальним витрачанням ресурсів) [2]. У той же час зауважимо, що досить часто «комунікацію» розуміють як синонім «спілкування», підкреслюючи, що «комунікативний» вплив є взаємодією двох і більше людей, з метою зміни поведінки одного/декількох комунікантів.

За характеристиками компонентів, зачасти, фахівцями розглядаються наступні функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляторно-комунікативна, афективно-комунікативна.

Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування, передачі та прийому інформації. Дана функція реалізується на наступних рівнях:

- перший – з'ясування розбіжностей у поінформованості людей, що вступають у комунікацію;
- другий – передача інформації та прийняття рішення;
- третій – пов'язаний із прагненням людини зрозуміти інших (комунікативно-соціальна ідентифікація (оцінка ступеню розуміння інформації, фактів: порівняння, узгодження/неузгодження).

Регуляційно-комунікативна функція: завдяки отриманій інформації людина здійснює не лише регуляцію власної поведінки, а й здатна впливати та змінювати поведінку інших людей.

Афективно-комунікативна функція характеризує емоційну сферу людини (комунікація впливає на емоційну сферу людини, формуючи емоційні стани та ставлення людини до життєвої ситуації).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у комунікації та міжособистісній взаємодії лікаря та пацієнта виокремлюють такі складові:

- комунікативна – інформація про ситуацію стану здоров'я пацієнта;
- інтерактивна – організації взаємодії у процесі лікування пацієнта (узгодження дії пацієнта та його рідних, психоемоційний стан пацієнта);
- перцептивна – «комунікативний тандем», взаєморозуміння між лікарем і пацієнтом.

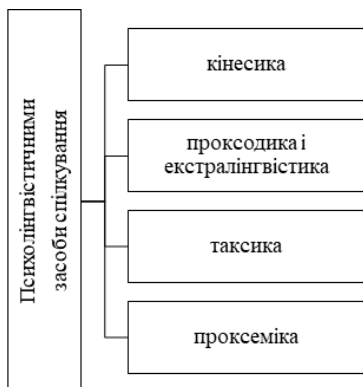
Л. О. Качала, Р. Ю. Погоріляк, І. М. Рогач, Шніцер Р. І. у медичній діяльності лікарів загальної практики відокремлюють такі компоненти комунікативної компетентності:

- «орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда;
- спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням, завдяки розумінню себе та інших, при постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища;
- адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному потенціалі, у потенціалі партнера, у ситуації;

- готовність і уміння будувати контакт з людьми;
- внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;
- знання, уміння і навички конструктивного спілкування;
- внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії» [2, с. 19].

Таким чином, ґрунтуючись на аналізі теоретичного доробку медико-психологічної літератури, визначимо комунікативну компетентність лікаря як систему внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії у системі «лікар – пацієнт»: знання психологічних проявів поведінки пацієнта, уміння і навички застосовувати доцільні стилі та моделі спілкування, попередження стереотипів та установок взаємодії.

Передача будь-якої інформації здійснюється не тільки за допомогою лінгвістичних знаків та засобів спілкування (вербально), а й за допомогою емоційного вираження/супроводу/коментарю знаками (невербально), що супроводжують інформацію. Тому виділяють вербальний і невербальний рівень комунікативної компетентності, що передбачає вміння інтерпретувати невербальні прояви інших людей. Психолінгвістичними засобами спілкування визначено (рис.1.):



*Рис.1. Психолінгвістичні засоби спілкування
(розроблено автором)*

- *кінесика* (експресивно-виразні рухи, поза, міміка, жестикуляція, хода, візуальний контакт);
- *проксодика і екстралінгвістика* (інтонація, тембр, гучність швидкість мовлення, паузи, зітхання, плач);

- *таксика* (рукоостискання, поплескування);
- *проксемика* (орієнтація у просторі, дистанція).

У спілкуванні лікаря із пацієнтом має значення психолінгвістична сторона мовлення (зрозумілі слова та терміни, побудова речення та логічне пояснення ситуації), яке за змістом та значенням однаково сприймається як лікарем, так і пацієнтом, а екстралінгвістика взаємодії лікаря і пацієнта: інтонація, емоційна виразність, яка може надавати різного змісту тій самій фразі; міміка, поза, погляд, що здатні посилювати, доповнювати або спростовувати зміст сказаного; жести (які можуть бути загальноприйнятими, що мають закріплене за ними значення, або ж експресивними, що служать для більшої виразності мовлення) [2].

У міжособистісній комунікації лікаря-хірурга та пацієнта визначаються наступні етапи: планування змісту повідомлення про стан здоров'я пацієнта; психологічні знання про особливості реагування пацієнта у хворобі; застосування вербальних та невербальних засобів комунікації (фрази, стиль спілкуванням з пацієнтом, тональність повідомлення інформації); оцінка реакції пацієнта, зворотного зв'язок на інформацію про стан пацієнта.

Поєднання усього переліченого у певну функціональну єдність формує процес успішного спілкування. При цьому потреби особистості пацієнта слід розглядати як його особливий психічний стан (напруження, незадоволення, дискомфорт), який він відчуває і усвідомлює, а також враховувати ймовірну мотиваційну кризу пацієнта – болючу зміну мотивів, до якої він зазвичай погано підготовлений [2, с.19].

Бар'єрами комунікації лікаря з пацієнтом хірургічного профілю можуть бути: стереотипи, упереджене ставлення, відсутність інтересу до співрозмовника; нехтування фактами, тобто звичка робити висновки за відсутності достатнього підтвердження інформації; помилки у побудові висловлювань: неправильний вибір слів, складність повідомлення, нелогічність; помилковий вибір стратегії і тактики у спілкуванні лікаря з пацієнтом може виникати, коли лікар неправильно оцінив психічний стан пацієнта і намагається вибудувати спілкування, ґрунтуючись на недоречних стратегіях [2, с. 18-22].

Позитивний психологічний контакт з пацієнтом допомагає отримати якісний анамнез. Комунікативна компетентність лікарів-хірургів забезпечує взаєморозуміння у системі взаємодії «лікар-пацієнт», що суттєво впливає на ефективність в рішенні поставлених задач.

«Якщо пацієнт довіряє лікареві, не сумніваючись в правильності діагностики та лікування, то він виконуватиме призначення, пройде всі необхідні діагностичні і терапевтичні процедури. За відсутності психологічного контакту, пацієнт, можливо, не стане дотримуватись лікарських рекомендацій і призначень, проконсультується у інших лікарів або у своїх знайомих, займеться самолікуванням, звернеться до представників альтернативної медицини» [2, с.18-22].

Висновки. Професійна діяльність лікаря-хірурга пов'язана з розробкою стратегії і тактики терапевтичної дії, передбачає прогнозування розвитку захворювань, ускладнень, наслідків хірургічного та фармакологічного лікування.

Професійно-психологічними чинниками діяльності лікарів-хірургів визначено: вербальна та невербальна взаємодія з пацієнтами та членами родини; вплив соматичної нозології захворювання, що призводить до незворотніх змін органів та систем у пацієнтів хірургічного профілю; організація професійної діяльності та вимоги до фахово-практичних навичок лікарів-хірургів.

Визначено комунікативну компетентність лікаря як систему внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії у системі «лікар – пацієнт»: знання психологічних проявів поведінки пацієнта, уміння і навички застосовувати доцільні стилі та моделі спілкування, попередження стереотипів та установок взаємодії. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості лікаря, є структурний феноменом, що включає комунікативний, перцептивний, інтерактивний аспекти взаємодії, містить знання, мотиви, установки.

Література.

1. Судакова О. С. Специфіка синдрому емоційного вигорання у онкологів: Медична психологія. Т. 4, 2012. С. 92-96.
2. Рогач І. М., Шніцер Р. І., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. Морально – етичні та психологічні аспекти медичної діяльності лікарів загальної практики : навч.– метод. посібн. Ужгород. 2010. 64 с.
3. Рогач І. М., Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю., Чопей К. І. Культура управління як складова частину менеджменту в охороні здоров'я : навч. посіб. Ужгород : УжНУ 2012. 38 с.
4. Фармацевтична енциклопедія. Хірургія. URL : <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/202/xirurgiya>

ВИСНОВКИ

За підсумками науково-дослідної роботи кафедри, кваліфікаційних та дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти отримано такі теоретико-емпіричні результати:

1. В напрямку акме-психологічних стратегій формування професійної траєкторії фахівця досліджено: професійна ідентифікація особистості, особливості психолого-педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, психосоціальні аспекти професійної діяльності особистості, розглянуто важливість психологічної підготовки та розвитку ціннісних орієнтацій у професійній діяльності, а також особистісні та професійні компетентності, як чинник професійної діяльності особистості; надано аналіз впливу локусу контролю на професійне самовизначення та стресостійкість випускників професійно-технічних навчальних закладів, досліджено особистісні якості та професійні компетентності персоналу девелоперських організацій.

2. В напрямку теоретико-методологічних та практичних підходів до забезпечення ментального здоров'я особистості досліджено: невротичні стани та емоційні проблеми при порушенні сімейного функціонування, невротичні розлади у дітей та дорослих в умовах соціального стресу, особливості психологічних механізмів комунікації у підлітковому віці, визначено психологічні особливості психоемоційного реагування особистості в ситуації життєвих змін, досліджено аспекти агресивності та «девіації» у підлітковому віці, формування резильєнтності здобувачів вищої освіти в умовах війни, виявлено особистісні особливості спортсменів в умовах стресу; проведено аналіз сучасних проблем осіб з дисфункціональних родин, проаналізовано психологічні ускладнення дітей та підлітків з надмірною вагою та ожирінням. Досліджено психологічні особливості медичних працівників в умовах емоційного виснаження, психоемоційний стан вагітних жінок, тенденції розвитку алкогольної залежності серед молоді України та інформаційно-психологічну безпеку особистості.

3. В напрямку вивчення соціально-психологічної допомоги постраждалим у наслідок військових дій досліджено: психологічну підтримку працевлаштування та групове консультування у психологічному супроводі емоційних станів внутрішньо переміщених осіб з відновлення працевлаштування, розглянуто психічні стани особистості, як наслідок кризових подій в Україні, висвітлено функціонування сімейної системи і постстресової психологічної дезадаптації учасників бойових дій, окреслено психологічна підтримка військовослужбовця з розладами адап-

тації, виявлено особливості психоемоційних станів військовослужбовців у адаптаційний період, досліджено психоемоційну сферу особистості у умовах життєвих викликів.

4. В напрямку теоретико-емпіричного дослідження психічного здоров'я організацій та персоналу в умовах війни досліджено: психічне здоров'я персоналу в ІТ індустрії в умовах війни та роль психологічних чинників у виникненні емоційного вигорання працівників ІТ-сфери; проаналізовано психічне здоров'я організацій та персоналу в умовах війни; з'ясовано емоційне вигорання керівника в сфері охорони здоров'я; доведено мотиваційний вплив ідентичності та іміджу бренда на поведінку споживача; окреслено психологічні механізми формування організаційної культури підприємства та теоретичні аспекти психології управління та менеджменту бізнес-процесами на підприємстві; розкрито психологічні детермінанти адаптації та мотивації персоналу організації до професійної діяльності, психологічні особливості професійної діяльності керівника організації; концертуалізовано поняття «емоційне лідерство», «ролева компетентність», «попередження конфліктів в організації»;

5. В напрямку консультативної, діагностичної та терапевтичної діяльності фахівця у медико-психологічному та психосоціальному супроводі особистості та організації: узагальнено погляди на сутність медико-психологічної взаємодії у системі «медичний працівник-пацієнт», розглянуто використання методів арт-терапії у роботі з дітьми, хворими на епілепсію, з'ясовано ризики застосування методу психологічного дебрифінгу та формування стресостійкості особистості; виокремлено вплив зовнішніх факторів стресу на підвищення кількості захворювань розладами харчової поведінки; обґрунтовано особливості та чинники розладів харчової поведінки у жінок, розкрито передумови виникнення психологічної залежності від гаджетів у підлітковому віці, розкрито соціально-психологічні аспекти вирішення конфліктів в територіальних громадах шляхом медіації; встановлено психологічні особливості тренувальної діяльності спортсменів-професіоналів у передзмагальний період, визначено психологічні особливості взаємодії у сімейному та родинному середовищі.

Усе вищезазначене дозволяє стверджувати, що в умовах трансформаційних перетворень соціуму важливим є допомога у збереженні ментального здоров'я особистості та організації. У цьому контексті використання психологічних технологій, засобів та моделей задля розкриття внутрішніх ресурсів особистості сприятиме відновленню її сил та енергії, упевненості у собі та майбутньому, розвитку мотивації і підвищенню компетентності, що загалом буде сприяти на подальших життєвих кроках у процесі прийняття відповідальних рішень.



Навчатись
психології – варто!



КАФЕДРА
ПСИХОЛОГІЇ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ



ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА

Освітні програми

Education - Experience
Effect



АКАДЕМІЯ ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНИХ
ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

НАВЧАТИСЬ В АКАДЕМІЇ – ЦЕ ЦІКАВО
Високий професійний рівень викладачів
Сучасні методи навчання



Київ, 17 вул. Кітківська, 3-А, 03187 Україна
+380 (93) 969-58-99, (044) 526-06-64



EUROPEAN EDUCATION

Бакалаврат
Магістратура
Аспірантура

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ

Освіта - Досвід
Результат

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ
ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 053 ПСИХОЛОГІЯ

КАФЕДРА
ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

БАКАЛАВРАТ



Підготовка бакалаврів, здатних професійно
розв'язувати проблеми психології та соціальної
роботи на міжнародному рівні та виконувати
практичного характеру в галузі психології та
соціальної роботи в суспільстві, сфері,
що тісно пов'язані з експлуатацією людських
ресурсів та турботи

- Розв'язування складних задач і проблем у
сфері психології
- Навчання професійних психологічних
дисциплін та психологічних
дисциплін та психологічних дисциплін
- Володіння технологіями психологічного
консультування та психотерапії

ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ

- Отримання спеціальностей з психології
управління підприємством,
- Підготовка висококваліфікованих кадрів, які
володіють сучасним мисленням, творчими
навичками та спеціальними знаннями
КОМАНДИ ПСИХОЛОГІЯ
- Набуття компетенцій з психології,
психологічного мислення, психотерапії
- Навчання критичного психологічного
консультування, групової психотерапії і
суперечностей психологічності

МАГІСТРАТУРА



АСПІРАНТУРА



ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНО
ПІДГОТОВЛЕНИХ ДОСЛІДНИКІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ПЕДАГОГІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИКОНАТИ
ПРОФЕСІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

- Підвищення рівня професійної та
власноручної майстерності
- Розвиток науково-дослідницьких навичок
- Посилення рівня викладацької
спроможності викладати
- Розвиток навичок підготовки та
оформлення результатів наукових робіт,
випускних дисертацій, монографій тощо

European Community Course Credit Transfer System

Бакалавр з психології. Форма навчання: денна, заочна. Обсяг програми 240 кредитів ECTS. Після навчання із здобутими навчальними знаннями, які забезпечують, відповідно, на спеціалізованому міжнародному рівні, подальшої освіти, кар'єрного зростання та самостійності при виконанні міжнародних завдань.

Магістр з психології, спеціалізація: викладацька. Форма навчання: денна, заочна. Студентів підготують, проблемно-орієнтовано та підготують спеціалізованих дисертантів, проектів, інформаційно-комунікативних, спеціалізованих, колективних та інтегративних компетенцій психології навчання.

Доктор філософії з психології (Ph.D.). Навчання 4 роки (на спеціалізованому та міжнародному рівні). Форма навчання: денна, заочна. Обсяг програми 60 кредитів ECTS. Асистентська педагогічна практика триває 3 тижні. Підготовка здійснюється шляхом інтегративного підходу на підставі та знань педагогічних технологій, таких як: інформаційно-комунікативне навчання, використання інтегративних методів, навчання за технологією тренінгу.

Наукове видання

**МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ**

Монографія

За загальною редакцією

Г.А. Пріба, Л.Є. Бегези

*Матеріали друкуються в авторській редакції.
Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних
даних і мовностилістичний рівень матеріалів.*

Підписано до друку 20.01.2024. Формат 60х84 ^{1/16}

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. 29,64. Обл.-вид. арк. 25,64

Видавець і виготовлювач: ТОВ «Типографія АМГ»

03142, Україна, Київ, вул. Омеляна Пріцака 8.